

護理人員法解釋彙編

(108 年版)

衛生福利部 編印

中華民國 108 年 5 月

凡 例

- 一、本彙編各條文之解釋，按條次及時間先後次序編列。
- 二、本彙編所收載之解釋，就同一事項有不同之解釋時，適用後做成之解釋。
- 三、本彙編盡量將曾作之解釋均予收載供參，以求完備。

目 錄

一、護理人員法	1
二、護理人員法施行細則	13
三、護理機構分類設置標準	19
四、護理機構設置或擴充許可辦法	33
五、護理人員法解釋彙編	37
第一章 總則	37
第 1 條	37
第 2 條	39
第 3 條	41
第 4 條	41
第 5 條	41
第 6 條	41
第 7 條	41
第 7-1 條	42
第二章 執業	47
第 8 條	47
第 9 條	68
第 10 條	69
第 11 條	69
第 12 條	80
第 13 條	103
第三章 護理機構之設置及管理	106
第 14 條	107
第 15 條	108
〔釋例類別〕 第 1 類 護理機構屬性	108
〔釋例類別〕 第 2 類 護理機構服務對象	120
〔釋例類別〕 第 3 類 產後護理機構與坐月子中心之區別	126
〔釋例類別〕 第 4 類 是否屬醫療勞務，免徵營業稅	133

第 16 條	139
第 17 條	159
〔釋例類別〕第 1 類 開業執照登記	160
〔釋例類別〕第 2 類 申請設置主體	168
〔釋例類別〕第 3 類 負責人變更，重新申請設立規定	182
〔釋例類別〕第 4 類 護理機構建築物使用	189
〔釋例類別〕第 5 類 違規開業之懲處	207
第 18 條	212
第 18-1 條	213
第 18-2 條	213
第 19 條	218
第 19-1 條	223
第 20 條	223
第 21 條	223
第 22 條	234
第 23 條	237
第 23-1 條	237
第 23-2 條	240
第四章 業務與責任	241
第 24 條	241
〔釋例類別〕第 1 類 醫療輔助行為之範圍	242
〔釋例類別〕第 2 類 輔助藥物之投與及採血送檢	251
〔釋例類別〕第 3 類 輔助傷口照護	263
〔釋例類別〕第 4 類 輔助管路照護	271
〔釋例類別〕第 5 類 輔助牙齒及口腔照護	289
〔釋例類別〕第 6 類 輔助施行麻醉	296
〔釋例類別〕第 7 類 公共衛生預防保健	300
〔釋例類別〕第 8 類 輔助醫療儀器檢測	311
〔釋例類別〕第 9 類 其他（輔助病歷處理、協助石膏固定）	323
第 25 條	329

第 26 條	341
第 27 條	345
第 28 條	345
第五章 懲處	347
第 29 條	347
第 30 條	348
第 30-1 條	348
第 31 條	348
第 31-1 條	348
第 31-2 條	348
第 32 條	350
第 33 條	350
第 34 條	350
第 35 條	351
第 36 條	356
第 37 條	356
第 38 條	368
第 39 條	368
第 40 條	368
第 41 條	368
第 42 條	368
第六章 公會	368
第 43 條	368
第 44 條	368
第 45 條	368
第 46 條	368
第 47 條	368
第 48 條	369
第 49 條	369
第 50 條	369
第 51 條	369

第 52 條	370
第 53 條	370
第 54 條	370
第 54-1 條	370
第 55 條	370
第 55-1 條	371
第 55-2 條	371
第 55-3 條	371
第七章 附則	374
第 56 條	374
第 57 條	374
六、護理機構分類設置標準解釋彙編	377
第 1 條	377
第 2 條	377
第 3 條	377
第 4 條	378
第 5 條	378
第 6 條	378
第 7 條	378
第 8 條	379
〔釋例類別〕第 1 類 護理、社工及其他醫事人員之設置	379
〔釋例類別〕第 2 類 照顧服務員、嬰兒照顧人員之設置 及業務範圍	386
照顧服務員訓練實施計畫	403
〔釋例類別〕第 3 類 硬體空間	423
〔釋例類別〕第 4 類 設施及設備	447
第 9 條	457
第 10 條	460
第 10-1 條	460
第 11 條	460

附 錄

一、行政程序法	461
二、行政罰法	497
三、長期照顧服務法	509
四、長期照顧服務法施行細則	527
五、專科護理師分科及甄審辦法	531
六、長期照顧服務機構法人條例	541
七、長期照顧服務機構法人條例施行細則	555
八、專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法	561
九、護理機構評鑑辦法	563
十、助產人員法	567
十一、助產人員法施行細則	579
十二、助產機構設置標準	583
十三、醫事人員執業登記及繼續教育辦法	585
十四、實習護士實施要點	597
十五、醫院照顧服務員管理要點	599

一、護理人員法

護理人員法

1. 中華民國 80 年 5 月 17 日總統令制定公布全文 57 條
2. 中華民國 89 年 11 月 8 日總統(89)華總一義字第 8900270320 號令修正公布第 5~7、21、28 條條文；並增訂第 7-1 條條文
3. 中華民國 91 年 6 月 12 日總統華總一義字第 09100119160 號令修正公布第 32、33、38、43 條條文；並增訂第 18-1、19-1、23-1、50-1、55-1 條條文
4. 中華民國 96 年 1 月 29 日總統華總一義字第 09600011041 號令修正公布第 6、8、9、11、22、29~35、40、41、43、47~49、51~55、56、57 條條文；增訂第 18-2、30-1、54-1、55-2、55-3 條條文；刪除第 42、46 條條文；並自公布日施行
5. 中華民國 100 年 12 月 21 日總統華總一義字第 10000283841 號令修正公布第 16 條條文
6. 中華民國 102 年 7 月 19 日行政院院臺規字第 1020141353 號公告第 5 條所列屬「行政院衛生署」之權責事項，自 102 年 7 月 23 日起改由「衛生福利部」管轄
7. 中華民國 102 年 12 月 11 日總統華總一義字第 10200225141 號令修正公布第 25、44、47 條條文
8. 中華民國 103 年 8 月 20 日總統華總一義字第 10300123091 號令修正公布第 24 條條文
9. 中華民國 104 年 1 月 14 日總統華總一義字第 10400002301 號令修正公布第 5、23-1、28、33 條條文；並增訂第 23-2、31-1、31-2 條條文

第一章 總則

- 第 1 條 中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。
- 前項考試得以檢覈行之；其檢覈辦法，由考試院會同行政院定之。
- 第 2 條 本法所稱護理人員，指護理師及護士。
- 第 3 條 經護理人員考試及格者，得請領護理人員證書。
- 第 4 條 請領護理人員證書，應具申請書及資格證明文件，送請中央主管機關審核後發給之。
- 第 5 條 本法所稱主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第 6 條 有下列情形之一者，不得充護理人員；其已充護理人員者，撤銷或廢止其護理人員證書：

一、曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，經判刑確定。

二、曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定。

三、依本法受廢止護理人員證書處分。

第 7 條 非領有護理師或護士證書者，不得使用護理師或護士名稱。

非領有專科護理師證書者，不得使用專科護理師名稱。

第 7-1 條 護理師經完成專科護理師訓練，並經中央主管機關甄審合格者，得請領專科護理師證書。

前項專科護理師之甄審，中央主管機關得委託各相關專科護理學會辦理初審工作。領有護理師證書並完成相關專科護理師訓練者，均得參加各該專科護理師之甄審。

專科護理師之分科及甄審辦法，由中央主管機關定之。

第二章 執業

第 8 條 護理人員應向執業所在地直轄市、縣（市）主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。

護理人員執業，應每六年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新。

第一項申請執業登記之資格、條件、應檢附文件、執業執照發給、換發、補發、更新與前項繼續教育之課程內容、積分、實施方式、完成繼續教育之認定及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 9 條 有下列情形之一者，不得發給執業執照；已領者，撤銷或廢止之：

一、經廢止護理人員證書。

二、經廢止護理人員執業執照未滿一年。

三、罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關認定不能執行業務。

前項第三款原因消失後，仍得依本法規定申請執業執照。

主管機關依第一項第三款規定為認定時，應委請相關專科醫師鑑定。

第 10 條 護理人員非加入所在地護理人員公會，不得執業。
護理人員公會不得拒絕具有會員資格者入會。

第 11 條 護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。

前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業。

護理人員變更執業處所或復業者，準用關於執業之規定。

護理人員死亡者，由原發執業執照機關註銷其執業執照。

第 12 條 護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。

第 13 條 護理人員執業，其登記執業之處所，以一處為限。

第三章 護理機構之設置及管理

第 14 條 為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。

第 15 條 護理機構之服務對象如左：

一、罹患慢性病需長期護理之病人。

二、出院後需繼續護理之病人。

三、產後需護理之產婦及嬰幼兒。

第 16 條 護理機構之設置或擴充，應先經主管機關許可；其

申請人之資格、審查程序與基準、撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

護理機構之分類及設置標準，由中央主管機關定之。

第 17 條 護理機構之開業，應依左列規定，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照：

- 一、公立護理機構：由其代表人為申請人。
- 二、財團法人護理機構：由該法人為申請人。
- 三、私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。

第 18 條 護理機構名稱之使用或變更，應以主管機關核准者為限。

非護理機構不得使用護理機構或類似護理機構之名稱。

第 18-1 條 護理機構廣告，其內容以左列事項為限：

- 一、護理機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。
- 二、負責護理人員之姓名、性別、學歷、經歷、護理人員證書及執業執照字號。
- 三、業務項目及執業時間。
- 四、開業、歇業、停業、復業、遷移及其年、月、日。
- 五、其他經中央主管機關公告容許事項。

非護理機構，不得為護理業務之廣告。

第 18-2 條 護理機構不得使用下列名稱：

- 一、在同一直轄市或縣(市)區域內，他人已登記使用之護理機構名稱。
- 二、在同一直轄市或縣(市)區域內，與被廢止開業執照未滿一年或受停業處分之護理機構相同或類似之名稱。

三、易使人誤認其與政府機關、公益團體有關或有妨害公共秩序或善良風俗之名稱。

第 19 條 護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，其資格條件由中央主管機關定之。

私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其中請人為負責人。

第 19-1 條 護理機構負責護理人員因故不能執行業務，應指定合於負責人資格者代理之。代理期間超過一個月者，應報請原發開業執照機關備查。

前項代理期間，最長不得逾一年。

第 20 條 護理機構應與鄰近醫院訂定轉介關係之契約。

前項醫院以經主管機關依法評鑑合格者為限。

第一項契約終止、解除或內容有變更時，應另訂新約，並於契約終止、解除或內容變更之日起十五日內，檢具新約，向原發開業執照機關報備。

第 21 條 護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。

護理機構不得違反收費標準，超額收費。

第 22 條 護理機構停業、歇業或其登記事項變更時，應於事實發生之日起三十日內，報請原發開業執照機關備查。

護理機構遷移或復業者，準用關於設立之規定。

第 23 條 護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、收費、作業、衛生、安全、紀錄等之檢查及資料蒐集。

第 23-1 條 中央主管機關應辦理護理機構評鑑。直轄市、縣(市)主管機關對轄區內護理機構業務，應定期實施督導考核。

護理機構對前項評鑑及督導考核，不得規避、妨礙或拒絕。

第一項之評鑑、督導考核，必要時，得委託相關機構或團體辦理。

第 23-2 條 中央主管機關辦理護理機構評鑑，應將各機構評鑑之結果、有效期間及類別等事項公告之。

護理機構於評鑑合格有效期間內，違反本法或依本法所發布之命令，經主管機關令其限期改善，屆期未改善或其違反情節重大者，中央主管機關得調降其評鑑合格類別或廢止其評鑑合格資格。

護理機構評鑑之標準，包括對象、項目、評等、方式等，與評鑑結果之撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第四章 業務與責任

第 24 條 護理人員之業務如下：

- 一、健康問題之護理評估。
- 二、預防保健之護理措施。
- 三、護理指導及諮詢。
- 四、醫療輔助行為。

前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

專科護理師及依第七條之一接受專科護理師訓練期間之護理師，除得執行第一項業務外，並得於醫師監督下執行醫療業務。

前項所定於醫師監督下得執行醫療業務之辦法，由中央主管機關定之。

第 25 條 護理人員執行業務時，應製作紀錄。

前項紀錄應由該護理人員執業之機構依醫療法第七十條辦理。

第 26 條 護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。

第 27 條 護理人員受有關機關詢問時，不得為虛偽之陳述或報告。

第 28 條 除依前條規定外，護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，非依法、或經當事人或其法定代理人之書面同意者，不得洩漏。

第五章 懲處

第 29 條 護理機構有下列情形之一者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰；其情節重大者，並得廢止其開業執照：

- 一、容留未具護理人員資格者擅自執行護理業務。
- 二、從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務。
- 三、超收費用經查屬實，而未依限將超收部分退還。
- 四、受停業處分而不停業。

第 30 條 護理人員受停業處分仍執行業務者，廢止其執業執照；受廢止執業執照處分仍執行業務者，廢止其護理人員證書。

第 30-1 條 護理人員將證照租借予不具護理人員資格者使用，廢止其護理人員證書；租借予前述以外之人使用者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，得併處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其執業執照。

前項情形涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。

第 31 條 護理機構受廢止開業執照處分，仍繼續開業者，得由中央主管機關吊扣其負責護理人員證書二年。

第 31-1 條 違反依第十六條第二項所定設置標準者，應令其限期改善；屆期未改善者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未改善者，得處一個月以上一年以下停業處分；停業期滿仍未改善者，得廢止其設置許可。

第 31-2 條 護理機構依第二十三條之一第一項規定接受評鑑，經評鑑不合格者，除違反依第十六條第二項所定設置標

準，依前條規定處罰外，應令其限期改善；屆期未改善者，其屬收住式護理機構，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，其他護理機構，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設置許可。

第 32 條 違反第十六條第一項、第十七條、第十八條第一項、第十八條之一第一項、第二十條第三項、第二十二條或第二十三條規定者，處新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照。

第 33 條 違反第八條第一項、第二項、第十條第一項、第十二條、第十九條之一第一項、第二十三條之一第二項或第二十五條至第二十八條規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下之停業處分。

護理人員公會違反第十條第二項規定者，由人民團體主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

第 34 條 護理機構受廢止開業執照處分者，其負責護理人員於一年內不得申請設置護理機構。

第 35 條 護理人員於業務上有違法或不正當行為者，處一個月以上一年以下之停業處分；其情節重大者，得廢止其執業執照；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。

第 36 條 違反第十八條第二項或第二十一條第二項規定者，處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。

違反第二十一條第二項規定者，並應限期退還超額收費。

第 37 條 未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰

鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。

第 38 條 違反第七條或第十八條之一第二項規定者，處新臺幣一萬元以上六萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。

第 39 條 違反第十一條第一項規定者，處新台幣三千元以上三萬元以下罰鍰。

第 40 條 護理人員受廢止執業執照之處分時，應自事實發生之日起三日內將執照繳銷；其受停業之處分者，應將執照送由主管機關將停業理由及期限記載於該執照背面，仍交由本人收執，期滿後方准復業。

第 41 條 本法所定之罰鍰、停業、撤銷或廢止執業執照、開業執照，除本法另有規定外，由直轄市、縣（市）主管機關處罰之；撤銷、廢止或吊扣護理人員證書，由中央主管機關處罰之。

第 42 條 （刪除）

第六章 公會

第 43 條 護理人員公會分直轄市及縣（市）公會，並得設護理人員公會全國聯合會。

第 44 條 護理人員公會之區域，依現有之行政區域，在同一區域內，同級之公會以一個為限。但於行政區域調整變更前已成立者，不在此限。

第 45 條 直轄市及縣（市）護理人員公會，由該轄區域內護理人員九人以上發起組織之；未滿九人者，得加入鄰近區域之公會或共同組織之。

第 46 條 （刪除）

第 47 條 護理人員公會全國聯合會應由三分之一以上之直轄市、縣（市）護理人員公會完成組織後，始得發起組織。

前項護理人員公會聯合會成立後，本法第四十五條

之直轄市及縣（市）護理人員公會應加入之。

第 48 條 各級護理人員公會，由人民團體主管機關主管。但其目的事業，應受主管機關之指導、監督。

第 49 條 各級護理人員公會置理事、監事，均於召開會員（會員代表）大會時，由會員（會員代表）選舉之，並分別成立理事會、監事會，其名額如下：

一、直轄市、縣（市）護理人員公會之理事，不得超過二十七人。

二、護理人員公會全國聯合會之理事，不得超過三十五人。

三、各級護理人員公會之理事名額，不得超過全體會員（會員代表）人數二分之一。

四、各級護理人員公會之監事名額，不得超過各該公會理事名額三分之一。

各級護理人員公會得置候補理事、候補監事；其名額不得超過各該公會理事、監事名額三分之一。

理事、監事名額在三人以上者，得分別互選常務理事、常務監事，其名額不得超過理事或監事總額三分之一，並應由理事就常務理事中選舉一人為理事長；其不置常務理事者，就理事中互選之。常務監事在三人以上者，應互選一人為監事會召集人。

第 50 條 理、監事任期均為三年，連選連任者不得超過二分之一；理事長之連任，以一次為限。

第 50-1 條 上級護理人員公會理事、監事之當選，不限於下級護理人員公會選派參加之會員代表。

下級護理人員公會選派參加上級護理人員公會之會員代表，不限於該下級護理人員公會之理事、監事。

第 51 條 護理人員公會每年召開會員（會員代表）大會一次，必要時得召開臨時大會。護理人員公會會員人數超過三百人時，得依章程之規定，就會員分布狀況劃定區域，按其會員人數比率選定代表，召開會員代表大會，行

使會員大會之職權。

第 52 條 護理人員公會應訂立章程，造具會員名冊及選任職員簡歷名冊，送請所在地人民團體主管機關立案，並分送中央及所在地主管機關備查。

第 53 條 各級護理人員公會之章程，應載明下列事項：

- 一、名稱、區域及會所所在地。
- 二、宗旨、組織、任務或事業。
- 三、會員之入會及出會。
- 四、會員應納之會費及繳納期限。
- 五、會員代表之產生及其任期。
- 六、理事、監事名額、權限、任期及其選任、解任。
- 七、會員（會員代表）大會及理事會、監事會會議之規定。
- 八、會員應遵守之公約。
- 九、經費及會計。
- 十、章程之修改。
- 十一、其他依法令規定應載明或處理會務之必要事項。

第 54 條 護理人員公會違反法令或章程者，人民團體主管機關得為下列之處分：

- 一、警告。
- 二、撤銷其決議。
- 三、撤免其理事、監事。
- 四、限期整理。

前項第一款、第二款處分，亦得由主管機關為之。

第 54-1 條 直轄市、縣（市）護理人員公會對護理人員公會全國聯合會之章程及決議，有遵守義務。

第 55 條 護理人員公會之會員有違反法令或章程之行為者，公會得依章程、理事會、監事會或會員（會員代表）大會之決議處分。

第 55-1 條 中央或直轄市、縣（市）主管機關依本法核發證書或執照時，得收取證書費或執照費；其費額，由中央主管機關定之。

第 55-2 條 本法中華民國九十六年一月九日修正之條文施行前已立案之護理人員公會全國聯合會，應自本法修正施行之日起四年內，依本法規定完成改組；已立案之省護理人員公會，應併辦理解散。

第 55-3 條 外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試。

前項考試及格，領有護理人員證書之外國人與華僑，在中華民國執行護理業務，應經中央主管機關許可，並應遵守中華民國關於護理與醫療之相關法令及護理人員公會章程；其執業之許可及管理辦法，由中央主管機關定之。

違反前項規定者，除依法處罰外，中央主管機關並得廢止其許可。

第七章 附則

第 56 條 本法施行細則，由中央主管機關定之。

第 57 條 本法自公布日施行。

二、護理人員法施行細則

護理人員法施行細則

1. 中華民國 81 年 4 月 29 日行政院衛生署(81)衛署保字第 819951 號令、內政部(81)台內社字第 8172847 號令會銜訂定發布全文 35 條
2. 中華民國 87 年 9 月 9 日行政院衛生署(87)衛署醫字第 87052957 號令、內政部(87)台內社字第 8793338 號令會銜修正發布第 8、15 條條文
3. 中華民國 89 年 1 月 20 日行政院衛生署(89)衛署醫字第 88057609 號令、內政部(89)台內社字第 8809950 號令會銜修正發布第 21 條條文
4. 中華民國 90 年 5 月 10 日行政院衛生署(90)衛署醫字第 0900025315 號令、內政部(90)台內中社字第 9017077 號令會銜修正發布第 8 條條文
5. 中華民國 97 年 3 月 21 日行政院衛生署衛署醫字第 0970011087 號令修正發布全文 18 條；並自發布日施行
6. 中華民國 105 年 11 月 3 日衛生福利部衛部照字第 1051564285 號令修正發布第 7 條條文

第 1 條 本細則依護理人員法（以下簡稱本法）第五十六條規定訂定之。

第 2 條 依本法第四條規定請領護理人員證書者，應填具申請書，檢附考試院頒發之護理人員考試及格證書，並繳納證書費，送請中央主管機關核發。

第 3 條 護理人員證書滅失或遺失者，應填具申請書，並繳納證書費，向中央主管機關申請補發。

護理人員證書損壞者，應填具申請書，並繳納證書費，連同原證書，向中央主管機關申請換發。

第 4 條 護理人員停業、歇業，依本法第十一條第一項規定報請備查時，應填具申請書，並檢附執業執照及有關文件，送由原發給執業執照機關依下列規定辦理：

一、停業：登記其停業日期及理由後，發還其執業執照。

二、歇業：註銷其執業登記及執業執照。

第 5 條 依本法第十六條第一項規定，申請許可設置或擴充

護理機構，應檢具下列文件：

- 一、設置或擴充計畫書，包括申請人、護理機構名稱、建築地址、設置類別、設立床數、基地面積、建築面積、人員配置、設立進度、經費概算、擬定開業日期及其他依護理機構分類及設置標準規定應記載事項。
- 二、位置圖。
- 三、護理機構配置簡圖。
- 四、由其他法人依有關法律規定附設者，應檢附各該法人主管機關同意函件。

護理機構之設置或擴充經許可後，其申請人、設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可。

第 6 條 依本法第十六條第一項規定申請許可設置或擴充護理機構，依下列規定辦理：

一、公立護理機構或私立護理機構：

- (一) 設置或擴充後之規模在九十九床以下者，由所在地直轄市或縣（市）主管機關許可。
- (二) 設置或擴充後之規模在一百床以上，或由醫療法人依醫療法規定附設者，由所在地直轄市或縣（市）主管機關核轉中央主管機關許可。

二、財團法人護理機構：由所在地直轄市或縣（市）主管機關核轉中央主管機關許可。

第 7 條 護理機構依本法第十七條規定申請開業，應填具申請書，檢附下列書件，並繳納開業執照費，向所在地直轄市或縣（市）主管機關申請：

- 一、護理機構平面簡圖，並以平方公尺註明樓層、各隔間面積、用途說明及總面積。
- 二、主管機關許可設置或擴充文件。
- 三、建築物合法使用證明文件。

- 四、負責護理人員之證明文件。
- 五、配置之醫事人員及相關人員名冊。
- 六、設施、設備之項目。
- 七、依本法第二十條規定與醫院所訂定之契約。
- 八、其他依規定應檢具之文件。

直轄市或縣（市）主管機關對於前項之申請，經派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。

申請於原住民族地區設立居家護理機構，經直轄市、縣（市）主管機關認定確無危險之虞者，於取得第一項第三款所定文件前，得以經開業之建築師、執業之土木工程科技師或結構工程科技師出具之結構安全鑑定證明文件，及經直轄市、縣（市）消防主管機關查驗合格之簡易消防安全設備配置平面圖替代之；並應每年報直轄市、縣（市）主管機關備查，直轄市、縣（市）主管機關於許可後應持續輔導及管理。

前項原住民族地區之適用範圍，由中央原住民族主管機關公告之。

第 8 條 本法第十七條所定護理機構核准登記事項如下：

- 一、名稱、地址及開業執照字號。
- 二、申請人之姓名、國民身分證統一編號、出生年月日、住址；申請人為法人者，其名稱、事務所所在地及其代表人姓名。
- 三、負責護理人員之姓名、國民身分證統一編號、出生年月日、證書字號及住址。
- 四、依本法第十六條規定申請審核許可之床數、日期及字號。
- 五、依本法第二十條規定訂定契約醫院之名稱、地址及開業執照字號。
- 六、業務項目。
- 七、其他依規定應行登記事項。

第 9 條 本法第十八條所定護理機構名稱之使用或變更，依

下列規定辦理：

- 一、護理機構，應依護理機構之分類標明其名稱。
- 二、醫療機構附設之護理機構，應冠以醫療機構名稱，並加註附設字樣。
- 三、財團法人護理機構，應冠以財團法人字樣。
- 四、依本法第十七條第三款由其他法人依有關法律規定附設者，應冠以其法人名稱，並加註附設字樣。
- 五、其他經中央主管機關核准使用之名稱。

第 10 條 護理機構開業執照減失或遺失者，應填具申請書，並繳納開業執照費，向原發給開業執照機關申請補發。

開業執照損壞者，應填具申請書，並繳納開業執照費，連同原開業執照，向原發給開業執照機關申請換發。

第 11 條 本法第十九條第一項所定護理機構負責資深護理人員之資格條件，應具備從事臨床護理工作年資七年以上，或以護理師資格登記執業從事臨床護理工作年資四年以上。

第 12 條 本法第二十條第一項所稱之契約，其內容應包括急救、急診、轉診及定期出診等事項。

第 13 條 護理機構停業、歇業或其登記事項變更，依本法第二十二條第一項規定報請備查時，應填具申請書，並檢附開業執照及有關文件，送由原發給開業執照機關依下列規定辦理：

- 一、停業：於其開業執照註明停業日期及理由後發還。
- 二、歇業：註銷其開業登記及開業執照。
- 三、登記事項變更：辦理變更登記。

前項第三款登記事項變更，如需換發開業執照，申請人應依規定繳納開業執照費。

第 14 條 護理機構停業、歇業或受停業、撤銷、廢止開業執照處分者，其所屬護理人員，應依本法第十一條第一項

、第三項規定辦理停業、歇業或變更執業處所。

第 15 條 護理機構歇業或受撤銷、廢止開業執照處分者，應將其招牌拆除。

第 16 條 主管機關依本法第二十三條規定執行檢查及資料蒐集時，其檢查及資料蒐集人員應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。

第 17 條 直轄市或縣（市）主管機關依本法第二十三條之一規定辦理護理機構業務督導考核，應訂定計畫實施，每年至少辦理一次。

第 18 條 本細則自發布日施行。

三、護理機構分類設置標準

護理機構分類設置標準

1. 中華民國 82 年 8 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 8247383 號令訂定發布全文 14 條，自發布日施行
2. 中華民國 85 年 3 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 85013102 號令修正發布第 11 條附表
3. 中華民國 87 年 6 月 17 日行政院衛生署衛署醫字第 87032530 號令修正發布全文 11 條
4. 中華民國 92 年 10 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 0920216079 號令修正發布第 8 條附表「護理機構設置標準表」
5. 中華民國 97 年 9 月 23 日行政院衛生署衛署醫字第 0970205502 號令修正發布名稱及第 2 條、第 3 條、第 9 條條文；並刪除第 10 條條文(原名稱:護理機構設置標準)
6. 中華民國 100 年 12 月 2 日行政院衛生署衛署照字第 1002863077 號令修正發布第 8 條附表，並增訂第 10 條之 1 條文
7. 中華民國 102 年 8 月 9 日衛生福利部衛部照字第 1021580033 號令修正發布第 8 條附表

第 1 條 本標準依護理人員法（以下簡稱本法）第十六條第二項規定訂定之。

第 2 條 護理機構，分類如下：

- 一、居家護理機構。
- 二、護理之家。
- 三、產後護理機構。

第 3 條 產後護理機構之服務對象，以下列各款產後需護理之產婦及嬰幼兒為限：

- 一、產後未滿二個月之產婦。
- 二、出生未滿二個月之嬰幼兒。

前項各款服務對象，經醫師診斷有特殊需要者，得不受二個月之限制。

第 4 條 居家護理機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要，至少每二個月由醫師再予診察一次。

第 5 條 護理之家機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要，至少每個月由醫師再予

診察一次。

第 6 條 居家護理機構及護理之家機構，對於轉診及醫師每次診察之病歷摘要，應連同護理紀錄依規定妥善保存。

第 7 條 護理機構之負責資深護理人員，應督導其機構所屬護理人員及其他人員，善盡業務上必要之注意。

第 8 條 護理機構之設置，其設置標準如附表「護理機構設置標準表」。

第 9 條 居家護理機構之設置，其設立計畫書內容，應載明下列事項：

- 一、服務對象之條件。
- 二、服務區域。
- 三、病人轉介流程。
- 四、服務品質管制制度。
- 五、經費需求及來源。

前項第二款服務區域，跨直轄市或縣（市）行政區域提供服務者，應事先經各該直轄市或縣（市）主管機關核准。

第 10 條 （刪除）

第 10-1 條 本標準修正施行前已設置之護理機構與本標準規定不符者，應於本標準修正施行之日起六個月內完成補正。

第 11 條 本標準自發布日施行。

第八條附表修正規定

護理機構設置標準表

區分 設置標準 項目		護理之家機構		產後護理機構 (產後護理之家)	居家護理機構	備註
		一般護理之家	精神護理之家			
一、人員	(一) 護理人員	1、十五床至少應有一人。 2、設有日間照護者，按登記提供服務量，每登記提供二十人之服務量，應增置一人。 3、負責資深護理人員，應具本法施行細則第十一條所定之資格與條件。 4、二十四小時均應有護理人員值班。 5、收住呼吸器依賴個案達四床以上者，其人員應符合下列規定： (1) 每十床應有一人，不足十床以十床計。 (2) 至少有一位護理人員具備呼吸照護臨床經驗二年。 (3) 收住呼吸器依賴個案以二十四床為計算單位，每超過二十四床應再增加一人。	1、每二十床應有一人。 2、設有日間照護者，按登記提供服務量，每登記提供二十人之服務量，應增置一人。 3、負責資深護理人員，應具本法施行細則第十一條所定之資格與條件。 4、二十四小時均應有護理人員值班。	1、每十五床(含嬰兒床)至少應有一人。 2、負責資深護理人員，應具本法施行細則第十一條所定之資格與條件。 3、二十四小時均應有護理人員值班。	負責資深護理人員，應具本法施行細則第十一條所定之資格與條件。	一、一般護理之家收住呼吸器依賴個案人數，不得逾機構許可床數之二分之一。 二、精神護理之家服務對象：精神病症狀穩定且呈現慢性化，需生活照顧之精神病患，且應符合本標準第五條之規定。 三、任何時段護理人員及照顧服務員之總數與住民人數比例： (一) 一般護理之家不得低於一比十五，且須視各班別之工作內容增加適當人

護理機構分類設置標準

						力。 (二)精神護理之家不得低於一比二十,且須視各班別之工作內容增加適當人力;夜間照顧人力並得計入輔助人員,如駐衛警、保全人員、行政人員等。 四、護理人員最低設置總人數,一般護理之家應能同時符合1及4,產後護理機構(產後護理之家)應能同時符合1及3。
	(二)照顧服務員	每五床應有一人以上。	每十床應有一人。	視業務需要設置。	視業務需要設置。	一、得由具護理人員資格者擔任並計列其人數。 二、任何時段護理人員及照顧服務員之總數與住民人數比例: (一)一般護理之

					家不得低於一比十五，且須視各班別之工作內容增加適當人力。 (二)精神護理之家不得低於一比二十，且須視各班別之工作內容增加適當人力；夜間照顧人力並得計入輔助人員，如駐衛警、保全人員、行政人員等。
	(三)嬰兒照顧人員			每五床嬰兒床應置嬰兒照顧人員一人。	一、嬰兒照顧人員應具備下列資格之一： (一)護理、助產及幼兒保育相關學科、系、所畢業。 (二)取得保母人員技術士證。 (三)修畢保母專業訓練課程，並領有結業證書。 二、嬰兒照顧人員

護理機構分類設置標準

					資格自中華民國一百零一年七月一日起適用。 三、高於設置標準之護理人員人數可聘人採計為應聘人嬰兒照顧員數。
(四) 社會工作人員	1、未滿一〇〇床者，應指定專人負責社會服務工作。 2、一〇〇床至二〇〇床以下者，應有一人。 3、二〇〇床以上者，至少應有二人。	1、每一百床應有一人。 2、未滿一百床者，應有兼任之社會工作人員。		視業務需要設置。	
(五) 職能治療人員	得視業務需要專任或特約職能治療人員。	1、每二百床應有一人。 2、未滿二百床者，應有兼任之職能治療人員， 3、二百床以上者，至少應有一名職能治療師。		得視業務需要專任或特約職能治療人員。	職能治療人員，係指職能治療師或職能治療生。
(六) 臨床心理人員		1、每二百床應有一人。 2、未滿二百床者，應有兼任之臨床心理人員，			臨床心理人員，係指下列人員： 一、臨床心理師。 二、符合心理師法第六十一條第四項規定者。

	(七) 其他人員	1、應有指定人員管理護理紀錄。 2、得視業務需要置專任或特約醫師、物理治療師、物理治療生及營養師。 3、收住呼吸器依賴個案達四床以上者，應符合下列規定： (1) 特約受過胸腔或重症加護相關訓練之相關專責專科醫師至少一名。 (2) 特約、專任或兼任呼吸治療人員至少一名。	1、應有指定人員管理工作紀錄。 2、得視業務需要置專任或特約精神科醫師。 3、得視業務需要置專任或特約物理治療師、物理治療生及營養師。	應有指定人員管理護理紀錄。	1、應有指定人員管理護理紀錄。 2、得視業務需要置專任或特約醫師、物理治療師、物理治療生及營養師。	
二、護理服務設施	(一) 住房	1、不得設於地下樓層。 2、應設寢室並符合下列規定： (1) 床尾與牆壁(床尾)間之距離至少一公尺。 (2) 床邊與鄰床之距離至少零點八公尺。 (3) 床邊與牆壁距離至少零點八公尺。 (4) 每床應具有床頭櫃及與護理站之呼叫器。 (5) 每床應有床欄及調節高度之裝置。 (6) 二人或多人床之寢	1、不得設於地下樓層。 2、應設寢室並符合下列規定： (1) 床尾與牆壁(床尾)間之距離至少一公尺。 (2) 床邊與鄰床之距離至少零點八公尺。 (3) 床邊與牆壁距離至少零點八公尺。 (4) 二人或多人床之寢室，應備有隔離視線的	1、不得設於地下樓層。 2、應設寢室，其為二人或多人床之寢室，應備有隔離視線的屏障物。 3、應設護理站，並具有下列設備： (1) 治療車。 (2) 護理紀錄、藥品及醫療器材存放櫃。 (3) 污物處理設備。 (4) 緊急應變應		一、本標準中華民國一百零二年八月六日修正施行前已設立之機構或已許可擴充之床數，其後僅變更機構負責人(其餘開業登記項目均未變更)者，(一)一般護理之家其寢室免受標準2.(1)、(3)及(7)

護理機構分類設置標準

	室，應備有隔離視線之屏障物。 (7)每一寢室以六床為限。 3、收住呼吸器依賴個案達四床以上者，其病房應符合下列規定： (1)應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床。 (2)每床最小面積（不含浴廁、護理站）至少應有七點五平方公尺。 (3)床邊與鄰床之距離至少應有一公尺。 (4)床邊與牆壁距離至少一公尺。 (5)每床應有中央氣體供應系統（含氧氣、抽吸設備）或每床設置移動式之氧氣、抽吸設備。 (6)使用移動式氧氣筒，應有獨立儲存空間，並有安全防護設備。 (7)每床備有呼吸器。 (8)心肺血壓監視器。 (9)收住呼吸器依賴個案區域應有適當之	屏障物。 (5)每一寢室以六床為限。 3、設有日間照護者，視需要設置休息床位。 4、應設護理站，並具有下列設備： (1)準備室、工作車。 (2)護理紀錄、工作紀錄、藥品及醫療器材存放櫃。 (3)應有下列急救設備： ①氧氣。 ②鼻管。 ③人工氣道。 ④氧氣面罩。 ⑤抽吸設備。 ⑥喉頭鏡。 ⑦氣管內管。 ⑧甦醒袋。 ⑨常備急救藥品。 (4)輪椅。 (5)污物處理設備。 (6)逃生滑墊或軟式擔架。 (7)緊急應變應勤	勤裝備。 4、應有空調設備。 5、應有被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏設施，應隨時上鎖。	規定之限制。 (二)精神護理之家其寢室免受標準2.(1)、(3)及(5)規定之限制。 二、緊急應變應勤裝備包括： (一)哨子或可攜式擴音器、可保護眼、口、鼻之防煙面罩或濾罐式防煙面罩及指揮棒等。 (二)兩層樓(含)以上之機構應備無線電及其備用電池。
--	--	---	---	---

		空調。 4、設有日間照護者，視需要設置休息床位。 5、應設護理站，並具有下設備： (1)準備室、工作車。 (2)護理紀錄、藥品及醫療器材存放櫃。 (3)應有下列急救設備： ①氧氣。 ②鼻管。 ③人工氣道。 ④氧氣面罩。 ⑤抽吸設備。 ⑥喉頭鏡。 ⑦氣管內管。 ⑧甦醒袋。 ⑨常備急救藥品。 (4)輪椅。 (5)污物處理設備。 (6)逃生滑墊或軟式擔架。 (7)緊急應變應勤裝備。 6、設置呼吸器照護床之規模達二十四床者，應另設立護理站；每超過四十床，應再增設一個護理站。 7、應有空調設備。 8、應有被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏設施	5、應有空調設備。 6、應有被褥、床單存放櫃及雜物之貯藏設施，且應隨時上鎖。		
--	--	--	--	--	--

護理機構分類設置標準

		，應隨時上鎖。				
	(二) 嬰兒室			應設嬰兒室並具有下列設備： (1)調奶台、奶品貯存及冷藏設備。 (2)專用之嬰兒洗澡台及工作台。 (3)於入口處設洗手台。 (4)空調設備。 (5)應有下列急救設備： ①氧氣。 ②鼻管。 ③人工氣道。 ④氧氣面罩。 ⑤抽吸設備。 ⑥喉頭鏡。 ⑦氣管內管。 ⑧甦醒袋。 ⑨常備急救藥品。		
	(三) 復健服務設施	視需要設置物理治療、職能治療室。	1、應有適當之會談空間。 2、視需要設置職能治療室。 3、應有適當之健身設備。 4、應有電視、音響及其他適當之康樂設備。			
	(四) 日	按病床數計，平均每床應有四平方公尺以上。	按病床數計，平均每床應有四·五平方公	按病床數(不包括嬰兒床)計，平均每床		

	常活動場所		尺以上。	應有一·五平方公尺以上。		
	(五) 衛浴設備	1、住房應設衛生設備及淋浴設備，且每六人至少應有一套。 2、應有為臥床或乘坐輪椅病人特殊設計之衛浴設備。 3、多人使用之衛浴設備，應有適當之隔間或門簾。 4、應有扶手及緊急呼叫系統。	1、住房應設衛生設備及淋浴設備，且每六人至少應有一套，未滿六人以六人計。 2、多人使用之衛浴設備，應有適當之隔間或門簾。 3、應有扶手。	每寢室應設衛浴設備。		本標準中華民國一百零二年八月前已設立之機構或床數，其後僅變更機構負責人（其餘開業登記項目均未變更）者，其住房免受標準1規定之限制。
	(六) 其他	1、應有護理紀錄放置設施。 2、應有醫材儲藏設施。	1、應有護理紀錄放置設施。 2、應有醫材儲藏設施。	1、應有護理紀錄放置設施。 2、應有醫材儲藏設施。	1、應有護理紀錄放置設施。 2、應有醫材儲藏設施。	
三、建築物之設計構造與	(一) 總樓地板面積	1、平均每床應有十六平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。 2、設有日間照護者，按登記提供服務量計，平均每人應有十平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。	1、平均每床應有二十平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。 2、設有日間照護者，按登記提供服務量計，平均每人應有十平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。	平均每床（不含嬰兒床）應有十六平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。		

護理機構分類設置標準

設備	(二) 一般設施	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房寢室應有可資自然採光之窗戶。 3、住房走道淨寬至少一·四公尺。 4、住房、寢室及衛浴設備，至少應各有一扇門，且寬度至少為○·八公尺。 5、主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。 6、浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對身心障礙或行動不便者之特殊設計。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房寢室應有可資自然採光之窗戶。 3、住房走道淨寬至少一·四公尺。 4、住房、寢室及衛浴設備，至少應各有一扇門，且寬度至少為○·八公尺。 5、主要走道台階處，應有推床或輪椅之專用斜坡道。 6、浴廁、走道、公共電話等公共設施，應有對身心障礙或行動不便者之特殊設計。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房寢室應有可資自然採光之窗戶。 3、住房寢室及衛浴設備，至少應各有一扇門，且寬度至少為○·八公尺。		
	(三) 空調設備	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、中央空氣調節系統之電源開關應具有連動切斷之功能。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、中央空氣調節系統之電源開關應具有連動火警探測之功能。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、嬰兒室應維持攝氏二十四度至二十八度；相對濕度五十至八十百分比。 3、中央空氣調節系統之電源開關應具有連動火警探測之功能。		

			測設備自動切斷之功能。		
(四) 消防設備	應符合建築法及消防法暨其有關法規規定。	應符合建築法及消防法暨其有關法規規定。	應符合建築法及消防法暨其有關法規規定。		
(五) 安全設備	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房走道、樓梯及平台應設有扶手、欄杆。 3、樓梯、走道及浴廁地板，應有防滑措施。 4、住房浴廁應設有扶手，並設有緊急呼叫系統。 5、各樓層安全區劃之防火門，應可兩端開啟且不得上鎖。 6、所有隔間牆、走道、牆壁、地板、天花板，均採用防火構造或耐燃建材。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房走道、樓梯及平台應設有扶手、欄杆。 3、樓梯、走道及浴廁地板，應有防滑措施。 4、住房浴廁應設有扶手，並設有緊急呼叫系統。 5、各樓層安全區劃之防火門，應可兩端開啟且不得上鎖。 6、所有隔間牆、走道、牆壁、地板、天花板，均採用防火構造或耐燃建材。	1、應符合建築法及其有關法規規定。 2、住房走道、樓梯及平台應設有扶手、欄杆。 3、樓梯、走道及浴廁地板，應有防滑措施。 4、住房浴廁應設有扶手。 5、各樓層安全區劃之防火門，應可兩端開啟且不得上鎖。 6、所有隔間牆、走道、牆壁、地板、天花板，均採用防火構造或耐燃建材。		
四、其他	1、應維持機構內外環境整潔。 2、寢室應通風、光線充足。 3、廚房應維持清潔，並	1、應維持機構內外環境整潔。 2、寢室應通風、光線充足。 3、廚房應維持清潔	1、應維持機構內外環境整潔。 2、寢室應通風、光線充足。 3、廚房應維持清潔		

護理機構分類設置標準

	設有食物貯藏及冷凍設備。 4、用水供應應充足，飲用水並應符合飲用水水質標準之規定。 5、應有適當照明設備。 6、應有蚊、蠅、蟑螂、鼠害防治之適當措施。 7、設太平間者，應具有屍體冷藏設備。 8、儲藏空間及儲存易燃或可燃性物品之空間，應隨時上鎖，並建置適用之火警探測器或自動撒水頭。	，並設有食物貯藏及冷凍設備。 4、用水供應應充足，飲用水並應符合飲用水水質標準之規定。 5、應有適當照明設備。 6、應有蚊、蠅、蟑螂、鼠害防治之適當措施。 7、儲藏空間及儲存易燃或可燃性物品之空間，應隨時上鎖，並建置適用之火警探測器或自動撒水頭。	，並設有食物貯藏及冷凍設備。 4、用水供應應充足，飲用水並應符合飲用水水質標準之規定。 5、應有適當照明設備。 6、應有蚊、蠅、蟑螂、鼠害防治之適當措施。 7、儲藏空間及儲存易燃或可燃性物品之空間，應隨時上鎖，並建置適用之火警探測器或自動撒水頭。		
--	--	--	--	--	--

四、護理機構設置或擴充許可辦法

護理機構設置或擴充許可辦法

中華民國 101 年 12 月 19 日行政院衛生署衛署照字第 1012864546 號令
訂定發布全文 14 條；並自發布日施行

第 1 條 本辦法依護理人員法（以下稱本法）第十六條第一項規定訂定之。

第 2 條 護理機構設置或擴充床數時，應申請許可，其申請人之資格如下：

- 一、公立護理機構，為其代表人。
- 二、財團法人護理機構，為該法人。
- 三、私立護理機構，為其負責資深護理人員。但其他法人依有關法律規定附設之護理機構，為該法人。

第 3 條 護理機構申請設置或擴充許可，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關提出。其為護理之家機構、產後護理機構設置或擴充後之規模在九十九床以下者及居家護理機構，由所在地直轄市、縣（市）主管機關許可；其為護理之家機構、產後護理機構設置或擴充後之規模在一百床以上者，由所在地直轄市、縣（市）主管機關初審通過後，報中央主管機關許可。

財團法人護理機構或其他法人依有關法律規定附設之護理機構，申請設置或擴充許可，應向所在地直轄市、縣（市）主管機關提出，由所在地直轄市、縣（市）主管機關初審通過後，報中央主管機關許可。

第 4 條 護理機構申請設置或擴充，應檢具下列文件：

- 一、設置或擴充計畫書及計畫摘要一式各四份。
- 二、財團法人護理機構及其他法人附設者，應分別檢具董事會或社員總會同意護理機構設置或擴充之會議紀錄一式各四份。
- 三、其他法人依有關法律附設者，應檢具該法人主管機關及其目的事業主管機關同意函件。

第 5 條 護理之家機構及產後護理機構計畫書，應載明下列事項：

- 一、護理機構名稱、設置類別、申請人、設立床數、組織架構、人員配置等相關基本資料。
- 二、設置或擴充之目的、當地資源概況、住民來源分析、住民轉介流程、服務品質管理及營運後三年內機構業務預估。
- 三、建築地址（地號）、建物位置圖、基地面積、建築面積、設置或擴充前後之總樓地板及各樓層地板面積及樓層平面配置圖；擴充者應檢附擴充前後配置對照表。
- 四、土地使用取得情形，包括用途類別、用途變更及應否實施環境影響評估。
- 五、經費需求、來源及使用計畫。
- 六、設置進度、預定開業日期及床數開放期程、收費、服務契約。
- 七、申請擴充者，其最近三年之財務報告。
- 八、其他依護理機構分類設置標準規定應記載事項。

第 6 條 居家護理機構計畫書，應載明下列事項：

- 一、護理機構名稱、設置類別、申請人、組織架構、人員配置等相關基本資料。
- 二、設置目的、當地資源概況、服務對象之條件、服務區域、病人轉介流程、服務品質管理及營運後三年內機構業務預估。
- 三、機構地址、總樓地板面積及樓層平面配置圖。
- 四、經費需求、來源及使用計畫。
- 五、設置進度、預定開業日期及收費。

第 7 條 護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。

第 8 條 護理之家機構及產後護理機構之床數，依所在地直轄市、縣（市）主管機關之統計資料顯示，其最近三年之平均占床率未達百分之六十五者，及前一年度主管機關評鑑或督導考核不合格者，不得申請擴充床數。

第 9 條 護理機構經許可設置或擴充之床數，有下列情事之一者，得廢止其許可或核減其已許可之床數：

- 一、自許可之日起，逾三年未取得建造執照。
- 二、自取得建造執照之日起，逾五年未取得使用執照。
- 三、自取得使用執照之日起，許可設置或擴充之床數，逾二年未全數開放使用或開放使用後再行停止使用逾二年。
- 四、最近三年內，已開放床數之占床率，依所在地直轄市、縣（市）主管機關之統計資料顯示，未達百分之五十。
- 五、已完成開放使用後，因故停業一年以上。
- 六、經直轄市、縣（市）主管機關廢止或撤銷開業執照。

本辦法施行前，經主管機關原則同意設置之床數，應自本辦法施行日起一年內，取得主管機關許可，屆期未取得許可者，應廢止或核減其原則同意之床數。

第 10 條 護理機構有下列情事之一，致未能依前條限定之日期完成開放使用時，得檢具相關資料、證明文件及床數分期開放之具體計畫書申請展延：

- 一、依相關法規規定須辦理機構基地土地用途變更、環境影響評估、水土保持處理等事項，受相關目的事業主管機關辦理時效影響。
- 二、受不可抗力之災害影響。
- 三、其他不可歸責於該機構之事由。

前項展延之申請，準用第三條有關申請設置或擴充許可之規定；展延之申請，於前條第一項第一款至第三

護理機構設置或擴充許可辦法

款各階段，各以一次為限。

第 11 條 第九條第一項第一款至第三款規定期間及前條許可展延期間，合計不得逾十年。

第 12 條 申請人有以詐欺或不實之資料，取得許可之情事者，主管機關得撤銷其許可。

第 13 條 本辦法施行前，已取得設置或擴充許可者，第九條第一項第一款至第三款及第十一條所定期間，自本辦法施行日起算。

第 14 條 本辦法自發布日施行。

五、護理人員法解釋彙編

護理人員法解釋彙編

1. 中華民國 80 年 5 月 17 日總統令制定公布全文 57 條
2. 中華民國 89 年 11 月 8 日總統（89）華總一義字第 8900270320 號令修正公布第 5～7、21、28 條條文；並增訂第 7-1 條條文
3. 中華民國 91 年 6 月 12 日總統華總一義字第 09100119160 號令修正公布第 32、33、38、43 條條文；並增訂第 18-1、19-1、23-1、50-1、55-1 條條文
4. 中華民國 96 年 1 月 29 日總統華總一義字第 09600011041 號令修正公布第 6、8、9、11、22、29～35、40、41、43、47～49、51～55、56、57 條條文；增訂第 18-2、30-1、54-1、55-2、55-3 條條文；刪除第 42、46 條條文；並自公布日施行
5. 中華民國 100 年 12 月 21 日總統華總一義字第 10000283841 號令修正公布第 16 條條文
6. 中華民國 102 年 7 月 19 日行政院院臺規字第 1020141353 號公告第 5 條所列屬「行政院衛生署」之權責事項，自 102 年 7 月 23 日起改由「衛生福利部」管轄
7. 中華民國 102 年 12 月 11 日總統華總一義字第 10200225141 號令修正公布第 25、44、47 條條文
8. 中華民國 103 年 8 月 20 日總統華總一義字第 10300123091 號令修正公布第 24 條條文
9. 中華民國 104 年 1 月 14 日總統華總一義字第 10400002301 號令修正公布第 5、23-1、28、33 條條文；並增訂第 23-2、31-1、31-2 條條文

第一章 總則

第 1 條 中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。

前項考試得以檢覈行之；其檢覈辦法，由考試院會同行政院定之。

103.9.12 衛部照字第 1031561619 號函

主旨：有關 台端陳詢護理師證書資格疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復 台端 103 年 9 月 1 日陳情書辦理。

二、按護理人員法第 1 條規定略以：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員……」。暨同法第 3 條規定：「經護理人員考試及格者，得請領護理人員證書」。另依同法第 6 條規定：有下列情形一者，不得充護理人員；其已充護理人員者，撤銷或廢止其護理人員證書：

(一)曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，經判刑確定。

(二)曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定。

(三)依本法受廢止護理人員證書處分。

三、另據同法第 8 條規定：護理人員應向執業所在地直轄市、縣（市）主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。及第 11 條規定略以：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執…」。

四、綜上述，護理人員證書與護理人員執業執照係兩種不同證明文件，領有護理師證書者，表示具有護理人員資格，如未違反前述相關規定，則該證書具有永久效力。而如護理人員欲執業時，依法須向執業所在地申請執業登記，領有執照始得執業，如因故不再繼續執業，則依同法第 11 條辦理歇業，原所持有執業執照須繳回執業縣市衛生局，並於護理師證書背面註記登錄動態章戳。

106.4.14 衛部照字第 1060110015 號

主旨：有關台端陳情「國立臺灣大學醫學院附設醫院（以下簡稱臺大醫院）甄選護理系應屆畢業生之護理儲備人員，建議男性護理畢業生應放寬申請條件至兵役結束後一年可以應屆身分申請」一案，復請查照。

說明：

一、依據 106 年 4 月 5 日行政院性別平等處院臺性平字第 1060169355 號函轉台端陳情案辦理。

二、有關台端陳情「臺大醫院甄選護理系應屆畢業生之護理儲

備人員，建議男性護理畢業生應放寬申請條件至兵役結束後一年可以應屆身分申請」一案，本部相當重視並關心。

三、經詢國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室，該院表示每年 3 月會函請護理學校推薦該校應屆畢業之學生，並於 4 月進行甄選，出缺按錄取名次依序進用。若非經該甄選管道，亦可至該院徵才資訊網頁報名出缺之護理人員職缺。

四、有關台端之建議，本部亦轉請臺大醫院於未來規劃甄選應屆畢業生時，應考慮男性護理人員盡其服役義務時之工作權利，彈性放寬男性應屆畢業甄選之申請條件。

106.4.14 衛部照字第 1060110015A 號

主旨：有關貴院甄選護理系應屆畢業生之護理儲備人員，建議彈性放寬男性應屆畢業甄選申請條件，請查照。

說明：

一、依據 106 年 4 月 5 日行政院性別平等處(以下簡稱性平處)院臺性平字第 1060169355 號函轉民眾陳情事項辦理。

二、案係民眾陳情貴院徵選優秀應屆護理師規範不明，損害男性護理師申請工作之權利，建議針對男性護理系(所)畢業者放寬申請條件為「兵役結束一年內可以應屆身份申請」。

三、經詢貴院人事室表示每年 3 月會函請護理學校推薦該校應屆畢業之學生，並於 4 月進行甄選，出缺按錄取名次依序進用。惟考量男性護理人員盡其服役義務時之工作權利，建議貴院得彈性放寬男性應屆畢業甄選之申請條件。

四、隨函檢附陳情內容供參(如附件)，請貴院依「行政院及所屬機關處理人民陳情案件要點」之規定予以保密。

第 2 條 本法所稱護理人員，指護理師及護士。

88.10.15. 衛署醫字第 88061415 號函

主旨：有關醫療院所護理長職稱，僅領有護士證書者，可否擔任

乙案，查依護理人員法規定，並無特別限制不得擔任，復請 查照。

說明：復 貴局 88 年 9 月 8 日(88)基衛人字第 10523 號函。

93.12.14. 衛署醫字第 0930220481 號書函

主旨：所詢醫療院所於夜間(即所謂「大夜班」)急診室之護理人員之配置人數，有何相關規定？該規定有無以醫院之等級，或者當時就診之急診病患人數為依據，而就夜間急診室之護理人員配置人數為不同規定？又「醫佐」是否係屬護理人員等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 93 年 11 月 24 日苗檢惠廉 93 偵 3464 字第 16454 號函。
- 二、有關醫療院所護理人員之配置人數規定，係依「醫療機構設置標準」規定辦理。
- 三、至所詢「醫佐」之工作性質未明，查護理人員法並無此稱謂。
- 四、檢送醫療機構設置標準一份，請參考。

95.6.12. 衛署醫字第 0950023280 號書函

主旨：所詢「學校衛生護理人員是否為公共衛生護士」一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 6 月 2 日高市衛疾管字第 0950018842 號函。
- 二、依護理人員法第 2 條規定，護理人員係指護理師及護士，至學校衛生護理人員及所謂之公共衛生護士，係將執業場所或業務特性予以區隔標示而言。查學校護理人員其工作包括衛生保健、疾病管理及救護、傳染病防治、預防接種及衛生教育等，係屬護理人員業務範疇，其工作性質亦屬公共衛生業務範疇，是以，學校衛生護理人員得依衛生機工作計畫或公函執行或協助公共衛生業務工作。

95.7.13.衛署醫字第0950328158號函

主旨：有關所詢「醫護」含義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 台端 95 年 6 月 15 日致本署藥政處箋函。
- 二、依醫療法第 10 條規定：「本法所稱醫事人員，係指領有中央衛生主管機關核發之醫師、藥師、護理師、物理治療師、職能治療師、醫事檢驗師、醫事放射師、營養師、藥劑生、護士、助產士、物理治療生、職能治療生、醫事檢驗生、醫事放射士及其他醫事專門職業證書之人員。本法所稱醫師，係指醫師法所稱之醫師、中醫師及牙醫師」。
- 三、又依護理人員法第 2 條規定：「本法所稱護理人員，指護理師及護士」。查護理業務，是指涉屬足以影響人類身體結構及生理機能之專業護理措施，應由護理人員執行；至為因應我國長期照護人力需求，提昇照顧服務品質所訓練之照顧服務員，其服務項目為家務、日常生活及身體照顧服務，其服務範疇不得涉及醫療及護理行為，併予敘明。

第 3 條 經護理人員考試及格者，得請領護理人員證書。

第 4 條 請領護理人員證書，應具申請書及資格證明文件，送請中央主管機關審核後發給之。

第 5 條 本法所稱主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第 6 條 有下列情形之一者，不得充護理人員；其已充護理人員者，撤銷或廢止其護理人員證書：

一、曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，經判刑確定。

二、曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定。

三、依本法受廢止護理人員證書處分。

第 7 條 非領有護理師或護士證書者，不得使用護理師或護士名稱。非領有專科護理師證書者，不得使用專科護理師名稱。

第 7-1 條 護理師經完成專科護理師訓練，並經中央主管機關甄審合格者，得請領專科護理師證書。

前項專科護理師之甄審，中央主管機關得委託各相關專科護理學會辦理初審工作。領有護理師證書並完成相關專科護理師訓練者，均得參加各該專科護理師之甄審。

專科護理師之分科及甄審辦法，由中央主管機關定之。

87.1.14. 衛署醫字第 86075939 號函

主旨：何○○係應 86 年中央暨地方機關公務人員升等考試薦任升等考試護理助產職系公職護理師考試及格，惟未領有護理師證書，得否擔任護理師職務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 86 年 12 月 19 日 86 台甄 5 字第 1561752 號簡便行文表。
- 二、按護理人員法第 7 條規定，非領有護理師或護士證書者，不得使用護理師或護士名稱。護理師或護士係屬專業名稱，須經護理師或護士之專門職業考試，取得各該專業資格後，方得使用；查何員僅具護士資格，其雖經 86 年中央暨地方機關公務人員升等考試薦任升等考試護理助產職系公職護理師考試及格，惟未領有護理師證書，應不得擔任護理師職務。

（註：本函釋當事人之名字以○○表示）

89.10.4. 衛署醫字第 89033210 號函

主旨：所請將「專科護理師」法制化，以有效提昇護理師之角色功能，部份解決醫師人力的不足乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 6 月 22 日北市衛五字第 8922669300 號函。
- 二、貴局建請修改護理人員法，將專科護理師業務範圍擴大其

輔助醫療之範圍，俾讓專科護理師合法延伸其角色乙節，經查本署刻正修訂醫療法，於該法修正草案訂定臨床助理制度，明訂臨床助理應由經適當訓練之護理人員擔任，且可依醫囑協助醫師執行下列行為：(1)協助住院病人身體理學檢查之初步評估及病情詢問。(2)協助填寫檢驗單、特殊檢查單、會診單、轉診單及診斷證明等各項臨床單據。(3)協助記錄住院病人病情及各項檢查、檢驗結果。(4)於現場協助醫師為臨床處置。(5)簡易之傷口處置、導管更換及非侵入性檢查之技術操作。(6)協助處理住院病人或其家屬醫療諮詢及病情之說明。透過該制度之施行，應可提升護理師之角色功能及部分解決醫師人力不足之問題。

三、另查護理人員法並已修正納入專科護理師制度，其修正草案刻正立法院審議中。

(註：1. 醫療法第 58 條經規定「醫療機構不得置臨床助理執行醫療業務」，意即臨床助理若執行醫療業務，需具備醫事人員資格，始得為之，請參閱 P. 247 本署 101.3.29. 衛署醫字第 1010064877 號函。

2. 專科護理師執業範圍，請參閱 P. 245 本署 96.6.20. 衛署照字第 0962801033 號函。)

94.11.9. 衛署醫字第 0940058715 號書函

主旨：有關坊間美容中心及 SPA 美容沙龍，未聘僱護理人員執業，常以「XX 護理」二字作廣告宣傳，所詢該行為是否逾越醫療相關法規之規定一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 94 年 10 月 27 日北市衛醫護字第 09438269001 號函。

二、按「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。」、「本法所稱護理人員，指護理師及護士」、「非領有護理師或護士證書者，不得使用護理師或護士名稱」，為護理人員法第 1 條第 1 項

、第 2 條及第 7 條所明定。是以，不具護理人員資格而使用護理師或護士名稱者，則依違反護理人員法第 38 條規定論處。

- 三、又按護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：
一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第 4 款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」前該護理業務之執行，涉屬足以影響人類身體結構及生理機能之專業護理措施。
- 四、至「護理」一詞之使用方式，如足使社會大眾誤認為護理機構、醫療機構或護理人員執業之業務項目時，即應依護理人員法及其相關法規規定論處。

102.2.18. 衛署照字第 1022860396 號函

主旨：有關 貴會陳情「希望本署廢除以婦產科專科護理師訓練取代助產人員法定工作之行政命令，以維護助產專業及保障現有助產人員權益」案，復如說明段，請 鑑察。

說明：

- 一、依據行政院 102 年 2 月 1 日院臺衛字第 1020123799 號函轉中國國民黨中央政策委員會 102 年 1 月 25 日 102 年政研字第 135 號函辦理。
- 二、所送陳情「希望本署廢除以婦產科專科護理師訓練取代助產人員法定工作之行政命令，以維護助產專業及保障現有助產人員權益」案，說明如下：
- (一)本署係依據護理人員法第 7-1 條及其授權之專科護理師分科及甄審辦法規定，辦理專科護理師訓練及甄審，並無貴會所指破壞考、用制度之情事，合先敘明。
- (二)完成外科專科護理師（婦產科組）訓練及通過甄審之護理人員仍需在醫師指示之下，執行醫療輔助行為，其業務範疇仍為需符合護理人員法所界定之護理業務，故並無所陳取代助產人員法定工作之情事。
- (三)有鑑於婦產科醫師人力吃緊，本署業於 101 年 9 月 12

日召開 101 年本署專科護理師諮詢委員會分科及甄審工作小組第 1 次會議，就婦產科醫學會建議增列婦產科專科護理師進行討論，會中決議同意於外科下設立婦產科分組，台灣婦產科醫學會業依會議決議，與台灣專科護理師學會邀集台灣助產學會完成訓練課程之研擬，並送 101 年 11 月 12 日本署專科護理師諮詢委員會確認，並於 101 年 12 月 20 日函知專科護理師訓練醫院及醫護助產團體週知，預計於 102 年辦理首次訓練及甄審。

- (四)考量助產師因已具備產科完整之知能，僅須補專科護理師角色與功能及婦科相關訓練課程及實習，再通過專科護理師外科（婦產科組）甄審，即可與婦產科醫師於醫院共同照顧產婦及婦科病人，逐漸發展助產師與高危險母嬰醫學專業醫師合作生產模式。
- (五)另依據 100 年 9 月 26 日衛署醫字第 1000210648 號函同意具多重醫事人員資格者得同時辦理執業登記，執業登錄場所限於同一處所。是以，具有外科專科護理師（婦產科組）證書人員如只具護理師資格，則只能執行護理業務，如具有助產師資格者，則可同時執行助產業務。
- (六)依助產人員法第 13 條規定，助產師須執行助產業務二年以上得設立助產機構執行業務，本署將賡續進行醫界、助產界、及護理界醫院合作模式對話、透過醫療機構設置標準訂定執業登記配套措施、加強助產機構開業及助產人員執業管理、辦理助產人員繼續教育，以善用助產人力，保障婦女生產品質及安全。
- (七)有關貴會訴求，本署將於後續相關會議中審慎評估、研議與規劃。

102.6.5. 署援國字第 1020200733 號函
主旨：有關大院請本署就「職業安全衛生促進方案」調查意見檢

討改進乙案，本署復如說明，請 鑒察。

說明：

一、復 大院 102 年 4 月 8 日院台財字第 1022230447 號函。

二、有關應積極檢討處理國內職業安全專科醫師及護理人力不足部分，說明如下：

(一)目前國內執業醫師人數約有 3 萬餘人，國內對於專科醫師制度之規定，係為提昇醫療品質，對已取得醫師資格而繼續接受臨床專業訓練者之一種專長認定，現於 23 個專科醫師類別中，尚無職業安全專科醫師之類別設置，是以，只要具醫師資格，並經中央主管機關指定之課程訓練或勞工安全衛生教育訓練規則相關規定，經訓練合格者皆可擔任。

(二)本署網址首頁設有「醫事人員執業登記資料查詢」服務，可方便民眾查詢醫師執業及專科專長資訊，以資利用。

(三)另，國內目前尚無職業醫學科專科護理師之類別設置，只要具護理人員資格，並經中央主管機關指定之課程訓練或勞工安全衛生教育訓練規則第 14-1 條訓練合格者皆可擔任。

(四)本署將持續與勞委會合作，透過醫護人員繼續教育，讓有興趣及熱忱之醫護人員可加入職業健康照護服務行列，以改善國內職業安全專科醫護人力不足之問題。

三、有關應研議增進職業衛生護理人員專業水準，提昇其從事臨廠服務及勞工檢查服務之能力部分，說明如下：

(一)查本署 89 年開始，陸續發布各類醫事人員執業登記及其繼續教育辦法，規範各類醫事人員執業，應每 6 年接受一定時數（醫師 180 小時、護理人員 150 小時）之繼續教育課程（內容包括醫學專業、專業品質、專業倫理及專業相關法規），以維持醫事人員執業應有之知能，提高醫療服務品質，並維護民眾

就醫權益。

- (二)為增進職業衛生護理人員之專業水準，有關勞工職場健康服務提供之醫療專業課程規劃（例如員工健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項等），勞委會於「勞工健康保護規則」第4條即規定，辦理臨廠健康服務之醫護人員，應接受該會相關指定之課程訓練合格。
- (三)另目前除專科護理師外，其他護理專業認證分屬各專業團體執行，本署將持續透過繼續教育鼓勵職業衛生相關專業團體強化職業衛生護理人員之角色及知能，使其發揮預防疾病及職場健康管理之功能。另對於勞委會所委託相關護理人員專業知能提升計畫，本署亦將出席相關會議及參與研討，以期適時提供行政協助，提升護理人員職業衛生專業知能。

第二章 執業

第8條 護理人員應向執業所在地直轄市、縣（市）主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。

護理人員執業，應每六年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新。

第一項申請執業登記之資格、條件、應檢附文件、執業執照發給、換發、補發、更新與前項繼續教育之課程內容、積分、實施方式、完成繼續教育之認定及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

81.2.8. 衛署保字第984945號函

主旨：有關護理人員未依規定辦理執業登記，及未具護理人員資格者執行業務應如何處理疑義乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴處80年10月18日80衛五字第76997號函。

二、護理人員法公布施行後，護理人員未依規定辦理執業登記者，依護理人員法第 33 條規定原應處罰。惟查護理人員法甫經公布施行不久，護理人員對該法之認識普遍不足，亟需繼續加強宣導工作。另，配合該法第 37 條之施行，得於民國 82 年 6 月 30 日前審酌實際情況分區實行之規定，故對未依同法第 8 條及第 11 條第 1 項規定辦理執業登錄或異動核備者，宜自本(81)年 7 月 1 日起處罰。

三、具護理人員資格者倘隱匿其所具有之資格，依護理人員法第 37 條但書執行業務，以迴避須加入所在地公會及執業登錄之法令約束，其處罰比照說明二規定，惟該狀況權益損害最大為當事者，因無法取得執業年資證明，足見護理人員對於法規認識仍不足，請加強輔導。

四、未具護理人員資格執行護理人員業務者，仍請依本署 80 年 6 月 19 日衛署保字第 954621 號公告(如附)辦理。

83.6.17. 衛署醫字第 83035197 號函

主旨：衛生機關人員，縱具有醫事人員資格，如所從事之工作，非各該專業法規所規定之專業業務，不應辦理執業登記，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.6.17. 衛署醫字第 83035198 號函

主旨：醫療機構之醫事人員，不論其職稱為何，如係執行各該專業法規所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.6.17. 衛署醫字第 83035199 號函

主旨：護理人員擔任護理學校教師，從事護理教育或護生實習指

導工作，非以執行護理人員業務為其職業，可無須辦理執業登記。如欲辦理執業登記者，應向其學校所在地之地方衛生主管機關申請執業登記，並以其學校為登記處所，請查照。

說明：依據本署於83年4月22日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.6.17. 衛署醫字第83035200號函

主旨：衛生局之護理督導，係以辦理護理行政督導業務為主，非以執行護理人員業務為其職業，縱具護理人員資格，可免辦理執業登記。

說明：依據本署於83年4月22日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.6.17. 衛署醫字第83035201號函

主旨：護理人員具有護理師、護士或助產士多重資格者，其執業登記，應擇一資格辦理，但除助產士法第10條第1項及本署72年8月31日衛署醫字第444517號函另有規定外，於同一執業處所，雖擇一資格登記，仍得執行他種資格業務，請查照。

說明：依據本署於83年4月22日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.7.11. 衛署醫字第83031330號函

主旨：護理人員於學校擔任校護工作，屬護理人員法第8條所稱之執業，其有關執業登記及管理，自應依該法之規定辦理，請查照。

說明：依據雲林縣衛生局83年5月27日雲衛五字第5409號函辦理。

84.9.14. 衛署醫字第84055861號函

主旨：護理人員在取得護士、護理師證書後未立即辦理執業登錄，是否可依服務證明申請自願接受行政罰鍰後，再追溯其執業登錄日期自取得護士或護理師證書日起算乙案，於法不合，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處 84 年 9 月 2 日 84 衛五字第 069914 號函。
- 二、依護理人員法第 8 條規定，護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。護理人員法施行細則第 4 條規定，依本法第 8 條規定，請領護理人員執業執照者，應填具申請書，並檢具「擬執業機構之證明文件」等相關文件及執照費，送請所在地直轄市或縣(市)主管機關核辦。
- 三、依前開規定，護理人員於確定擬執業機構後，即應持擬執業機構開具之證明文件，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請執業登記。因此，護理人員依法辦理執業登記後之執業，始為合法之執業。至地方衛生主管機關對於護理人員因違反護理人員第 8 條規定所為之行政處分，係為匡正其違法行為及落實執業管理，且其違法既屬事實，應不因其接受行政處分是否出於自願，而得以改變或追溯其執業登記日期。

85.5.13. 衛署醫字第 85024010 號函

主旨：有關衛生局擔任外籍勞工健康管理及體格檢查審核之臨時人員若滿 2 年，並領有護士證書，可否依技術人員任用條例第 5 條第 3 項規定，任用為衛生所公共衛生護士乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 85 年 5 月 4 日 85 台中甄五字第 1296034 號函。
- 二、按辦理外籍勞工健康管理及體格檢查審核，應屬衛生機關之衛生技術行政工作範疇，醫事人員擔任該項工作，可免辦理執業登記。本案具護士資格之人員辦理外籍勞工健康

管理及體格檢查審核之年資，宜採計為技術人員任用條例第5條第3項所定之年資。如滿2年建請准予轉任公立醫療機構之護士。

86.1.29.衛署醫字第86007633號函

- 一、台端86年1月14日函，收悉。
- 二、查「護理人員管理規則」（護理人員法公布施行後停止適用）第10條及護理人員法第8條均規定，護理人員執業，應向所在地直轄市或縣（市）衛生主管機關申請執業登記。台端擔任國立中正紀念堂「約僱護士」，如係執行護理人員業務，應依上開規定辦理。至於台端應辦理而未辦理執業登記之服務年資，可否採計為公務人員銓敘之年資，應由採認機關決定。
- 三、復請 查照。

86.2.3.衛署醫字第85064399號函

- 一、台端85年11月來函收悉。
- 二、按護理人員法公布施行前，護理人員之執業及管理係依「護理人員管理規則」規定辦理。該規則第10條規定，護理人員執業時，應向所在地直轄市或縣（市）衛生主管機關繳驗護理師或護士證書，……申請發給執業執照。惟家庭計畫推廣中心兼具醫療及衛生雙重性質，依台端所附「僱用契約書」規定工作內容亦可歸屬衛生技術行政工作，得免辦理執業登記。
- 三、復請 查照。

86.3.20.衛署醫字第86012919號函

主旨：任職於中華民國紅十字會台灣省台南市支會之護士，是否准予辦理執業登記乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處86年3月7日衛五字第860012943號函。

- 二、本案護士從事學校教職員、學生及一般社會人士…之急救訓練工作，與護理業務相關，得准予辦理執業登記。

86.5.17. 衛署醫字第 86017775 號函

主旨：有關中華民國新生兒醫學會辦理「早產兒追蹤門診計畫」約僱派駐縣市之護士，能否准予辦理執業登記乙案，復請查照。

說明：本案該學會辦理「早產兒追蹤門診專案計畫」，約僱派駐縣市之護士，執行早產兒門診跟診、量身高體重、護理指導及電話追蹤，涉及執行護理人員業務，應依法辦理執業登記，並以其執業之場所，為其執業登記之地點。

87.3.23. 衛署醫字第 87014069 號函

主旨：有關花蓮縣秀林鄉天祥晶華渡假酒店擬聘僱護士，並辦理執業登錄乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 87 年 2 月 27 日 87 花衛五字第 2363 號函。
- 二、花蓮縣秀林鄉天祥晶華渡假酒店為顧及遊客醫療需求聘僱護理人員擔任該店景觀資源娛樂活動部護士，如其確有從事護理工作之事實，得准其辦理執業登記。其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。

87.11.6. 衛署醫字第 87056029 號函

主旨：所詢台南市緊急救護指揮中心護理人員，自民國 81 年起進駐台南市消防局救災救護指揮中心，擔任協勤護理人員，於本(87)年 9 月 1 日方辦理執業登錄，是否可追溯登錄年資至 81 年乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 87 年 9 月 17 日南市衛五字第 8717686 號函。
- 二、護理人員執業，未依規定向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請發給執業執照者，縱申請自願接受行政罰鍰，仍不

得改變或追溯其執業登記日期，前經本署 84 年 9 月 14 日衛署醫字第 84055861 號函釋在案，惟本案救護指揮中心護理人員，若曾提出申請辦理執業執照但遭駁回，則不在此限。

88.3.25. 衛署醫字第 88010515 號函

主旨：有關高雄縣衛生局為護理人員執業與歇業登錄事宜，函請釋疑乙案，復請 查照

說明：

- 一、復 貴處 88 年 1 月 21 日 88 衛五字第 0002729 號函。
- 二、按護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，發給執業執照」。爰此，護理人員未辦理執業登錄即行執業，應依同法第 33 條規定處理。
- 三、護理人員如係執行護理人員法規定之業務，即應依規定辦理執業登錄，故護理人員於試用期間仍須辦理執業登錄。至護理人員於軍中部隊醫務室服務可否辦理執業登錄乙節，由於目前國軍部隊之醫務室，均未另設置民眾診療服務處，依醫療法第 88 條規定，其管理由國防部另依其所訂頒之「國軍衛生勤務規則」及其相關作業規定辦理；又由於醫務室主要任務為部隊衛勤作業，非屬一般服務民眾之執業單位，其護理人員不須向所在地直轄市或縣(市)主管機關辦理執業登記。
- 四、護理人員與其服務之醫療機構發生糾紛，而未能取得離職證明書者，其於申請執業執照註銷登記時，得以其出具之切結書（應敘明離職日期）辦理執業執照之註銷登記事宜，前經本署 84 年 8 月 14 日衛署醫字第 84049486 號函釋在案。

88.9.9. 衛署醫字第 88047523 號函

主旨：函詢本署根除三麻一風計畫派駐苗栗縣衛生局工作人員，

持有護士證書，是否准予辦理護理人員執業登錄乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 88 年 7 月 15 日 88 衛五字第 8810898 號函。
- 二、依所附業務項目證明書，根除三麻一風計畫，應屬衛生機關之衛生技術行政工作範疇，護理人員擔任該項工作，依護理人員法第 8 條及第 11 條規定，非屬須辦理執業登記之範圍。

88.11.22. 衛署醫字第 88069200 號函

主旨：所詢衛生局之技士、技佐領有助產士證書者，是否適用助產士法第 7 條規定，准予發給助產士執業執照乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 88 年 11 月 1 日 88 衛五字第 12048 號函。
- 二、依助產士法第 18 條規定，助產士業務為(1)接生；(2)產前檢查及保健指導；(3)產後檢查及指導；(4)嬰兒保健指導；(5)生育指導。衛生機關人員非屬從事上開業務，縱領有助產士證書，依助產士法第 7 條、第 10 條及同法施行細則第 7 條規定之旨，亦不應辦理執業登記。

90.7.24. 衛署醫字第 0900044551 號函

主旨：所詢已領有護士證書，而仍就讀於大學或技術學校、專科學校等日間部未畢業學生，可否請領護理人員執業執照乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 6 月 19 日彰衛字第 90101708 號函。
- 二、按就讀大學或技術學院、專科學校等日間部學生，應以學業為重，其雖領有醫事人員證書，仍宜俟其畢業後始可請領執業執照；至於就讀夜間部或在職班者，為利已就業之社會青年繼續進修，得不予限制其申領執業執照。

92.12.19.衛署醫字第 0920066391 號書函

主旨：所詢台北市政府社會局至善老人養護中心委託財團法人天主教耕莘醫院辦理福利服務，所聘僱護理人員申請執業執照登錄乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 12 月 15 日北市衛五字第 09238353310 號函。
- 二、台北市政府社會局至善老人養護中心委託財團法人天主教耕莘醫院辦理福利服務，所聘僱護理人員如其確有從事護理工作之事實，得准其辦理執業登記，其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。

93.8.27.衛署醫字第 0930031576 號書函

主旨：所詢具有醫事人員資格者之高壓氧設備操作技術員，是否須辦理執業登錄等情乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 7 月 22 日北衛醫字第 0930029820 號函。
- 二、按各類醫事人員執業，應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照後，始得依各該專門職業法律規定之業務執業，為各該醫事人員專業法規所明定。惟據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」第 2 條附表第 19 項高壓氧設備，有關配合醫師操作該設備之醫事人員資格包括護理人員；另依該辦法第 10 條規定，本辦法施行前，已施行或使用特定治療檢查檢驗項目者，應於本辦法施行之日起 6 個月內，依本辦法規定補正申請登記。查該管理辦法有關補正申請登記之規定係於 93 年 2 月 26 日修正發布，本案謝姓及唐姓護理人員於 7 月 9 日在法定期限內辦理執業登錄補正程序，應無不法。
- 三、檢送「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」乙份，請參考。

93.12.31.衛署醫字第 0930051198 號書函

主旨：所詢護理人員任公共衛生護士，完成報到手續後當日即借調辦理防疫業務，未實際從事護理工作，是否需依規定辦理執業登錄等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 12 月 2 日北市衛五字第 09338188100 號函。
- 二、按護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員依法應以領有執業執照後，始得執業，未依法辦理執業，即擅自執業，係屬違法執業，應依護理人員法第 33 條規定處罰；另按護理人員法第 11 條規定，護理人員歇業、停業、復業或變更執業處所時，應自事實發生之日起 10 內，報請原發執業執照機關核備，違反前述規定者，則依同法第 39 條規定論處。
- 三、經查本案護理人員江○○女士於 11 月 1 日至新單位完成報到手續，當日即借調辦理防疫業務一個月，並未實際從事護理工作，至 11 月 24 日始完成執業登記手續，爰此，有關該員執業登錄認定疑義一節，請依個案事實參酌前述規定辦理。

(註：本函釋當事人之名字以○○表示)

93.12.31.衛署醫字第 0930053629 號書函

主旨：所詢護理人員辦理執業登記，所檢附服務機構證明文件之到職日期與其辦理執業登記日期有差異時之日期認定疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 12 月 16 日北市衛五字第 09339232800 號函。
- 二、查護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員執業依法應以領有執業執照後，始得為之；護理人員未依法辦理執業登記，即擅自執

業，係屬違法執業，應依護理人員法第 33 條規定處罰。至於執業執照之核發，以申請日為發照日，前經本署 86 年 6 月 10 日衛署醫字第 86019839 號函釋在案。

三、次查護理人員法第 11 條係護理人員執業異動之規範，並不適用上開申請執業登記之情形。

94.10.14. 衛署醫字第 0940041107 號函

主旨：為臺北市政府社會局函請貴部釋示老人安養護機構本國籍服務人員同時登錄護理人員執業情形相關適法性疑義案，有關護理人員執業登記與執行業務之相關規定一節，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 94 年 9 月 16 日內授中社字第 0940713745 號函。
- 二、按醫事人員不論其職稱為何，如係執行各該專門職業法律所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記。是以，具有護理人員資格者，不論其職稱為何，如所從事之工作，非屬護理人員法第 24 條規定之業務，尚不需辦理執業登記；如從事護理人員法第 24 條所規定之業務，即應依同法第 8 條之規定辦理執業登記，依法領有執業執照後，始得執業。
- 三、至具有護理人員資格者，從事護理工作卻未依法辦理執業登記，即擅自執業，係屬違法執業，應依護理人員法第 33 條規定論處。
- 四、爰此，本案所詢護理人員執業登錄與執行業務之相關規定一節，應依其實際工作內容認定，並依前述規定辦理。

96.1.30. 衛署醫字第 0960004121 號函

主旨：有關台灣高速鐵路局擬聘僱護理人員，所詢執業登錄一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 23 日桃衛醫字第 0960000937 號函。

- 二、按醫事人員不論其職稱為何，如係執行各該專門職業法律所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記。是以，具有護理人員資格者，不論其職稱為何，如所從事之工作，非屬護理人員法第 24 條所規定之業務，尚不需辦理執業登記；如從事護理人員法第 24 條規定之業務，即應依同法第 8 條之規定辦理執業登記，依法領有執業執照後，始得執業，先予敘明。
- 三、本案台灣高速鐵路局為顧及乘客醫療需求，聘僱護理人員擔任該局駐站服務人員，如其確有從事緊急救護、急救訓練等工作事實，與護理業務相關，得准其辦理執業登記。至其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。

96.2.13. 衛署醫字第 0960004908 號函

主旨：有關 貴局查獲於未立案護理機構執業之護理人員，涉及違反護理人員法之規定，所詢適用法條疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 29 日北衛醫字第 0960004835 號函。
- 二、查護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員執業依法應以領有執業執照後，始得為之；次查同法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」即未經立案之護理機構，非屬護理人員合法執業之場所。本案護理人員未辦理執業登錄即執行護理業務，核屬違反護理人員法第 8 條之規定；又查，該員於未立案之護理機構執行護理業務，同時違反護理人員法第 12 條之規定。
- 三、依行政罰法第 24 條第 1 項規定：「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額。」是

以，本案護理人員未領有執業執照即執行護理業務之違法行為情節，依一行為不二罰原則，以護理人員法第 33 條規定論處。

102.11.25 衛部照字第 1020171533 號函

主旨：有關 貴署函請釋示國立彰化啟智學校持有護理師證書之生活輔導員，支援健康中心照護學生，是否依護理人員法辦理執業登錄案，本部復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 102 年 11 月 15 日臺教國署原字第 1020114414 號函。
- 二、查護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。
- 三、護理人員於學校以執行護理人員業務為其職責，依護理人員法第 8 條規定應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業，前經行政院衛生署 83 年 7 月 11 日衛署醫字第 83031330 號函釋在案。
- 四、有關所詢生活輔導員其持有護理師證書，至健康中心執行護理人員法第 24 條所規定業務，依同法第 8 條規定應辦理執業登記。

103.1.7 衛部照字第 1021581525 號函

主旨：有關執業執照有效日期迄日為 103 年 6 月 19 日之護理人員辦理停業或歇業後，尚未取得繼續教育積分 150 點，復業時更新執業執照繼續教育積分計算疑義案，請 查照。

說明：

- 一、按護理人員法第 11 條第 1 項至第 3 項規定：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十內，報請原發執業執照機關備查。前項停業之期間，以一年為限；逾一年

者，應辦理歇業。護理人員變更執業處所或復業者，準用關於執業之規定。」

- 二、按醫事人員執業登記繼續教育辦法（以下簡稱辦法）第 5 條及第 6 條規定，醫事人員（含護理人員）曾經執業後因故歇業，如再重新辦理復業者，有兩種方式辦理執業登記，以免影響權益。

（一）辦法第 5 條第 3 款規定：醫事人員（含護理人員）歇業後重新申請執業登記之日期，未逾原執業處所執業執照所載應更新日期，得免檢具繼續教育積分證明申請執業執照。

（二）辦法第 6 條第 1 項第 3 款規定：醫事人員（含護理人員）連續歇業期間逾 2 年，得以申請執業登記前 1 年內接受繼續教育積分達 6 分之 1 以上（即 25 點）之證明辦理執業執照，其執業執照有效期間自復業日起算加 6 年。

- 三、另據同（護理人員）法第 8 條第 2 項規定，護理人員執業，應每 6 年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新，按此，執業執照有效日期迄日為 103 年 6 月 19 日之護理人員，停業後之護理人員仍應於 103 年 6 月 19 日前修習繼續教育積分 150 點，惟如無法於有效期間內取得繼續教育積分 150 點，復業時繼續教育積分計算應以辦理復業當日往前推算 6 年內積分 150 點為準。

103.4.22 衛部照字第 1030007876 號函

主旨：有關貴院派遣護理人員江○○支援新竹縣尖石鄉秀巒衛生室，其繼續教育積分採認案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 103 年 3 月 31 日馬院乙字第 1030008056 號函。
二、同意旨揭護理人員依繼續教育積分適用醫事人員執業登記及繼續教育辦法第 14 條第 2 項規定，其積分 1 點得以 1.5 點採計，時間溯自 100 年 3 月到職日起計算。

（註：本函釋當事人之名字以○○表示）

103.5.5 衛部照字第 1030111496 號函

主旨：有關貴縣轄區護理人員黃○○小姐於 99 年 1 月 8 日起迄今原執業登記護士，擬申請追溯自 99 年 10 月 15 日起變更執業登記為護理師乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 4 月 8 日彰衛醫字第 1030011786 號函。
- 二、依護理人員法第 8 條規定：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業」。復依 102 年 7 月 1 日公告修正「醫事人員執業登記及繼續教育辦法」(前為護理人員執業登記及繼續教育辦法)第 4 條規定：「醫事人員申請執業，應填具申請書，並檢附相關文件及繳納執業執照費，向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請，發給執業登記」。
- 三、有關來函所述黃君係以護士執業登記，後考取護理師因疏忽未以護理師辦理護理人員執業乙節，依前開護理人員法相關規定尚未要求同時兼具護士及護理師資格者，須以較高等級之醫事人員資格證書辦理執業登記之規定，爰應無因申請追溯或變更執業登記而違反護理人員法第 8 條之適用情形，先予敘明。
- 四、綜上，護理人員擬申請追溯變更執業登記為護理師乙案，業前經本部(組改前行政院衛生署)分別於 84 年 9 月 14 日衛署醫字第 84055861 號規定略以：「……護理人員依法辦理執業登記後之執業，始為合法之執業。至地方衛生主管機關對於護理人員因違反護理人員第 8 條規定所為之行政處分，係為匡正其違法行為及落實執業管理，且其違法既屬事實，應不因其接受行政處分是否出於自願，而得以改變或追溯其執業登記日期」，及 87 年 1 月 16 日衛署醫字第 87056029 號規定略以：「…護理人員執業，未依規定向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請發給執業執照者，縱申請自願接受行政罰鍰，仍不得改變或追溯其執業登記日期…」。

五、按上開規定，黃君於99年1月8日起以護士資格登錄執業，惟後續考取護理師擬變更執業身分別登錄，僅能依所提變更時向服務縣市衛生局提出申請變更，所詢溯其取得護理師證書日起算，爰不符相關規定。

(註：本函釋當事人之名字以○○表示)

103.6.19 衛部照字第1030013544號函

主旨：關於台端陳述醫事人員執業登記及繼續教育辦法，護理人員更新執業執照於103年6月19日到期，建議給予緩衝期日案，敬復如說明段，請查照。

說明：

一、復 台端103年5月29日瓊芝字第1030529號函。

二、依護理人員法第8條第2項規定：護理人員執業，應每六年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新；另依據醫事人員執業登記及繼續教育辦法第13條第1項規定，醫事人員執業(含護理人員)，應每6年接受……繼續教育之課程積分達150點以上，此為14類醫事人員共通規定。

三、有關台端旨揭疑義與建議，本部業於103年5月9日與各縣市衛生局共同召開會議，並有初步共識。由於執業效期屆滿與否，與繼續執業之認定依權責仍由縣市衛生主管機關依個案事實判定，爰建議您逕洽執業地點之縣市衛生局，以儘速協助您處理疑義。

103.6.23 衛部照字第1030115010號函

主旨：有關民眾反映衛生局要求護理人員接受繼續教育訓練課程，並自行上衛生福利部網頁登錄時數，再將積分證明影印提供衛生局一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復 貴局103年5月30日北市衛醫護字第10352712701號函及103年5月21日北市衛醫護字第10352524701號函。

- 二、依據醫事人員執業登記及繼續教育辦法第7條規定：「醫事人員辦理執業執照更新，應填具申請書、並檢具原領執業執照、相片、公會會員證明、完成所定繼續教育積分或其他相關證明文件，向原發執業執照機關申請換領執業執照」。
- 三、依前揭規定，醫事人員辦理執業執照更新，應有檢具繼續教育或其他相關證明文件之義務，惟證明文件之型式，法未無明文規範，爰基於便民考量，在不違反上開原則下，該證明文件之型式，得由各縣市政府衛生局自行訂定。
- 四、另貴局在辦理更新執業執照時，是否再進行查核乙節，請貴局本權責併前述逕復陳情人。

103.9.12 衛部照字第 1031561619 號函

主旨：有關台端陳詢護理師證書資格疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 台端 103 年 9 月 1 日陳情書。
- 二、按護理人員法第1條規定略以：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員……」。暨同法第3條規定：「經護理人員考試及格者，得請領護理人員證書」。另依同法第6條規定：有下列情形一者，不得充護理人員；其已充護理人員者，撤銷或廢止其護理人員證書：
 - (一)曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，經判刑確定。
 - (二)曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定。
 - (三)依本法受廢止護理人員證書處分。
- 三、另據同法第8條規定：護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。及第11條規定略以：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執…」。

四、綜上述，護理人員證書與護理人員執業執照係兩種不同證明文件，領有護理師證書者，表示具有護理人員資格，如未違反前述相關規定，則該證書具有永久效力。而如護理人員欲執業時，依法須向執業所在地申請執業登記，領有執照始得執業，如因故不再繼續執業，則依同法第 11 條辦理歇業，原所持有執業執照須繳回執業縣市衛生局，並於護理師證書背面註記登錄動態章戳。

103.10.17 衛部照字第 1030024348 號函

主旨：有關勞動部函轉未署名之陳情人投訴於貴轄蘋果日報擔任護理師工作，該事業單位未辦理執業登記案，請依說明段查處函復本部，請查照。

說明：

一、依據勞動部 103 年 9 月 29 日勞動 2 條字第 1030132078 號函辦理。

二、依護理人員法第 8 條第 1 項規定：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」暨同法第 12 條規定略以：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。…。」，另依醫事人員執業登記及繼續教育辦法第 4 條規定略以：「醫事人員申請執業登記，應填具申請書，並檢附下列文件及繳納執業執照費，向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請，發給執業執照；…4. 擬執業機構出具之證明文件。…。」。

三、綜上，惠請 貴府查明事業單位(蘋果日報)如依勞工健康保護規則第 3 條規定雇用陳情人為護理人員，依醫事人員執業登記及繼續教育辦法第 4 條規定，應協助出具相關證明文件，以供陳情人依護理人員法規定辦理執登記。

四、檢附原函影本及相關資料各 1 份。本案請依行政程序法第 170 條第 2 項及個人資料保護法第 18 條規定，防止陳情人

資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。

103.12.22 衛部照字第 1030031594 號函

主旨：關於台端申訴護理人員繼續教育積分已取得 150 點，因專業課程部分未達規定積分，致無法更新執業執照一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 台端 103 年 12 月 10 日申訴書。
- 二、按醫事人員執業登記及繼續教育辦法第 13 條規定略以：
「醫師執業，應每 6 年接受下列繼續教育之課程積分達 180 點以上；其他類醫事人員(含護理人員)執業，應每 6 年接受下列繼續教育之課程積分達 150 點以上，包括 1. 專業課程。2. 專業品質。3. 專業倫理。4. 專業相關法規。…前項第 3 款、第 4 款繼續教育課程之積分數，於其他醫事人員合計至少應達 150 點，其中應包括感染管制及性別議題之課程；超過 30 點者，以 30 點計。」
- 三、綜上，護理人員繼續教育積分每 6 年應取得 150 點積分，專業倫理及專業相關法規合計至少應達 15 點，其中應包括感染管制及性別議題之課程；超過 30 點者，以 30 點計；專業課程及專業品質至少應達 120 至 135 點，合先予敘明。
- 四、本部於 103 年度已持續免費辦理至少 300 場之護理人員繼續教育實體及視訊課程，60 點免費通訊課程及 30 點數位學習課程，並於全國各縣市定點同步提供視訊課程，護理人員可至本部網頁查詢可參加之網路、通訊及實體課程(網址:<http://www.mohw.gov.tw>，路徑:衛生福利部→護理及健康照護→護理人員繼續教育專區→課程資訊)。另查目前中華民國護理師護士公會全國聯合會網站仍有護理專業之網路及通訊繼續教育課程(網址:<http://www.nurse.org.tw>，路徑:中華民國護理師護士公會全國合會→繼續教育數位學習網→通訊課程及網路

課程)，請逕行至該網站儘速完成繼續教育積分，以符規定辦理執業執照更新作業。

104.1.22 衛部照字第 1040100716 號函

主旨：有關老人日間照顧服務中心、幼兒園、托嬰中心聘僱之護理人員能否辦理執業登記及醫療機構護理人員到府安寧及居家照顧，是否需要支援報備及如何報備疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復 貴局 104 年 1 月 8 日北市衛醫字第 10430633100 號函。

二、按護理人員法第 8 條第 1 項規定「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」暨同法第 12 條規定略以：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。…。」；所稱「其他經中央主管機關認可之機構」，係指依相關法令規定須(得)配置護理人員執業之場所。

三、另按本部(前行政院衛生署)96 年 1 月 30 日衛署醫字第 0960004121 號函示略以：「……二、按醫事人員不論其職稱為何，如係執行各該專門職業法律所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記。是以，具有護理人員資格者，不論其職稱為何，如所從事之工作，非屬護理人員法第 24 條規定之業務，尚不須辦理執業登記；如從事護理人員法第 24 條規定之業務，即應依同法第 8 條之規定辦理執業登記，依法領有執業執照後，始得執業，先予敘明。」。

四、經查幼兒教育及照顧法第 18 條暨兒童及少年福利機構設置標準第 11 條皆已明訂依收置人數得或應置護理人員。爰所詢如老人日間服務中心、幼兒園、托嬰中心護理人員，如確有實際從事護理人員法第 24 條所規定之業務項目，則得依規定辦理執業執照，其執業登記之機構代碼得以

護產機構權屬別「其他」編碼。

- 五、至所詢醫療機構護理人員到府安寧及居家照顧，是否需要支援報備及如何報備乙節，按本部(前行政院衛生署)83年8月24日衛署醫字第83050863號函略以：「……。二、居家護理機構或醫療機構所設居家護理服務部門，其服務區域跨直轄市或縣(市)行政區區域者，仍須依護理人員法第12條規定申請報准，…。三、其護理人員執業異動或每年逐期辦理1次之報准時，應檢具前項第3款之文件。」，本案請參酌前揭規定辦理。

104.7.20 衛部照字第1041561306號函

主旨：有關您致本部部長信箱陳述擬參加日本護理師考試，陳詢護理師證書資格及已取得護理人員繼續教育積分更新執業執照換發證明案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據本部部長信箱104年7月13日案件編號1040713-00015號辦理。
- 二、按護理人員法第1條第1項：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。」、第3條：「經護理人員考試及格者，得請領護理人員證書」及第8條略以：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。護理人員執業，應每6年接受一定時數繼續教育，始得辦理執業執照更新」。
- 三、另依97年6月20日發布施行之護理人員執業登記及繼續教育辦法第8條規定略以：「護理人員執業，應每6年接受下列繼續教育之課程積分達150點以上……。」、第3條第2項規定略以：護理人員申請執業登記，有下列情形之一者，得免檢具繼續教育積分文件：1.領得護理人員證書5年內申請執業登記。2.本辦法施行前已取得護理人員證書，且於本辦法施行之日起5年內申請首次執業登記。

以及同法第 5 條第 2 項規定略以：「本辦法施行前已取得護理人員證書，且於本辦法施行之日起 5 年內，申請執業登記者，其執業執照之更新日期不得逾本辦法施行日起算 6 年。」。

- 四、綜上，護理人員證書與護理人員執業執照係屬兩種不同證明文件，領有護理師證書者代表具有護理人員資格，如未受廢止證書處分者，則具有永久效力。而具有護理人員資格者如欲執業時，則應依護理人員法規定向執業所在地主管機關申請執業登記，且執業期間應每 6 年接受 150 點以上繼續教育積分，始得辦理執業執照更新，繼續執業。
- 五、另查台端係於 96 年取得護理師證書，並辦理執業，故符合護理人員執業登記及繼續教育辦法第 3 條第 2 項規定，即於該辦法施行前已取得護理人員證書，且 5 年內首次執業登記時，得免檢具繼續教育證明換證之規定；又按同法第 5 條第 2 項規定台端符合該辦法施行之日 5 年內申請執業登記者，故執業執照之更新日期為不超過辦法施行日起算 6 年(即 103 年 6 月 19 日)，而台端 103 年 6 月 30 日未辦理更新執業執照，故原執業執照已失效。
- 六、台端如若欲回國執業，查目前累計之繼續教育積分已達法定積分數，得向執業所在地衛生主管機關申請執業登記並取得更新後執業執照，如無返國執業則無須辦理執業執照之更新。

第 9 條 有下列情形之一者，不得發給執業執照；已領者，撤銷或廢止之：

一、經廢止護理人員證書。

二、經廢止護理人員執業執照未滿一年。三、罹患精神疾病或身心狀況達常，經主管機關認定不能執行業務。

前項第三款原因消失後，仍得依本法規定申請執業執照。

主管機關依第一項第三款規定為認定時，應委請相關專科醫師鑑定。

第 10 條 護理人員非加入所在地護理人員公會，不得執業。
護理人員公會不得拒絕具有會員資格者入會。

第 11 條 護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。

前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業。

護理人員變更執業處所或復業者，準用關於執業之規定。

護理人員死亡者，由原發執業執照機關註銷其執業執照。

81.2.8. 衛署保字第 983194 號函

主旨：有關護理人員法公布前歇業、停業、變更執業處所之護理人員，於事實發生時未辦理核備，於該法公布後逾 10 日以上始核備者，可否免罰疑義乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴處 80 年 10 月 3 日 80 衛五字第 74754 號函。

二、查護理人員歇業、停業、復業或變更執業處所時，應自事實發生之日起 10 日內，報請原發執業執照機關核備，護理人員法第 11 條第 1 項定有明文，苟異動事實發生及應辦理核備之期限屆滿於該法生效之前，依中央法規標準法第 13 條規定，免予處罰。若應辦理核備之 10 日期限屆滿於護理人員法公布生效之後，原應依同法第 11 條規定辦理，違反者依第 39 條規定處罰。惟查該法甫經公布施行不久，護理人員對該法之認識不足，亟需繼續加強宣導工作，另配合該法第 37 條之施行，得於民國 82 年 6 月 30 日前審酌實際情況分區實行之規定，故對異動事實未依規定核備者，宜自本(81)年 7 月 1 日起予以處罰。

83.6.17. 衛署醫字第 83035147 號函

主旨：護理人員歇業、停業、復業或變更執業處所報請核備時，應依說明段之規定辦理，請 查照。

說明：

一、護理人員歇業、停業、復業報請核備時，應依左列規定辦理：

(一)歇業者，註銷其執業執照。

(二)停業者，於其執業執照註明其停業日期後，仍交由其本人收執；復業時，於其執業執照註明復業日期。

二、護理人員變更執業處所，其原執業處所，應辦理歇業登記；新執業處所應依護理人員法第 8 條規定辦理執業登記。

三、護理人員歇業(離職)，未依規定辦理者，應依違反護理人員法第 11 條規定處理，並通知辦理註銷登記；如逾通知期限仍未辦理者，得逕予公告註銷其執業執照。至於違反護理人員法第 11 條規定，其事實行為，係在 81 年 7 月 1 日以前發生，依本署 81 年 2 月 8 日衛署保字第 983194 號函規定，得予免罰。(依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理)

四、醫事人員系統之歇業註銷日期，應以核准註銷之日為註銷日期；至於離職日期，應係作為是否有違反護理人員法第 11 條規定事實認定之參考，於處分紀錄之違反事實已有登載，不須再登記加註離職日期。(依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理)

83.6.17. 衛署醫字第 83035202 號函

主旨：護理人員因故未能執行業務，如留職停薪或服務機關荐派出國進修等，其期間在 1 個月以上者，應辦理停業；在 1 年以上者，應辦理歇業，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

84. 8. 14. 衛署醫字第 84049486 號函

主旨：護理人員與醫療機構發生糾紛，而欲申請執業執照註銷登記，當院方不核發離職證明書時，可否准予註銷執業登記乙案，復請 查照

說明：

- 一、復 貴局 84 年 8 月 2 日(84)北市衛五字第 45569 號函。
- 二、按護理人員法第 11 條規定，護理人員歇業、停業、復業或變更執業處所時，應自事實發生之日起 10 日內，報請原發執業執照機關核備。助產士法第 10 條第 2 項規定，助產士停業、歇業、復業或移轉時，應於 15 日內向原發執業執照機關報告。
- 三、護理人員依前項規定，向原發執業執照機關申請註銷執業登記時，應檢具何種文件，法無明文，惟地方衛生主管機關為便於瞭解其歇業、停業或復業等之確實日期，一般均以其服務單位開具之證明文件為憑；至護產人員與其服務之醫療機構發生糾紛，而未能取得離職證明書者，其於申請執業執照註銷登記時，得以其出具之切結書（應敘明離職日期）辦理執業執照之註銷登記事宜，以兼顧實情並保障其依法辦理執業異動之權益。

90. 4. 13. 衛署醫字第 0900020837 號函

主旨：有關醫事人員執業異動報請核備之期限，如適逢例假日，是否扣除順延抑或合併計算乙案，請依行政程序法第 48 條規定辦理，請 查照。

說明：復 貴局 90 年 3 月 29 日 90 衛醫字第 08413 號函。

90. 10. 18. 衛署醫字第 0900060799 號函

主旨：護理人員邱○○於民國 81 年 5 月 20 日離職，至民國 90 年 9 月 11 日始辦理歇業，是否違反護理人員法第 11 條，依同法第 39 規定處分乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 9 月 21 日 90 高縣衛醫字第 52271 號函。
- 二、查本署 81 年 2 月 8 日衛署保字第 983194 號函規定對護理人員「執業異動事實未依規定核備者，宜自 81 年 7 月 1 日起予以處罰」，意指護理人員法公布施行後，未依該法規定於執業異動事實發生後 10 日內辦理核備，其於 81 年 7 月 1 日前辦理核備者，免予處罰。本案邱員於 81 年 5 月 20 日離職，迄 90 年 9 月 11 日始辦理歇業，應依護理人員法第 39 條規定予以處分。

(註：本函釋當事人之名字以○○表示)

90.11.19. 衛署醫字第 0900065469 號函

主旨：所詢雲林技術學院於 86 年 8 月 1 日改制為「國立雲林科技大學」，該校醫務室護理人員於 90 年 9 月 19 日始向貴局辦理變更手續乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 10 月 15 日 90 雲衛三字第 20655 號函。
- 二、有關雲林技術學院於 86 年 8 月 1 日改制為「國立雲林科技大學」乙案，係屬機構名稱之變更，其機構代碼未有變更，非屬護理人員法第 11 條所定歇業、停業、復業或變更執業處所情事。

95.11.1. 衛署醫字第 0950041002 號函

主旨：所詢醫師、醫事檢驗師、醫事放射師等醫事人員辦理歇業或停業時，其所定期限之事實認定，得否扣除星期例假日及國定假日乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 9 月 15 日衛醫字第 0950042119 號函。
- 二、按行政程序法第 48 條第 2 項及第 4 項分別規定，「期間以日、星期、月或年計算者。其始日不計算在內。但法律規定即日起算者，不在此限。」、「期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日

；期間之末日為星期六者，以其次星期一上午為期間末日。」。

- 三、查醫事人員執業異動報請核備之期限，如適逢例假日，是否扣除順延抑或合併計算，請依行政程序法第 48 條規定辦理，前經本署以 90 年 4 月 13 日衛署醫字第 0900020837 號函釋示在案。爰此，醫事人員執業異動報請核備期限，其期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；期間之末日為星期六者，以其次星期一上午為期間末日。
- 四、本署 84 年 2 月 27 日衛署醫字第 84004428 號函及 93 年 2 月 9 日衛署醫字第 0930003596 號函，自 95 年 12 月 31 日起停止適用。

101.5.18. 衛署醫字第 1010203193 號函

主旨：有關護理人員於產假或育嬰假等留職停薪期間，是否需辦理停業、歇業一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 101 年 4 月 30 日全聯護會字第 101138 號函。
- 二、依護理人員第 11 條第 1 項規定：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。」違反者，依同法第 39 條規定處新台幣三千以上三萬元以下罰鍰。亦即領有執業執照之護理人員未執行同法第 24 條規定護理人員之業務持續超過三十日，此時無報請原發執業執照機關備查者，為違反護理人員法第 11 條第 1 項規定。
- 三、旨揭護理人員依相關法令請產假或育嬰假，或經服務機構同意留職停薪，期間既無執行護理業務，應依護理人員法第 11 條第 1 項規定辦理停業或歇業。其停業、歇業係衛生行政之管理要求，並不影響其受雇身分之相關權益。至護理人員有前開情形是否致勞健保等權益受損時，得逕向勞工主管機關會商。

(註：本函釋說明三末段所敘「護理人員於產假或育嬰留職停薪之勞工保險權益」疑義，請參閱行政院勞工委員會 101.6.27.勞保 2 字第 1010068957 號函，其內容如下：

主旨：有關函詢護理人員於產假或育嬰留職停薪期間之勞工保險權益疑義一案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 101 年 6 月 13 日衛署醫字第 1010203202 號函。
- 二、查勞工保險為在職保險，並以僱傭關係為前提。依勞工保險條例第 6 條第 1 項第 1 款至第 3 款規定，受僱於僱用勞工 5 人以上之公、民營工廠、公司、行號及公益事業等單位之員工，應以其雇主為投保單位，參加勞工保險為被保險人。受僱於第 6 條第 1 項各款規定各業以外及僱用未滿 5 人之第 6 條第 1 項第 1 款至第 3 款規定各業之員工，得依同條例第 8 條第 1 項規定，自願參加勞工保險。基此，勞工於產假期間，因其僱傭關係仍存續，有關勞工保險加保事宜應依上開規定辦理。
- 三、依性別工作平等法第 16 條第 1 項及第 2 項規定，受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。受僱於育嬰留職停薪期間，得繼續參加原有之社會保險，原由雇主負擔之保險費，免予繳納；原由受僱者負擔之保險費，得延三年繳納。故勞工保險被保險人依上開規定申請育嬰留職停薪期間，得依規定繼續參加勞工保險。)

101.10.3. 衛署醫字第 1010266500 號函

主旨：有關護理人員於產假或育嬰假等留職停薪期間，是否需辦理停業、歇業一案，再予釋示詳如說明段，請 查照。

說明：

- 一、依台灣醫院協會 101 年 8 月 15 日院協衛字第 10120559 號函及中華民國區域醫院協會 101 年 8 月 20 日(101)區域醫協字第 029 號函辦理。

- 二、依護理人員法第 11 條第 1 項及第 2 項規定：「護理人員停業或歇業，應自事實發生之日起 30 日內，報請原發執業執照機關備查。前項停業期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業。」爰此，領有執業執照之護理人員如有未執行同法第 24 條所定業務之情事相當時日，且實際不執行業務在一年以下者，應在符合停業的事實發生之日起 30 日內，辦理停業備查。護理人員於產假或育嬰假等留職停薪期間，如確無執行護理業務，依前開規定辦理停業或歇業，應無不可。
- 三、綜上，本署 101 年 5 月 18 日衛署醫字第 1010203193 號及同年 7 月 2 日衛署醫字第 1010072518 號函釋所稱護理人員辦理停業或歇業，係依據其有否執行護理人員業務，而非以假別為考量。又護理人員請假，係基於個人所需依相關法令辦理請假以利休養，非屬個人可任意申請，倘若護理人員請假期間未有停業或辦理停業之意願，尚無違反護理人員法第 11 條第 1 項之規定，爰另予補充。

102.3.4. 衛署醫字第 1020201143 號函

主旨：有關護理人員於育嬰假之留職停薪期間是否須辦理停業、歇業，及其他醫事人員一體適用與否疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 11 月 8 日高市衛醫字第 10140766300 號函。
- 二、依目前 14 類醫事人員專門職業法律規定，醫事人員停業或歇業，應自事實發生之日起 30 天內，報請原發執業執照機關備查；又前項停業期間，以一年為限，逾一年者，應辦理歇業。查該規範之意旨及精神，除可避免各類醫事機構實際提供醫事人力計算之誤差外，並藉以提升醫療服務品質、效率及均衡醫療資源分布，並作為醫事人力及醫療資源管理之參考。
- 三、另查，性別工作平等法第 15 條第 1 項規定：「雇主於女

性受僱者分娩前後，應使其停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，應使其停止工作，給予產假四星期；……。」同法第 16 條第 1 項規定：「受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。」是以，產假係婦女生產或流產後恢復生理機能所需休養之連續過程，有其必要性，非屬個人可任意申請，且不可自由選擇時段；而育嬰假係基於子女照護需要，依個人意願及需要，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，最長可達 2 年，若同時撫育子女二人以上者，最長可至最幼子女受撫育 2 年為止。

- 四、綜上，基於產假係為政府保護婦女生育健康所為強制性規定及特有權利，護理人員(包括其他女性醫事人員)於產假休養期間如無執業之事實，且未有停業、歇業之意願下，得免強制辦理停業及歇業；至於育嬰留職停薪之申請係屬任意性規範，為社會福利措施，子女滿 3 歲前得依意願申請，期間則依個案需求及子女數而異，最長可至最幼子女受撫育 2 年為止。是以，基於醫療人力管理、醫療品質之維護及民眾就醫安全，請育嬰假人員仍應依各該醫事人員專門職業法律有關執業規範辦理。本署 101 年 10 月 3 日衛署醫字第 1010266500 號說明段意旨未明處，再予補充說明。

102.8.23. 衛署醫字第 1021580318 號函

主旨：新北市政府衛生局函詢老人福利機構變更負責人涉及開業、歇業程序，所屬護理人員執業是否併同歇業變更事實發生日起 30 日內一併完成執業登記疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 102 年 8 月 12 日社家老字第 1020000599 號書函。

- 二、查護理人員法第 8 條第 1 項規定：「護理人員應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」次按第 11 條第 1 項規定，護理人員歇業、停業、復業或變更執業處所時，應自事實發生之日起 30 日內，報請原發執業執照機關核備，違反前述規定者，則依同法第 39 條規定論處。
- 三、旨案醫事管理系統之機構代碼變更及該機構所屬護理人員執登變更，應以社政單位許可設立公函核准之日期為準，另護理人員辦理執業登錄變更程序，自應按上開規定辦理。

102.11.26 衛部照字第 1021581113 號函

主旨：有關 貴會所詢護理人員依性別工作平等法申請 2 年育嬰留職停薪，是否屬護理人員法第 11 條所定之停業或歇業疑義乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴會 102 年 11 月 6 日勞動 3 字第 1020083413 號函。
- 二、依目前 14 類醫事人員專門職業法律規定，醫事人員停業或歇業，應自事實發生之日起 30 天內，報請原發執業執照機關備查；又前項停業期間，以 1 年為限，逾 1 年者，應辦理歇業。查該規範之意旨及精神，除可避免各類醫事機構實際提供醫事人力計算之誤差外，並藉以提升醫療服務品質、效率及均衡醫療資源分布，並作為醫事人力及醫療資源管理之參考。
- 三、次查，性別工作平等法第 16 條第 1 項規定：「受僱者任職滿一年後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。」。
- 四、是以，育嬰假係基於子女照護需要及個人意願，係屬任意性規範，為社會福利措施，子女滿 3 歲前得依意願申請，

期間則依個案需求及子女數而異，最長可至最幼子女受撫育 2 年為止。是以，基於醫療人力管理、醫療品質之維護及民眾就醫安全，請育嬰假人員仍應依各該醫事人員專門職業法律有關規範辦理。前經行政院衛生署 102 年 3 月 4 日衛署醫字第 1020201143 號函釋在案。

- 五、綜上，故護理人員法第 11 條並未規範護理人員育嬰留職停薪僅得申請 1 年，其育嬰留職停薪期間，因辦理停業或歇業不認列為工作年資，然並無年資全部歸零之情事，另其後如依護理人員法第 11 條辦理復業後，其原工作年資仍得以累計之。

103.12.22 衛部照字第 1030136413 號函

主旨：有關貴局函詢護理人員自行歇業，經通知仍未至原發執業執照機關辦理歇業一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 12 月 4 日彰衛醫字第 1030038673 號函。
- 二、按護理人員法第 11 條第 1 項規定：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。」，同條第 2 項規定：「前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業」。同法第 39 條規定：「違反第十一條第一項規定者，處新台幣 3000 元以上 3 萬元以下罰鍰。」，合予敘明。
- 三、本案護理人員如未依規定辦理歇業，按行政程序法(36 條及 39 條)規定，貴局應本於機關權責調查事實及證據，必要時得以書面通知其陳述意見，如經調查確實違法(當事人仍未依規定辦理歇業程序)，得依護理人員法第 39 條裁處。另依行政程序法 123 條規定略以：「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：一、法規准許廢止者……。」，按此，考量執業登錄規定之立法意旨及現況，建請貴局參酌前揭規定並本權責及事實辦理。

104.1.12 衛部照字第 1030139595 號函

主旨：有關貴局再次請本部函釋示未依規定辦理歇業，依行政程序法第 123 條規定，法規准許廢止者得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止，法規為何疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 12 月 30 日彰衛醫字第 1030041148 號函。
- 二、按本部前函釋示重點如下：考量執業登錄規定之立法意旨及現況，建請貴局依護理人員法第 11 條及 39 條規定辦理，並參酌行政程序法 36 條及 39 條規定辦理，依調查所得事實及證據，適用同法第 123 條第 4 款規定本於權責處理。

104.4.28 衛部照字第 1040111415 號函

主旨：有關貴局函詢護理人員未於歇業事實發生之日起 30 日內，依規定向原發執業執照機關辦理報備，裁處時效疑義，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 4 月 22 日桃衛醫護字第 1040028658 號函。
- 二、依護理人員法第 11 規定：「護理人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業。護理人員變更執業處所或復業者，準用關於執業之規定。護理人員死亡者，由原發執業執照機關註銷其執業執照。」同法第 39 條規定：「違反第十一條第一項規定者，處新台幣 3000 元以上 3 萬元以下罰鍰。」，合予敘明。
- 三、另依行政罰法第 27 條規定略以：「行政罰之裁處權，因三年期間之經過消滅。前項期間，自違反行政法義務之行為終了時起算。…。」。
- 四、據貴局函述該護理人員於 97 年 10 月 16 日自服務機構離職，遲至 104 年 4 月 9 日始向貴局辦理歇業手續。雖該護

理人員未自離職日之事實發生之日起 30 天內(至 97 年 11 月 14 日止)向原發執業執照機關備查與辦理停歇業手續，但該行政罰法之裁處期間應於其離職事實發生日(行為終了時)起滿三十天後之翌日起三年內(即 97 年 11 月 15 日起至 100 年 11 月 15 日止)，非以辦理歇業手續日期起算。

五、綜上所述，請貴局依相關規定與個案事實之認定辦理。

第 12 條 護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。

83.6.17. 衛署醫字第 83035204 號函

主旨：居家護理機構，其服務區域跨直轄市或縣(市)行政區域者，應依護理人員法第 12 條規定申請報准，並應每年定期辦理 1 次報准，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

83.8.24. 衛署醫字第 83050863 號函

主旨：所詢醫療機構、護理機構跨縣市辦理居家護理服務，依規定申請報准之程序要件乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴處 83 年 8 月 9 日 83 五字第 059963 號函。

二、居家護理機構或醫療機構所設居家護理服務部門，其服務區域跨直轄市或縣(市)行政區域者，依護理人員法第 12 條規定申請報准，應檢具左列文件：

(1)開業執照影本。

(2)依護理機構設置標準第 9 條所定之設立計畫書。

(3)其執業之護理人員證書與執業執照影本。

- 三、其護理人員執業異動或每年逐期辦理 1 次之報准時，應檢具前項第 3 款之文件。

84.10.13. 衛署醫字第 84060356 號函

主旨：各鄉鎮市立托兒所護士，是否為中央主管機關認可之機構，並准予發給執業執照乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 84 年 9 月 20 日 84 桃衛五字第 2554 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。本案鄉鎮市立托兒所護士，其工作包括幼兒衛生保健、疾病管理及救護、傳染病防治、預防接種及衛生教育等，均屬護理業務範疇，得視同在中央主管機關認可之機構執業。

86.9.1. 衛署醫字第 86045926 號函

主旨：護理人員法第 12 條所稱「其他經中央主管機關認可之機構」所指為何乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處 86 年 7 月 30 日衛五字第 860046157 號函。
- 二、依台東縣衛生局 86 年 7 月 22 日 86 衛五字第 86006434 號函說明，張○○○小姐為交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處業務員，擔任杉原海水浴場護理工作，申請辦理護士執業登記，應可准予登記。至護理人員法第 12 條所稱「其他經中央主管機關認可之機構」所指為何乙節，應視個案事實分別加以認定。

（註：本函釋當事人之名字以○○○表示）

87.6.22. 衛署醫字第 87040675 號函

主旨：護理人員支援其他醫療機構或護理機構，應依說明段辦理，請 查照。

說明：

- 一、依據 87 年護理行政業務研討會決議辦理。
- 二、護理人員支援其他醫療機構或護理機構，應事先報准，如越區前往支援者，應報經所在地直轄市或縣(市)衛生主管機關核准，並副知執行地直轄市或縣(市)衛生主管機關。前往其他醫療機構或護理機構受訓者，其受訓期間在 1 年內，得以報准方式辦理，免辦理執業登記異動。

89.11.8. 衛署醫字第 0890017628 號函

主旨：有關已立案居家護理所之醫護人員，未經報備核准而至立案或未立案之長期照護機構執行業務，是否違反相關法規；又插鼻胃管、導尿管係屬醫療行為或護理行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 9 月 25 日彰衛五字第 26227 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定：護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。已立案居家護理所之護理人員，未經事先報准，即至立案或未立案之長期照護機構執行業務，核屬違反上開規定。
- 三、鼻胃管、導尿管之裝置，係屬醫療業務，得由護理人員依醫師指示為之。

90.6.6. 衛署醫字第 0900028344 號函

主旨：所詢護理人員法第 12 條規定疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 5 月 7 日北市五字第 9021867400 號函。
- 二、護理人員法第 12 條規定「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事

先報准者，不在此限」，揆其立法意旨，所稱「執業機構間之支援」，係指未固定排班執行護理業務者，例如遇有大量傷病患，需臨時增加護理人力處理之情形，至於護理人員定期至其他機構支援，應屬需經事先報准事項。

- 三、衛生主管機關於受理申請護理人員至他機構執行業務時，應權衡是否影響申請機構之人力配置、業務執行，支援者每週全部工作時數之適當性及支援期間是否過長等因素，再予核准。

91.4.12. 衛署醫字第 0910019005 號函

主旨：有關居家護理機構逐年跨行政區域提供服務乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 91 年 2 月 27 日北衛保字第 0910005845 號函。
- 二、查居家護理機構，其服務區域跨直轄市或縣(市)行政區域者，應依護理人員法第 12 條規定向擬服務區域之衛生主管機關申請報准，並應每年定期辦理 1 次報備；跨縣市辦理居家護理服務，依規定申請報准，應檢具之文件包括：開業執照影本、依護理機構設置標準第 9 條規定所定之設立計畫書及其執業之護理人員證書與執業執照影本。前經本署分別以 83 年 6 月 17 日衛署醫第 83035204 號函及 83 年 8 月 24 日衛署醫字第 83050863 號函釋在案。居家護理機構應檢附前開之文件，報請其擬服務區域之衛生主管機關核准。

(註：本函釋說明二所敘本署 83.6.17. 衛署醫字第 83035204 號函及 83.8.24. 衛署醫字第 83050863 號函釋，請參閱 P. 80)

93.4.1. 衛署醫字第 0930200468 號書函

主旨：所詢護理人員未依規定辦理執業登記，接受服務單位（醫療機構）之服務派遣單，未經報備核准即自行跨縣市到民宅從事抽血執行醫療業務行為，其違反護理人員法之相關

規定該如何論處乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 2 月 25 日北市衛五字第 09331164600 號函。
- 二、查依本署 88 年 7 月 29 日衛署醫字第 88045247 號函規定略以：「按醫療機構之業務違反醫療法之相關規定，其處罰以發照地之衛生主管機關為權責單位；至其醫事人員之行為違反醫事人員管理法規相關規定，其處罰以行為地之衛生主管機關為權責單位。故本案如僅罰鍰處分應由行為地執行，若涉及停業或撤銷執業執照則由發照地執行。」。
- 三、本案護理人員其未經報准跨至貴轄違法執行業務，依前開規定，應由貴局依違反護理人員法第 12 條規定論處，至其並涉違反同法第 8 條規定未辦理執業登記部分，應移由其所在地主管機關依法查處。

93.10.5. 衛署醫字第 0930040594 號書函

主旨：所詢服務於衛生所僅具助產人員資格者，是否得支援學校護理工作乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 9 月 16 日衛署醫字第 0930025238 號函。
- 二、查助產人員法第 25 條規定，助產人員業務如下：(一)接生。(二)產前檢查及保健指導。(三)產後檢查及保健指導。(四)嬰兒保健指導。(五)生育指導。(六)其他經中央主管機關認定之項目。至學校護理人員其工作包括衛生保健、疾病管理及救護、傳染病防治、預防接種及衛生教育等，係屬護理人員業務範疇，核與助產人員業務不同。按各該醫事人員應依其專門職業法律規定執行業務，爰此，僅具助產人員資格者執行學校護理工作，核已逾越執業規定範疇。

94.7.6. 衛署醫字第 0940025548 號書函

主旨：所詢醫療機構（衛生所）開業執照是否得於診療科別項下

加註業務項目：「居家護理」，及該居家護理機構以衛生所護理人員 1 名為負責人，則該員執行衛生所之護理業務時是否亦應事先報准？又該衛生所醫師及其他醫事人員支援附設居家護理所之業務，是否亦須事先報備一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 15 日嘉衛醫字第 0940011168 號函。
- 二、按衛生所提供醫療服務者，參照醫療法施行細則第 10 條第 2 款第 11 目規定，性質應屬診所，其附設居家護理所者，依本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函示以，醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。是以，有關醫療機構附設護理機構開業執照之核發，請依前開函示辦理。
- 三、另按護理人員法第 13 條規定，護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。爰此，執業登錄於該附設居家護理所之護理人員，若至醫療機構（衛生所）執行護理業務，仍應依護理人員法第 12 條規定辦理。
- 四、至該醫療機構（衛生所）醫師及其他相關醫事人員支援附設居家護理所之業務，仍請依各該專業法規之規定，經事先報准，始得為之。

（註：1. 本函釋說明二所敘本署 90.5.10. 衛署醫字第 0900031774 號函釋，請參閱 P.162）

2. 說明四所敘醫療機構（衛生所）醫師及其他醫事人員支援附設居家護理所之業務，其報備支援疑義，業經 100.9.20 衛署醫字第 1000264653 號函補充解釋，請參閱 P.94）

94.7.12. 衛署醫字第 0940027094 號書函

主旨：所詢護理人員法第 12 條規定，居家護理機構跨行政區域提供服務，應事先向擬服務區域之衛生主管機關申請報准，

有關該轄衛生主管機關准予核備之依據疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 29 日南市衛保字第 094013833 號函。
- 二、按居家護理機構服務區域跨直轄市或縣(市)行政區域者，應依護理人員法第 12 條規定經事先報准，為護理機構設置標準第 9 條第 2 項所規定。至該居家護理機構應檢具開業執照影本、依護理機構設置標準第 9 條規定所定之設立計畫書及其執業之護理人員證書與執業執照影本，向擬服務區域之衛生主管機關申請報准，並應每年定期辦理一次報備，前業經本署 91 年 4 月 12 日衛署醫字第 0910019005 號函釋在案。
- 三、至衛生主管機關於受理擬至所轄區域提供護理服務之居家護理機構申請報准時，應權衡該居家護理機構提供之業務特性及便利性、服務品質、病人轉介流程適當性、地方之需要性及服務對象之權益等因素，再予核准。

94.10.28.衛署醫字第 0940209826 號書函

主旨：所詢具護士及助產士雙重醫事人員資格者，擇助產士資格執業登錄於助產所，其可否至養護中心支援醫療業務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 8 月 24 日北衛醫字第 0940052862 號函。
- 二、查助產人員法第 25 條規定，助產人員業務如下：(1)接生。(2)產前檢查及保健指導。(3)產後檢查及保健指導。(4)嬰兒保健指導。(5)生育指導。(6)其他經中央主管機關認定之項目；至養護中心支援醫療業務，執行醫療輔助行為、健康問題之護理評估、預防保健之護理措施及護理指導及諮詢等，係屬護理人員業務範疇，核與助產人員業務不同。且助產人員之執業，依同法 12 條第 1 項規定，以一處為限，並應在所在地主管機關核准登記之助產機構或醫療

機構為之。

- 三、按醫事人員執行各該專門職業法律所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記，領有執業執照，始得為之。本案該員具護理人員及助產人員雙重資格，並擇助產人員資格於助產所辦理執業登記，安養中心非前開助產人員法所定之醫療機構或助產機構，故尚不得以護理人員資格至養護中心執行護理業務。

95.1.4. 衛署醫字第 0950200710 號書函

主旨：有關非獨立型態之居家護理機構之護理人員，支援原附設醫療機構或原附設護理機構業務時，免依護理人員法第 12 條規定辦理支援報備，請 查照。

說明：

- 一、依據 94 年醫療行政及醫療法規研討會決議辦理。
- 二、檢送各縣市衛生局針對所轄非獨立型態之居家護理所支援報備情形之調查結果彙整資料一份。（見附件）

（註：本函釋主旨段所敘免依護理人員法第 12 條規定辦理支援報備，其適用之範圍，以「遇有大量傷病或緊急情況下，必須臨時增加護理人力協助處理之情況」為限，業經 100.9.20. 衛署醫字第 1000264653 號函補充解釋，請參閱 P. 94）

95.5.15. 衛署醫字第 0950018483 號書函

主旨：所詢教學醫院代訓其他醫療院所護理人員之相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 95 年 5 月 3 日校附醫秘字第 0950001618 號函。
- 二、有關支援報備一節，查「護理人員支援其他醫療機構或護理機構，應事先報准，如越區前往支援者，應報經所在地直轄市或縣（市）衛生主管機關核准，並副知執行地直轄市或縣（市）衛生主管機關。前往其他醫療機構或護理機構受訓者，其受訓期間在一年內，得以報准方式辦理，免

辦理執業登記異動。」，前經本署 87 年 6 月 22 日衛署醫字第 87040675 號函釋在案，請依前述規定辦理。

- 三、護理人員於接受訓練期間，應遵守訓練機構內部管理相關規範，並依護理人員法之相關規定執行護理業務。按護理人員依醫囑執行醫療輔助行為時，如確已善盡護理人員之注意義務，依醫療專業注意事項執行護理業務，應無業務過失責任問題；至執行該行為所依據之指示如有不當，應由指示醫師負醫療責任。

（註：本函釋說明二所敘本署 87.6.22. 衛署醫字第 87040675 號函，請參閱 P.81）

95.8.8. 衛署醫字第 0950033582 號函

主旨：所詢校護短時間請假，若請合格惟非現職之護理人員代理業務，是否得免辦理執業登記即可為之及免辦執業登記代理之時限等疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 8 月 2 日桃衛醫字第 0950006460 號函。
- 二、查護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員執業依法應以領有執業執照後，始得為之；護理人員未依法辦理執業登記，即擅自執業，係屬違法執業，應依護理人員法第 33 條規定論處，先予敘明。
- 三、另查同法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」是以，有關校護編制或實際運作僅有一名之學校，當該校護短時間請假時，可商請鄰近機構之護理人員，依護理人員法第 12 條之規定前往支援學校護理工作。

95. 9. 13. 衛署醫字第 0950039910 號書函

主旨：所詢任職衛生局護理人員出勤支援救護工作者是否需辦理執業登記一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 9 月 8 日衛醫字第 0950007609 號函。
- 二、查護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員執業依法應以領有執業執照後，始得為之；護理人員未依法辦理執業登記，即擅自執業，係屬違法執業，應依護理人員法第 33 條規定論處。
- 三、爰此，貴局護理人員出勤支援救護工作，涉及執行護理業務，除有護理人員法第 12 條但書所定情事外，應依法辦理執業登記。

95. 9. 28. 衛署醫字第 0950041791 號函

主旨：所詢執業登錄於醫院之護理人員因病患行動不便，可否依原診治醫院醫師開立之醫囑單至病患家中替病患施打抗生素一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 9 月 20 日新縣衛醫字第 0950019670 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」爰此，本案請依前開規定辦理。
- 三、又查本案醫師開立每日肌肉注射抗生素（streptomycin）3-6 個月之長期處方，交由護理人員執行該業務時，護理人員應確依藥物注射注意事項執行並善盡護理人員必要之注意，應無業務過失責任問題，至其醫療責任仍應由指示醫師負責。

96.2.7. 衛署醫字第 0960004894 號函

主旨：所詢護理人員法第 12 條所稱「其他經中央主管機關認可之機構」所指為何一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 23 日桃衛醫字第 0960000940 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」，至所稱「其他經中央主管機關認可之機構」，查為中央主管機關端視個案事實分別認定。
- 三、次查歷年本署視個案事實所認可護理人員可執業之機構，請參見本署 83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035199 號函、83 年 7 月 11 日衛署醫字第 83031330 號函、84 年 10 月 13 日衛署醫字第 84060356 號函、86 年 1 月 29 日衛署醫字第 86007633 號函、86 年 3 月 20 日衛署醫字第 86012919 號函、86 年 5 月 17 日衛署醫字第 86017775 號函、86 年 9 月 1 日衛署醫字第 86045926 號函、87 年 3 月 23 日衛署醫字第 87014069 號函、87 年 11 月 6 日衛署醫字第 87056029 號函、92 年 12 月 19 日衛署醫字第 0920066391 號函、96 年 1 月 30 日衛署醫字第 0960004121 號函。檢送前述函釋資料 1 份，請參考。

(註)本函釋說明三所列文號函，其認可護理人員可執業之機構，摘錄如下：

83.6.17 衛署醫字第 83035199 號函(P.48)	護理學校教師從事護理教育或護生實習，可以其學校為執業登記處所。
83.7.11 衛署醫字第 83031330 號函(P.49)	學校校護。
84.10.13 衛署醫字第 84060356 號函(P.81)	各鄉鎮市立托兒所護士。
86.1.29 衛署醫字第 86007633 號函(P.51)	國立中正紀念堂約僱護士。
86.3.20 衛署醫字第	中華民國紅十字會台灣省台南市支會之護士，從

86012919 號函(P. 51)	事學校教職員、學生及一般社會人士之急救訓練工作。
86.5.17 衛署醫字第 86017775 號函(P. 52)	中華民國新生兒醫學會辦理「早產兒追蹤門診專案計畫」約僱派駐縣市之護士，執行早產兒門診跟診、量身高體重、護理指導及電話追蹤，可以其執業之場所，為其執業登記之地點。
86.9.1 衛署醫字第 86045926 號函(P. 81)	海水浴場護理工作。
87.3.23 衛署醫字第 87014069 號函(P. 52)	花蓮縣秀林鄉天祥晶華渡假酒店聘僱護士，如確有從事護理工作之事實，得辦理執業登記，其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。
87.11.6 衛署醫字第 87056029 號函(P. 52)	台南市緊急救護指揮中心護理人員。
92.12.19 衛署醫字第 0920066391 號函(P. 55)	台南市政府社會局至善老人養護中心委託財團法人天主教耕莘醫院辦理福利服務，所聘僱護理人員如確有從事護理工作之事實，得辦理執業登記，其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。
96.1.30 衛署醫字第 0960004121 號函(P. 57)	台灣高速鐵路局聘僱護理人員從事緊急救護、急救訓練等工作，得辦理執業登記，其機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。

96.2.13. 衛署醫字第 0960004908 號函

主旨：有關 貴局查獲於未立案護理機構執業之護理人員，涉及違反護理人員法之規定，所詢適用法條疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 29 日北衛醫字第 0960004835 號函。
- 二、查護理人員法第 8 條規定：「護理人員執業，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關送驗護理人員證書，申請登記，發給執業執照。」即護理人員執業依法應以領有執業執照後，始得為之；次查同法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」即未經立案之護理機構，非屬護理人員合法執業之場所。本案護理人員未辦

理執業登錄即執行護理業務，核屬違反護理人員法第 8 條之規定；又查，該員於未立案之護理機構執行護理業務，同時違反護理人員法第 12 條之規定。

- 三、依行政罰法第 24 條第 1 項規定：「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額。」是以，本案護理人員未領有執業執照即執行護理業務之違法行為情節，依一行為不二罰原則，以護理人員法第 33 條規定論處。

96.3.2. 衛署醫字第 0960006428 號函

主旨：有關「醫事檢驗所」派護士外出抽血帶回檢驗並收取費用違反規定之適法性疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 2 月 7 日北衛醫字第 0960012401 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」，經查「醫事檢驗所」非屬中央主管機關認可之護理人員執業場所，先予敘明。
- 三、關於本案所述醫事檢驗所派護士外出為民眾抽血，再將檢體帶回該醫事檢驗所檢驗並收取費用等情節，處理方式如下：(1)醫事檢驗機構部分：事涉醫事檢驗所不正當招攬業務，係違反醫事檢驗師法第 30 條規定，應依同法第 41 條規定論處，請參考本署 96 年 1 月 4 日衛署醫字第 0950066335 號書函辦理。(2)醫事檢驗人員部分：該醫事檢驗所之醫事檢驗人員如執行該檢驗業務，業涉違反醫事檢驗師法第 12 條第 2 項前段之規定，另依同法第 34 條第 1 項規定論處。(3)護理人員部分：查抽血之醫療輔助行為係屬護理人員法第 24 條所規定之護理業務。護理人員執行護理業務依法應以領有執業執照後，始得為之。本案護理

人員如未辦理執業登錄即執行護理業務，核屬違反護理人員法第 8 條規定；又護理人員於非屬中央主管機關認可之執業場所執行護理業務，亦同時違反護理人員法第 12 條之規定。惟依行政罰法第 24 條之意旨，本案護理人員如未領有執業執照即執行護理業務之違法行為情節，依一行為不二罰原則，以護理人員法第 33 條規定論處。是以，本案請依權責視個案事實認定，並依前述規定查處。

（註：本函釋說明三所敘本署 96.1.4. 衛署醫字第 0950066335 號書函，其內容如下：

主旨：所詢「醫事機構」以不正當方法跨轄區招攬病人，其行政處分之法令依據為何一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 12 月 21 日北衛醫字第 0950106904 號函。
- 二、按醫事檢驗師法第 9 條規定，醫事檢驗師執業以一處為限，並應在所在地衛生主管機關核准登記之醫療機構、醫事檢驗所或其他經衛生主管機關認可必須聘請醫事檢驗師之機構為之。但機構間之支援或經事先報准者，不在此限。違者依同法第 37 條規定，處新台幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰。
- 三、由 貴局來函所示，貴轄醫事檢驗機構跨區不正當招攬業務，其違法行為係發生於台北市，按土地管轄兩縣市均有管轄權。另依行政程序法第 13 條第 1 項規定，同一事件，數行政機關依前二條之規定均有管轄權者，由受理在先之機關管轄……。本案請參酌前揭說明辦理。
- 四、又個案於裁罰後之執行事宜，其僅處罰鍰處分者，應由為處分之縣（市）主管機關執行；若涉及停業或撤銷廢止執業執照，應適用本署 88 年 7 月 29 日衛署醫字第 88045247 號函釋，由發照地主管機關執行。）

96.10.5. 衛署醫字第 0960211487 號函

主旨：為本署 83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035196 號函及 85 年 1 月 5 日衛署醫字第 84076144 號函，有關無固定執業處所

擔任特聘(別)護士或部分工時之護理人員，暫以所在地護理師護士公會辦理執業處所登記一節，自即日停止適用，請 查照。

說明：查依前述函釋，係因應當時特殊時空背景之個案函釋，惟因時空背景之轉換，該函釋業已不適用，併予說明。

(註：本函釋主旨段所敘本署 83.6.17. 衛署醫字第 83035196 號函，請參閱 P.103)

100.9.20. 衛署醫字第 1000264653 號函

主旨：有關護理機構及醫療機構之護理人員，支援附設居家護理機構之業務時，其報備支援之疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 100 年 8 月 17 日東衛醫字第 1000014253 號函。

二、依護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。又，參考醫療機構設置標準第 26 條第 2 項規定：「前項所稱醫療機構間之會診、支援，指下列情形且未固定排班提供診療者而言：一、遇有大量傷病患，需臨時增加醫師人力處理者。二、對於緊急或重症傷病，需徵詢其他醫師意見者。」。

三、爰此，護理機構及醫療機構之護理人員，支援附設居家護理機構之業務時，除遇有大量傷病患或緊急情況下，必須臨時增加護理人力協助處理之情形外，仍應依照護理人員法第 12 條但書規定，事先向主管機關報准後為之。

四、至於非獨立型態之居家護理機構護理人員，支援其原附設醫療機構或原附設護理機構時，免依護理人員法第 12 條規定辦理支援報備，其適用之範圍，亦應同於前揭情形為限。本署 95 年 1 月 4 日衛署醫字第 0950200710 號書函，應予補充。

(註：本函釋說明四所敘本署 95.1.4 衛署醫字第 0950200710 號書函

，請參閱 P.87)

101.1.20. 衛署照字第 1002860240 號函

主旨：關於未立案老人福利機構於主管機關限期改善期間如何確保醫療照護品質一案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 101 年 1 月 6 日內授中社字第 1015930081 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」。因此，於經主管機關限期改善之尚未完成立案老人福利機構，其限期改善期間之照護問題，得依同法第 12 條但書規定，商請轄區衛生局以個案方式准予醫療機構或護理機構派護理人員協助服務。
- 三、又各衛生局並無上開限期改善機構資料，為避免衛生局可能誤准醫療機構或護理機構護理人員至其他未立案老人福利機構提供照護服務，故建請老人福利機構主管機關函知轄區衛生局此類機構名稱、地址及限期改善期間等資料，俾利協助辦理。

101.3.12. 衛署照字第 1012860716 號函

主旨：關於護理機構或醫療機構之護理人員，支援附設居家護理機構之報備支援事宜，請 查照。

說明：

- 一、依護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。又，參考醫療機構設置標準第 26 條第 2 項規定，「前項所稱醫療機構間之會診、支援，指下列情形且未固定排班提供診療者而言：一、遇有大量傷病患，需臨時增加醫師人力處理者。二、對於緊急或重症

傷病，需徵詢其他醫師意見者。」。

- 二、爰此，護理機構及醫療機構之護理人員，支援附設居家護理機構之業務時，除遇有大量傷病患或緊急情況下，必需臨時增加護理人力協助處理之情形外，仍應依護理人員法第 12 條但書規定，事先向主管機關報准後為之。
- 三、惟近來發現，部分護理機構或醫療機構之護理人員，支援附設居家護理機構業務，有未依上開規定之情事，惠請貴局宜向轄內機構宣導該等規定，並要求落實完成報備支援之程序。

101.12.28. 衛署照字第 1012864978 號函

主旨：所詢護理之家負責人是否可提出跨區支援報備乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 12 月 13 日桃衛照字第 1010192654 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。
- 三、護理人員支援其他醫療機構或護理機構，應事先報准，如越區前往支援者，應報經所在地直轄市或縣(市)衛生主管機關核准，並副知執行地直轄市或縣(市)衛生主管機關。
- 四、依據護理人員法第 19 條，護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任。本案申請跨區支援報備之護理人員為護理機構負責人，而個案申請跨區支援之醫療機構或護理機構人力不足問題，非屬該個案之責任，申請跨區支援之適當性、其所設置之護理機構營運、人員派班值勤及業務督導管理狀況、該機構每年督導考核、不定期查核、相關行政處分及本署辦理之評鑑評等情形，本權責逕行判定該護理機構負責人申請跨區支援報備相關條件之合理性。

103.2.11 衛部照字第 1031560143 號函

主旨：有關貴局函詢護理人員於醫事檢驗機構辦理公共衛生事業，得否執業登記乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 1 月 14 日中市衛醫字第 1030004284 號函。
- 二、按護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之，但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限」。及同法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。另按醫事檢驗師法第 9 條規定：「醫事檢驗師執業以一處為限，並應在所在地衛生主管機關核准登記之醫療機構、醫事檢驗所或其他經衛生主管機關認可必須聘請醫事檢驗師之機構為之」。
- 三、按上開規定，醫事檢驗機構非護理人員執業登記場所，爰無法辦理執業登記。

103.2.13 衛部照字第 1031560187 號函

主旨：所詢有關貴機構「特聘護理服務」業務應否支援報備一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴機構 102 年 11 月 25 日獎(特聘)字第 102007 號函。
- 二、依據護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」。次依護理機構分類設置標準第 9 條規定：「居家護理機構之設置，其設立計畫書內容，應載明下列事項：一、服務對象之條件。二、服務區域。三、病人轉介流程。四、服務品質管制制度。五、

經費需求及來源。前項第二款服務區域，跨直轄市或縣(市)行政區域提供服務者，應事先經各該直轄市或縣(市)主管機關核准。」。

- 三、對於居家護理所之服務方式，係以執業登記於該機構之護理人員及提供外展服務為主，機構設置之計畫書亦包含服務區域，如需跨區域需事先支援報備且經核准後始得為之，故居家護理機構之護理人員，若係提供派駐醫院，執行病房之護理工作，仍應依報備規定辦理。本案請依前揭原則認定辦理。

103.3.4 衛部照字第 1031560362 號函

主旨：有關貴協會函詢聘請專職護理人員執行衛生教育及照顧技巧指導相關業務，是否符合執業登記處所一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴協會 103 年 1 月 8 日北市家協(103)字第 002 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」另據同法第 24 條規定：「護理人員之業務包括健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢及醫療輔助行為。」。
- 三、依貴協會所附簡介，貴協會成立宗旨主要為提供家庭照顧者權益及關懷等，服務項目包括居家照顧服務、照顧技巧、到宅指導服務、照顧者諮詢專線、社區長者關懷訪視，非屬前開護理人員業務，爰非屬護理人員執業登記處所。

103.3.7 衛部照字第 1030105256 號函

主旨：所詢有關貴局具有護理師證書且有實際執行護理業務，是否得比照醫事檢驗師准予辦理執業登記案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 2 月 21 日東衛醫字第 1030003393 號函。

- 二、按護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之…」。
- 另依護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。
- 三、復按本部(前衛生署)83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035197 號函示，衛生機關人員，縱具有醫事人員資格，如所從事之工作，非各該專業法規所規定之專業業務，不應辦理執業登記。
- 四、綜上，該護理人員是否辦理執業登記，仍應依前揭規定認定辦理。

103.4.14 衛部照字第 1030110313 號函

主旨：所詢貴局疾病管制科是否為護理人員法第 12 條所列其他經中央主管機關認可之機構之執業登記處所一案，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 3 月 18 日東衛醫字第 103000765 號函。
- 二、旨揭案本部業於 103 年 3 月 7 日衛部照字第 1030105256 回復貴局略以：「按護理人員法第 12 條及第 24 條……規定，復按本部(前衛生署)83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035197 號函示衛生機關人員，縱具有醫事人員資格，如所從事之工作，非各該專業法規所規定之專業業務，不應辦理執業登記。綜上，該護理人員是否辦理執業登記，仍應依前揭規定認定辦理」。
- 三、故若於貴局服務，且其確有從事所函之護理工作事實，仍請貴局依事實據以認定。

103.4.15 衛部照字第 1030007880 號函

主旨：有關貴協會函詢聘請專職護理人員收容照顧愛滋病患者、身心障礙者、各縣市遊民、更生人及植物人等，是否可辦理護理人員執業登記案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴協會 103 年 3 月 31 日關屏字第 1030961001 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」另據同法第 24 條規定：「護理人員之業務包括健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢及醫療輔助行為。」。
- 三、依貴協會來函及服務內容，貴協會成立主要為提供感染者收容照顧、感染者心理諮商輔導、中途收容、志工培訓等，非屬前開護理人員業務，爰非屬護理人員業務執業執照登記之處所。

103.6.23 衛部照字第 1030014120 號函

主旨：有關貴協會函詢聘請專職護理人員服務先天及罕見代謝疾病之病友，是否可辦理護理人員執業登記案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴協會 103 年 6 月 9 日(103)先代字第 0602 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」，同法第 24 條規定：「護理人員之業務包括健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢及醫療輔助行為。」。
- 三、依 貴協會成立之章程中所述任務主要為：
 - (一)協助先天及代謝疾病患者爭取健保尚未給付之醫療、特殊食品及醫療檢驗等費用。
 - (二)促使先天及代謝疾病患者需要的特殊藥品與食品之研發製造。

- (三)幫助患者及家庭接受治療及做生活心理的調適。
- (四)舉辦聯誼會、座談會介紹醫療新知及互相鼓勵。
- (五)支持相關醫學研究。

四、上揭章程任務內容並非屬護理人員法第 24 條所規範須由護理人員執行之業務範疇，故貴協會尚無法認定為該法第 12 條規定之護理人員執業登記機構。

103.9.23 衛部照字第 1030125879 號函

主旨：關於本部疾病管制署補助貴會辦理「愛滋病感染者社區家庭化照護中途之家計畫」，有關執行該計畫之護理人員，函請同意辦理執業登記案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴協會 103 年 8 月 18 日 103 關愛(秘)字第 1030818001 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」，另所稱「其他經中央主管機關認可之機構」，係指依相關法令規定須(得)配置護理人員執業之場所，如學校衛生法規定高級中等以下學校應置護理人員及勞工健康保護規則規定：「事業單位之同一工作場所，勞工人數在三百人以上者，應視該場所之規模及性質，僱用從事勞工健康服務之護理人員，辦理臨廠健康服務。」，且該人員於該場所實際從事護理人員法第 24 條所規定之業務，並經由本部核定後，始得辦理執業登記。
- 三、經查 貴協會成立宗旨，主要為提供愛滋病感染者中途收容生活關懷照護、志工培訓等愛滋病防治相關防治工作，並接受本部疾管署「愛滋病感染者社區家庭化照護中途之家計畫」，雖所聘護理人員從事個案護理照顧工作及防治業務，惟非屬前開規定所核准登記之醫療機構、護理機構或為本部認可之機構，故貴機構如護理人員確有執業登記

需要，仍請依前揭規定辦理。

103.10.2 衛部照字第 1030023963 號函

主旨：有關貴基金會辦理協助早產兒接受適當醫療及照護品質等相關事項，擬請本部同意認可為護理人員執業登記機構案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴基金會 103 年 9 月 23 日(103)早字第 1030906 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。」，另所稱「其他經中央主管機關認可之機構」，係指依相關法令規定須(得)配置護理人員執業之場所，例如依學校衛生法第 7 條規定略以：「高級中等以下學校……應置護理人員……。」以及勞工健康保護規則第 3 條規定略以：「事業單位之同一工作場所，勞工人數在三百人以上者，……，僱用或特約從事勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員，辦理臨廠健康服務。」，且該人員於該場所實際從事護理人員法第 24 條所規定之業務，並經由本部核定後，始得辦理執業登記。
- 三、據 貴基金會函述成立宗旨，主要為協助早產兒接受適當醫療及照護品質、研究及教育及舉辦各類活動等相關事項，所聘護理師係從事提供相關衛教等公共衛生業務，非屬前開規定所核准登記之醫療機構、護理機構或為本部認可之機構，故貴基金會如護理人員確有執業登記需要，仍請依前揭規定辦理。

106.10.13 衛部照字第 1060130867 號

主旨：有關「執業登錄於醫院之護理人員，利用非上班時間，可否至其他醫療機構或民間救護車執行救護出勤任務」疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 10 月 11 日屏衛醫字第 10632818600 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」。
- 三、再按本部(前行政院衛生署)100 年 1 月 7 日衛署醫字第 0990034815 號函，略以：「二、…醫療法第 60 條第 1 項規定：『醫院、診所遇有危急病人，應先予適當之急救，並即依其人員及設備能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延』同法第 73 條第 1 項規定：「醫院、診所因限於人員、設備及專長能力，無法確定病人之病因或提供完整治療時，應建議病人轉診。但危急病人應依第六十條第一項規定，先予適當之急救，始可轉診。』三、前揭所稱危急病人，係指依醫療專業判斷，病人之病情緊急，需立即施以醫療救治或措施，否則將危及生命安全或導致生理功能受損者。爰『急救』，應係醫師就病人之病情，依前開規定妥予緊急處置之過程。」。
- 四、承上，貴局函詢「護理人員利用非上班時間隨非執登醫院之救護車出勤，是否屬護理人員法第 12 條規範之急救，無需報備支援」乙節，查救護車所乘載之個案並非全屬上開所稱危急病人，須立即施以醫療救治或措施，否則將危及生命安全或導致生理功能受損者，且護理人員利用個人非上班時間隨非執登醫院之救護車出勤，應屬自願且預先安排之行為，與護理人員法第 12 條規範之急救意涵不符，建請貴局仍須依個案事實認定。

第 13 條 **護理人員執業，其登記執業之處所，以一處為限。**

83.6.17. 衛署醫字第 83035196 號函

主旨：擔任特聘（別）護士或部分工時之護理人員，其辦理執業

登記之處所，規定如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。
- 二、無固定執業處所擔任特聘（別）護士之護理人員，其執業處所，暫以所在地護理師護士公會或其服務居家護理機構，辦理執業登記。
- 三、在二處以上處所擔任部分工時之護理員，應擇一處所登記，其他處所，視同護理人員法第 12 條但書所定之「支援」辦理。

（註：本函釋說明二所規定事項，業經 96.10.5. 衛署醫字第 0960211487 號函停止適用，請參閱 P.93）

92.6.24. 衛署醫字第 0920030877 號函

主旨：有關 貴局函詢護理人員擔任民間救護車機構管理人，可否於其他醫療院所執業乙案，查依護理人員法第 13 條規定：護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。惟為增加民間救護車機構管理及用人彈性，民間救護車機構管理辦法第 5 條規定，護理人員亦可擔任民間救護車機構之管理人，對其機構之業務，負督導責任，原則上可以兼任方式為之，請 查照。

說明：復 貴局 92 年 6 月 6 日衛醫字第 0920006359 號函。

93.1.14. 衛署醫字第 0930000311 號書函

主旨：所詢護理人員陳○○涉及兩地執業之違反護理人員法罰責認定疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 1 月 2 日北市衛五字第 09238488100 號函。
- 二、按護理人員法第 13 條規定，護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。又依同法第 12 條但書規定，急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。本案護理人

員執業登錄一處，未經事先報准之下，長期在另一處兼職，有關兩地執業，若涉及租照行為，應以違反護理人員法第 35 條之業務不正當行為論處；如係屬未經事先報准，即至另一護理機構執行業務，核屬違反同法第 12 條之規定。

（註：本函釋當事人之名字以○○表示）

93. 10. 20. 衛署醫字第 0930042915 號書函

主旨：所詢護理人員未依規定辦理執業登錄，又至其他診所支援等疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 10 月 11 日北市衛五字第 09337559400 號函。
- 二、查依本署 88 年 7 月 29 日衛署醫字第 88045247 號函規定略以：「按醫療機構之業務違反醫療法之相關規定，其處罰以發照地之衛生主管機關為權責單位；至其醫事人員之行為違反醫事人員管理法規相關規定，其處罰以行為地之衛生主管機關為權責單位。故本案如僅罰鍰處分應由行為地執行，若涉及停業或撤銷執業執照則由發照地執行。」爰此，本案護理人員未辦理執業登錄即執行護理業務，核屬違反護理人員法第 8 條規定；另其未經核備報准即至其他醫療機構執行護理業務，應依違反護理人員法第 12 條規定論處。
- 三、又護理人員在多處執業而未辦理執業登錄，應如何判定乙節，查護理人員法第 13 條規定，護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。爰此，在二處以上處所擔任部分工時之護理人員，應擇一處所登記，其他處所，視同護理人員法第 12 條但書所定之「支援」辦理。

94. 4. 8. 衛署醫字第 0940011902 號函

主旨：所詢醫療機構附設居家護理所負責護理人員得否兼任疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 3 月 23 日健保醫字第 0940059252 號函。
- 二、按護理人員法第 13 條規定，護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。至護理之家同時辦理居家護理或產後護理服務部門，或醫療機構所設之護理之家、居家護理或產後護理服務部門，其負責護理人員得以同一人登記，前經本署 83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035205 號函釋在案。至其負責護理人員之執業場所應登記於護理之家，其他人員則依實際執業場所分別核給執業執照。爰此，本案所述台北市立聯合醫院附設之居家護理所，其負責護理人員之執業場所應登記於護理機構。

94.6.15. 衛署醫字第 0940023958 號函

主旨：所詢醫院附設之護理機構與該院位於同一行政區域，該醫院之護理主任（執業登記於醫院）是否得兼任該附設護理機構之負責護理人員一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 6 日衛醫字第 0940004730 號函。
- 二、依護理人員法第 13 條規定，護理人員執業，其登記執業之處所以一處為限。惟為利醫療機構及護理機構管理，本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函示：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照」。基於前開所述管理規則及護理人員法之相關規定，本署 85 年 2 月 7 日衛署醫字第 84068211 號函，有關醫院附設之護理機構與該醫院位於同一行政區域者，該醫院之護理主任得兼任該附設護理機構之負責護理人員一節，亦應停止適用。

（註：本函釋說明二所敘本署 90.5.10. 衛署醫字第 0900031774 號函，請參閱 P.162）

第三章 護理機構之設置及管理

第 14 條 為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。

104.2.16 衛部照字第 1041560304 號函

主旨：所詢關於退休公務員至護理機構任職，是否違反公務員服務法第 14 條之 1 規定疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴部 104 年 1 月 27 日法一字第 1043934188 號函。
- 二、查護理人員法第 14 條及第 15 條規定護理機構之設立及其服務對象；又護理人員法第 24 條規定護理之家可提供之服務內容。爰經衛生主管機關核准設立之護理機構，其所提供之護理服務，以辦理執業登記之照護服務項目為限，非屬 貴部來文所述公司法第 1 條、商業登記法第 3 條及所得稅法第 11 條第 2 項規定所稱「營利事業」。

104.3.12 衛部照字第 1041560167 號函

主旨：所詢業者欲申請設置一般護理之家提供日間照護服務相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 1 月 19 日衛醫字第 1030026717 號函。
- 二、按護理機構分類設置標準第八條附表「護理機構設置標準」之一般護理之家規定：二、護理服務設施之住房部分，應設寢室並符合規定、應設護理站並具有相關設備。(五)衛浴設備住房應設衛生設備及淋浴設備，且每六人至少應有一套。應有為臥床或乘坐輪椅病人特殊設計之衛浴設備。又，其中設有為日間照護者，視需要設置休息床位。三、建築物之設計構造與設備之總樓地板面積：設有日間照護者，按登記提供服務量計，平均每人應有十平方公尺以上(不包括車庫及宿舍面積)。
- 三、依上開規定及立法精神，一般護理之家之設置以收住式機構為申請主體，設置日間照護屬該機構之服務項目之一，

並應依相關規定配置人力及空間規劃。另，機構床位數雖無最低限制，仍應視該地區民眾之長照資源需求及機構之營運規劃而定。

四、護理機構設置日間照護之服務，其總樓地板面積應依上開規定獨立計算並有足夠之空間規劃。

五、日間照護之服務可否販賣物品營利乙節，按護理人員法第 14 條規定，一般護理之家之設置，以提供護理照護等相關服務為主，且護理機構設置係依護理機構設置標準規定設立，其服務對象係以機構之住民以及其家屬為原則。爰此，有關營利型態之設置，其活動空間、人員應與機構有所區隔，且營業登記等相關事項應按營利事業管理相關規定辦理。

第 15 條 護理機構之服務對象如左：

- 一、罹患慢性病需長期護理之病人。
- 二、出院後需繼續護理之病人。
- 三、產後需護理之產婦及嬰幼兒。

〔釋例類別〕 第 1 類 護理機構屬性

90.6.12. 衛署醫字第 0900028339 號函

主旨：所詢乙種工業區能否比照老人長期照護機構設立護理之家乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 5 月 3 日 90 南市衛醫字第 08667 號函。
- 二、按「都市計畫法台灣省施行細則」第 18 條規定，乙種工業區可設置工廠必要附屬設施、與工業發展有關之設施、公共服務設施及公用事業設施，其中公共服務設施及公用事業設施包含醫療保健設施及社會福利設施等。
- 三、依護理人員法第 15 條規定，護理之家機構，係以罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人為服務

對象，經衛生主管機關核准設立之上開機構，應可認屬廣義之「醫療保健設施」。次查老人福利法第 9 條第 1 項第 1 款規定，長期照護機構係以照顧罹患長期慢性疾病並且需要醫護服務之老人為目的，經社政主管機關核准設立之機構。同法第 2 項、第 3 項並規定，長期照護機構如涉及醫事服務者，其設立標準應會同中央主管機關定之，又其醫療或護理服務，應依醫療法、護理人員法或其他醫事專門職業法等規定辦理。故護理之家機構與長期照護機構之服務對象及所具功能相當類似。

104.9.14 衛部照字第 1041561758 號

主旨：有關貴局函詢有關「興辦醫療保健事業申請免受山坡地開發建築面積不得少於十公頃限制案審議規範」疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 8 月 19 日中市衛醫字第 1040077906 號函。
- 二、有關貴局函詢「興辦醫療保健事業申請免受山坡地開發建築面積不得少於十公頃限制案審議規範」第 4 條第 1 項第 3 點：「所在地不符前二款之規定，但因人口密集，確無適當地點可供設置，且為醫療資源缺乏地區者」，有關其規範之「醫療資源缺乏地區者」是否含本部 103 年度公開甄選「獎勵偏遠（含山地離島）及長照資源不足地區設置在地且社區化長期照護服務據點計畫」之長照資源不足偏遠鄉鎮乙案，查前述計畫長照資源不足之偏遠鄉鎮提供長照服務係指居家或社區長照服務，前揭審議規範之醫療資源缺乏地區，若所設長照機構提供長照服務類別係為居家式或社區式服務，尚無不可。

105.3.18 衛部照字第 1050107119 號

主旨：有關護理機構是否屬都市計畫法臺灣省施行細則第 29 條之 1 所稱公用事業設施疑義案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據內政部營建署 105 年 3 月 12 日營授辦城字第 1050012768 號函辦理(如附件)，兼復貴局 105 年 2 月 24 日桃衛照字第 1050010684 號函。
- 二、按都市計畫法第 2 條規定；「都市計畫依本法之規定；本法未規定者，適用其他法律之規定。」合先敘明。
- 三、都市計畫法臺灣省施行細則第 29 條之 1 所稱公用事業設施，按民營公用事業監督條例第 2 條規定略以：「左列各款之公用事業，……一、電燈、電力、及其他電氣事業。二、電車。三、市內電話。四、自來水。五、煤氣。六、公共汽車及長途汽車。七、船舶運輸。八、航空運輸。九、其他依法得由民營之公用事業」爰此，護理機構係屬依據護理人員法規定設置及管理，非屬上開規定所稱公用事業之範疇。

105.5.23 衛部照字第 1050114425 號

主旨：所詢護理之家得否視為非都市土地使用管制規則之丁種建築用地許可使用細目之「社區衛生及福利設施」疑義1案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據內政部105年5月17日內授中辦地字第1050417641號函辦理，兼復貴局105年5月5日彰衛長字第1050015391號函。
- 二、按丁種建築用地依非都市土地使用管制規則第6條附表一及其備註二規定，容許作工業社區使用，其許可使用細目計有社區住宅、社區教育設施、社區衛生及福利設施等15目（各細目之附帶條件均限於已開發工業區且規劃有案者），並免依該規則規定申請許可使用；但目的事業主管機關另有規定或得逕依建築法申請建造執照、雜項執照者，應依其規定辦理。故本案應請貴縣府查明該工業區之主管機關(單位)，並請其釐清是否有規劃設置一般護理之家。

105.10.6 衛部照字第 1051564108 號

主旨：所詢有關「護理之家」是否得為「其他醫療保健服務業」或為中華民國行業標準分類所稱分類編號「Q870 居住型照顧服務業」，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 9 月 20 日彰衛長字第 1050033641 號函。
- 二、旨案有關「護理之家」之認屬，按護理人員法及其相關規定，基於護理機構之服務對象及服務內容範疇，已涉及醫療及護理業務，是以，經衛生主管機關核准設立之護理之家，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」，並前經本部於 98 年 3 月 23 日衛署醫字第 0980005980 號函及 103 年 1 月 2 日衛部照字第 1021581375 號函釋在案，併予敘明。

95.11.21. 衛署醫字第 0950050783 號函

主旨：所詢產後護理之家，可否歸類為社會福利機構一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴府 95 年 11 月 14 日府衛醫字第 0950020688 號函。
- 二、查「都市計畫法臺灣省施行細則」第 18 條第 2 項第 3 款第 9 目「醫療保健設施」係指：(1)醫療院所(但不包括傳染病醫院及精神病醫院)。(2)衛生所(站)；第 10 目「社會福利設施」係指：(1)托兒所。(2)老人長期照護機構、安養機構或養護機構。(3)身心障礙福利機構。先予敘明。
- 三、按護理機構設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰幼兒。另查產後護理機構提供之服務內容，除因應我國婦女產後調養習俗，產後婦女生活起居及嬰兒之基本照顧，如準備飲食、清洗衣物等外，尚包括提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺餵、衛生教育等護理業務，業已涉及醫療及護理業務。是以，經衛生主管機關核准設立之產後護理機構，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」。

98.3.23. 衛署醫字第 0980005980 號函

主旨：有關護理之家是屬醫療保健服務機構或社會福利機構疑義一案。

說明：

- 一、查「都市計畫法臺灣省施行細則」第 18 條第 2 項第 3 款第 9 目「醫療保健設施」係指：(1)醫療院所（但不包括傳染病醫院及精神病醫院）。(2)衛生所（站）；第 10 目「社會福利設施」係指：(1)托兒所。(2)老人長期照護機構、安養機構或養護機構。(3)身心障礙福利機構。
- 二、按護理人員法第 15 條規定，護理機構之服務對象包含(1)罹患慢性病需長期護理之病人；(2)出院後需繼續護理之病人、(3)產後需護理之產婦及嬰幼兒。又按護理機構分類設置標準第 5 條規定，護理之家機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要，至少每個月由醫師再予診察一次。爰業已涉及醫療及護理業務，是以，經衛生主管機關核准設立之護理之家，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」。至是否可歸屬為社會福利機構，則建請逕向內政部洽詢。

（註：本函釋說明二末段所敘護理之家是否可歸屬「社會福利機構」疑義，請參閱 P.115 所列內政部 96.1.10 台內中營字第 0950807779 號函釋）

103.1.2 衛部照字第 1021581375 號函

主旨：所詢有關財政部中區國稅局民權稽徵所所詢本部臺中醫院附設護理之家提供醫療服務對象膳食服務、育養勞務及醫療勞務是否適用加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 11 月 13 日中市衛醫字第 1020121542 號函。
- 二、依據護理人員法第 14 條規定：「為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能

，得設置護理機構。」同法第 15 條規定：「護理機構之服務對象如左：一、罹患慢性病需長期護理之病人。二、出院後需繼續護理之病人。…」又，護理之家提供之服務內容，依據護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」爰護理機構所提供之服務內容範疇，依法可執行前開業務，提供住民護理照護服務項目，故業已涉及醫療及護理業務。又，上開所稱醫療輔助行為範疇，係屬醫療勞務，惟其提供服務之項目，仍應視契約所訂之內容而定。

三、本部業於 102 年 11 月 29 日邀集財政部、縣市衛生局及相關單位共同研商護理機構提供服務與醫療勞務範圍，決議為：經衛生主管機關核准設立之護理機構，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」，其所提供之護理服務，屬醫療勞務範疇者，若係因日常生活照顧所衍生，則非屬醫療勞務之範疇；本案業於 102 年 12 月 12 日衛部照字第 1021581226 號函諒達。

四、是以，經衛生主管機關核准設立之護理機構，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」，其所提供之護理服務，屬醫療勞務範疇者，若係因日常生活照顧所衍生，則非屬醫療勞務之範疇。

五、至護理之家所提供之勞務內容是否適用加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款之規定，仍應由稅務機關認定之。

103.3.18 衛部照字第 1031560405 號函

主旨：所詢有關貴轄名家護理之家因土地暨建物經法院拍賣，產權已轉移，可否辦理負責人變更，如無法變更擬重新申請籌設許可，是否適用農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點一案，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 3 月 6 日彰衛長字第 1030006204 號函。
- 二、依據護理人員法施行細則第 5 條第 2 項規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其申請人、設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可。」次依護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」前開法規係明訂機構經許可設立後，如欲變更負責人，應由機構提出申請，惟對於其變更負責人之原因（例如因土地所有權轉移是否應辦理負責人變更），非屬本法規範內容，先予敘明。
- 三、又按農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 6 點第 1 項規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」查前開所稱公益性福利設施，應視申請計畫內容進行專案審查後始得認定。

103.4.18 衛部照字第 1030110714 號函

主旨：所詢護理之家機構設置，預定使用都市計畫農業土地時，是否適用都市計畫農業區土地使用審查要項表中之「社會福利事業設施」興建一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 4 月 11 日新縣衛醫字第 1030004911 號函。
- 二、有關護理之家機構設置是否符合社會福利事業設施乙項，查內政部 96 年 1 月 10 日台內中營字第 0950807779 號函示在案(如附件)，本案請參酌前開原則依個案事實認定之。
- 三、長照服務法刻正進行審議，俟法案通過後，相關議題將納入討論。

(註：本函釋說明二末段所敘內政部 96.1.10 台內中營字第 0950807779 號函，其內容如下：

要旨：有關「獨立型護理之家」及「護理之家」是否符合社會福利設施或社會福利事業設施範疇（原內政部 90.07.31 台內營字第 9084722 號函認定「護理之家」屬有關都市計畫法臺灣省施行細則第 18 條第 2 項第 3 款第 10 目所稱「社會福利設施」部分，應自即日起不予適用）。

全文內容：案經本部邀集相關單位召開會議研商，獲致結論略以：依據護理人員法施行細則第 6 條規定護理機構分為：居家護理機構、護理之家機構及產後護理機構，準此，護理之家機構，係屬經衛生主管機關依護理人員法相關規定，核准設立之護理機構。故本案「護理之家」及「獨立型護理之家」非屬兒童福利法、老人福利法、殘障福利法或社會救助法等規定所稱之社會福利事業設施。是以，本部 90 年 7 月 31 日台內營字第 9084722 號函認定「護理之家」屬有關都市計畫法臺灣省施行細則第 18 條第 2 項第 3 款第 10 目所稱「社會福利設施」部分，應自即日起停止適用。）

103.10.14 衛部照字第 1031561690 號函

主旨：所詢有關一般護理之家相關疑義案，如說明段，請查照。
說明：

- 一、依據內政部營建署 103 年 9 月 12 日營授辦城字第 1033580690 號函及行政院農業委員會 103 年 9 月 9 日農企字第 1030230729 號函兼復貴中心 103 年 8 月 22 日苗照管字第 1030007304 號函。
- 二、有關護理之家是否符合都市計畫法臺灣省施行細則所稱『公益上需要』乙節：依據都市計畫法臺灣省施行細則第 23 條規定：「行政區以供政府機關、自治團體、人民團體及其他公益上需要之建築物使用為主，不得建築住宅、商店、旅社、工廠及其他娛樂用建築物。但紀念性之建築物與附屬於建築物之車庫及非營業性之招待所，不在此限。」

次依內政部營建署說明，前項所稱『公益上需要』之建築物使用，係指出於公共利益的目的，為使社會公眾或者一定範圍內的社會公眾受益所需之建築物使用而言，且應依都市計畫法第 37 條規定，洽都市計畫擬定機關審查土地使用分區管制查明其規定目地之使用。爰一般護理之家是否符合前開規定，應視機構申請計畫個案事實認定之。

三、又，護理之家是否符合農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點『公益性福利設施』乙節：農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 6 點規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」按行政院農委會說明，前項所稱『公益性福利設施』，需具『公益性福利設施』性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應先確認以何種設施合法化，再由縣市政府業務主管機關，依前開要點第 4 點規定，就該事業設置之必要性與計畫所提使用特定農業區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性提出目的事業主管機關之評估意見，如認為本案有專案核准之必要性，再為本案向中央目的事業主管機關提出專案核准之申請。爰一般護理之家是否符合前開規定，應按機構興辦事業計畫之性質及使用內涵，視個案事實認定。

四、有關醫院附設一般護理之家，設置於醫院同址且分散不同樓層之通道(出入口及電梯)是否應獨立乙節，本部前於 95 年 12 月 15 日衛署醫字第 0950062433 號書函及 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函示在案，併予敘明，內容略以：如於同棟大樓不同樓層設置護理之家，護理機構與醫療機構之執業場所使用空間應有明確區隔，並各有獨立動線(包含出入口及電梯)，且符合護理機構設置標準之相關規定，得予准許。本案請依此原則辦理。

104.1.6 衛部照字第 1031562634 號函

主旨：有關提送貴轄陳君申請興建隆安護理之家是否符合專案核准設立之公益性福利設施一案，如說明段，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 11 月 27 日彰衛長字第 1030037319 號函。
- 二、依據農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 4 點規定：「目的事業主管機關對於興辦事業人申請農業用地變更，應就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見，或具體表示是否支持該興辦事業及土地使用。」同要點第 6 點規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」。
- 三、前項所稱『公益性福利設施』，需具『公益性福利設施』性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應依前開要點第 4 點規定，應由目的事業主管(中央及縣市衛生主管單位)對於本申請農業用地變更案提出評估意見，爰請貴局就旨案興辦事業計畫之事業設置必要性與計畫所提使用特定農業區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性等提出審查意見；又如經評估結果認為本案確實有專案核准之必要，併附評估意見再向本部提出專案核准之申請。
- 四、檢還陳君申請興建隆安護理之家之新建計畫書 1 本。

104.1.16 衛部照字第 1041560039 號函

主旨：有關提送貴轄邱君申請興建庭安護理之家計畫書一案，如說明段，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 12 月 31 日彰衛長字第 1030042161 號函。

二、依據農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 4 點規定：「目的事業主管機關對於興辦事業人申請農業用地變更，應就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見，或具體表示是否支持該興辦事業及土地使用。」同要點第 6 點規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」。

三、前項所稱『公益性福利設施』，需具『公益性福利設施』性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應依前開要點第 4 點規定，應由目的事業主管(中央及縣市衛生主管單位)對於本申請農業用地變更案提出評估意見，爰請貴局就旨案興辦事業計畫之事業設置必要性與計畫所提使用特定農業區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性等提出審查意見；又如經評估結果認為本案確實有專案核准之必要，併附評估意見再向本部提出專案核准之申請。

四、檢還邱君申請興建庭安護理之家設立計畫書 10 本。

104.1.26 衛部照字第 1031560192 號函

主旨：所詢有關護理之家是否符合公益性福利設施疑義案，如說明段，復請查照。

說明：

一、復 貴局 104 年 1 月 20 日彰衛長字第 1040001487 號函。

二、有關護理之家是否符合「公益性福利設施」，查農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 4 點規定：「目的事業主管機關對於興辦事業人申請農業用地變更，應就事業設置之必要性與計畫使用農業用地所提區位、面積之必要性、合理性及無可替代性，提出評估意見，或具體

表示是否支持該興辦事業及土地使用。」同要點第 6 點規定略以：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」。

- 三、前項所稱「公益性福利設施」，需具「公益性福利設施」性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應先確認以何種設施合法化，再由目的事業主管(中央及縣市衛生主管單位)依前開要點第 4 點規定，就該事業設置之必要性與計畫所提使用特定農業區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性提出目地事業主管機關之評估意見，如認為本案有專案核准之必要，再向中央目的事業主管機關提出專案核准之申請。爰護理之家是否符合前開規定，應按機構興辦事業計畫之性質及使用內涵，視個案事實認定。

104.5.29 衛部照字第 1041560989 號函

主旨：有關貴處函請建議研修「一般護理之家定型化契約範本暨其應記載及不得記載事項」案，本部辦理情形如說明，請查照。

說明：

- 一、依據 貴處 104 年 5 月 8 日院臺消保字第 1040132809 號函辦理。
- 二、旨案定型契約範本暨其應記載及不得記載事項之研修，鑑於長期照顧服務法將一般護理之家將納為長照機構，該法甫於 104 年 5 月 15 日經立法院三讀通過，本部後續將著手研訂相關子法；又，查該法第 42 條規定「長照機構於提供長照服務時，應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂書面契約。前項契約書之格式、內容，中央主管機關應訂定定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項」本部刻正展開相關研擬作業，並同時將旨揭研修案納入檢

討及修訂。

〔釋例類別〕 第 2 類 護理機構服務對象

88.9.9.衛署醫字第 88056482 號函

主旨：承詢老人養護機構可否收容照顧插管老人乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴部 87 年 12 月 11 日台(87)內社字第 8778898 號函。
- 二、對老人執行插管照護，應屬技術性護理服務，得由護理人員依醫師指示或醫囑為之。至於老人養護機構可否收容照顧插管老人乙案，仍請依老人福利法規定辦理。

90.3.26.衛署醫字第 0900015344 號函

主旨：所詢護理人員法第 15 條護理機構之服務對象第 1 款「罹患慢性病需長期護理之病人」，是否得包括慢性精神病患乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 3 月 7 日彰衛醫字第 90005344 號函。
- 二、依護理人員法施行細則第 6 條規定，護理機構有三類，分為護理之家機構、居家護理機構、產後護理機構，其中護理之家機構以罹患慢性病需長期照護之病人為服務對象，由於該類機構之設置標準，不論人力配置或相關設施，均以身體罹患器質性疾病者為主要考量對象，故尚不宜收治慢性精神病患。
- 三、至於慢性精神病患長期照顧需要，本署業已另案檢討。

(註：1.92 年 10 月 27 日修正發布護理機構設置標準第 8 條附表，將護理之家機構分為一般護理之家及精神護理之家。

2.相關函釋：本署 100.3.24 衛署醫字第 1000064197 號函，請參閱 P.124)

93.3.11. 衛署醫字第 0930008749 號函

主旨：所詢護理之家是否得收容精神障礙者乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 2 月 27 日嘉衛保字第 0930003003 號函。
- 二、查本署業於 92 年 10 月 27 日衛署醫字第 0920216079 號令修正發布護理機構設置標準第 8 條附表，將護理之家機構分為一般護理之家及精神護理之家。
- 三、按精神護理之家服務對象，係以精神病症狀穩定且呈現慢性化、需生活照顧之精神病患；一般護理之家係以罹患慢性病需長期照護之病人為服務對象，由於該類機構之設置標準，不論人力配置或相關設施，均以身體罹患器質性疾病者為考量對象，慢性精神病患應不屬一般護理之家收案對象。

94.11.16. 衛署醫字第 0940052998 號函

主旨：為精神疾病併慢性病行動不便需長期照護之個案應由精神護理之家或一般護理之家機構收容安置乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 9 月 15 日投衛醫字第 0940300921 號函。
- 二、查「護理機構設置標準」規定，精神護理之家服務對象為：「精神病症狀穩定且呈現慢性化，需生活照顧之精神病患，且應符合本標準第 5 條之規定。」；一般護理之家服務對象依護理人員法第 15 條第 1 項第 1 款規定為：「罹患慢性病需長期照顧之病人」。
- 三、前項精神護理之家收治之對象，若以本署與社政單位共同商定之「精神病患照顧體系權責劃分」表劃定，係指第 5 類（精神病症狀穩定且呈現慢性化，不需住院治療但需生活照顧者）、第 6 類（精神病症狀穩定且呈現慢性化，不需住院治療之年邁者、痴呆者、智障者、無家可歸者）精

神病人。

- 四、該精神病症狀穩定且呈現慢性化之第 5、6 類病人，隨年齡老化、退化，亦可能與一般人一樣，因病情而導致肢體失能或行動不便。是以，一般護理之家及精神護理之家均得予以收治。至於此類病人收容於精神護理之家或一般護理之家較易獲得妥善照護，宜考量病人病情依個案事實認定。

95.11.10. 衛署醫字第 0952802020 號函

主旨：所詢護理之家、慢性病房及呼吸照護病房是否屬於老人福利機構設立標準之長期照護機構？及上開機構之服務人員如何認定與計算一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 95 年 10 月 23 日勞職外字第 0950042179 號函。
- 二、按護理之家機構，係以罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人為服務對象，依護理人員法及護理機構設置標準之相關規定，經衛生主管機關核准設立之機構；至慢性病房及呼吸照護病房，係對已經疾病急性期之治療後惟仍需相當程度之特殊醫療照護為主之病患，依醫療法及醫療機構設置標準之相關規定，經衛生主管機關核准設立之機構，先予敘明。
- 三、另查老人福利法第 9 條第 1 項第 1 款規定，長期照護機構係以照顧罹患長期慢性疾病並且需要醫護服務之老人為目的，經社政主管機關核准設立之機構。同條第 2 項、第 3 項並規定，長期照護機構如涉及醫事服務者，其設立標準應會同中央衛生主管機關定之，又其醫療或護理服務，應依醫療法、護理人員法或其他醫事專門職業法等規定辦理。故護理之家機構與長期照護機構之服務對象及所具功能相當類似。
- 四、檢送護理機構設置標準及醫療機構設置標準各一份，請參酌。

96.12.4. 衛署醫字第 0960051867 號函

主旨：所詢護理機構之服務對象為失智者，其設置標準是否適用護理人員法第 16 條第 2 項之規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 11 月 7 日衛局醫字第 09600357350 號函。
- 二、查護理人員法第 15 條規定：「護理機構之服務對象如左：一、罹患慢性病需長期護理之病人。二、出院後需繼續護理之病人。……」。次查「護理機構設置標準表」規定，護理之家機構包括一般護理之家及精神護理之家。一般護理之家之服務對象，係以身體罹患器質性疾病者為主要考量對象；而精神護理之家之服務對象，為「精神病症狀穩定且呈現慢性化，需生活照顧之精神病患，且應符合本標準第 5 條之規定。」先予敘明。
- 三、另查，前揭精神護理之家收治之對象，若依本署與社政單位共同商定之「精神病患照顧體系權責劃分」表劃定，為第 5 類(精神病症狀穩定且呈現慢性化，不需住院治療但需生活照顧者)、第 6 類(精神病症狀穩定且呈現慢性化，不需住院治療之年邁者、痴呆者、智障者、無家可歸者)精神病人。前經本署 94 年 11 月 16 日衛署醫字第 0940052998 號函釋在案。惟查，失智症病人的心智衰退是漸進式的，最嚴重者甚至達到自我照顧能力完全喪失，需完全依賴他人照顧之程度，其照護人力需求或相關設施，不同於一般精神病人。
- 四、復查「護理機構設置標準表」規定，一般護理之家之設置標準，不論人力配置或相關設施，均以身體罹患器質性疾病者為主要考量對象，該機構之護理人員、社工人員及照顧服務員人數等均優於精神護理之家，較符合失智症照顧需求；又失智症之疾病特性及所需之生理照顧需求，入住一般護理機構亦可獲得更為妥適之照護。至關於該護理之家機構建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定；至其建築物之空間規劃，則應符合建築法及

消防法等有關規定。

100. 3. 24. 衛署醫字第 1000064197 號函

主旨：有關一般護理之家是否可以收治精神病人疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 3 月 11 日苗衛醫字第 1000300397 號函。
- 二、按護理人員法第 15 條業明訂護理機構之服務對象，係包括罹患慢性病需長期護理之病人或出院後需繼續護理之病人…等。至護理機構分類設置標準，主要係供規劃設置或擴充護理機構時參考依循之標準，及衛生主管機關受理護理機構申請設置開業時據以審核之規定。
- 三、是以，精神病人如其精神疾病之症狀穩定且呈現慢性化者，在符合護理人員法第 15 條規定下，由一般護理之家收治，尚無明文規定不可。

101. 11. 27. 衛署照字第 1012864517 號函

主旨：有關貴局所詢護理之家設置標準呼吸器依賴個案病床疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 11 月 16 日衛醫字第 1010019739 號函。
- 二、本案所指之呼吸器依賴個案，係指護理人員法第 15 條所定護理機構之服務對象，且需裝置呼吸器以維生，無法脫離使用者。鑑於一般護理之家收住該等住民，需要更專業之照護及適當人力、設施及設備，故非以費用來源或使用呼吸器之天數為依據。
- 三、爰此，所詢一般護理之家收住呼吸器依賴個案病床界定之疑義乙節，護理之家收住個案若有呼吸器依賴者，均應依本署 100 年 12 月 2 日發布修正之護理機構分類設置標準第 8 條附表（護理機構設置標準表），一般護理之家收住呼吸器依賴個案達四床以上者之病房設置標準，其病房應為

獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床等規定辦理。

102. 2. 27. 衛署照字第 1022860040 號函

主旨：所詢有關臺南市賴市長建議放寬養護型機構得收容腸造口病患，是否可參照或依據鼻胃管、導尿管等護理服務需求老人之規定，讓養護型機構得收容腸造口、胃造口、膀胱造口等對象乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 102 年 1 月 2 日內授中社字第 1015072308 號函。
- 二、依據護理人員法容留具腸造口、胃造口、膀胱造口等之照護對象，其相關護理業務係屬護理專業工作範圍。
- 三、護理人員之執業場所包括各類醫療機構、護理機構、安養護機構及其他醫事機構（如捐血中心）、學校…等場所。
- 四、前述住民其護理需求較一般養護機構住民為高，而養護機構設置標準對護理人員之要求低於老福法之「長期照顧機構」及護理人員法之「一般護理之家」，故養護型機構如收住需前述專業護理服務之對象，應確保個案所需之照護品質，至於養護型機構是否得收容腸造口、胃造口、膀胱造口等對象，仍須依護理人員法、老人福利法等法規之規範，惠請貴部考量前述照護品質，本於權責予以審酌。

103. 7. 28 衛部照字第 1031500136 號函

主旨：所詢護理之家是否有護理人員應固定時間巡房之規定一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴署 103 年 7 月 17 日北檢治崑 103 相 247 字第 48475 號函。
- 二、查護理人員法係規範護理人員執業條件、業務範疇及護理機構設置管理規定，依護理人員法第 15 條規定，護理機構之服務對象包含罹患慢性病需長期護理之病人及出院

後需繼續護理之病人等。同法第 24 條規定護理人員業務，包含健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢、醫療輔助行為，前項醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

三、承上，有關護理之家之護理人員是否應固定時間巡房，除護理人員執行業務應善盡必要之注意義務之外，並應視住民病況及照護需求認定，其事涉照護品質，非屬護理人員法之規定範疇。

四、檢附護理人員法全文 1 份。

〔釋例類別〕 第 3 類 產後護理機構與坐月子中心之區別

88.5.25. 衛署醫字第 88023071 號函

主旨：所詢醫院附設所謂「坐月子中心」照顧產後婦女，是否有違相關法規乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 88 年 4 月 20 日北市衛五字第 8821835200 號函。

二、醫院附設「坐月子中心」，如不影響醫院應有總樓地板面積之使用，尚無不可，惟應符合坐月子中心定型化契約範本之要求。

（註：本函釋嗣經 89.10.5. 衛署醫字第 0890020710 號函釋，請衛生局積極輔導轄區內之坐月子中心轉型為產後護理機構，請參閱 P.128）

88.5.29. 衛署醫字第 85025644 號函

主旨：有關台灣省政府建設廳函為確定「坐月子中心」、「安親班」之目的事業主管機關及其審核標準一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴部 85 年 4 月 15 日台(85)內營字第 8502632 號函。

二、查護理人員法施行細則第 6 條規定，護理機構種類分為居

家護理機構、護理之家機構及產後護理機構，其主管機關在中央為行政院衛生署；在省(市)為省(市)政府衛生處(局)；在縣(市)為縣(市)政府。

- 三、依護理機構設置標準第 4 條規定，產後護理機構係以產後未滿 2 個月需護理之產婦及出生未滿 2 個月需護理之嬰幼兒為服務對象。該標準對於產後護理機構之人員、護理服務設施、建築物之設計、構造與設備等均有明文規定。
- 四、按「坐月子中心」係因應我國婦女產後調養習俗及家庭型態由大家庭轉型為核心家庭致產婦產後乏人照料而衍生之事業，其若僅係針對產婦之生活起居及嬰兒之基本照顧，而未涉及產婦產後醫療或護理者，應不受護理人員法及其相關規定之規範，其目的事業主管機關應非衛生主管機關。惟基於產婦產後應有獲得良好照護之權益，本署刻正研議輔導坐月子中心依法設立為產後護理機構之可行性。
- 五、所稱「安親班」如係以提供兒童之生活照顧為主要業務，應非屬醫療衛生機構，衛生主管機關亦非其主管機關。
- 六、副本抄送台灣省政府衛生處，復貴處 85 年 5 月 15 日 85 衛五字第 850039168 號函。

89. 7. 19. 衛署醫字第 89040214 號函

主旨：有關坐月子中心之管理問題，本署處理情形如說明段，請查照，並分送各委員參考。

說明：

- 一、依據立法院第 4 屆第 3 會期衛生環境及社會福利、司法二委員會第 4 次聯席會議議事錄辦理。
- 二、本案經本署於 89 年 6 月 29 日邀集行政院消費者保護委員會、內政部營建署、內政部消防署及各縣市衛生局開會研商，決議如下：
 - (1)坐月子中心之服務對象與護理人員法所規定之產後護理機構服務對象相同，應依該法之規定辦理。
 - (2)檢討修正「護理機構設置標準」，將病房、病室及衛

浴設備之門寬規定修正刪除；所定病房走道淨寬至少 1.4 公尺部分，修正為 1.2 公尺。

- (3)請各縣、市衛生局依護理人員法規定，積極輔導轄區內之坐月子中心轉型為產後護理機構，並於 89 年 12 月 31 日前，將輔導結果報署備查，若因建管、消防法令問題造成輔導轉型困難之情形，請將其問題點一併報署，再由本署邀集建管、消防及消保會等相關機關協調辦理。

(註：本函釋說明二所敘決議(2)檢討修正護理機構設置標準有關門寬及走道淨寬部分，嗣經檢討結果，未作修正)

89.10.5. 衛署醫字第 0890020710 號函

主旨：坐月子中心之服務對象與護理人員法所規定之產後護理機構服務對象相同，應依該法之規定辦理，請貴局依護理人員法規定，積極輔導轄區內之坐月子中心轉型為產後護理機構，請 查照。

說明：依據 89 年 6 月 29 日「研商坐月子中心納入產後護理機構管理相關事宜」會議決議辦理。

89.11.28. 衛署醫字第 0890026496 號函

主旨：所詢護理人員法規定之產後護理機構業務內容，是否包括產後生活照顧，其護理與生活照顧如何區分乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 11 月 2 日北市衛五字第 8924870300 號函。
- 二、依護理機構設置標準第 3 條規定：產後護理機構之服務對象為產後未滿 2 個月需護理之產婦及出生未滿 2 個月需護理之嬰幼兒，又為因應我國婦女產後調養習俗，產後婦女生活起居之基本照顧，如準備飲食、清洗衣物等，均需仰賴機構協助提供，同時機構尚需提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺餵、衛生教育等。爰此，產後護

理機構提供之服務內容，包括護理業務及產婦、嬰兒之生活照顧。

- 三、所送「台北市產後護理機構輔導管理自治條例草案」第 4 條規定：產後護理機構之服務項目有嬰兒沐浴、產婦膳食、臍帶處理等，與產後護理機構之服務內容並無不同。

89.12.18. 衛署醫字第 0890031804 號函

主旨：所詢坊間針對產後產婦及嬰兒提供到府護理照顧服務及食補調養之機構，是否可以居家護理機構申請立案乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 11 月 20 日北市衛五字第 8925153600 號函。
- 二、依該等機構所提供服務項目，包括新生兒沐浴、臍帶護理、餵乳指導、教導新生兒運動、奶瓶消毒及協助處理新生兒黃疸……，應可依居家護理機構之規定申請設立。

94.12.2. 衛署醫字第 0940062038 號書函

主旨：有關 貴院所詢產後護理機構與私人婦產科醫院附設育嬰室之區別為何等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 94 年 11 月 15 日板院通行篤 94 醫訴 1 字第 39545 號函。
- 二、按護理人員法第 14 條規定：為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。是以，護理人員如符合護理人員法所規定之護理機構負責護理人員應具備之臨床護理工作年資資格者，得依該法之相關規定申請設立護理機構。
- 三、另按護理機構設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿 2 個月需護理之產婦及出生未滿 2 個月需護理之嬰幼兒。又為因應我國婦女產後調養習俗，產後婦女生活起居之基本照顧，如準備飲食、清洗衣物等，均需

仰賴機構協助提供，同時機構尚需提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺餵、衛生教育等。爰此，產後護理機構提供之服務內容，包括護理業務及產婦、嬰兒之生活照顧。

- 四、至所詢私人婦產科醫院附設育嬰室之性質未明，護理機構設置標準亦無此名稱。惟查醫療機構設置標準有嬰兒室之醫療服務設施規範。醫院嬰兒室設施包括嬰兒床、空調設備、嬰兒專用保溫箱、日光照射治療設備、與護理站之緊急聯絡系統及調奶室等；婦產科「診所」嬰兒室設施包括嬰兒床、空調設備、嬰兒保溫設備及調奶設備等。至醫療機構之嬰兒室，係以出生 1 週內之新生兒醫療照護為主。

102.10.2 衛部照字第 1021580472 號函

主旨：有關民宅提供產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰兒生活照顧服務乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 9 月 4 日彰衛長字第 1020028152 號函。
- 二、有關民宅提供產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰兒生活照顧服務，其若僅係針對產婦之生活起居及嬰兒之基本照顧，而未涉及產婦產後醫療或護理者，非護理人員法之適用範圍，但仍應依其原始營業登記之各該管法令規定辦理。
- 三、若前述場所未經核准設立護理機構卻執行護理人員法之業務內容，則應依護理人員法規定予以裁處。
- 四、本部業於 101 年 7 月 30 日衛署照字第 1012863253 號函暨 102 年 5 月 7 日衛署照字第 1022863121 號函請貴局輔導轄內坐月子中心依護理人員法第 16 條規定轉型為產後護理機構。另本部於 99 年 9 月公告產後護理機構及坐月子中心定型化契約範本及應記載事項，該等實際提供相關服務者仍須依前述公告簽訂契約。

102.12.16 衛部照字第 1021581366 號函

主旨：所詢關於民宅提供產後未滿二個月之產婦食宿但未提供未滿二個月之嬰兒生活照顧服務，是否視為民間俗稱之坐月子中心案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 10 月 22 日彰衛長字第 1020034203 號函。
- 二、依據本部 99 年 9 月公告產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載及不得記載事項，其對象係以「產婦及嬰兒」為主體。另定型化契約範本第四條，坐月子中心僅得提供產婦或嬰兒之居住場所、膳食、哺乳、衣物及洗滌等。查坊間所稱「坐月子中心」係依其原始營業登記之各該管法令規定辦理，非依護理人員法許可設置，爰旨揭疑義應依事實，以上開原則本權責進行認定。
- 三、本部前於 101 年 7 月 30 日衛署照字第 1012863253 號函暨 102 年 5 月 7 日衛署照字第 1022863121 號函請貴局輔導轄內坐月子中心依護理人員法第 16 條規定轉型為產後護理機構在案。另該等實際提供相關服務者仍須依前述公告簽訂契約。

103.11.12 衛部照字第 1030027790 號函

主旨：所詢設立坐月子中心相關疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴會 103 年 10 月 31 日三采麗園字第 103103102 號函。
- 二、坊間所稱之「坐月子中心」，非法定名稱且非屬護理機構，其設立非本部依護理人員法核准，係由各地方主管機關（商業科）辦理營業登記，且其使用之名稱非限定為「坐月子中心」，但不得為「護理機構」名稱，且不得提供護理人員法規定之護理人員業務與服務，僅能提供產婦及嬰兒之生活照顧，故本部於「產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載及不得記載事項」明訂坐月子中心之建築物

及其設備應符合建築法規及消防法規有關公共安全之相關規定；惟坐月子中心之建築物使用類組或消防安全場所用途分類之規定，仍應依營建及消防各該法令進行認定。

三、另依護理人員法所設立之產後護理機構，其設置規範應符合「護理機構分類設置標準」及「護理機構設置或擴充許可辦法」之規定始得設置，其提供之服務內容，除產後婦女及嬰兒之基本照顧外，尚提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺育、衛生教育等業務，其涉及醫療及護理業務，故「坐月子中心」與「產後護理機構」，兩者核准設立及提供之服務內容不同。

四、至所詢未經區分所有權人會議決議同意，逕行將社區法定空地規劃入其營業範圍乙節，係屬司法權範疇，如有爭議，應循司法途徑解決，併為敘明。

106.12.15 衛部照字第 1060137204 號

主旨：有關貴市政府婦女權益促進委員會第 4 屆第 2 次會議，針對坐月子中心訂定地方自治條例之可行性案提供意見案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 106 年 12 月 6 日南市衛醫字第 1060196548A 號函。

二、坊間所稱「坐月子中心」非屬衛生主管機關核准設立，且非法定名稱，故不得提供護理人員法規定之護理人員業務與服務，其所提供之服務項目係向地方主管機關(商業科)辦理營利事業登記坐月子中心，目前並無相關法規規範其收費標準，惟考量婦嬰照護品質及安全，本部自 102 年起責請地方政府衛生局對轄區月子中心進行清查及輔導轄內坐月子中心轉型為產後護理機構為首要目標。

三、旨揭坐月子中心訂定地方自治條例之可行性案，本部尊重貴市政府婦女權益促進委員會意見，另建議可參照「臺北市政府管理到府坐月子服務機構作業要點」，訂定相關管

理機制。

〔釋例類別〕 第 4 類 是否屬醫療勞務，免徵營業稅

96.1.5. 衛署醫字第 0960222704 號函

主旨：有關產後護理機構提供之產後護理服務（包括向產婦或嬰兒家長所收取之膳食費或服務報酬），應屬「醫務勞務」範疇，請 查照。

說明：

- 一、依據立法委員李慶安國會辦公室 95 年 12 月 21 日安華字第 95122101 號函辦理。
- 二、查護理人員法第 14 條規定：「為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。」次查護理機構設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿 2 個月之產婦及出生未滿 2 個月之嬰幼兒；另查產後護理機構提供之服務內容，除因應我國婦女產後調養習俗，產後婦女生活起居及嬰兒之基本照顧，如準備飲食、清洗衣物等外，尚包括提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺餵、衛生教育等護理業務，業已涉及醫療及護理業務。是以，經衛生主管機關核准設立之產後護理機構，應可認屬為廣義之「醫療保健設施」，產後護理機構提供之服務，應屬「醫療勞務」範疇。
- 三、至於坊間「坐月子中心」係因應我國婦女產後調養習俗，及家庭型態改變致產婦產後乏人照料而衍生之服務事業，提供產婦膳食或住宿服務，並未涉及產婦產後醫療或護理服務。是以，「產後護理機構」與一般僅從事產婦膳食或住宿服務之「坐月子中心」功能不同，併予敘明。

96.4.18. 衛署照字第 0960057430 號函

主旨：函轉財政部令依「護理機構設置標準」設置之產後護理機

構，其所提供之產後護理服務，准依加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款規定免徵營業稅，並依同法第 29 條規定免辦營業登記，請 查照。

說明：

一、依據 96 年 4 月 13 日台財稅字第 09604523030 號令辦理。

二、請積極輔導轄區內尚未立案之「坐月子中心」依「護理機構設置標準」申請設置產後護理機構。

(註：本函釋說明一所敘財政部 96.4.13. 台財稅字第 09604523030 號令，其內容如下：

一、依「護理機構設置標準」設置之產後護理機構，其所提供之產後護理服務，准依加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款規定免徵營業稅，並依同法第 29 條規定免辦營業登記。

二、本部 94 年 5 月 6 日台財稅字第 09404530460 號函，並同時停止適用。)

99.1.25. 衛署照字第 0990061556 號函

主旨：有關一般護理之家是否適用商業會計法、加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款規定疑義一案，經轉經濟部核復如附件，請 查照。

說明：依據經濟部 99 年 1 月 20 日經商字第 09902303480 號函辦理，並復貴局 98 年 12 月 30 日北衛心字第 0980160405 號函。

(註：本函釋說明段所敘經濟部 99.1.20. 經商字第 09902303480 號函，其內容如下：

主旨：關於行政院衛生署函詢有關一般護理之家是否適用商業會計法一案，復如說明，請 查照。

說明：

一、依據本部商業司案陳財政部賦稅署 99 年 1 月 14 日台稅二發字第 09900008240 號函副本辦理。

二、按商業會計法第 2 條第 1 項規定：「本法所稱商業，謂以營利

為目的之事業，其範圍依商業登記法、公司法及其他法律之規定。」準此，一般護理之家如非以公司、商業組織型態經營者，自非屬本法所稱之商業；又依其主管機關法令未特別規定者，自亦無商業會計法之適用。）

99.2.26. 衛署照字第 0990063629 號函

主旨：有關一般護理之家是否適用商業會計法、加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款規定疑義一案，經轉據財政部台灣省北區國稅局函復如附件，請 查照。

說明：

- 一、依據財政部台灣省北區國稅局 99 年 2 月 22 日北區國稅審四字第 0990002190 號函辦理（附影本及附件）。
- 二、有關是否適用商業會計法規定辦理商業會計事務一節，前經本署 99 年 1 月 25 日衛署照字第 0990061556 號函轉經濟部 99 年 1 月 20 日經商字第 09902303480 號函諒達。

（註：本函釋說明一所敘財政部北區國稅局 99.2.22. 北區國稅審四字第 0990002190 號函，其內容如下：

主旨：有關一般護理之家是否適用商業會計法、加值型及非加值型營業稅法（以下簡稱營業稅法）第 8 條第 1 項第 3 款規定疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、依據財政部賦稅署 99 年 1 月 14 日稅二發字第 09900008240 號函交 大署 99 年 1 月 6 日衛署照字第 0990000021 號函及附件辦理。
- 二、按「下列貨物或勞務免徵營業稅：……三、醫院、診所、療養院提供之醫療勞務、藥品、病房之住宿及膳食。」為營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款所明定。次按「私人辦理之補習班、幼稚園、托兒所、養護、療養院（所），不符合免稅規定者，其所得之查核準用本辦法。」為執行業務者帳簿憑證設置取得保管辦法第 2 條第 2 款所規定。又「依『護理機構設置標準』設置之產後護理機構，其所提供之產後護理服務，准依營業稅法第 8 條

第 1 項第 3 款規定免徵營業稅，並依同法第 29 條規定免辦營業登記。」「護理人員以個人名義設置護理機構所獲得報酬，與個人設立幼稚園、托兒所所獲得之報酬並無不同，其所得類別依所得稅法第 14 條規定，核屬其他所得。」分別為財政部 96 年 4 月 13 日台財稅字第 09604523030 號令及及 96 年 3 月 13 日台財稅字第 09604028710 號函所明釋。

三、參照前揭財政部令釋意旨，倘「一般護理之家」之設置，受「護理人員法」及相關規定規範，大署亦認定其為廣義之「醫療保健設施」，其所提供之護理服務，屬醫療勞務範疇者，免徵營業稅並免辦營業登記，惟應依法課徵所得稅。

四、又一般護理機構之所得類別核屬其他所得，雖應依執行業務者帳簿憑證設置取得保管辦法第 1 條第 2 項規定設置會計帳簿憑證，惟若未依法設帳記載及保存憑證者，稽徵機關得依所得稅法施行細則第 13 條規定照同業一般收費及費用標準核定其所得額；至於是否應依商業會計法規定辦理商業會計事務，請逕向該法主管機關詢問。

五、隨文檢附執行業務者帳簿憑證設置取得保管辦法 1 份供參。)

102.8.16. 衛部照字第 1022863803 號函

主旨：有關公立醫院附設護理之家提供之護理服務，是否適用加值型及非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 3 款規定免徵營業稅一案，復請 查照。

說明：

一、依據 貴局 102 年 4 月 15 日財北國稅審四字第 1020014547A 號函辦理。

二、依護理機構設置標準設置之產後護理機構所提供之產後護理服務範疇為何？是否包含尿布(片)費用？

(一)產後護理機構提供之服務內容，除產後婦女及嬰兒之基本照顧外，尚提供產婦之傷口護理、嬰兒臍帶護理、指導母乳哺育、衛生教育等業務，業已涉及護理業務。爰護理機構所提供之服務內容範疇，依法可執行

前開護理業務，提供護理照護服務項目。

(二)至產後護理機構提供護理照護服務是否包含尿布(片)乙節，應視該服務係因專業需求或一般生活照顧所衍生而定；所述尿布需求應屬後者。

三、有關現行公立醫院附設一般護理之家所提供之護理服務範疇為何？得否認屬醫療勞務之範疇？該護理服務是否包含尿布(片)費用乙節，說明如下：

(一)護理之家提供之服務內容，依據護理人員法第 24 條規定：護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。護理機構所提供之服務內容範疇，依法可執行前開護理業務，提供住民護理照護服務項目。

(二)上開所稱醫療輔助行為範疇，係屬醫療勞務，惟其提供服務之項目，仍應視契約所訂之內容而定。

(三)至一般護理之家提供護理服務是否包含尿布(片)乙節，應視該服務係因專業需求或一般生活照顧所衍生而定，尿布需求應屬後者。

四、前開護理服務（含一般及產後護理）如有部分費用（例如尿布、尿片等）未包含於護理服務費用內，或依其使用量，按使用者付費方式另行收取者，得否認屬護理服務範疇乙節，綜上說明，護理機構（含一般及產後護理）之尿布、尿片等逕依上開原則認定。

102.10.31 衛部照字第 1021580843 號函

主旨：有關依護理機構分類設置標準設置之產後護理機構提供之護理勞務是否屬醫療勞務範疇，復如說明段，請 查照。

說明：

一、復 貴部 102 年 10 月 16 日台財稅字第 10204668130 號函。

二、查護理人員法第 18 之 1 條規定「護理機構廣告，其內容

以左列事項為限：一、護理機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。二、負責護理人員之姓名、性別、學歷、經歷、護理人員證書及執業執照字號。三、業務項目及執業時間。四、開業、歇業、停業、復業、遷移及其年、月、日。五、其他經中央主管機關公告容許事項。」，至貴部來函所述「現行產後護理機構強調其規模及服務如休閒渡假飯店」乙節，如以廣告方式宣傳，已非屬產後護理機構業務項目，應依同法第 32 條「處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照」規定論處。

三、另產後護理機構收費標準核定係依護理人員法第 21 條第 1 項規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。」如有提供非收費項目的服務內容，應依違反本法第 21 條第 2 項「護理機構不得違反收費標準，超額收費」規定，依本法第 36 條之規定，處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰……，並應限期退還超額收費。

四、查護理人員法第 14 條規定「為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。」次查醫療法第 31 條第 3 項規定：「醫療法人經中央主管機關及目的事業主管機關之許可，得附設護理機構……。設立條件、程序及其他相關事項，仍依各該相關法規之規定辦理」，爰依護理機構分類設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰幼兒。是以由衛生主管機關核准設立之產後護理機構所提供之護理服務，係因醫療照護需求所衍生之照護服務，仍屬醫療勞務之範疇；惟產後護理機構所提供之服務若係因一般生活照顧所衍生，則非屬醫療勞務之範疇。

102.12.18 衛部照字第 1021581296 A 號函

主旨：有關產後護理機構收費項目訂定「醫療勞務」及「一般生活照顧」範疇乙案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、復財政部 102 年 11 月 5 日台財稅字第 10204679190 號函。
- 二、本部於 102 年 11 月 29 日召開「研商護理機構提供服務與醫療勞務範圍會議」，會中邀請財政部、衛生局、專家學者及護理機構等代表出席。有關產後護理機構收費項目包括「醫療勞務」及「日常生活照顧」兩類，其中屬「醫療勞務」係包括護理費（含護理評估、護理指導及處置等）、住房費、醫療診療及諮詢費等；日常生活服務費用則包括：嬰兒奶粉及尿布、清潔衛生用品及一般飲食等；地方衛生主管機關於核定護理機構收費項目，應能判別上述項目之類別。
- 三、惠請各直轄市及縣市衛生局轉知所轄產後護理機構於提供服務及收取費用時，應掣給收據並載明提供服務項目及收費金額，且項目內容是可判別屬「醫療勞務」或「日常生活照顧」，以確保民眾權益。

第 16 條 護理機構之設置或擴充，應先經主管機關許可；其申請人之資格、審查程序與基準、撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

護理機構之分類及設置標準，由中央主管機關定之。

。

89.10.18. 衛署醫字第 089012011 號函

主旨：所詢 85 年以前申請設立安養或護理之家，應否聘用專業護理人員，如在醫院或診所附設，是否可以免予另外申請許可？85 年 5 月以後，對於護理之家或安養中心之設立條件是否有所改變乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 89 年 8 月 25 日中分義民風決字第 12934 號函。
- 二、依護理人員法第 16 條規定：護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可。同法施行細則第 8 條規定：護理機構設置或擴充規模在 49 床以下者，由地方主管機關許可；50 床以上者，應報由中央主管機關許可。上項規定於 87 年 9 月 9 日修正為 300 床以上者，始需報由中央主管機關許可。
- 三、護理機構之開業，依護理人員法第 17 條規定，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照。醫院或診所如欲附設護理之家，應依護理人員法相關規定辦理。
- 四、護理機構設置標準原規定，每 10 床至少應配置有 1 名護理人員，87 年 6 月 17 日以後則修正為每 15 床至少應配置有 1 名護理人員。
- 五、至於安養機構之設立規定，請向內政部洽詢。
- 六、檢送護理人員法及其施行細則乙本，請卓參。

(註：本函釋說明二末段所敘「上項規定於 87 年 9 月 9 日修正為 300 床以上者，始需報由中央主管機關許可」乙節，其中「300 床」係「100 床」之誤植。)

90.3.1. 衛署醫字第 0900000693 號函

主旨：所詢預定設立護理之家之土地及建物均遭法院查封，則是否仍得准予設立乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 1 月 3 日衛醫字第 20075 號函。
- 二、查貴轄嘉鴻護理之家預定設立地點，除土地及建物均遭屏東地方法院查封外，全案並已進入強制執行程序，為免爾後影響護理之家病患權益，建請勿同意其申請設立。

94.3.1. 衛署醫字第 0940005474 號函

主旨：所詢設立護理之家法規相關問題一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴機構 94 年 1 月 17 日東照字第 94001005 號函。
- 二、查護理人員法第 16 條規定：「護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可，其申請程序應依中央主管機關之規定。護理機構之分類及設置標準，由中央主管機關定之。」至護理機構設置標準第八條附表「護理機構設置標準表」前經本署 92 年 10 月 27 日衛署醫字第 0920216079 號令修正發布在案。爰此，所詢設立護理之家，其病房應設洗手及衛浴設備一節，請依前述護理機構設置標準表之二、護理服務設施(五)病房衛浴設備項下之規定設置。
- 三、至護理機構之設立申請，依護理人員法施行細則第八條規定：「前條所定之申請，依左列規定辦理：1. 設置或擴充後之規模在 99 床以下者，報由直轄市或縣(市)主管機關許可。2. 設置或擴充後之規模在 100 床以上者，報由直轄市或縣(市)主管機關核轉中央主管機關許可。……」爰此，本案護理機構之設立及申請開業，請貴機構依護理人員法施行細則第 7 條及第 11 條之規定辦理。
- 四、檢送護理機構設置標準表一份，請參考。

94. 6. 30. 衛署醫字第 0940024147 號函

主旨：有關本署朴子醫院擬將急性一般病床 30 床暫借作為護理之家病床使用乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 7 日嘉衛醫字第 09400110000 號函。
- 二、按醫療法第 14 條規定，醫療機構之開業，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請核准登記，經發給開業執照，始得為之；其登記事項如有變更，應於事實發生之日起 30 日內辦理變更登記。是以，醫院開放之床數，應符合其向所在地衛生局申請核准之開業執照所登記床數。如減縮開放床數，應依規定向衛生局申請核減開放床數。
- 三、本案該院因業務需要，擬將醫療大樓 5 樓之急性一般病床

30 床，暫借作為護理之家病床使用（期限 1 年），本署原則同意，惟仍應符合護理機構設置標準，且該院仍應依前述醫療法之相關規定辦理變更登記，並俟該院附設護理之家完成後，即應回復原許可使用用途，屆期，尚未開放之該類許可病床數，將如數予以核減，程序如說明五。

四、至該護理機構之擴充亦應依護理人員法之相關規定申請許可，始得接續申請開業，發給開業執照。

五、請貴局確實督導該院開放病床進度，且如該院未於上開期限內全數開放完成，即請逕予核減其尚未開放之許可急性一般病床數，並更新醫事機構管理系統之該院病床資料後，副知本署備查。

95.11.24. 衛署醫字第 0950044990 號函

主旨：有關 貴員林鎮協和醫院業已核准設置附設護理之家 40 床在案，所詢該院能否於不同地點社頭鄉另增設置命名為協和醫院附設永安護理之家 72 床，及有關護理之家床數應如何計算等疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 95 年 10 月 11 日彰衛醫字第 0951005806 號函。

二、醫療機構依護理機構設置標準規定申請附設護理機構，該附設護理機構之申請主體為該醫療機構，其附設之護理機構，應另核發開業執照，先予敘明；至該附設護理機構之擴充，應以同址增建為限；如因應護理業務需要，該醫療機構擬於他址增置護理機構床數，應係另一附設護理機構之新設立，由該申請主體另依護理人員法第 16 條及相關規定，向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請許可，並依相關規定完成所需事項後，由該主管機關另核發開業執照。

三、經查本案協和醫院已於 90 年核准設置附設護理之家 40 床在案，現擬於不同地址增置另一附設護理機構床數 72 床，依說明二所述，應係另一護理機構之成立。本案請依前述規定，視個案事實，依職權辦理。

95.12.15.衛署醫字第 0950062433 號書函

主旨：有關 貴轄行政院衛生署南投醫院擬於該院南投院區 3 樓新設護理之家，惟原 2 樓為急性精神病房，5 樓為內科病房，是否許可一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 95 年 11 月 27 日投衛局醫字第 0950301483 號函。

二、按醫療法第 15 條第 1 項規定：「醫療機構之開業，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請核准登記，經發給開業執照，始得為之；其登記事項如有變更，應於事實發生之日起 30 日內辦理變更登記。」是以，醫院開放之床數，應符合其向所在地衛生局申請核准之開業執照所登記床數；如縮減開放床數，應依規定向衛生局申請核減開放床數。又醫療機構依護理機構設置標準規定申請附設護理機構之相關規定，請依本署 95 年 11 月 24 日衛署醫字第 0950044990 號函釋(諒達)規定辦理，先予敘明。

三、是以，本案醫療機構擬以部分病房申請附設護理機構，應依前述規定辦理；至該護理機構與醫療機構之執業場所使用空間應有明確區隔，並各有獨立動線，且符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許。

96.1.8.衛署照字第 0962800016 號函

主旨：有關民眾檢舉 貴市康福護理之家超床一案，經 貴局現場查核屬實，但業者陳情超收之住民大多為未繳住院費住民，是否仍須以違反護理人員法第 22 條規定，依同法第 32 條規定罰鍰？罰鍰後仍無法改善，後續應如何裁處一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 95 年 12 月 13 日衛醫字第 0950043221 號函。

二、按護理人員法第 16 條第 1 項規定：「護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可，其申請程序應依中央主

管機關之規定。」違反規定者，依同法第32條規定，處新臺幣1萬5千元以上15萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處1個月以上1年以下之停業處分或撤銷其開業執照。查本案護理機構有超收住民之事實，係屬護理機構床數之擴充，該機構未經申請許可即有擴床之事實，應依前述規定辦理，先予敘明。

- 三、至業者陳情該護理機構長期未繳住院費及棄養之住民逾三成比率，雖屢經催討或請家屬自行帶回，惟家屬罔顧親情或因失聯而遭棄養，造成長期佔用床位而被認為有超收住民之嫌一節，查民法第1114條規定，親屬互負扶養之義務，如有惡意遺棄之嫌時，如涉有刑法第294條、第295條規定，應通知當地社政機關會同警察單位處理；至住民長期未繳費用一節，事涉契約履行義務之相關責任，業者得依民法相關規定要求給付。爰此，本案護理機構之床數擴充，應先經申請主管機關許可、完成法定程序，始符法制，如該機構受有之行為義務而不為或無法執行時，除需瞭解該機構無法執行之原因，依個案事實予以適度輔導、轉介或提供必要之協助外，原處分機關得依權責，依前所述規定辦理。

96.1.25. 衛署照字第0962800295號函

主旨：有關 貴院詢問醫院附設護理之家及居家護理的定位及隸屬疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院95年12月5日耕醫住院字第0950120044號函。
- 二、按護理機構係以罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人為服務對象，依護理人員法及護理機構設置標準之相關規定，經衛生主管機關核准設立之機構；至醫療機構係對病人疾病急性期之治療、或疾病急性期治療後仍需相當程度之特殊醫療照護為主之病患，依醫療法及醫療機構設置標準之相關規定，經衛生主管機關核准設立

之機構，先予敘明。

三、至為利醫療機構及護理機構之管理，本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函釋略以：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。」另查「醫療機構附設護理之家或獨立型態護理之家，於不同時間，分別再增設居家護理機構及產後護理機構，不另核發開業執照及核給機構代碼，而以新增業務項目方式辦理，惟若先設居家護理，再增設護理之家，則需換發開業執照。」前經本署 90 年 5 月 8 日衛署醫字第 0900031567 號函釋在案。爰此，有關該醫療機構附設護理機構應依上開規定辦理。

四、依據全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法規定，居家護理機構及護理之家機構得申請為本保險之特約居家護理機構，辦理本保險居家照護業務，提供保險民眾居家照護服務並申請居家照護費用，其相關特約規定及給付標準詳如附件。

五、檢附「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法規定」之相關特約規定及給付標準乙份。

（註：本函釋說明三所敘本署 90.5.10. 衛署醫字第 0900031774 號函及 90.5.8. 衛署醫字第 0900031567 號函，請參閱 P.162、161）

96.4.16. 衛署醫字第 0960013393 號函

主旨：有關行政院衛生署樂生療養院附設護理之家設立案之許可管轄機關疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 96 年 3 月 20 日北衛醫字第 0960019128 號函。

二、按「醫療機構依護理機構設置標準規定申請附設護理機構，該附設護理機構之申請主體為該醫療機構，其附設之護理機構，應另核發開業執照，先予敘明；至該附設護理機構之擴充，應以同址增建為限；如因應護理業務需要，該

醫療機構擬於他址增置護理機構床數，應係另一附設護理機構之新設立，由該申請主體另依護理人員法第 16 條及相關規定，向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請許可，並依相關規定完成所需事項後，由該主管機關另核發開業執照。」前經本署 95 年 11 月 24 日衛署醫字第 0950044990 號函釋在案。

三、爰此，本案行政院衛生署樂生療養院擬於該院新醫療大樓（座落於桃園縣龜山鄉）設立附設護理之家，依前所述，該護理機構之設立，應向桃園縣政府申請許可，並依相關規定完成所需事項後，由該主管機關另核發開業執照。

四、至 貴局建議將行政院衛生署樂生療養院之衛生主管機關變更為桃園縣政府衛生局管轄一節，請依本署 95 年 8 月 24 日衛署醫字第 0950200900 號函辦理(諒達)。

(註：本函釋說明四所敘本署 95.8.24.衛署醫字第 0950200900 號函

，其內容如下：

主旨：貴局建議本署樂生療院之衛生主管機關變更為桃園縣政府衛生局管轄乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 95 年 7 月 27 日北衛醫字第 0950061889 號函。

二、按醫事機構申請擴建醫療大樓，係屬醫療法第 14 條之醫院擴充，擴充後應屬原醫療機構之一部份。是以，該機構之主管機關應以該機構申請開業執照之地址認定。)

96.7.20.衛署照字第 0960031101 號函

主旨：有關護理之家設置或擴充，可否免經委員審查同意，授權主管機關核可展延 6 個月一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 96 年 7 月 11 日投衛局醫字第 0960300666 號函。

二、有關護理之家設置或擴充經本署或貴局許可應於規定期限內，取得建築執照期程。如需再申請展延取得建築執照期程，則應檢具具體事實敘明理由及相關證明文件資料，送

請當地衛生主管機關審查後，100 床以上轉本署核辦。本案是否須經委員會審查同意，請本權責依事實認定辦理。

96.8.2. 衛署照字第 0960034115 號函

主旨：有關本署規劃醫療網護理之家床數及經許可未於規定期限內籌建完成，其申請展延一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 26 日衛醫字第 0960034156 號函。
- 二、有關本署規劃每萬老人 65 張床數為醫療網計畫目標，另「醫療法」第 90 條第 2 項規定「對於醫療設施過賸區域，主管機關得限制醫療機構或護理機構之擴充」。惟「護理人員法」並未對資源過賸區，作明確規範限制；鑑於「護理之家」目前屬自費市場，對床位之設置或擴充，希望以市場機制自然運作，讓民眾能有選擇的權利。
- 三、有關護理之家設置或擴充經本署或貴局許可應於 6 個月規定期限內，取得建築執照期程。如需再申請展延取得建築執照期程，則應檢具具體事實敘明理由及相關證明文件資料，送請當地衛生主管機關審查後，100 床以上轉本署核辦。

96.12.18. 衛署醫字第 0960064867 號函

主旨：所詢護理機構於原許可設立擴建面積外，另申請擴充面積並擴建廚房、餐廳及廁所等建築物，是否須依護理人員法第 16 條規定辦理一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 12 月 6 日衛醫字第 0960054549 號函。
- 二、按護理人員法施行細則第 7 條規定：「護理機構依本法第 16 條規定，申請主管機關許可設置或擴充，應檢具左列文件：一、設立或擴充計畫書，包括護理機構名稱、建築地址、設置類別、設立床數、基地面積、建築面積、護理機構組織架構、人員配置、設立進度、經費概算及擬定開業

日期。二、位置圖。三、建築物平面簡圖。四、由其他法人依有關法律規定附設者，應檢附各該法人主管機關同意函件。」先予敘明。

- 三、是以，護理機構之設置，有關建築物之設計、構造與設備應符合護理機構設置標準表所列之相關規定。本案於原許可設立擴建面積外，另申請擴充面積，擴建廚房、餐廳、廁所等建築物供護理機構使用，該建築物變更設計，應符合建築法及消防法等有關規定，而該護理機構如擴充地點、總床數不變情形下，尚不需重新申請許可，惟變更事項仍應報請原申請主管機關核備。

99.4.28. 衛署照字第 0992861056 號函

主旨：有關護理機構之設置或擴充，其申請開業登記或建築執照許可之展延期限及次數等案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴府 99 年 4 月 6 日府政查字第 0990080875 號函。
- 二、查本署 84 年 7 月 12 日衛署醫字第 84045553 號函規定：護理機構之設立或擴充，經衛生主管機關許可後，應於 6 個月內申請開業登記或依法申請建築執照，並由衛生主管機關於許可函內載明。逾期者，衛生主管機關得撤銷其許可。如期限屆滿未能完成，而有正當理由者，得申請展延。惟展延期限，最長以 2 年為限。
- 三、揆諸上開函規定，係指單次辦理申請展延之期限，至其申請開業登記或建築執照許可之展延期限及次數，則係衡量地方資源需求，且展延時需檢具具體事實敘明理由及相關證明文件，由權責單位認定辦理。

100.2.21. 衛署照字第 1002860481 號函

主旨：所詢老人福利機構於原址變更為護理之家，得否比照老人福利機構負責人變更之程序，收容對象不須淨空辦理乙案，復如說明二，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 99 年 12 月 30 日內授中社字第 0990071351 號函及 100 年 2 月 8 日內授中社字第 1000715587 號函。
- 二、護理機構之設置，依護理人員法第 16 條及同法施行細則第 6 條規定，應先經申請主管機關許可；另依護理人員法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，護理機構之開業應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。
- 三、綜上規定，本案老人福利機構擬於原址變更為護理之家，應符合前開規範，於申請許可及開業核准後，始能執行相關之業務。
- 四、本署目前已著手修訂相關法規，有關機構類型轉換之行政程序將朝更便民方式規劃。

100.6.23. 衛署醫字第 1000263266 號函

主旨：有關病情穩定但仍需使用呼吸器之患者入住一般護理之家，其設置標準（人力比及設施設備）是否仍僅適用護理人員法第 16 條第 2 項規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、依據 貴局 100 年 5 月 18 日北衛心字第 1000059662 號函辦理。
- 二、按護理機構設置或擴充，應先經申請主管機關許可，於護理人員法第 16 條明定。其申請程序等相關規定，亦於同法施行細則第 5 條與第 6 條訂有明文。爰主管機關得就申請之護理機構設置或擴充計畫，參酌護理機構之分類及設置標準等相關規定，及基於機構收住住民之安全及照護環境品質等客觀因素，審酌其得設立或擴充之許可規模。合先敘明。
- 三、至有關護理機構設立或擴充之申請計畫案，其申請之部分床數，未來擬收住病情穩定但尚需依賴呼吸器使用之住民

一節，基於前揭呼吸器依賴患者由呼吸照護病房下轉至護理之家之需求日益增多，及其所需呼吸儀器之置放空間與該類住民所需之照護人力相對高於一般住民之照護等因素考量，本署（護理及健康照護處）刻正研議修訂相關規範，惟於前揭規範修訂前，有關前開計畫之審查，建議仍得視需要請申請者，就其收住呼吸器依賴患者之空間、人力及相關照護之整體規劃提出補充或說明，並在考量符合受照護者之需要下，據以審核其設立或擴充之許可規模。

100.8.12. 衛署照字第 1000074972 號函

主旨：所詢安養中心變更為一般護理之家，其歇業、開業行政作業期間住民之安置疑義案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 8 月 9 日高市衛長字第 1000072735 號函。
- 二、護理機構之設置，依護理人員法第 16 條及同法施行細則第 6 條規定，應先經申請主管機關許可；另依護理人員法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，護理機構之開業應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。
- 三、綜上規定，本案安養中心擬於原址變更為一般護理之家，應符合前開規範，於申請許可及開業核准後，始能執行相關之業務。

100.9.26. 衛署醫字第 1002862587 號函

主旨：所詢有關護理之家申請設置或擴充案件之審查原則，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 9 月 13 日桃衛照字第 1000005390 號函。
- 二、來函說明一及說明二引用之法規條文應更正為護理人員法施行細則第 6 條及醫院設立或擴充許可辦法第 3 條，先予

敘明。

- 三、依據護理人員法施行細則第 6 條規定，護理之家設置或擴充後之規模在 99 床以下之申請案，其准駁與否係屬地方主管機關之行政裁量權責，目前縣市政府對於護理之家設置或擴充案件之審查方式有提送地方醫事審議委員會審查或聘請審查委員審查，至其行政裁量基準是否參考醫院設立或擴充許可辦法、參酌護理之家前 1 年之平均佔床率、照護品質、歷年督考、評鑑、違規紀錄等事宜，宜由各地方主管機關考量當地資源及管理需要，因地制宜予以設定，惟行政裁量基準係屬行政規則，並事涉人民權益申請事項，建議應依行政程序法第 160 條規定，應先發布後才予施行。
- 四、旨揭事宜，本署刻正辦理護理人員法第 16 條修正，授權訂定護理之家設置或擴充許可辦法，以使護理之家設置或擴充案件審理有所依據。

101.11.16. 衛署照字第 1012863920 號函

主旨：有關 貴局所詢一般護理之家設立是否屬公共設施、公用事業或重大公共建設等相關疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 9 月 19 日桃衛照字第 1010179741 號函。
- 二、依據桃園縣政府地政局函略以，上開限制發展地區，除國防與國家重大建設外或因生活環境品質與安全之考量，不允許作非保育目的之發展與任何開發行為。
- 三、另依內政部所頒「都市計畫法臺灣省施行細則」第 18 條規定，乙種工業區可設置公害輕微之工廠與其必要附屬設施，及與工業發展有關之設施、公共服務設施及公用事業設施、一般商業設施，其中第 3 款公共服務設施及公用事業設施包含醫療保健設施（醫療機構及護理機構）。
- 四、福音護理之家係由資深護理人員以個人身分依護理人員法規定申請設立，非政府自行或補助其設立，請貴局逕行考

量民眾需求之迫切性及該類機構分布密度等綜合判定。

102.1.23. 衛署照字第 1022860177 號函

主旨：有關 貴局再詢一般護理之家設立是否屬公共設施、公用事業或重大公共建設之貴轄某護理之家設置案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 12 月 21 日桃衛照字第 1010193543 號函。
- 二、前案業經本署 101 年 11 月 16 日衛署照字第 1012863920 函復在案。另，因長照需求快速增加，故一般護理之家設立以全國而言係屬重大公共建設，然各縣市地區仍有其需求之差異性，故應考量縣市或區域機構分布密度及民眾需求狀況為綜合判定。
- 三、依本署國民長期照護需要調查之結果推估，桃園縣失能人口約有 37,185 人，另依 99 年底長照資源盤點結果，桃園縣龍潭鄉小區長照型機構式資源共 8 家，590 床，佔床率 73.56%，平均每萬失能人口床數為 2,627.2 床（高於所定義全國長照資源不足區域之 700 床），申請設置護理機構位址位於限制區範圍內，惠請貴局依據上述說明本於權責予以審酌。

102.2.19 衛部照字第 1022860291 號函

主旨：有關產後護理機構設置或擴充許可之辦理，適用「護理機構設置或擴充許可辦法」或「84 年 7 月 12 日衛署醫字第 84045553 號函」之疑義，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 1 月 22 日高市衛建字第 10230739400 號函。
- 二、本署已於 101 年 12 月 19 日公告護理機構設置或擴充許可辦法（以下簡稱本辦法），本辦法施行前，已取得設置許可之產後護理機構，如因故需提出開業展延，應依本辦法第 9 條至第 11 條規定申請，其起算日之計算應依本辦法第

13 條「本辦法施行前，已取得設置或擴充許可者，自本辦法施行日起算」規定辦理。

三、自本辦法公告施行後，84 年 7 月 12 日衛署醫字第 84045553 號函應停止適用。

102. 7. 29. 衛部照字第 102580055 號函

主旨：有關貴轄再詢福音護理之家申請設立是否屬公共建設、公用事業或重大公共建設乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 4 月 23 日桃衛照字第 1020162918 號函。
- 二、有關旨案函請協助認定是否屬公共建設、公用事業或重大公共建設乙案，本部意見前於 101 年 11 月 16 日衛署照字第 1012863920 號函及 102 年 1 月 23 日衛署照字第 1022860177 號函復在案。
- 三、又，本部請一般護理之家新設置或擴充業務審查委員會委員審查，檢附委員審查意見表供參。

103. 1. 6 衛部照字第 1021581579 號函

主旨：所詢私立護理之家申請擴充，得否將鄰近長照機構申請作為擴充區域，逕行變更為護理之家，不須將住民淨空一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 12 月 10 日桃衛照字第 1020308801 號函。
- 二、依據護理人員法第 16 條及同法施行細則第 6 條規定，護理機構之設置及擴充，應先申請並經主管機關許可；又同法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，護理機構之開業應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。次依私立老人福利機構設立許可及管理辦法第 17 條第 1 項規定：「私立老人福利機構歇業或解散時，應於 1 個月前檢具申請書敘明理由、現有收容老人安

置計畫及日期，報主管機關許可。」先予敘明。

- 三、旨案老人長照機構欲申請變更為護理之家，應同時符合前開法令規定，至變更過程是否須先完成歇業程序將住民淨空，應由當地縣市政府社會局(處)及衛生局依個案事實認定辦理。意即，倘老人長照機構經縣市社會局(處)許可歇業日期能與護理之家經衛生局核准開業日期訂為同時，讓現有老人安置與入住護理之家能無縫接軌，則可避免讓已入住該機構老人面臨搬遷問題，如否，因本案係擬變更為護理之家，仍應依護理人員法相關規定辦理。

103.3.18 衛部照字第 1031560405 號函

主旨：所詢有關貴轄名家護理之家因土地暨建物經法院拍賣，產權已轉移，可否辦理負責人變更，如無法變更擬重新申請籌設許可，是否適用農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點一案，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 3 月 6 日彰衛長字第 1030006204 號函。
- 二、依據護理人員法施行細則第 4 條第 2 項規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其申請人、設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可。」次依護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」前開法規係明訂機構經許可設立後，如欲變更負責人，應由機構提出申請，惟對於其變更負責人原因（例如因土地所有權轉移是否應辦理負責人變更），非屬本法規範內容，先多敘明。
- 三、又按農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 6 點第 1 項規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」查

前開所稱公益性福利設施，應視申請計畫內容進行專案審查後始得認定。

103.4.15. 衛部照字第 1031560433 號

主旨：有關產後護理機構設置及坐月子中心相關疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 10 月 16 日高市衛健字第 10239956900 號函。
- 二、有關產後護理機構擴充地點為原已設置機構之鄰近地點，並由原已設置機構負責人同時擔任乙節，護理機構之設立或擴充，應依護理人員法、護理機構分類設置標準及護理機構設置或擴充許可辦法等規定辦理，至產後護理機構擴充地點之距離範圍，除應符合前開規定外，亦應考量機構現址與各分支點之照護品質服務、照護人力、行政管理、作業動線、安全管理、設備設施及配套措施之完善及運作順暢原則下設立，惟仍應依個案實際狀況認定之。
- 三、有關護理機構分類設置標準門寬定義乙節，查本部 102 年 12 月 31 日衛部照字第 1021581254 號函副本諒達，按護理機構分類設置標準規定，略以：「護理機構，其一般設施應符合建築法及其有關法規規定；住房寢室及衛浴設備至少應各有一扇門，寬度至少為零點八公尺」，所詢門寬定義，係指門實體寬度（淨寬），尚不包括門框寬度。爰此，護理機構住房寢室及衛浴設備門寬應依該標準之特別規定辦理。
- 四、有關坐月子中心建築物及其設備規範乙節，查坊間所稱「坐月子中心」，係向經濟部辦理營業登記，應依其原始營業登記之各該管法令規定辦理，非依護理人員法許可設置；為顧及產婦及嬰兒之安全，故本部於「產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載及不得記載事項」明訂坐月子中心之建築物及其設備應符合建築法規及消防法規有關公共安全之相關規定；惟坐月子中心之建築物使用類組或

消防安全場所用途分類之規定，仍應依營建及消防各該法令進行認定。

103.9.1 衛部照字第 1031500160 號函

主旨：所詢申請護理機構擴床程序，針對已核准立案範圍，是否需要重新審核一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴分院 103 年 8 月 22 日中總嘉護字第 1030010690 號函。
- 二、按護理機構設置或擴充許可辦法第 3 條第 1 項規定，護理之家機構設置或擴充後之規模在一百床以上者，由當地衛生主管機關初審通過後，報中央主管機關許可。同辦法第 5 條規定：「護理之家機構及產後護理機構計畫書，應載明下列事項：…二、設置或擴充之目的、當地資源概況、住民來源分析、住民轉介流程、服務品質管理及營運後三年內機構業務預估。三、建築地址(地號)、建物位置圖、基地面積、建築面積、設置或擴充前後之總樓地板及各樓層地板面積及樓層平面配置圖；擴充者應檢附擴充前後配置對照表。…七、申請擴充者，其最近三年之財務報告」。
- 三、承上，旨案因申請機構擴充後之規模達一百床以上，應由衛生局初審後，提報本部進行審查及許可；又申請擴床案之計畫書內容包含擴充前後之資料，故按上開規定應完整提供，以利地方及中央主管機關進行審查。

106.10.16 衛部照字第 1061562633 號

主旨：有關 106 年 6 月 3 日長期照顧服務法(以下稱長服法)施行後，新設立一般護理之家、公立護理之家擴充、遷址及一般護理之家新增或擴充服務項目是否可依護理人員法辦理之疑義，詳如說明，復請查照。

說明：

- 一、復新北市政府衛生局 106 年 9 月 1 日新北衛心字第

1061713603 號函、十方都市開發顧問有限公司 106 年 8 月 29 日十字(106)第 1060822 號函、宜蘭縣長期照護服務管理所 106 年 8 月 24 日宜長照字第 1060007319 號函。

- 二、長服法施行後，倘設置住宿型長照機構應依長服法規定辦理，意即無新設一般護理之家。
- 三、如為既有一般護理之家且總樓地板面積不變前提下，符合護理機構分類設置標準，得依護理人員法新增日間照護服務項目或擴充日間照護服務量(如增加日間照護服務人數)。
- 四、長服法施行後，既有公立醫院附設護理之家之擴充或遷址，得依護理人員法辦理。

106.09.12 衛部照字第 1061562527 號

主旨：所詢有關居家護理所提供居家服務是否需再申請設立居家式服務類長期照顧服務機構一案，復請查照。

說明：

- 一、依據貴局 106 年 8 月 14 日中市衛醫字第 1060081431 號函辦理。
- 二、長期照顧服務法（以下簡稱長服法）自今年 6 月 3 日正式施行，該法施行前已依護理人員法設立之居家護理機構，依長服法第 62 條規定，仍得依原適用法令繼續提供長照服務，先予敘明。
- 三、又為踐行長服法的精神、設立標準規定及未來管理與各類醫事機構設立原則之一致性，如居家護理機構除護理專業服務外，欲提供「身體照顧、日常生活照顧及家事服務」等服務內容者，仍需依據長期照顧服務機構設立標準規定辦理申請設立居家式服務類長期照顧服務機構。然基於簡化原則及考量實務運作面，此一類型之居家式服務類長期照顧服務機構可與居家護理機構同址設置(即俗稱掛雙牌)，其居家式服務類長期照顧服務機構之業務負責人得與居家護理機構之負責人同一人，且同址設立之兩機構無須

獨立出入口。

106.10.17 衛部照字第 1061562739 號

主旨：有關依護理人員法申請新設居家護理機構一案，請查照。

說明：

- 一、長期照顧服務法自 106 年 6 月 3 日起施行，不論是該法施行前或施行後，如居家護理機構僅提供護理專業服務，仍得依護理人員法設立居家護理機構，並可特約長期照顧服務法之居家護理服務。
- 二、另有關居家護理機構提供居家服務是否需再申請設立居家式服務類長期照顧服務機構乙節，請依本部 106 年 9 月 12 日衛部照字第 1061562527 號函辦理，檢附函文供參。

106.12.20 衛部照字第 1060137504 號

主旨：所詢有關居家式長期照顧服務機構提供醫事照護服務，其設立標準應依醫事人員相關法規辦理之疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 12 月 7 日北市社老字第 10646513600 號函。
- 二、查本部 106 年 10 月 17 日衛部照字第 1061562739 號函(如附件)，係為踐行長服法的精神、設立標準規定、未來管理與各類醫事機構設立原則之一致性，以及基於簡化原則及考量實務運作面，故依護理人員法新設的居家護理機構，倘除護理專業服務外，欲提供「身體照顧、日常生活照顧及家事服務」，則可依長期照顧服務法(以下稱長服法)申請設立居家式長照機構，並可與居家護理機構同址設置(即俗稱雙掛牌)，其居家式服務類長期照顧服務機構之業務負責人得與居家護理機構之負責人同一人。
- 三、依護理人員法設立居家護理機構與依長服法設立居家式長照機構先後設立之次序乙節，涉及地方實際作業程序及需

要，爰尊重貴局決定辦理之程序及設立流程。

第 17 條 護理機構之開業，應依左列規定，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照：

- 一、公立護理機構：由其代表人為申請人。
- 二、財團法人護理機構：由該法人為申請人。
- 三、私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。

103.1.6 衛部照字第 1021581579 號函

主旨：所詢私立護理之家申請擴充，得否將鄰近長照機構申請作為擴充區域，逕行變更為護理之家，不須將住民淨空一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 12 月 10 日桃衛照字第 1020308801 號函。
- 二、依據護理人員法第 16 條及同法施行細則第 6 條規定，護理機構之設置及擴充，應先申請並經主管機關許可；又同法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，護理機構之開業應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。次依私立老人福利機構設立許可及管理辦法第 17 條第 1 項規定：「私立老人福利機構歇業或解散時，應於 1 個月前檢具申請書敘明理由、現有收容老人安置計畫及日期，報主管機關許可。」先予敘明。
- 三、旨案老人長照機構欲申請變更為護理之家，應同時符合前開法令規定，至變更過程是否須先完成歇業程序將住民淨空，應由當地縣市政府社會局(處)及衛生局依個案事實認定辦理。意即，倘老人長照機構經縣市社會局(處)許可歇業日期能與護理之家經衛生局核准開業日期訂為同時，讓現有老人安置與入住護理之家能無縫接軌，則可避免讓已

入住該機構老人面臨搬遷問題，如否，因本案係擬變更為護理之家，仍應依護理人員法相關規定辦理。

〔釋例類別〕 第 1 類 開業執照登記

82.11.6. 衛署醫字第 82074320 號函

主旨：護理人員法施行細則第 13 條第 7 款所定護理機構之業務項目登記，係指依其機構種類分別登記「護理之家」、「產後護理」或「居家護理」，請 查照。

82.11.16. 衛署醫字第 82074320 號公告

主旨：公告護理機構開業執照格式，如附件。

說明：

- 一、依據護理人員法施行細則第 32 條規定辦理。
- 二、護理機構開業執照格式，長 25.8 公分，寬 35.5 公分；梅花圖案邊，其外層長 20.2 公分，寬 30.5 公分，內層長 17.6 公分，寬 27.9 公分；國旗印於上方中央；黃底套色；衛生署徽白底居中。左下方貼負責護理人員 2 吋半身相片。
- 三、內容文字為正楷列印，包括護理機構名稱、開業地址、負責護理人員之姓名、證書字號及業務項目。
- 四、業務項目，依其機構種類填列護理之家、產後護理或居家護理。

85.6.15. 衛署醫字第 85031184 號函

主旨：所詢醫療機構附設居家護理業務應否給予新醫事機構代碼疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 85 年 6 月 5 日健保醫字第 85009298 號函。
- 二、按醫療機構依護理機構設置標準第 13 條規定，設居家護理、產後護理或護理之家服務部門者，地方衛生主管機關除應依本署 82 年 11 月 16 日衛署醫字第 82074320 號函規

定，於醫療機構開業執照診療科別欄，加註「居家護理」、「產後護理」或「護理之家」之業務項目外，並應參照本署 85 年 3 月 13 日衛署醫字第 85013024 號簡便行文表所送「醫療資訊網—醫事機構管理系統」權屬別及型態修訂表，分別給予新醫事機構代碼，以利醫政管理。

三、至於全民健康保險特約醫療機構已附設之「居家護理」，是否因衛生主管機關另予新醫事機構代編，而需另送特約申請書重新申請特約一節，請貴局逕依權責裁量。

四、副本抄送台灣省政府衛生處、台北市政府衛生局、高雄市政府衛生局、金門縣、連江縣衛生局，關於說明二之規定，請查照轉行。

(註：本函釋說明二所敘「本署 82.11.16.衛署醫字第 82074320 號函規定，於醫療機構開業執照診療科別欄加註護理機構之業務項目」乙節，業經 90.5.10.衛署醫字第 0900031774 號函停止適用，請參閱 P.162)

90.4.25.衛署醫字第 0900023169 號函

主旨：有關醫療機構申請附設護理機構，依規定核准開業後，於原醫療機構開業執照加註服務項目者，需否收取執照費乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 90 年 4 月 11 日 90 投衛局醫字第 90005895 號函。

二、依 89 年醫政、護政業務會議決議：有關醫療機構附設護理機構，其附設之護理機構，一律另發開業執照，至原加註於醫療機構診療科別者，則應於異動時，重新核發開業執照，本案請依前開決議辦理。

90.5.8.衛署醫字第 0900031567 號函

主旨：醫療機構附設護理之家或獨立型態護理之家，於不同時間，分別再增設居家護理機構及產後護理機構，不另核發開業執照及核給機構代碼，而以新增業務項目方式辦理，惟

若先設居家護理，再增設護理之家，則需換發開發執照，請 查照。

說明：依據 89 年醫政、護政業務會議決議辦理。

90.5.10.衛署醫字第 0900031774 號函

主旨：醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照，請 查照。

說明：依據 89 年醫政、護政業務會議決議辦理。

91.5.7.衛署醫字第 0910014365 號函

主旨：有關貴轄國軍桃園總醫院附設護理之家申請變更負責人，其開、執業執照應如何掣給乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 91 年 1 月 31 日桃衛醫字第 9105451 號函。

二、本案原係國軍桃園總醫院以附設護理之家及居家護理服務部門登記，依本署 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函規定，醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。

三、另醫院同時設有居家護理及護理之家，核發開業執照時，得以護理之家機構代碼或居家護理機構代碼擇一印出開業執照，若考慮居家護理與健保特約問題，得優先以居家護理機構列印開業執照，至於原核給之機構代碼可同時保留。至其機構名稱應依護理人員法施行細則第 14 條規定辦理。

四、另護理之家同時辦理居家護理或產後護理服務部門，其負責護理人員得以同一人登記，前經本署 83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035205 號函釋在案。其負責護理人員之執業場所應登記於護理之家，至其他人員則依其實際執業場所分別核給執業執照。

96. 4. 16. 衛署醫字第 0960014958 號書函

主旨：有關醫療機構附設居家護理所設置疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 4 月 4 日北衛醫字第 0960029330 號函。
- 二、查護理機構設置標準第 2 條：「本標準所稱護理機構，指依本法施行細則第 6 條所定之居家護理機構、護理之家機構及產後護理機構。」至為利於醫療機構及護理機構之管理，本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函釋略以：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。」又該護理機構因係由醫院附設，宜以醫療機構名稱作為申請人，前經本署 96 年 2 月 6 日衛署醫字第 0960004896 號書函函釋在案，先予敘明。
- 三、是以，醫療機構與附設之護理機構如同址設立，其總樓地板面積應分別計算，並符合各該機構設置標準之規定；又其執業場所使用空間與公共場所應有明確區隔，並各有獨立動線，始准許開業。至所述本案附設居家護理機構與該院辦公空間如以 OA 辦公桌或拉簾區隔，是否符合上揭規定一節，請依前述規定視個案事實依權責認定。

（註：本函釋說明二末段所敘「又該護理機構因係由醫院附設，宜以醫療機構名稱作為申請人」乙節，業經 97. 4. 1. 衛署醫字第 0970201290 號函停止適用，請參閱 P. 209）

100. 1. 7. 衛署照字第 0992863553 號函

主旨：有關 貴院附設護理之家擬增加居家護理服務項目一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 99 年 11 月 26 日第 0990002886 號函。
- 二、護理之家機構設居家護理者，應於其開業執照業務項目欄

，加註「居家護理」業務項目。惟另依本署 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函示：醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。

三、貴院附設護理之家須具備另發開業執照，始得辦理加註「居家護理」業務項目。

101.1.3. 衛署照字第 1002863487 號函

主旨：一般護理之家收住呼吸器依賴個案之設置標準相關規定公告施行後，有關許可核發及開業登記之處理方式如說明段，請 查照。

說明：

一、旨揭規定為「護理機構分類設置標準」第 10-1 條及第 8 條附表，業經本署於 100 年 12 月 2 日以衛署照字第 1002863077 號令修正發布施行，並於 100 年 12 月 2 日以衛署照字第 1002863077C 號函諒達。

二、為使一般護理之家收住呼吸器依賴個案之管理能符合規定，有關機構該類床數之許可核發及開業登記處理方式如下：

(一)已開業機構部分：

1. 惠請稽核所轄一般護理之家收住呼吸器依賴個案之情形，並輔導轄內已收住呼吸器依賴個案達 4 床以上之一般護理之家，於 101 年 6 月 1 日前依設置標準改善。
2. 若機構於現有設置規模內收住呼吸器依賴個案達 4 床以上者，應依設置標準規定配置相關人力及設施設備。
3. 前揭二項經實地履勘與規定相符者，應依護理人員法施行細則第 13 條規定，辦理登記事項變更，於該等機構之開業執照病床數登載「(含收住呼吸器

依賴個案○床)」。

(二)新設置或擴充申請部分：

1. 經審核准予設置或擴充之許可函其許可事項，於護理之家許可床數加註「(含收住呼吸器依賴個案○床)」。
2. 開業核准登記，仍依現行規定辦理，並於開業執照病床數登載「(含收住呼吸器依賴個案○床)」。

(三)為配合「護理機構分類設置標準」修正規定，本署醫事管理系統刻正進行一般護理之家收住呼吸器依賴個案床之登記欄位、相關資料串聯及護理機構開業執照病床數內容增修等事宜(系統增修後，如有登錄收住呼吸器依賴個案床數資料，系統產出之開業執照病床數將會帶入【含收住呼吸器依賴個案○床】之資料)，爰此，上開機構開業登記、許可事項及護理人力數資料更新部分，建請先行紙本登記，俟醫事系統增修完成後，將另行通知至系統做補登作業。

三、檢附護理機構開業執照病床數加註「含收住呼吸器依賴個案床數」範例，如附件。

附件

○○○○○字第○○○○○○○號

護理機構開業執照

○○○申請護理機構開業登記核與護理人員法規定相符合予發給開業執照並摘錄登記事項如下：

名 稱：○○護理之家

地 址：○○○○○○○○○○○○○○○○○○

負 責 人：○○○

業務項目：護理之家

病 床 數：一般護理之家○床(含收住呼吸器依賴個案○床)

○○市

中華民國○年○月○日

機構代碼：○○○○○○○○○○

101.5.4. 衛署照字第 1012862269 號函

主旨：為配合一般護理之家收住呼吸器依賴個案之設置標準相關規定公告施行，本署醫事管理系統（以下簡稱醫事系統）已完成相關功能之增修，請 查照。

說明：

- 一、「護理機構分類設置標準」已於 100 年 12 月 2 日衛署照字第 1002863077 號令修正發布施行一般護理之家收住呼吸器依賴個案床之規定，並於 100 年 12 月 2 日以衛署照字第 1002863077C 號函計達，另有關一般護理之家收住呼吸器依賴個案之許可核發及開業登記處理方式，亦已於 101 年 1 月 3 日衛署照字第 1002863487 號函諒達。
- 二、為配合「護理機構分類設置標準」修正規定，醫事系統已完成一般護理之家收住呼吸器依賴個案床之登記欄位、相關資料串聯及護理機構開業執照病床數內容增修等事宜（系統增修後，如有登錄收住呼吸器依賴個案床數資料，系統產出之開業執照病床數將會帶入【含收住呼吸器依賴個案○床】之資料）。
- 三、已開業之機構，其於醫事系統之資料更新部分，請先於「擴建／設立許可資料」功能進行病床資料更新，並於備註欄位加註依本署 101 年 1 月 3 日衛署照字第 1002863487 號函，已於○年○月○日進行病床資料異動後，再至「開業（護理機構）」功能進行開業資料變動；新設置或擴充申請者，請依原作業程序至醫事系統進行相關資料登錄。
- 四、綜上，貴轄之一般護理之家配合「護理機構分類設置標準」修正規定，須更新開業登記、許可事項及護理人力數資料部分，如已先行紙本登記，請至醫事系統進行補登作業。
- 五、本署醫事管理系統之操作如有疑義，請逕洽客服專線

(02)8952-1508 詢問。

101.6.5. 衛署照字第 1012800430 號函

主旨：所詢關於護理之家提供居家護理服務疑義案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 5 月 21 日健保醫字第 1010078104 號函。
- 二、本署已於 82 年 11 月 16 日衛署醫字第 82074320 號函示，護理之家得設居家護理部門，惟其所設之居家護理部門仍應符合護理機構設置標準所定之居家護理機構之標準，另於 100 年 1 月 7 日衛署照字第 0992863553 號函示，護理之家機構設居家護理者，應於其開業執照業務項目欄，加註「居家護理」之業務項目。
- 三、爰此，護理之家得提供居家護理服務，其服務對象及服務區域應以地方主管機關核准之範圍予以執行。

101.6.27. 衛署照字第 1012862942 號函

主旨：所詢有關護理之家提供居家護理服務疑義案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 6 月 14 日健保醫字第 1010004871 號函。
- 二、護理之家提供居家護理服務，應於其開業執照業務項目欄，加註「居家護理」之業務項目。該機構除符合護理機構分類設置標準第 8 條之設置規範外，原許可計畫書即應載明人員配置，爰此，該機構若提供居家護理服務時，應無額外配置護理人員與互相流用之虞。
- 三、另護理之家得提供居家護理服務，其服務對象及服務區域應以原主管機關許可計畫書之範圍予以執行。

101.11.27. 衛署照字第 1012864520 號函

主旨：有關貴局所詢護理之家申請變更業務項目，新增「居家護

理」業務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 11 月 19 日新縣衛醫字第 1010024312 號函。
- 二、護理之家設居家護理業務者，應於其開業執照業務項目欄，加註「居家護理」業務項目。惟其設之居家護理部門，仍應符合護理機構分類設置標準所定之居家護理機構之標準。

〔釋例類別〕 第 2 類 申請設置主體

82.10.2. 衛署醫字第 8266038 號函

主旨：公告設立財團法人護理機構所需財產總額之最低限額。

依據：護理人員法施行細則第 9 條、第 10 條及行政院衛生署監督衛生財團法人準則第 5 條。

- 一、財團法人護理機構，應有足以購置所需建築基地、房舍及必要設備之設立基金。其申請設立之最低限額，依左列之規模或條件核計：
 - (1) 護理之家機構及產後護理機構，應具 50 床以上規模。
 - (2) 居家護理機構，應有壹百平方公尺以上之辦公房舍及土地。
- 二、其已有之土地、房舍合於設立護理機構之用者，得抵充前項之設立基金。

86.1.27. 衛署醫字第 86002275 號函

主旨：有關護理人員法第 17 條第 1 項第 3 款規定，「私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律附設者，以該法人為申請人。」，所稱「其他法人」係指為何一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 86 年 1 月 14 日(86)財北國審壹字第 86001586 號函。

- 二、查護理人員法第 17 條第 1 項第 3 款所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構。

89.3.14. 衛署醫字第 89009639 號函

主旨：所詢私人診所可否申請設立居家護理所乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 2 月 14 日(89)衛三字第 890245 號函。
- 二、按護理機構設置標準第 10 條：醫療機構所設之居家護理、產後護理或護理之家部門，適用本標準之規定。
- 三、「私立診所」屬醫療機構，其附設居家護理所，依現行規定尚無不可。

89.4.11. 衛署醫字第 89005516 號函

主旨：居家護理所與安養護機構係屬不同性質機構，於安養機構內設居家護理機構，核有不宜，復請 查照。

說明：復貴局 89 年 1 月 14 日桃衛五字第 0133 號函。

89.5.22. 衛署醫字第 89025068 號函

主旨：所詢衛生所主任兼醫師懸缺，群體醫療業務停診，或由支援醫師協助之衛生所，可否申請衛生所附設居家護理所乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 5 月 4 日 89 雲衛五字第 8116 號函。
- 二、按護理機構設置標準第 10 條規定：醫療機構所設之居家護理、產後護理或護理之家部門，適用本標準之規定。查衛生所係屬醫療機構設置標準第 2 條所稱之一般診所，依規定可附設居家護理所，負責醫師出缺應不影響其申請。
- 三、查護理機構設置標準第 4 條規定：居家護理機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要

，至少每 2 個月由醫師再予診察 1 次。若衛生所負責醫師出缺，可考慮由契約醫院提供前述之醫療服務。

89.6.7. 衛署醫字第 89033826 號函

主旨：符合中醫醫院設置標準之中醫綜合醫院，得依護理機構設置標準第 10 條規定，申請設置產後護理、護理之家服務部門。

說明：復 貴會 88 年 12 月 20 日衛中會醫字第 88012809 號函。

90.6.19. 衛署醫字第 0900035198 號函

主旨：所詢貴轄台中健康暨管理學院擬附設護理之家，可否以學校名義申請附設；另護理人員法第 17 條第 1 項第 3 款規定，私立護理機構，由個人設置者，以資深護理人員為申請人，由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人，所稱其他法人是否涵蓋私立學校乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 5 月 31 日 90 衛醫字第 24566 號函。
- 二、按私立學校法第 65 條第 1 項規定，私立學校為增進教學效果，並充實學校基金，得辦理與教學、實習、實驗、研究、推廣相關之附屬機構。但應先訂定章則報經主管教育行政機關及目的事業主管機關核准後，始得辦理……。故私立學校若設有醫護相關科、系、所，於取得主管教育行政機關之同意後，可依護理人員法相關規定，申請附設護理機構。

92.10.27. 衛署醫字第 0920054376 號函

主旨：所詢「財團法人伊甸社會福利基金會嘉義服務中心」是否符合護理人員第 17 條第 3 款規定設置居家護理所乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 10 月 3 日衛醫字第 0921030459 號函。

- 二、依據老人福利法第 18 條第 1 項及身心障礙者保護法第 40 條規定，地方政府、直轄市、縣(市)主管機應提供或結合民間資源提供下列居家服務：(1)居家護理。(2)居家照顧。……(8)其他相關之居家服務。故該基金會於取得主管社政行政機關之同意後，得依護理人員法第 17 條第 3 款規定申請附設居家護理機構。

94. 7. 29. 衛署醫字第 0940029419 號函

主旨：有關陳○○醫師申請百川醫院附設護理之家更名為金百川護理之家乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 7 月 5 日彰衛醫字第 0940017887 號函。
- 二、按醫療機構依護理機構設置標準規定申請附設護理機構，若該醫療機構辦理歇業，因涉屬申請主體變更，其所附設之護理機構，自亦應依規定辦理歇業。經查本案原係醫療機構附設護理機構，惟該醫療機構已於 92 年 12 月 23 日辦理歇業在案，其由原屬機構附設型態於同址重新申請為獨立型態護理機構，應屬護理機構之新設立，另按護理人員法第 17 條第 3 款及第 19 條第 2 項之規定，應由資深護理人員為申請人申請設立，至其護理機構申請程序請依護理人員法之相關規定辦理。

(註：本函釋當事人之名字以○○表示)

96. 1. 29. 衛署照字第 0962800019 號函

主旨：有關財團法人全成社會福利基金會向怡億公司承租之場所變更原規劃設立機構，改籌設為財團法人附設護理之家，所詢如何成立財團法人附設護理機構一節，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 95 年 8 月 22 日內授中社字第 0950012131 號函。
- 二、查護理人員法第 17 條第 3 款規定：「私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有

關法律規定附設者，以該法人為申請人。」

- 三、次查老人福利法第 18 條第 1 項及身心障礙者保護法第 40 條規定，直轄市、縣(市)主管機關應提供或結合民間資源提供下列居家服務：一、居家護理。二、居家照顧。三、……。八、其他相關之居家服務。爰此，該基金會於取得主管社政行政機關之同意後，得依護理人員法相關規定，申請附設居家護理機構。

96.11.2. 衛署醫字第 0960211476 號函

主旨：貴會函詢護理人員法第 17 條疑義一案。

說明：查護理人員法第 17 條第 3 款規定：「私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。」所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構。

98.5.25. 衛署醫字第 0980013839 號函

主旨：財團法人天下為公社會福利慈善基金會第 4 屆第 5 次董事會議決議擬於台北縣汐止市大同路 3 段 425 號 1、2 樓開辦護理之家一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 98 年 5 月 11 日內社中字第 090008337 號函。
- 二、按護理人員法第 16 條規定，護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可，其申請程序應依中央主管機關之規定。復按護理人員法第 17 條規定，由其他法人依有關法律規定附設之私立護理機構，其開業應以該法人為申請人，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照，始得為之。
- 三、另依同法施行細則第 6 條規定，護理機構設置或擴充後之規模如在 99 床以下者，由所在地直轄市或縣(市)主管機關

許可；100 床以上，或由醫療法人依醫療法規定附設者，則需由所在地直轄市或縣(市)主管機關核轉中央主管機關許可。

- 四、至申請許可設置或擴充護理機構，依同法施行細則第 5 條規定應檢具下列文件：(一)設立或擴充計畫書，包括護理機構名稱、建築地址、設置類別、設立床數、基地面積、建築面積、人員配置、設立進度、經費概算、擬定開業日期及其他依護理機構分類及設置標準規定應記載事項。(二)位置圖。(三)護理機構配置簡圖。(四)由其他法人依有關法律規定附設者，應檢附各該法人主管機關同意函件。

100.1.19. 衛署照字第 1002860257 號函

主旨：所詢財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院，可否申請附設「居家護理所」乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 99 年 10 月 26 花衛醫字第 0990019833 號函。
- 二、醫療法第 31 條第 3 項規定，醫療法人經中央主管機關及目的事業主管機關之許可，得附設下列機構：1. 護理機構、精神復健機構。2. 關於醫學研究之機構。3. 老人福利法等社會福利法規規定之相關福利機構。
- 三、護理人員法第 17 條規定，護理機構之開業，應依下列規定，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照：1. 公立護理機構：由其代表人為申請人。2. 財團法人護理機構：由該法人為申請人。3. 私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。
- 四、查財團法人台灣基督教門諾會附設花蓮縣私立黎明教養院不符護理人員法第 17 條之規定，亦非醫療法人，依規定不得申請附設居家護理所。

100.2.21. 衛署照第 1002860481 號函

主旨：所詢老人福利機構於原址變更為護理之家，得否比照老人福利機構負責人變更之程序，收容對象不須淨空辦理乙案，復如說明二，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 99 年 12 月 30 日內授中社字第 0990071351 號函及 100 年 2 月 8 日內授中社字第 1000715587 號函。
- 二、護理機構之設置，依護理人員法第 16 條及同法施行細則第 6 條規定，應先經申請主管機關許可；另依護理人員法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，護理機構之開業應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。
- 三、綜上規定，本案老人福利機構擬於原址變更為護理之家，應符合前開規範，於申請許可及開業核准後，始能執行相關之業務。
- 四、本署目前已著手修訂相關法規，有關機構類型轉換之行政程序將朝更便民方式規劃。

100.3.14. 衛署照字第 1002860666 號函

主旨：所送財團法人高雄縣私立萃文書院社會福利慈善事業基金會申請籌設居家護理所乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據原高雄縣政府衛生局 99 年 12 月 7 日衛局醫字第 09900521560 號函辦理。
- 二、按護理人員法第 17 條規定，護理機構申請人，公立護理機構由其代表人為申請人；財團法人護理機構由該法人為申請人；私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人，由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。又前述財團法人護理機構係指財團法人捐助成立之護理機構；另私立護理機構中由其他法人依有關法律規定附設者，依據 96 年 11 月 2 日衛署醫字第 0960211476

號函解釋，略以所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構。

- 三、本申請案申請人均未符合護理人員法第 17 條申請人資格要件，爰不得申請附設居家護理所。

100.5.13. 衛署照字第 1002860998 號函

主旨：貴局函詢社團法人中華藥師山居士佛學會申請附居家護理所之疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 3 月 30 日及 4 月 29 日北衛心字第 1000041133 號及 1000053784 號函。
- 二、本案來函表示，旨揭法人之章程經本署 99 年 5 月 19 日衛署醫字第 0990204445 函同意增修第 5 條第 4 款為「設置長期照護機構、護理機構，以落實社會關懷」乙節，經查本署前開函對關於該社團法人章程內容變更部分，並未表示同意，先予敘明。
- 三、按護理人員法第 17 條規定，護理機構申請人，公立護理機構由其代表人為申請人；財團法人護理機構由該法人為申請人；私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人，由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。私立護理機構中由其他法人依有關法律規定附設者，係指財團法人以外之法人，如有法律規定作為依據，亦得附設護理機構之意，另 96 年 11 月 2 日衛署醫字第 0960211476 號函解釋，略以所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構。爰上述函釋之農會、漁會、工會、私立學校，僅為例示，並非限縮於該等法人始得附設，與貴局所述之「法律保留原則」不相違背。
- 四、次查農會法、漁會法、工會法等法律規定，渠等法規在其

法人之任務上，均有明確授權得辦理醫療衛生事業；又私立學校法第 50 條規定略以：「學校法人所設私立學校為增進教學效果，…得設立與教學、實習、實驗、研究、推廣相關之附屬機構。」。

- 五、另民法第 26 條規定：「法人於法令限制內，有受權利、負擔義務之能力」，故知法人與自然人原則上雖有同等享受權利、負擔義務之能力，但當然亦得以法令加以限制。護理人員法第 17 條第 3 款對於財團法人以外法人申請設置護理機構所為限制，係法律所明定，完全符合上述民法規定。

101.9.5. 衛署照字第 1012863580 號函

主旨：有關貴事務所為護理機構之開業，適用法條之相關疑義申請函釋乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴事務所 101 年 7 月 31 日 101 敦黃律字第 0732 號函。
- 二、所詢護理人員法第 17 條第 1 項第 3 款之「私立護理機構」規定，適用上之疑義說明如下：

(一)依護理人員法 17 條第 1 項第 3 款規定，私立護理機構得有其他法人依規定附設者：

1. 依據本署 96 年 11 月 2 日衛署醫字第 0960211476 號函解釋，略以所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構。
2. 次查農會法、漁會法、工會法等法律規定，渠等法規在其法人之任務上，均有明確授權得辦理醫療衛生事業；又私立學校法第 50 條規定略以：「學校法人所設私立學校為增進教學效果，…得設立與教學、實習、實驗、研究、推廣相關之附屬機構。」。
3. 故私立護理機構中由其他法人依有關法律規定附設

者，係指財團法人以外之法人，如有法律規定作為依據，亦得附設護理機構之意。

4. 綜上，依據公司法成立之有限公司、股份有限公司之法人，非屬上項法規在其法人之任務上，有明確授權得辦理醫療衛生事業者之範圍。

(二)至於依據公司法成立之有限公司、股份有限公司之法人，可否投資醫療法人成為股東乙節，依據醫療法第 49 條規定，法人不得為醫療社團法人之社員，爰此，公司不得為醫療社團法人之社員。

101.12.3. 衛署照字第 1012864535 號函

主旨：有關貴局所詢護理之家擬於該護理機構以外地點申請設置「日間照顧」據點，以推展業務之疑義，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 10 月 22 日屏衛醫字第 1010030467 號函。
- 二、依據護理機構分類設置標準第 8 條附表規定，一般護理之家設有日間照護者，護理人員配置按登記提供服務量，每登記提供二十人之服務量，應增置一人；病房視需要設置休息床位；總樓地板面積按登記提供服務量計，平均每人應有十平方公尺以上（不包括車庫及宿舍面積）。
- 三、爰此，非護理之家機構所在地不得另設「日間照護」據點，若欲至護理機構以外地點設置「日間照護」，應另案申請護理機構設置。

102.8.12. 衛部照字第 1021580183 號函

主旨：所詢私立醫療機構附設護理機構負責人為私立醫療機構所聘任，可否逕自辦理機構歇業乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 7 月 25 日彰衛長字第 1020023922 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條第 3 款規定：「私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人，由其他法人依有

關法律規定附設者，以該法人為申請人」。同法第 19 條規定略以：「護理機構應置負責資深護理人員一人，…。私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。」。

- 三、爰私立醫療機構附設護理機構如係由資深護理人員申請並擔任負責人，如該負責人申請辦理歇業，自亦應依護理人員法相關規定辦理。

102.10.18 衛部照字第 1020167621 號函

主旨：所詢有關護理機構之醫療財團法人醫院所附設之一般護理之家其所投保之公共意外責任險，得否同醫院共同投保疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 10 月 9 日新縣衛醫字第 1020023922 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條規定，略以：「護理機構之開業，應依左列規定，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照：...三、私立護理機構：...由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。」又，護理人員法施行細則第 7 條規定，略以：「護理機構依本法第十七條規定申請開業，應填具申請書，檢附下列書件...：一、護理機構平面簡圖，並以平方公尺註明樓層、各隔間面積、用途說明及總面積。」爰醫療財團法人醫院附設一般護理之家之設立，係由該法人擔任申請人設立，其設立計畫書亦包含護理之家營業範圍。
- 三、查公共意外責任保險承保的範圍，係指「公共意外責任保險承保被保險人因下列意外事故所致第三人體傷、死亡或第三人財物損害，依法應負賠償責任，而受賠償請求時，由保險公司負賠償之責：被保險人或其受僱人因經營業務之行為在本保險單載明之營業處所內發生之意外事故。被保險人營業處所之建築物、通道、機器或其他工作物所發生之意外事故。」故公共意外責任保險旨在針對承保「營

業處所內」發生之意外事故。

- 四、綜上，醫療財團法人醫院附設一般護理之家其所投保之公共意外責任險，被保險人之營業範圍應包含護理之家，意即該機構所經營業務之行為，係屬保險單載明之營業處所內，以確保機構內之人員安全。本案請依此原則辦理。

104.1.22 衛部照字第 1041560124 號函

主旨：所詢因應少子化、社會大眾未來對護理之家之需求日殷，若欲新設或成立分支機構，則負責人之資格如何界定一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴護理之家 104 年 1 月 12 日高雄市瑞豐字第 144 號函。
- 二、依據護理人員法第 19 條規定：「護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，……。私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。」負責人相關資格應符合民法施行細則第 11 條之規定。另護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同」。
- 三、具有機構負責人資格之護理人員加入保險(勞保)之義務，仍應依相關保險法之規定辦理；且為保障工作人員勞動權益，一般護理之家評鑑指標將「業務負責人設置情形(A 2.1)」為一級必要項目指標，其基準包含：1. 資格符合相關法規標準規定。2. 專任且於機構投保勞健保、提撥勞退休金。3. 實際參與行政與照護品質管理等項目，仍請參酌。
- 四、護理機構設置之申請，按護理人員法第 17 條規定，私立護理機構申請人包含個人及法人等，故(股份)有限公司未符前開申請人資格。又對機構之營運方式，係於機構提出申請計畫時即審核其經費(如自籌、補助或募款)，以評估

機構是否有完善之財務計畫，確保照護品質。

- 五、私人機構如更換負責人，無論獨資、合夥或公司聘任，隔年是否需接受評鑑乙節：護理機構之設置或擴充許可後，私人機構如更換負責人，按規定應重新提出申請(即視為新機構)，爰該機構亦應重新接受評鑑。

104.12.1 衛部照字第 1041562417 號

主旨：所詢○○診所附設護理之家申請變更名稱為○○護理之家疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 11 月 13 日北市衛醫護字第 1044066410 號函。
- 二、依貴局來函所述，本案原係診所附設護理之家，惟該診所於 104 年 9 月 23 日辦理歇業在案，其權屬別由私立醫療機構附設護理機構變更為私立護理機構，惟護理機構申請人及負責人皆未變動，該機構是否需參加 105 年度一般護理之家評鑑。
- 三、依護理機構評鑑辦法第三條第二項第四款及第三項規定，私立護理機構歇業後，由他人於原址重新申准設立及取得開業執照，應參加當年度的評鑑，倘已逾當年五月三十一日者，應於次年接受評鑑。查○○診所附設護理之家於本年度參加一般護理之家評鑑，雖該機構由私立醫療機構附設護理機構變更為私立護理機構，且申請變更機構名稱，惟其申請人及負責人皆未變更，爰此，該機構非屬前開規定之評鑑對象。

(註：本函釋診所、護理之家以○○表示)

105.7.28 衛部照字第 1051563418 號

主旨：所詢護理機構設置或擴充規範疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年7月13日桃衛照字第1050056480號函。
- 二、查護理人員法第17條第3款規定：「私立護理機構：由個規定附設者，以該法人為申請人。」又護理機構設置或擴充許可辦法第3條之規定，係就機構設置或擴充申請案主管機關之審查分工權責，予以明定，先予敘明。
- 三、所詢貴轄某護理之家申請設置，於原有醫院及醫院附設護理之家同址之建物，可否由同醫療體系經營團隊另申請新設立護理機構乙節，應先請釐清該新設立護理機構之申請人，與原醫院或附設之護理之家是否屬同一人（包括法人及自然人），並依上開規定辦理。又，長期照顧服務法將於106年6月施行，該法第22條第1項規定住宿式服務長照機構應以法人型態設立，其立法意旨除維護護理機構穩定經營機制之外，並提升機構住宿式服務長照機構主體之健全性。
- 四、本案護理機構之申設，其申請床數之規模及申請人條件，請貴局依護理人員法相關規定逕依權責及事實認定辦理。

105.10.3 衛部照字第 1050128863 號

主旨：所詢貴轄○○○大學附設醫院或○○○大學得否申請設立護理之家一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年9月21日屏衛醫字第10532707400號函。
- 二、查護理人員法第17條第3款規定略以，護理機構之開業，應依左列規定，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照：私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。又，前開所稱「其他法人」，係指農會、漁會、工會、私立學校等法人。該法人得依農會法、漁會法、工會法、私立學校法等法律規定，申請附設護理機構，前經本部於96年11月2日衛署醫字第0960211476號函釋在案，先予敘明。

三、綜上，○○○大學附設醫院（以資深護理人員為申請人）或○○○大學（以學校法人為申請人）得依上開規定申請設立護理之家。

（註：本函釋醫院、大學以○○○表示）

〔釋例類別〕 第 3 類 負責人變更，重新申請設立規定

89. 3. 1. 衛署醫字第 89009217 號函

主旨：有關合法立案獨立型態護理之家，欲變更負責人其行政手續為何乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 88 年 2 月 17 日 89 南市衛醫字第 02692 號函。
- 二、按護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，係以資深護理人員為申請人申請設立，其申請主體變更，即屬護理機構之新設立。因此由資深護理人員設立之護理機構，於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，註銷原領開業執照及所屬醫事人員執業執照。新任負責護理人員應符合法定資格，其人員及設施，並經審查及重新履勘符合護理機構設置標準，始得核准開業，重新核發開業執照及所屬醫事人員執照。
- 三、惟為簡化程序以資便民，由護理人員設立之私立護理機構，於同址由另位護理人員重新申請設立時（即變更負責人），得從寬免依護理人員法施行細則第 7 條規定踐行衛生主管機關許可之程序，且硬體部分得免再重新履勘，但其人員仍應符合設置標準規定，始得重新發給開業執照。

90. 3. 28. 衛署醫字第 0900010373 號函

主旨：所詢醫療機構變更負責人時，其所附設之護理機構是否需重新申請開業乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 2 月 12 日北衛保字第 09331 號函。

- 二、有關醫療機構變更負責醫師，若為公立或財團法人醫療機構負責醫師變更，依醫療法第 13 條規定，屬登記事項變更；至於私立醫療機構由醫師設立者，其負責醫師變更，涉屬設立權屬變更，依醫療法第 13 條及第 24 條規定，應重新申請開業，其附設之護理機構，自亦應依規定重行申請附設開業。

100.8.5. 衛署醫字第 1002862085 號函

主旨：所詢轄內合法立案之護理之家，欲申請變更負責人之行政程序疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 8 月 1 日屏衛醫字第 1000024337 號函。
- 二、查護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，係以資深護理人員為申請人申請設立，同法施行細則第 5 條規定，護理機構之設置或擴充經許可後，其申請人、設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可。又本署 97 年 4 月 1 日衛署醫字第 0990201290 號函解釋，私立護理機構之負責護理人員變更，即為申請主體變更，因涉屬設立權屬變更，係屬護理機構之新設立，應重新申請開業。
- 三、依護理人員法施行細則第 7 條規定，護理機構向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請開業，前述機關對於其申請，經派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。至該護理機構之建築使用執照是否符合規定，建請洽詢地方建管單位釋疑。

(註：本函釋說明二所敘本署 97.4.1. 衛署醫字第 0970201290 號函，請參閱 P.209)

102.1.23. 衛署照字第 1022860185 號函

主旨：有關貴轄某護理之家申請變更負責人，惟該護理之家尚有刑事附帶民事案件，是否准予變更疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 1 月 4 日彰衛醫字第 1010038690 號函。
- 二、依據護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定，護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。
- 三、另依貴局所提供該機構負責人被告業務過失傷害之案件，經臺灣彰化地方法院檢察署判定不起訴處分，原告家屬復向臺灣高等法院台中分院聲請再議，業經該院駁回再議；另原告向臺灣彰化地方法院刑事附帶民事訴訟為原告之訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回，復向臺灣高等法院台中分院刑事附帶民事聲明上訴，業經貴局於 101 年 12 月 26 日系統查詢結果為上訴駁回。
- 四、爰此，該機構申請變更負責人，應依護理人員法第 16 條第 1 項及其施行細則第 5 條第 1 項及護理機構設置或擴充許可辦法第 5 條規定檢具相關文件，重新申請許可。

102.1.23. 衛署照字第 1022860183 號函

主旨：所詢私立護理之家申請變更負責人是否需審查護理機構設址之土地及建物之相關權利證明乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 1 月 9 日桃衛照字第 1021400901 號函。
- 二、依據本署 101 年 12 月 19 日公告實施之護理機構設置或擴充可辦法第 7 條規定，護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。
- 三、惟為簡化程序以資便民，得依據本署 89 年 3 月 1 日衛署醫字第 89009217 號函釋辦理。

102.3.13. 衛署照字第 1022860678 號函

主旨：有關 貴府所詢轄內某醫院附設護理之家欲申請辦理歇業

，同址由其他資深護理人員申請設立乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴府 102 年 1 月 14 日府衛醫字第 1020000564 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人申請設立，其申請主體變更，即屬護理機構之新設立。因此由資深護理人員設立之護理機構，於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，新任負責護理人員及其人員及設施應符合相關法規規定，始得核准開業。次查，依據護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」先予敘明。
- 三、承上，有關旨案之護理之家歇業及申請新設立，應先符合上開規定辦理，惟是否符合簡化程序其硬體部分得免再重新履勘，請參酌本署 89 年 3 月 1 日衛署醫字第 89009217 號函釋，視個案實際條件認定。
- 四、另對於機構使用執照使用用途是否應依「建築物使用類組使用項目表」辦理變更乙節，因非本署權管業務，建請 貴府逕依所管規定辦理。

102.5.21. 衛署照字第 1022863296 號函

主旨：有關 貴局所詢轄內某私立護理之家於短期內多次(1 年內 2 次)申請變更負責人一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 3 月 26 日桃衛照字第 1021400941 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人申請設立，其申請主體變更，即屬護理機構之新設立。因此由資深護理人員設立之護理機構，於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，新任負責護理人員及其人員及

設施應符合相關法規規定，始得核准開業。

- 三、次查，依據護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」先予敘明。
- 四、承上，有關旨案護理之家於短期內多次申請變更負責人，得逕依本署 89 年 3 月 1 日衛署醫字第 89009217 號函釋認定，其硬體部分得免再重新履勘，惟硬體應符合建築及消防安全相關法規，以維公安及住民安全。

102.9.17. 衛署照字第 1020164786 號函

主旨：所詢轄內某私立護理之家於新設核發開業執照或擴充換發開業執照後，立即申請變更負責人一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 9 月 6 日桃衛照字第 102184007 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人申請設立，其申請主體變更，即屬護理機構之新設立。因此由資深護理人員設立之護理機構，於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，新任負責護理人員及其人員及設施應符合相關法規規定，始得核准開業。
- 三、次查，依據護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」先予敘明。
- 四、承上，有關旨案護理之家於申請新設立或擴充案，核准取得開業執照後申請變更負責人，逕依上開相關規定辦理。

103.3.18 衛部照字第 1031560405 號函

主旨：所詢有關貴轄名家護理之家因土地暨建物經法院拍賣，產權已轉移，可否辦理負責人變更，如無法變更擬重新申請

籌設許可，是否適用農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點一案，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 3 月 6 日彰衛長字第 1030006204 號函。
- 二、依據護理人員法施行細則第 4 條第 2 項規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其申請人、設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可。」次依護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」前開法規係明訂機構經許可設立後，如欲變更負責人，應由機構提出申請，惟對於其變更負責人原因（例如因土地所有權轉移是否應辦理負責人變更），非屬本法規範內容，先多敘明。
- 三、又按農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 6 點第 1 項規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」查前開所稱公益性福利設施，應視申請計畫內容進行專案審查後始得認定。

105.4.26 衛部照字第 1050110796 號

主旨：所詢投資股份有限公司擬申請設立「產後護理機構」並擔任該機構出資人一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 4 月 15 日北市衛醫護字第 10534122800 號函。
- 二、按護理人員法第 17 條規定，私立護理機構，由個人設置者，以資深護理人員為申請人；又按護理人員法第 19 條規定，護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，私立護理機構由前項資深護理人員設

置者，以其申請人為負責人。同法施行細則第 11 條並規定，護理機構負責資深護理人員之資格條件，應具備從事臨床護理工作年資 7 年以上，或以護理師資格登記執業從事臨床護理工作年資 4 年以上。

- 三、有關護理機構之申請人及負責資深護理人員之資格，應依前述規定辦理；至於投資股份有限公司擬擔任機構出資人乙節，係屬民事法律關係，惟為確保母嬰照護品質及員工權益，機構應具備營運管理能力、資金穩定並有完善之財務計畫。

106.10.23 衛部照字第 1061562911 號

主旨：有關私立產後護理機構變更負責人疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 10 月 13 日中市衛醫字第 1060096822 號函。

- 二、依據護理人員法第 19 條規定：「護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，…。私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。」負責人相關資格應符合同法施行細則第 11 條之規定。另護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同。」。

- 三、護理機構設置之申請，按護理人員法第 17 條規定，私立護理機構申請人包含個人及法人等，股東之間合夥關係未符前開申請人資格。另，以個人名義設置之私立護理機構，該資深護理人員與股東間成立合夥關係一節，係為雙方私法契約的約定，非屬護理人員法之規定範疇。

- 四、綜上，由資深護理人員設立之私立護理機構，當機構申請主體變更（變更負責人），於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，註銷原領開

業執照及所屬醫事人員執業執照。旨案請本權責辦理。

104.6.25 衛部照字第 1041561168 號函

主旨：所詢非財團法人護理機構之負責人變更，該機構之適法性疑義案，本部回復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴部 104 年 6 月 15 日勞動福 3 字第 10401359452 號函。
- 二、依據護理人員法第 17 條第 3 款規定，私立護理機構由個人設置者，以資深護理人員為申請人；同法第 19 條第 2 項規定，私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。次依護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同」。
- 三、承上，私立護理機構係以其負責人(資深護理人員)申請設立，因此依護理人員法相關規定，其負責人變更，即屬護理機構之新設立，應依護理人員法有關護理機構設立及開業之規定辦理。除由原任負責護理人員申請歇業之外，若係於原址由另位護理人員重新申請設立時(即變更負責人)，機構之醫療照護設施、照顧人員不變，僅變更機構負責人，為兼顧實情，得從寬免依護理人員法施行細則第 7 條規定踐行衛生主管機關許可之程序，且硬體部分得免再重新履勘，請參酌本部 89 年 3 月 1 日衛署醫字第 89009217 號函釋(如附件)。
- 四、至上開說明是否認屬勞工退休金專戶之轉讓等之規定，係屬勞動機關之權責，逕予認定。

(註：本函釋說明三所敘本部 89.3.1. 衛署醫字第 89009217 號函，請參閱 P.182)

〔釋例類別〕 第 4 類 護理機構建築物使用

83.5.3. 衛署醫字第 83019754 號函

主旨：護理機構建築物之用途，並無規定須何種特定用途，惟其建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定，復請 查照。

說明：復 貴處 83 年 4 月 6 日 83 衛五字第 030734 號函。

83.6.17. 衛署醫字第 83035206 號函

主旨：醫療機構所設護理之家或產後護理服務部門，其總樓地板面積應與醫療機構分別計算，且應符合護理機構設置標準規定，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

86.1.6. 衛署醫字第 85071427 號書函

一、復 貴會 85 年 9 月 17 日(85)長期阮字第 156 號函。

二、依內政部 85 年 12 月 19 日台(85)內營建字第 8582274 號函（影本如附件），略以：護理之家如屬供特定性短期性住宿之場所且無提供醫療行為者，歸屬「建築法第 73 條執行要點」所定使用分類之 H-1 組。即護理之家之建築物使用強度及危險指標，比照養老院、安養(收容)中心等機構標準審查。

三、復請 查照。

86.4.15. 衛署醫字第 86010960 號函

主旨：實施區域計畫地區新建用途為護理之家機構申請建築執照，有關用途建請列屬供公眾使用建築物之範圍，復請 查照。

說明：復 貴部 86 年 2 月 22 日台(86)內營字第 8601588 號函。

87.1.16. 衛署醫字第 87000482 號函

主旨：所詢醫院附設護理之家不得與醫院樓層交叉使用疑義乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴院 86 年 12 月 31 日楊醫字第 861231 號函。

二、查「醫療機構附設產後護理及護理之家服務部門若未分幢、分棟設置者，其與急性病房及慢性病房之病房區，應獨立設置，且不得以交叉樓層設置」，前經本署 84 年 12 月 4 日衛署醫字第 84070908 號函釋在案。所稱「不得以交叉樓層設置」，係指產後護理或護理之家服務部門床位使用數樓層者，各樓層應為連續使用，且不得在連續使用之樓層內設置急性或慢性病床。是以貴院擬將護理之家服務部門設於 7 樓，若未涉及交叉樓層使用，於法尚無不合。

（註：本函釋說明二所敘本署 84.12.4. 衛署醫字第 84070908 號函，業經 88.8.16. 衛署醫字第 88044734 號函停止適用，請參閱 P.191）

88.7.15. 衛署醫字第 88043333 號函

主旨：貴轄財團法人馬偕紀念醫院淡水分院附設護理之家，既經貴局會勘相關單位，均符合設置標準規定，且經工務局核予合法房屋之證明，請逕依護理人員法施行細則第 11 條第 2 項核定辦理，請 查照。

說明：復 貴局 88 年 7 月 1 日 88 北衛五字第 38845 號函。

88.8.16. 衛署醫字第 88044734 號函

主旨：所詢醫院附設護理之家其院舍使用疑義乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 88 年 7 月 7 日 88 花衛五字第 7000 號函。

二、按原護理機構設置標準第 13 條：「醫療機構所設之產後護理或護理之家服務部門，其房舍應與醫療機構之房舍分別獨立設置。但本標準發布施行前，已設置並經中央主管機關核備者，不在此限」之規定，業於 87 年 6 月 17 日修正刪除。因此，本署 84 年 12 月 4 日衛署醫字第 84070908 號函規定：「醫療機構附設產後護理及護理之家服務部門

若未分幢、分棟設置者，其與急性病房及慢性病房之病房區，應獨立設置，且不得以交叉樓層設置」，亦應停止適用。

- 三、本署花蓮醫院擬於不同棟大樓之三、四、五樓擴充設置護理之家，如符護理機構設置標準規定，應無不可。

88.8.27. 衛署醫字第 88055989 號函

主旨：有關護理之家設立除依護理機構設置標準規定外，對於醫療廢棄物是否有相關之法令規定乙案，復請 查照。

說明：

- 一、依據台灣省政府衛生處 88 年 5 月 20 日 88 衛五字第 0022970 號函核轉貴局 88 年 5 月 13 日 88 北衛五字第 28028 號函辦理。
- 二、按廢棄物清理法台灣省施行細則第 19 條規定：事業機關係指農工礦場、公司行號、醫療院所及中央主管機關指定之事業。護理機構非屬上述所稱事業機關，惟其產生之廢棄物，宜參照醫療院所產生之廢棄物處理方式，輔導其妥適處理。

94.8.12. 衛署醫字第 0940032352 號書函

主旨：有關 貴局函詢所轄已取得開業執照之醫院附設護理之家，是否得依建築法第 73 條執行要點所定變更使用分類之 H-1 組用途疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 7 月 21 日苗衛醫字第 0940300969 號函。
- 二、按護理之家如屬供特定人短期住宿之場所且無提供醫療行為者，「建築物使用類組及變更使用辦法」第 2 條規定，歸屬所定使用分類附表之 H-1 組。另依該辦法同條第 3 項規定，原核發之使用執照未登載使用類組者，該管主管建築機關應於建築物申請變更使用執照時，依前二項規定確認其類別、組別，加註於使用執照或核發確認使用類組之

文件。

- 三、至申請設置護理機構者，有關護理機構建築物之用途，查護理人員法及其相關法規並無明文規定，故其建築物使用執照是否為護理之家用途始得核准開業一節，本署認為不宜硬性規定，惟「建築物非經領得使用執照，不得接水、接電及使用。」為建築法第 73 條第 1 項所規定，是以，新設立之護理機構或護理機構涉有建築物新建擴充者，報經衛生主管機關許可後，應向建築主管機關申領建築物使用執照，始予核准開業。
- 四、另查醫院建築物之使用強度及危險指標分類之相關規定較護理機構建築物更為嚴謹。爰此，醫院調整內部設施，將部分空間改為附設護理之家及獨立設置且已取得開業執照之護理之家，其建築物用途得否依建築法相關規定全面辦理變更，係屬建築主管機關權責。

94.8.29. 衛署醫字第 0940036454 號函

主旨：有關護理機構建築物使用類組，依照「建築物使用類組及變更使用辦法」第 2 條第 2 項所附建築物使用類組使用項目表規定，護理之家樓地板面積在 500 平方公尺以上，屬 F-1 組，至其樓地板面積未達 500 平方公尺者，始歸屬 H-1 組，請 查照。

說明：

- 一、依據內政部營建署 94 年 8 月 19 日營署建管字第 0940043713 號函辦理。
- 二、本案前經本署 94 年 8 月 12 日衛署醫字第 0940032352 號書函諒達，惟前書函說明二有關護理機構建築物使用類別、組別及其定義、使用項目舉例，尚遺漏 F-1 組部分，爰應予補充。

95.3.30. 衛署醫字第 0950011024 號函

主旨：所詢醫療機構擬以原病房申請附設護理之家，其設置是否

需經工務、消防主管機關勘驗合格始予發照相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 3 月 15 日桃衛醫字第 0950003844 號函。
- 二、查為利於醫療機構及護理機構之管理，本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函釋略以：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。」是以，醫療機構擬以部分病房申請附設護理機構，係屬另一機構之新成立，非屬調整內部設施，因此，本署 88 年 5 月 17 日衛署醫字第 88023112 號函規定，亦不再適用。
- 三、「按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定；至其建築物之空調設備、消防設備、安全設備及一般設施等，應符合建築法及其有關法規規定，依建築及消防之規定辦理。」前經本署 94 年 8 月 9 日衛署醫字第 0940028242 號書函釋在案。另查醫院建築物之使用強度及危險指標分類之相關規定較護理機構建築物更為嚴謹，是以，醫院如已依規定定期接受消防及安全檢查，其將部分空間改為附設護理之家時，是否需再經工務、消防主管勘驗，依建築法之相關規定，係屬建築主管機關權責。

96.1.24. 衛署醫字第 0960002169 號函

主旨：所詢 貴轄護理機構開業場所疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 11 日北衛醫字第 0960002973 號函。
- 二、查護理機構之設立，應依護理人員法之規定申請許可，並符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許開業。至同一地址分別申請開設護理機構，為利護政管理，其執業場所使用空間應有明確區隔，並各有獨立動線，且符合護理

機構設置標準之相關規定，始予准許。本案請依此原則辦理。

- 三、至本署 95 年 12 月 20 日衛署醫字第 0950062381 號函略以：「……三、至助產機構與西藥房或醫療機構同址設立，除應依各該醫事法規規定辦理開執業外，並應有其獨立門戶，且使用空間明確區隔。」所謂獨立門戶係指執業場所與公共場所有明顯區隔、各有獨立動線之謂，併予敘明。

106.9.27 衛部照字第 1060128953 號

主旨：有關彰化縣轄某場所「開業執照」與「使用執照」所載用途不同，有無「違規使用場所」適用疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴署 106 年 9 月 21 日消署預字第 1061116963 號函。
- 二、「按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定；至其建築物之空調設備、消防設備、安全設備及一般設施等，應符合建築法及其有關法規規定，依建築及消防之規定辦理。」前經本部 94 年 8 月 9 日衛署醫字第 0940028242 號書函釋在案。
- 三、另查醫院建築物之使用強度及危險指標分類之相關規定較護理機構建築物更為嚴謹。爰此，醫院調整內部設施，將部分空間改為附設護理之家及獨立設置且已取得開業執照之護理之家，其建築物用途得否依建築法相關規定全面辦理變更，係屬建築主管機關權責。

98.1.13. 衛署醫字第 0980200102 號函

主旨：有關醫院設置登記樓層為 1 至 9 樓，欲申請於 6、7 及 9 樓部分空間附設護理機構乙案，復請 查照。

說明：依本署 88 年 8 月 16 日衛署醫字第 88044734 號函說明二「原護理機構設置標準第 13 條業於 87 年 6 月 17 日修正刪除。因此，本署 84 年 12 月 4 日衛署醫字第 84070908 號函

，…，亦應停止適用」之意旨，醫療機構之附設護理機構，如符合護理機構設置標準規定，且與醫院之急性病房及慢性病房之病房區，均分別獨立設置，亦即兩類機構之空間有明顯區隔且各均在符合其相關設置標準之原則下，應無不可。

98.4.21. 衛署照字第 0982860012 號函

主旨：有關臺北縣政府函詢老人長期照護機構(養護型)之建築物，其與相鄰建物護理之家是否得以常閉式鐵捲門區隔疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 98 年 3 月 31 日內授中社字第 0980005333 號函。
- 二、按護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可，並向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照，始得為之，於護理人員法第 16 條、第 17 條定有明文。又護理機構建築物之設計、構造與設備並應符合護理機構設置標準。即並應符合建築法及其有關規定。
- 三、復按護理機構與其他機構同址設立，應各有獨立門戶及動線，且使用空間應明確區隔，並應以不影響其照護作業及其住民使用之安全性與便利性為原則。
- 四、至護理機構與老人長期照顧機構(養護型)於建物相同樓層，其相鄰部分以常閉式防火鐵捲門區隔一節，查護理人員法及相關法規，尚無明定。

98.5.12. 衛署醫字第 0980013269 號函

主旨：有關內政部函示有關申請變更使用執照為老人長期照顧機構(養護型)之建築物，其與相鄰建築(護理之家)是否得以常閉式鐵捲門區隔疑義案，轉請 查照。

說明：依據內政部 98 年 5 月 1 日內授中社字第 0908715734 號函辦理(附原函影本一份)。

(原函：按建築技術規則設計施工編第 1 條第 24 款規定，分戶牆係分

隔住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁，另防火捲門及其附設寬度 75 公分以上、高度 180 公分以上之防火門係屬建築物之防火設備，同編第 75 條及第 76 條業有明定。惟本案究係為分戶牆或防火區劃之防火設備，涉關個案事實認定，請檢具具體資料逕向建築物所在地主管建築機關查詢。)

99.5.25. 衛署照字第 0992861376 號函

主旨：有關護理機構設置於不同棟建築物疑義一案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 99 年 5 月 14 日北衛心字第 0990058170 號函。
- 二、按護理機構之設立，應依護理人員法之規定申請許可，並符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許開業。有關不同大樓設置護理之家前經本署 96 年 10 月 29 日衛署醫字 09600429243 號及 88 年 8 月 16 日衛署醫字 88044734 號函釋，如符合護理機構設置標準規定，應無不可在案，先予敘明。
- 三、本案經貴府核准設立於同電梯 3 樓及 5 樓之護理之家，擬於相鄰棟之電梯大樓 4 樓擴充床位數案，因本案係屬同一宗土地面積，如符合護理機構設置標準之相關規定，得予准許。另應請落實照顧人力，每棟建築物 3 班均應有護理人員之原則辦理。

100.8.12. 衛署照字第 1000074942 號函

主旨：所詢轄內護理機構擴充床位申請開業，建築物用途是否須辦理用途變更案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 8 月 8 日嘉衛保字第 1000018949 號函。
- 二、護理機構之開業，依據護理人員法第 17 條及同法施行細則第 7 條規定，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請

核准登記，並由直轄市或縣(市)主管機關派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。至該護理機構之建築使用執照是否符合規定，建請依地方建築、消防等主管相關機關意見辦理。

101.11.22. 衛署照字第 1012864415 號函

主旨：有關 貴局函詢黃○○君設立馨禾護理之家疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 11 月 5 日桃衛照字第 1010185235 號函。
- 二、依本署 98 年 4 月 21 日衛署照字第 0982860012 號函略以：護理機構建築物之設計、構造與設備並應符合護理機構設置標準。即並應符合建築法及其有關規定，…應各有獨立門戶及動線，且使用空間應明確區隔，並應以不影響其照護作業及其住民使用之安全性與便利性為原則。
- 三、對於御禾園護理之家及馨禾護理之家建築物本體外圍之花園及圍牆大門等共同空間，請確認 2 家護理之家申請設置時是否均已納入機構申請設置許可之範圍。
- 四、綜上，請貴局依上開原則本權責辦理。

(註：1. 本函釋當事人之名字以○○表示

2. 本函釋說明二所敘本署 98.4.21. 衛署照字第 0982860012 號函，請參閱 P.196)

102.2.27 衛部照字第 1022860456 號函

主旨：有關產後護理之家設置，其使用樓層與旅館共用，非獨立空間是否可准予設置乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 12 月 19 日衛醫字第 1010020869 號函。
- 二、依據「建築物使用類組及變更使用辦法」，產後護理機構設置，應符合建築物使用執照之類組為 F-1(供醫療照護之場所組別)之規定，始可設置。

- 三、產後護理之家設置之樓層與旅館共用，其應有明顯之區隔，並設有獨立出入口，以利動線獨立及管控人員，減少感染風險。
- 四、另本案事涉建管及消防等相關單位，應請各單位針對設置或擴充變更內容表示意見，並檢附貴轄相關單位之審查同意函文等資料。

102.7.2. 衛署醫字第 1020200305 號函

主旨：所詢有關貴轄西園醫院永越大樓 6 樓申請設立私立護理機構，其服務設施使用區域區隔及出入口疑義一案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 6 月 19 日北市衛醫護字第 10233913300 號函。
- 二、查本署 98 年 1 月 13 日衛署醫字第 0980200102 號函略以，「醫療機構之附設護理機構，如符合護理機構設置標準規定，且與醫院之急性病房及慢性病房之病房區隔，均分別獨立設置，亦即兩類機構之空間有明顯區隔且各均在符合其相關設置標準之原則下，應無不可。」，另為符合上開原則，及不影響醫療作業，該二類機構應具獨立出入口。
- 三、至來函說明二引用「醫療機構設置標準」第 3 條附表(一)綜合醫院、醫院設置標準表之五、「建築物之設計、構造與設備」之(二)「一般設施」之第 13 點規定，係針對同一基地設立二個醫療機構之規定，與旨揭醫療機構與護理機構同址設置不同，併予敘明。

102.6.14. 衛署照字第 1022863047 號函

主旨：有關護理人員法第 21 條收費標準及護理機構同址是否可從事其他營業項目之疑義，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 3 月 18 日北市衛醫護字第 10231275002 號函。
- 二、有關貴局所詢護理機構開業後因應物價等因素自行調整收費標準，未超過貴局收費基準上限規定，未經核備乙節，尚難認屬違反護理人員法第 21 條之規定；至於護理機構收費標準如係由機構報請縣市衛生局核定者，該機構後續調整收費標準仍應依護理人員法第 21 條規定辦理。
- 三、另詢護理機構申請設置或擴充時發現同址已有其他營業項目（包括商業登記為坐月子食品公司、或向衛生局登記販賣醫療器材等）乙節，說明如下：
 - （一）查護理機構為醫事人員之執業場所，以提供辦理執業登記在案之醫事服務項目為限。又護理機構非屬營利事業，應避免醫療行為與商業行為混淆而影響醫療作業。
 - （二）又，設立坐月子食品公司係屬商業行為，宜請住民於符合相關規定之營業場所購買服務；又，前述食品公司之經營行為應屬商業營利性質，就營運主體而言，其設立登記應依公司法、商業登記等規定辦理，以資適法。故護理機構內附設商業性質之坐月子食品公司，應不予同意；至護理機構如與坐月子食品公司同址設置，其執業場所有實體區隔、二處內部無法相通，且分別有對外出口，得視同不在同一地址。
 - （三）另有關護理機構販賣醫療器材，如僅對護理機構之病患或其家屬提供必要之服務，經當地縣市衛生主管機關實地履勘屬實，在不影響護理照護服務品質下，尚無不可。惟其如將藥局、藥商登記於護理機構地址內，並以對外從事醫療器材推銷、銷售為主要業務，則非所宜。
 - （四）綜上，除上述所述機構外，護理機構營運範圍應符合護理機構申請設置或擴充之計畫書核准事項為準。

102.8.12. 衛署照字第 1021580174 號函

主旨：所詢護理人員法第 21 條收費標準及居家護理機構同址是否可從事其他營業項目之疑義，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 7 月 29 日北市衛醫護字第 10236099601 號函。
- 二、旨案有關護理機構(含居家護理機構)同址如有其他公司設立之認定，以及提供居家護理服務時，依個案需求提供租借或販售醫療器材服務乙節，本部前於 102 年 6 月 14 日以衛署照字第 1022863047 號函諒達，合先敘明。
- 三、至居家護理所除使用健保支付標準外，另採專案服務方式收費乙節，依據護理人員法規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。…。護理機構不得違反收費標準，超額收費。」爰居家護理之收費標準審定，係屬地方衛生主管機關權責，故由貴局逕予審核。

102.11.5 衛部照字第 1021580888 號函

主旨：所詢有關同一建築物內得否分別設立老人福利機構及一般護理之家案，復請查照。

說明：

- 一、依據苗栗縣政府長期照護管理 102 年 9 月 24 日苗照管字第 1020004720 號函辦理。
- 二、旨案有關同一棟建築物之不同樓層分設老人福利機構及一般護理之家，應符合下列條件：
 - (一) 門牌號碼需不同。(應辦理分戶)
 - (二) 應有獨立出入口。有關「獨立出入口」請依下列原則予以認定：
 1. 不具共同出入口者，則機構應設有可直接通達地面之專用電梯間或樓梯。
 2. 具有共同出入口者，則電梯或樓梯不可相通直接進入各樓層內部，例如 1 樓至 2 樓，電梯與樓梯須在機構外。

(三) 使用空間須獨立、完整區隔。

(四) 老人福利機構及護理機構皆應符合其相關法規。

1. 老人福利機構須符合老人長期照護機構設立標準及許可辦法或老人福利機構設立標準之規定。

2. 護理機構須符合護理機構設置標準及許可辦法、護理人員法等之規定。

(五) 工作人員、環境設施設備、經營組織及管理獨立，不與他機構共用。

三、本案因涉事實之認定，宜秉上開認定原則本權責審酌辦理。

105.11.21 衛部照字第1051564292號函

主旨：所詢有關護理機構出入口規範疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局105年10月11日桃衛照字第1050079027號函。

二、按護理機構之設置或擴充，應先經申請主管機關許可，並向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照，始得為之，於護理人員法第16條、第17條定有明文。又護理機構建築物之設計、構造與設備並應符合護理機構設置標準。即並應符合建築法及其有關規定。

三、有關於同址設立兩家機構應各有獨立門戶及動線，且使用空間應明確區隔，並應以不影響其照護作業及其住民使用之安全性與便利性為原則，前經本部於98年4月21日衛署照字第0982860012號函、102年11月5日衛署照字第1021580888號函及103年12月24日衛署照字第1031562533號函釋在案，併予敘明。爰本案請依此認定原則辦理。

103.5.6 衛部照字第1030112466號函

主旨：有關一般護理之家申請擴充至不連續樓層及照護人力配置疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 4 月 29 日北衛醫字第 1030775515 號函。
- 二、按護理機構之設立，應依護理人員法之規定申請許可，並符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許開業。有關一般護理之家設置於不連續樓層前經本部 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函及 89 年 10 月 4 日衛署醫字第 0890017043 號函釋，如符合護理機構設置標準規定，應無不可在案，先予敘明。
- 三、次按護理機構設置標準表之二、護理服務設施(一)住房項下規定應設護理站及其相關設施、設備，有關同一護理機構跨數樓層，每一樓層是否應依護理機構設置標準配置人力及設置護理站，亦經本部 97 年 3 月 5 日衛署醫字第 0970006126 號函釋，跨數樓層之護理機構，如相鄰樓層共用護理站，在不影響護理業務執行及能為護理機構住民及民眾方便利用下，尚無不可。爰本案請依權責，視個案事實認定。

(註：本函釋說明二所敘本部 96.10.29.衛署醫字第 0960049243 號函及 89.10.4.衛署醫字第 0890017043 號函，請參閱 P.428、P.425。說明三所敘本部 97.3.5 衛署醫字第 0970006126 號函，請參閱 P.429)

103.10.14 衛部照字第 1031561690 號函

主旨：所詢有關一般護理之家相關疑義案，如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據內政部營建署 103 年 9 月 12 日營授辦城字第 1033580690 號函及行政院農業委員會 103 年 9 月 9 日農企字第 1030230729 號函兼復貴中心 103 年 8 月 22 日苗照管字第 1030007304 號函。
- 二、有關護理之家是否符合都市計畫法臺灣省施行細則所稱『公益上需要』乙節：依據都市計畫法臺灣省施行細則第 23 條規定：「行政區以供政府機關、自治團體、人民團體及

其他公益上需要之建築物使用為主，不得建築住宅、商店、旅社、工廠及其他娛樂用建築物。但紀念性之建築物與附屬於建築物之車庫及非營業性之招待所，不在此限。」次依內政部營建署說明，前項所稱『公益上需要』之建築物使用，係指出於公共利益的目的，為使社會公眾或者一定範圍內的社會公眾受益所需之建築物使用而言，且應依都市計畫法第 37 條規定，洽都市計畫擬定機關審查土地使用分區管制查明其規定目地之使用。爰一般護理之家是否符合前開規定，應視機構申請計畫個案事實認定之。

三、又，護理之家是否符合農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點『公益性福利設施』乙節：農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第 6 點規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」按行政院農委會說明，前項所稱『公益性福利設施』，需具『公益性福利設施』性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應先確認以何種設施合法化，再由縣市政府業務主管機關，依前開要點第 4 點規定，就該事業設置之必要性與計畫所提使用特定農業區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性提出目的事業主管機關之評估意見，如認為本案有專案核准之必要性，再為本案向中央主管目的事業機關提出專案核准之申請。爰一般護理之家是否符合前開規定，應按機構興辦事業計畫之性質及使用內涵，視個案事實認定。

四、有關醫院附設一般護理之家，設置於醫院同址且分散不同樓層之通道(出入口及電梯)是否應獨立乙節，本部前於 95 年 12 月 15 日衛署醫字第 0950062433 號書函及 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函示在案，併予敘明，內容略以：如於同棟大樓不同樓層設置護理之家，護理機

構與醫療機構之執業場所使用空間應有明確區隔，並各有獨立動線(包含出入口及電梯)，且符合護理機構設置標準之相關規定，得予准許。本案請依此原則辦理。

103.12.24 衛部照字第 1031562533 號函

主旨：所詢有關護理機構設置於不連續樓層及獨立動線疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴院 103 年 12 月 11 日中總嘉企字第 1030016136 號函。
- 二、有關護理機構擬與醫療機構同棟設置，如其護理機構申請執業場所使用空間及公共場所與醫療機構應有明顯區隔，並各有獨立動線，且符合護理機構設置標準之相關規定，始得准許，本部業於 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函釋在案。貴院擬規劃於同棟不同樓層設置護理之家，其獨立出入口之規劃，應符合前開規定，先予敘明。
- 三、又本部 102 年 11 月 5 日衛部照字第 1021580888 號函釋之內容，係針對同棟建築物設置老人福利機構及一般護理之家應符合條件(包含不同門牌號碼及應有獨立出入口)，惟不同樓層設醫療機構及護理之家需符合之條件，仍請按本部 96 年 10 月 29 日函釋內容辦理。爰本案請依此原則辦理。

104.11.27 衛部醫字第 1041668673 號

主旨：所詢醫療財團法人之房地供其附設護理之家與居家護理所開業使用，是否認屬供醫院使用一案，本部意見如說明段，復請查照。

說明：

- 一、復貴部 104 年 10 月 14 日台財稅字第 10404027180 號函，及依據本部護理及健康照護司 104 年 10 月 30 日意見辦理。

- 二、查「醫療財團法人」之名稱，係依據 93 年 4 月 28 日所修正公布醫療法第 5 條規定，為本部所許可從事醫療事業辦理醫療機構之財團法人之專有名詞。又依同法第 31 條規定，醫療法人得設立醫院、診所及其他醫療機構，或經中央主管機關及目的事業主管機關許可，得附設護理機構、精神復健機構、醫學研究機構或相關福利機構等，查其立法宗旨，在使「醫療法人」與其所「設立或附設機構」有所區別。
- 三、次查 93 年 4 月 28 日醫療法修正前許可設立之「財團法人醫療機構」，將醫療法人與其設立醫療機構視為一體，即「法人」與「醫院」名稱相同，未有區別。惟其與現行醫療法規定有所牴觸，是以，為利本部對醫療財團法人之管理，本部爰於 96 年 7 月 2 日公告「醫療財團法人及其設立醫療機構或其他附設機構命名原則」，並請其配合修正法人及其設立機構或其他附設機構名稱。故前開醫療法人設立醫療機構或其他附設機構，係因應法人名稱變更而更改機構名稱，原法人之設立目的及其主體性質均未改變。
- 四、又查護理人員法第 17 條第 1 項第 3 款規定：「私立護理機構：由個人設置者，以資深護理人員為申請人；由其他法人依有關法律規定附設者，以該法人為申請人。」，及同法施行細則第 7 條第 1 項規定：「護理機構依本法第 17 條規定申請開業，應填具申請書，檢附下列書件，並繳納開業執照費，向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請：...」，與護理機構分類設置標準第 2 條規定，護理機構之分類包含居家護理機構及護理之家。依據上開規定，醫療財團法人如附設護理機構（包含護理之家及居家護理所），係以該法人為申請人，並按護理人員法等相關規定設立及開業。
- 五、爰此，醫療財團法人設置護理之家，其設置型態包含：該法人附設之護理機構，以及該法人附設醫院之護理機構（護理機構與醫院位於同一主體）等。至，護理機構房地是

否供醫院使用，及其房屋稅及土地稅減免等規定之認屬，則請逕依稅法相關規定辦理。

〔釋例類別〕 第 5 類 違規開業之懲處

88.12.3. 衛署醫字第 880702225 號函

主旨：所詢已許可籌設之護理之家，未開業即收容病人，以及非護理之家機構，以護理之家名稱收容病人，執行業務等節，應如何懲處乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 88 年 11 月 10 日北市衛五字第 8825568000 號函。
- 二、依護理人員法第 17 條規定，護理機構之開業，應向所在地直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照。
- 三、已許可籌設之護理之家，未開業即收容病人，以及非護理之家機構，以護理之家名稱收容病人，執行業務，均為未申請核准登記取得開業執照，即有開業之實，應依同法第 32 條規定，處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。

95.3.3. 衛署照字第 0952800401 號函

主旨：有關護理機構未合法立案懲處疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 2 月 13 日桃衛醫字第 0950000690 號函。
- 二、有關護理機構未合法立案，經予行政處分處以罰鍰，並限期令其改善，惟機構屆期未改善或遲遲無法完成立案者，處置規定如下：
 - (一)依行政執行法第 27 條規定：「依法令或本於法令之行政處分，負有行為或不行為義務，經於處分書或另以書面限定相當期間履行，逾期仍不履行者，由執行

機關依間接強制或直接強制方法執行之。前項文書，應載明不依限履行時將予強制執行之意旨。」。

- (二)按命尚未領有開業執照之護理機構完成法定立案程序係屬行為義務，該機構受有必須申請設立、合法立案之行為義務而不為或無法執行時，除需瞭解該機構無法執行之原因予以適度輔導或轉業外，原處分機關得依權責，依行政執行法之相關規定辦理。

96.2.15. 衛署照字第 0960005773 號函

主旨：所詢立案之護理機構違反護理機構設置標準(如應置人力、應置設施不符等)，應如何處辦一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 2 月 2 日北衛醫字第 0960009348 號函。
- 二、依行政程序法第 123 條第 4 款規定：「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。……四、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。」是以，護理機構依護理人員法之相關規定經向主管機關申請設立許可，並符合護理機構設置標準規定、完成法定程序後，則由主管機關發予開業執照之授益行政處分；如該護理機構受有之授益行政處分所依據之事實事後發生變更，除需瞭解該機構變更原因，依個案事實予以適度輔導、轉介或提供必要之協助外，原處分機關得依權責，依前所述規定辦理。

96.6.15. 衛署照字第 0962801007 號函

主旨：所詢業者申請籌設護理機構在未完成設置許可登記(即發予開業執照)，擅自懸掛招牌並加註「籌設中」有無違反相關規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 5 月 23 日花衛醫字第 09600083160 號函。

- 二、查護理機構申請許可設置或擴充，應檢具護理人員法施行細則第 7 條規定之文件，經衛生主管機關許可後，依同法施行細則第 11 條規定申請開業，經衛生主管機關派員履勘後，認與規定相符者，發給開業執照，先予敘明。
- 三、次查本案業者申請護理之家，經 貴局設立許可可在案，惟查尚未領有開業執照前，非屬合法護理機構，是以，自不得為護理業務之廣告。至所述本案業者擅自懸掛招牌並加註「籌設中」一詞之使用方式，如無使社會大眾誤認為合法護理機構，且經查證確無收治住民情事，得認未違反護理人員法第 18 條之 1 相關規定。

96.8.6. 衛署醫字第 0960034734 號函

主旨：所詢 貴轄私立護理機構違反護理人員法相關規定，依法處分對象疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 30 日北衛醫字第 0960067837 號函。
- 二、依護理人員法第 17 規定，私立護理機構由個人設置者，並未具法人資格，係屬護理人員自然人之開業場所。是以，護理人員法第 19 條規定，私立護理機構由護理人員設置者，應以護理人員為申請人，並為該護理機構之負責人，即由護理人員設立之私立護理機構，係以其負責人為權利義務主體，故有關私立護理機構之處分(罰鍰部分)，依上開規定，係處罰其負責護理人員。本案請依前揭規定辦理。

97.4.1. 衛署醫字第 0970201290 號函

主旨：有關私立醫療機構附設護理機構之機構屬性暨處分對象疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 1 月 22 日北衛醫字第 0970007119 號函。
- 二、查「護理機構違反護理人員法規定，除有特別規定外，應處罰該機構本身，但由個人設置之私立護理機構應處罰其

負責資深護理人員。」前經本署 90 年 3 月 5 日衛署醫字第 0900002348 號函釋在案。

三、另查護理人員法第 17 條規定之護理機構分類為公立護理機構、財團法人護理機構及私立護理機構。關於醫療機構附設之護理機構型態類別，應視其申請主體之醫療機構屬性論之。即公立醫療機構申請附設之護理機構，性質上認屬為公立之護理機構，由其代表人為申請人；醫療法人醫院依有關法律規定附設之護理機構，性質上應認屬為私立之護理機構，以該法人為申請人；私立醫療機構申請附設之護理機構，性質上認屬為私立之護理機構，惟私立醫療機構未具法人資格，爰應依護理人員法第 17 條規定，應由資深護理人員為申請人。至該護理機構應經醫療機構同意，始得冠以醫療機構名稱，並加註附設字樣。本署 96 年 2 月 6 日及 4 月 16 日衛署醫字第 0960004896 號及第 0960014958 號書函，關於「護理機構因係由醫院附設，宜以醫療機構名稱為申請人」一節，與上開護理人員法規定容有未合，應予停止適用。

四、另查護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，係以資深護理人員為申請人申請設立，其負責護理人員變更，即為申請主體變更，因涉屬設立權屬變更，係屬護理機構之新設立，應重新申請開業；至公立醫療機構、醫療法人或其他法人依有關法律規定附設之護理機構，因以該機構代表人或法人為申請人，故當其負責護理人員變更時，因非屬申請主體變更，依護理人員法之相關規定，應辦理登記事項變更。

（註：本函釋說明三所敘本署 96.4.16. 衛署醫字第 0960014958 號書函，請參閱 P.163）

102.4.10. 衛署照字第 1020066808 號函

主旨：所詢護理之家照顧服務員人力不足，不符護理機構設置標準，違反護理人員法第 16 條第 2 項，應如何懲處一案，請

查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 3 月 28 日嘉市衛醫字第 1020510319 號函。
- 二、查護理人員法第 16 條第 2 項規定，護理機構之分類及設置標準，由中央主管機關定之，意旨係指前項設置標準授權本署訂定之，先予敘明。
- 三、對於旨案護理之家人力管理，按護理人員法第 16 條第 1 項規定，略以：「護理機構之設置或擴充，應先經主管機關許可；…」機構之設置經主管機關許可立案後，仍應按許可事項及相關法規營運及管理。
- 四、按行政程序法第 123 條規定，略以「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止；…四、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。…」爰，針對機構許可設置後，據以許可之事實發生變更而有違反相關規定之情事時，貴局得自行依職權認定事實並進行相關處理。

102.5.22. 衛署照字第 1022863185 號函

主旨：所詢一般護理之家開業後違反設置標準疑義一案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據新竹市衛生局 102 年 5 月 2 日衛醫字第 1020006087 號函辦理。
- 二、依據護理機構設置標準第 8 條規定，一般護理之家護理人員數為 15 床至少應有 1 人，且 24 小時均應有護理人員值班，爰護理機構應至少聘足人員數需符床人比之標準，且需在人員派班可符 24 小時均應有護理人員值班之規定，惟其三班輪值人力分配，係為機構內部管理事項，人員派班之工時及休息休假等均應符勞基法之規定。
- 三、來函所詢二十四小時均應有護理人員值班之「值班」意指

「上班」，爰值班人員不在現場而以手機方式待命，未符二十四小時均應有護理人員提供服務之精神。

四、機構護理人員執業登錄人數係查核該機構聘僱之人員數。現場稽查可依機構人員派班狀況與排班表，查核人員確實在班狀況，以符二十四小時有人值班之規定。

五、所詢遇有機構違反護理機構分類及設置標準應處辦，本署前於 98 年 3 月 4 日衛署照字第 0982800807 號函釋在案，雖然無相關罰則，得參酌行政程序法第 123 條第 1 項第 4 款規定，「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。」辦理。

102.7.29. 衛部照字第 1020076089 號函

主旨：有關護理機構於申請設立時，針對建築物違章建築部分經申請人提出切結不使用證明，其切結書是否可視為「準負擔」，當開業後發現機構違規使用違章建築，得否依行政程序法第 123 條廢止其開業執照乙案，請 查照。

說明：

一、復 貴局 102 年 7 月 19 日桃衛照字第 1021400886 號函。

二、按護理機構分類設置標準第 8 條規定：「護理機構之設置，其設置標準如附表『護理機構設置標表』」又，該表三、建築物之設計構造與設備乙項中，明訂應符合建築法及其有關法規規定，故護理機構之設立應符合前開規定，先予敘明。至機構針對建築物違規建築部分提出切結不使用，其切結書是否可視為準負擔乙節，非前開所規定。

三、又，機構如違反護理機構分類及設置標準之處辦，得參酌行政程序法第 123 條規定，貴局得自行依職權認定事實並進行相關處理。

第 18 條 護理機構名稱之使用或變更，應以主管機關核准者為限。

非護理機構不得使用護理機構或類似護理機構之名稱。

第 18-1 條 護理機構廣告，其內容以左列事項為限：

- 一、護理機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。
- 二、負責護理人員之姓名、性別、學歷、經歷、護理人員證書及執業執照字號。
- 三、業務項目及執業時間。
- 四、開業、歇業、停業、復業、遷移及其年、月、日。
- 五、其他經中央主管機關公告容許事項。

非護理機構，不得為護理業務之廣告。

第 18-2 條 護理機構不得使用下列名稱：

- 一、在同一直轄市或縣(市)區域內，他人已登記使用之護理機構名稱。
- 二、在同一直轄市或縣(市)區域內，與被廢止開業執照未滿一年或受停業處分之護理機構相同或類似之名稱。
- 三、易使人誤認其與政府機關、公益團體有關或有妨害公共秩序或善良風俗之名稱。

92.11.24. 衛署醫字第 0920059829 號書函

主旨：所詢護理機構廣告容許事項所指為何？另如涉及違規時罰則規範為何等情乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 11 月 6 日北市衛五字第 09237117700 號函。
- 二、護理人員法業於 91 年 6 月 12 日修正公布施行，有關護理機構之廣告規範，業納入該法第 18 條之 1 明定，違反者依同法第 32 條或第 38 條規定處罰。
- 三、至於該法第 18 條之 1 第 1 項第 5 款所定「其他經中央主管機關公告容許事項」乙節，目前本署尚無特別公告容許

刊登。

95.11.24. 衛署醫字第 0950050892 號函

主旨：有關 貴局所詢使用「大愛」為名稱申請設立護理機構疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 11 月 1 日及 11 月 14 日投衛局字第 0950301387 號及第 095031437 號函。
- 二、查護理機構名稱之使用及限制，依護理人員法第 18 條及其施行細則第 14 條已定有明文，衛生主管機關於審查或核准護理機構之名稱時，除應依上開規定辦理外，亦可參考醫療法有關醫療機構名稱使用審核原則之相關規定。
- 三、次查衛生主管機關核准護理機構使用某項名稱，與商標主管機關就某名稱核准註冊為其服務商標，係屬 2 事；是以，有關財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會於 95 年 9 月 1 日申請「大愛」為註冊商標，與本案護理機構申請設立擬以「大愛」為機構名稱是否違反商標法之相關規定及處理一節，係屬商標主管機關職權，非屬衛生主管機關業務範疇。

95.12.6. 衛署醫字第 0950051313 號函

主旨：有關護理機構於大樓內 5 樓電梯口外張貼與登記機構名稱不符之廣告，是否違反護理人員法第 18 條第 1 項之規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 11 月 15 日北衛醫字第 09500911331 號函。
- 二、查護理機構刊(登)播之廣告內容，或懸掛市招(招牌)，應依護理人員法第 18 條之 1 及同法施行細則第 22 條規定辦理；衛生主管機關於審查或核准護理機構廣告內容時，除應依上開規定辦理外，亦可參考醫療法有關醫療廣告審核原則之相關規定，先予敘明。

三、關於市招之認定，本署業於 82 年 7 月 19 日衛署醫字第 8236536 號函釋在案，略以：「醫院診所於外牆、玻璃門或鐵門上作廣告，宣傳醫療業務，以達招徠患者為目的，仍視同市招，依醫療廣告規定辦理。」是以，本案皇家護理機構於大樓內 5 樓電梯口外張貼護理機構名稱，應以視同市招廣告之相關規定辦理；至該護理機構冠以「頂級」為市招廣告文宣一節，請依護理人員法第 18 條之 1 規定辦理。

96.5.17. 衛署醫字第 0960017760 號函

主旨：所詢護理機構名稱之使用疑義等情一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 96 年 4 月 23 日北衛醫字第 09600332031 號函。

二、查「護理機構名稱之使用及限制，依護理人員法第 18 條及其施行細則第 14 條已定有明文，衛生主管機關於審查或核准護理機構之名稱時，除應依上開規定辦理外，亦可參考醫療法有關醫療機構名稱使用審核原則之相關規定。」前經本署 95 年 11 月 24 日衛署醫字第 0950050892 號函函釋在案。次查醫療法施行細則第 10 條規定：「本法第十七條醫療機構名稱之使用、變更，不得有下列情形之一：……五、私立醫療機構使用易使人誤認與政府機關或公益團體有關之名稱。……」。是以，所述以「紅十字」為護理機構名稱申請設立一節，請 貴轄依權責，視個案事實依前述原則辦理。

三、另查護理人員法第 17 條規定，私立護理機構由個人設置者，係以資深護理人員為申請人申請設立，其申請主體變更，即屬護理機構之新設立；同法第 19 條第 2 項規定，私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。是以，由資深護理人員設立之私立護理機構，當機構申請主體變更（變更負責人），於同址由另位護理人員重新申請設立時，應由原任負責護理人員申請歇業，註銷

原領開業執照及所屬醫事人員執業執照。新任負責護理人員應符合法定資格，其人員及設施，並經審查及重新履勘符合護理機構設置標準，始得核准開業，重新核發開業執照及所屬醫事人員執業執照。

96. 6. 15. 衛署醫字第 0962801007 號函

主旨：所詢業者申請籌設護理機構在未完成設置許可登記(即發予開業執照)，擅自懸掛招牌並加註「籌設中」，有無違反相關規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 5 月 23 日花衛醫字第 0960083160 號函。
- 二、查護理機構申請許可設置或擴充，應檢具護理人員法施行細則第 7 條所規定之文件，經衛生主管機關許可後，依同法施行細則第 11 條規定申請開業，經衛生主管機關派員履勘後，認與規定相符者，發給開業執照，先予敘明。
- 三、次查本案業者申請護理之家，經 貴局設立許可，在案，惟查尚未領有開業執照前，非屬合法護理機構，是以，自不得為護理業務之廣告。至所述本案業者擅自懸掛招牌並加註「籌設中」一詞之使用方式，如無使社會大眾誤認為合法護理機構，且經查證確無收治住民情事，得認未違反護理人員法第 18 條之 1 相關規定。

102. 5. 20. 衛署照字第 1022863282 號函

主旨：所詢有關醫院附設護理機構擬予員工眷屬及特定對象給予優惠折扣計畫方案，是否合法妥適乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 4 月 19 日北衛醫字第 1021674152 號函。
- 二、按護理人員法第 18 條之 1 規定，護理機構廣告不得宣傳折扣方案，因考量優惠折扣係以該機構之員工眷屬及特定對象作為對象，爰如其無針對一般社會大眾宣傳機構業務，以達招徠住民之主觀意圖，則尚無違反護理人員法第 35

條之處罰要件。

三、本案請貴局依上開原則，就個案之事實予以查明認定。

102.9.25. 衛署照字第 1021580475 號函

主旨：有關護理機構網頁廣告公開宣稱住房折扣費，涉及違反護理人員法第 18 條之 1 規定，原 102 年 4 月 29 日衛署照字第 1022861001 號函自即日起停止適用，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 5 月 24 彰衛醫字第 1020015952 號函。
- 二、按護理人員法第 18 條之 1 規定護理機構廣告內容之範疇，有關護理機構於網頁廣告公開宣稱住房折扣專案，已違反前述規定，依同法第 32 條懲處；至於參觀、簽訂契約時推出住房折扣專案，非屬廣告，尚無違反護理人員法之規定。
- 三、有關護理人員法第 29 條第 1 項所稱「不正當業務」，與醫療法第 61 條第 1 項所稱「不正當方法」，兩者各自有具體明確之列舉及例示規定，且規範性質不同，尚不可完全比照辦理。
- 四、原 102 年 4 月 29 日衛署照字第 1022861001 號函自即日起停止適用。

102.10.31 衛部照字第 1021580843 號函

主旨：有關依護理機構分類設置標準設置之產後護理機構提供之護理勞務是否屬醫療勞務範疇，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 102 年 10 月 16 日台財稅字第 10204668130 號函。
- 二、查護理人員法第 18 之 1 條規定「護理機構廣告，其內容以左列事項為限：一、護理機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。二、負責護理人員之姓名、性別、學歷、經歷、護理人員證書及執業執照字號。三、業務

項目及執業時間。四、開業、歇業、停業、復業、遷移及其年、月、日。五、其他經中央主管機關公告容許事項。」至，貴部來函所述「現行產後護理機構強調其規模及服務如休閒渡假飯店」乙節，如以廣告方式宣傳，已非屬產後護理機構業務項目，應依本法第 32 條「處新台幣一萬五千元上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照」規定論處。

三、另產後護理機構收費標準核定係依護理人員法第 21 條第 1 項規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之。」如有提供非收費項目的服務內容，應依違反本法第 21 條第 2 項「護理機構不得違反收費標準，超額收費」規定，依本法第 36 條之規定，處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰……，並應限期退還超額收費。

四、查護理人員法第 14 條規定「為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。」次查醫療法第 31 條第 3 項規定：「醫療法人經中央主管機關及目的事業主管機關之許可，得附設護理機構……。設立條件、程序及其他相關事項，仍依各該相關法規之規定辦理」，爰依護理機構分類設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰幼兒。是以由衛生主管機關核准設立之產後護理機構所提供之護理服務，係因醫療照護需求所衍生之照護服務，仍屬醫療勞務之範疇；惟產後護理機構所提供之服務若係因一般生活照顧所衍生，則非屬醫療勞務之範疇。

第 19 條 護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，其資格條件由中央主管機關定之。

私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其中

請人為負責人。

83.6.17. 衛署醫字第 83035207 號函

主旨：護理人員法施行細則第 15 條所定執業年資之認定，應以其服務證明與辦理執業登記重疊之年資，始予採計，請查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 24 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

84.4.24. 衛署醫字第 84018597 號函

主旨：護理人員法施行細則第 15 條所定護理機構負責護理人員執業年資採認疑義乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴處 84 年 3 月 31 日 84 衛五字第 08797 號函。
- 二、護理人員法施行細則第 15 條第 1 款及第 2 款之第 1 目及第 2 目所定，從事護理工作之年資，應以取得證明文件並辦理執業登記者，始予採認。
- 三、又同條款第 2 目，如其於醫院之服務年資係本署 77 年度辦理醫院評鑑以前者，因無評鑑類別之規範，得視同具備經中央主管機關評鑑合格地區醫院以上之醫院服務年資。

85.4.15. 衛署醫字第 85015501 號函

主旨：所詢護理之家負責護理人員與工商事業登記之營業納稅負責人，依法是否限定為同一負責人乙事，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 85 年 3 月 14 日 85 中市衛五字第 5310 號函。
- 二、依據商業登記法第 2 條：本法所稱商業，謂以營利為目的，以獨資或合夥方式經營之事業。護理機構非以營利為目的，應免辦商業登記，故無主旨段所敘問題。

88.2.11. 衛署醫字第 87076093 號函

主旨：所詢護理機構之負責資深護理人員，應具備從事臨床護理工作之資格，其所界定之「臨床護理工作」範疇為何乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 87 年 12 月 28 日北市衛五字第 8726766200 號函。
- 二、凡依法辦理執業登記之實際執業年資，均得採計為護理人員施行細則第 15 條所定護理機構之負責資深護理人員應具備「從事臨床護理工作」資格之年資。

95.3.7. 衛署醫字第 0950008912 號函

主旨：所詢護理執業年資認定疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 3 月 1 日(95)全字第 007 號函。
- 二、查護理人員法施行細則第 15 條，有關護理人員從事臨床護理工作年資之認定，須以其服務證明與辦理執業登記重疊之年資，始予採計。

101.12.28. 衛署醫字第 1012864978 號函

主旨：所詢護理之家負責人是否可提出跨區支援報備乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 12 月 13 日桃衛照字第 1010192654 號函。
- 二、依護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。
- 三、護理人員支援其他醫療機構或護理機構，應事先報准，如越區前往支援者，應報經所在地直轄市或縣(市)衛生主管機關核准，並副知執行地直轄市或縣(市)衛生主管機關。
- 四、依據護理人員法第 19 條，護理機構應置負責資深護理人

員一人，對其機構護理業務，負督導責任。本案申請跨區支援報備之護理人員為護理機構負責人，而個案申請跨區支援之醫療機構或護理機構人力不足問題，非屬該個案之責任，申請跨區支援之適當性、其所設置之護理機構營運、人員派班值勤及業務督導管理狀況、該機構每年督導考核、不定期查核、相關行政處分及本署辦理之評鑑等情形，本權責逕行判定該護理機構負責人申請跨區支援報備相關條件之合理性。

104.1.22 衛部照字第 1041560124 號函

主旨：所詢因應少子化、社會大眾未來對護理之家之需求日殷，若欲新設或成立分支機構，則負責人之資格如何界定一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴護理之家 104 年 1 月 12 日高雄市瑞豐字第 144 號。
- 二、依據護理人員法第 19 條規定：「護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任，……。私立護理機構由前項資深護理人員設置者，以其申請人為負責人。」負責人相關資格應符合民法施行細則第 11 條之規定。另護理機構設置或擴充許可辦法第 7 條規定：「護理機構之設置或擴充經許可後，其設置或擴充地點、床數有變更者，應重新申請許可；私立護理機構負責人變更者，亦同」。
- 三、具有機構負責人資格之護理人員加入保險(勞保)之義務，仍應依相關保險法之規定辦理；且為保障工作人員勞動權益，一般護理之家評鑑指標將「業務負責人設置情形(A 2.1)」為一級必要項目指標，其基準包含：1. 資格符合相關法規標準規定。2. 專任且於機構投保勞健保、提撥勞退金。3. 實際參與行政與照護品質管理等項目，仍請參酌。
- 四、護理機構設置之申請，按護理人員法第 17 條規定，私立護理機構申請人包含個人及法人等，故(股份)有限公司未

符前開申請人資格。又對機構之營運方式，係於機構提出申請計畫時即審核其經費(如自籌、補助或募款)，以評估機構是否有完善之財務計畫，確保照護品質。

- 五、私人機構如更換負責人，無論獨資、合夥或公司聘任隔年是否需接受評鑑乙節：護理機構之設置或擴充許可後，私人機構如更換負責人，按規定應重新提出申請(即視為新機構)，爰該機構亦應重新接受評鑑。

106.10.26 衛部照字第 1061562914 號

主旨：有關產後護理之家負責人將執照租借機構，每月向該機構領取護理師執照出租費是否違反護理人員法一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 10 月 13 日中市衛醫字第 10600968221 號函。

- 二、依護理人員法第 19 條護理機構應置負責資深護理人員一人，對其機構護理業務，負督導責任...。又按護理機構分類設置標準第 7 條規定護理機構之負責資深護理人員，應督導其機構所屬護理人員及其他人員，善盡業務上必要之注意。綜上，護理機構由資深護理人員擔任負責人，對其機構護理業務，負督導責任，並善盡業務上必要之注意。

- 三、另依護理人員法第 30-1 條規定略以「護理人員將證照租借予不具護理人員資格者使用，廢止其護理人員證書；租借予前述以外之人使用者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，得併處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其執業執照。前項情形涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。」。

- 四、所詢機構每月給予機構負責人執照費(並附有機構損益表科目名稱為「負責人執照費」)，是否違反護理人員法乙節，請貴局釐清「負責人執照費」科目實際用途為何？租借行為之認定應有雙方確認及具體事證為依據，就所提供

片面資訊尚難採認，請貴局本於權責查明後依事實認定。

第 19-1 條 護理機構負責護理人員因故不能執行業務，應指定合於負責人資格者代理之。代理期間超過一個月者，應報請原發開業執照機關備查。

前項代理期間，最長不得逾一年。

第 20 條 護理機構應與鄰近醫院訂定轉介關係之契約。

前項醫院以經主管機關依法評鑑合格者為限。

第一項契約終止、解除或內容有變更時，應另訂新約，並於契約終止、解除或內容變更之日起十五日內，檢具新約，向原發開業執照機關報備。

84.5.11. 衛署醫字第 84020896 號函

主旨：醫療機構得跨直轄市或縣(市)行政區域附設護理機構，惟應依護理人員法第 20 條規定與其護理機構設置所在地之醫院訂定契約，其申請與管理均由當地衛生主管機關辦理。

說明：復 貴處 84 年 3 月 31 日 84 衛五字第 028884 號函。

第 21 條 護理機構之收費標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。

護理機構不得違反收費標準，超額收費。

93.12.8. 衛署醫字第 0930050897 號書函

主旨：所詢醫院附設護理之住民因病情變化必需轉入急性病房治療或因個別因素需求，而要求保留原床位亦或要求預先控留床位，為避免影響醫院之營運收入，是否得酌收保留費，每日 500 元一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 93 年 11 月 26 日衛醫字第 0930013697 號函。

- 二、按醫療法第 21 條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。」所稱醫療費用，當係指醫療上所發生之費用而言；另按醫療法第 22 條第 2 項規定：「醫療機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。」爰此，醫療機構應依據核定之收費標準收取醫療費用，所述床位保留費並非醫療之費用且目前並無是項收費規定，醫療機構向病患收取該項費用，應屬擅立名目收費，核與醫療法第 22 條第 2 項規定不合。

(註：相關函釋 100.8.8.衛署醫字第 1000201065 號函釋略以：其床位得依定型化契約第 8 條，由雙方共同約定之方式予以保留，請參閱 P.225)

96.4.3. 衛署醫字第 0960008731 號函

主旨：有關署立八里療養院附設精神護理之家收費標準核定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴府 96 年 2 月 27 日北府衛醫字第 0960017208 號函。
- 二、查公立護理機構之開業，依護理人員法第 17 條第 1 款及同法施行細則第 11 條之規定，係由該機構之代表人為申請人，向直轄市或縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照；至公立醫療機構附設之護理機構，依申請主體論之，性質上亦宜認屬公立之護理機構。是以，有關該類公立護理機構收費標準之核定，依護理人員法第 21 條第 1 項但書之規定，由該管主管機關核定。
- 三、又各公立醫院主管機關，為辦理前開公立護理機構收費標準之核定時，宜由各縣市衛生局提供其轄區護理機構收費標準參核。

99.10.19. 衛署醫字第 0990078853 號函

主旨：有關公立護理機構之收費標準，其核定之權責機關，依護理人員法第 21 條第 1 項規定，係由其直屬之上級機關核定，

請 查照。

說明：

- 一、依據 貴部 99 年 9 月 28 日台高(三)字第 0990165735 號函副本辦理。
- 二、護理人員法第 21 條第 1 項規定，護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。該條第 1 項但書所稱該管主管機關，係指該公立護理機構直屬之上級機關而言。國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院其護理之家收費標準，仍請貴部依前開護理人員法之規定核定之。
- 三、至臺大醫院附設護理之家收費標準之核定，可參考台北市政府衛生局公告之台北市一般護理之家之收費標準(如附件)。

100.8.8. 衛署醫字第 1000201065 號函

主旨：所詢部分護理之家住民因病情變化需轉入醫院治療，如欲保留床位，是否得酌收保留費一案，復請 查照

說明：

- 一、復 貴局 100 年 6 月 29 日雲衛醫字第 1000015834 號函。
- 二、按護理人員法第 21 條規定，護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之；護理機構不得違反收費標準，超額收費。查本署 96 年 10 月 1 日衛署照字第 0962801438 號函公告之一般護理之家(委託型、自定型)定型化契約範本，依契約內容第 3 條及第 6 條，收費項目包括保證金、長期照護費及自行負擔費用。第 8 條亦規定，「住民因病就醫或其他正當理由而於機構外生活，經辦妥護理之家所規定之手續且連續外住 3 日以上者，得按實際院外生活日數請求退還每日之膳食費。但護理之家、委託人雙方另有約定，較有利於住民時，從其約定。」爰此，旨揭床位保留費，雖非屬前開定型化契約約定之費用，惟住民因病情變化需轉入醫院治療者，其床位仍得依該定

型化契約第 8 條由雙方共同約定之方式予以保留，則尚無不可。

102.4.9. 衛署照字第 1022860972 號函

主旨：有關 貴會於 102 年 3 月 12 日召開「台電、中油及台水公司政策性負擔逐步回歸各部會編列預算」會議之決議，本署意見如說明，復請 查照。

說明：

一、依據經濟部國營事業委員會 102 年 3 月 19 日經國一字第 10200044980 號函辦理。

二、按 貴會 102 年 3 月 12 日召開研商「台電、中油及台水公司政策性負擔逐步回歸各部會編列預算」會議討論事項—決議事項說明，針對本署護理之家部分(含一般護理之家及精神護理之家)是否納入電價優惠等疑義，說明如下：

(一)電業法第 65 條新增護理之家為優待對象，惟鑑於護理之家係屬自費市場，按護理人員法第 21 條規定：「護理機構之收費標準，由直轄市或縣(市)主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。護理機構不得違反收費標準，超額收費。」爰護理之家考量該機構應有之營運成本，自行訂定相關收費標準。

(二)考量長期照護之需求逐年增加，其機構成長預估十年內將有明顯成長，如由中央目的事業主管機關編列其政策性電費負擔，恐嚴重排擠衛生醫療預算。且電業法第 65 條僅規定護理之家等用電收費，應低於普通電價，但不低於供電成本，並無強制規定應由中央目的事業主管機關編列其優惠用電之政策性負擔預算。

三、綜上，鑑於護理之家機構所收取之費用已涵括用電成本，因應機構快速成長，編列政策性電費負擔，恐排擠衛生醫療預算，及所優惠之電價在不低於供電成本下，並不造成台電公司之負擔等綜合考量，建議現階段(未來十年)暫不

由本署編列護理之家用電之政策性負擔預算。

102.6.14. 衛署照字第 1022863047 號函

主旨：有關護理人員法第 21 條收費標準及護理機構同址是否可從事其他營業項目之疑義，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 3 月 18 日北市衛醫護字第 10231275002 號函。
- 二、有關貴局所詢護理機構開業後因應物價等因素自行調整收費標準，未超過貴局收費基準上限規定，未經核備乙節，尚難認屬違反護理人員法第 21 條之規定；至於護理機構收費標準如係由機構報請縣市衛生局核定者，該機構後續調整收費標準仍應依護理人員法第 21 條規定辦理。
- 三、另詢護理機構申請設置或擴充時，發現同址已有其他營業項目(包括商業登記為坐月子食品公司、或向衛生局登記販賣醫療器材等)乙節，說明如下：
 - (一)查護理機構為醫事人員之執業場所，以提供辦理執業登記在案之醫事服務項目為限。又護理機構非屬營利事業，應避免醫療行為與商業行為混淆而影響醫療作業。
 - (二)又，設立坐月子食品公司係屬商業行為，宜請住民於符合相關規定之營業場所購買服務；又，前述食品公司之經營行為應屬商業營利性質，就營運主體而言，其設立登記應依公司法、商業登記等規定辦理，以資適法。故護理機構內附設商業性質之坐月子食品公司，應不予同意；至護理機構如與坐月子食品公司同址設置，其執業場所有實體區隔、二處內部無法相通，且分別有對外出口，得視同不在同一地址。
 - (三)另有關護理機構販賣醫療器材，如僅對護理機構之病患或其家屬提供必要之服務，經當地縣市衛生主管機關實地履勘屬實，在不響護理照護服務品質下，尚無

不可。惟其如將藥局、藥商登記於護理機構地址內，並以對外從事醫療器材推銷、銷售為主要業務，則非所宜。

(四)綜上，除上述所述機構外，護理機構營運範圍應符合護理機構申請設置或擴充之計畫書核准事項為準。

102.8.12. 衛署照字第 1021580174 號函

主旨：所詢護理人員法第 21 條收費標準及居家護理機構同址是否可從事其他營業項目之疑義，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 7 月 29 日北市衛醫護字第 10236099601 號函。
- 二、旨案有關護理機構（含居家護理機構）同址如有其他公司設立之認定，以及提供居家護理服務時，依個案需求提供租借或販售醫療器材服務乙節，本部前於 102 年 6 月 14 日以衛署照字第 1022863047 號函諒達，合先敘明。
- 三、至居家護理所除使用健保支付標準外，另採專案服務方式收費乙節，依據護理人員法規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。…。護理機構不得違反收費標準，超額收費。」爰居家護理之收費標準審定，係屬地方衛生主管機關權責，故由貴局逕予審核。

102.8.14. 衛部照字第 1021580214 號函

主旨：有關委員關切本部辦理臺北市大清居家生活有限公司，其於今年三月成立至今，然因居家護理所之設置相關疑義，請本部協助了解及函復乙案，請 查照。

說明：

- 一、依據立法委員會陳節如國會辦公室 102 年 8 月 9 日傳真文件辦理。
- 二、有關護理機構(含居家護理機構)同址如有其他公司設立之認定，以及提供居家護理服務時，依個案需求提供租借或

販售醫療器材服務乙節，本部前於 102 年 6 月 14 日以衛署照字第 1022863047 號函諒達臺北市政府衛生局在案(如附件)。

- 三、至居家護理所除使用健保支付標準外，另採專案服務方式收費乙節，依據護理人員法規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。…。護理機構不得違反收費標準，超額收費。」爰居家護理之收費標準審定，係屬地方衛生主管機關權責，故由該局逕予審核。
- 四、旨案本部業於 102 年 8 月 12 日以衛部照字第 1021580174 號函復臺北市政府衛生局(如附件)。
- 五、感謝委員對於居家護理業務之關心，尚祈不吝指教。

105.12.1 衛部照字第 1050135061 號

主旨：有關貴局函詢產後護理機構可否容許依公司法、商業登記等規定設立之單位向機構住民收取機構之住房設備、沐浴組、盥洗用具等費用疑義案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 11 月 17 日北市衛醫護字第 10556494601 號函。
- 二、查本部 102 年 6 月 14 日衛署照字第 1022863047 號函示略以，查護理機構為醫事人員之執業場所，以提供辦理執業登記在案之醫事服務項目為限。又護理機構非屬營利事業，應避免醫療行為與商業行為混淆而影響醫療作業。又，同址設置，其執業場所應有實體區隔，且分別有對外出口。
- 三、有關機構之收費標準及服務項目，應尊重住民意願，不宜由依公司法或商業登記等規定設立之單位以多層次傳銷或仲介方式招攬業務。又產後護理機構定型化契約應記載及不得記載事項第 4 點及定型化契約範本第 9 條，均禁止推銷人員進入。
- 四、綜上，本案是否有違反護理人員法規定情事，請貴局參酌

前揭規定並本權責及事實認定之。

102.8.15. 衛署照字第 1021580233 號函

主旨：為使產後護理機構收費有所依循，惠請貴局依護理人員法訂定產後護理機構收費標準，請 查照。

說明：

- 一、依據護理人員法(以下簡稱本法)第 21 條規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。....」次依本法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」爰請貴局依前開規定辦理並訂定收費項目及標準。
- 二、產後護理機構如有提供非收費項目的服務內容，應依違反本法第 21 條第 2 項規定：「護理機構不得違反收費標準，超額收費」規定，依本法第 36 條「違反....第 21 條第 2 項規定者，處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。」規定論處。
- 三、已依法訂定產後護理機構收費標準且於 102 年 6 月後有修訂者，另請於 102 年 8 月 19 日(一)免備文回復承辦人莊○○。

(註：本函釋說明三所敘承辦人之名字以○○表示)

102.9.14. 衛署照字第 1021580498 號函

主旨：惠請轉知所轄產後護理機構，服務收取費用應開具收據，並載明收費項目及金額，請 查照。

說明：

- 一、護理人員法第 21 條規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之」。
- 二、本部已於 102 年 8 月 15 日衛署照字第 1021580233 號函請貴局依護理人員法訂定收費項目及標準。

- 三、惠請各局轉知所轄產後護理機構於提供服務並收取費用，應開給收據並載明服務項目及收費金額，以確保民眾權益。

102.10.31 衛部照字第 1021580843 號函

主旨：有關依護理機構分類設置標準設置之產後護理機構提供之護理勞務是否屬醫療勞務範疇，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 102 年 10 月 16 日台財稅字第 10204668130 號函。

二、查護理人員法第 18 之 1 條規定「護理機構廣告，其內容以左列事項為限：一、護理機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。二、負責護理人員之姓名、性別、學歷、經歷、護理人員證書及執業執照字號。三、業務項目及執業時間。四、開業、歇業、停業、復業、遷移及其年、月、日。五、其他經中央主管機關公告容許事項。」至，貴部來函所述「現行產後護理機構強調其規模及服務如休閒渡假飯店」乙節，如以廣告方式宣傳，已非屬產後護理機構業務項目，應依同法第 32 條「處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照」規定論處。

三、另產後護理機構收費標準核定係依護理人員法第 21 條第 1 項規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。」如有提供非收費項目的服務內容，應依違反本法第 21 條第 2 項「護理機構不得違反收費標準，超額收費」規定，依本法第 36 條之規定，處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰……，並應限期退還超額收費。

四、查護理人員法第 14 條規定「為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員之執業功能，得設置護理機構。」次查醫療法第 31 條第 3 項規定：「醫療法人經中央主管機關及目的事業主管機關之許可，得附設

護理機構……。設立條件、程序及其他相關事項，仍依各該相關法規之規定辦理」，爰依護理機構分類設置標準第 3 條規定，產後護理機構之服務對象為產後未滿二個月之產婦及出生未滿二個月之嬰幼兒。是以由衛生主管機關核准設立之產後護理機構所提供之護理服務，係因醫療照護需求所衍生之照護服務，仍屬醫療勞務之範疇；惟產後護理機構所提供之服務若係因一般生活照顧所衍生，則非屬醫療勞務之範疇。

102.12.18 衛部照字第 1021581296A 號函

主旨：有關產後護理機構收費項目訂定「醫療勞務」及「一般生活照顧」範疇乙案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、復財政部 102 年 11 月 5 日台財稅字第 10204679190 號函。
- 二、本部於 102 年 11 月 29 日召開「研商護理機構提供服務與醫療勞務範圍會議」，會中邀請財政部、衛生局、專家學者及護理機構等代表出席。有關產後護理機構收費項目包括「醫療勞務」及「日常生活照顧」兩類，其中屬「醫療勞務」係包括護理費(含護理評估、護理指導及處置等)、住房費、醫療診療及諮詢費等；日常生活服務費用則包括：嬰兒奶粉及尿布、清潔衛生用品及一般飲食等；地方衛生主管機關於核定護理機構收費項目，應能判別上述項目之類別。
- 三、惠請各直轄市及縣市衛生局轉知所轄產後護理機構於提供服務及收取費用時，應掣給收據並載明提供服務項目及收費金額，且項目內容是可判別屬「醫療勞務」或「日常生活照顧」，以確保民眾權益。

103.3.18 衛部照字第 1031560438 號函

主旨：所詢貴轄某護理之家「定型化契約」中敍明入住須收取保

證金後，同時要求住民需連帶保證人及保證人之規定疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 2 月 27 日高市衛長字第 10331737200 號函。
- 二、查「一般護理之家定型化契約應記載及不得記載事項」中，應記載事項：三、應記載消費者應繳納保證金、長期照護費，其方式參考護理之家定型化契約範本第三條規定。不得記載事項：三、約定長期照護費數額超過直轄市或縣(市)主管機關核定之護理之家收費標準。
- 三、次查一般護理之家定型化契約範本之契約內容第三條規範：「乙方應繳納保證金及長期照護費，其數額及繳費方式如下：一、保證金：乙方應於訂立契約時，一次繳足保證金新台幣 元(最高不得逾二個月長期照護費)予甲方，甲方應以機構名義於金融機構設立專戶儲存保證金，並將專戶影本交付乙方收執。乙方欠繳長期照護費或其他費用，或對甲方負損害賠償責任時，甲方得定○○日(不得少於七日)以上之期限通知乙方繳納，逾期仍不繳納者，甲方得於保證金內扣抵，其不足數乙方仍應依第七條補足。」。
- 四、綜上，定型化契約應記載及不得記載事項，及契約範本相關規定內容，係規範住民應繳納保證金及費用金額，且不得超過衛生局核定之收費標準；又，該定型化契約並未載明及約束收取保證金之外，不得再記載其他保證問題(例如：要求另需連帶保證人)，再者，契約範本僅供機構及住民參考，該契約雖為定型化契約之一種，惟住民家屬或委託人仍得針對個別狀況，要求機構業者增刪修改。
- 五、故旨案所稱機構於契約中要求需連帶保證人乙節，係屬契約自由。惟契約之約定，仍應視雙方約定內容而定，並遵循消費者保護法相關規定辦理，以維雙方權益，避免爭議。

104.1.6 衛部照字第 1030033867 號函

主旨：所詢函請本部提供關於生活無法自理者之照護收費標準明細一案，如說明段，復請查照。

說明：

- 一、復 貴院 103 年 12 月 24 日南院昆民暢 101 醫 14 字第 1030062893 號函。
- 二、依據護理人員法第 21 條規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。護理機構不得違反收費標準，超額收費。」護理之家之收費標準訂定，係屬地方主管機關之權限，由其訂定及公告之，爰本案請逕向系爭所屬之衛生主管機關聯繫及提供收費標準。

第 22 條 護理機構停業、歇業或其登記事項變更時，應於事實發生之日起三十日內，報請原發開業執照機關備查。護理機構遷移或復業者，準用關於設立之規定。

90.3.5. 衛署醫字第 0900002348 號函

主旨：承詢貴轄行政院衛生署台中醫院附設居家護理所變更負責人，其未依護理人員法第 22 條規定於 10 日內辦理變更手續，則應處分代表人或居家護理所負責人乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 1 月 5 日 90 衛醫字第 000624 號函。
- 二、按護理機構違反護理人員法規定，除有特別規定外，應處罰該機構本身，但由個人設置之私立護理機構應處罰其負責資深護理人員。

90.5.16. 衛署醫字第 0900032045 號函

主旨：醫療機構依護理機構設置標準第 10 條規定附設護理機構，其醫療機構變更負責醫師，若已依醫療法第 19 條規定

報請變更登記，應已完成辦理登記，勿需另依護理人員法第 22 條規定，申請變更登記，請 查照。

說明：依據 89 年醫政、護政業務會議決議辦理。

97.1.22. 衛署醫字第 0970003729 號函

主旨：有關署立南投醫院附設護理之家申請復業，在原主體設施及設備未改變狀況下，得否免辦理實地會勘(消防、建築)一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 1 月 19 日投衛局醫字第 0970300072 號函。
- 二、查按護理人員法第 22 條第 2 項規定：「護理機構遷移或復業者，準用關於設立之規定。」揆其立法意旨，護理機構辦理停業後，所屬醫事人員亦需辦理停業，而該護理機構於停業期間之硬體設備，亦或有所變動。是以，護理機構辦理復業時，其人員配置及相關設施，應經審查及重新履勘符合護理機構設置標準後，始得核准開業，核發開業執照及所屬醫事人員執業執照。
- 三、惟為簡化程序以資便民，護理機構申請復業時，在原主體設施與設備及人員無重大改變狀況下，除消防、建管設施由主管機關依權責視個案事實辦理外，有關設立及開業程序可合併予以簡化，衛生主管機關得免辦理現場履勘，惟仍應符合護理機構設置標準之規定。爰此，本案請依前揭原則辦理。

97.1.30. 衛署醫字第 0970005382 號函

主旨：有關 貴轄惠德醫院附設護理之家申請遷移新址，因新遷移地址多處違建，業經 貴府建管處予以行政處分在案，惟該機構尚未拆除違建部分，可否核發開業執照等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、依據立法委員陳啟昱國會辦公室 97 年 1 月 29 日簡便行文

轉 貴局 97 年 1 月 28 日衛局醫字第 09700034140 號函辦理。

- 二、查醫療法第 23 條第 2 項規定：「醫療機構遷移者，準用關於設立及開業之規定。」另查護理人員法第 22 條第 2 項規定：「護理機構遷移或復業者，準用關於設立之規定。」是以，醫療機構及護理機構遷移後，依前揭規定申請開業時，建築物除須符合建築及消防法規外，其人員配置及相關設施，應經審查符合醫療機構或護理機構設置標準後，始得核准開業，核發開業執照及所屬醫事人員執業執照。爰此，本案請依前揭原則辦理。

100.1.31. 衛署醫字第 1000060944 號函

主旨：所詢護理機構依護理人員法第 22 條申請停業時，停業之期限是否有其規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 1 月 13 日桃衛照字第 1000005105 號函。
- 二、查護理人員法第 22 條規定，護理機構停業、歇業或其登記事項變更時，應於事實發生之日起 30 日內，報請原發開業執照機關備查。是以，護理機構如需停業，應依前開規定辦理。又如其停業時間超過 1 年，則宜請輔導其辦理歇業。

101.11.23. 衛署照字第 1012864527 號函

主旨：有關 貴局所詢轄內某公立醫院附設護理之家違反護理人員法第 22 條規定，其受處分對象疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 10 月 24 日南市衛醫字第 1010151302 號函。
- 二、本案因該院附設護理之家，於 101 年 7 月 26 日更換申請人，其登記事項變更時 30 日內未向貴局辦理變更登記，遲於 101 年 10 月 9 日提出申請乙案，依護理人員法第 22 條 規

定，其主體為護理機構。爰此，依護理人員法第 32 條規定辦理之裁罰，其裁罰對象應為護理機構。

三、據查，貴局曾於 101 年 10 月 18 日至該護理機構辦理現場稽查，且該院於 101 年 10 月 23 日發生大火，亦請就該護理機構於變更期間，負責人管理部分及該次查察情形有無缺失進行檢視及妥處。

第 23 條 護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、收費、作業、衛生、安全、紀錄等之檢查及資料蒐集。

第 23-1 條 中央主管機關應辦理護理機構評鑑。直轄市、縣(市)主管機關對轄區內護理機構業務，應定期實施督導考核。

護理機構對前項評鑑及督導考核，不得規避、妨礙或拒絕。

第一項之評鑑、督導考核，必要時，得委託相關機構或團體辦理。

102.1.24. 衛署照字第 1022860013 號函

主旨：所詢有關護理機構評鑑之法規依據、參加對象及拒絕申請評鑑之罰則等疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復貴公司 101 年 12 月 20 日衛署護評釋函第 1011220001 號申請函。

二、查護理人員法第 23 條，護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、收費、作業、衛生、安全、紀錄等之檢查及資料蒐集。同法第 23-1 條及施行細則第 17 條規定，中央主管機關應視需要，辦理護理機構評鑑；直轄市、縣(市)主管機關對轄區內護理機構業務，應定期實施督導考核，並應訂定計畫實施，每年至少辦理一次。已明確訂定護理機構應

配合相關檢查及資料蒐集等，與本署辦理評鑑及直轄市、縣(市)主管機關辦理督考核等相關規定。

三、爰此，本署自 98 年起辦理全國護理之家評鑑，每年依公告之當年度評鑑作業程序（包含評鑑對象及評鑑基準）辦理，以 101 年度為例，評鑑對象為：

(一)至 101 年 6 月 1 日，開業滿 1 年之一般護理之家(以下稱機構)及其評鑑合格效期已於最後一年之機構，應參加本次評鑑；新立案開業未滿 1 年之機構則非屬本次評鑑對象。

(二)在評鑑合格效期內之機構，如有遷移地址重新開業、擴充設立(涉及建築物設計變更或使用執照類別變更)或於直轄市、縣(市)衛生局之督導考核，發現有其他重大變更情事之機構，應參加本次評鑑。

(三)私立機構因故歇業由他人於原址重新開業者(俗稱變更負責人)，均應參加本次評鑑。

四、對於符合當年度公告之評鑑對象，除辦理停、歇業者外，受評鑑機構之名單由地方政府衛生主管機關提供。當年度評鑑結果除公告外，也提供地方政府做為機構安置補助或簽約對象之參考，另依本署 101 年 12 月 19 日公告之「護理機構設置或擴充許可辦法」第 8 條規定，前一年度主管機關評鑑或督導考核不合格者，不得申請擴充床數。

五、當年度參加一般護理之家評鑑合格者，有效期限三年，評鑑不合格之機構，則責成地方衛生局加強輔導及督導考核，且於次年度需再接受評鑑。

102. 7. 19. 衛署照字第 1020014484 號函

主旨：所詢有關居家護理機構變更負責人，是否可免予參與當年度地方主管機關辦理之督導考核一案，請 查照。

說明：

一、復 貴局 102 年 7 月 10 日桃衛照字第 1020175639 號函。

二、按護理人員法第 23 條之 1 第 1 項規定，直轄市、縣(市)

主管機關對轄區內護理機構業務，應定期實施督導考核。又，同法第 23 條規定，護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、收費、作業、衛生、安全、紀錄等之檢查及資料蒐集。

- 三、爰地方主管機關辦理之督導考核作業，係按上開規定針對所轄護理機構進行查核，該等機構亦應接受主管機關之檢查。至護理機構變更負責人是否可免予參與當年度地方衛生局督考，基於護理機構管理之責，請貴局落實辦理相關作業。

104.4.1 衛部照字第 1040006456 號函

主旨：有關貴學會申請課予義務函釋「督導考核與評鑑結果不得違反護理人員法第 16 條、第 17 條設置標準」、「護理之家督導考核與評鑑有何立法與實施差異」及「護理機構督導考核與評鑑之停業撤照法律不得溯及既往」等案，本部回復意見如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴會 104 年 3 月 5 日衛護督評違字第 1040305002 號函及 104 年 3 月 4 日護鑑廢字第 1040304002 號函。

- 二、旨案貴學會針對護理人員法修正公布後之相關疑義，本部回復說明如下：

- (一)依據護理人員法第 23 條之 1 第 1 項規定，中央主管機關應辦理護理機構評鑑，地方主管機關定期辦理督導考核，同法第 23 條之 2 第 2 項規定，護理機構於評鑑合格效期內，如有違法情事，經限期改善，屆期末改善者得調降其評鑑合格格類別或廢止評鑑合格資格；又，同法第 31 條之 2 規定，護理機構接受評鑑，經評鑑不合格者之處分。同法施行細則第 17 條規定，直轄市或縣(市)主管機關應訂定計畫實施，每年至少辦理 1 次護理機構業務督導考核。

- (二)護理機構設置，依護理人員法第 16 條辦理，該條文亦授權中央主管機關訂定相關子法(護理機構設置或擴充許可辦法及護理機構分類設置標準)，爰主管機關據此作為機構申准設立之依據。機構如違反設置標準，則依護理人員法第 31 條之 1 規定處分。
- (三)然，護理機構之管理，依護理人員法規定，由中央主管機關辦理評鑑，地方主管機關辦理督導考核，該法第 23 條之 2 第 3 項亦授權中央主管機關訂定評鑑辦法，該法施行細則第 17 條則規定地方主管機關應訂定督導考核計畫實施。又，護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，配合相關檢查及資料蒐集等。評鑑結果如不合格者，逕依護理人員法第 31 條之 2 規定進行處分。此外，基於護理機構管理之責及減少機構同一年度同時接受評鑑與督導考核之負擔，並減少機構準備程序及公文書作業，地方主管機關辦理督考得結合本部之評鑑工作共同辦理。
- (四)承上，護理機構申准設立，依照護理人員法等相關規定許可設置，其設立之標準則依護理機構分類設置標準配置；然護理機構評鑑及督導考核，旨為提升護理機構照護品質，以保障入住民眾之權益，故機構之申准設立及接受評鑑及督導考核，各依法辦理，互不扞格；且如有違反設置標準或評鑑不合格者，亦需依法辦理相關處分。
- (五)有關護理機構評鑑不得溯及既往或信賴保護原則，護理人員法所規定之評鑑等事項，乃指新法公告後所辦理之訪查等事項，惟如有違反本法或依本法所發布之命令者，仍得依法處分。

第 23-2 條 中央主管機關辦理護理機構評鑑，應將各機構評鑑之結果、有效期間及類別等事項公告之。

護理機構於評鑑合格有效期間內，違反本法或依本

法所發布之命令，經主管機關令其限期改善，屆期未改善或其違反情節重大者，中央主管機關得調降其評鑑合格類別或廢止其評鑑合格資格。

護理機構評鑑之標準，包括對象、項目、評等、方式等，與評鑑結果之撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第四章 業務與責任

第 24 條 護理人員之業務如下：

- 一、健康問題之護理評估。
- 二、預防保健之護理措施。
- 三、護理指導及諮詢。
- 四、醫療輔助行為。

前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

專科護理師及依第七條之一接受專科護理師訓練期間之護理師，除得執行第一項業務外，並得於醫師監督下執行醫療業務。

前項所定於醫師監督下得執行醫療業務之辦法，由中央主管機關定之。

103.7.28 衛部照字第 1031500136 號函

主旨：所詢護理之家是否有護理人員應固定時間巡房之規定一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴署 103 年 7 月 17 日北檢治崑 103 相 247 字第 48475 號函。
- 二、查護理人員法係規範護理人員執業條件、業務範疇及護理機構設置管理規定，依護理人員法第 15 條規定，護理機構之服務對象包含罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人等。同法第 24 條規定護理人員業務

，包含健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢、醫療輔助行為，前項醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

三、承上，有關護理之家之護理人員是否應固定時間巡房，除護理人員執行業務應善盡必要之注意義務之外，並應視住民病況及照護需求認定，其事涉照護品質，非屬護理人員法之規定範疇。

四、檢附護理人員法全文 1 份。

〔釋例類別〕 第 1 類 醫療輔助行為之範圍

82.6.29. 衛署醫字第 8246034 號公告

主旨：公告護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍及其相關事項。

說明：

一、護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為，其範圍如左：

- (1)侵入性檢查之護理。
- (2)侵入性治療、處置之護理。
- (3)各項手術全程護理。
- (4)分娩全程護理。
- (5)放射線檢查、治療之護理。
- (6)化學治療之護理。
- (7)氧氣療法、光線療法之護理。
- (8)恢復室，加護病房(含精神科保護室)、洗腎室、急診室病人全程護理。
- (9)住院病人、暫留病人口服藥物之投與。
- (10)生命徵象監視儀器之監測。
- (11)住院病人生命徵象之測量與評估。
- (12)其他經中央衛生主管機關認定之醫療輔助行為。

二、護理人員除執行前項醫療輔助行為外，對於住院病人仍應

依病人病情需要，提供適當之護理服務，或指導其他人員提供適當之服務。

（註：本函釋業經 90.3.12.衛署醫字 0900017655 號公告修訂，請參閱 P.244）

82.9.3. 衛署醫字第 8255075 號函

主旨：護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為，係屬醫療業務範圍，如未依同條第 2 項規定，在醫師指示下行之，即不符醫師法第 28 條第 1 項但書第 2 款之條件，自屬構成違反醫師法第 28 條第 1 項本文之規定，復請 查照。

說明：復 貴處 82 年 8 月 7 日 82 衛五字第 066704 號函。

85.12.31. 衛署醫字第 85072934 號函

- 一、台端 85 年 12 月 9 日函詢護理人員服務於醫療機構，於何種情況下視為違反醫師法乙案，收悉。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療工作得在醫師親自指導下，由輔助人員為之，但該行為所產生之責任應由指導醫師負責。醫院、診所輔助人員縱於醫師在場指導下，執行應由醫師親自執行之醫療行為，仍屬擅自執行醫療業務。
- 三、另護理人員之業務及其從事醫療輔助行為之範圍，已有明文規定。檢附護理人員法及其相關法規暨本署 82 年 6 月 29 日衛署醫字第 8246034 號公告影本各乙份供參。
- 四、復請 查照。

87.12.28. 衛署醫字第 87072102 號函

主旨：承詢「對到診病人做檢傷分類」需否具備醫師資格？是否屬醫療行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 87 年 12 月 3 日中分信刑志決字第 19130 號函。
- 二、查依本署「醫院評鑑及教學醫院評鑑標準—醫院急診部門評鑑標準」規定；病人到診時應由醫護人員先做檢傷分類(如附件)，爰此具備醫師或護理人員資格者，均可執行病患檢傷分類。

90.3.12. 衛署醫字第 0900017655 號公告

主旨：修訂護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍。

公告事項：

- 一、護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 82 年 6 月 29 日衛署醫字第 8246034 號公告在案。
- 二、前項公告醫療輔助行為之範圍，修訂如下：
 - (1)輔助施行侵入性檢查。
 - (2)輔助施行侵入性治療、處置。
 - (3)輔助各項手術。
 - (4)輔助分娩。
 - (5)輔助施行放射線檢查、治療。
 - (6)輔助施行化學治療。
 - (7)輔助施行氧氣療法(含吸入療法)、光線療法。
 - (8)輔助藥物之投與。
 - (9)輔助心理、行為相關治療。
 - (10)病人生命徵象之監測與評估。
 - (11)其他經中央衛生主管機關認定之醫療輔助行為。
- 三、護理人員除執行前項醫療輔助行為外，對於住院病人仍應依病人病情需要，提供適當之護理服務。

91.8.27. 衛署醫字第 0910047110 號函

主旨：有關精神科「會談治療」是否屬於應由醫師親自執行之醫療行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 91 年 7 月 25 日健保醫字第 0910014320 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害殘缺或保健為直接目的，所為的診察、診斷及治療，或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為應由醫師親自執行，其餘醫療工作得在醫師指示下，由具醫事人員資格者為之，前經本署 90 年 4 月 27 日衛署醫字第 0900022159 號函釋在案。

96.6.20. 衛署照字第 0962801033 號函

主旨：有關專科護理師執業範圍，請參照下列說明段辦理，請查照。

說明：

- 一、依據 96 年 5 月 16 日本署專科護理師臨床執業範疇相關事宜第 3 次會議決議事項辦理。
- 二、專科護理師執業範圍：
 - (一)住院病人身體理學檢查之初步評估及病情詢問。
 - (二)記錄住院病人病情及各項檢查、檢驗結果。
 - (三)處理住院病人及其家屬醫療諮詢及病情說明。
 - (四)在醫囑或醫師指示下，得開立檢驗、檢查申請單，但該檢驗、檢查申請單需註明指示醫師之姓名及時間，該指示醫師並應於 24 小時內，依醫師法及醫療法之相關規定，親自補開立檢驗、檢查單。
 - (五)在醫囑或醫師指示下，得開立領藥單，但該領藥單上需註明指示醫師之姓名及時間，該指示醫師並應於 24 小時內，依醫師法及醫療法之相關規定，親自補開立處方箋。
 - (六)其他經中央衛生主管機關認定宜由專科護理師執行之醫療輔助行為。

上述執業內容，應在醫院成立專科護理師執業委員會制定 Clinical nursing guideline 或 Clinical nursing pathway 後執行。

96.8.2. 衛署照字第 0962801382 號函

主旨：所詢專科護理師執業範圍中，有關「記錄住院病人病情及各項檢查、檢驗結果」，是否可記錄於病歷之病程紀錄（progress note）乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 11 日衛醫字第 0960027976 號函。
- 二、按護理人員執行業務應製作紀錄，為護理人員法第 25 條第 1 項所明定。另依醫療法第 67 條第 1 項及第 2 項規定：「醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷。前項所稱病歷，包括下列各款之資料：（一）醫師依醫師法執行業務所製作之病歷。（二）各項檢查、檢驗報告資料。（三）其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。」同法第 68 條第 1 項及第 2 項規定：「醫療機構應督導其所屬醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。前項病歷或紀錄如有增刪，應於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日；刪改部分，應以畫線去除，不得塗燬。」先予敘明。
- 三、至專科護理師執業過程之紀錄，可否直接書寫於醫師專用之病程紀錄（progress note）上一節，按病程紀錄（progress note）係病人於住院中，醫事人員觀察病情發展及進行各種診斷、治療相關流程與結果之紀錄，法無明文規定屬某類醫事人員之紀載，惟該紀錄之製作，仍應依前揭規定辦理。

100.11.3 衛署照字第 1002863075 號函

主旨：貴院擬請本署同意專科護理師執行腹水抽吸工作案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴院 100 年 9 月 19 日(100)和院護字第 0424 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、施行麻醉之醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內，但該行為所產生責任應由指示醫師負責。
- 三、查「腹水抽吸」係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋（如附件）在案。爰腹水抽吸之擷取部位涉及高度之醫療專業判斷及操作之風險，應由醫師親自執行，專科護理師及護理人員，可提供輔助。

101.3.29. 衛署醫字第 1010064877 號函

主旨：所詢醫療機構於開刀房，任用非醫事人員從事非醫療工作之適法疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 3 月 19 日高市衛醫字第 10132643300 號函。
- 二、查醫師法第 28 條所稱「醫療業務」，係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人所為之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。上揭所稱醫療行為，係指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。
- 三、另查，醫療法第 58 條規定：「醫療機構不得置臨床助理執行醫療業務。」意即臨床助理若執行醫療業務，需具備

有醫事人員資格，始得為之。即未具醫事人員資格不可於醫療機構，逕自或於醫師指示下從事任何醫療業務，違者依醫療相關法律規定論處。

- 四、至於來函所陳開刀房相關硬體設備、器械之維護、清潔，及庶務性文書作業等工作之排定，非屬醫療業務，爰執行者尚無資格之限制。惟查，施行手術醫療過程中，傳遞紗布予醫師、手術部位標示及病人無菌洞巾之鋪置等措施，係屬手術連續過程中之一環，應由醫師或護理人員依醫師指示為之。

- 五、綜上，本案所述情事，應以前揭原則認定辦理。

106.11.22 衛部照字第 1069001927 號

主旨：有關貴局函詢「醫療輔助行為疑義」案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 11 月 14 日中市衛醫字第 1060115687 號函。

- 二、查本部(前行政院衛生署)98 年 5 月 7 日衛署醫字第 0980013103 號函，略以：「二、按醫師法第 28 條所稱『醫療業務』，係凡指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。」。

- 三、依護理人員法第 24 條規定略以：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。

三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。……。」；次依本部（前行政院衛生署）101 年 3 月 6 日衛署醫字第 1010063205 號函，略以：「三、…病人矯正器鬆脫掉落時，為病人『矯正鐵線』、『調整鐵線』、『更換鐵線』之行為，如直接影響牙齒排列及治療結果之操作行為，應屬醫療行為，護理人員得依醫師指示協助為之；至於磨刮線頭、剪鐵線、線頭之行為，未涉及醫療行為。」。

四、綜上，醫療輔助行為係由護理人員依其專業，於醫師指示下執行之；至貴局函詢「遞酒精棉、置針盒予執行針灸業務中之中醫師，及消毒針灸或埋線所使用之醫療器材，是否屬醫療輔助行為」疑義一節，事涉該行為之操作是否屬護理人員法定之業務職掌範圍，建請貴局逕依上開原則就個案事實認定。

105.4.29 衛部照字第 1050111425 號

主旨：有關貴局函詢○○○君申請設立「○○○整形術後護理中心」其適法性疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局105年4月21日北市衛醫護字第10534128601號函。

二、按護理人員法第24條規定：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第4款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」；復按依護理機構分類設置標準第2條規定：「護理機構，分類如下：一、居家護理機構。二、護理之家。四、產後護理機構。」及同法第8條規定，護理機構之設置，其設置標準應依「護理機構設置標準表」設置。又依護理人員法施行細則第9條第1款規定，護理機構應依護理機構之分類標明其名稱，合先敘明。

三、有關所詢申請業務項目為「整形術後護理」，服務對象及

內容係針對乳癌義乳重建、隆乳、抽脂等整形相關乳房術後按摩，爰該「乳房術後按摩」行為，係為術後併發症之預防，具醫療效能，仍屬醫療行為管理範疇，故仍應由醫師或在醫師指示下由相關醫事人員於醫療機構執行之。

四、綜上，依來文所附何君申請「○○○整形術後護理中心」之設立許可申請書內容，查其業務項目非屬上開三類之護理機構，且機構名稱亦不符護理人員法規定。是以，本案請貴局依前述規定及原則，本於權責及事實認定。

(註：本函釋所敘之名字及護理中心之名稱以○○○表示)

105.5.24 衛部照字第 1050012312 號

主旨：有關○○○「懇請責成臺北市政府衛生局，依貴部(前行政院衛生署)100年9月6日函，協助指導○○學館新辦、或變更為護理機構」一案，復請查照。

說明：

- 一、復○○○105年5月3日送達存證信函。
- 二、有關○○○來函所詢請本部協助旨揭事項，查臺北市政府衛生局已於105年5月9日北市衛醫護字第10552587300號函復○○○並函示在案。
- 三、副本抄送臺北市政府衛生局，如該館對於申請機構立案仍有疑義，惠請貴局予以充分說明。

(註：本函釋所敘之名稱以○○○表示)

105.7.21 衛部照字第 1051563463 號

主旨：所詢有關○○○公司申請設立護理機構之適法性疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、依據貴局105年7月11日北市衛醫護字第10535478701號函暨立法委員黃國書國會辦公室105年5月13日協調會決議辦理。
- 二、旨案○○○公司申請提供之業務項目為「整形術後護理」

（隆乳按摩、術後按摩、抽脂術後按摩等），前項行為之認定請參本部105年4月29日衛部照字第1050111425號函辦理。

（註：本函釋所敘之公司名稱以○○○表示）

〔釋例類別〕 第 2 類 輔助藥物之投與及採血送檢

87.12.18. 衛署醫字第 87068786 號函

主旨：函詢具醫師資格之家屬或安養院人員是否可自行在宅或安養院內為糖尿病患施打胰島素乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 87 年 11 月 19 日院刑來字第 18183 號函。
- 二、糖尿病患者經醫師診斷需注射胰島素後，為免病人頻頻往返於醫療機構接受注射之不便，得經指導使用方式後，交由病人攜回自行注射。
- 三、按為病患施行注射，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員為之。安養院人員若未具護理人員資格，為病人施行注射，應認屬違反護理人員法第 37 條之規定；至家屬自行為其家人施行注射，非屬執行業務之行為，尚未違反上開規定。

90.1.5. 衛署醫字第 0890032940 號函

主旨：承詢依民國 87 年 7 月間當時有效之法令，不具醫師法第 28 條第 1 項各款及醫療法第 9 條第 1 項規定之醫事人員資格者，能否在醫師授意或監督下，進行針劑注射之醫療行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 89 年 11 月 27 日雲院任刑清決字第 11735 號函。
- 二、按「注射」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為，護理人員執行該項業務，依同條第 2 項規定，應在醫師之指示下行之。未具護理人員資格，在醫師

授意或監督下執行該項護理人員業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，宜依同條規定處罰。

三、檢送護理人員法及其相關規定乙份，請參考。

90.3.12. 衛署醫字第 0900017656 號函

主旨：有關針灸療法之取針與灸法、耳穴埋豆法、中藥超聲霧吸入法、中藥保留灌腸、坐藥法等行為之輔助施行，係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條規定，得由護理人員在醫師指示下行之，請 查照。

說明：依據本署護理諮詢委員會第 13 次會議決議辦理。

91.4.18. 衛署醫字第 0910018302 號函

主旨：有關貴會建議醫院護士抽血應認屬醫療輔助行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、依據行政院秘書處 91 年 2 月 27 日臺衛移字第 0910008325 號移文單轉貴會 91 年 2 月 8 日私地協 91003 號函辦理。
- 二、查護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：(1)健康問題之護理評估。(2)預防保健之護理措施。(3)護理指導及諮詢。(4)醫療輔助行為，前項第 4 款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」。
- 三、抽血得由醫事檢驗人員或護理人員依醫師處方或檢驗單為之，前經本署 86 年 3 月 26 日衛署醫字第 86012072 號函釋在案。本案醫院護理人員至院外為民眾抽血乙節，應依前開規定辦理。

91.8.22. 衛署醫字第 0910051309 號函

主旨：所詢傳○○醫師陳情，有關本署 90 年 11 月發行之醫師法解釋彙編第 505、506 頁指出：為病人洗眼睛或上藥膏治療行為，無須由醫師親自執行，可由「輔助人員」為之，有

關輔助人員可否由眼科醫師診所內未具醫事人員資格之助理人員擔任，該助手於醫師指示下執行上開行為，是否構成醫師法第 28 條所稱擅自執行醫療業務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴室 91 年 8 月 9 日苗鴻國字第 0061 號函。
- 二、查本署 81 年 1 月 6 日衛署醫字第 1001162 號函釋，稱有關未具醫事人員資格者，於醫師指示下為病人洗眼睛或上藥膏之治療行為，尚不構成醫師法第 28 條所稱之擅自執行醫療業務等語，係為闡釋醫師法第 28 條之罪之構成要件，並非規定未具醫事人員資格者，可從事前開業務。
- 三、前開業務仍應由護理人員於醫師指示下始得為之，未具護理人員資格者擅自執行上開業務，應以違反護理人員法第 37 條規定論處。

93.1.30. 衛署醫字第 0930001755 號書函

主旨：所詢護理人員未經醫師同意，擅自依原處方箋所載以前就診所開處方，拿藥予病患，是否構成醫師法第 28 條之罪責乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 93 年 1 月 9 日院信刑卯字第 428 號函。
- 二、依醫師法第 11 條規定之意旨，醫師對其診治之病人，無論是否有療效，均應再次對人親自診察，始可再開始方劑。但對特殊疾病之病人，如長期或慢性病人，醫師依其專業知識之判斷，確信可以掌握病情再開給相同方劑者，不在此限。
- 三、本案如係醫師未經看診診斷，而指示護理人員依上次看診結果之處方拿藥，係屬違反前開醫師法第 11 條規定；若非該醫師指示，該護理人員即逕依上次看診結果之處方拿藥，宜認屬違反同法第 28 條規定。

93.3.15. 衛署醫字第 0930004477 號書函

主旨：所詢無相關護理證照之診所助理可否從事如外傷處理、打針(含靜脈注射及肌肉注射)及急救等醫療行為乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 93 年 1 月 30 日北檢茂金 92 偵 17233 字第 4383 號函。
- 二、按外傷處理、打針(含靜脈注射及肌肉注射)及急救等係屬醫療行為，應由醫師或護理人員依醫囑執行之；若係在醫師指示下，由未具護理人員資格之診所助理依醫囑為之，應認屬違反護理人員法第 37 條之規定；如係未經醫師指示，即擅自執行前述醫療行為，則核屬違反醫師法第 28 條之規定。

93.12.17. 衛署藥字第 0930050615 號函

主旨：有關貴部函詢所屬部分矯正機關，因無藥事人員編制，是否可由護理人員於醫師監督下執行調劑業務乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴部 93 年 11 月 29 日法矯字第 0930904441 號函。
- 二、依藥事法第 102 條規定，醫師以診療為目的，並具有本法規定之調劑設備者，得依自開處方，親自為藥品之調劑(第 1 項)；全民健康保險實施二年後，前項規定以在中央或直轄市衛生主管機關公告無藥事人員執業之偏遠地區或醫療急迫情形為限(第 2 項規定)，復依同法施行細則第 50 條所稱醫療急迫情形，係指醫師於醫療機構為急迫醫療處置，須立即使用藥品之情況。因此，貴部所屬矯正機關藥品之使用，仍應符合上開所稱醫療急迫情形，始得由醫師依自開處方，親自為藥品之調劑。

95.3.16. 衛署藥字第 0950009620 號函

主旨：所詢病患領藥相關事宜乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 95 年 3 月 6 日(95)國藥師榮字第 950428 號函。
- 二、依據藥品優良調劑作業準則第 3 條所稱調劑，係指藥事人員自受理處方箋至病患取得藥品間，所為之處方確認、處方登錄、用藥適當性評估、藥品調配或調製、再次核對、確認取藥者交付藥品、用藥指導等相關之行為。因此，由「處方確認」至「用藥指導」過程之行為，皆屬於調劑之相關行為，應由藥事人員為之。
- 三、醫療過程中，領藥者是否須為病患本人乙節，於藥事法中尚無規範，又依藥品優良調劑作業準則第 23 條規定，藥事人員交付藥品時，應確認所交付之對象為交付處方箋者。因此，倘由病患同意，由其代理人協助領取藥品，再交由病患使用，尚無違反藥事相關法規。

95.3.17. 衛署醫字第 0950005061 號書函

主旨：有關野崎君子文教基金會防癌運動委員會擅自提供醫療服務於民眾一案，所詢衛生人員擅自為民眾採血檢驗，勾選檢查報告單及向受檢者解說檢查結果，是否涉及醫療診斷行為及違反醫師法第 28 條等相關規定一節，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 1 月 26 日北衛醫字第 0950007377 號函。
- 二、查疾病之檢查、診斷與治療屬醫療業務整體連貫作業。抽血檢驗屬醫療輔助行為，係提供醫師診斷與治療之參考數據。抽血得由護理人員、醫事檢驗人員依醫師指示為之；檢驗應由醫事檢驗人員依醫師處方或檢驗單為之。
- 三、護理人員如未依醫師指示，即擅自執行抽血及檢驗等醫療業務，並勾選檢查報告單及向受檢者解說檢驗結果，已涉及醫療專業判斷，應屬醫師法第 28 條所指擅自執行醫療業務行為。至本案護理人員是否擅自執行醫療業務一節，請依個案事實認定，如前所述規定辦理。

95.5.10. 衛署藥字第 0950016419 號函

主旨：所詢藥品交付之相關疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 4 月 19 日健保醫字第 0950059488 號函。
- 二、經查醫療過程中，領藥者是否須為病患本人，於藥事法中尚無規範，又依藥品優良調劑作業準則第 23 條規定，藥事人員交付藥品時，應確認所交付之對象為交付處方箋者。因此，倘由病患同意，由其代理人協助領取藥品，再交由病患使用，尚無違反藥事相關法規，本署 95 年 3 月 16 日衛署藥字第 0950010483 號函釋在案。
- 三、本案診所將處方箋傳真藥局，經藥局藥師調劑後，由非藥事人員將藥品送至診所直接交給病人或交給診所掛號處或護理人員交予病人乙節，倘該非藥事人員確屬病患之代理人，由病患之代理人協助領取藥品，再交由病患使用，則尚無違反藥事相關法規。至於該非藥事人員是否為診所或藥局所聘請，並經病患同意，抑或是由病患所委請，為病患之代理人，則藥事相關法規未有明文規範。

96.12.5. 衛署醫字第 0960211536 號函

主旨：有關醫療院所之洗腎單位聘用未具護理人員資格者之外籍人士，依護理人員指示調配洗腎機器之透析藥水(透析 B 液)，是否違反護理人員法或藥事法等相關規定一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 11 月 2 日北衛醫字第 0960099185 號函。
- 二、查洗腎透析液產品係屬藥品。次查藥品調劑為藥師法第 15 條所定藥師業務之一，爰此，調配洗腎透析液藥品應由藥師調劑，至藥品之交付，可由護理人員在醫師指示下交付病人於機構內使用。本案如由非藥師調劑洗腎透析液藥品，應已違反藥師法第 15 條規定，可依同法第 24 條規定論處。是以，本案請依個案事實，依前述原則查明處理。

96.12.21. 衛署醫字第 0960067699 號函

主旨：有關在醫師指示下執行點眼藥水之業務，是否屬於醫療輔助行為一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 12 月 18 日衛醫字第 0960054190 號函。
- 二、查為病人點眼藥水，係屬醫療輔助行為。另查「輔助藥物之投與」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範疇，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。是以，護理人員在醫師指示下，得執行點眼藥水之業務。

97.3.7. 衛署醫字第 0970201279 號函

主旨：有關醫療院所之洗腎單位執行洗腎透析藥水(透析 B 液)之調配，如係使用濃縮透析藥粉經透析機混合逆滲透水使用，是否仍逕予認定為藥師業務疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 1 月 28 日北衛醫字第 0970006728 號函及第 0970013508 號函。
- 二、查「洗腎透析液產品係屬藥品。次查藥品調劑為藥師法第 15 條所定藥師業務之一，爰此，調配洗腎透析液藥品應由藥師調劑，至藥品之交付，可由護理人員在醫師指示下交付病人於機構內使用。」前經本署 96 年 12 月 5 日衛署醫字第 0960211536 號函釋在案。
- 三、另查「輔助藥物之投與」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，得由護理人員依醫師指示為之。是以，調配洗腎透析藥品應由藥師調劑。至將藥師調劑完成之濃縮透析藥品依規定比例之逆滲透水泡製後使用，得認屬「輔助藥物之投與」之醫療輔助行為，由護理人員依醫師指示為之。

97.4.17. 衛署照字第 0972801020 號函

主旨：台端針對藥師依專科護理師所開立之領藥單配藥，是否違反藥師法相關規定等疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、台端 97 年 3 月 27 日就旨揭事項致本署署長信箱，經本署回復錄案研議後再行回復一節，諒悉。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其各該專門職業法律所規定之業務，依醫囑行之，前經本署多次函釋在案。
- 三、查醫師法第 13 條規定：「醫師處方時，應於處方箋載明下列事項，並簽名或蓋章：一、醫師姓名。二、病人姓名、年齡、藥名、劑量、數量、用法及處方年、月、日。」另查醫療法第 68 條第 3 項規定：「醫囑應於病歷載明或以書面為之。但情況急迫時，得先以口頭方式為之，並於二十四小時內完成書面紀錄。」至醫師親自執行醫療業務後之口頭處方指示，由專科護理師代筆詳實記載，所開立之領藥單，性質係為記載醫師之口頭處方，以供藥師調劑，目的在於病患緊急用藥時之權宜措施，為醫療作業實務所需；事後該指示醫師仍應依前揭醫師法及醫療法之相關規定，對於前揭口頭處方親自補具處方箋。
- 四、是以，依前揭所述，藥師受理醫師口頭處方性質之領藥單從事調劑業務，續依藥師法第 18 條規定，於醫師親自補具之處方箋上簽名蓋章，尚無抵觸藥師法相關規定。

98.11.30.衛署醫字第 0980032955 號函

主旨：所詢有關醫療相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 台端 98 年 10 月 2 日祐 981002375 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」，係凡指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，

所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之。

三、復按本署曾於 90 年 3 月 12 日以衛署醫字第 0900017655 號公告修訂護理人員法第 24 第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，如輔助施行侵入性檢查(治療或處置)、輔助各項手術、輔助分娩及輔助藥物之投與…等在案。

四、次查，針劑注射(包含針劑之抽取)係屬醫療輔助行為，爰得在醫師就特定病人診察後，由護理人員依照醫囑執行之。

五、是以，本案除依上開原則外，仍尚需視個案事實，始得認定。

99.6.18. 衛署醫字第 0990014627 號函

主旨：所詢有關老人養護機構常備急救藥品及護理人員可否於緊急情況下給藥乙案，復請 查照。

說明：

一、依據內政部 99 年 6 月 7 日內授中社字第 0990715753 號函辦理，兼復台端 99 年 6 月 3 日致內政部部長信箱電子郵件。

二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之。是以，護理人員於養護機構執行給藥之醫療輔助行為

，仍應在醫師就特定住民診察後，依其醫囑始得為之。

- 三、按醫師法第 11 條規定，醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，為應醫療需要，得由直轄市、縣(市)主管機關指定之醫師，以通訊方式詢問病情，為之診察，開給方劑，並囑由衛生醫療機構護理人員、助產人員執行治療。
- 四、次查護理人員法第 20 條明定，護理機構應與鄰近醫院訂定轉介關係之契約。同法施行細則第 12 條，亦定有本法第 20 條第 1 項所稱之契約，其內容應包括急救、急診、轉診及定期出診等事項。爰於護理機構或養護機構內設置常備急救用藥，主要應係為考量住民如需要緊急救護時，護理人員可在醫師指示下，及時並適切地提供所需之急救用藥，以確保住民之生命安全與照護品質。
- 五、是以，本案請參酌上開規定及原則辦理。

101.6.28. 衛署照字第 1012862926 號函

主旨：有關考量居家照顧服務個案實際需求(尤其是獨居老人)，貴聯盟建議護理人員專業授權及監督下，放寬照顧服務員可執行部分技術性護理服務，如注射胰島素、測血糖、甘油球通便及協助分藥一案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依據貴聯盟 101 年 6 月 18 日電子郵件所送 5 月 18 日修訂「照顧服務員訓練實施計畫」第一次工作小組會議紀錄辦理。
- 二、按「輔助施行侵入性治療、處置」及「輔助藥物之投與」屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範疇。爰此，執行胰島素注射、驗血糖、甘油灌腸及藥品之投與，為醫療輔助行為，由醫師或護理人員依醫囑為之。
- 三、有關身心障礙者居家照顧服務，照顧服務員執行排便前置作業乙案，前經本署 101 年 4 月 30 日衛署照字第

1012862341 號函有關照顧服務員提供身心障礙者居家照顧服務，從事個案身體之照顧，使用成藥類別之甘油球浣腸劑，對個案肛門口週遭糞便所為之簡易、少量甘油灌腸，以維持個案身體清潔與衛生及增加舒適感，如不涉及醫療專業判斷及醫療輔助行為，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。

- 四、查一般病人經醫師診察後得返家休養，並出具處方胰島素注射、驗血糖、甘油灌腸及服藥，經指導使用方式後，可由病人於家中自行施用或由家屬協助，則不受上開限制。又成藥類別之甘油浣腸劑，係以維持個案身體清潔與衛生及增加舒適感；使用簡便之攜帶式血糖機驗血糖，係為個案日常保健參考，如不涉及醫療專業判斷及醫療輔助行為，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。
- 五、次查照顧服務員係針對日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足，需他人協助者，提供(一)家務及日常生活照顧服務。(二)身體照顧服務。(三)在護理人員指導下執行病患照顧之輔助服務。但服務範疇不得涉及醫療及護理行為。
- 六、綜上，依居家照顧服務個案實際需求（尤其是獨居老人）及服務性質，對於成藥性質之甘油球通便、依照藥袋指示協助置入藥盒或協助服藥，及使用簡便之攜帶式血糖機驗血糖，屬日常生活、身體照顧服務，故可由照顧服務員執行。胰島素注射涉及診斷、治療之醫療業務，宜洽醫療機構或居家護理機構之護理人員協助服務。但對於「有行為能力且醫囑可自行施打胰島素者」，此時，照顧服務員依「個案要求」而「協助施行」胰島素注射，難謂違反現行護理人員法第 37 條規定。至家屬自行為其家人施行前述處置時，非屬執行業務之行為，尚未違反上開規定。

（註：本函釋說明三所敘本署 101.4.30.衛署照字第 1012862341 號函，請參閱 P.399）

102. 2. 21. 衛署照字第 1022860392 號函

主旨：所詢社區糖尿病居民需要協助注射胰島素，居家護理師是否可依據就診醫院之醫師醫囑給予胰島素注射衍生疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴校 102 年 1 月 10 日美科大護居字第 1020000242 號函。
- 二、護理人員之業務範圍，依據護理人員法第 24 條，及本署於 90 年 3 月 12 日以衛署醫字第 0900017655 號公告修訂護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款，護理人員執行醫療輔助行為，應在醫師之指示下行之。
- 三、爰此，居家護理所協助服務對象執行各項醫療輔助行為，應以醫囑為之，其方式可由服務對象提供就診醫院之醫師所開立或逕由貴所合約醫師提供，並應確保藥品來源、劑量、途徑、保存情形等。
- 四、至於醫院藥袋上之藥物名稱、劑量、途徑、給藥次數，不得作為醫囑之依據。

103. 4. 25 衛部照字第 1031560739 號函

主旨：有關 貴局所詢診所醫師診療後由醫師執行打針技術後再由非具護理人員資格之人員執行推藥及拔針行為，是否違反護理人員法規定一案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 4 月 1 日衛醫字第 1030007500 號函。
- 二、查於民國 75 年 12 月 26 日修正公布之醫師法，於 76 年 12 月 21 日施行(附件 1)，茲規定醫療機構聘用醫師之輔助人員資格，現依該法第 28 條但書第 2 款規定，對所謂醫師之輔助人員，應以具有護理人員、助產人員或其他醫事人員之資格者為之，合先敘明。
- 三、查靜脈注射藥物之醫療行為係屬入侵性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24

條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範疇，並前經本部 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋(附件 2)在案。

四、是以，所詢非具護理人員資格之人員執行推藥及拔針行為，若非具前揭醫事人員之資格者，已違反相關規定。

106.10.25 衛部照字第 1060132043 號

主旨：有關貴院函詢「給藥行為是否有違反調劑權」之疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴院 106 年 10 月 20 日奇柳藥字第 1061001576 號函。
- 二、依護理人員法第 24 條規定，略以：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」。
- 三、查本部（前行政院衛生署）98 年 11 月 30 日衛署醫字第 0980032955 號函，略以：「三、…90 年 3 月 12 日以衛署醫字第 0900017655 號公告修訂護理人員法第 24 第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，如輔施行侵入性檢查(治療或處置)、輔助各項手術、輔助分娩及輔助藥物之投與…等在案。四、次查，針劑注射(包含針劑之抽取)係屬醫療輔助行為，爰得在醫師就特定病人診察後，由護理人員依照醫囑執行之。……。」，先予敘明。
- 四、承上，貴院函詢「護理人員於病人需用藥時，將藥品針劑由瓶中溶解抽出稀釋至點滴後給藥之行為是否有違反調劑權之規定」乙節，查該行為係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為之範圍，護理人員得依醫囑執行行之，並無違反調劑權之疑義。

〔釋例類別〕 第 3 類 輔助傷口照護

89.11.1. 衛署醫字第 0890017033 號函

主旨：進行左手腕肌腱瘤手術中，為病患縫合傷口，屬醫療行為，應具醫師資格，始得為之，至於繫止血帶，則屬醫療輔助行為，得由護理人員依醫師指示行之，復請 查照。

說明：復 貴署 89 年 9 月 20 日中檢楠謙 89 偵 014753 字第 63153 號函。

89.12.18. 衛署醫字第 0890031326 號函

主旨：所詢護理人員在醫師指示下為門診患者拆線及填寫診斷書之行為，是否有違反醫療相關法令乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 11 月 17 日 89 北衛醫字第 75716 號函。
- 二、按診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療行為得在醫師指示下，由輔助人員為之，但該行為所產生之責任應由指示醫師負責。拆除縫線係屬手術連續過程之一環，應由醫師親自執行。
- 三、至於護理人員依醫囑協助開立診斷證明書，並交由醫師審核簽章，尚難認有違反醫師法第 28 條規定。

（註：本函釋說明二後段所敘「拆除縫線係屬手術連續過程之一環，應由醫師親自執行」乙節，業經 90.10.16. 衛署醫字第 090043784 號函補充解釋。）

90.10.16. 衛署醫字第 0900043784 號函

主旨：所詢拆除縫線是否為僅醫師始得為之的醫療行為，或護士得在醫師指示下所為之醫療輔助行為乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 7 月 9 日院賓刑毅字第 10973 號函。
- 二、按凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺或保健為直接目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察或診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部，總稱為醫療行為。

三、醫療行為可以區分為需由醫師親自執行之醫療行為，及得由醫療機構輔助人員，在醫師指導下執行之醫療行為。若係手術後之拆除縫線，因仍有相當程度之危險，宜由醫師親自為之，但簡易傷口之拆線，如經醫師診察，判斷傷口癒合情形良好，則可指示護理人員為之。本署 89 年 12 月 18 日衛署醫字第 0890031326 號函說明二後段「拆除縫線係屬手術連續過程之一環，應由醫師親自執行」，意旨未明，應予補充。

93.8.27. 衛署醫字第 0930022696 號函

主旨：貴所函詢侵入性醫療行為相關問題乙案，詳如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴所 93 年 4 月 19 日 93 誠文字第 9321 號函。
- 二、按「侵入性醫療行為」，係指醫療行為步驟中，採用穿刺（puncture）；或採用皮膚切開術（incision of skin）；或將器械、外來物置入人體來從事診斷或治療之行為，均屬之。
- 三、處置褥瘡之「清創術」，屬侵入性醫療行為。至其是否應由醫師親自執行，應由醫師視清創狀況決定，得在醫師指示下，由護理人員協助為之。

94.12.28. 衛署醫字第 0940068631 號書函

主旨：所詢貴轄財團法人長庚紀念醫院林口分院病患莊○○之護理紀錄單中記載，關於護理人員監督指導下由菲傭執行換藥行為是否違反醫護相關法規等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 12 月 8 日桃衛醫字第 0940041887 號函。
- 二、查傷口處置及換藥之醫療行為係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行

該項業務，依同法第 2 項規定，應在醫師之指示下行之。未具護理人員資格者，執行前述護理人員業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，本人及其雇主各處新臺幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。

- 三、至為維持個案身體清潔及衛生以增加舒適感，未具護理人員資格之看護執行有關褥瘡、氣切造口或癌症腫瘤所引發之傷口分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷及醫療輔助行為，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。是以，依據所附護理紀錄記載，本案菲傭執行氣切造口傷口照護之行為一節，請依個案事實認定，如前所述規定辦理。

（註：本函釋病患之名字以○○表示）

95.1.17. 衛署醫字第 0950000308 號函

主旨：所詢貴轄財團法人長庚紀念醫院林口分院病患莊○○之護理紀錄單中記錄，於護理人員監督指導下由菲傭執行氣切管周圍傷口擦藥及更換紗布之行為，是否係屬侵入性之醫療行為一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 1 月 2 日桃衛醫字第 0940044943 號函。
- 二、查氣切管周圍傷口擦藥及更換紗布之行為，係屬醫療輔助行為，應由醫師或護理人員依醫囑執行之；若係在醫師指示下，由未具護理人員資格者之菲傭依醫囑為之，應認屬違反護理人員法第 37 條之規定；如係未經醫師指示，即擅自執行前述醫療行為，則核屬違反醫師法第 28 條之規定。本案所述菲傭執行氣切管周圍傷口擦藥及更換紗布等行為，請依個案事實認定，如前所述規定論處。

（註：本函釋主旨段所敘病患之名字以○○表示）

96.5.31. 衛署醫字第 0960023008 號書函

主旨：所詢醫師未親自拆線，囑護理人員執行拆線，護理人員又請未取得證書之護校畢業生在護理人員指導下執行拆線業

務工作，是否違反護理人員法之相關規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 5 月 28 日高市衛保字第 0960018849 號函。
- 二、查「醫療行為可以區分為需由醫師親自執行之醫療行為，及得由醫療機構輔助人員，在醫師指導下執行之醫療行為。若係手術後之拆除縫線，因仍有相當程度之危險，宜由醫師親自為之，但簡單傷口之拆線，如經醫師診察，判斷傷口癒合情形良好，則可指示護理人員為之。」前經本署 90 年 10 月 16 日衛署醫字第 0900043784 號函釋在案，先予敘明。
- 三、次查，護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格者，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新臺幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」是以，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，不得獨立執行護理業務；其若執行護理業務，應在護理人員指導下為之，而其所為之護理紀錄，並應經指導護理人員簽名或蓋章，始為合法；未依前述規定執行護理業務者，則依違反護理人員法第 37 條規定論處。本案請依上揭規定辦理。

97.1.25. 衛署照字第 0972800485 號函

主旨：貴院所詢專科護理師置放之各類管路及縫合等醫療輔助行為之適法性乙案，復請 查照。

說明：

- 一、本署 97 年 1 月 15 日衛署照字第 0970060170 號函復貴院 97 年 1 月 8 日校附醫護字第 0971580002 號函計達。
- 二、按「侵入性醫療行為」，係指醫療行為步驟中，採用穿刺（puncture）；或採用皮膚切開術（incision of skin）；或將器械、外來物置入人體來從事診斷或治療之行為，

均屬之。前經本署 93 年 8 月 27 日衛署醫字第 0930022696 號函釋在案。爰此，將屬於外來物之 PICC (peripheral insert central catheter)、膀胱造瘻管、腎臟造瘻管、手術中置放 SSEP 頭針(頭皮內)置入人體，以為引流、抽吸或給藥等行為，應屬侵入性治療及處置。又前述管路置入因有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之。

三、次查，傷口縫合為高度專業技術，並具有相當程度之危險性，係屬手術連續過程之一環，應由醫師親自為之。專科護理師如執行前揭業務，業已逾越其專業人員法律之規定。至為死亡病人傷口縫合，非屬執行醫療業務。

四、另查，Sheath (Angiography, cardiac, IABP) 及 Pig-tail (胸、腹部) 等管路拔除，仍具有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之。至管路拔除後之皮膚傷口加壓止血，如經醫師診察、判斷後，得指示專科護理師協助為之。

五、檢送相關函釋 1 份供參。

97.3.4. 衛署醫字第 0970006105 號書函

主旨：有關 貴院受理 97 年度簡上第 6 號案件所詢事項，復請查照。

說明：

一、復 貴院 97 年 1 月 31 日桃院永刑明 97 簡上 6 字第 0970003486 號函。

二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療工作得在醫師指示下，由其他醫事人員依其各專門職業法律規定依醫囑為之。至前揭所稱醫事人員，依醫療法第 10 條第 1 項規定，係指領有中央主管機關

核發之醫師、藥師、護理師……等醫事專門職業證書之人員，先予敘明。

- 三、查「傷口拆除縫線」之醫療輔助行為，係屬手術連續過程之一環；另查「輔助各項手術」、「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。次查，「手術後之拆除縫線，因仍有相當程度之危險，宜由醫師親自為之，但簡易傷口之拆線，如經醫師診察，判斷傷口癒合情形良好，則可指示護理人員為之。」前經本署多次函釋在案。是以，「簡易傷口」是否有相關判定標準，及手掌 4 公分乘 0.5 公分之刀傷，是否屬「簡易傷口」一節，係屬醫療專業判斷事項，應由醫師視個案事實認定之。
- 四、至為病人縫合傷口為高度醫療專業技術，並具有相當程度之危險性，係屬手術連續過程之一環，應由醫師親自為之，未具醫師資格執行此業務者，應屬違反醫師法第 28 條規定。
- 五、另檢送陳○○醫師之醫事人員基本資料 1 份，請參考。

（註：本函釋當事人之名字以○○表示）

104.3.3 衛部照字第 1040004840 號函

主旨：有關 貴署所詢「病患手術後拆線與拆除引流管係由護理人員或醫師為之」案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 104 年 2 月 9 日雄檢瑞萬 103 醫他 100 字第 14799 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。

- 三、次查，醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 1 項第 2 款之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。
- 四、又查，護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。而上述所稱醫療輔助行為之範圍包括：輔助施行侵入性檢查；輔助施行侵入性治療、處置；輔助各項手術；輔助分娩；輔助施行放射線檢查、治療；輔助施行化學治療；輔助施行氧氣療法（含吸入療法）、光線療法；輔助藥物之投與；輔助心理、行為相關治療；病人生命徵象之監測與評估；其他經中央主管機關認定之醫療輔助行為，並前經本部 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函示（附件 1）在案。
- 五、而對於所詢手術後拆線，依本部（前行政院衛生署）97 年 3 月 4 日衛署醫字第 0970006105 號書函釋略以：「三、查『傷口拆除縫線』之醫療輔助行為，係屬手術連續過程之一環；另查『輔助各項手術』、『輔助施行侵入性治療、處置』，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。次查，『手術後之拆除縫線，因仍有相當程度之危險，宜由醫師親自為之，但簡易傷口之拆線，如經醫師診察、判斷傷口癒合情形良好，則可指示護理人員為之。』前經本署多次函釋在案。……。」（附件 2）。而上述所指本署多次函示在案之文係指本部（前行政院衛生署）90 年 10 月 16 日衛署醫字第 0900043784 號函有關拆除縫線是否為僅醫師始得為之的醫療行為，或護士得在醫師指示下所為之醫療輔助行為乙案（附件 3）。

- 六、至所詢拆除引流管係屬侵入性治療、處置，然因引流管態樣眾多，而 貴署來函意旨未明，故對於是否應由醫師親自執行，除依上開原則外，仍尚須視個案事實，始得認定。

〔釋例類別〕 第 4 類 輔助管路照護

90.6.6. 衛署醫字第 0900029999 號函

主旨：所詢護理人員法相關規定乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復台端 90 年 5 月 17 日來函。
- 二、按抽痰、氣切管、導尿管或其他插管之護理，為護理人員之業務；至於協助病患翻身、餵食、大小便處理，則非屬護理業務，可由不具護理人員資格者為之。
- 三、又護理人員法並無限制未領有護理師證書者，不得擔任護理長。

90.9.7. 衛署醫字第 0900056916 號函

主旨：所詢養護中心之護理人員可否在醫師指示下執行插管病患照護工作乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴中心 90 年 8 月 25 日信函。
- 二、查本署 88 年 9 月 9 日衛署醫字第 88056482 號函示：對老人執行插管照護，得由護理人員依醫師指示或醫囑為之。
- 三、副本抄送內政部，有關老人養護機構可否收容照護插管老人，檢附來函影本 1 份，請參處。

92.12.15. 衛署醫字第 0920063011 號書函

主旨：所詢導尿行為是否為護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款規定之醫療輔助行為，及學校護理人員是否可獨立在學校行使導尿等情乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 11 月 25 日衛醫字第 092303559 號函。
- 二、導尿行為係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員依醫師指示為之。學校護理人員是否可獨立在學校為個案施予導尿乙節，需依醫師指示，並視個案情況依醫囑為之。

93.12.28. 衛署醫字第 0930052157 號書函

主旨：所詢「鼻胃管置入術」是否為「侵入性治療、處置」？如鼻胃管置入術為「侵入性治療、處置」，是否在初次置入時，及其後因某種理由把鼻胃管全管拔出，重新插鼻胃管入胃時，都應由醫師指示下，始可由護理人員協助為之等情乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 台端 93 年 12 月 7 日濟文字第 931207 號函。
- 二、按「侵入性醫療行為」，係指醫療行為步驟中，採用穿刺（puncture）；或採用皮膚切開術（incision of skin）；或將器械、外來物置入人體來從事診斷或治療之行為，均屬之。前經本署 93 年 8 月 27 日衛署醫字第 0930022696 號函釋在案。爰此，將屬於外來物之鼻胃管經由病患鼻腔、咽喉、避開大氣管、深入食道到達患者胃部，以為引流、抽吸或灌食、給藥之行為，應屬侵入性治療及處置。
- 三、次按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由輔助人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫囑行之。查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。因鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之。

94.3.4. 衛署醫字第 0940005560 號函

主旨：所詢插入胃管、鼻管是否為侵入性的醫療行為？此等醫療行為是否須獲醫師之在場指示，方得由護士實施等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 94 年 2 月 2 日雄檢楠調 93 偵 15619 字第 8591 號函。
- 二、按「侵入性醫療行為」，係指醫療行為步驟中，採用穿刺（puncture）；或採用皮膚切開術（incision of skin）；或將器械、外來物置入人體來從事診斷或治療之行為，均屬之。前經本署 93 年 8 月 27 日衛署醫字第 0930022696 號函釋在案。爰此，將屬於外來物之鼻胃管經由病患鼻腔、咽喉、避開大氣管、深入食道到達患者胃部，以為引流、抽吸或灌食、給藥之行為，應屬侵入性治療及處置。
- 三、次按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得在醫師就特定病人診察後，由輔助人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條但書二之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。
- 四、至「該護士是否須領有合格的護士執照？是否須定期接受檢測或訓練」一節，查護理人員法第 1 條第 1 項規定：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依法領有護理人員證書者，得充護理人員。」同法第 2 條規定：「本法所稱護理人員，指護理師及護士。」爰此，領有護理人員證書，並依法申請執業登記者，始得執行護理業務。惟依同法第 37 條但書規定，護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。又現行護理人員法並無護理人員應定期接受訓練之規定。

五、檢送護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為範圍資料 1 份，請參考。

94.12.9.衛署醫字第 0940063696 號函

主旨：有關學校護理人員是否可獨立在學校執行導尿之相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復國立和美實驗學校 94 年 11 月 17 日和實學字第 0940003411 號函兼復中華民國學校護理人員協進會 94 年 11 月 25 日校護協(珍)字第 94084-1 號函。
- 二、查「導尿行為係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員依醫師指示為之。學校護理人員是否可獨立在學校為個案施予導尿乙節，需依醫師指示，並視個案情況依醫囑為之。」前經本署 92 年 12 月 15 日衛署醫字第 0920063011 號書函釋在案。
- 三、至依護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。爰此，護理人員執行護理人員法第 24 條所規定之業務，非僅限於醫療機構。是以，護理人員於學校擔任校護工作，並已依護理人員法第 8 條規定辦理執業登記，其有關執行護理業務及管理，自應依護理人員法之相關規定辦理。
- 四、又查醫師開立定時(間歇性)導尿之長期處方，交由護理人員執行該業務時，護理人員如確依導尿注意事項執行及善盡護理人員必要之注意，應無業務過失責任問題。又依醫師法第 11 條第 1 項規定，醫師對其診治之病人，均應再次對病人親自診療，始可再開給方劑。是以，有關醫囑有效期限一節，應由醫師依其專業知識判斷，確信可以掌握病情，在不違反相關法規下，依個案事實認定，至其醫療責任仍應由醫師負責。

94.12.29. 衛署醫字第 0940070563 號書函

主旨：所詢學校護理人員在學校執行導尿需依醫師指示為之，文中所稱「醫師」係指該校兼任校醫？或教學醫院醫師？或社區衛生所醫師？亦或所有開業醫師等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 94 年 12 月 19 日校護協(珍)字第 94085 號函。
- 二、按醫師法第 28 條第 2 款所稱「指示」，係指醫師就特定病人診察後，得交由護理人員或其他醫事人員，依護理人員法或其專門職業法律規定執行業務，所為之口頭或書面醫囑。是以，本案所詢學校護理人員在學校執行導尿需依醫師指示為之，文中所稱之「醫師」，依前所述，係指已依醫師法相關規定辦理執業登記，並對個案實際執行醫療業務而言。

95.6.12. 衛署醫字第 0950210769 號函

主旨：所詢護理機構之護理人員執行更換鼻胃管之疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 95 年 5 月 5 日雄院隆民禮 94 訴 2405 字第 22145 號函。
- 二、查醫師法第 28 條所稱「指示」，係指醫師就特定病人診察後，得交由護理人員或其他醫事人員，依護理人員法或其他專門職業法律規定執行業務，所為之口頭或書面醫囑，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。是以，本案所詢護理機構之護理人員執行更換鼻胃管之醫療輔助行為，需依醫師指示為之，文中所稱之「醫師」，依前所述，係指已依醫師法相關規定辦理執業登記，並對個案實際執行醫療業務而言。
- 三、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人

員依其專門職業法律所規定之業務，依醫囑行之。查鼻胃管置入係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍。因鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之。至受照護者之鼻胃管因故發生阻塞、滑脫或易位等情形，導致無法執行應有之功能，甚至引發呼吸道症狀時，護理人員應依護理專業施予必要之緊急處置後，依醫囑執行後續醫療處置事宜。

- 四、至「護理之家」、「居家護理」該兩業務項目之差異為何一節，依護理人員法第 15 條規定，護理之家及居家護理機構，皆係以罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人為服務對象，惟護理之家之服務對象係該機構之住民，尚包括生活起居之基本照護，如準備飲食、清洗衣物及個案身體清潔等，而居家護理服務之對象，則係居家個案之護理服務。

96.4.24. 衛署醫字第 0960016845 號書函

主旨：有關所詢安養機構外籍勞工，對有氣切造口之安養院民從事抽痰工作是否合法一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴辦公室 96 年 4 月 11 日天主教竹越字第 0960139 號函。
- 二、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。前揭所稱醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。又醫療工作之診

斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其各該專門職業法律之規定，依醫師指示行之，先予敘明。

- 三、查抽痰係屬侵入性治療、處置之醫療輔助行為；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行該項業務，依同法第 2 項規定，應在醫師指示下行之。爰此，未具護理人員資格者，執行前述護理人員業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，本人及其雇主各處新臺幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。
- 四、至為維持個案身體清潔及衛生以增加舒適感，由未具護理人員資格之外籍勞工或看護執行有關氣切造口所引發之傷口分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷及醫療輔助行為，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。是以，本案須視個案事實，依前所述規定辦理。

96.5.11. 衛署醫字第 0960019797 號書函

主旨：有關安養機構為住民執行更換鼻胃管、導尿管等侵入性行為疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 台端 96 年 4 月 30 日陳情書。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款所定於醫師指示下之行為，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。
- 三、查更換鼻胃管、導尿管係屬侵入性治療、處置之醫療輔助行為；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍。是以，有關長期鼻胃管留置及長期導尿管留置患者之定期更換，經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之。

96.5.22. 衛署醫字第 0960020317 號函

主旨：所詢護理師執行護理業務之相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 96 年 5 月 4 日高行獻紀丁 96 訴 00153 字第 0960003316 號函。
- 二、查護理人員係屬專門職業資格。依護理人員法第 1 條第 1 項規定：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依法領有護理人員證書者，得充護理人員。」同法第 2 條規定：「本法所稱護理人員，指護理師及護士。」爰此，領有護理人員證書，並依法申請執業登記者，始得執行護理業務；至未具護理人員資格，執行護理人員業務者，依同法第 37 條規定，本人及其雇主各處新臺幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰，惟依同法第 37 條但書規定，護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。先予敘明。
- 三、次查醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其專門職業法律所規定之業務，依醫囑行之。查鼻胃管、留置導尿管及氣切套管之更換置入係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍。因前述三管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管、留置導尿管全管拔除及需長期鼻胃管、導尿管及氣切套管留置病人之定期更換如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員依其專門職業法律之規定，依醫師法第 28 條但書二之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。
- 四、另依護理人員法第 26 條規定：「護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。」是以，護理人員執行護理業務應善盡注意之義務，視個案事實，認有病人危急，應依前揭之規定

，並依護理專業施予必要之緊急處置後，依醫囑執行後續醫療處置事宜。

97.1.22. 衛署照字第 0972800481 號函

主旨：台端針對護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為相關疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、台端 96 年 10 月 2 日就旨揭事項致本署署長信箱，經本署回復錄案與相關單位研議後再行回復一節，諒悉。
- 二、查護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為應在醫師指示下行之，所謂「醫師指示下」，係指醫師就特定病人診察後，交由護理人員，依護理人員法之相關規定執行醫療輔助行為，所為之口頭或書面醫囑而言。而該「指示」，可由醫師視工作狀況，自行斟酌指示方式，尚不以在場為要件。
- 三、次查，氣管插管置入係屬侵入性治療、處置，因具有相當程度之危險性，應由醫師親自為之，護理人員在醫師指導下，得協助醫師執行氣管插管置入。至專科護理師於值班醫師不在場之情況下，為休克病人插管遭申誠二次處分之法規依據為何一節，語意不明，可否提供具體資料憑辦。

97.3.5. 衛署醫字第 0970201201 號函

主旨：有關「放置鼻胃管」是否屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之「醫療輔助行為」一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 97 年 2 月 4 日北檢盛騰 95 調偵 592 字第 8010 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」之行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總

稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條但書二之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。先予敘明。

- 三、查將屬於外來物之鼻胃管經由病患鼻腔、咽喉、避開大氣管、深入食道到達患者胃部，以為引流、抽吸或灌食、給藥之行為，應屬侵入性治療及處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。惟查，「因鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之。」前經本署 93 年 12 月 28 日衛署醫字第 0930052157 號函釋在案。
- 四、是以，所附「台北市立聯合醫院資深護理師執行業務管理作業要點」之伍、十四點項下第(四)醫療輔助行為之第 18 點「放置鼻胃管」施行有無限制一節，應依前揭原則辦理。
- 五、檢送護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為範圍資料 1 份，請參考。

97.7.1. 衛署醫字第 0970206340 號書函

主旨：貴院基於審判案件所需，函詢「換氣管外管」之醫療輔助行為相關規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 97 年 2 月 26 日及 5 月 14 日中院彥刑祥 96 醫訴 7 字第 21039 號及第 52621 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之；其

餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，得指示由其他醫事人員依其專門職業法律規定依醫囑為之。由於醫療行為種類眾多，對於高風險之醫療行為（如醫療技術、檢查、檢驗及醫療儀器之操作等），涉屬病人安全之維護，基於對民眾健康及醫療品質之維護，降低醫療風險，應由醫師親自為之為宜，合先敘明。

三、次查「換氣管外管」之醫療輔助行為，係屬侵入性之治療、處置，惟氣管外管初次更換及拔除或氣切傷口不穩定病人之氣管更換，仍具有相當程度之危險性，應由醫師親自為之。至氣切傷口穩定需長期氣切套管留置病人之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得以指示護理人員協助為之。

四、至醫師法第 28 條第 2 款所稱「指示」，係指醫師就特定病人診察後，得交由護理人員或其他醫事人員，依各該專門醫事人員職業法律之規定（如護理人員法）執行醫療輔助行為，所為之口頭或書面醫囑而言。而該「指示」，可由醫師視工作狀況，自行斟酌指示方式，尚不以在場為要件，併予敘明。

97.9.11. 衛署醫字第 0970215426 號函

主旨：所陳有關外國人領有工作證可否從事「家庭看護 IN HOUSE NURSE」職業案，就 CARE GIVER 可否從事醫療行為及法定護理工作等乙案，復請 查照。

說明：

一、依據行政院秘書處 97 年 8 月 22 日臺衛字第 0970037194 號函及 97 年 8 月 5 日院臺衛移字第 0970034026 號移文單、外交部 97 年 8 月 13 日外亞太二字第 09712007610 號函及 97 年 8 月 5 日外亞太二字第 09703105050 號函、監察院 97 年 8 月 5 日(97)院臺業貳字第 0970161410 號函、內政部 97 年 8 月 12 日台內社字第 0970127629 號函辦理，兼復台端 97 年 7 月 28 日陳情書。

- 二、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人所為之醫療行為均屬之。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由輔助人員依醫囑行之。上述所稱輔助人員，其資格應符合各該類醫事人員管理法規之規定。資格不符規定之人員，若依醫囑執行前開醫療輔助行為，應分別依違反各該醫事人員管理法規規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。再予敘明。
- 三、復按我國護理人員法第 55 條之 3 規定，外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試及格，並依法領有護理人員證書及經中央主管機關許可者，始得執行我國護理人員法所定護理人員之業務。併予敘明。
- 四、另查導尿及抽痰等工作，係屬醫療業務行為，應由醫師親自為之，或依護理人員法，得由護理人員依醫師指示為之。未具護理人員資格者，若依醫囑執行前述業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。
- 五、又鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之；至為維持個案生理機能所需，及維護身體清潔及衛生以增加舒適感，由未具護理人員資格之照顧服務員執行鼻胃管灌食，及因置入鼻胃管所引發之分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷、醫療行為等，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。前經本署 96 年 4 月 27 日衛署照字第 0962800730 號函釋在案。
- 六、至單純之量血壓、脈搏及體溫，如未涉及診斷，尚難認屬醫療業務，一般民眾均可為之；惟如涉及疾病檢查、診斷與治療等醫療業務之整體連貫作業，係屬醫療行為，應由

醫師或由護理人員依醫囑行之。

- 七、是以，本案就 CARE GIVER 可否從事醫療行為及法定護理工作乙事，請參酌上開原則及規定辦理。

（註：本函釋說明五所敘本署 96.4.27 衛署照字第 0962800730 號函，請參閱 P.392）

97.10.3. 衛署醫字第 0970042471 號函

主旨：所詢有關為病患導尿是否需醫師親自為之，或得否由護士單獨為之而醫師不用在場疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 97 年 9 月 15 日士檢清揚 97 偵 1715 字第 28411 號函。

二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。合先敘明。

- 三、復按導尿行為係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員依醫師指示為之。至護理人員是否可獨立為個案施予導尿一節，需依醫師指示，並視個案情況依醫囑為之。前經本署 94 年 12 月 9 日衛署醫字第 0940063696 號函釋在案。

- 四、是以，本案請依上開原則，並就個案具體事實認定。

（註：本函釋說明三所敘本署 94.12.9. 衛署醫字第 0940063696 號函，請參閱 P.274）

101.1.20.衛署醫字第 1010061165 號函

主旨：所詢居家護理所護理人員是否需受過長期照護相關教育訓練並取得相關結訓證明，始可執行長照居家護理換管業務之疑義，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 1 月 17 日新縣衛醫字第 1010000849 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，得指示其他醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫囑執行之。合先敘明。
- 三、查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。次查「鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置者之定期更換、氣切傷口穩定需長期氣切套管留置者之定期更換，及尿管更換」，係屬侵入性治療、處置之醫療輔助行為，經醫師診察、判斷後，得指示護理人員為之。
- 四、又居家護理所之護理人員若無執行上開換管工作之歷練，得由該護理機構有實務經驗者訓練，或至長期照護學會、醫療機構及相關護理機構等訓練，以維護護理品質。

102.1.7.衛署照字第 1012865147 號函

主旨：所詢居家護理人員相關業務之合法性疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴校 101 年 12 月 20 日美科大護居字第 1010010499 號函。
- 二、有關居家護理師向家屬示範膀胱造瘻口、鼻胃管、導尿管及氣切等管路之更換，尚無不可。若家屬於發現家人（即居家服務對象）有管路自拔與滑脫等突發狀況，而有能力自行為其家人施行前述處理時，非屬執行業務之行為，尚

未違反相關醫事法規。

三、至於居家護理師於所服務轄區內，得依醫囑協助注射胰島素。

103.3.18 衛部照字第 1031560477 號函

主旨：有關 貴單位所詢學校護理人員得否依學生原診治醫師醫囑獨立在學校執行導尿醫療輔助行為之疑義乙案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據苗栗縣政府衛生局 103 年 2 月 26 日苗衛醫字第 1030005570 號函及苗栗縣頭份鎮建國國民小學 103 年 2 月 27 日苗建小人字第 1030000626 號函辦理。
- 二、查「導尿行為係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員依醫囑指示為之。學校護理人員是否可獨立在學校為個案施予導尿乙節，須依醫師指示，並視個案情況依醫囑為之。」前經本部 94 年 12 月 9 日衛署醫字第 0940063696 號書函釋在案。
- 三、另依本部 100 年 12 月 28 日衛署醫字第 1000084017 號函說明，若無醫師駐校時，學校護理人員亦得依個案原診治醫師醫囑執行醫療輔助行為。
- 四、是以，所詢學校護理人員依學生原診治醫師醫囑獨立在學校執行導尿醫療輔助行為並無違反醫療相關規定。惟執行業務時，並應善盡必要之注意義務，及確實遵守醫療處置等相關作業規範辦理。

104.1.21 衛部照字第 1041560008 號函

主旨：有關貴會陳情開放全國照護機構之照顧服務員在機構內可合法執行抽痰工作案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴會 103 年 12 月 36 日長照聯字第 103049 號函。
- 二、依據護理人員法第 24 條第 1 項及第 2 項規定：「護理人

員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。

- 三、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。前揭所稱醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其各該專門職業法律之規定，依醫師指示行之，合先敘明。
- 四、查抽痰係屬侵入性治療、處置之輔助行為；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行該項業務，依同法第 2 項規定，應在醫師指示下行之。爰此，未具護理人員資格者(如外籍勞工)，執行前述護理人員業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，爰此依目前相關法令，照顧服務員尚不可執行抽痰工作，但可協助抽痰物品之準備及抽痰後之環境整理工作，本部前於 97 年 9 月 11 日衛署醫字第 0970215426 號函在案。(詳本部 102 年 7 月 17 日修正公告之醫院照顧服務員管理要點)
- 五、次查日本「介護福祉士」(類似我國照顧服務員)可進行抽痰相關技術，惟其福祉士須經兩年訓練及取得福祉士認證資格後始得為之，與我國目前照顧服務員僅接受 90 小時訓練不同。
- 六、考量旨案陳情內容攸關全國長期照護機構人力業務及照護品質，本部非常重視，已請相關護理團體、學會研議並提供意見供本部研議，屆時將再回復 貴會。

105.10.11 衛部照字第 1050129689 號

主旨：有關貴校函詢「護理人員法所指醫療輔助行為」疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴校105年9月29日北特校學字第10530786700號函。
- 二、按護理人員法第24條第1項規定略以：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估、二、預防保健之護理措施、三、護理指導及諮詢、四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」及同法第26條：「護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。」及教育部主管各級學校緊急傷病處理準則第3條：「本準則所稱緊急傷病處理，係指學校應提供學生及教職員工在學校內發生事故傷害與疾病之急救及照護。」等規定，先予敘明。
- 三、再查本部(前行政院衛生署)95年6月12日衛署醫字第0950210769號函示略以：「三、……。至受照護者之鼻胃管因故發生阻塞、滑脫或異位等情形，導致無法執行應有之功能，甚至引發呼吸道症狀時，護理人員應依護理專業施予必要之緊急處置後，依醫囑執行後續醫療處置事宜。」
- 四、綜上所述，「氣切管或胃造瘻管滑脫重置」係屬護理人員法第24條第1項第4款之醫療輔助行為，爰護理人員執行該項業務時，應在醫師之指示下執行；惟學生在校時，若因故發生氣切管或胃造瘻管阻塞、滑脫或異位等情形，導致無法執行應有功能，護理人員應依護理專業施予必要之緊急處置，以維護個案之生命安全。

106.4.24 衛部照字第 1060111322 號

主旨：有關貴部函詢「脊柱裂」學生就醫，學校醫護人員得否依醫囑，協助渠導尿等相關行為乙節，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴部 106 年 4 月 17 日臺教授國字第 1060042153 號函。
- 二、按護理人員法第 24 條規定，略以：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。…。」。
- 三、查本部(前行政院衛生署)96 年 5 月 22 日衛署醫字第 0960020317 號函，略以：「二、…醫療工作之診斷醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其專門職業法律所規定之業務，依醫囑行之。…。」；再查本部 103 年 3 月 18 日衛部照字第 1031560477 號函，略以：「…導尿行為係屬醫療輔助行為，依護理人員法第 24 條第 2 項規定，得由護理人員依醫囑指示為之。學校護理人員是否可獨立在學校為個案施予導尿乙節，須依醫師指示，並視個案情況依醫囑為之。」
- 四、綜上，學校醫護人員得依學生原診治醫師醫囑獨立在學校執行導尿醫療輔助行為，惟執行業務時應善盡必要之注意義務，及確實遵守醫療處置等相關作業規範辦理。

106.10.11 衛部照字第 1060130282 號

主旨：有關函詢「學校人員能否予以學生胃造口灌食」案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴署臺教國署原字第 1060110252 號函。
- 二、查本部 96 年 4 月 27 日衛署照字第 0962800730 號函，略以：「二、……。醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其各

該專門職業法律之規定，依醫師指示行之，先予敘明。三、查『輔助施行侵入性治療、處置』係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍……。四、至為維持個案生理機能所需、及維護身體清潔及衛生以增加舒適感，由未具護理人員資格之照顧服務員執行鼻胃管灌食，及因置入鼻胃管所引發之分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷、醫療輔助行為及醫療行為等，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。」。

三、承上，因身體照顧之必要，為維持個案生理機能所需，且未涉及醫療專業判斷，非屬醫療業務行為，得由非醫事人員執行，尚無不可。

〔釋例類別〕 第 5 類 輔助牙齒及口腔照護

93.2.3. 衛署醫字第 0930000778 號書函

主旨：所詢護士、菲律賓醫學院牙醫系畢業尚未通過牙醫師考試及在大陸就讀醫學院者，可否在牙醫師指示之下，從事洗牙、換藥或補牙等工作乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 台端未具日期之陳情書。
- 二、查洗牙(包括清除牙結石、牙縫清洗)、補牙乃醫療行為，屬牙醫師業務範圍，應由牙醫師親自為之。換藥得由護理人員依醫師醫囑執行之。
- 三、有關菲律賓牙醫系畢業生及大陸就讀醫學院者得否回國實習之問題，按符合醫師法第 2 條至第 4 條規定所稱符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院醫學系、科畢業生，實習期滿且領有畢業證書者，得依據醫師法第 28 條第 1 款規定，在中央衛生主管機關認可之醫療機構，於醫師指導下實習，前經本署函釋在案。又前揭涉及國外院校採認之問題，請逕洽教育部。

95.12.28.衛署醫字第 0950066177 號書函

主旨：所詢護理人員得否從事牙科口腔衛生保健等情疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴診所 95 年 12 月 18 日童嘉字第 122 號函。
- 二、查洗牙(包括清除牙結石、牙縫清洗)及為病患裝拆矯正鋼線之行為，係屬牙醫師業務範圍，應由牙醫師親自執行，未取得牙醫師資格之助理人員從事上開行為者，應依醫師法第 28 條規定論處，前經本署多次函釋在案。
- 三、次查口腔衛生及刷牙方式之護理指導及措施，係屬護理人員法第 24 條所規定之業務，應由護理人員執行；至為牙科患者口腔塗氟係屬醫療輔助行為，可由護理人員依護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款之規定，在牙醫師指示下為之。爰此，本案請依前述規定辦理。

96.7.12.衛署醫字第 0960030349 號函

主旨：所詢牙醫診所使用具腐蝕性之藥塗抹病人牙齒方式使牙齒美白，是否應由牙醫師親自執行，護理人員可否依醫師指示執行該行為之疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 6 日高市衛醫字第 0960023422 號函。
- 二、查使用具腐蝕性之藥物塗抹病人牙齒，使其牙齒美白之方式，乃醫療行為，屬牙醫師業務範疇，應由牙醫師親自為之。未具牙醫師資格者執行前述醫療業務，應依違反醫師法第 28 條規定論處。

96.12.18.衛署醫字第 09600632869 號函

主旨：所詢「冷光美白時，塗抹牙齦保護劑或調整光源方向是否屬醫療行為，又得否由具有醫事人員資格之護理人員依醫囑為之」一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 96 年 11 月 28 日牙全政字第 2396 號函。
- 二、按醫療行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。先予敘明。
- 三、查「使用具腐蝕性之藥物塗抹病人牙齒，使其牙齒美白之方式，乃醫療行為，屬牙醫師業務範疇，應由牙醫師親自為之。未具牙醫師資格者執行前述醫療業務，應依違反醫師法第 28 條規定論處。」前經本署 96 年 7 月 12 日衛署醫字第 0960030349 號函釋在案，至塗抹牙齦保護劑係屬醫療輔助行為一節，得由護理人員依醫囑執行之。
- 四、另所述「調整光源方向是否醫療行為，又得否由具有醫事人員資格之護理人員依醫囑為之」一節，查牙齒冷光美白係於牙齒最外層之琺瑯質塗上過氧化氫漂白劑，藉由氧化作用達到美白效果，惟查，冷光美白整體醫療行為中能達到牙齒美白效果者為過氧化氫漂白劑，燈光照射僅係加速氧化作用達到美白效果。是以，牙齒冷光美白醫療過程中，為加速過氧化氫漂白劑氧化作用達到美白效果，協助調整光源方向之操作人員，尚無資格之限制。

96.12.20.衛署醫字第 0960064480 號書函

主旨：所詢「牙科助理人員」之工作內容是否涉及醫療行為，及該類人員得否由職業訓練機構與民間合作辦理職業訓練培訓一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴中心 96 年 11 月 30 日北輔字第 0960012764 號函。
- 二、按「醫療機構不得置臨床助理執行醫療業務」為醫療法第 58 條所明定。至醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。前揭所稱醫療行為，係指凡以治療、矯

正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱，先予敘明。

三、復按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療工作，得由各該相關醫事人員本其專門職業法律規定，依醫師指示操作執行。次查依本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函公告護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為之範圍：(一)輔助施行侵入性檢查。(二)輔助施行侵入性治療、處置。(三)輔助各項手術。(四)輔助分娩。(五)輔助施行放射線檢查、治療。(六)輔助施行化學治療。(七)輔助施行氧氣療法(含吸入療法)、光線療法。(八)輔助藥物之投與。(九)輔助心理、行為相關治療。(十)病人生命徵象之監測與評估。(十一)其他經中央衛生主管機關認定之醫療輔助行為。

四、本案經查所附牙科助理訓練課程，其中有關醫療過程中，如執行輔助施行侵入性檢查、治療與處置，及輔助藥物投與之醫療輔助行為，係屬護理人員業務範疇，業已涉及專門職業規定，非屬技能檢定。爰此，依前揭原則所示，有關訓練課程如涉及醫療輔助行為之執行，由職業訓練機構辦理職業訓練培訓，是有不妥。

97.10.6. 衛署醫字第 0970205478 號函

主旨：所詢學生健康檢查體檢項目中之「口腔檢查」(有無蛀牙、缺牙、牙周病、牙結石等)，是否為醫師法第 28 所定義之醫療業務行為，及執行該業務之醫師資格或輔助人員資格等疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴署 97 年 9 月 19 日板檢慎義學 97 交查 1481 字第 103910 號函。

- 二、按醫師法第 28 條所稱之醫療業務，係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人所為之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。上揭所稱醫療行為，係指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。另查，醫師法所稱之醫師，包括醫師、中醫師、牙醫師等三類別，三者係經由不同之專業教育與考試程序，領取不同之醫師證書，各有其醫療業務範圍，不得互相逾越，先予敘明。
- 三、又查，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之；其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由其他醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條但書二之規定意旨，依照醫囑執行之，並善盡必要之注意，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內；未具醫事人員資格者依醫囑執行醫療輔助行為，或資格不符規定之醫事人員依醫囑執行非其專門職業法律規定之業務，應分別依違反各該醫事人員管理法規規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。
- 四、次查，「體檢之口腔檢查應由牙醫師執行。」，前經本署 86 年 8 月 28 日衛署醫字第 86042218 號函釋在案。是以，本案所述情節，請依前揭原則，視個案事實，依權責認定辦理。

101.3.6. 衛署醫字第 1010063205 號函

主旨：所詢護理人員是否得以協助醫師執行綁牙線疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 2 月 22 日北市衛醫護字第 10130455300

號函。

- 二、查醫師法第 28 條所稱「醫療業務」，係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人所為之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。上揭所稱醫療行為，係指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱，先予敘明。
- 三、至所述「綁牙線」行為，意旨未明。惟查，病人矯正器鬆脫掉落時，為病人「矯正鐵線」、「調整鐵線」、「更換鐵線」之行為，如直接影響牙齒排列及治療結果之操作行為，應屬醫療行為，護理人員得依醫師指示協助為之；至於磨刮線頭、剪鐵線、線頭之行為，未涉及醫療行為。
- 四、是以，本案所述情節，請參酌上開原則，視個案事實認定。

103.4.16 衛部心字第 1031760660 號函

主旨：所詢醫院聘僱未具醫師及護理人員資格者，從事牙科助理業務疑義乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 3 月 6 日北市衛醫護字第 10331231200 號函。
- 二、按醫師法第 58 條明定「醫療機構不得置臨床助理執行醫療業務」。至醫療業務係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其條件。前揭所稱醫療行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱，先

予敘明。

三、復按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療工作，得由各相關醫事人員依其各該專門職業法律規定，依醫師指示操作執行。次查依本部 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函(詳附件)公告護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為之範圍包括：輔助施行侵入性檢查；輔助施行侵入性治療、處置；輔助各項手術；輔助分娩；輔助施行放射線檢查、治療；輔助施行化學治療；輔助施行氧氣療法(含吸入療法)、光線療法；輔助藥物之投與；輔助心理、行為相關治療；病人生命徵象之監測與評估；其他經中央主管機關認定之醫療輔助行為。

四、爰上，貴轄醫院聘僱「牙科助理」，該職稱易使人誤認為醫療行為之輔助人員，宜請審酌。另，所詢牙科助理業務，是否涉及醫療行為或醫療輔助行為，請依上開原則及個案事實審認。

106.3.14 衛部照字第 1061560602 號

主旨：有關貴局函詢「牙醫院所聘僱護理人員為病患執行牙模壓印、上橡皮筋(一般)、矯正後衛教，幫忙卸鋼絲、取模，是否合於法令規範」一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 106 年 2 月 9 日中市衛醫字第 1060011155 號函。

二、依護理人員法第 24 條規定，略以：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」。

三、查本部(前行政院衛生署)101 年 3 月 6 日衛署醫字第 1010063205 號函，略以：「二、……所稱醫療行為，係指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治

療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱…。三、……，病人矯正器鬆脫掉落時，為病人『矯正鐵線』、『調整鐵線』、『更換鐵線』之行為，如直接影響牙齒排列及治療結果之操作行為，應屬醫療行為，護理人員得依醫師指示協助為之；至於磨刮線頭、剪鐵線、線頭之行為，未涉及醫療行為。」。

四、綜上，有關所詢護理人員為病患執行牙模壓印、上橡皮筋等行為，請參酌上開原則，視個案事實認定。

〔釋例類別〕 第 6 類 輔助施行麻醉

93.5.21. 衛署醫字第 0930019130 號書函

主旨：所詢護理人員是否能在醫師指導下為病患施行脊椎麻醉疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 5 月 7 日北市衛三字第 09333088401 號函。
- 二、按麻醉係屬醫療行為，應具有醫師資格者始得為之。護理人員在醫師指導下，得協助醫師執行麻醉工作。

94.5.5. 衛署醫字第 0940011755 號函

主旨：有關貴署因業務所需，所詢麻醉護士張○○執行如附件所示之脊椎麻醉及硬脊膜外自體血液修補術之醫療行為，能否適用醫師法第 28 條但書第 2 款而排除該條之刑責一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 94 年 3 月 22 日彰檢榮校 94 偵 524 字第 10043 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、施行麻醉、病歷記載等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之

業務，依醫師法第 28 條第 2 款之規定意旨，依照醫囑執行之，但該行為所產生之責任應由指示醫師負責。

- 三、查脊椎麻醉及硬脊膜外自體血液修補術係屬侵入性治療、處置及手術，應由醫師為之；另查「輔助施行侵入性治療、處置」及「輔助各項手術」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。爰此，本案麻醉護士在醫師指導下，得協助醫師執行脊椎麻醉及硬脊膜外自體血液修補術之醫療輔助行為；如係未經醫師指示，即擅自執行前述醫療行為，則核屬違反醫師法第 28 條之規定。

(註：本函釋所敘當事人之名字以○○表示)

94.12.13. 衛署醫字第 0940063326 號書函

主旨：所詢具麻醉護士資格者，在醫師指示下，為「無痛分娩」療程之病患施行 Morphine 止痛劑 0.3mg 腰椎注射技術，是否違反醫師法第 28 條規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 11 月 22 日高市衛醫字第 0940040466 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、施行麻醉、病歷記載等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款之規定意旨，依照醫囑執行之，但該行為所產生之責任應由指示醫師負責。
- 三、查腰脊注射藥物之醫療行為係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。至腰椎注射過程中，擷取之注射部位涉及高度的專業判斷及操作技術時，應由醫師親自執行；至操作簡單、固定注射部位且著重注射技術層面，又注射過程中未涉及擷取部位之醫療判斷

時，在醫療機構受過麻醉專業訓練之護理人員得依其專門職業法律之規定，在醫師指導下，依醫囑操作執行。爰此，本案麻醉護士在醫師指導下，得協助醫師執行 Morphine 0.3mg 腰椎注射之醫療輔助行為；如係未經醫師指示，即擅自執行前述醫療行為，則核屬違反醫師法第 28 條之規定。

94.12.14. 衛署醫字第 0940064071 號函

主旨：所詢具有執照之護理人員，在醫師指示下，為病患施打麻醉藥物 citosol，是否違反醫師法第 28 條規定一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 11 月 28 日高市衛醫字第 0940041178 號函。
- 二、按「靜脈注射」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為，護理人員執行該項業務，依同條第 2 項規定，應在醫師之指示下行之。
- 三、查靜脈注射藥物之醫療行為係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。是以，本案護理人員在醫師指示下，得協助醫師執行靜脈注射麻醉藥物之醫療輔助行為。

103.5.6 衛部醫字第 1031663237 號函

主旨：所詢為病人靜脈注射 Citosol 麻醉藥物之人員資格疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、依據本部食品藥物管理署 103 年 5 月 1 日請辦事項轉台端 103 年 4 月 26 日致本部食品藥物管理署署長信箱辦理。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療工作得在醫師就特定病人診療後，由各該醫事人員本其專門職

業法律所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款規定之意旨，依醫師指示或醫囑為之。

三、查靜脈注射藥物之醫療行為，係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行該項業務，依同條第 2 項規定，應在醫師指示下行之。

四、綜上，旨揭所述情事，應由醫師或護理人員在醫師指示下，協助執行靜脈注射 Cytosol 麻醉藥物。

104.1.22 衛部照字第 1040101436 號函

主旨：有關貴局所詢護理人員得否於病人全身麻醉時，在醫師指示下為病人插氣管內管之業務一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復 貴局 104 年 1 月 14 日新北衛醫字第 1040048204 號函。

二、按醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為應在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師醫囑始得為之。

三、次查，護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。而上述所稱醫療輔助行為之範圍前經本部(前行政院衛生署)90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函示在案(附件 1)。

四、另本部(前行政院衛生署)前於 97 年 1 月 22 日衛署照字第 0972800481 號函釋有關護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為相關疑義案，略以：「二、查護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為應在醫師指示下行之，所謂『醫師指示下』，係指醫師就特定病人診察後，交由護理人員，依護理人員法之相關規定執行醫療輔助行為，所

為之口頭或書面醫囑而言。……。三、次查，氣管插管置入係屬侵入性治療、處置，因具有相當程度之危險性，應由醫師親自為之，護理人員在醫師指導下，得協助醫師執行氣管插管置入。…」(如附件 2)。

五、是以，所詢建請依前開釋示原則，並依個案事實認定。

(註：本函釋說明四所敘本署 97.1.22 衛署照字第 0972800481 號函，請參閱 P.279)

〔釋例類別〕 第 7 類 公共衛生預防保健

93.4.13. 衛署醫字第 0930013213 號書函

主旨：所詢護理人員為推展公共衛生及社區篩檢業務之需要，執行骨密度檢查，是否違反相關法規一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 3 月 29 日衛醫字第 0930010891 號函。
- 二、按骨密度檢查係屬醫療行為，得由醫事放射師、醫事檢驗師或護理人員依其專門職業法律規定，依醫師指示操作執行。衛生所受過特別訓練之護理人員，如係為推展預防保健公共衛生需要，依據衛生機關工作計畫，在不涉及診斷及治療行為下執行骨密度之簡易檢查，可視同在醫師指示下行之。
- 三、至有關社區整合式篩檢之骨密度檢查，可否由非醫事專業人員協助操作乙節，查與前述規定不符。

94.8.11. 衛署醫字第 0940033418 號書函

主旨：有關貴署因偵查案件需要，所詢具護士身分之人有無法令依據，在無醫師處方之情形下，對幼兒施打疫苗其所違反之法令為何乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴署 94 年 7 月 29 日投檢良忠 94 偵 121 字第 11689

號函。

- 二、查「學校保健員或衛生所之護士，依據衛生機關工作計畫或公函執行公共衛生預防接種工作，如：白喉、破傷風、日本腦炎、口服小兒麻痺等，可視同在醫師指導下或依據醫師處方執行醫療行為。」前經本署 72 年 1 月 4 日衛署醫字第 405771 號函釋在案。

94. 9. 27. 衛署醫字第 0940036029 號書函

主旨：為貴署因偵查案件需要，所詢具護士身分之人有無法令依據，在無醫師處方之情形下，對幼兒施打疫苗一案，前經本署 94 年 8 月 11 日衛署醫字第 0940033418 號書函回復在案(諒達)，惟有關該函釋法令依據為何一節，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 94 年 8 月 17 日投檢良忠 94 偵 121 字第 12699 號函。
- 二、查「醫師非親自診察，不得施行治療、開給方劑或交付診斷書。但於山地、離島、偏僻地區或有特殊、急迫情形，為應醫療需要，得由直轄市、縣(市)主管機關指定之醫師，以通訊方式詢問病情，為之診察，開給方劑，並囑由衛生醫療機構護理人員、助產人員執行治療。前項但書所定之通訊診察、治療，其醫療項目、醫師之指定及通訊方式等，由中央主管機關定之。」為醫師法第 11 條所明定。
- 三、按「預防接種注射」係屬醫療行為，護理人員執行該項業務時，依護理人員法第 24 條規定，應在醫師指示下為之；惟為因應台灣醫師人力過度集中都會區，對於地處偏遠地區民眾，由於醫療資源缺乏無支援醫師，無法享有可近性之保健服務，爰此，權宜學校保健員及衛生所受過訓練之護產人員，為推展預防保健公共衛生業務需要，依據衛生機關工作計畫或公函執行預防接種注射工作，如未涉及診斷、治療行為，尚屬可行，可視同在醫師指導下或依據醫

師處方執行醫療行為。

四、檢送傳染病防治法與兒童預防接種紀錄檢查及補種辦法各 1 份，請參考。

94.12.22.衛署醫字第 0940211278 號書函

主旨：所詢衛生所主任醫師，於實施子宮頸抹片檢查時，可否不由醫師在場實施，而逕由或委由衛生所之護士實施檢查？又各該衛生所實施子宮頸抹片檢查後，向中央健康保險局申請健保給付之依據為何？中央健康保險局如何給付等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 94 年 11 月 27 日嘉檢慎平偵瀆 6 字第 21751 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、施行麻醉、病歷記載等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療工作得由相關醫事人員依其各該專門職業法律之規定，依醫師指示下為之。查子宮頸抹片檢查係屬醫療行為，惟衛生所受過特別訓練之護產人員，為推展預防保健公共衛生業務需要，依據衛生機關工作計畫或公函，執行子宮頸抹片採樣工作，可視同在醫師指示下行之，如未涉及診斷、治療行為，尚屬可行，前經本署以 80 年 11 月 8 日衛署醫字第 982182 號函釋在案。
- 三、另查特約醫事服務機構提供全民健康保險預防保健服務，係依「全民健康保險預防保健實施辦法」之規定辦理，而該辦法於 94 年 11 月 10 日配合預防保健服務回歸公務預算修正發布前之第 4 條規定：「特約醫院及診所具有下列醫事人員實際負責作業，得申請辦理本保險預防保健服務；……(三)申請辦理婦女子宮頸抹片檢查者，應具有登記執業之專任婦產科醫師或家庭醫學科專科醫師。」同辦法第 11 條規定：各項預防保健服務之支付依全民健康保險醫療費用支付標準辦理。

95. 2. 17. 衛署醫字第 0958900060 號函

主旨：有關基層公衛護理人員執行疫苗接種業務說明，請 查照並轉知所屬。

說明：

- 一、預防接種是全球最重要之公共衛生業務。護理人員依據由醫師等相關專業人員參與訂定、經中央衛生主管機關頒布之疫苗接種時程、劑量、接種方式及接種部位執行預防接種，而且於接種前亦遵守提經本署預防接種諮詢委員會(ACIP)討論通過後訂定之「預防接種前幼兒健康評估表」相關規範，對幼兒先進行護理專業之評估後，再行施予疫苗接種，是一種依指示執行之醫療輔助行為，也是一種依法令之行為。
- 二、各種疫苗的接種，都有明確而可依循的流程，惟幼童接受預防接種，仍有其一定之風險存在。為此，本署訂有『預防接種受害救濟要點』，如依正常接種程序仍引起嚴重的疾病、殘障或死亡，可以依照前項要點，迅速獲得救濟。個案可以檢具有關資料送請本署審議，經審議如符合「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」之規定者，本署將撥發給最高新台幣 200 萬元之救濟金給予補助。
- 三、為使現行法令能有更明確之規範，並讓第一線之公衛護士，能無後顧之憂照顧國民健康，本署已立即研修傳染病防治法有關預防接種相關規定。在修法完成前，地方衛生主管機關可視地方醫療資源分布情形、民眾需求及衛生所、室人力配置，依實際之需要，適度調整疫苗接種之門診時間及作業流程，必要時可商請本署醫院予以支援。
- 四、本署對第一線護理同仁對臺灣衛生防疫保健的貢獻深表肯定，並期護理同仁繼續堅守崗位，為臺灣公共衛生的進步繼續努力，共創更卓越的未來。

95. 2. 22. 衛署醫字第 0950006758 號書函

主旨：所詢執行國小學童預防注射時，倘無醫師在場，由公衛護

士執行預防接種之適法性一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 2 月 15 日北市衛疾字第 09530970800 號函。
- 二、預防接種是全球最重要之公共衛生業務。護理人員依據由醫師等相關專業人員參與訂定、經中央衛生主管機關頒布之疫苗接種時程、劑量、接種方式及接種部位執行預防接種，而且於接種前亦遵守提經本署預防接種諮詢委員會(ACIP)討論通過後訂定之「預防接種前幼兒健康評估表」相關規範，對幼兒先進行護理專業之評估後，再行施予疫苗接種，是一種依指示執行之醫療輔助行為，也是一種依法令之行為。
- 三、各種疫苗的接種，都有明確而可依循的流程，惟幼童接受預防接種，仍有其一定之風險存在。為此，本署訂有『預防接種受害救濟要點』，如依正常接種程序仍引起嚴重的疾病、殘障或死亡，可以依照前項要點，迅速獲得救濟。個案可以檢具有關資料送請本署審議，經審議如符合「預防接種受害救濟基金徵收基準及審議辦法」之規定者，本署將撥發給最高新台幣 200 萬元之救濟金給予補助。
- 四、為使現行法令能有更明確之規範，並讓第一線之公衛護士，能無後顧之憂照顧國民健康，本署已立即研修傳染病防治法有關預防接種相關規定。在修法完成前，地方衛生主管機關可視地方醫療資源分布情形、民眾需求及衛生所、室人力配置，依實際之需要，適度調整疫苗接種之門診時間及作業流程，必要時可商請本署醫院予以支援。

95.3.27. 衛署醫字第 0950006873 號書函

主旨：所詢爰公共衛生需要，對國小學童蟯蟲肛門擦拭檢查陽性學童及同住家屬，由衛生所轉交該校護士，代為轉發 mebendazole 100mg/錠治療一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 2 月 16 日高市疾管護字第 0950000697 號函。
- 二、有關寄生蟲篩檢防治及治療，係屬集體預防醫學措施。依據學校衛生法所定之學生健康檢查實施辦法之相關規定，學校實施學生健康檢查，應委託醫院承辦，至公共衛生護士經由專家、學者參與討論定案之學童蛻蟲肛門擦拭檢查與投藥建議，對於檢查結果為陽性之罹患者，先進行護理專業之評估，確定罹患者無相關過敏病史、特殊體質及投藥禁忌後，再逕予投藥，尚無不可。

95.5.19.國健兒字第 0950500341 號函

主旨：有關 貴局所陳 貴市執行「國小學童蟲檢查肛門擦拭檢查陽性學童及同住家屬之投藥方式」函請備查乙案，請依權責自行妥處，請 查照。

說明：

- 一、依據行政院衛生署 95 年 5 月 12 日衛署醫字第 0950019676 號移文單及貴局 95 年 5 月 10 日高市衛疾管護字第 0950015841 函辦理。
- 二、相關規定仍請依據行政院衛生署 95 年 3 月 27 日衛署醫字第 0950006873 號書函辦理。

95.6.20.衛署醫字第 0950023419 號書函

主旨：所詢學校校護配合公共衛生推展，代為轉發「頭蝨藥」、「寄生蟲(蛻蟲及蛔蟲)藥」供所屬個案(學生)治療及同住家屬之預防性投藥，可否視同在醫師指導下執行醫療業務而不受醫師法第 28 條第 1 項之規範，及上述分藥行為是否符合藥事法相關規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 6 月 2 日投衛局醫字第 0950300611 號函。
- 二、有關寄生蟲篩檢防治及治療，係屬集體預防醫學措施。學校實施學生健康檢查，發現學生感染頭蝨傳染病時，由校

護協助領取非處方藥品之治療頭蝨洗劑(係醫師藥師藥劑生指示藥品)，交由感染學生及接觸者預防性使用，尚無不可，亦無違反藥事相關法規。

- 三、至蟯蟲及蛔蟲篩檢防治及治療一節，請依本署 95 年 3 月 27 日衛署醫字第 0950006873 號書函(見附件)相關規定辦理。

95.9.8. 衛署醫字第 0950214046 號書函

主旨：所詢助產人員執業於衛生所，是否可擔任注射疫苗工作疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 8 月 1 日苗衛疾字第 0950100211 號函。
- 二、按「疫苗接種」係屬於醫療輔助行為。
- 三、查助產人員法第 25 條規定：「助產士業務如下：(1)接生。(2)產前檢查及保健指導。(3)產後檢查及指導。(4)嬰兒保健指導。(5)生育指導。(6)其他經中央主管機關認定之項目。」同法第 27 條規定：「助產人員於執行正常分娩之接生時，得依需要施行灌腸、導尿、會陰縫合及給予產後子宮收縮劑等必要事項」。
- 四、基於推展預防保健、公共衛生業務所需，助產人員依醫囑執行預防接種注射之醫療輔助行為，可視同前開助產人員法第 25 條第 1 項第 6 款「其他經中央主管機關認定之項目」。
- 五、助產人員執行疫苗接種業務，應依中央衛生主管機關頒布之疫苗接種時程、劑量、接種方式及接種部位等相關規定，善盡業務上必要之注意，依疫苗注射注意事項確實執行，並接受預防注射相關之繼續教育或在職訓練，以確保服務品質。

95.9.28. 衛署醫字第 0950039264 號書函

主旨：有關 貴會對從事醫事檢驗業務資格人員疑義一案，復請

查照。

說明：

- 一、復 貴會 95 年 9 月 4 日(95)醫檢所協華字第 950014 號函。
- 二、臨床檢驗固屬醫事檢驗人員之醫事檢驗業務，惟亦屬醫師法上醫療業務中之臨床病理領域範疇，是以，除得由醫師指示醫事檢驗人員執行外，醫師亦得親自為之。
- 三、至公共衛生護理人員為推展預防保健、公共衛生業務需要，所執行之血糖、尿、尿蛋白等之簡易篩檢，亦屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之業務範疇，為社區個案健康管理時之重要工具，是以，護理人員得依醫師指示或醫囑，協助民眾執行之。

96.6.25. 衛署醫字第 0960025514 號書函

主旨：所詢為增進民眾健康及推動有利健康之公共衛生政策，公共衛生護理人員需至社區進行簡易抽血，執行人員是否不受護理人員法第 24 條及醫師法第 28 條之限制等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 6 月 11 日雲衛保字第 0965000176 號函。
- 二、按公共衛生護理人員為推展預防保健、公共衛生業務需要，至社區採集簡易血液檢體篩檢(血糖、血脂)，亦屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之業務範疇，以早期發現個案及轉介治療，為社區個案健康管理時之重要工具。是以，護理人員應依醫師指示或醫囑，協助民眾執行之。
- 三、至衛生所附設群體醫療中心因人力精簡或無醫師編制時，建議可商請鄰近之醫療機構或衛生所醫師，依醫師法第 8 條之 2 規定前往支援，以利公共衛生業務之推展。

96.7.6. 衛署醫字第 0960027479 號函

主旨：所詢公共衛生護士得否單獨執行注射疫苗職務等疑義一案

，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 96 年 6 月 21 日北檢盛號 96 他 3676 字第 42980 號函。
- 二、預防接種是全球最重要之公共衛生業務。查本署 72 年 1 月 4 日衛署醫字第 405771 號函釋之意旨，係指護理人員依據由醫師等相關專業人員參與訂定、經中央衛生主管機關頒布之疫苗接種時程、劑量、接種方式及接種部位執行預防接種工作，而且於接種前亦遵守提經本署預防接種諮詢委員會（ACIP）討論通過後訂定之「預防接種前幼兒健康評估表」相關規範，對幼兒先進行護理專業之評估後，再行施予疫苗接種，本質上應屬於依指示執行之醫療輔助行為，也是一種依法令之行為。是以，護理人員依前揭規定單獨執行注射疫苗業務，尚無違反醫師法第 28 條之規定。
- 三、為使現行法令能有更明確之規範，95 年 6 月 14 日修正之傳染病防治法第 4 條第 3 項增訂預防接種相關規定：「第一項所稱預防接種業務得由護理人員執行之，不受醫師法第 28 條規定之限制；其預防接種施行之條件與限制、預防接種紀錄之檢查與補行接種及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。」併予敘明。

96.10.12. 衛署醫字第 0960045197 號函

主旨：有關中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會所提公共衛生護士於居家訪問時逕行採驗老人血糖、膽固醇，明顯不符醫事檢驗師法等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 10 月 1 日衛醫字第 0960041103 號函。
- 二、查測量血糖、膽固醇係屬醫療輔助行為，為提供醫師診斷與治療之參考。至公共衛生護理人員為推展預防保健、公共衛生業務需要，至社區所執行之血糖、尿糖、尿蛋白等之簡易篩檢，亦屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫

療輔助行為之業務範疇，為社區個案健康管理時之重要工具。是以，護理人員得依醫師指示或醫囑，協助民眾執行之。前經本署 95 年 9 月 28 日衛署醫字第 0950039264 號及 96 年 6 月 25 日衛署醫字第 0960025514 號函釋在案。

- 三、是以，簡易血液檢體（血糖、血脂）之篩檢業務，係屬跨專業領域重疊性之業務，得由醫師或醫事檢驗人員、護理人員依其各該專門職業法律規定，依醫師指示操作執行。爰此，公共衛生護士依護理人員法第 24 條規定，依醫囑協助民眾執行前述簡易血液篩檢，並無不可；如係未經醫師指示，即擅自執行前述醫療輔助行為，則核屬違反醫師法第 28 條之規定。

103.5.7 衛部醫字第 1031663198 號函

主旨：所詢結核菌素測驗及卡介苗接種技術受訓合格之護理人員，執行結核菌測驗判讀之適法疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴署 103 年 4 月 1 日疾管愛核字第 1030300414 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療工作得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法律所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款規定之意旨，依醫師指示或醫囑為之。
- 三、次查，傳染病防治法第 28 條第 1 項規定：「主管機關規定之各項預防接種業務及因應疫情防治實施之特定疫苗接種措施，得由受過訓練且經認可之護理人員施行之，不受醫師法第二十八條規定之限制。」
- 四、是以，主管機關為杜絕傳染病之發生、傳染及蔓延，擬定結核病防治政策，由曾接受訓練及定期評價合格之護理人員，依「結核病防治工作手冊」作業規定（預立醫囑）內容，將結核菌素測驗判讀結果，提供醫師作為診斷及醫療處置參考，尚無不法。

五、本案應依前揭規定及原則辦理。

106.7.12 衛部照字第 1061561830 號

主旨：有關貴局函詢「所屬 12 區健康服務中心護理人員為疑似傳染病人之接觸者採檢行為疑義」一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴局 106 年 6 月 21 日北市衛疾字第 10635326300 號函。

二、有關旨揭疑義，依本部所屬疾病管制署說明如下：

(一)按傳染病防治法第 46 條第 1 項第 1 款之規定，略以：「傳染病檢體之採檢、檢驗與報告、確定及消毒，應採行下列方式：一、採檢：傳染病檢體，由醫師採檢為原則；接觸者檢體，由醫師或其他醫事人員採檢；環境等檢體，由醫事人員或經採檢相關訓練之人員採檢。採檢之實施，醫事機構負責人應負督導之責；病人及有關人員不得拒絕、規避或妨礙。…。」，先予敘明。

(二)再查傳染病防治法立法之目的，係在於杜絕傳染病之發生、傳染及蔓延，依該法所為之採檢係屬為配合公共衛生與防疫政策之實務需要，以保全公共利益為目的之防疫作為；復考量護理人員乃經專業教育養成，其實施接觸者採檢前，尚需獲得當地衛生局或健康服務中心負責人同意並受其監督。是以，護理人員執行傳染病防治法所定其對接觸者採檢之任務，係屬依法令規定之職務行為。

三、綜上，有關護理人員依傳染病防治法對傳染病個案及接觸者執行之採檢工作，請依上開規定辦理。

106.10.20 衛部照字第 1060028933 號

主旨：有關函詢事業單位從事勞工健康服務護理人員施打流感疫苗之疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴學會 106 年 10 月 13 日台事護(106)滿字第 0000192 號函。
- 二、有關「職場員工欲進行流感疫苗之接種，是否可由事業單位從事勞工健康服務護理人員是否可逕行執行之」疑義乙節，依本部所屬疾病管制署公告 106 年度流感疫苗接種計畫第五章接種作業之第 4 節醫事相關工作人員之接種作業之伍、健康評估「接種前應發給接種須知、量測體溫，並經醫師診察評估，同時於評估醫師欄簽章，並請接種者於接種名冊之同意接種簽名欄簽名。」，爰施打流感疫苗前須先由醫師診察評估後，護理人員再予協助施打流感疫苗。

〔釋例類別〕 第 8 類 輔助醫療儀器檢測

85.5.20. 衛署醫字第 85008524 號函

主旨：所詢為病患量血壓是否係護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所規定之醫療輔助行為？須具備何種資格之人始得為之乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴署 85 年 2 月 6 日嘉檢耀謙字第 02671 號暨 85 年 5 月 1 日嘉檢耀謙字第 08453 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」之行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部，均屬之。
- 三、查護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署以 82 年 6 月 29 日衛署醫字第 8246034 號公告如附件。
- 四、按單純之量血壓，如未涉及診斷，尚難認屬醫療業務，一般民眾均可為之；惟如涉及疾病檢查、診斷與治療等醫療

業務之整體連貫作業，係屬醫療行為，應由醫師或由護產人員依醫囑行之，本案請參酌上開原則依個案事實認定之。

86.2.1. 衛署醫字第 86000412 號函

主旨：僅持有考試院檢覈及格證書執行護理業務應依護理人員法第幾條懲處，及洗眼睛及紅外線眼睛照射之醫療儀器操作是否屬護理人員之業務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處 86 年 1 月 3 日衛五字第 850095210 號函。
- 二、護理人員法第 1 條規定：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。」同法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰」。依上開規定，僅持有考試院護理師或護士檢覈及格證書者，於尚未領取護理師或護士證書前，仍未具備護理人員資格，其執行護理業務，應依違反護理人員法第 37 條規定論處。惟因已經考試及格，具備取得護理人員之要件，祇因程序未完成，可依法從輕處罰。
- 三、醫療機構之護士，依照醫師之處方指示，可為患者洗眼睛。另紅外線眼睛照射之醫療儀器操作是否屬護理人員業務乙節，請提供該儀器之工作原理、功能說明及理論效果等資料憑處。

86.5.21. 衛署醫字第 86020733 號函

主旨：紅外線眼睛照射之醫療儀器操作是否屬護理人員業務乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處 86 年 4 月 14 日衛五字第 860021111 號函。
- 二、依所附資料，該紅外線眼睛照射儀器，為無須申領許可證之醫療器材，得依醫師之指示，由護理人員操作。

95.3.8. 衛署醫字第 0950009157 號書函

主旨：所詢衛生所之護理人員，因業務需求，在醫師指示下執行驗孕或心電圖檢查(不具判讀之用)，是否逾越醫師法第 28 條或醫事檢驗師法第 12 條相關規範一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 3 月 3 日北衛醫字第 0950014269 號函。
- 二、查簡易之驗孕及心電圖檢查操作業務，係屬跨專業領域重疊性之業務，得由醫事檢驗人員或護理人員依其專門職業法律規定，依醫師指示為之。

96.2.5. 衛署醫字第 0960005075 號書函

主旨：所詢衛生保健志願服務人員可否為民眾測量血壓、體溫、體重及血糖一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 1 月 30 日北衛企字第 0960005609 號函。
- 二、按單純之量血壓、體溫及體重，如未涉及診斷，尚難認屬醫療業務，一般民眾均可為之；惟如涉及疾病檢查、診斷與治療等醫療業務之整體連貫作業，係屬醫療輔助行為，應由醫師或由護理人員依醫囑為之，本案請參酌上開原則依個案事實認定之。
- 三、至測量血糖屬醫療輔助行為，係提供醫師診斷與治療之參考數據，應由醫師或護理人員、醫事檢驗人員依醫師指示為之。是以，由未具前該醫事人員資格者測量血糖，查與前述規定不符。

97.4.3. 衛署醫字第 0970014380 號函

主旨：有關執行超音波影像、骨密度及紅外線掃描等業務人員資格一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 97 年 3 月 21 日義醫字第 09700371 號函。
- 二、查有關超音波檢查、骨密度及紅外線掃描等之操作業務，

係屬跨專業領域重疊性之業務。按本署前於 93 年 7 月 27 日召開「研議醫用超音波影像、骨密度及紅外線掃描等業務人員資格」協調會之會議決議，略以：

- (一)超音波檢查過程中，操作者擷取之影像部位會影響醫療專業判斷時，應由醫師親自執行，至簡單超音波檢查，操作過程中未涉及影像部位擷取之選擇，著重機器操作技術層面，在醫療機構之醫事放射人員、醫事檢驗人員及護理人員得依其各該專門職業法律之規定，在醫師指導下，依醫囑操作執行。
- (二)骨密度檢查方式目前有三種：(1)非游離輻射：超音波。(2)游離輻射：X 光線。及(3)核子醫學(同位素攝影)。醫事放射人員在醫師指示下，可執行前三種檢查方式；至於 89 年 2 月 3 日醫事放射師法公布之前，在醫療機構已從事超音波操作業務，且目前仍繼續執行該項檢查業務之醫事檢驗人員及護理人員，其在醫師指示下，得執行骨密度超音波檢查。
- (三)紅外線影像造影之掃描操作，宜由醫事放射人員在醫師指示之下執行之。
- (四)為保障民眾安全及權益、維持醫療品質及避免醫療資源浪費，超音波檢查宜由醫師親自操作，或醫療機構經醫師診視後，在醫師指導下，得由醫事放射人員、醫事檢驗人員及護理人員依其各該專門職業法律之規定執行之。

三、檢附上開會議紀錄 1 份，供參。

97.8.29. 衛署醫字第 0970034654 號函

主旨：有關護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款醫療輔助行為疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 7 月 15 日嘉衛保字第 0970016928 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等

醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之；其餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，得指示由其他醫事人員依其各該專門職業法律規定依醫囑為之。由於醫療行為種類眾多，對於高風險之醫療行為(如醫療技術、檢查、檢驗及醫療儀器之操作)，涉屬病人安全之維護，基於對民眾健康及醫療品質之提升，降低醫療風險，應由醫師親自為之，合先敘明。

三、復按一般視力檢查與眼底鏡檢查(或點散瞳劑)係屬醫療行為，應由醫師或由醫事檢驗師、護理人員依其專門職業法律規定，並依醫師指示操作執行。衛生所受過特別訓練之護理人員，如係為推展預防保健公共衛生需要，依據衛生機關工作計畫，在不涉及診斷及治療行為下執行一般視力(如燈箱型 E 字視力表、NTU 亂點立體圖及紅藍眼鏡等)之簡易篩檢，可視同在醫師指示下行之。至執行眼底、眼壓檢查或點散瞳劑等醫療業務，因涉及診斷及處方之醫療行為，基於對病人或民眾健康及安全之維護，建議在經醫師親自診察後，由醫師親自為之或可指示由其他醫事人員依其各該專門職業法律規定依醫囑為之。

四、另本署為提升聽力檢查業務品質，刻正研擬聽力師法草案，俟本法完成立法程序後，聽力檢查業務之執行，應由取得聽力治療師證書人員，始得執行。至本法完成立法程序前，聽力檢查人員尚無資格之限制。

97.9.5. 衛署醫字第 0970208776 號函

主旨：所詢有關運動心電圖係屬醫療行為或醫療輔助行為等疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 台端 97 年 7 月 31 日來函。

二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目

的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。合先敘明。

- 三、查運動心電圖之檢測係屬醫療輔助行為，復依醫事檢驗師法第 12 條規定，醫事檢驗師業務包含臨床生理檢驗，爰具醫事檢驗師執照資格者，可依醫師醫囑執行該項檢查業務，以提供醫師診斷與治療之參考。
- 四、復查護理人員法第 24 條亦規定，護理人員得在醫師之指示下從事醫療輔助行為，至前開所稱醫療輔助行為之範圍，自應依本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函修正公告之規定認定（依所附資料諒悉）。
- 五、醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務，於醫療法 57 條即有明定。又同法第 68 條規定，醫療機構應督導其所屬醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。違者，將依同法第 102、103 及 107 條規定論處。
- 六、復按健康檢查作業流程中非屬上開說明二所稱應由醫師親自執行之醫療行為者，得在醫師指示下，由各該醫事人員依其專門職業法規規定為之。至健康檢查結果之總評及建議，涉及醫療專業判斷，應由醫師親自為之。是以本案醫院之健檢中心是否得由護理人員非經醫師就個案診視後指示之情形下，逕行安排並進行其運動心電圖之檢查業務乙節，除依上開原則外，仍尚須視個案事實及具體事證查明後，方得予以認定。
- 七、另如發現醫療機構疑有違反相關法規規定之情事時，建請得檢具相關具體事證，逕向當地衛生局提出檢舉，以為查處。

97.10.5. 署醫字第 0970083172 號函

主旨：所詢有關員工健康檢查使用音叉從事聽力檢測是否為醫療輔助行為疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 9 月 11 日北衛心字第 0970094213 號函。
- 二、按聽力檢查業務，於醫事聽力師立法完成前，尚無法界定其是否專屬聽力師之業務範疇，爰目前仍得由其他醫事人員依其各該專門職業法律之規定，在醫師指示下執行之。
- 三、是以，本案應依上開原則，並視個案事實予以認定。

97.10.22. 衛署醫字第 0970043357 號函

主旨：所詢有關合格護士依醫師之檢驗處方（門診之檢驗處方或健檢之通囑）操作運動心電圖、或內視鏡等是否合法疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 97 年 9 月 24 日西園醫字第 244 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款之規定意旨，依照醫囑執行之。
- 三、所詢有關運動心電圖之檢測乙節，檢附本署 97 年 9 月 5 日衛署醫字第 0970208776 號函釋在案之抄本(如附件)供參。
- 四、另按「侵入性醫療行為」，係指醫療行為步驟中，採用穿刺；或採用皮膚切開術；或將器械、外來物置入人體來從事診斷或治療之行為，均屬之。是以，內視鏡檢查屬侵入性醫療行為，因仍有相當程度之危險性，應由醫師親自為之。護理人員則得依其專門職業法規之規定，在醫師指導下，協助醫師執行侵入性檢查。

五、本案除依上開原則外，仍尚須視個案事實認定。

97.11.4. 衛署醫字第 0970086877 號函

主旨：有關員工健康檢查，非醫事人員從事色盲檢測是否違反醫療相關法規疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴院 97 年 10 月 28 日北衛心字第 0970110178 號函。

二、查「體格檢查係屬醫療業務，其檢查項目中之身高、體重測量及色盲檢查，得由醫師指示其他醫事人員為之，但體格檢查結果之綜合判斷，應具備醫師資格者始得為之。」前經本署 91 年 7 月 3 日衛署醫字第 0910038519 號函釋在案。

三、另查，「色盲檢測」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱之醫療輔助行為，護理人員執行該項業務，依同條第 2 項規定，應在醫師之指示下為之；未具護理人員資格者，在醫師授意或監督下執行該項護理人員業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，則應依同條規定論處。

98.5.7. 衛署醫字第 0980013103 號函

主旨：所詢有關骨質密度檢測相關疑義一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴委員國會辦公室 98 年 5 月 5 日簡便簽。

二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」，係凡指以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在

場指示或目視所及範圍以內。

- 三、查本署 92 年 6 月 10 日衛署醫字第 0920213572 號函釋略以，按醫用超音波、骨密度及紅外線掃描之操作業務，係屬跨專業領域重疊性之業務，得由各該相關醫事人員依其專門職業法律規定，並依醫師指示操作執行。
- 四、復查本署 93 年 7 月 27 日召開「研議超音波影像、骨密度及紅外線掃描等業務人員資格」協調會之會議決議略以，骨密度檢查方式目前有三種：(1)非游離輻射：超音波。(2)游離輻射：X 光線。及(3)核子醫學(同位素攝影)。醫事放射人員在醫師指示下，可執行前三種檢查方式；至於 89 年 2 月 3 日醫事放射師法公布之前，在醫療機構已從事超音波操作業務，且目前仍繼續執行該項檢查業務之醫事檢驗人員及護理人員，其在醫師指示下，得執行骨密度超音波檢查。另為推展預防保健公共衛生需要，護理人員依據衛生機關工作計畫，在不涉及診斷及治療行為下，執行骨密度超音波之簡易檢查，可視同在醫師指示下行之。
- 五、另有關社區整合式篩檢之骨密度檢查，可否由非醫事專業人員協助操作，核與規定不符，前經本署 93 年 4 月 13 日衛署醫字第 0930013213 號函釋在案。
- 六、是以，本案有關使用 DXA 儀器(雙能 X 光吸收儀；屬游離輻射方式)，或 QUS 儀器(定量超音波；屬非游離輻射方式)進行骨質密度檢測之操作人員資格，應依上開規定及原則分別認定辦理。至檢測結果之說明，如涉及診斷或處置之情形時，則應由醫師說明為宜。

98.9.24. 衛署醫字第 0980027951 號函

主旨：所詢有關執行眼科手術前之 K 值、DBR 檢測是否為醫療輔助行為疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、依據中華民國眼科醫學會 98 年 9 月 18 日中眼台(98)字第 174 號函辦理，兼復 貴局 98 年 9 月 9 日北衛心字第

0980108358 號函。

- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」，係凡指以治療、矯正或預法人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之。復按護理人員之業務範圍，於護理人員法第 24 條及本署 90 年 3 月 12 日以衛署醫字第 0900017655 號公告，業分別定有明文。
- 三、次查，眼科 K 值與 DBR 檢測，係屬醫療輔助行為。又前開 K 值與 DBR 值之測定，其準確度攸關白內障手術是否理想之直接結果。爰依上開規定，得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑始得為之。非醫事人員自不得執行之。
- 四、是以，本案請依上開規定及原則，就個案事實本於權責認定。

104.1.16 衛部照字第 1040100860 號函

主旨：有關貴局所詢護理人員執行物理治療師相關業務是否涉及違法一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 1 月 9 日衛醫字第 1040000260 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療工作得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法律所規定之業務，依醫師法第 28 條第 2 款規定之意旨，依醫師指示或醫囑為之。
- 三、查物理治療師法第 15 條規定：「物理治療師業務如左：
一、物理治療之評估及測試。二、物理治療目標及內容之

擬定。三、操作治療。四、運動治療。五、冷、熱、光、電、水、超音波等物理治療。六、牽引、振動或其他機械性治療。七、義肢、輪椅、助行器、裝具之使用訓練及指導。八、其他經中央衛生主管機關認可之物理治療業務。物理治療師執行業務，應依醫師開具之診斷、照會或醫囑為之。」。

四、次查，護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。而上述所稱醫療輔助行為之範圍包括：輔助施行侵入性檢查；輔助施行侵入性治療、處置；輔助各項手術；輔助分娩；輔助施行放射線檢查、治療；輔助施行化學治療；輔助施行氧氣療法（含吸入療法）、光線療法；輔助藥物之投與；輔助心理、行為相關治療；病人生命徵象之監測與評估；其他經中央主管機關認定之醫療輔助行為。前經本部 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函示在案（附件 1）。

五、另本部（前行政院衛生署）前於 97 年 4 月 3 日衛署醫字第 09700371 號函釋有關執行超音波影像、骨密度及紅外線掃描等業務人員資格一案（如附件 2）供參酌。惟貴局來函所詢執行超音波治療等情節，與前揭函釋所指操作、檢查是否相同，仍請就個案事實，依權責認定。

（註：本函釋說明五所敘本署 97.4.3. 衛署醫字第「09700371」號函，係「0970014380」之誤值，請參閱 P.313）

105.7.22 衛部照字第 1050121473 號

主旨：有關貴局函詢「里辦公處自行辦理里民健康篩檢保健活動疑義」一案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 105 年 7 月 19 日新北醫字第 1051306463 號函。

二、查本部（前行政院衛生署）96 年 10 月 12 日衛署醫字第

0960045197號函，略以：「二、查測量血糖、膽固醇係屬醫療輔助行為，為提供醫師診斷與治療之參考。…至社區所執行之血糖、尿糖、尿蛋白等之簡易篩檢，亦屬護理人員法第24條第1項第4款所稱之醫療輔助行為業務範疇，…。是以，護理人員得依醫師指示或醫囑，協助民眾執行之。……。三、…，簡易血液檢體(血糖、血脂)之篩檢業務，係屬跨專業領域重疊性之業務，得由醫師或醫事檢驗人員、護理人員依其各該專門職業法律規定，依醫師指示操作執行。……。」，再依本部104年3月3日衛部照字第1040004840號函，略以：「三、…醫療工作之診斷、處方、手術及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第28條第1項第2款之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。……。」，合先敘明。

三、另依護理人員法第24條規定：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第4款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。……。」，及本部(前行政院衛生署)90年3月12日衛署醫字第0900017655號公告，略以：「二、前項公告醫療輔助行為之範圍，修訂如下：(1)輔助施行侵入性檢查。(2)輔助施行侵入性治療、處置。……。」。

四、綜上所述，「測血糖及膽固醇檢查」係屬護理人員法第24條第1項第4款之醫療輔助行為，爰護理人員執行該項業務時，應在醫師之指示下執行，惟不限於醫師親自在場指示或目視所及之範圍內。本案請貴局依權責及事實認定。

106.3.15 衛部照字第 1069000308 號
主旨：有關貴局函詢「量血壓、脈搏及體溫等疑義」一案，復如

說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局106年3月1日中市衛醫字第1060010760號函。
- 二、依護理人員法第24條規定，略以：「護理人員之業務如下：
一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。…。」。
- 三、依本部(前行政院衛生署)90年3月12日衛署醫字第0900017655號公告，略以：「二、前項公告醫療輔助行為之範圍，修訂如下：……(10)病人生命徵象之監測與評估。…。」再依本部(前行政院衛生署)97年9月11日衛署醫字第0970215426號函，略以：「六、至單純之量血壓、脈搏及體溫，如未涉及診斷，尚難認屬醫療業務，一般民眾均可為之；惟如涉及疾病檢查、診斷與治療等醫療業務之整體連貫作業，係屬醫療行為，應由醫師或由護理人員依醫囑行之。」。。
- 四、承上，有關所詢醫院雇用佐理員(非護理人員)測量生命徵象(體溫、脈搏、呼吸及血壓)，如所雇人員(非護理人員)係依醫囑執行前述業務，尚難認非屬醫療業務，僅予單純之測量，爰本案仍請參酌上開原則及個案事實認定之。

〔釋例類別〕 第 9 類 其他(輔助病歷處理、協助石膏固定……)

93.11.3. 衛署醫字第 0930038903 號函

主旨：有關護理人員協助醫師謄寫病人「出院病歷摘要」或「病歷」後，交由醫師審閱核章，是否違反醫師法第 28 條「擅自執行醫療業務」之規定乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 9 月 13 日南市衛醫字第 0930021259 號函。
- 二、按凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺或保健為

直接目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察或診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部，總稱為醫療行為。

- 三、本案護理人員書寫護理紀錄或協助醫師謄寫病人「出院病歷摘要」後，交由醫師審閱核章，並未涉及執行醫療業務，尚不構成違反醫師法第 28 條之規定。

94. 3. 31. 衛署醫字第 0940010493 號函

主旨：所詢醫師使用電腦處理病歷，可否授權行政人員黏貼於紙本病歷及用印乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 3 月 11 日投衛局字第 0940003173 號函。
- 二、查醫療法第 68 條第 1 項規定，醫療機構應督導其所屬醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作病歷，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。
- 三、又查醫療機構實施電子病歷作業要點第 3 點規定，以電子文件方式製作、保存之病歷(以下簡稱電子病歷)，應經由行政院衛生署醫療憑證管理中心簽發憑證之醫事人員卡或醫事機構卡製作，並符合下列各款規定，得全部或部分免以書面方式製作：(一)電子病歷於記錄完成時，應由製作人以醫事人員卡加以簽署，並紀錄簽署之時間，且不得刪除。(二)電子病歷之修改，應一併保留原有紀錄，並應由修改人以醫事人員卡於修改部分加以簽署，並紀錄簽署之時間。(三)列印或查詢電子病歷時，應能完整呈現其內容，以供日後檢驗。(四)電子病歷系統應具有防止竄改之功能及使用權限管控機制。(五)電子病歷系統應具備系統故障時之回復機制及緊急應變措施，以確保醫療作業之進行。(六)電子病歷應有備份之機制，以確保病歷之完整保存。(七)電子病歷系統更新時，應確保更新前製作之電子病歷資料得完整呈現。
- 四、本案醫療機構使用電腦處理病歷，於醫師診治病人後，由

電腦列印出病歷，授權行政人員粘貼於紙本病歷上，尚無不可，惟除符合前開醫療機構實施電子病歷作業要點第 3 點規定外，仍應依醫療法第 68 條規定，親自簽名或蓋章。

97.3.11. 衛署醫字第 0970010995 號函

主旨：有關護理人員經訓練後可否協助執行石膏固定等業務一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 3 月 5 日新縣衛醫字第 0970002820 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依醫師法第 28 條但書二之規定意旨，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。合先敘明。
- 三、查石膏固定係屬手術連續過程之一環；另查「輔助各項手術」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，前經本署 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函釋在案。惟石膏固定過程中，就骨骼、關節及韌帶等位置如何正確固定，涉及高度之專業判斷及操作技術時，應由醫師親自執行；又石膏固定過程中，未涉及固定部位之醫療判斷時，在醫療機構受過骨科專業訓練之護理人員，得依其專門職業法律之規定，在醫師指導下，依醫囑操作執行。爰此，本案護理人員受訓練後，在醫師指導下，得協助醫師執行石膏固定過程之醫療輔助行為。

97.4.1. 衛署醫字第 0970014826 號書函

主旨：有關民眾檢舉 貴市○○骨科醫院行政副院長何○○君未具醫事人員資格，其領有接骨技術員執照為病患上石膏之行為是否違反相關醫事人員法規疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 3 月 25 日高市衛醫字第 0970011168 號函。
- 二、依醫療專業，所謂「接骨」包括「骨折」與「脫臼」之整復。前經本署 92 年 3 月 13 日衛署醫字第 0920011577 號函釋在案。
- 三、查接骨係屬醫療行為，未具醫師資格者，不得為之。另查，領有本署核發之「國術損傷接骨技術員登記證」者，其從事國術損傷接骨整復工作，依「國術損傷接骨技術員管理辦法」第 3 條規定，應依中醫師指示為之。
- 四、至於將病人骨折部位輔以石膏固定係屬醫療輔助行為；次查「輔助施行侵入性檢查、處置。」及「輔助各項手術。」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，得由護理人員依醫師指示為之；未具護理人員資格者依醫囑執行前述行為，應認屬違反護理人員法第 37 條之規定。是以，本案請依前揭原則，視個案事實認定辦理。

（註：本函釋醫院及當事人之名字以○○表示）

101.4.11. 衛署醫字第 1010203180 號函

主旨：所詢學校護理人員受託協助校內研究計畫進行人體抽血採樣之適法性一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 101 年 3 月 15 日臺高(四)字第 1010043146 號函。
- 二、按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預法人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。另，人體研究法第 3 條第 2 項規定：「人體研究之

監督、查核、管理、處分及研究對象權益保障等事項，由主持人體研究者(簡稱研究主持人)所屬機關(構)、學校、法人或團體(簡稱研究機構)之中央目的事業主管機關管轄。」；第5條第1項規定：「研究主持人實施研究前，應擬定計畫，經倫理審查委員會(簡稱審查會)審查通過，始得為之。但研究計畫屬主管機關公告得免審查之研究案件範圍者，不在此限。」。

- 三、爰此，研究計畫進行人體抽血採樣，非屬醫療行為，即非醫療輔助行為，至學校護理人員如係受託協助校內研究計畫進行人體抽血採樣，上揭計畫應經人體研究法相關規定審查通過，始得為之。

106.2.23 衛部照字第1061560405號

主旨：有關貴院函詢「對長照之家住民施以抬手、抬腳、翻滾及趴臥等動作，是否屬於護理行為或醫療行為」一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴院106年2月8日北院隆刑寅106醫易1字第1060001347號函。
- 二、查本部（前行政院衛生署）97年9月5日衛署醫字第0970208776號函略以：「按醫師法第28條所稱『醫療業務』行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。」先以敘明。
- 三、再依護理人員法第24條規定，略以：「護理人員之業務如

下：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第4款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。……。」。

- 四、承上，有關貴院函詢為長照之家住民施以抬手、抬腳、翻滾及趴臥等動作，仍需視執行該等動作之目的及住民之整體狀況而定，然因未提供案由及事實現況，欠難片段解釋究是否為醫療行為之認定。

106.9.6 衛部照字第 1060126663 號

主旨：有關函詢護理長執行護理行政業務是否屬護理人員法第 24 條規範之護理人員業務，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 8 月 30 日中市衛醫字第 1060084512 號函。
- 二、依護理人員法第 7 條第 1 項規定：「非領有護理師或護士證書者，不得使用護理師或護士名稱。」、同法第 8 條第 1 項：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」、第 12 條：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」、第 24 條：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估。三、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。三、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。……」及第 38 條規定：「違反第七條或第十八條之一第二項規定者，處新臺幣一萬元以上六萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。」，先予敘明。
- 三、經查本部(前行政院衛生署)83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035198 號函，「醫療機構之醫事人員，不論其職稱為何，如係執行各該專業法規所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記」83 年 6 月 17 日衛署醫字第 83035199

號函，「護理人員擔任護理學校教師，從事護理教育或護生實習指導工作，非以執行護理人員業務為其職業，可無須辦理執業登記。如欲辦理執業登記者，應向其學校所在地之地方衛生主管機關申請執業登記，並以其學校為登記處所」及 100 年 3 月 17 日衛署醫字第 1000063179 號函，略以：「二、按護理人員法第 12 條規定，護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主關機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。查……如非以執行護理人員業務為其職業，可無須辦理執業登記。三、……如有涉及需實際執行護理人員法第 24 條所定業務範疇內之臨床行為者，仍應依同法第 8 條規定辦理執業登記，始得為之。……。…辦理支援報備…，亦應依同法相關規定辦理。……」。

- 四、承上，「護理長」係屬醫療機構內之人事編制職稱，若其工作職掌有從事護理人員法第 24 條規定之護理業務者，依法須辦理執業登記始得執業，另於機構間支援亦應依法辦理支援報備；若無涉及護理業務，則不須辦理護理人員執業登記或支援報備。至有關所詢「護理人員法第 24 條第 1 項所定業務中『護理指導及諮詢』是否限於面對病患為之，抑或未直接對病患施以指導諮詢」疑義乙節，如僅對護理人員進行護理教育或指導，建請參考上開函釋及依個案事實認定。

第 25 條 護理人員執行業務時，應製作紀錄。

前項紀錄應由該護理人員執業之機構依醫療法第七十條辦理。

94.7.12. 衛署醫字第 0940028136 號書函

主旨：所詢何○○先生與○○醫院之醫療爭議案中，有關護理紀錄製作事隔 2 個月後再行補記錄，是否違反護理人員法之

相關規定一節，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 30 日北市衛醫護字第 09434579500 號函。
- 二、按護理人員執行業務應製作紀錄，為護理人員法第 25 條第 1 項所明定。另依醫療法第 68 條第 2 項規定，病歷或紀錄如有增刪，應於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日；刪改部分，應以畫線去除，不得塗燬。是以，醫療機構督導所屬護理人員於執行護理業務時，應親自製作紀錄，並應依醫療法第 68 條第 1 項規定簽名或蓋章及加註執行年、月、日；前項護理紀錄如有增刪，亦應符合醫療法第 68 條之相關規定。爰此，本案護理紀錄製作情形，請依上述相關規定依法查處。

（註：本函釋當事人之名字、醫院以○○表示）

95.10.26.衛署醫字第 0950045735 號書函

主旨：所詢未取得護理人員資格之護理學校畢業生製作護理紀錄疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、依據 貴局 95 年 10 月 13 日北衛醫字第 0950084334 號函辦理。
- 二、查護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」另查同法第 25 條第 1 項規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。」即護理紀錄之製作，係屬護理人員執行業務連續過程之一環，先予敘明。
- 三、次查護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級

護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」。是以，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，不得獨立執行護理業務；其若執行護理業務，應在護理人員指導下為之，而其所為之護理紀錄，並應經指導護理人員簽名或蓋章，始符合法；未依前述規定執行護理業務者，則依違反護理人員法第 37 條規定論處。本案請依上揭規定辦理。

95.11.21. 衛署醫字第 0950050648 號函

主旨：所詢護理機構申請歇業，惟該機構於歇業後無他人承接，關於其病歷保存期限及後續處理一案，請比照醫療法第 70 條第 2 項及第 3 項規定辦理，復請 查照。

說明：復 貴局 95 年 11 月 15 日北市衛護醫字第 09538609300 號函。

（註：1. 醫療法第 70 條第 2 項規定：醫療機構因故未能繼續開業，其病歷應交由承接者依規定保存；無承接者時，病人或其代理人得要求醫療機構交付病歷；其餘病歷應繼續保存六個月以上，始得銷燬。

2. 醫療法第 70 條第 3 項規定：醫療機構具有正當理由無法保存病歷時，由地方主管機關保存。）

96.5.22. 衛署醫字第 0960203313 號書函

主旨：所詢「現行護理及醫療相關法規規定，護理人員執行業務時是否製作記錄？如果忘了記錄嗣後可否補行記錄？其補正時限有否規定？」一案，復請 查照。

說明：

一、依據 台端 96 年 5 月 17 日到署檢附 96 年 5 月 16 日陳情函辦理。

二、按護理人員執行業務應製作紀錄，為護理人員法第 25 條第 1 項所明定。另依醫療法第 68 條第 2 項規定，病歷或紀錄如有增刪，應於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日；

刪改部分，應以畫線去除，不得塗燬。是以，護理人員於執行護理業務時，應親自製作紀錄，倘護理紀錄如有增刪，並應依醫療法第 68 條第 1 項規定簽名或蓋章及加註執行年、月、日。又該護理紀錄如有增刪，亦應符合醫療法第 68 條之相關規定。

96.7.3. 衛署醫字第 0960023885 號書函

主旨：所詢護理機構之護理紀錄或照護紀錄保存年限一案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 96 年 5 月 28 日護協字第 0960037 號函。
- 二、按護理人員法第 25 條規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。前項紀錄應由該護理人員執業之機構保存十年。」是以，居家護理機構及護理之家機構，對於轉診及醫師每次診察之病歷摘要，應連同護理紀錄依前揭規定妥善保存。
- 三、至護理機構對於前揭病歷保存場所，除應符合建築物使用用途規定外，如設置於地下室，並應裝置必要之防潮、防水設施（如緊急發電機、抽水機、消防設施等），並有專人定期進行保養維修與緊急情況處理演習，以確保該設備隨時處於堪用狀態。遇緊急情況時，適時開啟使用，始足以認定該護理機構已善盡保管、保存之責。

96.8.1. 衛署醫字第 0960032753 號書函

主旨：有關 台端所陳安養機構限制住民選擇轉介醫院之規定爭議及居家護理機構之護理紀錄申請疑義與醫療處置相關規範等情一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 台端 96 年 5 月 15 日及 7 月 20 日陳情書。
- 二、查安養機構係依老人福利法所設之老人福利服務機構，相關管理及規範非屬本署業務職責範疇，是以，關於安養機

構限制住民選擇轉介醫院規定之爭議，建請可洽詢內政部或縣市政府社政單位，以澄清疑義，先予敘明。

- 三、關於申請居家護理機構之護理紀錄一節，經查本署業已轉請各縣市衛生局轉告所轄護理機構，比照醫療法第 71 條之相關規定，依住民之要求提供護理紀錄等病歷複製本，以維護其知之權益。
- 四、另所詢關於醫療處置相關疑義一節，查結核病係屬第 3 類法定傳染病，關於開放性肺結核診斷、治療及處置，醫療機構應依個案病情進展而予適切之治療及處置，並依傳染病防治法之相關規定通報，並對於傳染病人之體液、分泌物、排泄物及其他可能具傳染性物品施行必要之消毒或其他適當處置；違者，視違法情節，依傳染病防治法之相關規定論處。
- 五、至所述從病人後背腰部腎臟置引流管係屬侵入性處置或手術及所應填具之同意書種類一節，查相關醫療處置，應視個案病情所需，經醫師醫療專業判斷後為之。爰此，本案情節應依個案事實認定，至關於同意書之填具，請依醫療法第 63 條、第 64 條規定辦理。

96.8.2. 衛署照字第 0962801382 號函

主旨：所詢專科護理師執業範圍中，有關「記錄住院病人病情及各項檢查、檢驗結果」，是否可記錄於病歷之病程紀錄（progress note）乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 11 日衛醫字第 0960027976 號函。
- 二、按護理人員執行業務應製作紀錄，為護理人員法第 25 條第 1 項所明定。另依醫療法第 67 條第 1 項及第 2 項規定：「醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷。前項所稱病歷，包括下列各款之資料：（一）醫師依醫師法執行業務所製作之病歷。（二）各項檢查、檢驗報告資料。（三）其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。」。同法第 68 條第 1

項及第 2 項規定：「醫療機構應督導其所屬醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。前項病歷或紀錄如有增刪，應於增刪處簽名或蓋章及註明年、月、日；刪改部分，應以畫線去除，不得塗燬。」。先予敘明。

三、至專科護理師執業過程之紀錄，可否直接書寫於醫師專用之病程紀錄（progress note）上一節，按病程紀錄（progress note）係病人於住院中，醫事人員觀察病情發展及進行各種診斷、治療相關流程與結果之紀錄，法無明文規定屬某類醫事人員之記載，惟該紀錄之製作，仍應依前揭規定辦理。

96.8.2. 衛署醫字第 0960203353 號函

主旨：有關護理機構之住民，要求該護理機構提供護理紀錄等病歷複製本一案，請比照醫療法第 71 條等相關規定辦理，並輔導所轄護理機構配合，請 查照。

說明：為尊重護理機構住民知之權利，及應住民轉診之需要，提供醫療機構診療之參考，護理機構應依其住民之要求，提供護理紀錄等病歷複製本；辦理時，應考量住民之負擔，並參酌本署 93 年 9 月 30 日衛署醫字第 0930217501 號函之說明事項辦理。

（註：本函釋說明段所敘本署 93.9.30. 衛署醫字第 0930217501 號函，其內容如下：

主旨：有關醫療法第 71 條規定醫療機構應依其診治之病人要求，提供病歷複製本，不得無故拖延或拒絕之相關原則，詳如說明，請加強輔導所轄醫療機構配合辦理，請查照。

說明：

一、依本署 93 年 6 月 28 日、8 月 4 日及 9 月 17 日召開之「醫療院所提供病歷複製本相關事宜」、「研商醫療院所提供病歷複製本之收費原則」會議紀錄辦理。

二、醫療機構提供病歷複製本之時限規範如下：

- (一) 檢查檢驗報告複製本、英文病歷摘要:以一個工作天內交付病人為原則,最遲不得超過三個工作天。
- (二) 全本病歷複製本:以三個工作天內交付病人為原則,最遲不得超過十四個工作天。
- (三) 中文病歷摘要:以十四個工作天內交付病人為原則。

三、醫療機構提供病歷複製本之收費原則。

- (一) 收費上限為病歷複製基本費二 00 元、每張紙五元,傳統膠片之影像病歷(包括:X 光片、CT、MRI、內視鏡及超音波檢查資料)每張二 00 元。
- (二) 前項所稱基本費,已包括醫療機構提供該病歷複製本所產生之病歷調閱、歸位等人力及影印機等相關成本,醫療機構應不得再行額外收取掛號費。
- (三) 另各醫療機構得於該收費上限內,依其實際狀況及需求,訂定細部收費標準,送衛生局核定。
- (四) 該收費原則係提供各縣市衛生局訂定「醫療機構提供病歷複製本之收費標準」參考,各縣市衛生局仍可依各該縣市實際生活消費水準,於該收費上限內自行調整費用。
- (五) 由於中文病歷摘要之內容格式尚未統一,各醫療院所提供之內容不同,該費用由醫療院所自行訂定後送衛生局核定。

四、為減少病人申請病歷多次往返醫院之舟車勞苦,請醫療機構研議提供郵寄方式之可行性,其產生之郵寄費用由病人負擔。

五、為免醫療機構和病人之間有所誤解,建議各醫療機構將提供病歷複製本可能遇到之相關問題,一併列入提供病歷複製本之申請書內供病人參考。)

96.9.7.衛署醫字第 0960039571 號函

主旨:所詢護理紀錄保存年限,究應依據護理人員法或醫療法之規範辦理一案,復請 查照。

說明:

- 一、復 貴院 96 年 8 月 27 日慈醫大林文字第 0960001458 號函。

二、查護理人員法第 25 條規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。前項紀錄應由該護理人員執業之機構保存 10 年。」是以，居家護理機構及護理之家機構，對於轉診及醫師每次診察之病歷摘要，應連同護理紀錄依前揭規定妥善保存。前經本署 96 年 7 月 3 日衛署醫字第 0960023885 號函釋在案。次查，依醫療法第 70 條第 1 項規定：「醫療機構之病歷，應指定適當場所及人員保管，並至少保存 7 年。……」爰此，關於護理人員執行業務所製作之紀錄保存年限，依其執業場所之法律規定辦理；未規定者，依護理人員法相關規定辦理。

三、另查，為利於醫療機構及護理機構之管理，本署於 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函釋略以：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，至原於醫療機構開業執照加註附設護理機構者，應於異動時，重新核發開業執照。」先予敘明。爰此，貴院醫療機構與附設護理機構之病歷應予分開管理，並依各該法律規定，善盡保管、保存之責。

96.12.31. 衛署醫字第 0960068348 號函

主旨：有關養護機構內之護理人員於執行護理業務時，製作紀錄是否應簽名或蓋章一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 96 年 12 月 19 日北衛醫字第 0960116398 號函。

二、查輔助藥物之投與，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行該項業務，依同條第 2 項規定，應在醫師指示下行之。另查同法第 25 條第 1 項規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。」即護理紀錄之製作，係屬護理人員執行業務連續過程之一環；另依醫療法第 68 條第 1 項規定：「醫療機構應督導其所屬醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日。」，即護理人員執

行護理業務所為之紀錄，應有足資辨識執行者之簽名或蓋章，始為完整、合法之護理紀錄，先予敘明。

- 三、爰此，本案所述養護機構內之護理給藥紀錄未有足資辨識執行者之簽名或蓋章一節，依前揭原則所示，貴局除本於職權加強所轄護理人員該項法制觀念外，應查明該護理紀錄未予簽章原因，並予輔導改善。如查該護理紀錄係由未具護理人員資格者所執行，則依違反護理人員法第 37 條規定論處。是以，本案請依前述規定，就個案事實認定。

97.2.20. 衛署照字第 0972800522 號函

主旨：所詢病歷記載為主要醫療行為以及醫事人員能否在醫師指示下書寫病人之病程紀錄於醫師所用之病程紀錄紙上等疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、本署 96 年 11 月 16 日衛署照字第 0960052768 號函復貴院 96 年 11 月 12 日明醫慶字第 429 號函計達。
- 二、所詢「病歷記載為主要醫療行為」究屬何意，及「專科護理師（或其他醫事人員）在醫師書寫之病程紀錄紙上書寫病程進展，由專科護理師（或其他醫事人員）署名後再由醫師副署。」此病歷記載方式有無違反本署 65 年 6 月 14 日衛署醫字第 116054 號函等情一案，回復如下：

（一）按醫師法第 28 條所稱「醫療業務」行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺或保健為直接目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療工作得在醫師指示下，由其他醫事人員依其各該專門職業法律規定依醫囑為之，先予敘明。

（二）按病程紀錄，係病人於住院中，醫事人員觀察病情發

展及進行各種診斷、治療相關流程與結果之紀錄；至病程紀錄單(progress note)，法無明文規定屬某類醫事人員之記載，亦無規定該病程紀錄單係屬何類醫事人員專用。專科護理師(或其他醫事人員)執行業務，依其專門職業法律及醫療法相關規定所製作紀錄，係屬護理(或所屬類別醫事人員)紀錄。

- (三)查專科護理師係屬護理人員，自不得執行醫師法規定應由醫師親自為之業務後，再製作所執行之病歷紀錄。是以，專科護理師依護理人員法規定執行業務後，製作執業紀錄署名後再由醫師副署，該執業紀錄，仍係屬護理紀錄而非醫師病歷紀錄；惟醫師親自執行醫療業務後之病歷記載，以口述方式，由專科護理師擔任輔助紀錄人詳實代筆，且於病歷加註「輔助紀錄人○○○」後，由醫師確認並依醫師法第 12 條規定辦理，尚無不可。

三、檢附相關函釋 1 份，供參。

101.9.14.衛署照字第 0962863745 號函

主旨：有關 貴局所詢護理之家內護理人員製作給藥紀錄等相關疑義案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 101 年 8 月 15 日嘉衛保字第 1010021453 號函。

二、經查依據護理人員法第 25 條第 1 項規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄」，其紀錄之製作形式，雖然沒有明文規定，惟執行業務之各該護理人員，仍應依該機構護理工作手冊內容，詳實記載執行業務之時間及情形，以資確保護理人員執行業務紀錄之完整性及受照護人員權益，始符合其規範意旨。

三、另護理機構之護理人員執行業務，應參照醫療法第 67 條規定，製作清晰、詳實、完整之紀錄，及醫療法第 68 條醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽

名或蓋章及加註執行年、月、日等項規定。

四、爰此，對於護理之家機構護理人員製作紀錄是否有違上開原則，請依權責就個案事實認定。

106.6.3 衛部照字第 1061561406 號

主旨：有關貴院函詢「護理紀錄」一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴院 106 年 5 月 22 日北院隆刑子 105 聲判 143 字第 1060006051 號函。

二、依來函說明欄二所示事項，本部依序說明如下：

(一)查醫療法所稱「醫事人員」，依醫療法第 10 條規定，係指「領有中央主管機關核發之醫師、…、護理師、…及其他醫事專門職業證書之人員。」、同法第 67 條規定，略以：「醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷。前項所稱病歷，應包括下列各款資料：(一)醫師依醫療法執行業務所製作之病歷。(二)各項檢查、檢驗報告資料。(三)其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。……。」，再依護理人員法第 25 條規定：「護理人員執行業務，應製作紀錄。前項紀錄應由該護理人員執業之機關依醫療法第七十條辦理。」，故護理人員執行業務所製作之護理紀錄，係屬病歷一部分，先予敘明。

(二)所詢「由護理人員所製作護理紀錄其範圍為何？是否包含護理人員於觀察、量測病人特定狀況而另行持續性摘記之紀錄」一節，如係記載與護理人員照護病人之評估及提供護理措施相關之內容(如生命徵象、輸入輸出量、傷口或管路護理等資料)應得視為護理紀錄之範圍，惟依貴院所附摘錄資料，非完整頁面，尚難判定係屬前述護理紀錄範圍，仍請依個案事實及上揭規定認定。

(三)另本部就護理紀錄其內容格式項目並無另外發布細節性規定或規則。

106.7.31 衛部照字第 1061562038 號

主旨：有關貴局函詢「病患點滴脫落及移除點滴等常規內容是否應於病歷中記載」疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 7 月 20 日彰衛醫字第 1060026559 號函。
- 二、依醫療法第 67 條第 1 項規定「醫療機構應建立清晰、詳實、完整之病歷。」及同法第 2 項規定「前項所稱病歷，應包括下列各款之資料：一、醫師依醫師法執行業務所製作之病歷。二、各項檢查、檢驗報告資料。三、其他各類醫事人員執行業務所製作之紀錄。」。
- 三、查本部(前行政院生署)101 年 9 月 14 日衛署照字第 0962863745 號函，略以：「二、…依據護理人員法第 25 條第 1 項規定：『護理人員執行業務時，應製作紀錄』，其紀錄之製作形式，雖然沒有明文規定，惟執行業務之各該護理人員，仍應依該機構護理工作手冊內容，詳實記載執行業務之時間及情形，以資確保護理人員執行業務紀錄之完整性及受照護人員權益，始符合其規範意旨。三、…護理人員執行業務，應參照醫療法第 67 條規定，製作清晰、詳實、完整之紀錄，及醫療法第 68 條醫事人員於執行業務時，親自記載病歷或製作紀錄，並簽名或蓋章及加註執行年、月、日等項規定。……。」合先敘明。
- 四、承上，有關貴局所詢醫療機構醫事人員於病歷應記載事項，請依前述原則及相關規定辦理。

106.9.25 衛部照字第 1060128350 號

主旨：有關所轄○○○○○○財團法人附設○○產後護理之家是否可以申請以電子病歷方式製作病例等相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 9 月 15 日北市衛長字第 10639834200 號函。

- 二、查護理人員法第 25 條規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。前項紀錄應由該護理人員執業之機構依醫療法第 70 條辦理。」又依本部 105 年 8 月 29 日衛部醫字第 1050125872 號函示，「醫療機構電子病歷製作及管理辦法」係依據「醫療法」第 69 條規定訂定，該辦法之適用對象為醫療機構，護理機構尚非上開辦法之規範對象。

（註：本函釋產後護理之家之名字以○○表示）

第 26 條 護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。

100.11.24. 衛署照字第 1002863326 號函

主旨：有關金門縣政府函請釋示機構就養住民簽立醫療行為同意書及緊急醫療行為之決策權疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴部 100 年 11 月 8 日內授中社字第 1000024099 號函。
- 二、本案關於簽立醫療行為同意書乙事，查醫療法第 63 條規定，醫療機構實施手術，應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人說明手術原因、手術成功率或可能發生之併發症及危險，並經其同意，簽具手術同意書及麻醉同意書，始得為之。但情況緊急者，不在此限。前項同意書之簽具，病人為未成年人或無法親自簽具者，得由其法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具。另同法第 64 條規定，醫療機構實施中央主管機關規定之侵入性檢查或治療，應向病人或其法定代理人、配偶、親屬或關係人說明，並經其同意，簽具同意書，始得為之。但情況緊急者，不在此限。前項同意書之簽具，病人為未成年人或無法親自簽具者，得由其法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具。
- 三、至遇有緊急醫療需求時，有關同意書之簽具，前揭規定已敘明「情況緊急者，不在此限。」，另醫療法第 60 條亦

規定，醫院、診所遇有危急病人，應先予適當之急救，並即依其人員及設備能力予以救治或採取必要措施，不得無故拖延。

106.3.10 衛部照字第 1060007622 號

主旨：有關貴會函詢從事勞工健康服務護理人員協助事業單位員工執行糖尿病照護及外傷處理等工作之疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴會106年3月2日台事護(106)滿字第0000022號函。
- 二、依護理人員法第24條規定，略以：「護理人員之業務如下：
一、健康問題之護理評估、二、預防保健之護理措施、三、護理指導及諮詢、四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之……。」及同法第26條：「護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。」，先予敘明。
- 三、查本部(前行政院衛生署)100年12月28日衛署醫字第1000084017號函，略以：「……。二、按輔助藥物之投與、輔助施行侵入性治療、處置，係屬護理人員法第24條第1項第4款所稱醫療輔助行為之範圍，護理人員執行該項業務，依同法第2規定應在醫師指示下行之。……。」；再查本部(前行政院衛生署)101年6月28日衛署照字第1012862926號函，略以：「按「輔助施行侵入性治療、處置」及「輔助藥物之投與」屬護理人員法第24條第1項第4款所稱醫療輔助行為之範疇。爰此，執行胰島素注射、驗血糖、甘油灌腸及藥品之投與，為醫療輔助行為，由醫師或護理人員依醫囑為之。……。」。
- 四、綜上，從事勞工健康服務護理人員如遇有事業單位內之員工生命危急，經由護理人員專業評估後，且為當時事業單位內之員工最適切或必要之照護需求，依護理人員法第26條規定先予處理，尚無不可。

105.3.24 衛部照字第 1051562368 號

主旨：有關貴局函詢護理人員執行業務時，遇有病人危急，於醫師不在場，使用非自動體外心臟電擊去顫器，是否符合護理人員法第 26 條「…必要時，得先行給予緊急救護處理」之範籌疑義案，復如說明段，請查照。

說明：

一、復貴局 104 年 12 月 24 日嘉市衛醫字第 1040503163 號函。

二、旨揭函詢本部前已於 104 年 8 月 25 日衛部照字第 1040125002 號函復在案。今貴局再詢「醫師不再場，護理人員無法依醫囑情況下，但以救護為先，先行使用非自動體外心臟電擊器」之適法性疑義說明如下：

(一) 依本部(前行政院衛生署)97 年 9 月 5 日衛署醫字第 0970208776 號函略以：「按醫師法第 28 條所稱『醫療業務』行為，係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為直接目的，所為之診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為之處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部總稱。是以，醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載及施行麻醉等醫療行為，係屬醫療業務之核心，應由醫師親自為之，其餘醫療輔助行為得在醫師就特定病人診察後，由各該醫事人員本其專門職業法規所規定之業務，依照醫囑執行之，不限於醫師親自在場指示或目視所及範圍以內。」，先予敘明。

(二) 本部(前行政院衛生署)98 年 11 月 19 日衛署醫字第 0980263367 號函釋略以：「…緊急醫療救護法第 17 條第 2 項規定『緊急情況』係指趕赴傷病現場或送醫途中；至於所謂緊急傷病，參照醫療緊急救護法施行細則第 2 條規定：「指具有急性及嚴重性症狀，如未即時給予醫療救護處理，將導致個人健康，身體功能嚴重傷害或身體器官機能嚴重異常之傷病」。

(三)另依本部醫事司104年3月24日衛部醫字第1041660850號函復貴局所詢醫療機構護理人員於值勤時間使用非自動體外心臟電擊器，得否為緊急醫療救護法，略以：「二、……，為鼓勵大眾對傷病患施以幫助，爰擬具『緊急醫療救護法』第14條之2條文，救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予緊急措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定，加上為避免救護人員在執行業務與善行義舉間有所爭議，並提升救護人員伸出援手施救之意願，對於救護人員下班後使用緊急救護設備或施予急救措施者，亦適用本條規定，合先敘明。三、醫療機構護理人員係為醫事專門職業人員，於上班或執勤期間應依相關法令規範執行業務，本案所詢於值勤時間使用「非自動體外心臟電擊去顫器」尚非本法第14條之2所適用對象。」。

三、綜上所述，護理人員於上班或執勤執行業務時，遇有病人危急，於醫師不在場，使用非自動體外心臟電擊去顫器，先行給予緊急救護處理，仍應依相關法令規範辦理。

105.7.7 衛部照字第1059001123號

主旨：有關貴部函詢某大專校院軍訓護理教師陳情該校要求執行換藥及急救處理之適法性案，復如說明段，請查照。說明：

一、復貴部105年7月1日臺教綜(五)字第1050087892號函。

二、依護理人員法第8條規定略以：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。…」、第10條：「護理人員非加入所在地護理人員公會，不得執業。」、第24條：「護理人員之業務如下：一、健康問題之護理評估、二、預防保健之護理措施、三、護理指導及諮詢、四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。」及第26條：「護理人員執行業務時，遇有病人危急，應立即聯絡醫師。但必要時，得先行給予緊急救護處理。」，先予敘明。

- 三、爰依上揭法規規定，領有護理師證書者應向執業所在地直轄縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照後，始得執行護理人員法定業務，另有關大專校院護理人員代理人之資格，本部前於105年6月16日衛部照字第1050117220號函復在案，請貴部參酌及本於權責辦理。

第 27 條 護理人員受有關機關詢問時，不得為虛偽之陳述或報告。

96.9.18. 衛署照字第 0962801437 號函
主旨：有關函詢財政部台灣中區國稅局台中市分局索取護理機構服務量及住民人數等資料一案，復請 查照。說明：

- 一、復 貴局 96 年 8 月 31 日衛醫字第 09600037300 號函。
- 二、查「稅捐稽徵機關為調查課稅資料，認為有必要要求醫療機構提示病歷文件，而透過該醫療機構所在地之衛生主管機關索取時，地方衛生主管機關自應配合辦理。惟應在不影響病人隱私權，並以相關之病歷摘要或摘述與醫療機構收入或支出有關之資料為限。」前經本署 83 年 12 月 23 日衛署醫字第 83074930 號函釋在案。
- 三、是以，財政部台灣中區國稅局台中市分局為稽徵業務需要，透過護理機構所在地衛生主管機關索取護理機構服務量及住民人數等資料，如未涉及住民病情及隱私，尚無不可。

第 28 條 除依前條規定外，護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，非依法、或經當事人或其法定代理人之書面同意者，不得洩漏。

99.4.8. 衛署照字第 0992860917 號函
主旨：貴院函詢附設護理之家裝設監視器有關事宜乙案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴院 99 年 3 月 9 日埔醫行字第 0990001614 號函。
- 二、按護理人員法第 28 條規定，護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，不得無故洩漏。另為確保接受長照服務者之隱私權，任何人未徵得接受長照服務者或其法定代理人之同意，不得對其進行錄影、錄音、攝影或其他涉及侵害個人隱私之行為。

102.5.20. 衛署照字第 1022863290 號函

主旨：所詢一般護理之家於住房內裝置監視器，是否影響個人隱私或違反相關規定一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 4 月 10 日高市衛長字第 10233359200 號函。
- 二、按護理人員法第 28 條規定：「護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，不得無故洩漏。」，為確保住民隱私，如未徵得住民或其法定代理人之同意，不得對其進行錄影、錄音、攝影或其他涉及侵害個人隱私之行為，本署亦於 99 年 4 月 8 日衛署照字第 0992860917 號函釋在案。

105.7.5 衛部照字第 1050052014 號

主旨：有關貴機構函詢有關是否可於徵得住民或其法定代理人之同意下裝設監視器案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、依據社團法人台灣評鑑協會 105 年 6 月 22 日(105)評鑑發字第 10510027 號函轉貴機構 105 年 6 月 15 日函辦理。
- 二、護理機構如係基於公共安全、維護場所秩序，於公共空間設有監視裝置，對非特定對象進行一般性之攝影監控，並於明顯處揭示進行監視攝影等相關文字宣告之原則下，尚無不可。惟，按隱私權乃為保障個人生活私密領域免於他

人侵擾之基本權利，住民之照護過程內容多涉個人私密事務，應屬於隱私權之內涵而受憲法之保障。

- 三、一般護理之家評鑑基準項目 C1.17「居家情境佈置情形」主要係基於個人空間隱私之維護，與本部 99 年 4 月 8 日衛署照字第 0992860917 號函釋意旨並無不同；考量寢室及浴廁係涉及個人空間隱私，仍不宜裝設監視器；若為住民安全考量，可安裝其他設備，例如：離床報知器。

第五章 懲處

第 29 條 護理機構有下列情形之一者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰；其情節重大者，並得廢止其開業執照：

- 一、容留未具護理人員資格者擅自執行護理業務。
- 二、從事有傷風化或危害人體健康等不正當業務。
- 三、超收費用經查屬實，而未依限將超收部分退還。
- 四、受停業處分而不停業。

102.9.25. 衛署照字第 1021580475 號函
主旨：有關護理機構網頁廣告公開宣稱住房折扣費，涉及違反護理人員法第 18 條之 1 規定，原 102 年 4 月 29 日衛署照字第 1022861001 號函自即日起停止適用，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 5 月 24 彰衛醫字第 1020015952 號函。
- 二、按護理人員法第 18 條之 1 規定護理機構廣告內容之範疇，有關護理機構於網頁廣告公開宣稱住房折扣專案，已違反前述規定，依同法第 32 條懲處；至於參觀、簽訂契約時推出住房折扣專案，非屬廣告，尚無違反護理人員法之規定。

三、有關護理人員法第 29 條第 1 項所稱「不正當業務」，與醫療法第 61 條第 1 項所稱「不正當方法」，兩者各自有具體明確之列舉及例示規定，且規範性質不同，尚不可完全比照辦理。

四、原 102 年 4 月 29 日衛署照字第 1022861001 號函自即日起停止適用。

第 30 條 護理人員受停業處分仍執行業務者，廢止其執業執照；受廢止執業執照處分仍執行業務者，廢止其護理人員證書。

第 30-1 條 護理人員將證照租借予不具護理人員資格者使用，廢止其護理人員證書；租借予前述以外之人使用者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，得併處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其執業執照。

前項情形涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。

第 31 條 護理機構受廢止開業執照處分，仍繼續開業者，得由中央主管機關吊扣其負責護理人員證書二年。

第 31-1 條 違反依第十六條第二項所定設置標準者，應令其限期改善；屆期未改善者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並再令其限期改善；屆期仍未改善者，得處一個月以上一年以下停業處分；停業期滿仍未改善者，得廢止其設置許可。

第 31-2 條 護理機構依第二十三條之一第一項規定接受評鑑，經評鑑不合格者，除違反依第十六條第二項所定設置標準，依前條規定處罰外，應令其限期改善；屆期未改善者，其屬收住式護理機構，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，其他護理機構，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並得按次處罰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設置許可。

104.4.1 衛部照字第 1040006456 號函

主旨：有關貴學會申請課予義務函釋「督導考核與評鑑結果不得違反護理人員法第 16 條、第 17 條設置標準」、「護理之家督導考核與評鑑有何立法與實施差異」及「護理機構督導考核與評鑑之停業撤業照法律不得溯及既往」等案，本部回復意見如說明，請查照。

說明：

一、復 貴會 104 年 3 月 5 日衛護督評違字第 1040305002 號函及 104 年 3 月 4 日護鑑廢字第 1040304002 號函。

二、旨案貴學會針對護理人員法修正公布後之相關疑義，本部回復說明如下：

(一)依據護理人員法第 23 條之 1 第 1 項規定，中央主管機關應辦理護理機構評鑑，地方主管機關定期辦理督導考核，同法第 23 條之 2 第 2 項規定，護理機構於評鑑合格效期內，如有違法情事，經限期改善，屆期末改善者得調降其評鑑合格格類；鬥或廢止評鑑合格資格；又，同法第 31 條之 2 規定，護理機構接受評鑑，經評鑑不合格者之處分。同法施行細則第 17 條規定，直轄市或縣(市)主管機關應訂定計畫實施，每年至少辦理 1 次護理機構業務督導考核。

(二)護理機構設置，依護理人員法第 16 條辦理，該條文亦授權中央主管機關訂定相關子法(護理機構設置或擴充許可辦法及護理機構分類設置標準)，爰主管機關據此作為機構申准設立之依據。機構如違反設置標準，則依護理人員法第 31 條之 1 規定處分。

(三)然，護理機構之管理，依護理人員法規定，由中央主管機關辦理評鑑，地方主管機關辦理督導考核，該法第 23 條之 2 第 3 項亦授權中央主管機關訂定評鑑辦法，該法施行細則第 17 條則規定地方主管機關應訂定督導考核計畫實施。又，護理機構應依法令規定或依主管機關之通知，配合相關檢查及資料蒐集等。評鑑結果如不合格

者，逕依護理人員法第 31 條之 2 規定進行處分。此外，基於護理機構管理之責及減少機構同一年度同時接受評鑑與督導考核之負擔，並減少機構準備程序及公文書作業，地方主管機關辦理督考得結合本部之評鑑工作共同辦理。

(四)承上，護理機構申准設立，依照護理人員法等相關規定許可設置，其設立之標準則依護理機構分類設置標準配置；然護理機構評鑑及督導考核，旨為提升護理機構照護品質，以保障入住民眾之權益，故機構之申准設立及接受評鑑及督導考核，各依法辦理，互不扞格；且如有違反設置標準或評鑑不合格者，亦需依法辦理相關處分。

(五)有關護理機構評鑑不得溯及既往或信賴保護原則，護理人員法所規定之評鑑等事項，乃指新法公告後所辦理之訪查等事項，惟如有違反本法或依本法所發布之命令者，仍得依法處分。

第 32 條 違反第十六條第一項、第十七條、第十八條第一項、第十八條之一第一項、第二十條第三項、第二十二條或第二十三條規定者，處新臺幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰，並得限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照。

第 33 條 違反第八條第一項、第二項、第十條第一項、第十二條、第十九條之一第一項、第二十三條之一第二項或第二十五條至第二十八條規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下之停業處分。

護理人員公會違反第十條第二項規定者，由人民團體主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

第 34 條 護理機構受廢止開業執照處分者，其負責護理人員

於一年內不得申請設置護理機構。

第 35 條 護理人員於業務上有違法或不正當行為者，處一個月以上一年以下之停業處分；其情節重大者，得廢止其執業執照；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。

84. 7. 12. 衛署醫字第 8404555 號函

主旨：護理人員兩地執業登錄，如涉及租照行為，應以違反護理人員法第 35 條之業務上不正當行為論處，請 查照。

說明：依據本署於 84 年 4 月 14 日召開之「護理行政業務研討會」會議紀錄辦理。

87. 11. 6. 衛署醫字第 87056158 號函

主旨：函詢貴轄○○婦產科診所護士傳○○涉嫌販嬰案，現仍在偵查期間，應如何給予適當行政處分乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 87 年 9 月 22 日北市衛五字第 872509930 號函。

二、本案該護士利用業務上機會涉嫌販嬰，不論判決結果為何，依其案情已屬護理人員法第 35 條所稱「於業務上有違法或不正當行為」，為正視聽，應予從重論處，撤銷其執業執照。

（註：本函釋所述之診所名稱及護士名字均以○○表示）

92. 7. 23. 衛署醫字第 0920029219 號函

主旨：有關護理人員法第 35 條之意旨疑義乙案，復如說明，請 查照。

說明：

一、復 貴局 92 年 5 月 28 日北市衛五字第 09232590000 號函。

二、護理人員法第 35 條規定：「護理人員於業務上有違法或不正當行為，得處一個月以上一年以下之停業處分或撤銷其執業執照」，所稱業務上違法或不正當行為之認定原

則，得適用本署 85 年 11 月 16 日衛署醫字第 85061891 號函及 90 年 3 月 23 日衛署醫字第 0900001839 號函之意旨認定處理。

- 三、至於建議參照醫師法解釋彙編乙節，查本署所編印之護理人員法及其相關規定，業已收錄護理人員法解釋彙編，該彙編本署將持續收錄彙整，以分送各衛生主管機關參考。

（註：本函釋說明二所敘本署 85.11.16. 衛署醫字第 85061891 號函及 90.3.23. 衛署醫字第 0900001839 號函，其內容如下：

85.11.16. 衛署醫字第 85061891 號

主旨：有關台北縣○○牙醫診所涉嫌病歷記載不實疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴處 85 年 10 月 28 日衛三字第 850078423 號函。
- 二、按醫療機構承辦全民健康保險醫療業務，若涉有違反合約規定，經中央健康保險局停止特約處分，此乃違約行為所衍生之效果。至於該違規事實若同時構成違反醫療管理相關法規，當地主管機構自應查明違規情節，依法另予行政處分。
- 三、醫師法第 25 條所定醫師於「業務」上不正當行為，所稱「業務」，並不僅限於醫療業務，凡與該醫療業務有關之事務事項均屬之。全民健康保險特約醫療院所醫師如無醫療之事實，而利用業務上機會，捏造病人就醫事實，詐領全民健康保險醫療給付，獲取個人不正當利益，該行為核屬不當，應依醫師法第 25 條醫師業務上不正當行為論處。
- 四、本案台北○○牙醫診所是否違反醫療管理相關法規？應由當地衛生局參酌一切事證查明處理。

90.3.23 衛署醫字第 0900001839 號函

主旨：有關醫師法第 25 條之意旨、適用範圍，以及保險特約醫事服務機構之違法或違背特約，為可歸責於醫師時之處理原則乙案，復請查照。

說明：

一、依貴秘書長 90 年 1 月 9 日(90)秘台大 1 字第 00902 號函。

二、關於醫師法第 25 條所定醫師業務上違法或不正當行為之立法意旨及適用範圍乙節：

- (一) 醫療行為之施行，直接涉及人體，與生命安全息息相關。以醫師身分，藉業務之執行，從事違法或不正當行為，將直接侵害民眾生命安全及身體之健康，故醫師之醫療行為，與一般服務業之服務行為，確有不同，應予特別規範。該條即為督促醫師尊重病人，重視醫療倫理，維護醫療品質所為之規定。
- (二) 所稱業務上違法行為，係指醫師藉由執行醫療業務之便，從事違法行為而言。易言之，該行為違反法律之禁止或應為之規定，固於各該法律均已定有罰則，惟在行政管理上，仍應予以懲處，以期矯正。民國 75 年修正醫師法時，有鑑於此，爰增列「違法」一詞，以資明確。
- (三) 所稱業務上不正當行為，係指其行為雖不違法，但在醫療品質與醫學倫理上不具正當之行為，其情節有輕重之別，情節重大者，可對病人生命安全及身體健康造成不良影響。例如：對患者過度用藥、中藥攪加西藥、藉業務之便騷擾病人、以絨毛膜採檢術從事胎兒性別鑑定等等，該等涉及醫德之行為，多係醫師在診療行為上之個別喜好或長期蓄積之診療習慣，對該行為處以罰鍰處分，並無法產生矯正之效果，故先進國家亦多以暫行停止其執行業務之方式，使該醫師得有重新學習或檢討改進之機會。至於輕微之不正當行為，則可透過宣導、輔導、繼續教育之方式，提昇其品質，予以糾正或導正。
- (四) 醫師於業務上如有違法或不正當行為，該條規定係「得」處 1 個月以上 1 年以下停業處分或撤銷其執業執照，其立法目的，即係授權主管機關本於前述立法意旨，得衡量違反情節之輕重，而作適當之量處，並非一律均予處 1 個月以上 1 年以下停業處分或撤銷其執業執照。

三、醫師法第 25 條具體適用類別情形如下：

- (一) 非法使用管制藥品。
- (二) 偽製病歷及診斷書、出生證明書、死亡證明書等醫療證明文件。
- (三) 容留密醫。
- (四) 將醫師證書、專科醫師證書租供他人使用。
- (五) 使用禁止使用之藥品或醫療器材治療病人。
- (六) 中醫師超越其專業範圍使用西藥治療病人。

四、保險特約醫事服務機構之違法或違背特約，為可歸責於醫師時之處理原則：

依全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法第 36 條規定，保險醫事服務機構受停止特約、停止指定或依第 35 條第 1 項第 1 款至第 9 款規定受終止特約或終止指定者，其負責醫事人員或負有行為責任之醫事人員，於停止特約、停止指定期間或終止特約、終止指定之日起 1 年內，對保險對象提供之醫療保健服務，不予支付。其效果僅止於不予支付之特約關係，至其行為違反醫師法時，係屬行政罰之範疇，其情形如下：

- (一) 於病歷記載不實之診斷、處方或其他醫療處置。
- (二) 收治非保險對象，而以保險對象之名義、申報醫療費用。
- (三) 簽註保險對象保險憑證，換給非對症之藥品營養品或其他物品。
- (四) 容留密醫為保險對象診療、處方。

五、檢送日本「醫師法」、「公共衛生護士助產士護士法」、「齒科衛生士法」及「關於按摩、推拿、指壓師、針師、灸師的法律」譯影本各乙份，請參考。）

102.5.20. 衛署照字第 1022863282 號函

主旨：所詢有關醫院附設護理機構擬予員工眷屬及特定對象給予優惠折扣計畫方案，是否合法妥適乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 102 年 4 月 19 日北衛醫字第 1021674152 號函。

- 二、按護理人員法第 18 條之 1 規定，護理機構廣告不得宣傳折扣方案，因考量優惠折扣係以該機構之員工眷屬及特定對象作為對象，爰如其無針對一般社會大眾宣傳機構業務，以達招徠住民之主觀意圖，則尚無違反護理人員法第 35 條之處罰要件。
- 三、本案請貴局依上開原則，就個案之事實予以查明認定。

102.7.25. 衛部照字第 1021580037 號函

主旨：有關貴轄護理之家負責人因犯業務侵占罪，處有期徒刑八個月，得否依護理人員法第 35 條處一個月以上一年以下停業處分，或依情節重大，廢止其執業執照乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 7 月 8 日屏衛醫字第 10232081200 號函。
- 二、依據護理人員法第 35 條規定：「護理人員於業務上有違法或不正當行為，得處一個月以上一年以下之停業處分；其情節重大者，得廢止其執業執照…」。
- 三、查旨案業經臺灣屏東地方法院刑事判決(102 年度易字第 225 號)在案，本案當事人(萬丹護理之家陳姓負責人)屬護理人員，至護理之家老人慶生經費應屬捐贈款項，係屬其業務範圍無誤，成立業務侵占罪。護理人員法第 35 條規範主體為業務上有違法或不正當行為之護理人員，前揭判決已經刑事判決認定，核屬業務上違法行為。

105.8.19 衛部照字第 1050124459 號

主旨：有關貴局函詢「護理人員依法執行同法第35條於業務上有不正當行為之疑義」一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局105年8月11日投衛局醫字第1050016826號函。
- 二、依護理人員法第35條規定：「護理人員於業務上有違法或不正當行為者，處一個月以上一年以下之停業處分；其情

節重大者，得廢止其執業執照；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。」。

三、查本部(前行政院衛生署)92年7月23日衛署醫字第0920029219號函，略以：「二、……，所稱業務上違法或不正當行為之認定原則，得適用本署85年11月16日衛署醫字第85061891號函及90年3月23日衛署醫字第0900001839號函之意旨認定處理。…。」；再依本部(前行政院衛生署)90年3月23日衛署醫字第0900001839號函，略以：「……(三)所稱業務上不正當行為，係指其行為雖不違法，但在醫療品質與醫學倫理上不具正當之行為，其情節有輕重之別，情節重大者，可對病人生命 safety 及身體健康造成不良影響。……。」，先予敘明。

四、本案請貴局依上開原則，就個案之事實予以查明認定。

第 36 條 違反第十八條第二項或第二十一條第二項規定者，處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。

違反第二十一條第二項規定者，並應限期退還超額收費。

第 37 條 未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。

84.9.7. 衛署醫字第 84053676 號函

主旨：貴市○○診所涉嫌留用他人所申請聘僱之二位外籍勞工，為病患注射藥物等醫療行為，應如何論處乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 84 年 8 月 18 日 84 高市衛五字第 26134 號函。

二、護理人員法第 37 條規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上

15 萬元以下罰鍰。上開罰則對於外籍勞工亦應一體適用。

- 三、本案○○診所涉嫌留用他人所申請聘僱之二位外籍勞工，為病患注射藥物等醫療行為，該診所負責醫師除應依護理人員法第 37 條論處外，併請將其非法留用外籍勞工之事實及外籍勞工從事醫療輔助行為等相關證卷，送請行政院勞工委員會依就業服務法及其相關法規規定，就外籍勞工、原雇主及非法雇主等分別予以處分。

(註：本函釋所敘之診所名稱以○○表示)

86. 3. 12. 衛署醫字第 86009030 號函

主旨：台北縣衛生局函為未取得護士證書而在醫院執業之護校畢業生，是否得以違反護理人員法第 37 條之規定處分乙案，請 查照。

說明：

- 一、依據台北縣衛生局 86 年 2 月 3 日 86 北衛五字第 07280 號函辦理。
- 二、依護理人員法第 1 條規定，中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。第 37 條規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。依上開規定，僅持有考試院護理師或護士檢覈及格證書，而未領取護理師或護士證書者，仍未具備護理人員資格，其若執行護理業務，應依違反護理人員法第 37 條規定論處。惟因此等人員已經考試及格，具備取得護理人員資格之要件，祇是程序尚未完成，可依法從輕處罰。
- 三、○○醫院經台北縣衛生局 85 年 12 月 16 日前往稽查，發現有護士經考試及格但尚未取得護士證書(於 85 年 9 月中旬到職，85 年 11 月 26 日方領有護理人員證書)，期間均於病房工作，並無護理人員指導，該院經台北縣政府衛生局行政處分後向台灣省政府提出訴願申請乙節，應請就上開事實詳細答辯，並提供相關事證，俾利台灣省政府訴願

委員會審查。

(註：本函釋所敘之醫院名稱以○○表示)

87.9.14. 衛署醫字第 87052680 號函

主旨：雲林縣衛生局函詢醫院或診所僱用護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書及執業執照者，在護理人員指導下從事護理工作，針對該護理人員及上述尚未取得護理人員證書及執業執照者，是否該處以行政罰鍰乙案，請查照。

說明：

- 一、依據雲林縣衛生局 87 年 8 月 28 日雲衛五字第 14223 號函辦理。
- 二、按護理人員法第 37 條規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。爰此，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，依前揭規定，若該等人員確係在護理人員指導下從事護理工作，尚難謂涉有違反護理人員法情事。

89.7.4. 衛署醫字第 89038062 號函

主旨：未取得護理人員資格者，依醫囑執行醫療輔助行為，應以違反護理人員法第 37 條規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束，請 查照。

說明：

- 一、醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。上揭所稱醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施

術或處置等行為的全部或一部，均屬之。

- 二、又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由輔助人員依醫囑行之。上述所稱輔助人員，其資格應符合各該類醫事人員管理法規之規定。資格不符規定之人員，若依醫囑執行前開醫療輔助行為，應分別依違反各該醫事人員管理法規規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。
- 三、護理人員法於 80 年 5 月 17 日公布施行，未取得護理人員資格者執行醫療輔助行為，若依醫囑行之，應以違反護理人員法第 37 條規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。本署 76 年 12 月 2 日衛署醫字第 666362 號函說明三後段「未具護士資格之行為人，亦將受醫師法及有關法令之約束」，意旨未明，應予補充。

89.12.18. 衛署醫字第 0890031707 號函

主旨：所詢貴轄○○耳鼻喉科診所聘用護理學校畢業尚未取得護理師(士)證書之人員，從事護理相關業務，是否違反護理人員法規規定乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 11 月 20 日 89 北衛醫字第 73989 號函。
- 二、依護理人員法第 1 條規定，中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。同法第 37 條並規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。依上開規定，僅護理學校畢業，而未領取護理師或護士證書者，仍未具護理人員資格，其若無合格護理人員之指導，執行護理業務應依違反護理人員法第 37 條論處。

(註：本函釋所敘之診所名稱以○○表示)

90. 6. 11. 衛署醫字第 0900030930 號函

主旨：所詢貴轄○○醫院聘僱未經護理人員考試及格之護校畢業生，執行抽痰及更換導尿管等行為，應如何適法處分案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局 90 年 5 月 23 日 90 北衛醫字第 30638 號函。

二、依護理人員法第 1 條規定，中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。同法第 37 條並規定，未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰，但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。本案請依上揭規定辦理。

（註：本函釋所敘之醫院名稱以○○表示）

91. 5. 29. 衛署醫字第 0910032199 號函

主旨：所詢有關應屆護理系畢業生無法立即取得證照，可否比照實習醫師以契約實習護士僱用乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴會 91 年 5 月 17 日輔陸字第 0912068 號函。

二、查「實習護士實施要點」第 2 點規定，本要點所稱之實習護士，係指在國內公立或立案之私立高級職業以上學校，修習護理學科系畢業學生依志願繼續從事實習者。又護理人員法第 37 條規定：未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。

三、按「實習護士實施要點」第 3 點、第 4 點規定，經中央衛生主管機關評鑑合格之地區以上之醫院，得進用實習護士，惟其進用人數以不超過該院護士人數之五分之一為限。

四、隨函檢附「實習護士實施要點」乙份供參。

94. 6. 30. 衛署醫字第 0940050047 號函

主旨：所詢尚未取得專業證照之護理學校應屆畢業生其任用資格等疑義，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 94 年 6 月 3 日宜醫秘字第 2852 號函。
- 二、按護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」爰此，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，依前揭規定，若該等人員確係在護理人員指導下從事護理工作，尚難謂涉有違反護理人員法情事。
- 三、次按護理師與護士等醫事人員，須經護理師或護士之專門職業考試，取得各該專業資格後，方得任用。依護理人員法第 37 條但書規定，實習之護理學校之學生或已畢業尚未取得護理人員證書者，其任用方式，宜由任用機關依相關法規辦理。
- 四、另按護理人員法第 1 條第 1 項規定，中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。爰此，持有考試院護理師或護士檢覈及格證書，而未領取護理師或護士證書前，僅具備取得護理人員資格之要件，因其程序尚未完成，依前開規定，仍未具備護理人員資格。

94. 12. 8. 衛署醫字第 0940062813 號函

主旨：所陳報越南籍護理人員○○○擬至貴院從事臨床護理研修一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 94 年 11 月 21 日校附醫國字第 0941140083 號函。
- 二、查護理人員法第 1 條第 1 項規定：「中華民國人民經護理

人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。」另同法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」。

- 三、前揭護理人員法第 37 條但書規定，並未限制實習者應具之學歷需在我國學校完成，爰如基於加強國際合作、促進學術交流或交換學生計畫之實際需要，該越南籍護理人員如係高級護理職業以上學校之學生或畢業生，經我駐外單位、政府機關或國際組織推薦至本國醫療機構從事臨床護理研修，尚符護理人員法第 37 條之相關規定。

（註：本函釋當事人之姓名以○○○表示）

95.12.28. 衛署醫字第 0950066615 號書函

主旨：所詢醫療機構任用實習護士之相關疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴診所 95 年 9 月 29 日、12 月 21 日相署保字第 09510902600 號及相署衛字第 09511201810 號函。
- 二、查「實習護士實施要點」第 2 點規定，本要點所稱之實習護士，指在國內公立或立案之私立高級職業以上學校，修習護理學科系畢業，領有畢業證書，繼續從事實習者；同要點第 3 點、第 4 點規定，經中央衛生主管機關評鑑合格之醫院，得進用實習護士，惟其進用人數以不超過該院護理人員人數之五分之一為限。
- 三、另按護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」是以，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，不得獨立執行護理業務；其若執行

護理業務，應在護理人員指導下為之，而其所為之護理紀錄，並應經指導護理人員簽名或蓋章，始符合法；未依前述規定執行護理業務者，則依違反護理人員法第 37 條規定論處。

四、爰此，貴診所任用實習護士，應依前揭規定辦理。

96.6.5. 衛署照字第 0960021848 號函

主旨：有關台灣護理學會函請澳門鏡湖護理學院 4 名護生於 96 年 6 月 25 日起至 7 月 6 日止為期 12 天至貴院參訓一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 96 年 5 月 18 日中榮教研字第 0960006749 號函。
- 二、查護理人員法第 1 條第 1 項規定：「中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。」。另同法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」。前揭護理人員法第 37 條但書規定，並未限制實習者應具之學歷需在我國學校完成，爰此，經我駐外單位、政府機關或國際組織推薦至本國醫療機構從事臨床護理研修，尚符護理人員法第 37 條之相關規定。另查，本案 4 名澳門籍護理學院在校護生，係以學生身分至本國醫療機構從事臨床護理研修，因涉及學生實習場所及課程規劃等相關權益，宜由學校具文，與貴院達成合作共識為之。
- 三、至該護生於貴院從事臨床護理研修期間，應遵守訓練機構內部管理相關規範，並依護理人員法之相關規定執行護理業務。

96.7.16. 衛署醫字第 0960030659 號函

主旨：所詢 貴轄私立醫療機構僱用密護違反護理人員法第 37

條規定，依法處分對象疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 7 月 6 日北衛醫字第 0960060392 號函。
- 二、依醫療法規定，私立醫療機構並未具法人資格，係屬醫師自然人之開業場所。是以，醫療法第 18 條規定，私立醫療機構由醫師設立者，應以醫師為申請人並為該機構之負責醫師，即由醫師設立之私立醫療機構，係以其負責醫師為權利義務主體，故有關私立醫療機構之處分(罰鍰部分)，按同法第 115 條規定處罰其負責醫師。本案請依前揭規定辦理。

(註：醫療法第 115 條第 1 項規定：本法所定之罰鍰，於私立醫療機構，處罰其負責醫師。)

103.2.21 衛部照字第 1031560264 號函

主旨：有關 貴會所詢護理人員法第 37 條所謂指導之定義是否包括各項紀錄之複核乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 103 年 1 月 22 日全聯護會盧字第 103034 號函。
- 二、依據護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」對所稱「指導」，得由護理人員自行斟酌指導之方式，並不以現場指導為要件，惟實習之學生或畢業生，於實習執行護理業務過程中對所為之護理業務，應經指導護理人員確認後，始得執行。
- 三、另查，護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。同法第 25 條規定亦指出，護理人員執行業務時，應製作紀錄。

- 四、是以，護理人員除業務執行，亦應製作紀錄，故對於實習之學生或畢業生從事上述事項亦應由護理人員指導及確認。

103.7.7 衛部照字第 1030015654 號函

主旨：有關貴局所詢護理人員未考取護理人員證書前，於醫療機構執行「跟診」一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 6 月 24 日桃衛醫字第 1030056710 號函。
- 二、查護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。前項第四款醫療輔助行為應在醫師之指示下行之」。而上述所稱醫療輔助行為之範圍包括：輔助施行侵入性檢查；輔助施行侵入性治療、處置；輔助各項手術；輔助分娩；輔助施行放射線檢查、治療；輔助施行化學治療；輔助施行氧氣療法(含吸入療法)、光線療法；輔助藥物之投與；輔助心理、行為相關治療；病人生命徵象之監測與評估；其他經中央主管機關認定之醫療輔助行為。前經本部 90 年 3 月 12 日衛署醫字第 0900017655 號函示在案。
- 三、次查護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」。
- 四、另查「實習護士實施要點」第 3 點及第 5 點規定略以，經中央衛生主管機關評鑑合格之醫院，得進用實習護士，在護理人員指導下，執行護理業務。而實習護士之實習期間，以自畢業之日起至次年 9 月 30 日止。
- 五、是以，所詢醫療機構內未考取護理人員證書之人員執行「跟診」是否違法疑義，仍請貴局應先釐清前揭人員目前身分資格、執業地點，並就其實際執業內容是否涉及護理業

務範疇，據以查處認定。

106.3.28 衛部照字第 1061560718 號

主旨：有關貴局所詢醫療機構聘僱或容留未具護理人員資格者執行護理業務之行政罰法相關疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局106年3月1日新北衛醫字第1060371766號函。
- 二、按「一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額。」、「數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分別處罰之。」行政罰法第24條第1項及第25條分別定有明文。準此，行為人違法之行為如評價為一行為（包括「自然一行為」與「法律上一行為」），縱違反數個行政法上義務規定，亦僅能依同法第24條規定裁罰；如認係數行為則應依同法第25條規定分別處罰；至違法之行為究應評價為「一行為」抑或「數行為」乃個案判斷之問題，並非僅就法規與法規間之關連或抽象事實予以抽象判斷，必須就具體個案之事實情節依據行為人主觀犯意、構成要件之事實、受侵害法益及所侵害之法律效果，斟酌被違反行政法上義務條文之文義、立法意旨、制裁之意義、期待可能性與社會通念等因素綜合判斷決定之（法務部102年1月23日法律字第10100258120號函釋意旨參考）。
- 三、據上，貴局應先判斷該未具護理人員資格者執行護理人員業務之醫療機構與其雇主是否為同一主體，倘非同一主體，應依違反醫療法第57條第2項及護理人員法第37條規定，分別處罰之；倘為同一主體，則須進一步依上開說明，依具體個案情節，判斷依療機構之行為屬一行為或數行為，如為一行為，應有行政罰法第24條規定之適用。
- 四、是以，貴局所詢，請依上開規定，並就個案事實認定。

106.6.19 衛部照字第 1061561542 號

主旨：有關貴局函詢「未取得護理人員資格，是否可執行護理人員業務之疑義」案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 5 月 16 日中市衛醫字第 1060046353 號函。
- 二、依護理人員法第 37 條規定：「未取得護理人員資格，執行護理人員業務者，本人及其雇主各處新台幣一萬五千元以上十五萬元以下罰鍰。但在護理人員指導下實習之高級護理職業以上學校之學生或畢業生，不在此限。」。
- 三、查本部(前行政院衛生署)95 年 12 月 28 日衛署醫字第 0950066615 號書函，略以：「三、……，護理學校應屆畢業生或已畢業尚未取得護理人員證書者，並未具護理人員資格，不得獨立執行護理業務；其若執行護理業務，應在護理人員指導下為之，而其所為之護理紀錄，並應經指導護理人員簽名或蓋章，始符合法；未依前述規定執行護理業務者，則依違反護理人員法第 37 條規定論處。」。又對於前述所稱之「指導」，按本部 103 年 2 月 21 日衛部照字第 1031560264 號函，略以：「二、……對所稱『指導』，得由護理人員自行斟酌指導之方式，並不以現場指導為要件，惟實習之學生或畢業生，於實習執行護理業務過程中對所為之護理業務，應經指導護理人員確認後，始得執行。」合先敘明。
- 四、綜上，就護理人員法第 37 條之但書所定高級護理職業以上學校畢業生，條文並未規定實習場所、年限等條件，亦未授權行政機關訂定法規命令予以補充。爰如該等實習學生或畢業生於實習執行護理業務過程符合前述規定，尚難以其違反護理人員法第 37 條規定裁罰。另為強化護理人員管理，並有效運用人力，本部業訂有「實習護士實施要點」(94 年 9 月 28 日修正)，建議醫院於進用護理科系畢業生時參照該要點第 3 至 5 點辦理(如附件)。
- 五、至所提若符合護理人員法第 37 條之但書規定，則無違反

法令規範恐有助長醫療機構規避稽查之疑慮，本部將再收集相關意見研議修法之可行性。

- 第 38 條 違反第七條或第十八條之一第二項規定者，處新臺幣一萬元以上六萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。
- 第 39 條 違反第十一條第一項規定者，處新台幣三千元以上三萬元以下罰鍰。
- 第 40 條 護理人員受廢止執業執照之處分時，應自事實發生之日起三日內將執照繳銷；其受停業之處分者，應將執照送由主管機關將停業理由及期限記載於該執照背面，仍交由本人收執，期滿後方准復業。
- 第 41 條 本法所定之罰鍰、停業、撤銷或廢止執業執照、開業執照，除本法另有規定外，由直轄市、縣（市）主管機關處罰之；撤銷、廢止或吊扣護理人員證書，由中央主管機關處罰之。
- 第 42 條 （刪除）

第六章 公會

- 第 43 條 護理人員公會分直轄市及縣（市）公會，並得設護理人員公會全國聯合會。
- 第 44 條 護理人員公會之區域，依現有之行政區域，在同一區域內，同級之公會以一個為限。但於行政區域調整變更前已成立者，不在此限。
- 第 45 條 直轄市及縣（市）護理人員公會，由該轄區域內護理人員九人以上發起組織之；未滿九人者，得加入鄰近區域之公會或共同組織之。
- 第 46 條 （刪除）
- 第 47 條 護理人員公會全國聯合會應由三分之一以上之直轄市、縣（市）護理人員公會完成組織後，始得發起組織。

前項護理人員公會聯合會成立後，本法第四十五條之直轄市及縣（市）護理人員公會應加入之。

第 48 條 各級護理人員公會，由人民團體主管機關主管。但其目的事業，應受主管機關之指導、監督。

第 49 條 各級護理人員公會置理事、監事，均於召開會員（會員代表）大會時，由會員（會員代表）選舉之，並分別成立理事會、監事會，其名額如下：

一、直轄市、縣（市）護理人員公會之理事，不得超過二十七人。

二、護理人員公會全國聯合會之理事，不得超過三十五人。

三、各級護理人員公會之理事名額，不得超過全體會員（會員代表）人數二分之一。

四、各級護理人員公會之監事名額，不得超過各該公會理事名額三分之一。

各級護理人員公會得置候補理事、候補監事；其名額不得超過各該公會理事、監事名額三分之一。

理事、監事名額在三人以上者，得分別互選常務理事、常務監事，其名額不得超過理事或監事總額三分之一，並應由理事就常務理事中選舉一人為理事長；其不置常務理事者，就理事中互選之。常務監事在三人以上者，應互選一人為監事會召集人。

第 50 條 理、監事任期均為三年，連選連任者不得超過二分之一；理事長之連任，以一次為限。第 50-1 條上級護理人員公會理事、監事之當選，不限於下級護理人員公會選派參加之會員代表。

下級護理人員公會選派參加上級護理人員公會之會員代表，不限於該下級護理人員公會之理事、監事。

第 51 條 護理人員公會每年召開會員（會員代表）大會一次，必要時得召開臨時大會。護理人員公會會員人數超過三百人時，得依章程之規定，就會員分布狀況劃定區域

，按其會員人數比率選定代表，召開會員代表大會，行使會員大會之職權。

第 52 條 護理人員公會應訂立章程，造具會員名冊及選任職員簡歷名冊，送請所在地人民團體主管機關立案，並分送中央及所在地主管機關備查。

第 53 條 各級護理人員公會之章程，應載明下列事項：

- 一、名稱、區域及會所所在地。
- 二、宗旨、組織、任務或事業。
- 三、會員之入會及出會。
- 四、會員應納之會費及繳納期限。
- 五、會員代表之產生及其任期。
- 六、理事、監事名額、權限、任期及其選任、解任。
- 七、會員（會員代表）大會及理事會、監事會會議之規定。
- 八、會員應遵守之公約。
- 九、經費及會計。
- 十、章程之修改。
- 十一、其他依法令規定應載明或處理會務之必要事項。

第 54 條 護理人員公會違反法令或章程者，人民團體主管機關得為下列之處分：

- 一、警告。
- 二、撤銷其決議。
- 三、撤免其理事、監事。
- 四、限期整理。

前項第一款、第二款處分，亦得由主管機關為之。

第 54-1 條 直轄市、縣（市）護理人員公會對護理人員公會全國聯合會之章程及決議，有遵守義務。

第 55 條 護理人員公會之會員有違反法令或章程之行為者，公會得依章程、理事會、監事會或會員（會員代表）大會之決議處分。

第 55-1 條 中央或直轄市、縣（市）主管機關依本法核發證書或執照時，得收取證書費或執照費；其費額，由中央主管機關定之。

第 55-2 條 本法中華民國九十六年一月九日修正之條文施行前已立案之護理人員公會全國聯合會，應自本法修正施行之日起四年內，依本法規定完成改組；已立案之省護理人員公會，應併辦理解散。

第 55-3 條 外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試。前項考試及格，領有護理人員證書之外國人與華僑，在中華民國執行護理業務，應經中央主管機關許可，並應遵守中華民國關於護理與醫療之相關法令及護理人員公會章程；其執業之許可及管理辦法，由中央主管機關定之。

違反前項規定者，除依法處罰外，中央主管機關並得廢止其許可。

97. 9. 11. 衛署醫字第 0970215426 號函

主旨：所陳有關外國人領有工作證可否從事「家庭看護 IN HOUSE NURSE」職業案，就 CARE GIVER 可否從事醫療行為及法定護理工作等乙案，復請 查照。

說明：

一、依據行政院秘書處 97 年 8 月 22 日臺衛字第 0970037194 號函及 97 年 8 月 5 日院臺衛移字第 0970034026 號移文單、外交部 97 年 8 月 13 日外亞太二字第 09712007610 號函及 97 年 8 月 5 日外亞太二字第 09703105050 號函、監察院 97 年 8 月 5 日(97)院臺業貳字第 0970161410 號函、內政部 97 年 8 月 12 日台內社字第 0970127629 號函辦理，兼復台端 97 年 7 月 28 日陳情書。

二、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言，不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人所為之醫療行為均屬之。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷

記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由輔助人員依醫囑行之。上述所稱輔助人員，其資格應符合各該類醫事人員管理法規之規定。資格不符規定之人員，若依醫囑執行前開醫療輔助行為，應分別依違反各該醫事人員管理法規規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。再予敘明。

- 三、復按我國護理人員法第 55 條之 3 規定，外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試及格，並依法領有護理人員證書及經中央主管機關許可者，始得執行我國護理人員法所定護理人員之業務。併予敘明。
- 四、另查導尿及抽痰等工作，係屬醫療業務行為，應由醫師親自為之，或依護理人員法，得由護理人員依醫師指示為之。未具護理人員資格者，若依醫囑執行前述業務，係屬違反護理人員法第 37 條規定，本人及其雇主各處新台幣 1 萬 5 千元以上 15 萬元以下罰鍰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。
- 五、又鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得指示護理人員協助為之；至為維持個案生理機能所需，及維護身體清潔及衛生以增加舒適感，由未具護理人員資格之照顧服務員執行鼻胃管灌食，及因置入鼻胃管所引發之分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷、醫療行為等，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。前經本署 96 年 4 月 27 日衛署照字第 0962800730 號函釋在案。
- 六、至單純之量血壓、脈搏及體溫，如未涉及診斷，尚難認屬醫療業務，一般民眾均可為之；惟如涉及疾病檢查、診斷與治療等醫療業務之整體連貫作業，係屬醫療行為，應由醫師或由護理人員依醫囑行之。
- 七、是以，本案就 CARE GIVER 可否從事醫療行為及法定護理工作乙事，請參酌上開原則及規定辦理。

(註：本函釋說明五所敘本署 96.4.27.衛署照字第 0962800730 號函，請參閱 P.392)

102.5.30.衛署照字第 1022863283 號函

主旨：有關所詢臺北市私立○○○長期照顧中心申請聘雇緬甸籍○○○君從事專門性、技術性工作乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 102 年 4 月 29 日勞職許字第 1020504630 號函。
- 二、依據護理人員法第 55-3 條規定：「外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試。前項考試及格，領有護理人員證書之外國人與華僑，在中華民國執行護理業務，應經中央主管機關許可，並應遵守中華民國關於護理與醫療之相關法令及護理人員公會章程；其執業之許可及管理辦法，由中央主管機關定之。」同法第 8 條：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」。
- 三、外國人及華僑領有合格護理人員證書者，須經執業登記並領有執業執照，始得執行護理業務，又，護理人員之執業場所包括醫療機構、護理機構、安養護機構及其他醫事機構（如捐血中心）、學校…等場所。查旨案緬甸籍○○○君已領有護理師證書，惟應經執業登記領有執業執照後，始得執行護理業務。
- 四、次查「外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 1 款至第 6 款工作資格及審查標準」第 28 條第 5 款規定「所稱其他經中央主管機關會商『中央目的事業主管機關』認定得聘僱前條外國人之機構」乙節，有關護理人員執登管理等事項係受護理人員法規範，按護理人員法第 5 條規定，本法所稱主管機關在中央為本署，又本案申請機構為老人長期照顧中心，其屬內政部權責，故前開規定所稱「中央目的事業主管機關」，仍應由貴會予以認定。

(註：本函釋長期照顧中心、當事人之姓名以○○○表示)

103.2.14 衛部照字第 1030103595 號函

主旨：有關 貴局所詢外籍人士得否以外國合格護士資格來台從事相關工作乙案，復如說明，請 查照。

說明：

一、復 貴局 103 年 2 月 5 日領二字第 1035104521 號函。

二、依據護理人員法第 55-3 條規定：「外國人及華僑得依中華民國法律，應護理人員考試。前項考試及格，應經中央主管機關許可，並應遵守中華民國關於護理與醫療之相關法令及護理人員公會章程；其執業之許可及管理辦法，由中央主管機關定之」。同法第 8 條：「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業」。

三、另外國學歷報考本國護理人員考試之相關訊息，請參考考試院考選部網站相關訊息(<http://www.moex.gov.tw>)。

四、是以，所詢對象如依法取得本國護理人員證書，尚須經執業登記並領有執業執照始得執業。

第七章 附則

第 56 條 本法施行細則，由中央主管機關定之。

第 57 條 本法自公布日施行。

80.6.19. 衛署保字第 954621 號公告

主旨：公告護理人員法第 37 條於民國 82 年 6 月 30 日前分區實施範圍。

依據：護理人員法第 57 條。

公告事項：

一、經醫院評鑑合格之醫學中心（含準醫學中心）自民國 81 年元月 1 日起列為護理人員法第 37 條之實施範圍。

二、經醫院評鑑合格之區域醫院（含準區域醫院）自民國 81 年 7 月 1 日起列為護理人員法第 37 條之實施範圍。

（註：護理人員法第 57 條原條文（96.1.29. 修正）：本法自公布日施行

。但第三十七條之施行，中央主管機關得於民國八十二年六月三十日前審酌實際情況分區實行。）

六、護理機構分類設置標準解釋彙編

護理機構分類設置標準解釋彙編

1. 中華民國 82 年 8 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 8247383 號令訂定發布全文 14 條，自發布日施行
2. 中華民國 85 年 3 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 85013102 號令修正發布第 11 條附表
3. 中華民國 87 年 6 月 17 日行政院衛生署衛署醫字第 87032530 號令修正發布全文 11 條
4. 中華民國 92 年 10 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 0920216079 號令修正發布第 8 條附表「護理機構設置標準表」
5. 中華民國 97 年 9 月 23 日行政院衛生署衛署醫字第 0970205502 號令修正發布名稱及第 2 條、第 3 條、第 9 條條文；並刪除第 10 條條文(原名稱:護理機構設置標準)
6. 中華民國 100 年 12 月 2 日行政院衛生署衛署照字第 1002863077 號令修正發布第 8 條附表，並增訂第 10 條之 1 條文
7. 中華民國 102 年 8 月 9 日衛生福利部衛部照字第 1021580033 號令修正發布第 8 條附表

第 1 條 本標準依護理人員法（以下簡稱本法）第十六條第二項規定訂定之。

第 2 條 護理機構，分類如下：

- 一、居家護理機構。
- 二、護理之家。
- 三、產後護理機構。

第 3 條 產後護理機構之服務對象，以下列各款產後需護理之產婦及嬰幼兒為限：

- 一、產後未滿二個月之產婦。
- 二、出生未滿二個月之嬰幼兒。

前項各款服務對象，經醫師診斷有特殊需要者，得不受二個月之限制。

86.5.19. 衛署醫字第 86020319 號函

主旨：護理機構設置標準第 3 條至第 8 條所稱之醫師，依該標準規定，並無限制須為護理人員法第 20 條所定契約醫院之醫師，復請 查照。

說明：復 貴會 86 年 4 月 2 日(86)長期阮字第 066 號函。

第 4 條 居家護理機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要，至少每二個月由醫師再予診察一次。

第 5 條 護理之家機構，對所收案之服務對象，應由醫師予以診察；並應依病人病情需要，至少每個月由醫師再予診察一次。

93.1.30.衛署醫字第 0930001230 號書函

主旨：所詢安養機構商請醫院醫師定期至該機構為不便老人看診，是否可行？及看診場所之限制、設備標準等規定乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 93 年 1 月 6 日苗衛醫字第 0930300035 號函。
- 二、有關安養機構之病人如須接受醫療照顧，得依醫療法規定設立醫務室，及依醫師法第 8 條之 2 但書規定，由依法登記之執業醫師，經事先報准定時前往診療。

第 6 條 居家護理機構及護理之家機構，對於轉診及醫師每次診察之病歷摘要，應連同護理紀錄依規定妥善保存。

第 7 條 護理機構之負責資深護理人員，應督導其機構所屬護理人員及其他人員，善盡業務上必要之注意。

103.7.28 衛部照字第 1031500136 號函

主旨：所詢護理之家是否有護理人員應固定時間巡房之規定一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴署 103 年 7 月 17 日北檢治崑 103 相 247 字第 48475 號函。
- 二、查護理人員法係規範護理人員執業條件、業務範疇及護理

機構設置管理規定，依護理人員法第 15 條規定，護理機構之服務對象包含罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人等。同法第 24 條規定護理人員業務，包含健康問題之護理評估、預防保健之護理措施、護理指導及諮詢、醫療輔助行為，前項醫療輔助行為應在醫師之指示下行之。

三、承上，有關護理之家之護理人員是否應固定時間巡房，除護理人員執行業務應善盡必要之注意義務之外，並應視住民病況及照護需求認定，其事涉照護品質，非屬護理人員法之規定範疇。

四、檢附護理人員法全文 1 份。

第 8 條 護理機構之設置，其設置標準如附表「護理機構設置標準表」。

〔釋例類別〕 第 1 類 護理、社工及其他醫事人員之設置

91.1.17. 衛署醫字第 0900075119 號函

主旨：有關護理機構相關法規疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復台端 90 年 11 月 27 日書函。
- 二、按護理人員法第 21 條規定：護理機構之收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。爰此，各財團法人護理之家應依其所屬地方主管機關訂定之收費標準收取費用。
- 三、查護理機構設置標準所訂之護理人員，係指依法領有護理人員證書者，包括護士及護理師。依上開規定：護理之家每 15 床至少應有 1 名護理人員，且 24 小時均應有護理人員值班。病患服務人員每 5 床至少應有 1 人，且須取得訓練證明。又病患服務人員如經完成訓練取得證明，即可認定，並未特別區分本國籍或外國籍。

- 四、依來函所敘，如某護理之家設有 22 床，無論其病床是否滿床，至少應有護理人員總數 2 人、病患服務員總數 5 名，且 24 小時均需有護理人員值班，至於各輪值班之人數得由機構自行調派。

95. 9. 22. 衛署醫字第 0950040365 號函

主旨：所詢服務於醫院社會服務員(社工人員)資格認定及應否辦理執業登記疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 9 月 11 日東衛醫字第 0950011177 號函。
- 二、查醫療機構及護理機構之設置標準規定及所服務對象，不論人力配置或相關設施，均以身體罹患器質性疾病者之醫療及照護為主要考量，至社政單位所設之相關社會福利機構係對其所服務對象促進、發展或恢復其社會功能或提供相關福利措施等為主；是以，醫療保健機構與社會福利機構屬性不同，所賦予之社會責任、功能亦不相同，先予敘明。
- 三、次查「醫療機構設置標準」附表二、三，有關社會工作人員資格之相關規定，係指大專院校社會工作學系、所、組畢業者而言；另查「護理機構設置標準」附表，關於社會工作人員資格除前述人員外，實務上於認定時尚包括醫學社會學系、所、組畢業者。是以，目前醫療機構及護理機構有關社會工作人員任用資格，請依前述規定辦理。

98. 3. 4. 衛署照字第 0982800807 號函

主旨：「護理機構大夜班護理人員採值班制於休息室休息是否違反護理機構設置標準規定」一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 98 年 1 月 17 日衛醫字第 0970304116 號函。
- 二、按護理機構分類及設置標準表表明定「護理機構 24 小時均應有護理人員值班」，揆其規定意旨，應係護理機構內之

住民，多屬自醫院出院後尚需提供其連續性醫療照護者，爰為考量提供住民之安全照護與提升照護品質目的需要所定。是以，護理人員值夜班，仍應依其工作職掌妥適照護住民為宜。又倘值班期間，於休息室休息應有不宜。

- 三、另如遇護理機構違反護理機構分類及設置標準之規定時，雖無相關罰則，惟得參酌行政程序法第123條第1項第4款規定「行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。」辦理。

101.4.18. 衛署照字第1012861991號函

主旨：所詢關於一般護理之家收住呼吸器依賴個案之護理人力配置疑義案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局101年3月16日新縣衛醫字第1010003083號函。
- 二、所詢貴轄某護理之家，許可床數60床，開放床數60床，其中收住呼吸器依賴個案4床之護理人力配置案例，查100年12月2日發布修正之護理機構分類設置標準第8條附表（護理機構設置標準表）修正規定，一般護理之家護理人員設置標準1、15床至少應有1人。設置標準4、24小時均應有護理人員值班。爰此，依上開規定，其一般護理之家56床之護理人力配置應設4人以上，24小時均應有護理人員值班。
- 三、另再查一般護理之家護理人員設置標準5、收住呼吸器依賴個案達4床以上者，其人員應符合下列規定：(1)每10床應有1人，不足10床以10床計。(2)至少有1位護理人員具備呼吸照護臨床經驗2年。(3)24小時均應有護理人員上班，收住呼吸器依賴個案以24床為計算單位，每超過24床應再增加1人。爰此，所詢案例收住呼吸器依賴個案4床之護理人力配置，依上開規定應設有1人以上，且24小時均應有護理人員在班。

四、綜上，該機構之護理人力配置應設有 5 人以上，並應依規定 24 小時有護理人員在班。

101.7.12. 衛署照字第 1012863124 號函
主旨：所詢關於「護理機構分類設置標準」疑義案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 6 月 29 日苗衛醫字第 1010016155 號函。
- 二、所詢一般護理之家收住呼吸器依賴個案與一般住床是否明顯空間區隔一節，查 100 年 12 月 2 日發布修正之護理機構分類設置標準第 8 條附表（護理機構設置標準表）修正規定，一般護理之家病房設置標準 3、收住呼吸器依賴個案達四床以上者，其病房應符合下列規定：(1)應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床。
- 三、另若機構收住呼吸器依賴個案 30 床，一般住床 32 床，則該機構護理人力如下：
 - (一)查一般護理之家護理人員設置標準 1、15 床至少應有 1 人。設置標準 4、24 小時均應有護理人員值班。爰此，依上開規定，其一般護理之家 32 床之護理人力配置應設 3 人以上，24 小時均應有護理人員值班。
 - (二)再查一般護理之家護理人員設置標準 5、收住呼吸器依賴個案達 4 床以上者，其人員應符合下列規定：(1)每 10 床應有 1 人，不足 10 床以 10 床計。(2)至少有 1 位護理人員具備呼吸照護臨床經驗 2 年。(3)24 小時均應有護理人員上班，收住呼吸器依賴個案以 24 床為計算單位，每超過 24 床應再增加 1 人。爰此，所詢案例收住呼吸器依賴個案 30 床之護理人力配置，依上開規定應設有 4 人以上，且 24 小時均應有護理人員在班。
 - (三)綜上，該機構之護理人力配置應設有 7 人以上，並應依規定 24 小時有護理人員在班，收住呼吸器依賴個案床與一般住床應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一

隔間區域不超過六床。其是否全面會勘，請貴局本權責處理。

101.7.30.衛署照字第1012863239號函

主旨：所詢關於一般護理之家護理人員設置標準之疑義案，復請查照。

說明：

一、復 貴局 101 年 7 月 13 日北市衛醫護字第 10137142500 號函。

二、有關本署 100 年 12 月 2 日發布修正之護理機構分類設置標準第 8 條附表（護理機構設置標準表）修正規定，說明如下：

（一）一般護理之家護理人員設置標準 1、15 床至少應有 1 人。設置標準 4、24 小時均應有護理人員值班。

（二）再查一般護理之家護理人員設置標準 5、收住呼吸器依賴個案達 4 床以上者，其人員應符合下列規定：

1. 每 10 床應有 1 人，不足 10 床以 10 床計。

2. 至少有 1 位護理人員具備呼吸照護臨床經驗 2 年。

3. 24 小時均應有護理人員上班，收住呼吸器依賴個案以 24 床為計算單位，每超過 24 床應再增加 1 人。

三、爰此，護理機構應依申請設置之床數，其所聘用之護理人員數不少於上開規定之數。至其所配置人力是否足敷輪班所需人力，應於審查機構設立時提出審查意見。

四、至於護理人員執業登錄，則係指護理人員依護理人員法規定，應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。執業人員可做為前款說明查核時之參考。

五、無論護理機構所聘之護理人員數，其工時均應依勞動基準法相關規定辦理。

六、另有關一般護理之家收住呼吸器依賴個案之設置標準相關規定公告施行後，許可核發及開業登記之處理方式，本署

業於 101 年 1 月 3 日衛署照字第 1002863487 號及 101 年 5 月 4 日衛署照字第 1012862269 號函通知在案（諒達），請貴局本權責辦理。

（註：本函釋說明六所敘本署 101.1.3.衛署照字第 1002863487 號函，請參閱 P.164；101.5.4.衛署照字第 1012862269 號函，請參閱 P.166）

101.11.21.衛署照字第 1012864123 號函

主旨：有關貴院所詢護理機構分類設置標準相關疑義及所送案件本署查察結果，請 查照。

說明：

一、復 貴院 101 年 10 月 12 日新院千刑仁 101 訴 151 字第 22954 號函。

二、依據護理機構分類設置標準表規定：

（一）護理人員 15 床至少應有 1 人，照顧服務員每 5 床應有 1 人以上，所稱床數係該機構申請開業之床數核計，經查○○護理之家 98 年 12 月 4 日申請開業 168 床，又於 101 年 4 月 27 日變更開業床數為 166 床（一般床 143 床、收住呼吸器依賴個案床 23 床），依據本署 100 年 12 月 2 日修正發布之護理機構分類設置標準，該機構護理人員至少應有 12 人（至少有一位護理人員具備呼吸照護臨床經驗二年），且 24 小時均應有護理人員值班；照顧服務員至少應有 34 人。

（二）護理機構合法引進之外籍看護工之工作內容，為家務、日常生活及身體照顧服務，應符合「護理機構設置標準表」所規範之照顧服務員，惟須向衛生主管機關登錄為照顧服務員，應檢具經行政院勞工委員會聘僱許可函及聘僱名冊之證明文件辦理登錄作業，始可核算照顧服務員人力，且合法引進之外籍看護工不得逾機構照顧服務員二分之一，該等人員每年應接受至少 20 小時在職訓練。

(三)護理機構於設置或擴充申請時，須檢附設置或擴充計畫書，內容包括申請人、機構名稱、人員配置、設立床數等相關資料，若為公立護理機構或私立護理機構設置或擴充後之規模在九十九床以下者，由所在地直轄市或縣(市)主管機關許可；設置或擴充後之規模在一百床以上，或由醫療法人依醫療法規定附設者，由所在地直轄市或縣(市)主管機關核轉中央主管機關許可。

三、另本署為提升護理之家照護品質，促進護理之家品質標準學習與自我品質管理，於98年起辦理一般護理機構評鑑，縣市政府衛生局則每年辦理護理之家督導考核，查核內容包括護理機構分類設置標準、行政管理、住民安全、服務內容及整體環境等面向，又對於民眾陳情及檢舉案件則進行不定期稽查。

(註：本函釋說明二之(一)所敘之護理之家名稱以○○表示，又該機構護理人員至少應有「12」人乙節，應為「13」人之誤植)

101.12.6. 衛署照字第1012864522號函

主旨：有關貴局所詢所轄某護理之家申請設立之護理人力設置標準疑義案，復請 查照。

說明：

一、復 貴局101年11月15日新縣衛醫字第1010024239號函。

二、所詢貴轄某護理之家，許可床數194床，其中收住呼吸器依賴個案48床之護理人力配置案例，依據100年12月2日發布修正之護理機構分類設置標準第8條附表(護理機構設置標準表)修正規定，則該機構護理人力應符合：

(一)一般護理之家護理人員設置標準15床至少應有1人，24小時均應有護理人員值班。

(二)另若收住呼吸器依賴個案達4床以上者，其護理人員應符合下列規定：(1)每10床應有1人，不足10床以

10 床計。(2)至少有 1 位護理人員具備呼吸照護臨床經驗 2 年。(3)24 小時均應有護理人員上班，收住呼吸器依賴個案以 24 床為計算單位，每超過 24 床應再增加 1 人。

三、依前開規定，所詢一般護理之家 194 床，其中收住呼吸器依賴個案 48 床，其護理人員配置最少應符合一般住床 146 床，其護理人力配置應設 10 人以上；收住呼吸器依賴個案 48 床，每 10 床應有 1 人，不足 10 床以 10 床計。

四、另一般護理之家護理人員派班原則為 24 小時均應有護理人員在班，收住呼吸器依賴個案以 24 床為計算單位，每超過 24 床應再增加 1 人。收住呼吸器依賴個案床與一般住床應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床。

〔釋例類別〕 第 2 類 照顧服務員、嬰兒照顧人員之設置及業務範圍

86.5.17. 衛署醫字第 86021923 號函

主旨：持外國護照居留本國之外籍人士，如接受護理機構病患服務員訓練之完整課程，訓練單位得依規定發給病患服務員結業證書，復請 查照。

說明：復貴處 86 年 4 月 21 日衛五字第 860022798 號函。

86.12.11. 衛署醫字第 86069131 號函

主旨：護理之家病患服務人員由護校畢業未取得護理人員證書者擔任，是否得免接受病患服務人員訓練；又非護校畢業且未受病患服務人員訓練者，能否於日後補正乙案，復請 查照。

說明：

一、復 貴處 86 年 11 月 22 日衛五字第 860070634 號函。

二、依護理機構設置標準表規定，病患服務人員應有適當之訓

練。但由護理人員擔任者，不在此限。惟為顧及護校畢業未取得護理人員證書者，業已完成護理之正規養成教育，得免接受病患服務人員訓練。至非護校畢業且未受病患服務人員訓練者，應於取得訓練證明後，始得擔任病患服務人員。

89.2.19. 衛署醫字第 88078720 號函

主旨：所詢本署樂生療養院擬僱用具護理專長之外籍勞工，得否不受「本署所屬醫院病患服務人員管理要點」第6點第3款規定限制乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴辦公室 88 年 12 月 28 日衛署中管字第 0041212 號函。
- 二、按依「本署所屬醫院病患服務人員管理要點」第2點規定，所稱病患服務人員，係指基於協助照顧住院病患之需要，於其住院期間，由病患或其家屬所僱用經醫院認定之合格人員。應非由該療養院僱用，合先敘明。
- 三、至於該院之病患或其家屬擬僱用具護理專長之外籍勞工，得否不受「本署所屬醫院病患服務人員管理要點」第6點第3款所定之資格限制，請本於訂定該要點之意旨，自行依權責處理。

90.4.11. 衛署醫字第 0900015936 號函

主旨：有關「看護員」之工作內容是否涉及醫療行為？其技術是否適合以技能檢定方式予以認證，並實施該業證照制度乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 90 年 3 月 13 日台 90 勞職檢字第 0200129 號函。
- 二、按「看護員」應係指家屬自行聘請協助照顧病患之人員，其工作內容主要在協助照顧病患的衣食起居，如協助沐浴、更衣、服藥、上下床等，應不涉及醫療行為。

- 三、至於是否開辦該類人員技能檢定乙節，因「看護員」之服務內容、訓練方式如何與現行「病患服務員」、「居家服務員」區隔或整合仍有疑義，建議邀集相關單位及團體審慎研商再議。

90.6.16. 衛署醫字第 0900027144 號函

主旨：所詢醫療院所對看護工之管理權責乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 4 月 27 日北市衛五字第 9021840100 號函。
- 二、按「病患服務員」係護理機構設置標準規定需配置之服務人力，且所稱病患服務員，需完成地方衛生機關指定或委託單位所辦理之一百小時訓練，並取得結業證書，始得為之。
- 三、至於目前因社會變遷，雙薪家庭工作繁忙，無暇親自照顧住院家屬，故常有家屬或病人自行聘請所稱看護工前往醫院協助照顧病人，醫院基於內部安全及保障病人得到適當之照顧，訂定內部管理規章，對於病人家屬或病人自行聘請之看護工，作適度之規範，應無不可。

90.7.10. 衛署醫字第 0900036874 號函

主旨：有關貴部對醫院管理看護人員之相關建議乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 90 年 6 月 18 日台審部參字第 902340 號函。
- 二、按「病患服務員」係護理機構設置標準規定需配置之服務人力，且所稱病患服務員，需完成地方衛生機關指定或委託單位所辦理之一百小時訓練，並取得結業證書，始得為之。至於醫院內由家屬自行聘僱協助照顧病患之看護人員(即看護或看護工)，並無資格上之限制，且係病人(或病人家屬)與看護人員之私契約關係。惟為醫療服務管理之需要，醫院可訂定輔導管理措施，予以規範。

- 三、有關看護工之遴用是否需訂定統一資格標準以及醫院對看護工之管理應否收取管理費，並訂定管理費收費標準等節，業已錄案研究。
- 四、檢送護理人員法及其施行細則乙份，併請參考。

90.10.2. 衛署醫字第 0900051408 號函

主旨：有關漢銘醫院擬辦理病患服務人員訓練，訓練課程是否可教導抽痰技術及其同一梯次之受訓人數有無規範乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 90 年 8 月 9 日彰衛醫字第 90192289 號函。
- 二、查本署 82 年 12 月 29 日衛署醫字第 8203825 號公告護理機構病房服務人員之訓練及其相關事項，對於同一梯次受訓之人數並無特別限制。又依上開公告，訓練課程雖未涵括抽痰技術，惟為增進病患服務人員知識，其訓練課程安排抽痰法及技術講解，尚無不可。

91.6.5. 衛署醫字第 0910040436 號函

主旨：有關中華看護病患服務聯盟，逕引用本署衛署醫字第 0900019473 號函文號，函請醫院協助其辦理病患服務員培訓乙案，有誤導醫院之虞，請惠予糾正。

說明：

- 一、依據中華看護病患服務聯盟 91 年 4 月 18 日護聯進字第 910418 號函辦理（檢附該函影本供參）。
- 二、查本署 90 年 4 月 2 日衛署醫字第 0900019473 號函，係本署回復貴部對該團體籌組設立，有關章程草案之修正意見，與病患服務員培訓辦理事項無涉，本案該團體引用上開文號函請醫院協助其辦理病患服務員培訓計畫，顯為不當使用本署公文文號，有誤導醫院之虞，爰請貴部惠予糾正。
- 三、副本送中華看護病患服務聯盟，貴團體擬辦理病房服務人

員訓練，應依本署 82 年 12 月 29 日衛署醫字第 82083825 號公告「護理機構病房服務人員之訓練及其相關事項」規定辦理。

92.5.20. 衛署醫字第 0920026735 號函

主旨：有關 貴府函詢醫院看護工是否需接受照顧服務員訓練或有其他相關規定乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴府 92 年 5 月 9 日屏府衛字第 0920077196 號函。
- 二、按「照顧服務員」係護理機構設置標準規定需配置之服務人力，且所稱照顧服務員，需完成地方衛生機關指定或委託單位所辦理 90 小時訓練，並取得結業證書，始得為之。至於醫院內家屬自行聘請協助照顧病患之人員(即看護工)，並無資格上之限制，其工作內容主要在協助照顧病患的衣食起居，如協助沐浴、更衣、服藥、上下床等，應不涉及醫療行為，且係病人(或病人家屬)與看護工之私契約關係。惟為醫療服務管理之需要，醫院可訂定輔導管理措施，予以規範。

92.11.27. 衛署醫字第 0920058049 號書函

主旨：所詢「護理機構設置標準」中設置之「病患服務人員」其服務範圍可否擴及醫療機構等情乙案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 10 月 27 日北市衛五字第 09236872400 號函。
- 二、按「護理機構設置標準」中設置之「照顧服務員」，係為因應我國長期照護人力需求，針對日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足，需他人協助者，提供照顧服務。內政部 92 年 2 月 13 日台內社字第 0920069151 號暨同日本署衛署醫字第 0920201712 號會銜公告照顧服務員訓練

實施計畫及其相關事項，有關照顧服務員之服務項目如下：
：(一)家務及日常生活照顧服務。(二)身體照顧服務。(三)在護理人員指導下執行病患照顧之輔助服務。但服務範疇不得涉及醫療及護理行為。爰此，是類人員之任用，醫療機構可依權責逕予決定。

93.1.30.衛署醫字第0930002637號函

主旨：所詢護理機構設置標準有關「產後護理機構得視業務需要設置照顧服務員」中所指「照顧服務員」是否可以「保母人員」取代？並於取得保母人員受訓結業證書後，可受雇於產後護理機構工作乙案，查產後護理機構因服務對象與護理之家機構不同，得視業務需要設置照顧服務員，至於產後護理機構依業務需要任用保母人員，應無不可，請查照。

說明：復 貴局93年1月15日北市衛五字第09330022000號函。

93.6.30.衛署醫字第0930025497號書函

主旨：所詢護理人員已取得國家考試證照者，如從事看護工作是否需參加照顧服務員技術士技能檢定乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、依據行政院勞工委員會中部辦公室93年6月17日勞中二字第0930200490號書函轉台端陳情書辦理。
- 二、按護理人員係屬專門職業資格，而技術士係屬技能檢定，兩種屬性不同。依護理人員法第1條規定：中華民國人民經護理人員考試及格，並依本法領有護理人員證書者，得充護理人員。至台端所詢「看護工作」之工作性質未明，惟依護理機構設置標準規定，護理機構之照顧服務員需符合本署與內政部於92年2月13日會銜公告照顧服務員訓練實施計畫之規定，凡經參加照顧服務員訓練，經考評及格領有結業證書者，即得擔任護理機構照顧服務員。至領

有護理人員證書者擔任護理機構照顧服務員，得免經前開之訓練。

96. 3. 5. 衛署照字第 0962800481 號函

主旨：所詢外籍監護工如何得認列為護理之家人力案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 96 年 1 月 18 日護協字第 096009 號函。
- 二、按「護理機構設置標準」中設置之「照顧服務員」，係為因應我國長期照顧人力需求，針對日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足，需他人協助者，提供家務及日常生活照顧服務、身體照顧服務及在護理人員指導下執行病患照顧之輔助服務，但服務範疇不得涉及醫療及護理行為；另按護理機構設置標準規定，護理機構之照顧服務員須符合本署與內政部於 92 年 2 月 13 日會銜公告照顧服務員訓練計畫之規定，凡經參加照顧服務員訓練，經考評及格領有結業證書者，即得擔任護理機構照顧服務員，先予敘明。
- 三、至所述外籍監護工於來台前，已接受 90 小時照顧服務員專長訓練，持有專長證明且實際從事老人日常照顧服務者，得否認列護理之家之人力一節，查護理機構設置標準之關於照顧服務員資格認定已如前所述，如該護理機構為提昇照顧品質，依相關法規聘僱受有照顧服員專長訓練之外籍監護工，協助照顧住民的衣食起居，尚無不可，惟該外籍監護工未領有本國認證單位訓練考評及格領取結業證書前，尚不得列計為護理機構設置有關照顧服務員應置之人數。

96. 4. 27. 衛署照字第 0962800730 號函

主旨：關於照顧服務員得否執行鼻胃灌食疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 4 月 11 日衛醫字第 0960014310 號函。
- 二、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。且醫療業務之認定，並不以收取報酬為其要件。前揭所稱醫療行為係指凡以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為的診察、診斷及治療；或基於診察、診斷結果，以治療為目的，所為的處方、用藥、施術或處置等行為的全部或一部的總稱。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由相關醫事人員依其各該專門職業法律之規定，依醫師指示行之，先予敘明。
- 三、查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，另查有關執行鼻胃管置入之醫療輔助行為為人員資格，前經本署 93 年 12 月 28 日衛署醫字第 0930052157 號書函函釋在案略以：「……三、…。因鼻胃管初次置入仍有相當程度之危險性，宜由醫師親自為之；至鼻胃管全管拔除及需長期鼻胃管留置患者之定期更換，如經醫師診察、判斷後，得可指示護理人員協助為之。」。
- 四、至為維持個案生理機能所需、及維護身體清潔及衛生以增加舒適感，由未具護理人員資格之照顧服務員執行鼻胃管灌食，及因置入鼻胃管所引發之分泌物簡易照顧處理，如不涉及醫療專業判斷、醫療輔助行為及醫療行為等，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。

（註：本函釋說明三所敘本署 93.12.28.衛署醫字第 0930052157 號書函，請參閱 P.272）

96.8.13.衛署醫字第 0960203358 號函

主旨：所詢國內護理學校畢業未取得護理人員證書者，得否以畢業證書取代照顧服務員訓練證書，擔任護理之家照顧服務員等情疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 96 年 8 月 2 日(96)長期林字第 280 號函。
- 二、按「照顧服務員」係護理機構設置標準規定需配置之服務人力，且所稱照顧服務員，需符合本署與內政部於 92 年 2 月 13 日會銜公告照顧服務員訓練實施計畫之規定，參加地方衛生機關指定或委託單位辦理之照顧服務員 90 小時訓練，經考評及格領有結業證書者，即得擔任護理機構照顧服務員，前經本署多次函釋在案。另依護理機構設置標準表規定，照顧服務員得由具護理人員資格者擔任並計列其人數，併予敘明。
- 三、至護理學校畢業未取得護理人員證書者，得否以畢業證書取代照顧服務員訓練證書，擔任護理之家照顧服務員一節，查護理人員係屬專門職業資格，而照顧服務員丙級技術士係屬技能檢定，兩者屬性不同；又查，護理學校畢業證書係為學歷證明，並非照顧服務員訓練證書，亦非等同技術檢定證書，僅該養成教育背景，具備取得照顧服務員丙級技術士資格之要件，先予敘明。惟護理學校畢業未取得護理人員證書者，因業已完成護理之正規養成教育，得免接受照顧服務員之技術訓練，前經本署 86 年 12 月 11 日衛署醫字第 86069131 號函釋在案，至本案關於照顧服務員結業證書之取得，仍需依「照顧服務員訓練實施計畫」之規定參訓，並經考評合格後始得為之。
- 四、副本抄送各縣市政府，有關護理學校畢業未取得護理人員證書者，依「照顧服務員訓練實施計畫」之規定參訓時，因業已完成護理之正規養成教育，得免接受照顧服務員之技術訓練，轉請依權責抵免相關受訓課程及費用。

(註：本函釋嗣經本署 97.10.29.衛署照字第 0972801896 號函補充說明，國內護理學校畢業，免再受照顧服務員該項訓練，如以「照顧服務員」任用，可依護理學校畢業證書向地方衛生機關登錄「照顧服務員」，請參閱 P.397)

97.3.4. 衛署照字第 0970009178 號函

主旨：所詢合法引進外籍機構看護工，完成國內照顧服務員訓練課程取得證明或取得照顧服務員丙級技術士證照，可否認列護理之家人力及相關法令規定案，請查照。

說明：

一、復 貴公司 97 年 1 月 28 日台護第 097012801 號函兼復內政部 97 年 1 月 25 日內授中社字第 0970001596 號書函。

二、按「護理機構設置標準」中設置之「照顧服務員」，係為因應我國長期照顧人力需求，針對日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足，需他人協助者，提供家務及日常生活照顧服務、身體照顧服務及在護理人員指導下執行病患照顧之輔助服務，但服務範疇不得涉及醫療及護理行為；另按護理機構設置標準規定，護理機構之照顧服務員須符合本署與內政部於 92 年 2 月 13 日會銜公告照顧服務員訓練計畫之規定，凡經參加照顧服務員訓練，經考評及格領有結業證書者，即得擔任護理機構照顧服務員，先予敘明。

三、依「外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準」第 21 條規定，護理之家得聘僱外籍看護工人數，以其依法登記之床位數，每 5 床聘僱 1 人計算，又受聘僱外國人人數合計不得超過本國看護工之人數（檢附行政院勞工委員會函及附件影本）。

（註：1. 本函釋嗣經本署 97.10.29. 衛署照字第 0972801896 號函補充說明，請參閱 P. 397。

2. 本函釋說明三所敘行政院勞工委員會函，其內容如下：

97.2.21. 勞職審字第 0970003674 號函

主旨：有關護理之家合法引進外籍看護工人數之法令規定，復如說明，請 查照。

說明：

一、復 貴署 97 年 2 月 4 日衛署照字第 0970005429 號函。

二、依「外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工

作資格及審查標準」第 21 條規定，護理之家得聘僱外籍看護工人數，以其依法登記之床位數，每 5 床聘僱 1 人計算，又受聘僱外國人人數合計不得超過本國看護工之人數。）

97.7.17. 衛署醫字第 0978900273 號函

主旨：有關行政院勞工委員會職業訓練局核發招募外國人在國內擔任「家庭看護」職位，從事醫療行為及法定看護 Nurse 工作疑義一案，復如說明，請 查照。

說明：

- 一、依 台端 97 年 6 月 24 日陳情書辦理。
- 二、按醫療業務係指以醫療行為為職業而言。不問是主要業務或附屬業務，凡職業上予以機會，為非特定多數人之醫療行為均屬之。又醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘行為得由輔助人員依醫囑行之。上述所稱輔助人員，其資格應符合各該類醫事人員管理法規之規定。資格不符規定之人員，若依醫囑執行前開醫療輔助行為，應分別依違反各該醫事人員管理法規規定處罰；若無醫囑擅自為之，則應受醫師法第 28 條之約束。先予敘明。
- 三、按「病患服務員」係護理機構設置標準規定需配置之服務人力，且所稱病患服務員，需完成地方衛生機關指定或委託單位辦理之一百小時訓練，並取得結業證書，始得為之。至醫院內或家庭內由家屬自行聘僱協助照顧病患之看護人員（即看護或看護工），其工作內容因主要在協助照顧病患的衣食起居，如協助沐浴、更衣、服藥、上下床等，應不涉及醫療行為，是以，並無資格上之限制。
- 四、另為因應人口老化之趨勢及我國長期照護人力需求，提昇照顧服務品質，促進居家服務員、病患服務人員就業市場相互流通，增加就業機會，並整合居家服務員、病患服務人員訓練課程為照顧服務員訓練課程，前於 92 年 2 月 13 日即以衛署醫字第 0920201712 號函與內政部會銜公告「照

顧服務員訓練實施計畫」在案，又前開訓練計畫明定服務項目，包含家務及日常生活照顧服務、身體照顧服務及在護理人員指導下執行病患照顧之輔助服務。但服務範疇不得涉及醫療及護理行為；實施要項之受訓對象並明定，包含具本國國籍，或領有工作證之外籍人士…等，併予敘明。

五、至其他有關外國人從事「看護 Nurse」職位工作等相關疑義，建議仍請逕向該業務主管機關(行政院勞工委員會職業訓練局)洽詢。

97.10.29.衛署照字第 0972801896 號函

主旨：為國內護理學校畢業，免再受照顧服務員該項訓練，如以「照顧服務員」任用，可依護理學校畢業證書向地方衛生主管機關登錄「照顧服務員」，核算護理機構照顧服務員人力，請 查照。

說明：補充說明本署 96 年 8 月 13 日衛署醫字第 0960203358 號函。

97.11.27.衛署照字第 0972802796 號函

主旨：有關合法引進之外籍看護工，是否符合「護理機構設置標準表」規範之照顧服務員案，請 查照。

說明：

- 一、修正本署 96 年 3 月 5 日衛署照字第 0962800481 號函及補充說明本署 97 年 3 月 4 日衛署照字第 0970009178 號函。
- 二、為因應我國長期照護人力需求，提昇照顧服務品質，內政部與本署於 92 年 2 月 13 日會銜公告「照顧服務員訓練實施計畫」，惟其受訓對象不包括合法引進之外籍看護工。又依內政部 97 年 6 月 19 日「研商照顧服務員培訓相關事宜會議紀錄」陸、報告案第二案：行政院勞工委員會 92 年 10 月 20 日職外字第 0920053865 號函以：合法引進之機構外籍看護工，因引進時已受訓合格並持有專長證明書，

故無接受照顧服務員訓練之需要。

- 三、護理機構合法引進之外籍看護工之工作內容，為家務、日常生活及身體照顧服務，應符合「護理機構設置標準表」所規範之照顧服務員，惟其合法引進之外籍看護工不得逾機構照顧服務員二分之一，同時該等人員每年應接受至少 20 小時在職訓練。

98.1.15. 衛署照字第 0980060730 號函

主旨：有關外籍看護工受僱「護理之家」須具備何種證明文件一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 98 年 1 月 12 日高市衛保字第 098001320 號函。
- 二、外籍看護工受僱「護理之家」，向衛生主管機關登錄為照顧服務員，應檢具經行政院勞工委員會聘僱許可函及聘僱名冊之證明文件辦理登錄作業，始可核算照顧服務員人力。

101.3.12. 衛署照字第 1012860714 號函

主旨：所詢關於居家服務提供單位聘用醫護等相關科系學歷者，擔任居家服務督導員之執業登記乙案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴聯盟 100 年 11 月 22 日 100 居盟(函)字第 021 號函。
- 二、查「居家服務提供單位營運管理規範」，所稱居家服務督導員係專職負責督導照顧服務員提供適切之居家服務業務，非以執行護理人員業務為其職業，縱具護理人員資格者，於社區從事民眾照顧指導、公共衛生教育，可免辦理執業登記。
- 三、又「居家服務提供單位營運管理規範」所稱居家服務提供單位，指直轄市、縣(市)政府，或經直轄市、縣(市)政府

委託辦理居家服務之公益慈善、醫療、護理社團法人、財團法人、人民團體，或醫療、護理、老人福利、身心障礙福利機構，並不限醫療及護理機構，且居家服務提供單位提供服務項目為「家務及日常生活照顧服務」與「身體照顧服務」，亦不涉及醫療業務。

- 四、依護理人員法第 12 條規定，「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限」。
- 五、爰此，居家服務督導員執行之業務，建議仍應以「居家服務提供單位營運管理規範」所訂之服務內容為宜，或再衡酌該規範之服務範疇。

101.4.30. 衛署照字第 1012862341 號函

主旨：所詢身心障礙者居家照顧服務，照顧服務員得否執行身心障礙者排便前置作業乙事，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復內政部 101 年 3 月 29 日授中社字第 1015931628 號函暨高雄市政府衛生局 101 年 4 月 20 日高市衛長字第 10133902400 號函。
- 二、按醫療工作之診斷、處方、手術、病歷記載、施行麻醉等醫療行為，應由醫師親自執行，其餘醫療輔助行為在醫師就特定病人診察後，得指示其他醫事人員依其各該專門職業法規之業務，依醫囑行之，合先敘明。
- 三、查使用「需由醫師處方使用」之浣腸劑，為病人執行清潔灌腸，係屬侵入性治療、處置；另查「輔助施行侵入性治療、處置」係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，應由護理人員依醫師指示下執行該項業務；至於照顧服務員提供身心障礙者居家照顧服務，從事個案身體之照顧，使用成藥類別之甘油球浣腸劑，對個案肛門口周遭糞便所為之簡易、少量甘油灌腸，以維持個案

身體清潔與衛生及增加舒適感，如不涉及醫療專業判斷及醫療輔助行為，僅係個案身體照顧服務，尚無不可。

四、是以，本案所述情事，請依前揭原則，視個案事實，逕依權責認定。

102. 2. 27. 衛署照字第 1022860492 號函

主旨：有關 貴會詢問外籍家庭看護工從事是項工作是否涉及專業醫療行為乙事，復請 查照。

說明：

一、復 貴會 102 年 1 月 31 日勞職管字第 1010038868 號函。

二、按外國人從事就業服務法第 46 條第 1 項第 8 款至第 11 款工作資格及審查標準第 4 款規定，家庭看護工作係在私人家庭從事身心障礙者或病患日常生活照顧等相關事務工作。是以，家庭看護工作人員非屬醫事專門職業人員，爰工作範疇不可涉及醫療行為，合先敘明。

三、旨案 貴會所詢外籍家庭看護工可否對被看護者使用市售 one touch 血糖機採血及測血糖，以及鼻胃管灌食一案，為維持被照顧者生理機能所需、維護身體清潔及衛生，及協助日常生活保健所需，得依照本署 101 年 6 月 28 日衛署照字第 1012862926 號函(如附件 1)及 96 年 4 月 27 日衛署照字第 0962800730 號函(如附件 2)說明段意旨之精神辦理，尚無不可。

四、另，基於照護品質，外籍家庭看護工是否具有國內照顧服務員資格，亦或接受與國內照顧服務員相當之照護專業訓練，亦請一併考量。

(註：本函釋說明三所敘本署 101. 6. 28. 衛署照字第 1012862926 號函，請參閱 P. 260；96. 4. 27. 衛署照字第 0962800730 號函，請參閱 P. 392)

103. 3. 14. 衛部照字第 1031560270 號

主旨：有關產後護理機構嬰兒照顧人員之工作內容疑義，復如說

明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 10 月 9 日北市衛醫護字第 10238132300 號函。
- 二、依據「護理機構分類設置標準」第八條附表「嬰兒照顧人員資格自中華民國 103 年 7 月 1 日起適用」，係指自該日起，產後護理機構人員配置應符合「每五床嬰兒床配置嬰兒照顧人員一人」之規定。
- 三、另有關嬰兒照顧人員之工作內容，尚僅得提供嬰兒之基本照顧，包括嬰兒之飲食、衣物及洗滌等，而未涉及依護理人員法第 24 條規定：「護理人員之業務如左：一、健康問題之護理評估。二、預防保健之護理措施。三、護理指導及諮詢。四、醫療輔助行為。」之有關嬰兒醫療及護理等業務。

104.12.28 衛部照字第 1041562773 號

主旨：所詢有關護理之家聘用照顧服務員時薪疑義案，本部回復說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 104 年 12 月 4 日東衛長字第 1040029185 號函暨依據本部社會及家庭署 104 年 12 月 10 日社家老字第 10400110092 號移文單辦理。
- 二、查護理之家聘用照顧人力，係依據護理機構分類設置標準規定之人床比，機構應依規定及實際照護需求聘用人員。至機構內各類照護人力薪資均由機構負責人依其管理制度敘薪。現行多數護理機構對專職人力大都採月薪方式敘薪。
- 三、來函所提居家照顧服務員時薪計算發放，其為「我國長期照顧十年計畫」中對於居家服務之照顧服務費之補助基準，故前項係屬「補助」之費用，非指聘用照顧服務員之時薪。

104.12.28 衛部照字第 1041562776 號

主旨：所詢有關為提升本國照顧服務員就業機會，能否放寬公立護理之家禁止聘僱外籍看護工規定疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局104年12月16日東衛長字第1040029997號函。
- 二、按外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準第3條及第20條規定，外國人受聘僱於護理之家機構，從事該法第46條第1項第8款及第9款規定之工作，其工作內容包括機構看護工作。另，同法第21條規定，外籍看護工受聘僱於護理之家之人數，則依護理之家登記之床位數計，每5床聘僱1人，且不得超過本國看護工之人數。
- 三、爰此，依上開規定，公立或私立護理之家聘用外籍看護工均可適用。建請貴局再次釐清建議事項之意旨。
- 四、檢附說明二之「外國人從事就業服務法第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」第3條、第20條及第21條規定供參。

照顧服務員訓練實施計畫

107年5月9日衛部顧字第1071960347號公告

- 一、為因應我國長期照顧人力需求，提升照顧服務品質，促進居家服務員、病患服務人員就業市場相互流通，增加就業機會，並整合居家服務員、病患服務人員訓練課程為照顧服務員訓練課程，特訂定本計畫。
- 二、本計畫之主管機關，在中央為衛生福利部，在地方為直轄市、縣(市)政府。
- 三、服務對象：日常生活活動功能或維持獨立自主生活能力不足，需他人協助者。
- 四、服務項目：
 - (一) 家務及日常生活照顧服務。
 - (二) 身體照顧服務。
 - (三) 服務範疇不得涉及醫療及護理行為，但在護理人員指導下，得協助執行技術性之照護工作(指臨床實習所列項目三內容)。
- 五、實施要項：
 - (一) 受訓對象：年滿十六歲以上、身體健康狀況良好，具擔任照顧服務工作熱忱者。
 - (二) 訓練單位：
 1. 接受直轄市、縣(市)政府補助或委託辦理本計畫者，或符合下列資格之單位且具合格實習訓練場所，或與合格實習訓練場所定有合作計畫者，得擬具計畫，以核心課程訓練地之所在為準，送當地直轄市、縣(市)政府審查核定：
 - (1) 依法設立之公益、醫療、護理社團法人，財團法人及公益、醫療、護理人民團體，或設有醫學、護理學、社會工作、老人照顧或長期照顧相關科系所之大專院校。
 - (2) 經衛生福利部或直轄市、縣(市)政府評鑑合格之醫療機構、護理機構、老人福利、身心障礙福利機構。

(3)依長期照顧服務法相關規定設立且經評鑑合格之長期照顧服務機構。

(4)依工會法設立且與照顧服務相關之工會。

2.第三款實習訓練場所得接受直轄市、縣(市)政府補助或委託辦理，或擬具計畫送所在地之直轄市、縣(市)政府審查核定後辦理本計畫，但訓練課程內容以臨床實習課程、實作課程及綜合討論與課程評量為限。

(三)實習訓練場所：經直轄市、縣(市)政府評估適合辦理且能容納訓練對象完成足夠個案臨床實習課程之下列單位之一者，實習訓練場所得視需要請實習人員提出健康檢查證明文件：

1.經直轄市、縣(市)政府督導考核成績優良之醫院。

2.經衛生福利部評鑑合格或直轄市、縣(市)政府督導考核成績優良之護理機構。

3.經衛生福利部或直轄市、縣(市)政府評鑑合格之老人長期照顧機構、身心障礙住宿機構、居家服務提供單位、日間照顧服務提供單位。

4.依長期照顧服務法相關規定設立且經評鑑合格之長期照顧服務機構。

5.原住民族及離島地區提供長期照顧相關服務之衛生所。

(四)收費標準：訓練收費標準由直轄市、縣(市)政府核定之。

(五)師資條件：

1.與授課主題相關之大專院校醫學、護理學、復健醫學、營養學、法律、社會工作、老人照顧或長期照顧相關科系所講師以上資格者。

2.與授課主題相關之大專以上畢業，且具實務工作經驗三年以上者。

3.與授課主題相關之實務經驗五年以上者(限臨床實習課程、實作課程)。

(六)成績考核：

1.受訓對象，除核心課程採線上訓練者外，參加核心課程

之出席率應達百分之八十以上，並完成所有臨床實習課程、實作課程及綜合討論與課程評量者，始可參加成績考核。

2. 核心課程採線上訓練者，應於線上完成全數課後測驗，並提供最近六個月內之線上學習證明予實習訓練場所，始可參加臨床實習課程；嗣完成所有臨床實習課程、實作課程及綜合討論與課程評量者，始可參加成績考核。

(七) 結業證明：

1. 訓練期滿後，訓練單位應將結訓人員名冊、出席情形及考核成績等相關資料，以核心課程訓練地之所在為準，送當地直轄市、縣(市)政府備查。但核心課程採線上訓練者，以實習訓練場所之所在為準，送當地直轄市、縣(市)政府備查。
2. 經考評及格者，由訓練單位核發結業證明書；訓練單位並應將所在地直轄市、縣(市)政府同意備查之日期、文號載明於結業證明書內，以利查核。
3. 結業證明書格式範例：如附件一。但核心課程採線上訓練者，如附件二。

(八) 照顧服務員依規定參加訓練並取得結業證明書者，不同直轄市、縣(市)政府應予以相互採認。

六、訓練課程內容與時數：

(一) 訓練課程：如附件三。

(二) 訓練時數：

1. 核心課程：五十小時。
2. 實作課程：八小時。
3. 綜合討論與課程評量：二小時。
4. 臨床實習課程：三十小時。
5. 直轄市、縣(市)政府得依其業務需要增列照顧服務員分科訓練課程內容與時數。但線上訓練之核心課程內容與時數，以衛生福利部辦理者為限。

附件一

結業證明書（格式範例）

（直轄市、縣市政府同意備查之日期、文號）

（姓名）（性別）（身分證字號）

民國〇〇〇年〇〇月〇〇日生

自〇〇〇年〇〇月〇〇日起

至〇〇〇年〇〇月〇〇日止參加（訓練單位）辦理之照顧服務員訓練，課程（含核心課程、臨床實習課程、實作課程、綜合討論與課程評量）共計〇〇〇小時，訓練結業。

特此證明

〇〇〇縣（市）長 〇〇〇
或〇〇〇縣（市）局（處）長
（如係委託辦理者，請受託單位一併用印）

中 華 民 國 〇〇〇年〇〇月〇〇日

（備註：本證明書格線長二十公分，寬十四公分；背頁應載明訓練課程、時數）

附件二

結業證明書（格式範例）

（直轄市、縣市政府同意備查之日期、文號）

（姓名）（性別）（身分證字號）

民國〇〇〇年〇〇月〇〇日生

〇〇〇年〇〇月〇〇日完成核心課程之線上訓練
（線上訓練學習證明流水號）

自〇〇〇年〇〇月〇〇日起

至〇〇〇年〇〇月〇〇日止參加（實習訓練場所）辦理之照顧服務
員訓練，課程（含臨床實習課程、實作課程、綜合討論與課程評
量）共計〇〇〇小時，訓練結業。

特此證明

〇〇〇縣（市）長 〇〇〇
或〇〇〇縣（市）局（處）長
（如係委託辦理者，請受託單位一併用印）

中 華 民 國 〇〇〇年〇〇月〇〇日

（備註：本證明書格線長二十公分，寬十四公分；背頁應載明訓
練課程、時數）

附件三

照顧服務員訓練課程表

壹、核心課程—五十小時

課程單元	時數	課程內容	參考學習目標
長期照顧服務願景與相關法律基本認識	二	一、照顧相關政策發展趨勢。 二、與服務對象相關之照顧服務法規。 三、涉及照顧服務員工作職責之相關法規。	一、了解長期照顧相關政策與未來願景。 二、認識長期照顧服務法、老人福利法、身心障礙者權益保障法、護理人員法等。 三、瞭解照顧服務相關民法、刑法、消費者保護法等概要。
照顧服務員功能角色與服務內涵	二	一、照顧服務員的角色及功能。 二、照顧服務員的工作對象及服務內容。 三、服務理念及工作倫理守則。 四、照顧服務員證照與職涯發展。	一、認識照顧服務員的工作場所及工作對象。 二、說出照顧服務員的業務範圍、角色功能與應具備的條件。 三、認識照顧服務員的工作倫理及工作守則。 四、瞭解照顧服務員證照與職涯發展。
照顧服務資源與團隊協同合作	二	一、照顧服務領域相關資源的內容。 二、服務對象及資格限制。 三、介紹跨專業團隊的各領域內涵及實務。 四、簡述跨專業協同合作的概念與策略。	一、認識社政、衛政(含精神照顧資源)、勞政、農政、原住民族行政體系現有照顧服務資源。 二、瞭解如何轉介與供給相關照顧服務資源。 三、瞭解各專業領域服務內涵及實務。

		五、簡述跨專業溝通的重要性及技術。 六、以案例解說實務運作情形。	四、瞭解跨專業協同合作模式概念。 五、瞭解在工作中扮演的角色與團隊間之溝通技巧。 六、透過實例說明瞭解實務運作。
認識身心障礙者之需求與服務技巧	四	一、介紹各類障礙者之特質與服務需求。 二、正向與支持的服務態度。 三、正向行為支持。 四、與各類障礙者日常溝通互動之重要性與內涵。 五、建立良好關係的溝通互動技巧。 六、運用輔助溝通系統促進有效溝通。 七、行為危機處理原則與基本流程。 八、案例分享。	一、認識各類障礙者（包括視覺障礙、智能障礙、聽覺障礙及肢體障礙等）之特質與服務需求。 二、學習正向行為觀察與紀錄、瞭解行為策略。 三、瞭解與各類障礙者溝通互動之重要性及如何與之溝通。 四、瞭解行為危機處理原則與基本流程。
認識失智症與溝通技巧	二	一、認識失智症（定義、病因、症狀、病程、診斷與治療）。 二、失智症者日常生活照顧目標、原則與應有之態度。 三、失智症者日常生活照顧內容及技巧。 四、與失智症者之互	一、理解失智症的醫學層面、心理及行為。 二、瞭解失智症者的日常生活照顧原則。 三、瞭解與失智症者的溝通技巧。 四、瞭解如何促進失智症者參與生活與活動安排之原則。

		動與溝通技巧。 五、促進失智症者參與生活與活動安排之原則。 六、案例分享。	
認識家庭照顧者與服務技巧	二	一、照顧者的角色與定位。 二、家庭照顧者的壓力與負荷(包括使用居家、社區及機構服務之照顧者)。 三、照顧者的調適方式。 四、與家屬溝通的技巧與態度。 五、建立與家屬共同照顧模式。 六、案例分享。	一、瞭解照顧者的角色與定位。 二、瞭解家庭照顧者的壓力來源與負荷。 三、說明服務對象及其家庭照顧者的調適方法。 四、瞭解與家屬溝通的技巧與態度。 五、瞭解如何與家屬共同照顧。
原住民族文化安全導論	三	一、介紹當代原住民所面臨之社會及健康不均等現象。 二、介紹文化敏感度之定義及於照顧情境中之重要性。 三、介紹原住民族照顧過程之文化安全概念與因素如文化、語言、信仰、禁忌及飲食等。 四、介紹文化適切性之照顧模式、倫理困	一、瞭解文化敏感度之定義與重要性。 二、瞭解原住民照顧過程文化安全的重要性。 三、瞭解文化適切性照顧模式與運用。 四、設計文化合適性之照顧方案。

		境與議題。 五、系統性介紹文化照顧知識、態度及技能，並融入於個案照顧情境中。	
心理健康 與壓力調適	二	一、服務對象的心理特質與需求。 二、憂鬱症的認識。 三、自殺的徵兆與預防。 四、照顧服務員壓力自我察覺與調適。	一、瞭解服務對象心理發展歷程之變化與調適。 二、學習如何促進服務對象心理健康。 三、認識憂鬱、憂鬱症及瞭解如何與憂鬱症個案溝通。 四、學習自殺防治的知能與實務技巧。 五、照顧服務員學習自我察覺與調適照顧壓力。
人際關係 與溝通技巧	一	一、溝通的重要性。 二、如何增進溝通能力。 三、建立與被照顧者良好的溝通技巧。 四、案例分享。	一、瞭解溝通的重要性、目的、及要素。 二、瞭解阻礙與促進溝通的因素。 三、說明增進溝通能力的方法。 四、說出特殊溝通情境的處理（含重聽、視力不佳）。 五、瞭解老人常見問題與溝通技巧。
身體結構 與功能	二	認識身體各器官名稱與功能	一、列舉人體細胞、組織和器官的相關性。 二、認識人體各系統的構造。

			三、說明人體各系統的功能。
基本生命徵象	二	一、生命徵象測量的意義及其重要性。 二、體溫、脈搏、呼吸、血壓、血糖的認識、測量與記錄。	一、瞭解體溫、脈搏、呼吸、血壓與血糖意義。瞭解影響體溫之各種因素。 二、認識測量體溫的工具。 三、瞭解影響脈搏的各種因素。 四、說明可測得脈搏的部位及正確測量脈搏。 五、瞭解影響血壓的因素及辨別異常的血壓數值。 六、認識測量血壓的工具。 七、學習正確測量體溫、脈搏、呼吸與血壓。 八、說明預防姿位性低血壓的方法。 九、瞭解影響血糖的因素及辨別異常的血糖數值。 十、認識測量血糖工具。 十一、學習正確測量血糖。
基本生理需求	二	一、知覺之需要。 二、活動之需要。 三、休息與睡眠之需要。 四、身體清潔與舒適	一、瞭解知覺的重要性及意識評估的方法。 二、認識知覺相關的問題照顧措施。 三、說明休息與睡眠的

		之需要。 五、泌尿道排泄之需要。 六、腸道排泄之需要。 七、呼吸之需要。 八、協助如何進食(含鼻胃管及胃造口)。	重要性。 四、瞭解睡眠的週期。 五、瞭解影響睡眠的因素。 六、描述促進睡眠的照顧措施。 七、認識身體清潔的目的對個人健康的重要性。 八、瞭解身體清潔照顧的種類與方法。 九、認識排便的生理機轉及影響排便的因素。 十、認識排尿的生理機轉及影響排尿的因素。 十一、瞭解排尿與排便常見的問題。 十二、認識呼吸的生理機轉及影響呼吸的因素。 十三、瞭解呼吸功能障礙的因素、症狀及徵象。 十四、說明維持呼吸道通暢的照顧方法。 十五、清楚灌食的定義、種類及注意事項，並能正確執行。
疾病徵兆之認識及老人常見疾病之照顧事項	二	一、身體正常與異常徵象的觀察與記錄： (1)一般外表、顏臉。 (2)排泄。 (3)輸出入量的記錄。 (4)發燒。	一、辨別一般外表、顏臉、鼻喉、口腔、聲音、皮膚、食慾、睡眠等所呈現的疾病徵兆。 二、透過觀察與服務對象的主觀陳述可辨別疾

		(5)冷熱效應之應用。 (6)出血。 (7)疼痛。 (8)感染之預防。 二、老人常見的慢性疾病與徵兆。 三、常見疾病之生活照顧注意事項。	病的徵兆。 三、瞭解排便常見的問題及簡易照顧措施。 四、描述噁心與嘔吐之相關簡易照顧措施。 五、認識收集尿液標本需遵循的原則。 六、分辨泌尿道感染的臨床表徵。 七、描述泌尿道感染的簡易照顧措施。 八、描述輸入輸出的途徑及輸出入量記錄的內容。 九、認識記錄輸出入量所需的用具。 十、瞭解輸出入量記錄的注意事項。 十一、說出發燒的可能原因。 十二、列出發燒的處理方法。 十三、說出一般外傷的處理種類及處理原則。 十四、說出疼痛及其簡易處理措施。 十五、指出腹痛的簡易處理方式。 十六、列舉疼痛的觀察與記錄方式。 十七、描述胸痛的簡易
--	--	--	--

			處理方法。 十八、瞭解牙痛的處置原則。 十九、說出肌肉酸痛的處理原則。 二十、認識冷熱應用的基本原則，並正確運用於病人。 二十一、指出感染源。 二十二、瞭解造成感染的相關因素。 二十三、描述易造成感染疾病的危險情況。 二十四、列舉感染的傳播途徑。 二十五、執行正確的洗手步驟。 二十六、認識無菌原則與常見的無菌技術。 二十七、瞭解老人常見的疾病。 二十八、學習提供罹患疾病之生活支援與技巧。
急症處理	二	一、肌肉骨骼系統意外之處理。 二、出血意外之處理。 三、癲癇的處理。	一、說明肌肉、關節、骨骼損傷的種類。 二、舉例說明肌肉、關節損傷的處理。 三、說明骨折的急救處理。 四、認識出血的徵兆。 五、學習各種止血方法。

			六、學習癲癇的緊急處理方法。
急救概念	二	一、異物哽塞的處理。 二、心肺復甦術。 三、認識自動體外心臟電擊去顫器(AED)。	一、說明急救的定義、目的和原則。 二、說明急救的優先次序與注意事項。 三、瞭解異物哽塞的原因及危險性。 四、瞭解異物哽塞的處理方法與注意事項。 五、學習正確執行異物哽塞的急救措施。 六、瞭解心肺復甦術的方法與注意事項。 七、學習正確執行心肺復甦術的操作步驟。 八、學習正確執行自動體外心臟電擊去顫器(AED)。
居家用藥安全	一	正確依照藥袋指示協助置入藥盒。	一、瞭解藥物儲存安全。 二、認識藥袋說明。 三、學習正確協助服藥。 四、其他用藥安全相關課程。
意外災害的緊急處理	一	一、災難(火災、水災、地震)緊急處理及人員疏散。 二、認識環境安全的重要性與潛藏的危機。 三、用電的相關基本常識或延長線的使用概	一、認識意外災害的定義。 二、列舉火災的危害與預防方法。 三、認識燃燒必備的三個要素、滅火原理與滅火器的使用。

		念。	四、學會火災、水災、地震緊急逃生要領。 五、說明意外災害時個案的情緒反應。 六、學習如何預防與處理日常生活環境中常見的意外事件。 七、學習用電的相關基本常識或延長線的使用。
臨終關懷及認識安寧照顧	二	一、臨終關懷的精神與內容。 二、照顧瀕死服務對象的壓力與調適。 三、安寧照護的發展。 四、服務對象及其家屬面對往生心理調適的過程。 五、服務對象往生警政及衛政之通報。	一、明白安寧照護的起源。 二、列舉安寧照顧的照顧重點。 三、說明臨終關懷的特殊議題。 四、瞭解面對死亡時服務對象及家屬的反應。 五、說明協助服務對象及家屬面對死亡的技巧。 六、說明遺體照顧的注意事項。 七、說明照顧瀕死服務對象的壓力。 八、描述照顧瀕死服務對象的調適方式。 九、服務對象往生警政及衛政的通報流程。
清潔與舒適協助技巧	六	失能老人及身心障礙者個人衛生與照顧： (一)洗頭(包含床上)。 (二)沐浴(包含床上)。	一、認識床鋪整潔維護的目的及鋪床原則。 二、學習適當維護床鋪的整齊清潔。

		(三)口腔清潔。 (四)更衣。 (五)鋪床與更換床。 (六)剪指甲。 (七)會陰沖洗。 (八)使用便盆(包含床上)。 (九)背部清潔與疼痛舒緩。 (十)修整儀容。 (十一)疼痛舒緩。 (十二)甘油灌腸。	三、認識毛髮清潔的目的、原則及注意事項。 四、學習適當維護服務對象毛髮的整齊清潔。 五、學習正確協助服務對象洗髮。 六、瞭解口腔清潔的重要性及目的。 七、正確提供服務對象口腔清潔衛教及協助正確執行口腔清潔。 八、認識背部清潔照顧的重要性，並正確提供背部照顧措施促進服務對象的舒適。 九、學會正確協助服務對象沐浴(含床上)。 十、學會正確協助服務對象更換衣服。 十一、瞭解指(趾)甲護理原則及注意事項，並正確協助服務對象修剪指(趾)甲。
營養膳食與備餐原則	二	一、營養素的功能與食物來源。 二、認識服務對象的營養需求。 三、各種特殊飲食的認識。 四、疾病飲食注意事項。	一、瞭解影響食物攝取和營養狀態的因素。 二、認識國民飲食之指標。 三、熟知營養素的功能及其主要的食物來源。 四、瞭解服務對象的生理變化及其營養需求。

		五、備餐的衛生。 六、吞嚥困難飲食（細泥、細軟食等）及自製灌食的設計與製備。	五、認識特殊飲食的種類、目的、適用對象及一般原則。 六、瞭解常見疾病飲食的種類、目的及適用對象。 七、認識服務對象常見之生理問題如：便秘、腹瀉、脫水、壓瘡等及慢性疾病如：糖尿病、慢性腎臟病等之飲食策略。 八、正確協助服務對象進食。 九、認識備餐衛生。
家務處理協助技巧	二	一、家務處理的功能及目標。 二、家務處理的基本原則。 三、家務處理工作內容及準則。	一、認識協助案主處理家務的工作內容及範圍。 二、瞭解協助案主處理家務的基本原則。
活動與運動及輔具協助	四	一、運動與活動的定義與重要性。 二、移位與擺位的注意事項。 三、簡易被動肢體關節活動。 四、自主性運動的協助。 五、壓傷（壓瘡）的定義、好發部位及發生的原因。 六、如何預防壓傷（壓	一、說明活動與運動的重要性與種類。 二、學習移位與擺位時的注意事項。 三、瞭解各種輔具的使用方法。 四、說明被動運動的項目。 五、說明主動運動的項目。 六、認識壓傷（壓瘡）、好發部位及原因。

		瘡)。 七、介紹長照設施中常舉辦之活動類型。 八、介紹生活輔具的功能、用途與使用，包括食、衣、住、行及工作者如何輕鬆使用輔具。 九、如何鼓勵自我照顧。 十、生活輔具 DIY。 十一、居家安全看視原則。 十二、居家安全環境塑造。 十三、安全照護技巧。	七、學習壓傷(壓瘡)的預防方法。 八、認識長照設施常舉辦之活動類型。 九、瞭解生活輔具的功能與使用方法。 十、瞭解如何透過生活輔導提昇受照顧者自主能力。 十一、善用現成生活物品發揮輔具的功能。 十二、了解居家安全看視的重要性。 十三、學習居家安全看視及居家安全環境塑造。 十四、學習運用安全照護技巧。
--	--	--	--

貳、實作課程—八小時

課程單元	時數	課 程 內 容
基本生命徵象	一	體溫、脈搏、呼吸、血壓、血糖的認識、測量與記錄。
急救概念	二	一、異物哽塞的處理。 二、心肺復甦術。 三、自動體外心臟電擊去顫器(AED)。
清潔與舒適協助技巧	二	失能老人及身心障礙者個人衛生與照顧： (一)洗頭(包含床上)。 (二)沐浴(包含床上)。 (三)口腔清潔。 (四)更衣。 (五)鋪床與更換床單。

		(六)剪指甲。 (七)會陰沖洗。 (八)使用便盆(包含床上)。 (九)背部清潔與疼痛舒緩。 (十)修整儀容。 (十一)疼痛舒緩。 (十二)甘油灌腸。
營養膳食與備餐原則	一	一、備餐的衛生。 二、吞嚥困難飲食(細泥、細軟食等)及自製灌食的設計與製備。
活動與運動及輔具協助	二	一、移位與擺位的注意事項。 二、簡易被動肢體關節活動。 三、自主性運動的協助。 四、如何預防壓傷(壓瘡)。 五、介紹生活輔具的使用，包括食、衣、住、行及工作者如何輕鬆使用輔具。 六、生活輔具DIY。 七、安全照護技巧。

參、綜合討論與課程評量—二小時

課程單元	課程內容	參考學習目標
綜合討論與課程評量	針對上述課程內容做一整體評值。	一、分享照顧服務員訓練課程的心得。 二、提出照顧服務員訓練課程的相關疑慮。 三、通過針對課程內容整體評估的測試。

肆、臨床實習—三十小時

項目	一、基礎身體照顧類 (一)協助沐浴床上洗頭洗澡 (二)協助洗澡椅洗頭洗澡 (三)協助更衣穿衣
----	---

	(四)口腔照顧(包括刷牙、假牙清潔) (五)清潔大小便 (六)協助用便盆、尿壺 (七)會陰沖洗 (八)正確的餵食方法 (九)翻身及拍背 (十)基本關節活動 (十一)修指甲、趾甲 (十二)刮鬍子、洗臉、整理儀容 二、生活支持照顧類 (一)鋪床及更換床單 (二)垃圾分類廢物處理 三、技術性照護 (一)尿管照護 (二)尿套使用 (三)鼻胃管灌食 (四)鼻胃管照護 (五)胃造口照護 (六)熱敷及冰寶使用 (七)異物哽塞的處理 (八)協助口腔內(懸壅垂之前)或人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸或移除及氧氣使用 四、安全保護照顧類 (一)協助輪椅患者上下床 (二)安全照顧 五、預防性照顧類 (一)測量體溫、呼吸、心跳、血壓 (二)感染控制及隔離措施 六、活動帶領技術類 (一)方案活動帶領
--	---

105.12.5 衛部照字第 1050134319 號

主旨：有關貴局所詢產後護理機構工作人員照顧比例是否符合法規疑義案，復請查照。

說明：

一、復貴局 105 年 11 月 10 日中市衛醫字第 1050112572 號函。

二、依本部 103 年 7 月 25 日衛部照字第 1031561246 號函示略以，按「護理機構分類設置標準」第八條附表規定，產後護理機構每 15 床(含嬰兒床)至少應有護理人員 1 人，且 24 小時均應有護理人員值班，嬰兒照顧人員每 5 床應設置 1 人；附表備註第三項「高於設置標準聘用之護理人員人數可採計為應聘嬰兒照顧人員數」，係指該機構高於設置標準聘用之護理人員人數，得列入設置標準嬰兒照顧人員應採計之人員數。

三、按護理機構分類設置標準係護理機構得以設立之最低要求，爰護理機構應至少聘足人員數需符床人比之標準，且需在人員派班可符 24 小時均應有護理人員值班之規定，惟其三班輪值人力分配，係為機構內部管理事項，人員派班之工時及休息休假等均應符勞動基準法之規定，且機構須視各班別之工作內容增加適當人力，依其規模及業務需要逕行調配。

〔釋例類別〕 第 3 類 硬體空間

84.11.16. 衛署醫字第 84067519 號函

主旨：有關蔡○○女士詢問護理之家機構應如何設置物理治療室及職能治療室，請查照轉知。

說明：

一、復 貴局 84 年 10 月 28 日 84 衛五字第 26972 號函。

二、依護理機構設置標準規定，護理之家機構得視需要設置物

理治療室、職能治療室，惟對於其設置空間及基本設備並未明文。本案護理之家機構設置物理治療室及職能治療室，其基本設備得參考「慢性醫院設置標準」規定，自行視需要斟酌辦理。

(註：本函釋當事人之名字以○○表示)

85.12.27. 衛署醫字第 85070702 號函

主旨：有關省立雲林醫院擬將該院現有醫療大樓 2 樓病房規劃為護理之家，是否符合護理機構設置標準總樓地板面積平均每床應有 20 平方公尺以上之規定一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴處 85 年 12 月 16 日衛五字第 850091665 號函。
- 二、醫療機構附設產後護理之家服務部門，其與急性病房及慢性病房之病房區，應獨立設置。至於其樓地板面積除該獨立部門之樓地板面積外，其分攤之公共使用樓地板面積，應併入核計。
- 三、本案省立雲林醫院將該院現有醫療大樓 2 樓病房規劃為 20 床之護理之家，該獨立區域(原 2 樓病房)面積 378.88 平方公尺，及該區域分攤 2 樓之公共使用樓地板面積 271.3 平方公尺，合計為 650.18 平方公尺，核已符合護理機構設置標準之規定。

87.2.12. 衛署醫字第 87004043 號函

主旨：雲林縣衛生局函詢所屬省立雲林醫院附設護理之家服務部門申請開業，是否符合護理機構設置標準乙案，復請 查照。

說明：

- 一、依據雲林縣衛生局 87 年 1 月 23 日雲衛五字第 1335 號函辦理。
- 二、台灣省立雲林醫院附設護理之家服務部門病房門寬 1 公尺，核已符合護理機構設置標準規定，至其病床寬度大於 1

公尺無法推出病房乙節，可改以推床、擔架或輪椅搬運病人。另其公共浴室未設置扶手，應請雲林縣衛生局責成該院改善。

- 三、又護理機構設置標準並未規定護理機構必須設置公共電話及太平間。

89.2.16. 衛署醫字第 88078055 號函

主旨：有關護理之家其病房走道之淨寬，應依建築法相關規定或依護理機構設置標準表規定審查乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 88 年 12 月 22 日南市衛五字第 22752 號函。
- 二、依護理機構設置標準規定：護理之家，其一般設施應符合建築法及其有關規定，至於病房走道淨寬，基於考量推床使用之需要，特別予以明定，應至少有 1.4 公尺。爰此，護理之家病房走道之淨寬應依該標準之特別規定辦理。
- 三、至於該規定一體適用於新建及既有建築物是否合理乙節，已錄案，擬併本署刻正研議中之護理機構設置標準修正案中研議。

89.5.18. 衛署醫字第 89011744 號函

主旨：醫院其嬰兒室、調奶室設置現狀若與產後護理機構設置標準規定相符，則院方與其附設產後護理之家共用嬰兒室、調奶室，尚無不可，請 查照。

說明：復 貴局 89 年 2 月 29 日 89 衛保字第 04850 號函。

（註：本函釋業經本署 102.8.8. 衛署照字第 1021580188 號函補充解釋：新設置或擴充（102.8.8. 之後）之產後護理機構並不宜與醫療機構共用嬰兒室、調奶室及相關設備，請參閱 P.434）

89.10.4. 衛署醫字第 0890017043 號函

主旨：所詢貴轄民雄鄉成功醫院申請附設護理之家，其設於該院三樓，而日常活動場所含文康活動室及會議室則分開設於

不同棟之一樓，是否能同意設立乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 9 月 20 日 89 衛五字第 8914770 號函。
- 二、按護理機構設置標準表規定：護理之家病床，其日常活動場所，按病床數計，平均每床應有 4 平方公以上。
- 三、申請護理之家地點與日常活動場所位於不同棟之建築物，若該日常活動場所能為護理之家病患方便利用，則計列入日常活動場所面積，尚無不可。

89.11.16. 衛署醫字第 0890026172 號函

主旨：有關貴轄康福護理之家及覺民護理之家擬設於同一棟大廈之不同樓層，並共用出入口及電梯乙案，應可同意，復請查照。

說明：復 貴署 89 年 10 月 30 日 89 衛署醫字第 31703 號函。

90.3.5. 衛署醫字第 0900001195 號函

主旨：貴機構申請護理之家開業，有關衛浴設備之門寬，仍應依現行護理機構設置標準規定辦理，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴家 90 年 1 月 5 日深字第 0118 號函。
- 二、至於護理機構設置標準，護理之家機構其病房、病室及衛浴設備，至少應各有 1 扇門，且寬度至少為 0.8 公尺之規定，是否酌予放寬，本署已錄案，俟修正該標準時，納入參考。

(註：本函釋業經本署 97.11.28. 衛署照字第 0972802859 號函補充解釋，該門寬係指「淨寬」，請參閱 P. 430)

93.6.8. 衛署醫字第 0930211113 號書函

主旨：所詢護理機構可從事哪些相關業務等乙案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴護理之家 93 年 5 月 19 日 93 年永護(愛)字第 028 號函。
- 二、查依護理機構設置標準規定，護理之家機構得視需要設置物理治療室、職能治療室，不需獨立申請。
- 三、藥師依前開設置標準規定，不得執業於護理機構。
- 四、護理之家之醫療診療部分，得由醫院之醫師依規定報備支援。

94.8.9. 衛署醫字第 0940028242 號函

主旨：所詢貴轄劉嘉修醫院(為醫療法公布前已開設之醫療機構)申請附設護理之家樓層建築用途為住家，其建築物之設計、構造與設備(包括空調設備、消防設備、安全設備、一般設施等)之認定為何一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 94 年 6 月 27 日衛局醫字第 09400179460 號函。
- 二、按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定；至其建築物之空調設備、消防設備、安全設備及一般設施等，應符合建築法及其有關法規規定，依建築及消防之規定辦理。

95.11.30. 衛署照字第 0952802161 號函

主旨：有關 台端詢問護理機構設置標準之病房與病室定義及設衛浴設備疑義一案，請 查照。

說明：

- 一、依據 台端 95 年 11 月 15 日電子郵件辦理。
- 二、查「護理機構設置標準表」之設置標準項目二、護理服務設施(一)病房：…2. 應設病室並符合下列規定：……(6) 每一病室以八床為限。爰此，依前所示，病房係護理機構服務設施之一，病房為包含數個病室之單位，病室係指設有病床之房間。至設衛浴設備，請依護理機構設置標準表之二、護理服務設施(五)衛浴設備項下規定設置。

95.12.22.衛署照字第 0950060538 號函

主旨：護理之家機構總樓地板面積是否包含日常活動場所、戶外庭園、頂樓、樓梯、護理站、會談室、職能治療室面積等疑義一案，請 查照。

說明：

- 一、按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合建築法及其有關法規之規定。至建築物之總樓地板面積之計算，應依地政及建築類相關法律規定，依建築物使用權狀區間所載，合法登記及權利範圍為限。
- 二、查護理機構總樓地板面積，一般護理之家平均每床應有 16 平方公尺以上(不包括車庫及宿舍面積)，精神護理之家平均每床應有 20 平方公尺以上(不包括車庫及宿舍面積)，而該總樓地板面積包含日常活動場所空間；又日常活動場所，係指住民餐廳、交誼活動休閒所需之空間而言。

96.1.17.衛署照字第 0962800130 號函

主旨：貴局函詢所轄「悠之家產後護理之家」因原申設之配膳室空間不足，擅自將部分配膳設備設置於陽台處等一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 8 月 24 日北衛醫字第 0950068782 號函。
- 二、按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合建築法及其有關法規之規定；至建築物之空調設備、消防設備、安全設備及一般設備等，應符合建築法及其有關法規規定，依建築及消防之規定辦理。
- 三、是以，本案護理機構因原配膳室空間不足，擅自將部分配膳設備設置於陽台，其變更空間使用用途一節，涉及消防、建築法相關規定，係屬消防、建築主管機關權責。

96.10.29.衛署醫字第 0960049243 號函

主旨：有關護理機構設置於不連續樓層及病室隔間疑義一案，復

請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 96 年 10 月 22 日北衛醫字第 0960093626 號函。
- 二、按護理機構之設立，應依護理人員法之規定申請許可，並符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許開業。查本署 88 年 8 月 16 日衛署醫字第 88044734 號函釋略以：「……三、本署花蓮醫院擬於不同棟大樓之三、四、五樓擴充設置護理之家，如符護理機構設置標準規定，應無不可。」是以，本案所述擬於同棟電梯大樓之 3 樓及 5 樓申請設置護理之家，而該同址 4 樓為安養護機構，如其申請執業場所使用空間及公共場所與安養護機構明顯區隔，並各有獨立動線，且符合護理機構設置標準之相關規定，得予准許。本案請依此原則辦理。
- 三、至護理機構病房內之病室隔間高度，是否應與天花板密接等情一節，按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合護理機構設置標準之規定；至其建築物之空調設備、消防設備、安全設備及一般設備等，則應符合建築法及消防法等有關規定。

（註：本函釋說明二所敘本署 88.8.16. 衛署醫字第 88044734 號函，請參閱 P.191）

97.3.5. 衛署醫字第 0970006126 號函

主旨：有關護理機構設置疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 1 月 31 日苗衛醫字第 0970300221 號函。
- 二、所詢護理機構依傳染病防治法規定所設之隔離病房之病床數，是否涵蓋於核發機構之開業床數內一節，查護理機構服務對象係為罹患慢性病、病情穩定，需長期護理之病人或產後需護理之產婦及嬰幼兒，是以，以急性醫療需求為目的設置之隔離病房(床)，並不適用於護理機構。至護理機構依「人口密集機構傳染病防治及監視作業注意事項」

等規定，為早期偵測機構內發生傳染病群聚事件，應由所核定之開業床數中，選擇若干具有獨立衛浴設備之住房，以供篩檢並予及時妥適隔離使用。

- 三、關於同一護理機構跨數樓層，各樓層是否均需設置護理站及配置護理人員一節，按護理機構之護理站設置，係為相關醫療器材、藥品及病歷存放管理空間，方便護理人員從事護理業務及提供住民、民眾諮詢服務之處。查護理機構設置標準表之二、護理服務設施(一)病房項下規定設置護理站，及相關設施與設備。另查，本案所稱各樓層是否均需設置護理站之病室設置情形未明，惟依前揭原則，跨數樓層之護理機構，如相鄰樓層共用護理站，在不影響護理業務執行及能為護理機構住民及民眾方便利用下，尚無不可。是以，本案請依權責，視個案事實認定。至護理機構24小時均應有護理人員值班，惟其三班輪值人力分配，係為機構內部管理事項，由機構依其規模及業務需要逕行調配。

97.6.20.衛署照字第0970027400號函

主旨：有關貴機構詢問護理機構設置標準之病房與病室定義疑義一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴機構97年6月4日安親護字第97-0604號函。
- 二、查「護理機構設置標準表」之設置標準項目二、護理服務設施(一)病房：…2.應設病室並符合下列規定：…(6)每一病室以八床為限。爰此，依前所示，病房係護理機構服務設施之一，病房為包含數個病室之單位，病室係設有病床之房間。

97.11.28.衛署照字第0972802859號函

主旨：貴轄弘光科技大學附設老人醫院有關「醫院床數變更為護理之家，原醫院病室之衛浴設備門寬可否放寬標準」一案

，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 11 月 5 日衛醫字第 0970049023 號函。
- 二、查護理機構設置標準規定，護理之家，其一般設施應符合建築法及其有關規定，其中病房、病室及衛浴設備，至少應各有一扇門，且寬度至少為 0.8 公尺(80 公分)部分，核其立法意旨，主要係為考量護理機構收治之病患或住民多屬行動不便者，爰在顧及收治對象使用病床或輪椅出入時之方便性及安全性考量，所為合理門寬需要，特別予以明定。是以，護理機構設置之病房、病室及供住民衛浴使用設備之門寬(係指淨寬)應符合上開規定。
- 三、有關以現有醫院建築物變更設置為護理之家，其原醫院建築物之衛浴門寬不符規定，是否予以放寬一節，請參照內政部 97 年 4 月 10 日台內營字第 0970802190 號函發布「建築物無障礙設施設計規範」辦理。

97.12.23. 衛署照字第 0970091075 號函

主旨：有關護理人員法「護理之家」護理機構設置標準表內病房病室應有自然採光之窗戶認定標準一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 97 年 12 月 17 日高市衛保字第 0970050309 號函。
- 二、查護理機構設置標準規定，護理之家，其一般設施應符合建築法及其有關規定，其中病房、病室應有可資自然採光之窗戶及病室應通風光線充足，先予敘明。
- 三、考量護理機構收治之病患或住民多屬行動不便，更應重視病房、病室的環境安全與健康。爰此，病房、病室仍應符合有可資採光之窗戶及病室應通風光線充足之設置標準規定。

99.10.20. 衛署照字第 0992862869 號函

主旨：所詢護理機構設置標準表—日常活動場所之空間是否包含走道、樓梯等疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 99 年 10 月 14 日花衛醫字第 0990019160 號函。
- 二、按護理機構建築物之設計、構造與設備，應符合建築法及其有關規定。至建築物之總樓地板面積之計算，應依地政及建築類相關法律規定，依建築物使用權狀區間所載，合法登記及權利範圍為限。
- 三、查護理機構總樓地板面積，一般護理之家平均每床應有 16 平方公尺以上(不包括車庫及宿舍面積)，而該總樓地板面積包含日常活動場所空間；又日常活動場所，係指住民餐廳、交誼活動休閒所需之空間而言，爰此未含樓梯之空間。
- 四、另查內政部公告之建築物無障礙設施設計規範，走道應符合第二章無障礙通路，有關室內通路走廊其坡度、寬度、迴轉空間之規定，至可否為住民之日常活動場所，請依前揭規定認定。

100.10.11. 衛署照字第 1000022956 號函

主旨：所詢獨立型護理機構附設居家護理所辦公室樓地板面積可否列入該護理機構總樓地板面積，及室外活動空間可否納入日常活動場所空間疑義案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 100 年 9 月 29 日東衛醫字第 1000017152 號函。
- 二、獨立型護理機構附設居家護理所之辦公室，其用途應係供該居家護理所業務執行需要使用，爰此，於檢討獨立型護理機構總樓地板面積時，應不宜將所附設之居家護理所辦公室面積列入。
- 三、本署 99 年 10 月 20 日衛署照字第 0992862869 號函釋略以，建築物總樓地板面積之計算，應依地政及建築類相關法律規定，依建築物使用權狀所載，合法登記及權利範圍為

限；護理機構總樓地板面積包含日常活動場所空間。爰此，護理機構之日常活動場所面積之檢討，應以該機構建築物使用權狀合法登記權利範圍為限。

101.7.12.衛署照字第 1012863124 號函

主旨：所詢關於「護理機構分類設置標準」疑義案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 6 月 29 日苗衛醫字第 1010016155 號函。
- 二、所詢一般護理之家收住呼吸器依賴個案與一般住床是否明顯空間區隔一節，查 100 年 12 月 2 日發布修正之護理機構分類設置標準第 8 條附表(護理機構設置標準表)修正規定，一般護理之家病房設置標準 3、收住呼吸器依賴個案達四床以上者，其病房應符合下列規定：(1)應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床。
- 三、另若機構收住呼吸器依賴個案 30 床，一般住床 32 床，則該機構護理人力如下：
 - (一)查一般護理之家護理人員設置標準 1、15 床至少應有 1 人。設置標準 4、24 小時均應有護理人員值班。爰此，依上開規定，其一般護理之家 32 床之護理人力配置應設 3 人以上，24 小時均應有護理人員值班。
 - (二)再查一般護理之家護理人員設置標準 5、收住呼吸器依賴個案達 4 床以上者，其人員應符合下列規定：(1)每 10 床應有 1 人，不足 10 床以 10 床計。(2)至少有 1 位護理人員具備呼吸照護臨床經驗 2 年。(3)24 小時均應有護理人員上班，收住呼吸器依賴個案以 24 床為計算單位，每超過 24 床應再增加 1 人。爰此，所詢案例收住呼吸器依賴個案 30 床之護理人力配置，依上開規定應設有 4 人以上，且 24 小時均應有護理人員在班。
 - (三)綜上該機構之護理人力配置應設有 7 人以上，並應依

規定 24 小時有護理人員在班，收住呼吸器依賴個案床與一般住床應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床。其是否全面會勘，請貴局本權責處理。

101.11.27. 衛署照字第 1012864517 號函

主旨：有關貴局所詢護理之家設置標準呼吸器依賴個案病床疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 101 年 11 月 16 日衛醫字第 1010019739 號函。
- 二、本案所指之呼吸器依賴個案，係指護理人員法第 15 條所定護理機構之服務對象，且需裝置呼吸器以維生，無法脫離使用者。鑑於一般護理之家收住該等住民，需要更專業之照護及適當人力、設施及設備，故非以費用來源或使用呼吸器之天數為依據。
- 三、爰此，所詢一般護理之家收住呼吸器依賴個案病床界定之疑義乙節，護理之家收住個案若有呼吸器依賴者，均應依本署 100 年 12 月 2 日發布修正之護理機構分類設置標準第 8 條附表(護理機構設置標準表)規定，一般護理之家收住呼吸器依賴個案達四床以上者之病房設置標準，其病房應為獨立隔間或區域有明顯區隔，每一隔間區域不超過六床等規定辦理。

102.8.8. 衛部照字第 1021580188 號函

主旨：有關醫院或診所附設產後護理機構之嬰兒室及相關設備，是否可與該醫院或診所共用疑義，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 6 月 27 日高市衛健字第 10235829100 號函。
- 二、查本部 89 年 5 月 18 日衛署醫字第 89011744 號函：「醫院其嬰兒室、調奶室設置現狀若與產後護理機構設置標準

規定相符，則院方與其附設產後護理機構共用嬰兒室、調奶室，尚無不可。」其當時之時空背景，醫院及其附設產後護理機構係共用一張開業執照。

- 三、次查本部 90 年 5 月 10 日衛署醫字第 0900031774 號函：「醫療機構依護理機構設置標準規定附設護理機構，應另發給開業執照，重新核發開業執照。」另本部 98 年 4 月 10 日衛署照字第 0982800729 號函釋，略以「婦產科診所之嬰兒室、調奶室係依醫療機構設置標準設置，兩者分屬不同型態與主體……不宜共用嬰兒室及相關設備……」爰此，上開二個獨立機構，其嬰兒室設置標準並不相同。
- 四、又考量實際狀況，於本函釋發布前，產後護理機構與醫療機構共用嬰兒室、調奶室及相關設備，業經地方主管機關許可設立者，應輔導其儘速改善；本函釋發布後，新設置或擴充之產後護理機構並不宜與醫療機構共用嬰兒室、調奶室及相關設備。

102.8.12. 衛部照字第 1021580181 號函

主旨：所詢護理之家機構設置之設置標準項目二、護理服務設施(四)日常活動場所，相關計算標準其中走廊是否得併計於日常活動場所之面積乙案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 8 月 1 日新縣衛醫字第 1020009330 號函。
- 二、依據護理機構分類設置標準第 8 條附表「護理機構設置標準表」規定：「二、護理服務設施(四)日常活動場所：按病床數計，平均每床應有四平方公尺以上。」又，日常活動場所係指住民餐廳、交誼活動休閒所需之空間，本部前於 99 年 10 月 20 日衛署照字第 0992862869 號函函示在案，合先敘明。
- 三、病室外之走廊係屬機構室內走道，考量護理之家機構收住多屬失能、行動不便之住民，其活動需倚賴輪椅或推床等，故室內通路走廊，除應依內政部公告之建築物無障礙設

施設計規範，其坡度、寬度及迴轉空間符合無障礙通路外，至可否為住民之日常活動場所，應依前開規定，並視其是否具有說明二之日常活動場所空間之功能逕予認定。

(註：本函釋說明二所敘本署 99.10.20.衛署照字第 0992862869 號函，請參閱 P. 431)

102.12.31.衛部照字第 1021581254 號

主旨：有關護理機構分類設置標準之門寬定義疑義一案，請查照。
說明：

- 一、復貴局 102 年 11 月 20 日衛醫字第 1020021140 號函。
- 二、查護理機構分類設置標準規定，略以：「護理機構，其一般設施應符合建築法及其有關法規規定；住房寢室及衛浴設備至少應各有一扇門，寬度至少為零點八公尺」，所詢門寬定義，係指門實體寬度(淨寬)，尚不包括門框寬度。爰此，護理機構住房寢室及衛浴設備門寬應依該標準之特別規定辦理。

103.1.10 衛部照字第 1031580059 號函

主旨：有關貴機構之設施未達護理機構分類設置標準乙案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴機構 102 年 12 月 16 日璽字第 1021127 號函。
- 二、查本部 102 年 12 月 31 日衛部照字第 1021581254 號函，略以：「『護理機構……；住房寢室及衛浴設備至少應各有一扇門，寬度至少為零點八公尺』，門寬定義，係指門實體寬度(淨寬)，尚不包括門框寬度。護理機構住房寢室及衛浴設備門寬應依該標準之特別規定辦理」。
- 三、本案仍請相關權責機關本於權責依護理人員法及相關規定辦理。

103.3.10 衛部照字第 1031560361 號函

主旨：所詢有關護理機構設置標準表之一般設施要求之疑義一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴事務所 103 年 2 月 19 日(103)峰建築字第 1030219003 號函。
- 二、查護理機構設置標準表之一般設施第 4 點規定：「住房、寢室及衛浴設備，至少應各有一扇門，且寬度至少為零點八公尺。」。所詢門之數量係指住房、每間寢室及每間衛浴設備等，至少均應有一扇門，其實體寬度(淨寬)為至少(含)零點八公尺。爰此，護理機構住房、寢室及衛浴設備之門數量及其淨寬，應依上開標準規定辦理。

105.11.3 衛部照字第 1050131525 號

主旨：有關貴局函轉台北市產後護理之家協會就護理機構分類設置標準之門寬疑義及評鑑內容建議案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 10 月 18 日北市衛醫護字第 10541281001 號函。
- 二、有關護理機構分類設置標準住房寢室及衛浴設備之門寬規定一節，所謂門寬定義，係指門實體寬度(淨寬)，尚不包括門框寬度，前經本部 102 年 12 月 31 日衛部照字第 1021581254 號函(副本函各直轄市及縣市衛生局)及 104 年 10 月 30 日衛部照字第 1040132665 號函釋在案。
- 三、又，本部護理機構評鑑作業係依護理機構評鑑辦法規定辦理，為求評鑑委員之評分基準一致，本部均會召開評鑑委員共識會，委員須全程參加共識會，始能擔任評鑑委員，以達評鑑一致性。本年度產後護理機構評鑑應注意事項，業於 105 年 3 月辦理評鑑說明會時說明在案。

103.4.15. 衛部照字第 1031560433 號

主旨：有關產後護理機構設置及坐月子中心相關疑義，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復貴局 102 年 10 月 16 日高市衛健字第 10239956900 號函。
- 二、有關產後護理機構擴充地點為原已設置機構之鄰近地點，並由原已設置機構負責人同時擔任乙節，護理機構之設立或擴充，應依護理人員法、護理機構分類設置標準及護理機構設置或擴充許可辦法等規定辦理，至產後護理機構擴充地點之距離範圍，除應符合前開規定外，亦應考量機構現址與各分支點之照護品質服務、照護人力、行政管理、作業動線、安全管理、設備設施及配套措施之完善及運作順暢原則下設立，惟仍應依個案實際狀況認定之。
- 三、有關護理機構分類設置標準門寬定義乙節，查本部 102 年 12 月 31 日衛部照字第 1021581254 號函副本諒達，按護理機構分類設置標準規定，略以：「護理機構，其一般設施應符合建築法及其有關法規規定；住房寢室及衛浴設備至少應各有一扇門，寬度至少為零點八公尺」，所詢門寬定義，係指門實體寬度(淨寬)，尚不包括門框寬度。爰此，護理機構住房寢室及衛浴設備門寬應依該標準之特別規定辦理。
- 四、有關坐月子中心建築物及其設備規範乙節，查坊間所稱「坐月子中心」，係向經濟部辦理營業登記，應依其原始營業登記之各該管法令規定辦理，非依護理人員法許可設置；為顧及產婦及嬰兒之安全，故本部於「產後護理機構及坐月子中心定型化契約應記載及不得記載事項」明訂坐月子中心之建築物及其設備應符合建築法規及消防法規有關公共安全之相關規定；惟坐月子中心之建築物使用類組或消防安全場所用途分類之規定，仍應依營建及消防各該法令進行認定。

103.5.6 衛部照字第 1030112466 號函

主旨：有關一般護理之家申請擴充至不連續樓層及照護人力配置疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 4 月 29 日北衛醫字第 1030775515 號函。
- 二、按護理機構之設立，應依護理人員法之規定申請許可，並符合護理機構設置標準之相關規定，始予准許開業。有關一般護理之家設置於不連續樓層前經本部 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函及 89 年 10 月 4 日衛署醫字第 0890017043 號函釋，如符合護理機構設置標準規定，應無不可在案，先予敘明。
- 三、次按護理機構設置標準表之二、護理服務設施(一)住房項下規定應設護理站及其相關設施、設備，有關同一護理機構跨數樓層，每一樓層是否應依護理機構設置標準配置人力及設置護理站，亦經本部 97 年 3 月 5 日衛署醫字第 0970006126 號函釋，跨數樓層之護理機構，如相鄰樓層共用護理站，在不影響護理業務執行及能為護理機構住民及民眾方便利用下，尚無不可。爰本案請依權責，視個案事實認定。

(註：本函釋說明二所敘本部 96.10.29.衛署醫字第 0960049243 號函及 89.10.4.衛署醫字第 0890017043 號函，請參閱 P.425；說明三所敘本部 97.3.5 衛署醫字第 0970006126 號函，請參閱 P.429)

105.7.4 衛部照字第 1051563227 號

主旨：所詢產後護理機構若為兩層樓以上建築，應否於每層樓設置護理站及簡易護理工作站一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 6 月 8 日桃衛照字第 1050044118 號函。
- 二、依護理機構分類設置標準第八條附表「護理機構設置標準」中就產後護理機構之護理服務設施規定略以，「3、應設

護理站並具有相關設備…。」先予敘明。

- 三、關於同一護理機構跨數樓層，各樓層是否均需設置護理站或簡易護理工作站乙節，前經本部 97 年 3 月 5 日衛署醫字第 0970006126 號函釋，按護理機構之護理站設置，係為相關醫療器材、藥品及病歷存放管理空間，方便護理人員從事護理業務及提供住民、民眾諮詢服務之處。跨數樓層之護理機構，如相鄰樓層共用護理站，在不影響護理業務執行及能為護理機構住民及民眾方便利用下，尚無不可。是以，本案請依權責，視個案事實認定之。

105.8.1 衛部照字第 1050121076 號

主旨：有關貴局函轉台北市產後護理之家協會就護理機構分類設置標準之門寬疑義及評鑑內容建議案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復貴局 105 年 10 月 18 日北市衛醫護字第 10541281001 號函。
- 二、有關護理機構分類設置標準住房寢室及衛浴設備之門寬規定一節，所謂門寬定義，係指門實體寬度(淨寬)，尚不包括門框寬度，前經本部 102 年 12 月 31 日衛部照字第 1021581254 號函(副本函各直轄市及縣市衛生局)及 104 年 10 月 30 日衛部照字第 1040132665 號函釋在案。
- 三、又，本部護理機構評鑑作業係依護理機構評鑑辦法規定辦理，為求評鑑委員之評分基準一致，本部均會召開評鑑委員共識會，委員須全程參加共識會，始能擔任評鑑委員，以達評鑑一致性。本年度產後護理機構評鑑應注意事項，業於 105 年 3 月辦理評鑑說明會時說明在案。

103.8.5 衛部照字第 1031561273 號函

主旨：所詢產後護理機構設置標準，護理服務設施之日常活動場所空間規劃應在住房內或外一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴院 103 年 6 月 30 日大安字第 103021 號函。
- 二、依據護理機構分類設置標準第 8 條附表「護理機構設置標準表」之設置標準項目「二、護理服務設施」分類包括「住房」、「嬰兒室」、「日常活動場所」、「衛浴設備」及「其他」，其中「日常活動場所」按病床數(不包括嬰兒床)計，平均每床應有一點五平方公尺以上；爰「住房」及「日常活動場所」係不同之分類設置標準，故日常活動場所係指住房外，提供產婦產後交誼活動休閒、照護嬰兒之教導及健康恢復之課程所需之空間，如 貴院執行母嬰同室於住房內增加空間之舒適度，依法僅能以「住房」之設置標準計算。

106.3.29 衛部照字第 1060009528 號

主旨：有關貴機構所詢一般護理之家日常活動空間之認定與面積計算疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴機構 106 年 3 月 20 日衛護活函釋字第 1060320002 號函。
- 二、依據護理機構分類設置標準第 8 條附表規定(四)日常活動場所，一般護理之家按病床數計，平均每床應有四平方公尺以上。又本部 102 年 8 月 12 日衛部照字第 1021580181 號函略以，日常活動場所：按病床數計，平均每床應有四平方公尺以上。日常活動場所係指住民餐廳、交誼活動休閒所需之空間。
- 三、有關單人房及多人房之活動空間，護理機構設置標準項目二、護理服務設施「住房」及「日常活動場所」係不同之分類設置標準，故日常活動場所係指住房外之住民餐廳、交誼活動休閒所需之空間。

106.11.22 衛部照字第 1060134270 號

主旨：有關貴局所詢護理機構之設置標準項目「日常活動場所面積計算及走道範圍認定」之疑義案，復請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 11 月 9 日新北衛醫字第 1062234765 號函。
- 二、查護理機構分類設置標準第八條附表規定「住房走道淨寬至少一·四公尺。」。又查本部 102 年 8 月 12 日衛部照字第 1021580181 號函，略以「...病室外之走廊係屬機構室內走道，考量護理之家機構收住多屬失能、行動不便之住民，其活動需倚賴輪椅或推床等，故室內通路走廊，除應依內政部公告之建築物無障礙設施設計規範，其坡度、寬度及迴轉空間符合無障礙通路外，至可否為住民之日常活動場所，應依前開規定，....逕予認定。」。
- 三、依長期照顧服務法 106 年 6 月 3 日施行後，對於機構住宿式服務類之日常活動場所計算，參考長期照顧服務機構設立標準第 12 條住宿式長照機構設立標準表規定之日常活動場所面積之計算，包含多功能活動空間、休閒交誼空間、客廳、餐廳、休憩設施、日常訓練室、活動室及其他活動空間，且不包括走廊。另本部針對護理機構分類設置標準表，有關日常活動場所定義業參照前述長期照顧服務機構設立標準定義修正，目前刻辦理預告程序中。
- 四、綜上，有關護理機構以住房之寢室門口前之走廊空間作為日常活動場所一節，建請貴局依前揭函釋及規定，並應考量住民入住環境權益，逕依權責認定。

103.10.7 衛部照字第 1030128718 號函

主旨：所詢某護理之家擬提出申請開業，其護理機構分類設置標準第 8 條附表規定適用疑慮一案，復如說明，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 103 年 9 月 29 日屏衛照字第 10332803600 號函。
- 二、依據護理機構分類設置標準表之「二、護理服務設施(一)住房 2、應設寢室並符合下列規定：...(3)床邊與牆壁距離

至少零點八公尺。…」該項備註欄亦說明：本標準自 102 年 8 月 9 日修正施行前已設立之機構或已許可擴充之床數，其後僅變更機構負責人(其餘開業登記項目均未變更)者，免受此規定之限制。前項所稱已設立之護理機構，係指立案領有開業執照之機構，先予敘明。

- 三、次依護理機構分類設置標準第 8 條附表於 102 年 8 月 9 日公布施行，按同標準第 10 條之 1 規定，機構應於修正施行之日起 6 個月內(即 103 年 2 月 9 日)前完成補正。意即 102 年 8 月 9 日前雖經許可，但尚未開業之護理之家，其機構設置標準應依現行規定辦理。
- 四、旨案所陳之機構擬於 103 年 9 月 15 日提出申請開業，按上開規定，非屬已設立之機構(尚未領有開業執照)，爰應適用現行護理機構分類設置標準之規定。

103.10.14 衛部照字第 1031561690 號函

主旨：所詢有關一般護理之家相關疑義案，如說明段，請查照。
說明：

- 一、依據內政部營建署 103 年 9 月 12 日營授辦城字第 1033580690 號函及行政院農業委員會 103 年 9 月 9 日農企字第 1030230729 號函兼復貴中心 03 年 8 月 22 日苗照管字第 1030007304 號函。
- 二、有關護理之家是否符合都市計畫法臺灣省施行細則所稱『公益上需要』乙節：依據都市計畫法臺灣省施行細則第 23 條規定：「行政區以供政府機關、自治團體、人民團體及其他公益上需要之建築物使用為主，不得建築住宅、商店、旅社、工廠及其他娛樂用建築物。但紀念性之建築物與附屬於建築物之車庫及非營業性之招待所，不在此限。」次依內政部營建署說明，前項所稱『公益上需要』之建築物使用，係指出於公共利益的目的，為使社會公眾或者一定範圍內的社會公眾受益所需之建築物使用而言，且應依都市計畫法第 37 條規定，洽都市計畫擬定機關審查土地使

用分區管制查明其規定地地之使用。爰一般護理之家是否符合前開規定，應視機構申請計畫個案事實認定之。

三、又，護理之家是否符合農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點『公益性福利設施』乙節：農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點第6點規定：「非都市土地特定農業區之農業用地，不同意變更使用。但符合下列情形之一，且無前點各款情形之一者，得申請變更使用：…(五)中央目的事業主管機關專案核准設立之公益性福利設施或再生能源設施。…」按行政院農委會說明，前項所稱『公益性福利設施』，需具『公益性福利設施』性質，且經中央目的事業主管機關核准設立者，始得辦理。本案應先確認以何種設施合法化，再由縣市政府業務主管機關，依前開要點第4點規定，就該事業設置之必要性與計畫所提使用特定農的區用地、面積之必要性、合理性及無可替代性提出目的事業主管機關之評估意見，如認為本案有專案核准之必要性，再為本案向中央目的事業主管機關提出專案核准之申請。爰一般護理之家是否符合前開規定，應按機構興辦事業計畫之性質及使用內涵，視個案事實認定。

四、有關醫院附設一般護理之家，設置於醫院同址且分散不同樓層之通道(出入口及電梯)是否應獨立乙節，本部前於95年12月15日衛署醫字第0950062433號書函及96年10月29日衛署醫字第0960049243號函示在案，併予敘明，內容略以：如於同棟大樓不同樓層設置護理之家，護理機構與醫療機構之執業場所使用空間應有明確區隔，並各有獨立動線(包含出入口及電梯)，且符合護理機構設置標準之相關規定，得予准許。本案請依此原則辦理。

103.12.24 衛部照字第1031562533號函

主旨：所詢有關護理機構設置於不連續樓層及獨立動線疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴院 103 年 12 月 11 日中總嘉企字第 1030016136 號函。
- 二、有關護理機構擬與醫療機構同棟設置，如其護理機構申請執業場所使用空間及公共場所與醫療機構應有明顯區隔，並各有獨立動線，且符合護理機構設置標準之相關規定，始得准許，本部業於 96 年 10 月 29 日衛署醫字第 0960049243 號函釋在案。貴院擬規劃於同棟不同樓層設置護理之家，其獨立出入口之規劃，應符合前開規定，先予敘明。
- 三、又本部 102 年 11 月 5 日衛部照字第 1021580888 號函釋之內容，係針對同棟建築物設置老人福利機構及一般護理之家應符合條件(包含不同門牌號碼及應有獨立出入口)，惟不同樓層設醫療機構及護理之家需符合之條件，仍請按本部 96 年 10 月 29 日函釋內容辦理。爰本案請依此原則辦理。

(註：本函釋說明三所敘 102.11.5 衛部照字第 1021580888 號函，請參閱 P.201)

106.4.7 衛部照字第 1060009955 號

主旨：有關貴轄○○醫院附設護理之家申請擴床，與醫療機構同棟設置，且規劃於不連續樓層疑義，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 3 月 24 日苗衛醫字第 1060005486 號函。
- 二、旨揭疑義本部前於 103 年 12 月 24 日衛部照字第 1031562533 號函釋在案，內容略以：「有關護理機構擬與醫療機構同棟設置，如其護理機構申請執業場所使用空間及公共場所與醫療機構應有明顯區隔，並各有獨立動線，且符合護理機構設置標準之相關規定，始得准許...。」故該院擬規劃於同棟不同樓層設置護理之家，其獨立出入口之規劃，應符合前開規定。
- 三、另護理機構係屬人口密集機構，其空間規劃及動線應符合

感染控制規範，本案請依上開原則辦理。

(註：本函釋護理之家以○○表示)

104.3.12 衛部照字第 1041560167 號函

主旨：所詢業者欲申請設置一般護理之家提供日間照護服務相關疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 1 月 19 日衛醫字第 1030026717 號函。
- 二、按護理機構分類設置標準第八條附表「護理機構設置標準」之一般護理之家規定：二、護理服務設施之住房部分，應設寢室並符合規定、應設護理站並具有相關設備。(五)衛浴設備住房應設衛生設備及淋浴設備，且每六人至少應有一套。應有為臥床或乘坐輪椅病人特殊設計之衛浴設備。又，其中設有為日間照護者，視需要設置休息床位。三、建築物之設計構造與設備之總樓地板面積：設有日間照護者，按登記提供服務量計，平均每人應有十平方公尺以上(不包括車庫及宿舍面積)。
- 三、依上開規定及立法精神，一般護理之家之設置以收住式機構為申請主體，設置日間照護屬該機構之服務項目之一，並應依相關規定配置人力及空間規劃。另，機構床位數雖無最低限制，仍應視該地區民眾之長照資源需求及機構之營運規劃而定。
- 四、護理機構設置日間照護之服務，其總樓地板面積應依上開規定獨立計算並有足夠之空間規劃。
- 五、日間照護之服務可否販賣物品營利乙節，按護理人員法第 14 條規定，一般護理之家之設置，以提供護理照護等相關服務為主，且護理機構設置係依護理機構設置標準規定設立，其服務對象係以機構之住民以及其家屬為原則。爰此，有關營利型態之設置，其活動空間、人員應與機構有所區隔，且營業登記等相關事項應按營利事業管理相關規定辦理。

106.5.12 衛部照字第 1061561200 號

主旨：貴局函詢有關護理機構(一般護理之家)辦理「日間照護」服務項目疑義乙案，請查照。

說明：

- 一、復貴局 106 年 4 月 5 日新縣衛醫字第 1060005699 號函。
- 二、依本部 104 年 3 月 12 日衛部照字第 1041560167 號函略以，二、按護理機構分類設置標準第八條附表「護理機構設置標準表」之一般護理之家規定：二、護理服務設施之住房部分，應設寢室並符合規定、應設護理站並具有相關設備。… 三、依上開規定及立法精神，一般護理之家之設置以收住式機構為申請主體，設置日間照護屬該機構之服務項目之一，並應依相關規定配置人力及空間規劃。
- 三、查「老人福利服務提供者資格要件及服務準則」(以下稱服務準則)係依老人福利法第 20 條第 1 規定訂定之，該準則除於第 55 條至第 59 條規範社區式日間照顧服務外，於第 111 條至第 113 條尚規範機構式日間照顧服務。
- 四、綜上，一般護理之家提供日間照護與依服務準則提供社區式日間照顧服務或機構式日間照顧服務之法源不同，倘一般護理之家所提供的日間照護服務係依護理人員法及護理機構設置標準表等規定設置，則需依該法規辦理。
- 五、至於，所提建築使用類組及變更使用規定，涉地方建管單位法規規定及認定，請洽貴府建管單位。

〔釋例類別〕 第 4 類 設施及設備

83.6.17. 衛署醫字第 83035203 號函

主旨：醫療機構所設居家護理服務部門，其應有之急救設備，如其醫療機構可提供使用，得免另行設置，請 查照。

說明：依據本署於 83 年 4 月 22 日召開之「護理業務研討會」會議紀錄辦理。

89.1.24. 衛署醫字第 88075466 號函

主旨：有關彰化縣衛生局函詢老人福利機構設立標準第 1 章第 2 條第 5 款「環境衛生應具適當之防治措施」及第 2 章第 2 節第 10 條第 3 款「護理站：應具有基本急救設備…」，其應審查項目為何乙案，本署意見如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 88 年 12 月 2 日台內中社字第 8510045 號函。
- 二、依老人福利法第 9 條規定：養護機構：以照顧生活自理能力缺損且無技術性護理服務需求之老人為目的。安養機構：以安養自費老人或留養無扶養義務之親屬或扶養義務之親屬無扶養能力之老人為目的。考量該二類機構收案對象性質不同，建議養護機構應參照護理機構配置急救設備，至於安養機構則可參考救護車裝備標準之「一般急救箱配備項目表」（如附件）配置其急救設備。
- 三、有關「環境衛生應具適當之防治措施」部分，請參考護理機構設置標準之「其他」乙節規定辦理。

89.11.20. 衛署醫字第 0890022234 號函

主旨：有關台南市政府所訂「台南市托兒機構設置自治條例」，本署意見如說明段，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 89 年 10 月 12 日(89)童托字第 8905965 號函。
- 二、專辦或兼辦托嬰業務者，除應設置調奶台、護理台、餵奶室外，建議要有奶品貯存、冷藏設備；其設有全日托嬰者，應有專用之嬰幼兒洗澡台及工作台。
- 三、依傳染病防治法規定，傳染病共分 4 類，包括霍亂、鼠疫、流行性感冒……等，本條例第 13 條規定：托兒機構工作人員應身心健康，每年至少應定期健康檢查 1 次且未患有法定傳染病，其條件限制是否失之過嚴，請斟酌。
- 四、檢附傳染病防治法暨施行細則、護理人員法及其施行細則各乙份，請卓參。

95.10.12. 衛署醫字第 0950201186 號函

主旨：所詢護理之家應備之「常備急救藥品」品項乙案，復請照。

說明：

- 一、依據台灣急診醫學會 95 年 6 月 7 日(九十五)急字第 0368 號函及貴局 94 年 3 月 28 日北衛保字第 0940019067 號函辦理。
- 二、按依護理之家應備之「常備急救藥品」項目，應包括 Albuterol(或 Aminophylline 等支氣管擴張劑) 1 瓶、Atropine 5 支、Epinephrine (或 Bosmin 等升壓劑) 10 支、Sodium bicarbonate 5 支、Vena 5 支、Solu-cortef 5 支、50%G/W 3 支及 NTG. Tab 數顆，又相關業務之執行，應由轉介醫院配合督導管理。

95.12.12. 衛署醫字第 0950063563 號函

主旨：所詢老人福利機構之護理站應具有之基本急救設備及藥品疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴部 95 年 12 月 7 日內授中社字第 0950714497 號函。
- 二、依醫師法第 28 條規定：「未取得合法醫師資格，擅自執行醫療業務者，處 6 個月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金，其所使用之藥械沒收之。但合於下列情形之一者，不罰：……四、臨時施行急救。」惟查施予氣管內插管、急救藥物注射及心臟電擊之急救措施係屬侵入性治療、處置，應由醫師執行；另查「輔助施行侵入性治療、處置」，係屬護理人員法第 24 條第 1 項第 4 款所稱醫療輔助行為之範圍，是以，護理人員在醫師指示下得執行前述醫療輔助行為。
- 三、查長期照護機構係以照顧罹患長期慢性疾病並且需要醫護服務之老人為目的，與護理之家機構以罹患慢性病需長期護理之病人及出院後需繼續護理之病人為服務對象，兩機構所具功能及服務對象相當類似，爰此，長期照護機構涉

及提供醫事服務者，依老人福利法第9條第2項及第3項規定，其急救設備可參考護理機構之相關規定，所需之醫療或護理服務，應依醫療法、護理人員法或其他醫事專門職業法等規定辦理。

四、至「依老人福利法第9條規定：養護機構：以照顧生活自理能力缺損且無技術性護理服務需求之老人為目的。安養機構：以安養自費老人或留養無扶養義務之親屬或扶養義務之親屬無扶養能力之老人為目的。考量該二類機構收案對象性質不同，建議養護機構應參照護理機構配置急救設備，至於安養機構則參考救護車裝備標準之『一般急救箱配備項目表』配置其急救設備。」前經本署89年1月24日衛署醫字第88075466號函提供意見在案。

五、檢送救護車裝備標準之『一般急救箱配備項目表』1份，請參考。

（註：本函釋說明五所敘救護車裝備標準之「一般急救箱配備項目」如下：

99.8.13. 行政院衛生署衛署醫字第0990263087號令

一、依據行政院衛生署「救護車裝備標準」規定，一般型急救箱之配備項目包括下列：

項目	數量	項目	數量	項目	數量
體溫計(肛溫及腋溫)	各一支	血壓計	一組	咬合器	二個
寬膠帶	二捲	聽診器	一組	口咽呼吸道(含各種大小型式五種以上)	一組
止血帶(止血用)	二條	紗布繃帶(大、中、小)	各二捲	鼻咽呼吸道(含各種大小型式五種以上)	一組
剪刀	一把	彈性繃帶	二捲	手電筒及其備用電源	一組
優碘液	一瓶	三角巾	五條	驅血帶(靜脈注射用)	一條
護目鏡	二個	手套	四雙	活性炭粉末	一瓶
紙口罩	一盒	酒精棉片	十片		
鑷子(有齒、無齒)	各一支	彎盆	一個		
乾棉球	一包	垃圾袋	一個		

紗布 (2*2、3*3、4*4)	各二包	生理食鹽水 (500ML)	一袋		
壓舌板	二支	甦醒袋 (含接頭及口罩)	一組		

二、功能：

急救箱之主要功能為便於救護技術員將各項救護器材攜至事故現場，以利於第一時間實施必要之處置。)

96.5.9. 衛署醫字第 0960015013 號函

主旨：有關人口密集機構工作人員健康檢查項目及老人長期照護機構護理站常備急救藥品購置方式一案，復請 查照。

說明：

一、復 貴部 96 年 4 月 4 內授中社字第 0960713867 號函。

二、查「人口密集機構感染控制措施指引」係提供人口密集機構執行感染控制之原則參考，目的係為防範因工作人員導致機構內感染發生及擴散；爰此，依據傳染病防治法第 30 條、第 31 條及勞動相關法令規定，人口密集機構為防範機構內感染發生，對住民和工作人員應善盡健康管理及照護之責任，關於工作人員健康檢查項目，建請視業務特性及需求，依「人口密集機構感染控制措施指引」之原則辦理。

三、至老人長期照護機構護理站配置之常備急救藥品，所詢如何購置一節，按藥事法第 50 條規定，急救藥品品項，因涉屬處方用藥，非經醫師處方不得調劑供應。是以，老人長期照護機構應備之「常備急救藥品」等之相關業務執行，建議得與鄰近醫療機構簽訂轉介契約後，由轉介醫療機構配合督導施行，並注意藥品及醫材之更新，且應妥善保管及符合藥事法第 50 條規定。

96.7.3. 衛署醫字第 0960023885 號書函

主旨：所詢護理機構之護理紀錄或照護紀錄保存年限一案，復如說明段，請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 96 年 5 月 28 日護協字第 0960037 號函。
- 二、按護理人員法第 25 條規定：「護理人員執行業務時，應製作紀錄。前項紀錄應由該護理人員執業之機構保存十年。」是以，居家護理機構及護理之家機構，對於轉診及醫師每次診察之病歷摘要，應連同護理紀錄依前揭規定妥善保存。
- 三、至護理機構對於前揭病歷保存場所，除應符合建築物使用用途規定外，如設置於地下室，並應裝置必要之防潮、防水設施（如緊急發電機、抽水機、消防設施等），並有專人定期進行保養維修與緊急情況處理演習，以確保該設備隨時處於堪用狀態。遇緊急情況時，適時開啟使用，始足以認定該護理機構已善盡保管、保存之責。

96.12.13. 衛署醫字第 0960053842 號函

主旨：建請將護理之家、康復之家等其他醫事機構排除於水污染防治法之列管事業乙事，請 查照。

說明：

- 一、依據水污染防治法第 2 條第 7 款所定之「水污染防治法事業分類及定義」，第 55 類業別「醫院、醫事機構」之定義為「醫院、醫事檢驗所、捐血機構及其他醫事機構」。查醫療法第 12 條第 1 項規定，醫療機構設有病房收治病入者為醫院，僅應門診者為診所；非以直接診治病人為目的而辦理醫療業務之機構為其他醫療機構。另依據醫療機構設置標準第 2 條之規定，其他醫療機構分為捐血機構、病理機構及其他。另傳染病防治法第 4 條第 3 項規定，本法所稱醫事機構，指醫療法第 10 條第 1 項所定醫事人員依其專門職業法規規定申請核准開業之機構。按目前由醫事人員依其專門職業法規規定申請核准開業之機構包括：醫療機構（醫院、診所、捐血機構及病理機構）、護理之家機構、居家護理機構、產後護理機構、社區復健中心、康復之

家、物理治療所、職能治療所、醫事檢驗所、醫事放射所、助產所、鑲牙所、心理治療所、心理諮商所、藥局等。

- 二、鑑於目前上述之醫事機構，除醫院、病理機構、捐血機構及醫事檢驗機構外，其餘醫事機構均未執行檢驗等侵入性醫療行為，其產生日常廢水與醫院或大型醫事檢驗所不同，爰建請 貴署對於醫院、病理機構、捐血機構及醫事檢驗機構以外之醫事機構，比照內政部所轄之養護機構，免受水污染防治法列管，並據以修正「水污染防治法事業分類及定義」，將第55類業別「醫院、醫事機構」修正為「醫事機構」，並將定義修正為(1)醫院。(2)捐血機構、病理機構及醫事檢驗所。未來對於有特殊屬性之醫事機構，再以指定事業方式納入管理。

(註：行政院環境保護署回復如下：

97.3.11.環署水字第0970018163號函

主旨：有關建請將護理之家、康復之家等其他醫事機構排除於水污染防治法之列管事業乙事，請 查照。

說明：

- 一、醫事機構如護理機構、復健中心或洗腎中心等，如其設置病床數、廢水產生量未達水污染防治法事業分類及定義之管制標準或所含廢水中之鉛、鉻等有害健康物質未超過放流水標準者，並未納入管制對象，先予敘明。
- 二、醫事機構，如執行注射或傷口包紮等醫療行為時，仍有可能產生具有傳染性之清洗廢水，故不宜直接排除管制。但如前述之醫事機構，實際未執行醫療行為時，則非屬水污染防治法中所列管之「醫院、醫事機構」事業。
- 三、綜上，本署仍維持「醫院、醫事機構」之定義為「醫院、醫事檢驗所、捐血機構及其他醫事機構」，並依事實認定是否有執行醫療行為。

97.4.22.環署水字第0970029173號函

主旨：有關嘉義縣衛生局函詢護理之家業務是否涉及醫療行為及是否屬水污染防治法指定之事業乙案，請 查照。

說明：

- 一、依 貴署 96 年 12 月 13 日函說明二，護理之家係由醫事人員申請核准開業之機構，如實際具醫療行為且達事業管制之適用條件，則屬水污染防治法中所列管之「醫院、醫事機構」事業；如實際不具醫療行為，則非屬水污染防治法所列管之事業。至於護理之家是否有執行醫療行為，仍宜由貴署本於目的事業主管機關立場依事實認定。
- 二、本署已參採貴署所提建議，並配合醫療法及其相關管制規定，刻正修正「水污染防治法事業分類及定義」第 55 類業別，將「醫院、醫事機構」定義修正為(1)醫院或設置洗腎治療床(台)之診所。(2)捐血機構、病理機構或醫事檢驗所。適用條件增列洗腎治療床(台)20 床(台)以上。目前正辦理法制作業程序中。)

97.5.27. 衛署醫字第 0970062109 號函

主旨：有關釋示護理之家機構是否定位於醫療機構及應否列入水污染防治之管制對象疑義一案。

說明：

- 一、按醫療法所稱醫療機構，係指供醫師執行醫療業務之機構。復按護理人員法，護理機構係為減少醫療資源浪費，因應連續性醫療照護之需求，並發揮護理人員執業功能之機構。其種類係以居家護理機構、護理之家機構及產後護理機構為限。爰護理之家係屬護理機構，非屬醫療機構。
- 二、至有關護理之家機構應否列入水污染防治之管制對象一案，前經行政院環境保護署於 97 年 4 月 22 日以環署水字第 0970029173 號函，就前開事項回復本署在案，茲檢附該署前開來函供參。

98.8.13. 衛署醫字第 0980020450 號函

主旨：有關護理機構將清潔浴廁用之鹽酸，擺置於浴廁地面致機構內人員誤食一案。

說明：所詢旨揭事項，事屬機構內部管理事項，經查於護理人員法與護理機構設置標準尚無特別規範。

98.8.13. 衛署照字第 0982860888 號函

主旨：護理機構設置標準規定護理之家應備之常備急救藥品疑義一案。

說明：有關貴轄護理之家反應常備急救藥品品項 Solu-cortef 因廠商停產或缺貨等因素多不易取得乙案，對於常備急救藥品之品項因廠商停產或缺貨等因素，欲以同類型、同作用之藥品替代，基於考量病患緊急醫療之需求，並無不可，惟應注意替代藥品之使用方法、用途、功效、數量等，且其藥品相關業務之執行，應由轉介醫院配合督導管理。

102.3.5 衛署照字第 1022860189 號函

主旨：有關「護理機構分類設置標準第八條附表」產後護理之家嬰兒常備急救藥品項目，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 1 月 14 日南市衛醫字第 1020006379 號函。
- 二、按產後護理之家嬰兒室應備之「常備急救藥品」項目應包括 Epinephrine(Bosmin)10 支、Sodium Bicarbonate 5 支、Solu-cortef 1 支、Dopamine premix 1 支、Normal saline 或 Ringer's lactate(500ml) 2 瓶、10%G/W(500ml)1 瓶及 20%G/W(20ml)2 支，又相關業務之執行，應由轉介醫院配合督導管理。

102.3.21 衛署照字第 1022860762 號函

主旨：有關「護理機構分類設置標準第八條附表」產後護理之家嬰兒常備急救藥品項目更正乙案，詳如說明段，請查照。

說明：

- 一、本署 102 年 3 月 5 日衛署照字第 1022860189 號函計達。
- 二、原產後護理之家嬰兒室應備之「常備急救藥品」項目，其

中 Dopamine premix 1 支因 premix 為商品名稱，只要是 Dopamine 皆可使用，故原 Dopamine premix 1 支應更正為 Dopamine 1 支，惠請轉知所轄機構辦理。

102.5.20. 衛署照字第 1022863290 號函

主旨：所詢一般護理之家於住房內裝置監視器，是否影響個人隱私或違反相關規定一案，請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 102 年 4 月 10 日高市衛長字第 10233359200 號函。
- 二、按護理人員法第 28 條規定：「護理人員或護理機構及其人員對於因業務而知悉或持有他人秘密，不得無故洩漏。」，為確保住民隱私，如未徵得住民或其法定代理人之同意，不得對其進行錄影、錄音、攝影或其他涉及侵害個人隱私之行為，本署亦於 99 年 4 月 8 日衛署照字第 0992860917 號函釋在案。

(註：本函釋說明二所敘本署 99.4.8. 衛署照字第 0992860917 號函，請參閱 P.345)

104.2.13 衛部照字第 1041560306 號函

主旨：所詢有關護理機構設置標準之衛浴設備設置疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 2 月 2 日高市衛長字第 10430868900 號函。
- 二、查護理機構設置標準表之設置標準項目二、護理服務設施(一)住房 2、應設寢室並符合下列規定：…(7)每一寢室以六床為限。爰此，依前所示，住房係護理機構服務設施之一，住房包含數個寢室之單位，寢室係指設有床位之房間。
- 三、護理機構設置標準表之衛浴設備規定，「住房」應設衛生設備及淋浴設備，且每六人至少應有一套，故指機構內部(包含寢室及活動室)設置之衛浴設備之總數達每六人至

少一套。

- 四、又，若 2 間「住房」相通共用一間衛浴是否亦符合規定乙節，依前開說明，應係指 2 間「寢室」相通共用一間衛浴，然仍應符合前開規定辦理之。

第 9 條 居家護理機構之設置，其設立計畫書內容，應載明下列事項：

- 一、服務對象之條件。
- 二、服務區域。
- 三、病人轉介流程。
- 四、服務品質管制制度。
- 五、經費需求及來源。

前項第二款服務區域，跨直轄市或縣(市)行政區域提供服務者，應事先經各該直轄市或縣(市)主管機關核准。

92.4.17. 衛署醫字第 0920018473 號書函

主旨：所詢有關醫院報備跨區，執行居家護理業務，其報備是否應有執行地點或報備至縣、市即可乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 92 年 3 月 18 日衛醫字第 13345 號函。
- 二、依護理機構設置標準第 9 條第 2 項規定，居家護理機構之設置，其設立計畫書內容所載之服務區域，跨直轄市或縣(市)行政區域者，應依本法第 12 條規定事先報准。依上開規定跨直轄市或縣(市)行政區域之報准，依居家護理機構之業務特性，係以報准跨行政區域即可。

95.5.4. 衛署照字第 0952800782 號書函

主旨：有關居家護理所申請跨行政區域提供服務案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴局 95 年 3 月 22 日北衛醫字第 0950022425 號函。
- 二、查醫師法第 8 條之 2 與醫療機構設置標準第 26 條第 3 項有關支援報備之規定，係指醫師越區前往他醫療機構執行業務；至居家護理所跨行政區域提供服務，係屬設立主體服務區域業務範圍之擴充，與醫事人員跨區支援醫療業務性質並不相同，先予敘明。
- 三、居家護理所跨行政區域提供服務，應向擬服務區域之衛生主管機關申請報准，而該衛生主管機關於受理擬至所轄區域提供護理服務之居家護理機構申請報准時，應權衡該居家護理機構提供之業務特性及便利性、服務品質、病人轉介流程適當性、地方之需要性及服務對象之權益等因素，再予核准。

96. 6. 25. 衛署醫字第 0960026322 號書函

主旨：所詢醫師支援居家護理所執行居家訪視醫療業務，是否得於門診診療服務 3 個時段以外時間行之等疑義一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會 96 年 6 月 13 日長照聯字第 0960026 號函。
- 二、查醫師法第 8 條之 2 規定：「醫師執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構為之。但急救、醫療機構間之會診、支援、應邀出診或經事先報准者，不在此限。」。
- 三、是以，醫師支援居家護理所執行居家訪視醫療業務，並無時段之限制，惟應依前開規定事先報經地方主管機關核准後，始得為之。至健保是否提供給付，應依健保有關規定辦理。

103. 2. 13 衛部照字第 1031560187 號函

主旨：所詢有關貴機構「特聘護理服務」業務應否支援報備一案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴機構 102 年 11 月 25 日獎(特聘)字第 102007 號函。
- 二、依據護理人員法第 12 條規定：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援或經事先報准者，不在此限。」。次依護理機構分類設置標準第 9 條規定：「居家護理機構之設置，其設立計畫書內容，應載明下列事項：一、服務對象之條件。二、服務區域。三、病人轉介流程。四、服務品質管制制度。五、經費需求及來源。前項第二款服務區域，跨直轄市或縣(市)行政區域提供服務者，應事先經各該直轄市或縣(市)主管機關核准。」。
- 三、對於居家護理所之服務方式，係以執業登記於該機構之護理人員及提供外展服務為主，機構設置之計畫書亦包含服務區域，如需跨區域需事先支援報備且經核准後始得為之，故居家護理機構之護理人員，若係提供派駐醫院，執行病房之護理工作，仍應依報備規定辦理。本案請依前揭原則認定辦理。

104.1.22 衛部照字第 1040100716 號函

主旨：有關老人日間照顧服務中心、幼兒園、托嬰中心聘僱之護理人員能否辦理執業登記及醫療機構護理人員到府安寧及居家照顧，是否需要支援報備及如何報備疑義一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復 貴局 104 年 1 月 8 日北市衛醫字第 10430633100 號函。
- 二、按護理人員法第 8 條第 1 項規定「護理人員應向執業所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。」暨同法第 12 條規定略以：「護理人員執業，應在所在地主管機關核准登記之醫療機構、護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。…。」；所稱『

其他經中央主管機關認可之機構』，係指依相關法令規定須(得)配置護理人員執業之場所。

三、另按本部(前行政院衛生署)96 年 1 月 30 日衛署醫字第 0960004121 號函示略以：「……二、按醫事人員不論其職稱為何，如係執行各該專門職業法律所規定之專業業務工作，均應依規定辦理執業登記。是以，具有護理人員資格者，不論其職稱為何，如所從事之工作，非屬護理人員法第 24 條規定之業務，尚不須辦理執業登記；如從事護理人員法第 24 條規定之業務，即應依同法第 8 條之規定辦理執業登記，依法領有執業執照後，始得執業，先予敘明。」。

四、經查幼兒教育及照顧法第 18 條暨兒童及少年福利機構設置標準第 11 條皆已明訂依收置人數得或應置護理人員。爰所詢如老人日間服務中心、幼兒園、托嬰中心護理人員，如確有實際從事護理人員法第 24 條所規定之業務項目，則得依規定辦理執業執照，其執業登記之機構代碼得以護產機構權屬別「其他」編碼。

五、至所詢醫療機構護理人員到府安寧及居家照顧，是否需要支援報備及如何報備乙節，按本部(前行政院衛生署)83 年 8 月 24 日衛署醫字第 83050863 號函略以：「……。二、居家護理機構或醫療機構所設居家護理服務部門，其服務區域跨直轄市或縣(市)行政區區域者，仍須依護理人員法第 12 條規定申請報准，…。三、其護理人員執業異動或每年逐期辦理 1 次之報准時，應檢具前項第 3 款之文件。」，本案請參酌前揭規定辦理。

第 10 條 (刪除)

第10-1條 本標準修正施行前已設置之護理機構與本標準規定不符者，應於本標準修正施行之日起六個月內完成補正。

第 11 條 本標準自發布日施行。

附錄一、行政程序法

行政程序法

1. 中華民國 88 年 2 月 3 日總統(88)華總一義字第 8800027120 號令公布全文 175 條；並自 90 年 1 月 1 日施行
2. 中華民國 89 年 12 月 27 日總統(89)華總一義字第 8900305050 號令增訂公布第 174-1 條條文
3. 中華民國 90 年 6 月 20 日總統(90)華總一義字第 9000119000 號令修正公布第 174-1 條條文
4. 中華民國 90 年 12 月 28 日總統(90)華總一義字第 9000265010 號令修正公布第 174-1 條條文
5. 中華民國 94 年 12 月 28 日總統華總一義字第 09400212541 號令刪除公布第 44、45 條條文
6. 中華民國 102 年 5 月 22 日總統華總一義字第 10200092011 號令修正公布第 131 條條文
7. 中華民國 104 年 12 月 30 日總統華總一義字第 10400151551 號令修正公布第 127、175 條條文；並自公布日施行

第一章 總則

第一節 法例

第 1 條 為使行政行為遵循公正、公開與民主之程序，確保依法行政之原則，以保障人民權益，提高行政效能，增進人民對行政之信賴，特制定本法。

第 2 條 本法所稱行政程序，係指行政機關作成行政處分、締結行政契約、訂定法規命令與行政規則、確定行政計畫、實施行政指導及處理陳情等行為之程序。

本法所稱行政機關，係指代表國家、地方自治團體或其他行政主體表示意思，從事公共事務，具有單獨法定地位之組織。

受託行使公權力之個人或團體，於委託範圍內，視為行政機關。

第 3 條 行政機關為行政行為時，除法律另有規定外，應依本法規定為之。

下列機關之行政行為，不適用本法之程序規定：

- 一、各級民意機關。
- 二、司法機關。
- 三、監察機關。

下列事項，不適用本法之程序規定：

一、有關外交行為、軍事行為或國家安全保障事項之行為。

二、外國人出、入境、難民認定及國籍變更之行為。

三、刑事案件犯罪偵查程序。

四、犯罪矯正機關或其他收容處所為達成收容目的所為之行為。

五、有關私權爭執之行政裁決程序。

六、學校或其他教育機構為達成教育目的之內部程序。

七、對公務員所為之人事行政行為。

八、考試院有關考選命題及評分之行為。

第 4 條 行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。

第 5 條 行政行為之內容應明確。

第 6 條 行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇。

第 7 條 行政行為，應依下列原則為之：

一、採取之方法應有助於目的之達成。

二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。

三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

第 8 條 行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。

第 9 條 行政機關就該管行政程序，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。

第 10 條 行政機關行使裁量權，不得逾越法定之裁量範圍，並應符合法規授權之目的。

第二節 管轄

第 11 條 行政機關之管轄權，依其組織法規或其他行政法規
定之。

行政機關之組織法規變更管轄權之規定，而相關行

政法規所定管轄機關尚未一併修正時，原管轄機關得會同組織法規變更後之管轄機關公告或逕由其共同上級機關公告變更管轄之事項。

行政機關經裁併者，前項公告得僅由組織法規變更後之管轄機關為之。

前二項公告事項，自公告之日起算至第三日起發生移轉管轄權之效力。但公告特定有生效日期者，依其規定。

管轄權非依法規不得設定或變更。

第 12 條 不能依前條第一項定土地管轄權者，依下列各款順序定之：

一、關於不動產之事件，依不動產之所在地。

二、關於企業之經營或其他繼續性事業之事件，依經營企業或從事事業之處所，或應經營或應從事之處所。

三、其他事件，關於自然人者，依其住所地，無住所或住所不明者，依其居所地，無居所或居所不明者，依其最後所在地。關於法人或團體者，依其主事務所或會址所在地。

四、不能依前三款之規定定其管轄權或有急迫情形者，依事件發生之原因定之。

第 13 條 同一事件，數行政機關依前二條之規定均有管轄權者，由受理在先之機關管轄，不能分別受理之先後者，由各該機關協議定之，不能協議或有統一管轄之必要時，由其共同上級機關指定管轄。無共同上級機關時，由各該上級機關協議定之。

前項機關於必要之情形時，應為必要之職務行為，並即通知其他機關。

第 14 條 數行政機關於管轄權有爭議時，由其共同上級機關決定之，無共同上級機關時，由各該上級機關協議定之。

前項情形，人民就其依法規申請之事件，得向共同上級機關申請指定管轄，無共同上級機關者，得向各該

上級機關之一為之。受理申請之機關應自請求到達之日起十日內決定之。

在前二項情形未經決定前，如有導致國家或人民難以回復之重大損害之虞時，該管轄權爭議之一方，應依當事人申請或依職權為緊急之臨時處置，並應層報共同上級機關及通知他方。

人民對行政機關依本條所為指定管轄之決定，不得聲明不服。

第 15 條 行政機關得依法規將其權限之一部分，委任所屬下級機關執行之。

行政機關因業務上之需要，得依法規將其權限之一部分，委託不相隸屬之行政機關執行之。

前二項情形，應將委任或委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。

第 16 條 行政機關得依法規將其權限之一部分，委託民間團體或個人辦理。

前項情形，應將委託事項及法規依據公告之，並刊登政府公報或新聞紙。

第一項委託所需費用，除另有約定外，由行政機關支付之。

第 17 條 行政機關對事件管轄權之有無，應依職權調查；其認無管轄權者，應即移送有管轄權之機關，並通知當事人。

人民於法定期間內提出申請，依前項規定移送有管轄權之機關者，視同已在法定期間內向有管轄權之機關提出申請。

第 18 條 行政機關因法規或事實之變更而喪失管轄權時，應將案件移送有管轄權之機關，並通知當事人。但經當事人及有管轄權機關之同意，亦得由原管轄機關繼續處理該案件。

第 19 條 行政機關為發揮共同一體之行政機能，應於其權限範圍內互相協助。

行政機關執行職務時，有下列情形之一者，得向無隸屬關係之其他機關請求協助：

- 一、因法律上之原因，不能獨自執行職務者。
 - 二、因人員、設備不足等事實上之原因，不能獨自執行職務者。
 - 三、執行職務所必要認定之事實，不能獨自調查者。
 - 四、執行職務所必要之文書或其他資料，為被請求機關所持有者。
 - 五、由被請求機關協助執行，顯較經濟者。
 - 六、其他職務上有正當理由須請求協助者。
- 前項請求，除緊急情形外，應以書面為之。

被請求機關於有下列情形之一者，應拒絕之：

- 一、協助之行為，非其權限範圍或依法不得為之者。
 - 二、如提供協助，將嚴重妨害其自身職務之執行者。
- 被請求機關認有正當理由不能協助者，得拒絕之。

被請求機關認為無提供行政協助之義務或有拒絕之事由時，應將其理由通知請求協助機關。請求協助機關對此有異議時，由其共同上級機關決定之，無共同上級機關時，由被請求機關之上級機關決定之。

被請求機關得向請求協助機關要求負擔行政協助所需費用。其負擔金額及支付方式，由請求協助機關及被請求機關以協議定之；協議不成時，由其共同上級機關定之。

第三節 當事人

第 20 條 本法所稱之當事人如下：

- 一、申請人及申請之相對人。
- 二、行政機關所為行政處分之相對人。
- 三、與行政機關締結行政契約之相對人。
- 四、行政機關實施行政指導之相對人。
- 五、對行政機關陳情之人。

- 六、其他依本法規定參加行政程序之人。
- 第 21 條 有行政程序之當事人能力者如下：
- 一、自然人。
 - 二、法人。
 - 三、非法人之團體設有代表人或管理人者。
 - 四、行政機關。
 - 五、其他依法律規定得為權利義務之主體者。
- 第 22 條 有行政程序之行為能力者如下：
- 一、依民法規定，有行為能力之自然人。
 - 二、法人。
 - 三、非法人之團體由其代表人或管理人為行政程序行為者。
 - 四、行政機關由首長或其代理人、授權之人為行政程序行為者。
 - 五、依其他法律規定者。
- 無行政程序行為能力者，應由其法定代理人代為行政程序行為。
- 外國人依其本國法律無行政程序之行為能力，而依中華民國法律有行政程序之行為能力者，視為有行政程序之行為能力。
- 第 23 條 因程序之進行將影響第三人之權利或法律上利益者，行政機關得依職權或依申請，通知其參加為當事人。
- 第 24 條 當事人得委任代理人。但依法規或行政程序之性質不得授權者，不得為之。
- 每一當事人委任之代理人，不得逾三人。
- 代理權之授與，及於該行政程序有關之全部程序行為。但申請之撤回，非受特別授權，不得為之。
- 行政程序代理人應於最初為行政程序行為時，提出委任書。
- 代理權授與之撤回，經通知行政機關後，始對行政機關發生效力。

- 第 25 條 代理人有二人以上者，均得單獨代理當事人。
違反前項規定而為委任者，其代理人仍得單獨代理。
代理人經本人同意得委任他人為複代理人。
- 第 26 條 代理權不因本人死亡或其行政程序行為能力喪失而消滅。法定代理有變更或行政機關經裁併或變更者，亦同。
- 第 27 條 多數有共同利益之當事人，未共同委任代理人者，得選定其中一人至五人為全體為行政程序行為。
未選定當事人，而行政機關認有礙程序之正常進行者，得定相當期限命其選定；逾期未選定者，得依職權指定之。
經選定或指定為當事人者，非有正當理由不得辭退。
經選定或指定當事人者，僅得由該當事人為行政程序行為，其他當事人脫離行政程序。但申請之撤回、權利之拋棄或義務之負擔，非經全體有共同利益之人同意，不得為之。
- 第 28 條 選定或指定當事人有二人以上時，均得單獨為全體為行政程序行為。
- 第 29 條 多數有共同利益之當事人於選定或經指定當事人後，仍得更換或增減之。
行政機關對於其指定之當事人，為共同利益人之權益，必要時，得更換或增減之。
依前二項規定喪失資格者，其他被選定或指定之人得為全體為行政程序行為。
- 第 30 條 當事人之選定、更換或增減，非以書面通知行政機關不生效力。
行政機關指定、更換或增減當事人者，非以書面通知全體有共同利益之當事人，不生效力。但通知顯有困難者，得以公告代之。
- 第 31 條 當事人或代理人經行政機關之許可，得偕同輔佐人到場。

行政機關認為必要時，得命當事人或代理人偕同輔佐人到場。

前二項之輔佐人，行政機關認為不適當時，得撤銷其許可或禁止其陳述。

輔佐人所為之陳述，當事人或代理人未立即提出異議者，視為其所自為。

第四節 迴避

第 32 條 公務員在行政程序中，有下列各款情形之一者，應自行迴避：

- 一、本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。
- 二、本人或其配偶、前配偶，就該事件與當事人有共同權利人或共同義務人之關係者。
- 三、現為或曾為該事件當事人之代理人、輔佐人者。
- 四、於該事件，曾為證人、鑑定人者。

第 33 條 公務員有下列各款情形之一者，當事人得申請迴避：

- 一、有前條所定之情形而不自行迴避者。
- 二、有具體事實，足認其執行職務有偏頗之虞者。

前項申請，應舉其原因及事實，向該公務員所屬機關為之，並應為適當之釋明；被申請迴避之公務員，對於該申請得提出意見書。

不服行政機關之駁回決定者，得於五日內提請上級機關覆決，受理機關除有正當理由外，應於十日內為適當之處置。

被申請迴避之公務員在其所屬機關就該申請事件為准許或駁回之決定前，應停止行政程序。但有急迫情形，仍應為必要處置。

公務員有前條所定情形不自行迴避，而未經當事人申請迴避者，應由該公務員所屬機關依職權命其迴避。

第五節 程序之開始

第 34 條 行政程序之開始，由行政機關依職權定之。但依本法或其他法規之規定有開始行政程序之義務，或當事人已依法規之規定提出申請者，不在此限。

第 35 條 當事人依法向行政機關提出申請者，除法規另有規定外，得以書面或言詞為之。以言詞為申請者，受理之行政機關應作成紀錄，經向申請人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後由其簽名或蓋章。

第六節 調查事實及證據

第 36 條 行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。

第 37 條 當事人於行政程序中，除得自行提出證據外，亦得向行政機關申請調查事實及證據。但行政機關認為無調查之必要者，得不為調查，並於第四十三條之理由中敘明之。

第 38 條 行政機關調查事實及證據，必要時得據實製作書面紀錄。

第 39 條 行政機關基於調查事實及證據之必要，得以書面通知相關之人陳述意見。

通知書中應記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場及不到場所生之效果。

第 40 條 行政機關基於調查事實及證據之必要，得要求當事人或第三人提供必要之文書、資料或物品。

第 41 條 行政機關得選定適當之人為鑑定。

以書面為鑑定者，必要時，得通知鑑定人到場說明。

第 42 條 行政機關為瞭解事實真相，得實施勘驗。

勘驗時應通知當事人到場。但不能通知者，不在此限。

第 43 條 行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人。

第七節 資訊公開

第 44 條 (刪除)

第 45 條 (刪除)

第 46 條 當事人或利害關係人得向行政機關申請閱覽、抄寫、複印或攝影有關資料或卷宗。但以主張或維護其法律上利益有必要者為限。

行政機關對前項之申請，除有下列情形之一者外，不得拒絕：

一、行政決定前之擬稿或其他準備作業文件。

二、涉及國防、軍事、外交及一般公務機密，依法規規定有保密之必要者。

三、涉及個人隱私、職業秘密、營業秘密，依法規規定有保密之必要者。

四、有侵害第三人權利之虞者。

五、有嚴重妨礙有關社會治安、公共安全或其他公共利益之職務正常進行之虞者。

前項第二款及第三款無保密必要之部分，仍應准許閱覽。

當事人就第一項資料或卷宗內容關於自身之記載有錯誤者，得檢具事實證明，請求相關機關更正。

第 47 條 公務員在行政程序中，除基於職務上之必要外，不得與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸。

公務員與當事人或代表其利益之人為行政程序外之接觸時，應將所有往來之書面文件附卷，並對其他當事人公開。

前項接觸非以書面為之者，應作成書面紀錄，載明接觸對象、時間、地點及內容。

第八節 期日與期間

第 48 條 期間以時計算者，即時起算。

期間以日、星期、月或年計算者，其始日不計算在內。但法律規定即日起算者，不在此限。

期間不以星期、月或年之始日起算者，以最後之星期、月或年與起算日相當日之前一日為期間之末日。但以月或年定期間，而於最後之月無相當日者，以其月之末日為期間之末日。

期間之末日為星期日、國定假日或其他休息日者，以該日之次日為期間之末日；期間之末日為星期六者，以其次星期一上午為期間末日。

期間涉及人民之處罰或其他不利行政處分者，其始日不計時刻以一日論；其末日為星期日、國定假日或其他休息日者，照計。但依第二項、第四項規定計算，對人民有利者，不在此限。

第 49 條 基於法規之申請，以掛號郵寄方式向行政機關提出者，以交郵當日之郵戳為準。

第 50 條 因天災或其他不應歸責於申請人之事由，致基於法規之申請不能於法定期間內提出者，得於其原因消滅後十日內，申請回復原狀。如該法定期間少於十日者，於相等之日數內得申請回復原狀。

申請回復原狀，應同時補行期間內應為之行政程序行為。

遲誤法定期間已逾一年者，不得申請回復原狀。

第 51 條 行政機關對於人民依法規之申請，除法規另有規定外，應按各事項類別，訂定處理期間公告之。

未依前項規定訂定處理期間者，其處理期間為二個月。

行政機關未能於前二項所定期間內處理終結者，得於原處理期間之限度內延長之，但以一次為限。

前項情形，應於原處理期間屆滿前，將延長之事由通知申請人。

行政機關因天災或其他不可歸責之事由，致事務之處理遭受阻礙時，於該項事由終止前，停止處理期間之進行。

第九節 費用

第 52 條 行政程序所生之費用，由行政機關負擔。但專為當事人或利害關係人利益所支出之費用，不在此限。

因可歸責於當事人或利害關係人之事由，致程序有顯著之延滯者，其因延滯所生之費用，由其負擔。

第 53 條 證人或鑑定人得向行政機關請求法定之日費及旅費，鑑定人並得請求相當之報酬。

前項費用及報酬，得請求行政機關預行酌給之。

第一項費用，除法規另有規定外，其標準由行政院定之。

第十節 聽證程序

第 54 條 依本法或其他法規舉行聽證時，適用本節規定。

第 55 條 行政機關舉行聽證前，應以書面記載下列事項，並通知當事人及其他已知之利害關係人，必要時並公告之：

一、聽證之事由與依據。

二、當事人之姓名或名稱及其住居所、事務所或營業所。

三、聽證之期日及場所。

四、聽證之主要程序。

五、當事人得選任代理人。

六、當事人依第六十一條所得享有之權利。

七、擬進行預備程序者，預備聽證之期日及場所。

八、缺席聽證之處理。

九、聽證之機關。

依法規之規定，舉行聽證應預先公告者，行政機關應將前項所列各款事項，登載於政府公報或以其他適當方法公告之。

聽證期日及場所之決定，應視事件之性質，預留相當期間，便利當事人或其代理人參與。

第 56 條 行政機關得依職權或當事人之申請，變更聽證期日或場所，但以有正當理由為限。

行政機關為前項之變更者，應依前條規定通知並公

告。

第 57 條 聽證，由行政機關首長或其指定人員為主持人，必要時得由律師、相關專業人員或其他熟諳法令之人員在場協助之。

第 58 條 行政機關為使聽證順利進行，認為必要時，得於聽證期日前，舉行預備聽證。

預備聽證得為下列事項：

一、議定聽證程序之進行。

二、釐清爭點。

三、提出有關文書及證據。

四、變更聽證之期日、場所與主持人。

預備聽證之進行，應作成紀錄。

第 59 條 聽證，除法律另有規定外，應公開以言詞為之。

有下列各款情形之一者，主持人得依職權或當事人之申請，決定全部或一部不公開：

一、公開顯然有違背公益之虞者。

二、公開對當事人利益有造成重大損害之虞者。

第 60 條 聽證以主持人說明案由為始。

聽證開始時，由主持人或其指定之人說明事件之內容要旨。

第 61 條 當事人於聽證時，得陳述意見、提出證據，經主持人同意後並得對機關指定之人員、證人、鑑定人、其他當事人或其代理人發問。

第 62 條 主持人應本中立公正之立場，主持聽證。

主持人於聽證時，得行使下列職權：

一、就事實或法律問題，詢問當事人、其他到場人，或促其提出證據。

二、依職權或當事人之申請，委託相關機關為必要之調查。

三、通知證人或鑑定人到場。

四、依職權或申請，通知或允許利害關係人參加聽

證。

五、許可當事人及其他到場人之發問或發言。

六、為避免延滯程序之進行，禁止當事人或其他到場之人發言；有妨礙聽證程序而情節重大者，並得命其退場。

七、當事人一部或全部無故缺席者，逕行開始、延期或終結聽證。

八、當事人曾於預備聽證中提出有關文書者，得以其所載內容視為陳述。

九、認為有必要時，於聽證期日結束前，決定繼續聽證之期日及場所。

十、如遇天災或其他事故不能聽證時，得依職權或當事人之申請，中止聽證。

十一、採取其他為順利進行聽證所必要之措施。

主持人依前項第九款決定繼續聽證之期日及場所者，應通知未到場之當事人及已知之利害關係人。

第 63 條 當事人認為主持人於聽證程序進行中所為之處置違法或不當者，得即時聲明異議。

主持人認為異議有理由者，應即撤銷原處置，認為無理由者，應即駁回異議。

第 64 條 聽證，應作成聽證紀錄。

前項紀錄，應載明到場人所為陳述或發問之要旨及其提出之文書、證據，並記明當事人於聽證程序進行中聲明異議之事由及主持人對異議之處理。

聽證紀錄，得以錄音、錄影輔助之。

聽證紀錄當場製作完成者，由陳述或發問人簽名或蓋章；未當場製作完成者，由主持人指定日期、場所供陳述或發問人閱覽，並由其簽名或蓋章。

前項情形，陳述或發問人拒絕簽名、蓋章或未於指定日期、場所閱覽者，應記明其事由。

陳述或發問人對聽證紀錄之記載有異議者，得即時

提出。主持人認異議有理由者，應予更正或補充；無理由者，應記明其異議。

第 65 條 主持人認當事人意見業經充分陳述，而事件已達可為決定之程度者，應即終結聽證。

第 66 條 聽證終結後，決定作成前，行政機關認為必要時，得再為聽證。

第十一節 送達

第 67 條 送達，除法規另有規定外，由行政機關依職權為之。

第 68 條 送達由行政機關自行或交由郵政機關送達。

行政機關之文書依法規以電報交換、電傳文件、傳真或其他電子文件行之者，視為自行送達。

由郵政機關送達者，以一般郵遞方式為之。但文書內容對人民權利義務有重大影響者，應為掛號。

文書由行政機關自行送達者，以承辦人員或辦理送達事務人員為送達人；其交郵政機關送達者，以郵務人員為送達人。

前項郵政機關之送達準用依民事訴訟法施行法第三條訂定之郵政機關送達訴訟文書實施辦法。

第 69 條 對於無行政程序之行為能力人為送達者，應向其法定代理人為之。

對於機關、法人或非法人之團體為送達者，應向其代表人或管理人為之。

法定代理人、代表人或管理人有二人以上者，送達得僅向其中之一人為之。

無行政程序之行為能力人為行政程序之行為，未向行政機關陳明其法定代理人者，於補正前，行政機關得向該無行為能力人為送達。

第 70 條 對於在中華民國有事務所或營業所之外國法人或團體為送達者，應向其於中華民國之代表人或管理人為之。

前條第三項規定，於前項送達準用之。

第 71 條 行政程序之代理人受送達之權限未受限制者，送達應向該代理人為之。但行政機關認為必要時，得送達於當事人本人。

第 72 條 送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。

對於機關、法人、非法人之團體之代表人或管理人為送達者，應向其機關所在地、事務所或營業所行之。但必要時亦得於會晤之處所或其住居所行之。

應受送達人有就業處所者，亦得向該處所為送達。

第 73 條 於應送達處所不獲會晤應受送達人時，得將文書付與有辨別事理能力之同居人、受雇人或應送達處所之接收郵件人員。

前項規定於前項人員與應受送達人在該行政程序上利害關係相反者，不適用之。

應受送達人或其同居人、受雇人、接收郵件人員無正當理由拒絕收領文書時，得將文書留置於應送達處所，以為送達。

第 74 條 送達，不能依前二條規定為之者，得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。

前項情形，由郵政機關為送達者，得將文書寄存於送達地之郵政機關。

寄存機關自收受寄存文書之日起，應保存三個月。

第 75 條 行政機關對於不特定人之送達，得以公告或刊登政府公報或新聞紙代替之。

第 76 條 送達人因證明之必要，得製作送達證書，記載下列事項並簽名：

一、交送達之機關。

- 二、應受送達人。
- 三、應送達文書之名稱。
- 四、送達處所、日期及時間。
- 五、送達方法。

除電子傳達方式之送達外，送達證書應由收領人簽名或蓋章；如拒絕或不能簽名或蓋章者，送達人應記明其事由。

送達證書，應提出於行政機關附卷。

第 77 條 送達係由當事人向行政機關申請對第三人為之者，行政機關應將已為送達或不能送達之事由，通知當事人。

第 78 條 對於當事人之送達，有下列各款情形之一者，行政機關得依申請，准為公示送達：

- 一、應為送達之處所不明者。
- 二、於有治外法權人之住居所或事務所為送達而無效者。
- 三、於外國或境外為送達，不能依第八十六條之規定辦理或預知雖依該規定辦理而無效者。

有前項所列各款之情形而無人為公示送達之申請者，行政機關為避免行政程序遲延，認為有必要時，得依職權命為公示送達。

當事人變更其送達之處所而不向行政機關陳明，致有第一項之情形者，行政機關得依職權命為公示送達。

第 79 條 依前條規定為公示送達後，對於同一當事人仍應為公示送達者，依職權為之。

第 80 條 公示送達應由行政機關保管送達之文書，而於行政機關公告欄黏貼公告，告知應受送達人得隨時領取；並得由行政機關將文書或其節本刊登政府公報或新聞紙。

第 81 條 公示送達自前條公告之日起，其刊登政府公報或新聞紙者，自最後刊登之日起，經二十日發生效力；於依第七十八條第一項第三款為公示送達者，經六十日發生效力。但第七十九條之公示送達，自黏貼公告欄翌日起

發生效力。

第 82 條 為公示送達者，行政機關應製作記載該事由及年、月、日、時之證書附卷。

第 83 條 當事人或代理人經指定送達代收人，向行政機關陳明者，應向該代收人為送達。

郵寄方式向行政機關提出者，以交郵地無住居所、事務所及營業所者，行政機關得命其於一定期間內，指定送達代收人。

如不於前項期間指定送達代收人並陳明者，行政機關得將應送達之文書，註明該當事人或代理人之住居所、事務所或營業所，交付郵政機關掛號發送，並以交付文書時，視為送達時。

第 84 條 送達，除第六十八條第一項規定交付郵政機關或依第二項之規定辦理者外，不得於星期日或其他休息日或日出前、日沒後為之。但應受送達人不拒絕收領者，不在此限。

第 85 條 不能為送達者，送達人應製作記載該事由之報告書，提出於行政機關附卷，並繳回應送達之文書。

第 86 條 於外國或境外為送達者，應囑託該國管轄機關或駐在該國之中華民國使領館或其他機構、團體為之。

不能依前項規定為送達者，得將應送達之文書交郵政機關以雙掛號發送，以為送達，並將掛號回執附卷。

第 87 條 對於駐在外國之中華民國大使、公使、領事或其他駐外人員為送達者，應囑託外交部為之。

第 88 條 對於在軍隊或軍艦服役之軍人為送達者，應囑託該管軍事機關或長官為之。

第 89 條 對於在監所人為送達者，應囑託該監所長官為之。

第 90 條 於有治外法權人之住居所或事務所為送達者，得囑託外交部為之。

第 91 條 受囑託之機關或公務員，經通知已為送達或不能為送達者，行政機關應將通知書附卷。

第二章 行政處分

第一節 行政處分之成立

第 92 條 本法所稱行政處分，係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。

前項決定或措施之相對人雖非特定，而依一般性特徵可得確定其範圍者，為一般處分，適用本法有關行政處分之規定。有關公物之設定、變更、廢止或其一般使用者，亦同。

第 93 條 行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。無裁量權者，以法律有明文規定或為確保行政處分法定要件之履行而以該要件為附款內容者為限，始得為之。

前項所稱之附款如下：

- 一、期限。
- 二、條件。
- 三、負擔。
- 四、保留行政處分之廢止權。
- 五、保留負擔之事後附加或變更。

第 94 條 前條之附款不得違背行政處分之目的，並應與該處分之目的具有正當合理之關聯。

第 95 條 行政處分除法規另有要式之規定者外，得以書面、言詞或其他方式為之。

以書面以外方式所為之行政處分，其相對人或利害關係人有正當理由要求作成書面時，處分機關不得拒絕。

第 96 條 行政處分以書面為之者，應記載下列事項：

- 一、處分相對人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所或其他足資辨別之特徵；如係法人或其他設有管理人或代表人之團體，其名稱、事務所或營業所，及管理人或代表人之姓名、出生年月日、性別、身分證統一號碼、住居所。

二、主旨、事實、理由及其法令依據。

三、有附款者，附款之內容。

四、處分機關及其首長署名、蓋章，該機關有代理人或受任人者，須同時於其下簽名。但以自動機器作成之大量行政處分，得不經署名，以蓋章為之。

五、發文字號及年、月、日。

六、表明其為行政處分之意旨及不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關。

前項規定於依前條第二項作成之書面，準用之。

第 97 條 書面之行政處分有下列各款情形之一者，得不記明理由：

一、未限制人民之權益者。

二、處分相對人或利害關係人無待處分機關之說明已知悉或可知悉作成處分之理由者。

三、大量作成之同種類行政處分或以自動機器作成之行政處分依其狀況無須說明理由者。

四、一般處分經公告或刊登政府公報或新聞紙者。

五、有關專門知識、技能或資格所為之考試、檢定或鑑定等程序。

六、依法律規定無須記明理由者。

第 98 條 處分機關告知之救濟期間有錯誤時，應由該機關以通知更正之，並自通知送達之翌日起算法定期間。

處分機關告知之救濟期間較法定期間為長者，處分機關雖以通知更正，如相對人或利害關係人信賴原告知之救濟期間，致無法於法定期間內提起救濟，而於原告知之期間內為之者，視為於法定期間內所為。

處分機關未告知救濟期間或告知錯誤未為更正，致相對人或利害關係人遲誤者，如自處分書送達後一年內聲明不服時，視為於法定期間內所為。

第 99 條 對於行政處分聲明不服，因處分機關未為告知或告

知錯誤致向無管轄權之機關為之者，該機關應於十日內移送有管轄權之機關，並通知當事人。

前項情形，視為自始向有管轄權之機關聲明不服。

第 100 條 書面之行政處分，應送達相對人及已知之利害關係人；書面以外之行政處分，應以其他適當方法通知或使其知悉。

一般處分之送達，得以公告或刊登政府公報或新聞紙代替之。

第 101 條 行政處分如有誤寫、誤算或其他類此之顯然錯誤者，處分機關得隨時或依申請更正之。

前項更正，附記於原處分書及其正本，如不能附記者，應製作更正書，以書面通知相對人及已知之利害關係人。

第二節 陳述意見及聽證

第 102 條 行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第三十九條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分

相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。

第 103 條 有下列各款情形之一者，行政機關得不給予陳述意見之機會：

一、大量作成同種類之處分。

二、情況急迫，如予陳述意見之機會，顯然違背公益者。

三、受法定期間之限制，如予陳述意見之機會，顯然不能遵行者。

四、行政強制執行時所採取之各種處置。

五、行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者。

六、限制自由或權利之內容及程度，顯屬輕微，而無事先聽取相對人意見之必要者。

七、相對人於提起訴願前依法律應向行政機關聲請再審查、異議、復查、重審或其他先行程序者。

八、為避免處分相對人隱匿、移轉財產或潛逃出境，依法律所為保全或限制出境之處分。

第 104 條 行政機關依第一百零二條給予相對人陳述意見之機會時，應以書面記載下列事項通知相對人，必要時並公告之：

一、相對人及其住居所、事務所或營業所。

二、將為限制或剝奪自由或權利行政處分之原因事實及法規依據。

三、得依第一百零五條提出陳述書之意旨。

四、提出陳述書之期限及不提出之效果。

五、其他必要事項。

前項情形，行政機關得以言詞通知相對人，並作成紀錄，向相對人朗讀或使閱覽後簽名或蓋章；其拒絕簽名或蓋章者，應記明其事由。

第 105 條 行政處分之相對人依前條規定提出之陳述書，應為事實上及法律上陳述。

利害關係人亦得提出陳述書，為事實上及法律上陳述，但應釋明其利害關係之所在。

不於期間內提出陳述書者，視為放棄陳述之機會。

第 106 條 行政處分之相對人或利害關係人得於第一百零四條第一項第四款所定期限內，以言詞向行政機關陳述意見代替陳述書之提出。

以言詞陳述意見者，行政機關應作成紀錄，經向陳述人朗讀或使閱覽確認其內容無誤後，由陳述人簽名或蓋章；其拒絕簽名或蓋章者，應記明其事由。陳述人對紀錄有異議者，應更正之。

第 107 條 行政機關遇有下列各款情形之一者，舉行聽證：

一、法規明文規定應舉行聽證者。

二、行政機關認為有舉行聽證之必要者。

第 108 條 行政機關作成經聽證之行政處分時，除依第四十三條之規定外，並應斟酌全部聽證之結果。但法規明定應依聽證紀錄作成處分者，從其規定。

前項行政處分應以書面為之，並通知當事人。

第 109 條 不服依前條作成之行政處分者，其行政救濟程序，免除訴願及其先行程序。

第三節 行政處分之效力

第 110 條 書面之行政處分自送達相對人及已知之利害關係人起；書面以外之行政處分自以其他適當方法通知或使其知悉時起，依送達、通知或使知悉之內容對其發生效力。

一般處分自公告日或刊登政府公報、新聞紙最後登載日起發生效力。但處分另訂不同日期者，從其規定。

行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在。

無效之行政處分自始不生效力。

第 111 條 行政處分有下列各款情形之一者，無效：

一、不能由書面處分中得知處分機關者。

二、應以證書方式作成而未給予證書者。

三、內容對任何人均屬不能實現者。

四、所要求或許可之行為構成犯罪者。

五、內容違背公共秩序、善良風俗者。

六、未經授權而違背法規有關專屬管轄之規定或缺乏事務權限者。

七、其他具有重大明顯之瑕疵者。

第 112 條 行政處分一部分無效者，其他部分仍為有效。但除去該無效部分，行政處分不能成立者，全部無效。

第 113 條 行政處分之無效，行政機關得依職權確認之。

行政處分之相對人或利害關係人有正當理由請求確認行政處分無效時，處分機關應確認其為有效或無效。

第 114 條 違反程序或方式規定之行政處分，除依第一百十一條規定而無效者外，因下列情形而補正：

- 一、須經申請始得作成之行政處分，當事人已於事後提出者。
- 二、必須記明之理由已於事後記明者。
- 三、應給予當事人陳述意見之機會已於事後給予者。
- 四、應參與行政處分作成之委員會已於事後作成決議者。
- 五、應參與行政處分作成之其他機關已於事後參與者。

前項第二款至第五款之補正行為，僅得於訴願程序終結前為之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之。

當事人因補正行為致未能於法定期間內聲明不服者，其期間之遲誤視為不應歸責於該當事人之事由，其回復原狀期間自該瑕疵補正時起算。

第 115 條 行政處分違反土地管轄之規定者，除依第一百一十一條第六款規定而無效者外，有管轄權之機關如就該事件仍應為相同之處分時，原處分無須撤銷。

第 116 條 行政機關得將違法行政處分轉換為與原處分具有相同實質及程序要件之其他行政處分。但有下列各款情形之一者，不得轉換：

- 一、違法行政處分，依第一百十七條但書規定，不得撤銷者。
 - 二、轉換不符作成原行政處分之目的者。
 - 三、轉換法律效果對當事人更為不利者。
- 羈束處分不得轉換為裁量處分。

行政機關於轉換前應給予當事人陳述意見之機會。但有第一百零三條之事由者，不在此限。

第 117 條 違法行政處分於法定救濟期間經過後，原處分機關得依職權為全部或一部之撤銷；其上級機關，亦得為之。但有下列各款情形之一者，不得撤銷：

- 一、撤銷對公益有重大危害者。

二、受益人無第一百十九條所列信賴不值得保護之情形，而信賴授予利益之行政處分，其信賴利益顯然大於撤銷所欲維護之公益者。

第 118 條 違法行政處分經撤銷後，溯及既往失其效力。但為維護公益或為避免受益人財產上之損失，為撤銷之機關得另定失其效力之日期。

第 119 條 受益人有下列各款情形之一者，其信賴不值得保護：

- 一、以詐欺、脅迫或賄賂方法，使行政機關作成行政處分者。
- 二、對重要事項提供不正確資料或為不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而作成行政處分者。
- 三、明知行政處分違法或因重大過失而不知者。

第 120 條 授予利益之違法行政處分經撤銷後，如受益人無前條所列信賴不值得保護之情形，其因信賴該處分致遭受財產上之損失者，為撤銷之機關應給予合理之補償。

前項補償額度不得超過受益人因該處分存續可得之利益。

關於補償之爭議及補償之金額，相對人有不服者，得向行政法院提起給付訴訟。

第 121 條 第一百十七條之撤銷權，應自原處分機關或其上級機關知有撤銷原因時起二年內為之。

前條之補償請求權，自行政機關告知其事由時起，因二年間不行使而消滅；自處分撤銷時起逾五年者，亦同。

第 122 條 非授予利益之合法行政處分，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止。但廢止後仍應為同一內容之處分或依法不得廢止者，不在此限。

第 123 條 授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：

- 一、法規准許廢止者。
- 二、原處分機關保留行政處分之廢止權者。

三、附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者。

四、行政處分所依據之法規或事實事後發生變更，致不廢止該處分對公益將有危害者。

五、其他為防止或除去對公益之重大危害者。

第 124 條 前條之廢止，應自廢止原因發生後二年內為之。

第 125 條 合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力。但受益人未履行負擔致行政處分受廢止者，得溯及既往失其效力。

第 126 條 原處分機關依第一百二十三條第四款、第五款規定廢止授予利益之合法行政處分者，對受益人因信賴該處分致遭受財產上之損失，應給予合理之補償。

第一百二十條第二項、第三項及第一百二十一條第二項之規定，於前項補償準用之。

第 127 條 授予利益之行政處分，其內容係提供一次或連續之金錢或可分物之給付者，經撤銷、廢止或條件成就而有溯及既往失效之情形時，受益人應返還因該處分所受領之給付。其行政處分經確認無效者，亦同。

前項返還範圍準用民法有關不當得利之規定。

行政機關依前二項規定請求返還時，應以書面行政處分確認返還範圍，並限期命受益人返還之。

前項行政處分未確定前，不得移送行政執行。

第 128 條 行政處分於法定救濟期間經過後，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限：

一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。

二、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分者為限。

三、其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影響行政處分者。

前項申請，應自法定救濟期間經過後三個月內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算。但自法定救濟期間經過後已逾五年者，不得申請。

第 129 條 行政機關認前條之申請為有理由者，應撤銷、廢止或變更原處分；認申請為無理由或雖有重新開始程序之原因，如認為原處分為正當者，應駁回之。

第 130 條 行政處分經撤銷或廢止確定，或因其他原因失其效力後，而有收回因該處分而發給之證書或物品之必要者，行政機關得命所有人或占有人返還之。

前項情形，所有人或占有人得請求行政機關將該證書或物品作成註銷之標示後，再予發還。但依物之性質不能作成註銷標示，或註銷標示不能明顯而持續者，不在此限。

第 131 條 公法上之請求權，於請求權人為行政機關時，除法律另有規定外，因五年間不行使而消滅；於請求權人為人民時，除法律另有規定外，因十年間不行使而消滅。

公法上請求權，因時效完成而當然消滅。

前項時效，因行政機關為實現該權利所作成之行政處分而中斷。

第 132 條 行政處分因撤銷、廢止或其他事由而溯及既往失效時，自該處分失效時起，已中斷之時效視為不中斷。

第 133 條 因行政處分而中斷之時效，自行政處分不得訴請撤銷或因其他原因失其效力後，重行起算。

第 134 條 因行政處分而中斷時效之請求權，於行政處分不得訴請撤銷後，其原有時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。

第三章 行政契約

第 135 條 公法上法律關係得以契約設定、變更或消滅之。但依其性質或法規規定不得締約者，不在此限。

第 136 條 行政機關對於行政處分所依據之事實或法律關係，經依職權調查仍不能確定者，為有效達成行政目的，並解決爭執，得與人民和解，締結行政契約，以代替行政處分。

第 137 條 行政機關與人民締結行政契約，互負給付義務者，應符合下列各款之規定：

- 一、契約中應約定人民給付之特定用途。
- 二、人民之給付有助於行政機關執行其職務。
- 三、人民之給付與行政機關之給付應相當，並具有正當合理之關聯。

行政處分之作成，行政機關無裁量權時，代替該行政處分之行政契約所約定之人民給付，以依第九十三條第一項規定得為附款者為限。

第一項契約應載明人民給付之特定用途及僅供該特定用途使用之意旨。

第 138 條 行政契約當事人之一方為人民，依法應以甄選或其他競爭方式決定該當事人時，行政機關應事先公告應具之資格及決定之程序。決定前，並應予參與競爭者表示意見之機會。

第 139 條 行政契約之締結，應以書面為之。但法規另有其他方式之規定者，依其規定。

第 140 條 行政契約依約定內容履行將侵害第三人之權利者，應經該第三人書面之同意，始生效力。

行政處分之作成，依法規之規定應經其他行政機關之核准、同意或會同辦理者，代替該行政處分而締結之行政契約，亦應經該行政機關之核准、同意或會同辦理，始生效力。

第 141 條 行政契約準用民法規定之結果為無效者，無效。

行政契約違反第一百三十五條但書或第一百三十八條之規定者，無效。

第 142 條 代替行政處分之行政契約，有下列各款情形之一者

，無效：

- 一、與其內容相同之行政處分為無效者。
- 二、與其內容相同之行政處分，有得撤銷之違法原因，並為締約雙方所明知者。
- 三、締結之和解契約，未符合第一百三十六條之規定者。
- 四、締結之雙務契約，未符合第一百三十七條之規定者。

第 143 條 行政契約之一部無效者，全部無效。但如可認為欠缺該部分，締約雙方亦將締結契約者，其他部分仍為有效。

第 144 條 行政契約當事人之一方為人民者，行政機關得就相對人契約之履行，依書面約定之方式，為必要之指導或協助。

第 145 條 行政契約當事人之一方為人民者，其締約後，因締約機關所屬公法人之其他機關於契約關係外行使公權力，致相對人履行契約義務時，顯增費用或受其他不可預期之損失者，相對人得向締約機關請求補償其損失。但公權力之行使與契約之履行無直接必要之關聯者，不在此限。

締約機關應就前項請求，以書面並敘明理由決定之。

關於補償之爭議及補償之金額，相對人有不服者，得向行政法院提起給付訴訟。

第 146 條 行政契約當事人之一方為人民者，行政機關為防止或除去對公益之重大危害，得於必要範圍內調整契約內容或終止契約。

前項之調整或終止，非補償相對人因此所受之財產上損失，不得為之。

第一項之調整或終止及第二項補償之決定，應以書面敘明理由為之。

相對人對第一項之調整難為履行者，得以書面敘明理由終止契約。

相對人對第二項補償金額不同意時，得向行政法院提起給付訴訟。

第 147 條 行政契約締結後，因有情事重大變更，非當時所得預料，而依原約定顯失公平者，當事人之一方得請求他方適當調整契約內容。如不能調整，得終止契約。

前項情形，行政契約當事人之一方為人民時，行政機關為維護公益，得於補償相對人之損失後，命其繼續履行原約定之義務。

第一項之請求調整或終止與第二項補償之決定，應以書面敘明理由為之。

相對人對第二項補償金額不同意時，得向行政法院提起給付訴訟。

第 148 條 行政契約約定自願接受執行時，債務人不為給付時，債權人得以該契約為強制執行之執行名義。

前項約定，締約之一方為中央行政機關時，應經主管院、部或同等級機關之認可；締約之一方為地方自治團體之行政機關時，應經該地方自治團體行政首長之認可；契約內容涉及委辦事項者，並應經委辦機關之認可，始生效力。

第一項強制執行，準用行政訴訟法有關強制執行之規定。

第 149 條 行政契約，本法未規定者，準用民法相關之規定。

第四章 法規命令及行政規則

第 150 條 本法所稱法規命令，係指行政機關基於法律授權，對多數不特定人民就一般事項所作抽象之對外發生法律效果之規定。

法規命令之內容應明列其法律授權之依據，並不得逾越法律授權之範圍與立法精神。

第 151 條 行政機關訂定法規命令，除關於軍事、外交或其他重大事項而涉及國家機密或安全者外，應依本法所定程

序為之。但法律另有規定者，從其規定。

法規命令之修正、廢止、停止或恢復適用，準用訂定程序之規定。

第 152 條 法規命令之訂定，除由行政機關自行草擬者外，並得由人民或團體提議為之。

前項提議，應以書面敘明法規命令訂定之目的、依據及理由，並附具相關資料。

第 153 條 受理前條提議之行政機關，應依下列情形分別處理：

- 一、非主管之事項，依第十七條之規定予以移送。
- 二、依法不得以法規命令規定之事項，附述理由通知原提議者。
- 三、無須訂定法規命令之事項，附述理由通知原提議者。
- 四、有訂定法規命令之必要者，著手研擬草案。

第 154 條 行政機關擬訂法規命令時，除情況急迫，顯然無法事先公告周知者外，應於政府公報或新聞紙公告，載明下列事項：

- 一、訂定機關之名稱，其依法應由數機關會同訂定者，各該機關名稱。
- 二、訂定之依據。
- 三、草案全文或其主要內容。
- 四、任何人得於所定期間內向指定機關陳述意見之意旨。

行政機關除為前項之公告外，並得以適當之方法，將公告內容廣泛周知。

第 155 條 行政機關訂定法規命令，得依職權舉行聽證。

第 156 條 行政機關為訂定法規命令，依法舉行聽證者，應於政府公報或新聞紙公告，載明下列事項：

- 一、訂定機關之名稱，其依法應由數機關會同訂定者，各該機關之名稱。

- 二、訂定之依據。
- 三、草案之全文或其主要內容。
- 四、聽證之日期及場所。
- 五、聽證之主要程序。

第 157 條 法規命令依法應經上級機關核定者，應於核定後始得發布。

數機關會同訂定之法規命令，依法應經上級機關或共同上級機關核定者，應於核定後始得會銜發布。
法規命令之發布，應刊登政府公報或新聞紙。

第 158 條 法規命令，有下列情形之一者，無效：

- 一、牴觸憲法、法律或上級機關之命令者。
- 二、無法律之授權而剝奪或限制人民之自由、權利者。

三、其訂定依法應經其他機關核准，而未經核准者。

法規命令之一部分無效者，其他部分仍為有效。但除去該無效部分，法規命令顯失規範目的者，全部無效。

第 159 條 本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。

行政規則包括下列各款之規定：

- 一、關於機關內部之組織、事務之分配、業務處理方式、人事管理等一般性規定。
- 二、為協助下級機關或屬官統一解釋法令、認定事實、及行使裁量權，而訂頒之解釋性規定及裁量基準。

第 160 條 行政規則應下達下級機關或屬官。

行政機關訂定前條第二項第二款之行政規則，應由其首長簽署，並登載於政府公報發布之。

第 161 條 有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。

第 162 條 行政規則得由原發布機關廢止之。

行政規則之廢止，適用第一百六十條規定。

第五章 行政計畫

第 163 條 本法所稱行政計畫，係指行政機關為將來一定期限內達成特定之目的或實現一定之構想，事前就達成該目的或實現該構想有關之方法、步驟或措施等所為之設計與規劃。

第 164 條 行政計畫有關一定地區土地之特定利用或重大公共設施之設置，涉及多數不同利益之人及多數不同行政機關權限者，確定其計畫之裁決，應經公開及聽證程序，並得有集中事權之效果。

前項行政計畫之擬訂、確定、修訂及廢棄之程序，由行政院另定之。

第六章 行政指導

第 165 條 本法所稱行政指導，謂行政機關在其職權或所掌事務範圍內，為實現一定之行政目的，以輔導、協助、勸告、建議或其他不具法律上強制力之方法，促請特定人為一定作為或不作為之行為。

第 166 條 行政機關為行政指導時，應注意有關法規規定之目的，不得濫用。

相對人明確拒絕指導時，行政機關應即停止，並不得據此對相對人為不利之處置。

第 167 條 行政機關對相對人為行政指導時，應明示行政指導之目的、內容、及負責指導者等事項。

前項明示，得以書面、言詞或其他方式為之。如相對人請求交付文書時，除行政上有特別困難外，應以書面為之。

第七章 陳情

第 168 條 人民對於行政興革之建議、行政法令之查詢、行政違失之舉發或行政上權益之維護，得向主管機關陳情。

第 169 條 陳情得以書面或言詞為之；其以言詞為之者，受理機關應作成紀錄，並向陳情人朗讀或使閱覽後命其簽名或蓋章。

陳情人對紀錄有異議者，應更正之。

第 170 條 行政機關對人民之陳情，應訂定作業規定，指派人員迅速、確實處理之。

人民之陳情有保密必要者，受理機關處理時，應不予公開。

第 171 條 受理機關認為人民之陳情有理由者，應採取適當之措施；認為無理由者，應通知陳情人，並說明其意旨。

受理機關認為陳情之重要內容不明確或有疑義者，得通知陳情人補陳之。

第 172 條 人民之陳情應向其他機關為之者，受理機關應告知陳情人。但受理機關認為適當時，應即移送其他機關處理，並通知陳情人。

陳情之事項，依法得提起訴願、訴訟或請求國家賠償者，受理機關應告知陳情人。

第 173 條 人民陳情案有下列情形之一者，得不予處理：

一、無具體之內容或未具真實姓名或住址者。

二、同一事由，經予適當處理，並已明確答覆後，而仍一再陳情者。

三、非主管陳情內容之機關，接獲陳情人以同一事由分向各機關陳情者。

第八章 附則

第 174 條 當事人或利害關係人不服行政機關於行政程序中所為之決定或處置，僅得於對實體決定聲明不服時一併聲明之。但行政機關之決定或處置得強制執行或本法或其他法規另有規定者，不在此限。

第 174-1 條 本法施行前，行政機關依中央法規標準法第七條訂定之命令，須以法律規定或以法律明列其授權依據者，

應於本法施行後二年內，以法律規定或以法律明列其授權依據後修正或訂定；逾期失效。

第 175 條 本法自中華民國九十年一月一日施行。

本法修正條文自公布日施行。

附錄二、行政罰法

行政罰法

1. 中華民國 94 年 2 月 5 日總統華總一義字第 09400016841 號令制定公布全文 46 條；並自公布後一年施行
2. 中華民國 100 年 11 月 23 日總統華總一義字第 10000259791 號令修正公布第 26、27、32、45、46 條條文；並自公布日施行

第一章 法例

第 1 條 違反行政法上義務而受罰鍰、沒入或其他種類行政罰之處罰時，適用本法。但其他法律有特別規定者，從其規定。

第 2 條 本法所稱其他種類行政罰，指下列裁罰性之不利處分：

- 一、限制或禁止行為之處分：限制或停止營業、吊扣證照、命令停工或停止使用、禁止行駛、禁止出入港口、機場或特定場所、禁止製造、販賣、輸出入、禁止申請或其他限制或禁止為一定行為之處分。
- 二、剝奪或消滅資格、權利之處分：命令歇業、命令解散、撤銷或廢止許可或登記、吊銷證照、強制拆除或其他剝奪或消滅一定資格或權利之處分。
- 三、影響名譽之處分：公布姓名或名稱、公布照片或其他相類似之處分。
- 四、警告性處分：警告、告誡、記點、記次、講習、輔導教育或其他相類似之處分。

第 3 條 本法所稱行為人，係指實施違反行政法上義務行為之自然人、法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織。

第 4 條 違反行政法上義務之處罰，以行為時之法律或自治條例有明文規定者為限。

第 5 條 行為後法律或自治條例有變更者，適用行政機關最

初裁處時之法律或自治條例。但裁處前之法律或自治條例有利於受處罰者，適用最有利於受處罰者之規定。

第 6 條 在中華民國領域內違反行政法上義務應受處罰者，適用本法。

在中華民國領域外之中華民國船艦、航空器或依法得由中華民國行使管轄權之區域內違反行政法上義務者，以在中華民國領域內違反論。

違反行政法上義務之行為或結果，有一在中華民國領域內者，為在中華民國領域內違反行政法上義務。

第二章 責任

第 7 條 違反行政法上義務之行為非出於故意或過失者，不予處罰。

法人、設有代表人或管理人之非法人團體、中央或地方機關或其他組織違反行政法上義務者，其代表人、管理人、其他有代表權之人或實際行為之職員、受僱人或從業人員之故意、過失，推定為該等組織之故意、過失。

第 8 條 不得因不知法規而免除行政處罰責任。但按其情節，得減輕或免除其處罰。

第 9 條 未滿十四歲人之行為，不予處罰。

十四歲以上未滿十八歲人之行為，得減輕處罰。

行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不予處罰。

行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕處罰。

前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。

第 10 條 對於違反行政法上義務事實之發生，依法有防止之義務，能防止而不防止者，與因積極行為發生事實者同。

因自己行為致有發生違反行政法上義務事實之危

險者，負防止其發生之義務。

第 11 條 依法令之行為，不予處罰。

依所屬上級公務員職務命令之行為，不予處罰。但明知職務命令違法，而未依法定程序向該上級公務員陳述意見者，不在此限。

第 12 條 對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不予處罰。但防衛行為過當者，得減輕或免除其處罰。

第 13 條 因避免自己或他人生命、身體、自由、名譽或財產之緊急危難而出於不得已之行為，不予處罰。但避難行為過當者，得減輕或免除其處罰。

第三章 共同違法及併同處罰

第 14 條 故意共同實施違反行政法上義務之行為者，依其行為情節之輕重，分別處罰之。

前項情形，因身分或其他特定關係成立之違反行政法上義務行為，其無此身分或特定關係者，仍處罰之。

因身分或其他特定關係致處罰有重輕或免除時，其無此身分或特定關係者，仍處以通常之處罰。

第 15 條 私法人之董事或其他有代表權之人，因執行其職務或為私法人之利益為行為，致使私法人違反行政法上義務應受處罰者，該行為人如有故意或重大過失時，除法律或自治條例另有規定外，應並受同一規定罰鍰之處罰。

私法人之職員、受僱人或從業人員，因執行其職務或為私法人之利益為行為，致使私法人違反行政法上義務應受處罰者，私法人之董事或其他有代表權之人，如對該行政法上義務之違反，因故意或重大過失，未盡其防止義務時，除法律或自治條例另有規定外，應並受同一規定罰鍰之處罰。

依前二項並受同一規定處罰之罰鍰，不得逾新臺幣一百萬元。但其所得之利益逾新臺幣一百萬元者，得於

其所得利益之範圍內裁處之。

第 16 條 前條之規定，於設有代表人或管理人之非法人團體，或法人以外之其他私法組織，違反行政法上義務者，準用之。

第 17 條 中央或地方機關或其他公法組織違反行政法上義務者，依各該法律或自治條例規定處罰之。

第四章 裁處之審酌加減及擴張

第 18 條 裁處罰鍰，應審酌違反行政法上義務行為應受責難程度、所生影響及因違反行政法上義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力。

前項所得之利益超過法定罰鍰最高額者，得於所得利益之範圍內酌量加重，不受法定罰鍰最高額之限制。

依本法規定減輕處罰時，裁處之罰鍰不得逾法定罰鍰最高額之二分之一，亦不得低於法定罰鍰最低額之二分之一；同時有免除處罰之規定者，不得逾法定罰鍰最高額之三分之一，亦不得低於法定罰鍰最低額之三分之一。

但法律或自治條例另有規定者，不在此限。

其他種類行政罰，其處罰定有期間者，準用前項之規定。

第 19 條 違反行政法上義務應受法定最高額新臺幣三千元以下罰鍰之處罰，其情節輕微，認以不處罰為適當者，得免予處罰。

前項情形，得對違反行政法上義務者施以糾正或勸導，並作成紀錄，命其簽名。

第 20 條 為他人利益而實施行為，致使他人違反行政法上義務應受處罰者，該行為人因其行為受有財產上利益而未受處罰時，得於其所受財產上利益價值範圍內，酌予追繳。

行為人違反行政法上義務應受處罰，他人因該行為

受有財產上利益而未受處罰時，得於其所受財產上利益價值範圍內，酌予追繳。

前二項追繳，由為裁處之主管機關以行政處分為之。

第 21 條 沒入之物，除本法或其他法律另有規定者外，以屬於受處罰者所有為限。

第 22 條 不屬於受處罰者所有之物，因所有人之故意或重大過失，致使該物成為違反行政法上義務行為之工具者，仍得裁處沒入。

物之所有人明知該物得沒入，為規避沒入之裁處而取得所有權者，亦同。

第 23 條 得沒入之物，受處罰者或前條物之所有人於受裁處沒入前，予以處分、使用或以他法致不能裁處沒入者，得裁處沒入其物之價額；其致物之價值減損者，得裁處沒入其物及減損之差額。

得沒入之物，受處罰者或前條物之所有人於受裁處沒入後，予以處分、使用或以他法致不能執行沒入者，得追徵其物之價額；其致物之價值減損者，得另追徵其減損之差額。

前項追徵，由為裁處之主管機關以行政處分為之。

第五章 單一行為及數行為之處罰

第 24 條 一行為違反數個行政法上義務規定而應處罰鍰者，依法定罰鍰額最高之規定裁處。但裁處之額度，不得低於各該規定之罰鍰最低額。

前項違反行政法上義務行為，除應處罰鍰外，另有沒入或其他種類行政罰之處罰者，得依該規定併為裁處。但其處罰種類相同，如從一重處罰已足以達成行政目的者，不得重複裁處。

一行為違反社會秩序維護法及其他行政法上義務規定而應受處罰，如已裁處拘留者，不再受罰鍰之處罰。

第 25 條 數行為違反同一或不同行政法上義務之規定者，分

別處罰之。

第 26 條 一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，依刑事法律處罰之。但其行為應處以其他種類行政罰或得沒入之物而未經法院宣告沒收者，亦得裁處之。

前項行為如經不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定者，得依違反行政法上義務規定裁處之。

第一項行為經緩起訴處分或緩刑宣告確定且經命向公庫或指定之公益團體、地方自治團體、政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，支付一定之金額或提供義務勞務者，其所支付之金額或提供之勞務，應於依前項規定裁處之罰鍰內扣抵之。

前項勞務扣抵罰鍰之金額，按最初裁處時之每小時基本工資乘以義務勞務時數核算。

依第二項規定所為之裁處，有下列情形之一者，由主管機關依受處罰者之申請或依職權撤銷之，已收繳之罰鍰，無息退還：

- 一、因緩起訴處分確定而為之裁處，其緩起訴處分經撤銷，並經判決有罪確定，且未受免刑或緩刑之宣告。
- 二、因緩刑裁判確定而為之裁處，其緩刑宣告經撤銷確定。

第六章 時效

第 27 條 行政罰之裁處權，因三年期間之經過而消滅。

前項期間，自違反行政法上義務之行為終了時起算。但行為之結果發生在後者，自該結果發生時起算。

前條第二項之情形，第一項期間自不起訴處分、緩起訴處分確定或無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑之裁判確定日起算。

行政罰之裁處因訴願、行政訴訟或其他救濟程序經撤銷而須另為裁處者，第一項期間自原裁處被撤銷確定之日起算。

第 28 條 裁處權時效，因天災、事變或依法律規定不能開始或進行裁處時，停止其進行。

前項時效停止，自停止原因消滅之翌日起，與停止前已經過之期間一併計算。

第七章 管轄機關

第 29 條 違反行政法上義務之行為，由行為地、結果地、行為人之住所、居所或營業所、事務所或公務所所在地之主管機關管轄。

在中華民國領域外之中華民國船艦或航空器內違反行政法上義務者，得由船艦本籍地、航空器出發地或行為後在中華民國領域內最初停泊地或降落地之主管機關管轄。

在中華民國領域外之外國船艦或航空器於依法得由中華民國行使管轄權之區域內違反行政法上義務者，得由行為後其船艦或航空器在中華民國領域內最初停泊地或降落地之主管機關管轄。

在中華民國領域外依法得由中華民國行使管轄權之區域內違反行政法上義務者，不能依前三項規定定其管轄機關時，得由行為人所在地之主管機關管轄。

第 30 條 故意共同實施違反行政法上義務之行為，其行為地、行為人之住所、居所或營業所、事務所或公務所所在地不在同一管轄區內者，各該行為地、住所、居所或所在地之主管機關均有管轄權。

第 31 條 一行為違反同一行政法上義務，數機關均有管轄權者，由處理在先之機關管轄。不能分別處理之先後者，由各該機關協議定之；不能協議或有統一管轄之必要者，由其共同上級機關指定之。

一行為違反數個行政法上義務而應處罰鍰，數機關均有管轄權者，由法定罰鍰額最高之主管機關管轄。法定罰鍰額相同者，依前項規定定其管轄。

一行為違反數個行政法上義務，應受沒入或其他種類行政罰者，由各該主管機關分別裁處。但其處罰種類相同者，如從一重處罰已足以達成行政目的者，不得重複裁處。

第一項及第二項情形，原有管轄權之其他機關於必要之情形時，應為必要之職務行為，並將有關資料移送為裁處之機關；為裁處之機關應於調查終結前，通知原有管轄權之其他機關。

第 32 條 一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法上義務規定者，應將涉及刑事部分移送該管司法機關。

前項移送案件，司法機關就刑事案件為不起訴處分、緩起訴處分確定或為無罪、免訴、不受理、不付審理、不付保護處分、免刑、緩刑、撤銷緩刑之裁判確定，或撤銷緩起訴處分後經判決有罪確定者，應通知原移送之行政機關。

前二項移送案件及業務聯繫之辦法，由行政院會同司法院定之。

第八章 裁處程序

第 33 條 行政機關執行職務之人員，應向行為人出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌，並告知其所違犯之法規。

第 34 條 行政機關對現行違反行政法上義務之行為人，得為下列之處置：

- 一、即時制止其行為。
- 二、製作書面紀錄。
- 三、為保全證據之措施。遇有抗拒保全證據之行為且情況急迫者，得使用強制力排除其抗拒。

四、確認其身分。其拒絕或規避身分之查證，經勸導無效，致確實無法辨認其身分且情況急迫者，得令其隨同到指定處所查證身分；其不隨同到指定處所接受身分查證者，得會同警察人員強制為之。

前項強制，不得逾越保全證據或確認身分目的之必要程度。

第 35 條 行為人對於行政機關依前條所為之強制排除抗拒保全證據或強制到指定處所查證身分不服者，得向該行政機關執行職務之人員，當場陳述理由表示異議。

行政機關執行職務之人員，認前項異議有理由者，應停止或變更強制排除抗拒保全證據或強制到指定處所查證身分之處置；認無理由者，得繼續執行。經行為人請求者，應將其異議要旨製作紀錄交付之。

第 36 條 得沒入或可為證據之物，得扣留之。

前項可為證據之物之扣留範圍及期間，以供檢查、檢驗、鑑定或其他為保全證據之目的所必要者為限。

第 37 條 對於應扣留物之所有人、持有人或保管人，得要求其提出或交付；無正當理由拒絕提出、交付或抗拒扣留者，得用強制力扣留之。

第 38 條 扣留，應作成紀錄，記載實施之時間、處所、扣留物之名目及其他必要之事項，並由在場之人簽名、蓋章或按指印；其拒絕簽名、蓋章或按指印者，應記明其事由。

扣留物之所有人、持有人或保管人在場或請求時，應製作收據，記載扣留物之名目，交付之。

第 39 條 扣留物，應加封緘或其他標識，並為適當之處置；其不便搬運或保管者，得命人看守或交由所有人或其他適當之人保管。得沒入之物，有毀損之虞或不便保管者，得拍賣或變賣而保管其價金。

易生危險之扣留物，得毀棄之。

第 40 條 扣留物於案件終結前無留存之必要，或案件為不予處罰或未為沒入之裁處者，應發還之；其經依前條規定拍賣或變賣而保管其價金或毀棄者，發還或償還其價金。但應沒入或為調查他案應留存者，不在此限。

扣留物之應受發還人所在不明，或因其他事故不能發還者，應公告之；自公告之日起滿六個月，無人申請發還者，以其物歸屬公庫。

第 41 條 物之所有人、持有人、保管人或利害關係人對扣留不服者，得向扣留機關聲明異議。

前項聲明異議，扣留機關認有理由者，應發還扣留物或變更扣留行為；認無理由者，應加具意見，送直接上級機關決定之。

對於直接上級機關之決定不服者，僅得於對裁處案件之實體決定聲明不服時一併聲明之。但第一項之人依法不得對裁處案件之實體決定聲明不服時，得單獨對第一項之扣留，逕行提起行政訴訟。

第一項及前項但書情形，不影響扣留或裁處程序之進行。

第 42 條 行政機關於裁處前，應給予受處罰者陳述意見之機會。但有下列情形之一者，不在此限：

一、已依行政程序法第三十九條規定，通知受處罰者陳述意見。

二、已依職權或依第四十三條規定，舉行聽證。

三、大量作成同種類之裁處。

四、情況急迫，如給予陳述意見之機會，顯然違背公益。

五、受法定期間之限制，如給予陳述意見之機會，顯然不能遵行。

六、裁處所根據之事實，客觀上明白足以確認。

七、法律有特別規定。

第 43 條 行政機關為第二條第一款及第二款之裁處前，應依

受處罰者之申請，舉行聽證。但有下列情形之一者，不在此限：

- 一、有前條但書各款情形之一。
- 二、影響自由或權利之內容及程度顯屬輕微。
- 三、經依行政程序法第一百零四條規定，通知受處罰者陳述意見，而未於期限內陳述意見。

第 44 條 行政機關裁處行政罰時，應作成裁處書，並為送達。

第九章 附 則

第 45 條 本法施行前違反行政法上義務之行為應受處罰而未經裁處，於本法施行後裁處者，除第十五條、第十六條、第十八條第二項、第二十條及第二十二條規定外，均適用之。

前項行政罰之裁處權時效，自本法施行之日起算。

本法中華民國一百年十一月八日修正之第二十六條第三項至第五項規定，於修正施行前違反行政法上義務之行為同時觸犯刑事法律，經緩起訴處分確定，應受行政罰之處罰而未經裁處者，亦適用之；曾經裁處，因訴願、行政訴訟或其他救濟程序經撤銷，而於修正施行後為裁處者，亦同。

本法中華民國一百年十一月八日修正施行前違反行政法上義務之行為同時觸犯刑事法律，於修正施行後受免刑或緩刑之裁判確定者，不適用修正後之第二十六條第二項至第五項、第二十七條第三項及第三十二條第二項之規定。

第 46 條 本法自公布後一年施行。

本法修正條文自公布日施行。

附錄三、長期照顧服務法

長期照顧服務法

1. 中華民國 104 年 6 月 3 日總統華總一義字第 10400064391 號令制定公布全文 66 條；並自公布後二年施行
2. 中華民國 106 年 1 月 26 日總統華總一義字第 10600011601 號令修正公布第 15、22、62、66 條條文；並自本法施行之日(106 年 6 月 3 日)施行

第一章 總則

第 1 條 為健全長期照顧服務體系提供長期照顧服務，確保照顧及支持服務品質，發展普及、多元及可負擔之服務，保障接受服務者與照顧者之尊嚴及權益，特制定本法。

長期照顧服務之提供不得因服務對象之性別、性傾向、性別認同、婚姻、年齡、身心障礙、疾病、階級、種族、宗教信仰、國籍與居住地域有差別待遇之歧視行為。

第 2 條 本法所稱主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。

第 3 條 本法用詞，定義如下：

- 一、長期照顧（以下稱長照）：指身心失能持續已達或預期達六個月以上者，依其個人或其照顧者之需要，所提供之生活支持、協助、社會參與、照顧及相關之醫護服務。
- 二、身心失能者（以下稱失能者）：指身體或心智功能部分或全部喪失，致其日常生活需他人協助者。
- 三、家庭照顧者：指於家庭中對失能者提供規律性照顧之主要親屬或家人。
- 四、長照服務人員（以下稱長照人員）：指經本法所定之訓練、認證，領有證明得提供長照服務之人員。

五、長照服務機構（以下稱長照機構）：指以提供長照服務或長照需要之評估服務為目的，依本法規定設立之機構。

六、長期照顧管理中心（以下稱照管中心）：指由中央主管機關指定以提供長照需要之評估及連結服務為目的之機關（構）。

七、長照服務體系（以下稱長照體系）：指長照人員、長照機構、財務及相關資源之發展、管理、轉介機制等構成之網絡。

八、個人看護者：指以個人身分受僱，於失能者家庭從事看護工作者。

第 4 條

下列事項，由中央主管機關掌理：

一、依提供長照服務，制定全國性長照政策、法規及長照體系之規劃、訂定及宣導。

二、對直轄市、縣（市）政府執行長照之監督及協調事項。

三、長照服務使用者權益保障之規劃。

四、長照機構之發展、獎勵及依第三十九條第三項之辦法所定應由中央主管機關辦理之評鑑。

五、跨縣市長照機構之輔導及監督。

六、長照人員之管理、培育及訓練之規劃。

七、長照財源之規劃、籌措與長照經費之分配及補助。

八、長照服務資訊系統、服務品質等之研發及監測。

九、長照服務之國際合作、交流與創新服務之規劃及推動。

十、應協調提供資源不足地區之長照服務。

十一、其他全國性長照服務之策劃及督導。

第 5 條

下列事項，由地方主管機關掌理：

一、提供長照服務，制定轄內長照政策、長照體系

之規劃、宣導及執行。

二、執行中央主管機關訂定之長照政策、法規及相關規劃方案。

三、辦理地方之長照服務訓練。

四、轄內長照機構之督導考核及依第三十九條第三項之辦法所定應由地方主管機關辦理之評鑑。

五、地方長照財源之規劃、籌措與長照經費之分配及補助。

六、獎勵轄內發展困難或資源不足地區之長照機構。

七、其他屬地方性質之長照服務事項。

第 6 條 本法所定事項，涉及中央各目的事業主管機關職掌者，其權責劃分如下：

一、教育主管機關：長照教育、人力培育及長照服務使用者體育活動、運動場地及設施設備等相關事項。

二、勞工主管機關：長照人員及個人看護者之勞動條件、就業服務、職業安全衛生等事項，與非為醫事或社工專業證照之長照人員，及個人看護者之訓練、技能檢定等相關事項。

三、國軍退除役官兵輔導主管機關：退除役官兵長照等相關事項。

四、建設、工務、消防主管機關：長照機構之建築管理、公共設施與建築物無障礙生活環境及消防安全等相關事項。

五、原住民族事務主管機關：原住民族長照相關事項之協調、聯繫，並協助規劃及推動等相關事項。

六、科技研究事務主管機關：長照服務輔助科技研發、技術研究移轉、應用等相關事項。

七、其他目的事業主管機關：與各該機關有關之長

照等相關事項。

第 7 條 主管機關應以首長為召集人，邀集長期照顧相關學者專家、民間相關機構、團體代表、服務使用者代表及各目的事業主管機關代表，協調、研究、審議及諮詢長照服務、本國長照人力資源之開發、收退費、人員薪資、監督考核等長期照顧相關事宜。

前項代表中，相關學者專家與民間相關機構、團體代表及服務使用者代表，不得少於三分之二；服務使用者與單一性別代表不得少於三分之一；並應有原住民之代表或熟諳原住民文化之專家學者至少一人。

第二章 長照服務及長照體系

第 8 條 中央主管機關得公告長照服務之特定範圍。

民眾申請前項服務，應由照管中心或直轄市、縣（市）主管機關評估；直轄市、縣（市）主管機關應依評估結果提供服務。

接受醫事照護之長照服務者，應經醫師出具意見書，並由照管中心或直轄市、縣（市）主管機關評估。

第二項服務，應依失能者失能程度及其家庭經濟狀況，由主管機關提供補助；依其他法令規定得申請相同性質之服務補助者，僅得擇一為之。

第二項及第三項之評估，得委託專業團體辦理；評估之基準、方式、人員之資格條件及其他有關事項，由中央主管機關公告之。

第四項補助之金額或比率，由中央主管機關定之。

第 9 條 長照服務依其提供方式，區分如下：

一、居家式：到宅提供服務。

二、社區式：於社區設置一定場所及設施，提供日間照顧、家庭托顧、臨時住宿、團體家屋、小規模多機能及其他整合性等服務。但不包括第三款之服務。

三、機構住宿式：以受照顧者入住之方式，提供全時照顧或夜間住宿等之服務。

四、家庭照顧者支持服務：為家庭照顧者所提供之定點、到宅等支持服務。

五、其他經中央主管機關公告之服務方式。

前項服務方式，長照機構得合併提供之。

第一項第二款社區式之整合性服務，得由直轄市、縣(市)主管機關邀集社區代表、長照服務提供者代表及專家學者協調、審議與諮詢長照服務及其相關計畫、社區式整合性服務區域之劃分、社區長照服務之社區人力資源開發、收退費、人員薪資、服務項目、爭議事件協調等相關事項；並得與第七條規定合併設立。

第 10 條 居家式長照服務之項目如下：

一、身體照顧服務。

二、日常生活照顧服務。

三、家事服務。

四、餐飲及營養服務。

五、輔具服務。

六、必要之住家設施調整改善服務。

七、心理支持服務。

八、緊急救援服務。

九、醫事照護服務。

十、預防引發其他失能或加重失能之服務。

十一、其他由中央主管機關認定到宅提供與長照有關之服務。

第 11 條 社區式長照服務之項目如下：

一、身體照顧服務。

二、日常生活照顧服務。

三、臨時住宿服務。

四、餐飲及營養服務。

五、輔具服務。

- 六、心理支持服務。
- 七、醫事照護服務。
- 八、交通接送服務。
- 九、社會參與服務。
- 十、預防引發其他失能或加重失能之服務。
- 十一、其他由中央主管機關認定以社區為導向所提供與長照有關之服務。

第 12 條 機構住宿式長照服務之項目如下：

- 一、身體照顧服務。
- 二、日常生活照顧服務。
- 三、餐飲及營養服務。
- 四、住宿服務。
- 五、醫事照護服務。
- 六、輔具服務。
- 七、心理支持服務。
- 八、緊急送醫服務。
- 九、家屬教育服務。
- 十、社會參與服務。
- 十一、預防引發其他失能或加重失能之服務。
- 十二、其他由中央主管機關認定以入住方式所提供與長照有關之服務。

第 13 條 家庭照顧者支持服務提供之項目如下：

- 一、有關資訊之提供及轉介。
- 二、長照知識、技能訓練。
- 三、喘息服務。
- 四、情緒支持及團體服務之轉介。
- 五、其他有助於提升家庭照顧者能力及其生活品質之服務。

前項支持服務之申請、評估、提供及其他應遵行事項，由中央主管機關定之。

第 14 條 中央主管機關應定期辦理長照有關資源及需要之調

查，並考慮多元文化特色，與離島偏鄉地區特殊處境，據以訂定長照服務發展計畫及採取必要之獎助措施。

中央主管機關為均衡長照資源之發展，得劃分長照服務網區，規劃區域資源、建置服務網絡與輸送體系及人力發展計畫，並得於資源過剩區，限制長照機構之設立或擴充；於資源不足之地區，應獎助辦理健全長照服務體系有關事項。

原住民族地區長照服務計畫、長照服務網區與人力發展之規劃及推動，中央主管機關應會商原住民族委員會定之。

中央主管機關應獎助辦理長期照顧創新服務之相關研究。

第一項及第二項獎助之項目、方式與長照機構設立或擴充之限制，及第二項長照服務網區之劃分、人力發展等有關事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 15 條 中央主管機關為提供長照服務、擴增與普及長照服務量能、促進長照相關資源之發展、提升服務品質與效率、充實並均衡服務與人力資源及補助各項經費，應設置特種基金。

基金之來源如下：

- 一、遺產稅及贈與稅稅率由百分之十調增至百分之二十以內所增加之稅課收入。
- 二、菸酒稅菸品應徵稅額由每千支（每公斤）徵收新臺幣五百九十元調增至新臺幣一千五百九十元所增加之稅課收入。
- 三、政府預算撥充。
- 四、菸品健康福利捐。
- 五、捐贈收入。
- 六、基金孳息收入。
- 七、其他收入。

依前項第一款及第二款增加之稅課收入，不適用財

政收支劃分法之規定。

基金來源應於本法施行二年後檢討，確保財源穩定。

第 16 條 中央主管機關應建置服務使用者照顧管理、服務人力管理、長照機構管理及服務品質等資訊系統，以作為長照政策調整之依據，並依法公開。

主管機關及各長照機構應提供前項所需資料。

第 17 條 非以營利為目的之長照機構配合國家政策有使用公有非公用不動產之必要時，得專案報請主管機關核轉該不動產管理機關依法出租。其租金基準，

按該土地及建築物當期依法應繳納之地價稅及房屋稅計收年租金。

前項土地應辦理用地變更者，由長照機構報請主管機關核轉有關機關依規定辦理。

第一項專案報請之申請程序、要件及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第三章 長照人員之管理

第 18 條 長照服務之提供，經中央主管機關公告之長照服務特定項目，應由長照人員為之。

長照人員之訓練、繼續教育、在職訓練課程內容，應考量不同地區、族群、性別、特定疾病及照顧經驗之差異性。

長照人員應接受一定積分之繼續教育、在職訓練。

長照人員之訓練、認證、繼續教育課程內容與積分之認定、證明效期及其更新等有關事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 19 條 長照人員非經登錄於長照機構，不得提供長照服務。但已完成前條第四項之訓練及認證，並依其他相關法令登錄之醫事人員及社工人員，於報經主管機關同意者，不在此限。

長照機構不得容留非長照人員提供前條第一項之長照服務。

第一項登錄內容異動時，應自異動之日起三十日內，由該長照機構報所在地主管機關核定。

第一項之登錄，其要件、程序、處所、服務內容、資格之撤銷與廢止、臨時支援及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 20 條 長照人員對於因業務而知悉或持有他人之秘密，非依法律規定，不得洩漏。

第四章 長照機構之管理

第 21 條 長照機構依其服務內容，分類如下：

- 一、居家式服務類。
- 二、社區式服務類。
- 三、機構住宿式服務類。
- 四、綜合式服務類。
- 五、其他經中央主管機關公告之服務類。

第 22 條 前條第三款及設有機構住宿式服務之第四款、第五款長照機構，應以財團法人或社團法人（以下合稱長照機構法人）設立之。

公立長照機構不適用前項規定。

本法施行前，已依老人福利法、護理人員法及身心障礙者權益保障法設立

從事本法所定機構住宿式長照服務之私立機構，除有擴充或遷移之情事外，不受第一項之限制。

第一項長照機構法人之設立、組織、管理及其他應遵行事項，另以法律定之。

第 23 條 長照機構之設立、擴充、遷移，應事先申請主管機關許可。

第 24 條 長照機構之申請要件、設立標準、負責人資格，與其設立、擴充、遷移之申請程序、審查基準及設立許可

證明應記載內容等有關事項之辦法，由中央主管機關定之。

原住民族地區長照機構之設立及人員配置，中央主管機關應會商原住民族委員會定之。

第 25 條 長照機構停業、歇業、復業或許可證明登載事項變更，應於事實發生日前三十日內，報主管機關核定。

前項停業期間最長不得超過一年。必要時得申請延長一次，期限為一年；逾期應辦理歇業。

前項歇業應於停業期滿之日起三十日內辦理；逾期未辦理者，主管機關得逕予廢止其設立許可。

第一項及第二項之申請程序及審查等有關事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 26 條 長照機構由政府機關（構）設立者，應於長照機構前冠以該政府機關（構）之名稱；由民間設立者，應冠以私立二字。

長照機構應於其場所，以明顯字體依前項規定標示其名稱，並應加註機構類別及其服務內容。

第 27 條 非長照機構，不得使用長照機構之名稱。

第 28 條 長照機構不得使用下列名稱：

一、在同一直轄市或縣(市)，與被廢止許可證明或已經主管機關許可設立之長照機構相同之名稱。

二、易使人誤認其與政府機關、其他公益團體有關之名稱。

第 29 條 非長照機構，不得為長照服務之廣告。

長照機構之廣告，其內容以下列事項為限：

一、長照機構名稱與第二十六條第二項所定應加註之事項、設立日期、許可證明字號、地址、電話及交通路線。

二、長照機構負責人之姓名、學歷及經歷。

三、長照人員之專門職業及技術人員證書或本法所

定之證明文件字號。

四、服務提供方式及服務時間。

五、停業、歇業、復業、遷移及其年、月、日。

六、主管機關核定之收費標準。

七、其他經中央主管機關公告指定得刊登或播放之事項。

第 30 條 長照機構應設置業務負責人一人，對其機構業務負督導責任。

前項業務負責人資格，由中央主管機關定之。

第 31 條 長照機構之業務負責人因故不能執行業務，應指定符合業務負責人資格者代理之。代理期間超過三十日，應報所在地主管機關核定。

前項代理期間，不得逾一年。

第 32 條 中央主管機關應訂定長照體系、醫療體系及社會福利服務體系間之連結機制，以提供服務使用者有效之轉介與整合性服務。

第 33 條 機構住宿式服務類之長照機構，應與能及時接受轉介或提供必要醫療服務之醫療機構訂定醫療服務契約。

第 34 條 機構住宿式服務類之長照機構，應投保公共意外責任險，確保長照服務使用者之生命安全。

前項應投保之保險範圍及金額，由中央主管機關會商目的事業主管機關定之。

第 35 條 中央主管機關應輔導地方主管機關參考地區所得、物價指數、服務品質等，提供長照機構收費參考資訊。

長照機構之收費項目及其金額，應報提供服務所在地之主管機關核定；變更時亦同。

第 36 條 長照機構收取費用，應開給載明收費項目及金額之收據。

長照機構不得違反前條收費規定，超額或擅立項目收費。

第 37 條 長照機構應將其設立許可證明、收費、服務項目及

主管機關所設之陳情管道等資訊，揭示於機構內明顯處所。

第 38 條 長照機構應督導其所屬登錄之長照人員，就其提供之長照服務有關事項製作紀錄。

前項紀錄有關醫事照護部分，除依醫事法令之規定保存外，應由該長照機構至少保存七年。

第 39 條 主管機關對長照機構應予輔導、監督、考核、檢查及評鑑；必要時，並得通知其提供相關服務資料，長照機構應提供必要之協助，不得規避、妨礙或拒絕。

前項評鑑結果，應予公告。

第一項評鑑之對象、內容、方式及其他有關事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 40 條 主管機關應依下列原則訂定長照服務品質基準：

一、以服務使用者為中心，並提供適切服務。

二、訊息公開透明。

三、家庭照顧者代表參與。

四、考量多元文化。

五、確保照顧與生活品質。

第 41 條 長照機構歇業或停業時，對長照服務使用者應予以適當之轉介或安置；無法轉介或安置時，由主管機關協助轉介安置，長照機構應予配合。

長照機構未依前項規定為適當之轉介或安置時，地方主管機關得強制之。

接受轉介之長照機構應配合主管機關提供必要之協助。

第五章 接受長照服務者之權益保障

第 42 條 長照機構於提供長照服務時，應與長照服務使用者、家屬或支付費用者簽訂書面契約。

前項契約書之格式、內容，中央主管機關應訂定定型化契約範本與其應記載及不得記載之事項。

第 43 條 未經長照服務使用者之書面同意，不得對其進行錄影、錄音或攝影，並不得報導或記載其姓名、出生年月日、住（居）所及其他足資辨別身分之資訊；其無法為意思表示者，應經其法定代理人或主要照顧之最近親屬之書面同意。

長照機構於維護長照服務使用者安全之必要範圍內，得設置監看設備，不受前項之限制，並應告知長照服務使用者、其法定代理人或主要照顧之最近親屬。

第 44 條 長照機構及其人員應對長照服務使用者予以適當之照顧與保護，不得有遺棄、身心虐待、歧視、傷害、違法限制其人身自由或其他侵害其權益之情事。

第 45 條 主管機關應建置陳情、申訴及調處機制，處理民眾申訴案件及長照服務單位委託之爭議等事件。

第 46 條 地方主管機關對接受機構住宿式長照服務使用者，其無扶養義務人或法定代理人，應自行或結合民間團體監督其長照服務品質，長照機構不得拒絕。

第六章 罰則

第 47 條 長照機構違反第二十三條、第四十一條第一項或第四十四條規定者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰。

長照機構違反第二十三條規定者，除依前項規定處罰外，並限期令其改善；屆期未改善者，得按次處罰。

未經許可設立為長照機構，提供長照服務者，除依前二項規定處罰外，並命其歇業與公布其名稱及負責人姓名。

長照機構違反第四十四條規定者，除依第一項規定處罰外，並限期令其改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設立許可。

長照機構違反第四十四條規定，情節重大者，得逕

行廢止其設立許可。

第 48 條 長照機構違反許可設立之標準時，應限期令其改善；屆期未改善者，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並再限期令其改善；屆期仍未改善者，得廢止其設立許可。

第 49 條 長照機構違反第三十六條第二項規定者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並限期令其將超收或擅自收取之費用退還。

第 50 條 有下列情形之一者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰：

- 一、非長照人員違反第十八條第一項規定，提供經中央主管機關公告之長照服務特定項目。
- 二、長照機構違反第十九條第二項規定，容留非長照人員提供長照服務。
- 三、非長照機構違反第二十七條規定，使用長照機構名稱。

第 51 條 長照機構違反第二十五條第一項規定、刊登或播放第二十九條第二項各款規定以外之廣告內容或其廣告內容不實者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善者，並得按次處罰。

非長照機構違反第二十九條第一項規定為長照服務之廣告，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

第 52 條 長照機構於提供長照服務時，未依第四十二條規定簽訂書面契約，或其契約內容違反中央主管機關依同條第二項所定應記載及不得記載規定者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

第 53 條 長照機構有下列情形之一者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰：

- 一、違反第十九條第三項規定，於所屬長照人員異動時，未依限報所在地主管機關核定。

- 二、違反第三十一條第一項規定，於業務負責人因故不能執行業務時，未指定符合資格人員代理，或代理超過三十日而未報所在地主管機關核定。
- 三、違反第三十三條規定，未與能及時接受轉介或提供必要醫療服務之醫療機構簽訂醫療服務契約。
- 四、所屬長照人員違反第三十八條規定，未就其提供之長照服務有關事項製作紀錄、依法保存。
- 五、違反第三十九條第一項規定，規避、妨礙或拒絕主管機關之評鑑、輔導、監督、考核、檢查或提供相關服務資料之要求。

長照機構違反第三十一條第一項、第三十三條、第三十八條規定者，除依前項規定處罰外，並限期令其改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下停業處分。

長照機構依第三十九條第一項接受評鑑，評鑑不合格者，應限期令其改善；屆期未改善者，機構住宿式服務類之長照機構，處新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰；其他服務類之長照機構評鑑不合格者，依第一項規定處罰；屆期未改善，並得按次連續處罰；情節重大者，得處一個月以上一年以下停業處分，停業期滿仍未改善者，得廢止其設立許可。

第 54 條 長照人員違反第二十條、長照機構業務負責人違反第三十條、長照機構違反第四十三條第一項規定者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善且情節重大者，處一個月以上一年以下停業處分。

長照機構違反第十九條第一項規定未報所在地主管機關核定，即由已登錄之所屬長照人員提供長照服務者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

第 55 條 長照機構違反第三十六條第一項、第三十七條規定

者，應限期令其改善；屆期未改善者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

第 56 條 長照人員有下列情事之一者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，得併處一個月以上一年以下停業處分；情節重大者，並得廢止其證明：

- 一、執行業務時，為不實之記載。
- 二、將長照人員證明租借他人使用。
- 三、違反第四十四條規定。

第 57 條 長照機構僱用未接受第六十四條第一項規定訓練之個人看護者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

第 58 條 有下列情形之一者，處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰：

- 一、長照人員未依第十九條第一項規定完成登錄程序，即提供長照服務者。
- 二、長照人員證照效期屆滿，未完成證照之更新，提供長照服務。

第 59 條 長照機構有下列情形之一者，得廢止其設立許可：

- 一、因管理之明顯疏失，情節重大，致接受長照服務者傷亡。

- 二、所屬之長照人員提供長照服務，違反本法規定，且情節重大，並可歸責於該機構。
- 三、受停業處分而不停業。

前項第一款及第二款情節之認定，應由主管機關召開爭議處理會調查，並應給予受調查者陳述意見之機會；爭議處理會之組成，由中央主管機關定之。

第 60 條 本法所定罰則，由地方主管機關處罰之。

第七章 附則

第 61 條 本法施行前，已依其他法律規定，從事本法所定長照服務之人員，於本法施行後二年內，得繼續從事長照

服務，不受第十八條第一項規定之限制。

前項人員之訓練課程，其與本法施行前課程之整合、原有證明之轉銜及認定標準等有關事項，由中央主管機關定之。

第 62 條 本法施行前，已依其他法律規定，從事本法所定長照服務之機關（構）、法人、團體、合作社、事務所等，仍得依原適用法令繼續提供長照服務。

第 63 條 依國軍退除役官兵輔導條例設立之榮譽國民之家，附設專為退除役官兵及併同安置眷屬提供長照服務之長照機構，除第二十三條、第二十五條及第三十五條有關許可、核定程序之規定不適用本法外，有關設立標準、業務負責人資格及長照人員訓練認證標準、評鑑等，均應依本法規定辦理。但應於經其上級主管機關核准後三十日內，報所在地主管機關備查。

前項長照機構不適用第十四條之規定。

第 64 條 個人看護者，應接受中央主管機關公告指定之訓練。
於本法施行後初次入國之外國人，並受僱於失能者家庭從事看護工作者，雇主得為其申請接受中央主管機關所定之補充訓練。

前項補充訓練之課程內容、收費項目、申請程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 65 條 本法施行細則，由中央主管機關定之。

第 66 條 本法自公布後二年施行。
本法修正條文自本法施行之日施行。

附錄四、長期照顧服務法施行細則

長期照顧服務法施行細則

中華民國 106 年 6 月 2 日衛生福利部衛部照字第 1061561291 號令
訂定發布全文 15 條；並自 106 年 6 月 3 日施行

第 1 條 本細則依長期照顧服務法（以下簡稱本法）第六十五條規定訂定之。

第 2 條 本法第八條第三項所定醫師出具之意見書，其內容應載明下列事項：

- 一、當事人姓名、出生年月日、性別、國民身分證統一編號及通訊地址。
- 二、相關疾病診斷與近期治療現況。
- 三、當事人身心狀態事項。
- 四、當事人接受醫事照護服務時應注意之事項。
- 五、其他有關事項或建議。

前項意見書得以三個月內之相關病歷摘要或診斷書替代之。

第一項意見書之格式，由中央主管機關定之。

第 3 條 本法第九條第一項用詞，定義如下：

- 一、日間照顧：指提供長期照顧（以下簡稱長照）服務對象於日間往返社區式長照機構，接受身體與日常生活照顧及其他多元服務。
- 二、家庭托顧：指提供長照服務對象於往返家庭托顧服務人員住所，接受身體及日常生活照顧服務。
- 三、臨時住宿服務：指提供長照服務對象機構住宿式以外之住宿服務。
- 四、團體家屋：指於社區中，提供具行動力之失智症者家庭化及個別化之服務。
- 五、小規模多機能：指配合長照服務對象之需求，提供日間照顧、臨時住宿，或到宅提供身體與日常生活照顧、家事服務及其他多元之服務。

六、夜間住宿服務：指提供長照服務對象於夜間住宿之服務。

第 4 條 本法第二十二條第二項所稱公立長照機構，指由政府機關或公法人設立之長照機構。

第 5 條 本法第二十二條第三項所稱擴充，指機構總樓地板面積擴增。

床數增設而機構總樓地板面積未擴增者，非屬前項之擴充。

第 6 條 長照機構依本法第二十六條規定於其場所標示其名稱、機構類別及服務內容時，以本法第十條至第十二條及第二十一條所定者為限。

第 7 條 機構住宿式服務類長照機構，依本法第三十三條規定與醫療機構訂定之醫療服務契約，應載明下列事項：

- 一、醫事照護服務需要之轉介機制。
- 二、醫事照護服務之電話或網路諮詢機制。
- 三、醫師及其他醫事人員之支援機制。
- 四、其他與醫事照護服務相關之事項。

第 8 條 依本法第三十八條製作之紀錄，其內容應包括下列事項：

- 一、當事人之姓名、性別、出生年月日及地址。
- 二、當事人需長照服務之身心狀況。
- 三、當事人接受之照顧服務。
- 四、長照服務人員執行業務情形。
- 五、長照服務人員執行業務之年、月、日，並簽名或蓋章。

前項長照服務人員為醫事人員及社會工作師者，其製作之紀錄內容，除依前項規定外，應依相關法規之規定辦理。

第 9 條 主管機關依本法第三十九條規定，至長照機構執行輔導、監督、考核、檢查或評鑑時，應出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌。

第 10 條 本法第四十二條所定書面契約，並應載明本法第四十五條所定陳情、申訴與調處及本法第五十九條第二項所定爭議處理機制。

第 11 條 主管機關依本法第五十九條第二項所設爭議處理會(以下簡稱處理會)，置委員十一人至十五人，由主管機關首長就下列人員聘(派)兼之，並指定其中一人為召集人：

- 一、長照服務、長照管理及醫護之學者專家。
- 二、法律、財務或會計之學者專家。
- 三、長照服務使用者代表。
- 四、機關代表。

前項第一款委員，不得少於委員總數二分之一；單一性別委員，不得少於委員總數三分之一。

委員任期一年，期滿得續聘之；委員出缺時，得予補聘；補聘委員之任期至原委員任期屆滿之日為止。機關代表擔任之委員，應隨其本職進退。

第 12 條 處理會委員會議由召集人召集並為主席；召集人因故未能出席時，應指定委員代理之。

前條第一項第一款至第三款委員，應親自出席會議，不得委託他人代理。

機關代表擔任之委員，委託他人出席時，得參與討論、發言及決議。

處理會委員會議，應有全體委員二分之一以上出席，始得開會，並有出席委員三分之二以上同意，始得決議。

第 13 條 處理會委員會議之與會人員及其他工作人員對於決議事項、委員意見及其他個人資料，應予以保密。

處理會委員會議討論事項涉及委員及其關係人之利益時，應依行政程序法規定迴避。

第 14 條 處理會作成之調查結果，應由主管機關依本法及其相關法規規定處理。

第 15 條 本細則自中華民國一百零六年六月三日施行。

附錄五、專科護理師分科及甄審辦法

專科護理師分科及甄審辦法

1. 中華民國 93 年 10 月 27 日行政院衛生署衛署醫字第 0930219004 號令訂定發布全文 15 條；並自發布日施行
2. 中華民國 95 年 12 月 28 日行政院衛生署衛署照字第 0952802293 號令修正發布第 5、6、8~10 條條文；並增訂第 14-1 條條文
3. 中華民國 96 年 6 月 12 日行政院衛生署衛署照字第 0962801018 號令修正發布第 10 條條文
4. 中華民國 96 年 11 月 15 日行政院衛生署衛署照字第 0962802210 號令修正發布全文 20 條；並自發布日施行
5. 中華民國 99 年 4 月 20 日行政院衛生署衛署照字第 0992860763 號令修正發布第 10 條條文；刪除第 19 條條文>>原條文
6. 中華民國 100 年 2 月 25 日行政院衛生署衛署照字第 1002860263 號令修正發布全文 14 條；並自發布日施行
7. 中華民國 101 年 6 月 4 日行政院衛生署衛署照字第 1012862308 號令修正發布第 4 條條文之附表一
8. 中華民國 103 年 3 月 19 日衛生福利部衛部照字第 1031560178 號令修正發布第 12 條條文
9. 中華民國 104 年 11 月 3 日衛生福利部衛部照字第 1041561725 號令修正發布全文 19 條；並自發布日施行
10. 中華民國 107 年 4 月 2 日衛生福利部衛部照字第 1071560529 號令修正發布第 15 條條文

第一章 總則

- 第 1 條 本辦法依護理人員法第七條之一第三項規定訂定之。
- 第 2 條 專科護理師（以下稱專師）之分科如下：
一、內科。
二、外科。
- 第 3 條 護理師完成專師訓練，且具備臨床護理師工作年資（以下稱護理師年資）者，得參加該科專師之甄審。
- 第 4 條 前條專師訓練，指符合下列各款規定之一者：
一、第六條所定之專師訓練課程。
二、就讀國內大專校院研究所之專師學位學程（以下稱專師學位學程），且於中央主管機關認定

公告之訓練醫院(以下稱訓練醫院)完成臨床訓練，其課程內容及時數符合第六條第一項規定。

三、於美國、加拿大、南非、澳洲、紐西蘭、歐盟等與我國專師制度相當之國家完成訓練，且持有其證明文件。

前項第三款與我國專師制度相當之採認有疑義者，得報中央主管機關協助認定。

第 5 條 第三條所定護理師年資，指下列各款規定之一者：

一、參加前條第一項第一款訓練課程前，自專科或大學護理科、系畢業者，應具備護理師年資三年以上；護理研究所畢業者，應具備護理師年資二年以上。

二、符合前條第一項第二款規定者，於入學就讀專師學位學程前，應具備護理師年資二年以上。但本辦法於中華民國一百零五年一月一日修正施行前已入學就讀者，得以專師訓練期間外之護理師年資併計。

三、符合前條第一項第三款規定者，應具備護理師年資二年以上。

前項護理師年資，以在我國從事臨床護理師工作，並經執業登記者為限。

第二章 訓練課程及訓練醫院

第 6 條 第三條所定專師訓練，其課程(以下稱訓練課程)包括學科訓練及臨床訓練，二者合計訓練期間，至少六個月，至多十二個月。課程內容及時數規定如附表一。

訓練醫院得視護理師之實際狀況，於其訓練課程完成後，予以補充臨床訓練(以下稱補充訓練)；補充訓練應於訓練課程完成日起十八個月內為之。補充訓練之應遵行事項，規定如附表二。

第一項訓練課程及前項補充訓練之期間，其期間稱訓練期間。

- 第 7 條 第四條第一項第一款及第二款之專師訓練，應於訓練醫院為之；訓練醫院之認定基準及應遵行事項，規定如附表三。

臨床訓練，得與經教學醫院評鑑合格之醫院合作，其合作訓練時數不得超過訓練總時數三分之二；學科訓練，得以專師學位學程為之。

訓練醫院之認定，中央主管機關得委託相關專業機構或團體辦理。

- 第 8 條 訓練醫院應將訓練期間專師名單登錄造冊，送直轄市、縣(市)主管機關備查。

前項登錄內容，包括國民身分證統一編號、護理師證書字號、專師訓練科別、訓練起迄時間及執業年資等事項。

- 第 9 條 訓練醫院有下列情形之一者，中央主管機關得廢止其訓練醫院之資格：

- 一、規避、妨礙或拒絕直轄市、縣(市)主管機關之檢查或輔導。
- 二、未依附表一、附表二規定辦理訓練，或不符合附表三所定基準及應遵行事項，經直轄市、縣(市)主管機關限期命其改善，屆期未改善。

第三章 甄審作業

- 第 10 條 專師甄審，以每年辦理一次為原則。甄審之日期、地點及報名方式等事項，中央主管機關應於甄審日一個月前公告之。

前項甄審，包括筆試及口試二階段。筆試及格者，始得參加口試；筆試及格之效期保留二年。

筆試成績，以科目總成績計算平均六十分，且每一科目成績皆達五十分者為及格。

口試成績，以六十分為及格。

第 11 條 前條筆試，包括下列科目：

- 一、專科護理通論：含專師角色與職責、護理倫理與醫事法規、健康促進、品質管理及健康評估。
- 二、進階專科護理：含進階藥理學、進階病理生理學及健康問題診斷與處置。

第 12 條 報名專師甄審，應檢具下列證明文件：

- 一、護理師證書影本。
- 二、符合第五條護理師年資之證明。
- 三、下列專師訓練證明文件之一：
 - (一) 符合第四條第一項第一款：專師完成訓練課程之證明影本；護理研究所畢業者，並應檢具最高護理學歷之畢業證書影本。
 - (二) 符合第四條第一項第二款：研究所各科目修課學分及格證明及訓練醫院臨床訓練證明。
 - (三) 符合第四條第一項第三款：與我國專師制度相當之外國發給之證明文件影本。

本辦法中華民國一百年二月二十五日修正施行前，已完成專科護理師訓練者，其臨床工作證明，依修正前之規定。

第 13 條 專師甄審之有關資料自成績通知二年後，得予銷毀。

第四章 專師證書及其更新

第 14 條 經專師甄審合格者，得向中央主管機關申請發給專師證書。

前項證書，應記載下列事項：

- 一、專科別。
- 二、證書字號。
- 三、姓名、性別。

四、國民身分證統一編號。

五、出生年月日。

六、證書有效期間。

七、發證日期。

第 15 條 專師證書應每六年更新一次。

前項更新，應於專師證書效期屆滿前六個月內，檢具效期屆至日前六年內完成第十六條所定繼續教育之證明，向中央主管機關申請辦理。但有特殊理由，經檢具書面理由及證明文件，向中央主管機關申請延期更新並經核准者，得於其專師證書有效期限屆至之日起一年內，補行申請。

中央主管機關得委託相關專業機構或團體辦理前項專師證書更新申請之審查。

第 16 條 專師應每六年接受下列繼續教育課程，其積分應達一百二十點以上：

一、專科護理有關之專業課程。

二、專科護理有關之品質課程。

三、醫事倫理。

四、醫事法規。

前項第二款至第四款繼續教育課程之積分，應包含感染控制及性別議題之課程；其積分合計應達十二點以上，逾二十四點部分，不予採計。

第 17 條 專師繼續教育之實施方式，除依醫事人員執業登記及繼續教育辦法第十四條第一項規定辦理外，其為研究所專師相關學分課程部分，每學期積分超過十五點者，以十五點計。

於中央主管機關認定之醫療資源不足地區執業或因公派駐國外從事外交有關國際醫療之專師，其繼續教育課程積分，得加倍採計。

專師繼續教育課程積分之認定，中央主管機關得委託相關專業機構或團體辦理。

本辦法中華民國一百年二月二十五日修正施行前，已取得之繼續教育積分，依修正前之規定採計。

第 18 條 護理師證書經依法撤銷或廢止者，併予撤銷或廢止其專師證書。

第五章 附則

第 19 條 本辦法自發布日施行。

附表一

訓練課程

	學科訓練			臨床訓練		
課程	基礎核心	進階課程I	進階課程II	基礎核心實習	進階實習I	進階實習II
最低訓練時數	56 小時	64 小時	64 小時	15 案例	15 案例	10 案例
及實習個案數	184 小時			504 小時		
內容	1、醫療品質。 2、法規與倫理。 3、專業課程：包括專科護理師角色與職責、健康促進、品質管理、進階藥理學、進階病理生理學、進階健康評估、健康問題診斷與處置等。			1、與本課程相關之病人照護。 2、於臨床訓練師資指導下，接受「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」附表所訂項目之相關訓練。		
訓練人員資格	具課程內容領域專長之大專校院教師或臨床專家。			訓練師資應包括下列人員，其資格如下： 1、醫師：應具分科領域之專科醫師資格，並於取得資格後，實際從事該專科工作至少二年。 2、專科護理師：應具分科領域之專科護理師資格，且實際從事該分科專科護理師工作至少二年。		
師資比例				一名專科醫師及二名專科護理師為一組，每梯次每組至多指導八名訓練期間專科護理師。		

附表二

補充訓練應遵行事項

補充訓練對象	已完成附表一訓練課程者，並於原訓練醫院為之。
訓練人員資格	同附表一臨床訓練。
師資比例	1、同附表一臨床訓練。 2、師資比例之計算，訓練人員所指導之補充訓練護理師人數應併計附表一之訓練期間專科護理師人數。

附表三

訓練醫院認定基準及應遵行事項

一、認定基準

基準		內容
一、醫院評鑑		教學醫院評鑑合格，且於效期內。
二、教學安排	師資比例及訓練人員資格	符合附表一之規範。
	臨床訓練之安排	(一)臨床訓練計畫之妥適性，包括地點、環境(場地及空間)、設備、實習指導師資及實習內容等之規劃。 (二)訓練醫院得與經教學醫院評鑑合格之醫院合作，惟其訓練時數不得超過訓練總時數之三分之二，並應事先擬具臨床訓練計畫，報經中央主管機關核准。

三、組織及品質管制	(一)具專責之培育單位： 1、培育單位組成成員： 由護理與醫療部門主管組成之專科護理師培育專責單位，並由副院長以上人員擔任召集人，護理與醫療部門主管分任副召集人。 2、任務： (1)專師訓練課程及師資之安排、執行及檢討。 (2)訓練期間專科護理師之指導、輔導與管理之規劃。 (3)專科護理師訓練之品質維護與監測。 (4)定期檢討專科護理師之訓練計畫、執行及成效。 (二)前項專責培育單位得與「專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法」第四條之作業小組合併設立之。
-----------	---

二、應遵行事項

經中央主管機關認定公告為訓練醫院後，應遵循下列事項：

- (一)參加訓練之護理師應具備第五條第一款規定之護理師年資。
- (二)依第八條規定辦理訓練期間專科護理師名單登錄造冊及管理。
- (三)定期召開培育單位會議。
- (四)定期檢討及評值教學計畫與訓練成果。
- (五)訓練醫院如有第九條情節，中央主管機關得廢止其資格。

附錄六、長期照顧服務機構法人條例

長期照顧服務機構法人條例

中華民國 107 年 1 月 31 日總統華總一義字第 10700010291 號令
制定公布全文 47 條；並自公布日施行

第一章 總則

- 第 1 條 為健全長期照顧服務機構法人之設立、組織及管理，特制定本條例。
- 第 2 條 本條例所稱主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。
- 第 3 條 本條例所稱長期照顧服務機構法人(以下稱長照機構法人)，指提供機構住宿式服務，並依本條例設立之長照機構財團法人及長照機構社團法人。
- 第 4 條 長照機構法人之管理及監督，由其主事務所所在地之直轄市、縣(市)政府為之。但長照機構法人所設立之長照機構如有跨縣市者，由中央主管機關為之。

第二章 長照機構法人

第一節 通則

- 第 5 條 長照機構法人所設立之長照機構，始得提供機構住宿式服務。但法律另有規定者，不在此限。
- 第 6 條 長照機構法人經主管機關許可，除設立長照機構外，並得設立社會福利機構或提供經中央主管機關公告之服務。
- 第 7 條 長照機構法人所設立之長照機構，其區域、分類、家數及規模，得為必要之限制。
前項限制，由中央主管機關公告之。
- 第 8 條 長照機構法人應有足以達成其設立目的所必要之財產。
前項必要之財產，由中央主管機關依其設立之規模及運用條件公告之。
- 第 9 條 長照機構法人所設立之機構，其相互間之財務及會

計帳務應獨立。

第 10 條 長照機構法人應設董事會，置董事長一人，並以董事長為其代表人。

長照機構法人應置監察人，其名額不得逾董事名額三分之一；置監察人三人以上者，應互推一人為常務監察人。

董事、監察人不得擔任長照機構法人及其所設機構之職員。但有第二十五條第四項情形者，不在此限。

監察人相互間、監察人與董事間，不得有配偶或三親等內親屬關係。

長照機構財團法人所登記之財產總額或該法人及其所設立機構之年度收入總額達新臺幣一億元以上者，主管機關應指派社會公正人士一人擔任該長照機構法人公益監察人，其職權與長照機構法人監察人同，並得依實際需要更換之。

前項公益監察人之資格、派免程序、得支領之費用及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 11 條 長照機構法人之董事會，每半年至少開會一次，由董事長召集之。必要時，得召開臨時會議。

董事應親自出席會議。

第 12 條 有下列各款情形之一者，不得擔任長照機構法人之董事或監察人：

- 一、曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定。
- 二、曾犯詐欺、背信、侵占或貪污罪，經判處有期徒刑一年以上之刑確定。
- 三、使用票據經拒絕往來，尚未期滿。
- 四、受破產宣告或依消費者債務清理條例經裁定開始清算程序，尚未復權。
- 五、受監護或輔助宣告，尚未撤銷。
- 六、曾擔任董事長、董事或監察人，經依第十三條

第一項第三款或第二十七條第二項規定解任。

第 13 條 長照機構法人之董事長、董事或監察人於任期中有下列情形之一者，當然解任：

一、具有書面辭職文件，經提董事會議報告，並列入會議紀錄。

二、具有前條所列情形之一。

三、利用職務或身分上之權力、機會或方法犯罪，經有罪判決確定。

四、董事長一年內無故不召集董事會議。

董事長、董事或監察人為政府機關之代表、其他法人或團體推薦者，其本職異動時，應隨本職進退；其推薦繼任人選，並應經董事會選任，任期至原任期屆滿時為止。

第 14 條 長照機構法人應依公認之會計處理準則建立會計制度，會計基礎採權責發生制，會計年度為曆年制。

長照機構法人應於每年五月三十一日前，將前一會計年度之財務報告經董事會通過，並經監察人查核後，報主管機關備查。

前項財務報告編製準則，由中央主管機關定之。

長照機構法人所登記之財產總額或該法人及其所設立機構之年度收入總額達新臺幣三千萬元以上者，其財務報告應經會計師查核簽證。

長照機構法人之財務報告，應依中央主管機關公告之方式，主動公開；變更時，亦同。

第 15 條 主管機關為確保服務品質及保障服務使用者權益，得檢查長照機構法人之財務、業務狀況，或令其提出財務、業務報告及其他相關文件；長照機構法人不得規避、妨礙或拒絕。

第 16 條 長照機構法人不得為公司之無限責任股東、有限合夥之普通合夥人或合夥事業之合夥人；其為公司之有限責任股東或有限合夥之有限合夥人時，投資總額及對單

一公司或有限合夥之投資金額或投資比率，不得超過一定之限制。

長照機構法人因前項之投資，以盈餘或公積增資配股所得之股份，不計入投資總額及對單一公司、有限合夥之投資金額。

第一項長照機構法人所有投資總額限制：

一、長照機構法人淨值總額未達應有之資本額者，不得投資。

二、長照機構法人淨值總額超過資本額，而未達資本額二倍者，得投資淨值總額超過資本額部分之百分之四十。

三、長照機構法人淨值總額超過資本額達二倍以上者，得投資淨值總額超過資本額二倍部分之百分之六十。

長照機構法人對單一公司之投資額，不得超過公司實收股本之百分之二十。但長照機構法人配合政府政策投資之事業，經中央主管機關專案核准者，不在此限。

長照機構法人不得投資衍生性金融商品。

第 17 條 長照機構法人之財產，應以法人名義登記或儲存。長照機構法人於辦理第二十八條第一項、第三十六條第一項提撥後，其對外捐贈達中央主管機關公告之一定金額或其資產之一定比率，為長照機構財團法人者，應事先報主管機關核准；為長照機構社團法人者，應事先報主管機關備查。

長照機構財團法人非經主管機關核准，不得對其不動產為買賣、設定負擔、出租、出借、變更用途或對其設備為設定負擔。

第 18 條 長照機構法人不得為保證人。

長照機構法人之資金，不得貸予任何人，亦不得以其資產為任何人提供擔保。

第 19 條 長期照顧服務法第六十二條所定之長照有關機構，

於本條例施行後五年內，依本條例設立登記為長照機構法人，並將原供作長照服務使用之土地於上開設立登記期限無償移轉該長照機構法人續作原來之用途者，得申請不課徵土地增值稅。但於再次移轉第三人時，以該土地無償移轉前之原規定地價或前次移轉現值為原地價，計徵土地增值稅。

第 20 條 長照機構法人經主管機關許可，得與其他同質性之長照機構法人合併之；其合併後法人之長照機構區域、分類、家數及規模，應符合第七條規定。長照機構法人經主管機關許可合併後，應於十四日內造具並公告有關合併之財務報告及財產目錄；對已知債權人並應個別通知；債權人對合併有異議者，應於公告後二個月內以書面提出異議，未提出異議者，視為承認合併。

長照機構法人不為前項之通知及公告，或對於在指定期間內提出異議之債權人不為清償，或不提供相當擔保者，不得以其合併對抗債權人。

因合併而消滅之長照機構法人，其權利義務由合併後存續或另立之長照機構法人概括承受。

長照機構法人合併後，應由存續、新設或消滅法人向各該法人之設立登記機關辦理變更、設立或解散登記。

長照機構法人合併之條件、許可程序、許可之廢止、撤銷及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 21 條 依本條例設立之長照機構法人，始得使用長照機構法人或類似之名稱。

長照機構法人名稱，不得使用與他長照機構法人相同或易於使人誤認與政府機關、其他公益團體有關之名稱。

長照機構法人所設機構，應標示其長照機構法人名稱。

第 22 條 長照機構法人辦理不善、違反法令或設立許可條件者，主管機關得視其情節予以糾正、限期整頓改善、停止其全部或一部之業務或廢止其許可。

長照機構法人有下列情形之一者，主管機關得廢止其許可：

- 一、經許可設立後，未依其設立計畫書設立機構住宿式服務長照機構，或設立計畫變更未報主管機關許可，經主管機關令其限期改善，屆期未改善。
- 二、因自有資產減少或其所設機構歇業、變更或被廢止許可，致未符合中央主管機關依第八條第二項所為之公告，經主管機關令其限期改善，屆期未改善。

第二節 長照機構財團法人

第 23 條 長照機構財團法人之設立，應檢具捐助章程、設立計畫書及相關文件，向主管機關申請許可。

前項申請經許可後，捐助人或遺囑執行人應於三十日內依捐助章程遴聘董事，成立董事會，並將董事名冊於董事會成立之日起三十日內，報請主管機關核定；於經核定後三十日內，應向該管地方法院辦理法人登記，並自法院發給登記證書後十五日內，將證書影本送主管機關備查。登記事項變更時，亦同。

捐助人或遺囑執行人，應於長照機構財團法人向法院完成登記之日起三個月內，將所捐助之全部財產移歸該長照機構財團法人所有，並報主管機關備查。

捐助人或遺囑執行人未於期限內將捐助財產移歸長照機構財團法人所有，主管機關應限期令其完成，屆期仍未完成者，得廢止其許可。

第 24 條 長照機構財團法人捐助章程應記載事項如下：

- 一、目的、名稱、主事務所及分事務所。
- 二、捐助財產之種類、總額及保管運用方法。

三、業務項目。

四、董事、監察人之人數、資格、產生方式、任期及任免。

五、董事長之產生方式、任期及任免。

六、董事會之組織、職權及決議方法。

七、定有存立時期者，其時期。

八、解散之事由及其賸餘財產之歸屬。

九、訂定捐助章程之年、月、日。

以遺囑捐助設立者，其遺囑未載明前項規定時，由遺囑執行人訂定捐助章程。

第 25 條 長照機構財團法人之董事會，由董事七人至十七人組成之。

董事長由董事互選，連選得連任一次。董事配置規定如下：

一、具長期照顧服務法所定長照服務人員（以下稱長照人員）資格者，至少一人。

二、社會公正人士代表至少一人。

三、由外國人擔任者，不得逾三分之一，且不得擔任董事長。

四、董事相互間，有配偶、三親等以內親屬之關係者，不得逾四分之一。

長照機構財團法人所設立之長照機構為跨縣市者，得由其全體員工選任代表至少一人擔任前項董事。

董事之任期，每屆不得逾四年，連選得連任。但連選連任董事，每屆不得逾四分之三。

董事任期屆滿前，因辭職、死亡，或因故無法執行職務被解任者，應選任他人繼任，至原任期屆滿為止；繼任人員經補選為董事長者，該任期應計入連任次數。

第 26 條 長照機構財團法人捐助章程及登記事項之變更，應報主管機關許可；解散時，亦同。

前項之變更，應於主管機關許可後三十日內，向該

管法院辦理變更或解散登記。

第 27 條 長照機構財團法人之董事，任期屆滿未能改選或出缺未能補任，致有妨礙董事會組織健全之虞者，主管機關得依其他董事、利害關係人之申請或依職權，選任董事充任之；其選任辦法，由中央主管機關定之。

長照機構財團法人之董事違反法令或捐助章程，致有損害該法人或其所設機構之利益，或有不能正常運作之虞者，主管機關得依其他董事或利害關係人之申請或依職權，命令該董事暫停行使職權或解任之。

前項命令董事暫停行使職權之期間，不得逾六個月。於暫停行使職權之期間內，因人數不足致有妨礙董事會組織健全之虞者，主管機關應選任臨時董事暫代之。選任臨時董事毋需變更登記；其選任，準用第一項選任辦法之規定。

第 28 條 長照機構財團法人應提撥其前一會計年度收支結餘之百分之十以上，辦理有關研究發展、長照宣導教育、社會福利；另應提撥百分之十以上辦理提升員工薪資待遇及人才培訓。

長照機構財團法人從事社會福利者，屬前項應提撥收支結餘辦理之事項。

第 29 條 長照機構財團法人應依中央主管機關公告之方式，主動公開下列資訊；其公開之事項變更者，亦同：

一、捐助章程。

二、董事及監察人姓名。

三、年度業務報告。

四、經主管機關備查之年度財務報告。

五、其他為利公眾監督之必要，經主管機關指定應限期公開之資訊。

第三節 長照機構社團法人

第 30 條 長照機構社團法人之設立，應檢具組織章程、設立計畫書及相關文件，向主管機關申請許可後，於三十日

內依其組織章程成立董事會，並依下列規定辦理：

- 一、以公益為目的之長照機構社團法人，應將董事名冊於董事會成立之日起三十日內，報主管機關核定；於經核定後三十日內，向該管地方法院辦理法人登記，並自法院發給登記證書後十五日內，將證書影本報主管機關備查。
- 二、前款以外之長照機構社團法人，應將董事名冊於董事會成立之日起三十日內，報主管機關登記後，發給法人登記證明。

第 31 條 長照機構社團法人組織章程應記載事項如下：

- 一、目的、名稱、主事務所及分事務所。
- 二、財產總額。
- 三、業務項目。
- 四、董事、監察人之人數、資格、產生方式、任期及任免。
- 五、董事長之產生方式、任期及任免。
- 六、董事會之組織、職權及決議方法。
- 七、社員資格之取得及喪失。
- 八、社員之出資、結餘與虧損之分派及表決權。但以公益為目的之長照機構社團法人，免予記載結餘之分派。
- 九、解散之事由及其賸餘財產之歸屬。
- 十、訂定組織章程之年、月、日。

第 32 條 長照機構社團法人每一社員均有一表決權。但得以組織章程訂定，按出資多寡比率分配表決權。

長照機構社團法人得於組織章程中規定，社員按其出資額保有對法人之財產權利，並得將其持分全部或部分轉讓於第三人。

長照機構社團法人之社員擔任董事或監察人，將其持分轉讓於第三人時，應報主管機關備查；轉讓全部持分之董事或監察人，當然解任。

第一項但書及前二項規定，於以公益為目的之長照機構社團法人，不適用之。

第 33 條 長照機構社團法人之董事會，由董事三人至十七人組成之。但以公益為目的之長照機構社團法人，不得少於七人。

董事長由董事互選，連選得連任。董事配置規定如下：

一、具長照人員資格者至少一人。

二、由營利法人社員指定代表及外國人擔任者，其人數合計不得逾總名額之三分之一，且不得擔任董事長。

第 34 條 長照機構社團法人組織章程及登記事項之變更，應報主管機關許可；解散時，亦同。

以公益為目的之長照機構社團法人為前項之變更，應於主管機關許可後三十日內，向該管法院辦理變更或解散登記。

第 35 條 長照機構社團法人之董事，任期屆滿未能改選或缺未能補任，致有妨礙董事會組織健全之虞者，主管機關得依其他董事、利害關係人之申請或依職權，命令限期召開臨時社員總會補選之。總會逾期不能召開時，主管機關得選任董事擔任之；其選任辦法，由中央主管機關定之。

長照機構社團法人之董事違反法令或組織章程，致有損害該法人或其所設機構之利益或有不能正常營運之虞者，主管機關得依其他董事或利害關係人之申請或依職權，命令解任之。

長照機構社團法人之董事會決議違反法令或組織章程，致有損害該法人或其所設機構之利益，或有不能正常運作之虞者，主管機關得依職權，命令解散董事會，由監察人召開社員總會重新改選之。

第 36 條 長照機構社團法人應提撥前一會計年度收支結餘之

百分之十以上，辦理有關研究發展、人才培訓、長照宣導教育及社會福利；另應提撥百分之二十以上作為營運資金。

以公益為目的之長照機構社團法人從事社會福利者，屬前項應提撥收支結餘辦理之事項。

長照機構社團法人結餘之分配，應依第一項規定提撥後，始得為之。但以公益為目的之長照機構社團法人，不得為結餘之分配。

第三章 罰則

第 37 條 長照機構法人違反第十八條第一項規定為保證人者，由主管機關處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善者，得按次處罰。其所為之保證，並由行為人自負保證責任。

長照機構法人違反第十八條第二項規定，由主管機關處董事長新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，長照機構法人如有因而受損害時，行為人並應負賠償責任。

第 38 條 長照機構社團法人之董事或監察人違反第三十二條第三項規定，未報主管機關備查者，由主管機關處該董事或監察人新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

第 39 條 有下列各款情形之一者，由主管機關處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善者，並得按次處罰：

- 一、長照機構法人違反第十四條第二項、第四項、第十五條或第十七條規定。
- 二、長照機構法人違反第十六條第一項、第三項至第五項規定。
- 三、長照機構財團法人違反第二十八條第一項所定之提撥比率。
- 四、長照機構社團法人違反第三十六條第一項所定之提撥比率。

第 40 條 違反第二十一條長照機構法人名稱使用規定者，由

主管機關處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善者，並得按次處罰。

第 41 條 長照機構財團法人違反第二十九條規定未為資訊公開者，由主管機關限期令其改善；屆期未改善者，處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰。

第 42 條 有下列各款情形之一者，由主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並限期令其改善；屆期未改善者，並得按次處罰：

一、長照機構法人合併後，存續、新設或消滅法人未依第二十條第五項規定辦理變更、設立或解散登記。

二、長照機構財團法人未依第二十三條第二項規定報主管機關備查。

三、長照機構財團法人之捐助人或遺囑執行人未依第二十三條第三項規定報主管機關備查。

四、長照機構財團法人未依第二十六條第一項規定報主管機關許可，或未依第二十六條第二項規定辦理變更或解散登記。

五、長照機構社團法人未依第三十條第一款規定報主管機關備查。

六、長照機構社團法人未依第三十四條第一項規定報主管機關許可，或未依第三十四條第二項規定辦理變更或解散登記。

第 43 條 有下列各款情形之一者，由主管機關限期令其改善，屆期未改善者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；經再限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰：

一、長照機構法人其董事會或監察人違反第十條第一項至第四項規定。

二、長照機構財團法人違反第二十五條第一項至第三項、第五項或第六項規定。

三、長照機構社團法人違反第三十三條規定。

第四章附則

- 第 44 條 本條例施行前，已依其他法律設立且辦理社會福利事項或醫事服務之財團法人、公益社團法人或醫療法人，經依其設立之各該法律規定辦理章程及登記事項變更，並報經主管機關許可者，得依長期照顧服務法規定設立機構住宿式長照服務機構。
- 第 45 條 前條法人之管理，除應符合其他法律規定外，準用第七條、第八條、第十四條至第十六條及第十八條規定；其有違反第八條規定者，依第二十二條規定辦理；有違反第十四條至第十六條或第十八條規定者，分別依第三十七條或第三十九條規定處罰之。
- 第 46 條 本條例施行細則，由中央主管機關定之。
- 第 47 條 本條例自公布日施行。

附錄七、長期照顧服務機構法人條例施行細則

長期照顧服務機構法人條例施行細則

中華民國 107 年 7 月 25 日衛生福利部衛部顧字第 1071961343 號令
訂定發布全文 23 條；並自發布日施行

- 第 1 條 本細則依長期照顧服務機構法人條例(以下稱本條例)第四十六條規定訂定之。
- 第 2 條 申請許可設立長期照顧服務機構(以下稱長照機構)法人，應依本條例第四條規定，向主事務所所在地之直轄市、縣(市)主管機關辦理。但其所設立之長照機構有跨直轄市、縣(市)行政區域時，其主事務所所在地之直轄市、縣(市)政府，應會商各機構所在地直轄市、縣(市)主管機關，擬具意見後報中央主管機關許可。
- 第 3 條 長照機構法人依本條例第十條第二項規定置監察人，除章程另有規定外，其職權如下：
- 一、財務之監察。
 - 二、財務帳冊、文件及財產資料之監察。
 - 三、決算報告之監察。
 - 四、其他章程規定事項之監察。
- 監察人獨立行使職權。監察人集會時，由常務監察人召集。
- 監察人會議得決議授權常務監察人執行第一項所定之職權。
- 公益監察人對監察人會議決議事項有不同意見，得要求將其意見記明於會議紀錄。
- 監察人有不適任情事時，長照機構法人得依章程所定程序解任，並報主管機關核定。
- 監察人因執行職權所需之必要費用，應由長照機構法人負擔。
- 第 4 條 本條例第十條第五項所定財產總額、第十四條第四項所定財產總額及第十六條第三項所定資本額，於

長照機構財團法人，為該法人設立時捐助之財產總額及設立後增加之永久受限淨值。

本條例第十四條第四項及第三十一條第二款所定財產總額，於長照機構社團法人，為其資本額。

第 5 條 依本條例第十九條規定，設立登記為長照機構法人者，於申請不課徵土地增值稅時，應檢具下列文件、資料，向主管稽徵機關辦理：

一、原長照有關機構設立許可證書或開業執照影本。

二、主管機關許可設立登記為長照機構法人之許可函影本。

三、長照有關機構所在地主管機關出具之原使用土地範圍之證明文件。

四、移轉後繼續作為長期照顧服務使用之承諾書。

第 6 條 本條例第二十一條第一項所定長照機構法人之名稱，應載明長照機構法人之文字。

第 7 條 申請許可設立長照機構財團法人，應由捐助人或遺囑執行人檢具下列文件、資料，依第二條規定辦理：

一、申請書。

二、捐助章程。以遺囑捐助設立者，並應檢附其遺囑影本。

三、設立計畫書，包括營運資金來源說明及設立後二年內之營運計畫財務推估。

四、捐助人名冊、捐助財產清冊、財產證明文件影本，及捐助人同意於法人登記成立時，將捐助之財產移轉為法人所有之承諾書。

五、其他經主管機關指定之必要文件。

第 8 條 長照機構財團法人依本條例第二十三條第二項規定，報主管機關核定時，應檢具下列文件、資料：

一、主管機關許可設立函影本。

二、捐助章程。

三、董事會成立之會議紀錄。

四、法人及董事印鑑。

五、董事、監察人名冊與願任同意書及其身分證明文件影本。

第 9 條 長照機構財團法人應於董事會通過捐助章程變更後三十日內，檢具原捐助章程與變更後條文對照表及董事會議決議通過之會議紀錄，報主管機關許可。

第 10 條 長照機構財團法人登記事項如有變更，應於發生之日起三十日內，檢具有關文件、資料，報請主管機關許可。

第 11 條 長照機構財團法人解散前，應檢具下列文件、資料，報主管機關許可：

一、解散之事由及其相關文件。

二、董事會通過解散之會議紀錄。

三、財產清冊及資產負債表。

四、賸餘財產之處理。

五、其他經主管機關指定之必要文件。

第 12 條 長照機構財團法人之董事或利害關係人，依本條例第二十七條第二項申請主管機關命令董事暫停行使職權或解任時，應檢具下列文件、資料：

一、為該長照財團法人之董事或利害關係人證明文件。

二、敘明本條例第二十七條第二項所定情事之說明書。

三、其他經主管機關指定之必要文件。

前項申請人，得一併推薦臨時董事候選人，並應以書面載明被推薦人之相關資料、推薦理由及檢具必要之證明文件。

第 13 條 主管機關依本條例第二十七條第三項選任之臨時董事，其任期以暫停行使職權董事之期間為限。

第 14 條 申請許可設立長照機構社團法人，應由其發起人代表檢具下列文件、資料，依第二條規定辦理：

- 一、申請書。
- 二、組織章程。
- 三、設立計畫書，包括營運資金來源說明及設立後二年內之營運計畫財務推估。
- 四、發起人會議紀錄。
- 五、社員名冊。
- 六、社員出資額及持分比率。但以公益為目的之長照機構社團法人，以捐助財產代替出資者，得以捐助財產代之。
- 七、其他經主管機關指定之必要文件。

第 15 條 長照機構社團法人依本條例第三十條第一款或第二款規定，報主管機關核定或登記時，應檢具下列文件、資料：

- 一、主管機關許可設立函影本。
- 二、組織章程。
- 三、社員總會成立會議紀錄。
- 四、董事會成立會議紀錄。
- 五、法人及董事印鑑。
- 六、董事、監察人名冊與願任同意書及其身分證明文件。
- 七、其他經主管機關指定之文件。

第 16 條 非以公益為目的之長照機構社團法人，依本條例第三十條登記或依本條例第三十四條申請變更登記之資本額，應經會計師查核簽證。

第 17 條 本條例第三十條第二款所定報主管機關登記，其應登記之事項如下：

- 一、法人設立目的及名稱。
- 二、主事務所及分事務所。
- 三、董事長、董事、監察人之姓名及住所。

四、財產總類及數額。

五、設立機構之所在地、類別及規模。

六、財產總額及各社員之出資額。

七、許可之年、月、日。

第 18 條 本條例第三十條第二款非以公益為目的之長照機構社團法人設立登記後，應發給社員持分單；其持分單應予編號，並載明下列事項：

一、法人名稱。

二、設立登記之年、月、日。

三、社員姓名及其出資額。

四、發給持分單之年、月、日。

前項持分單，應由全體董事簽名或蓋章。

第 19 條 長照機構社團法人登記事項之變更，應自事實發生日起三十日內，檢具董事會議決議通過之會議紀錄及相關證明文件，報主管機關許可。

第 20 條 長照機構社團法人解散前，應檢具下列文件、資料，報主管機關許可：

一、解散之事由及其相關文件。

二、社員總會通過解散之會議紀錄。

三、財產清冊及資產負債表。

四、財產之處理。

五、其他經主管機關指定之文件、資料。

第 21 條 長照機構社團法人之董事或利害關係人，依本條例第三十五條第二項申請主管機關命令解任董事時，應檢具下列文件、資料：

一、為該長照社團法人董事或利害關係人之證明文件。

二、敘明本條例第三十五條第二項所定情事之說明或文件、資料。

第 22 條 本條例與本細則所定之申請、報請核定、許可、備查及相關作業，所應檢具之文件格式，主管機關得指定

以電子方式辦理或下載。

第 23 條 本細則自發布日施行。

附錄八、專科護理師於醫師監督下執行 醫療業務辦法

專科護理師於醫師監督下執行醫療業務辦法

1. 中華民國 104 年 10 月 19 日衛生福利部衛部照字第 1041561723 號令訂定發布全文 8 條，自 105 年 1 月 1 日施行
2. 中華民國 106 年 5 月 8 日衛生福利部衛部照字第 1061560785 號令修正發布第 8 條條文及第 3 條附表；並自發布日施行

第 1 條 本辦法依護理人員法(以下稱本法)第二十四條第四項規定訂定之。

第 2 條 本法第二十四條第三項所稱監督，指由專科護理師及接受專科護理師訓練期間之護理師(以下稱專師及訓練專師)，執行醫療業務前或過程中，醫師對其所為之指示、指導或督促。

前項監督，不以醫師親自在場為必要。

第 3 條 專師及訓練專師於醫師監督下得執行之醫療業務(以下稱監督下之醫療業務)，其範圍如下：

一、涉及侵入人體者：

- (一)傷口處置。
- (二)管路處置。
- (三)檢查處置。
- (四)其他處置。

二、未涉及侵入人體者：

- (一)預立特定醫療流程所需表單之代為開立。
- (二)檢驗、檢查之初步綜合判斷。
- (三)非侵入性醫療處置。
- (四)相關醫療諮詢。

前項二款醫療業務之項目，規定如附表。

第 4 條 醫療機構以專師及訓練專師執行監督下之醫療業務者，應成立專科護理師作業小組(以下稱作業小組)，由副院長以上人員擔任召集人，護理及醫療部門主管分任副召集人，辦理下列事項：

- 一、訂定專師及訓練專師執行監督下之醫療業務時之標準作業程序，包括監督之醫師、醫囑、紀錄及回報病人狀況與處置結果之機制。
- 二、訂定醫療機構各分科專師及訓練專師可執行前條附表醫療業務範圍之項目及特定訓練。
- 三、審查及確認預立特定醫療流程內容。
- 四、訂定執行預立特定醫療流程之標準作業程序。
- 五、定期檢討專師及訓練專師所執行監督下之醫療業務之適當性及品質。

前項作業小組，得與專科護理師分科及甄審辦法附表三之專科護理師培育單位合併設立之。

第 5 條 專師及訓練專師執行監督下之醫療業務，得由醫師預立特定醫療流程。

預立特定醫療流程之訂定內容，應包括下列事項：

- 一、症狀、病史及身體評估等情境或診斷。
- 二、執行之項目。
- 三、相關處置及措施。
- 四、書寫紀錄。
- 五、監督之醫師及方式。
- 六、專師及訓練專師應具備之特定訓練標準或要件。

第 6 條 預立特定醫療流程經醫療機構核定後實施。

執行預立特定醫療流程，應依第四條第一項第四款之標準作業程序為之。

第 7 條 專師及訓練專師執行預立特定醫療流程後，監督醫師應於二十四小時內完成核簽；執行其他監督下之醫療業務，監督醫師亦應於二十四小時內完成書面醫囑紀錄。

第 8 條 本辦法自中華民國一百零五年一月一日施行。
本辦法修正條文，自發布日施行。

附錄九、護理機構評鑑辦法

護理機構評鑑辦法

1. 中華民國 104 年 7 月 3 日 衛部照字第 1041561140 號

2. 中華民國 106 年 3 月 22 日衛生福利部衛部照字第 1061560543 號

令修正發布全文 12 條；並自發布日施行

第 1 條 本辦法依護理人員法(以下稱本法)第二十三條之第二第三項規定訂定之。

第 2 條 依本法設立之護理機構，均應依本辦法接受中央主管機關辦理之評鑑。

第 3 條 護理機構應至少每四年接受中央主管機關之評鑑一次。但有下列各款情形之一者，從其規定：

一、新設立或停業後復業者，自開業之日起滿一年後之一年內，應接受評鑑。

二、原評鑑合格行政處分經撤銷或廢止，或前一年評鑑結果為不合格者，自行政處分送達之日起一年內，應接受評鑑。

第 4 條 中央主管機關應依下列規定，辦理評鑑工作：

一、訂定評鑑項目之評鑑基準。

二、訂定評鑑作業程序。

三、辦理評鑑說明會。

四、進行評鑑實地訪查，並作成評鑑紀錄。

五、召開評定會議，議決評鑑結果。

六、公告經核定之評鑑結果、有效期間、類別及其他相關事項。

前項第三款及第四款之評鑑業務，中央主管機關得委託專業性或與評鑑業務相關之機構、團體為之。

第一項第二款所定作業程序，應於評鑑實地訪查起始日三個月前公告。

第 5 條 中央主管機關辦理評鑑實地訪查時，得聘請醫護、管理與環境安全之專家學者及具護理機構實務經驗者

為評鑑委員。

評鑑委員應依相關法規規定，遵守利益迴避原則；對評鑑工作所獲悉之各項資訊，應負保密義務，除法規另有規定外，不得洩漏。

第 6 條 護理機構評鑑之項目如下：

- 一、經營管理效能。
- 二、專業照護品質。
- 三、安全維護及設施設備。
- 四、個案權益保障。
- 五、創新照護措施。

護理機構非屬收住式者，其評鑑得不包括前項第三款及第五款所定項目。

第一項評鑑項目之評鑑基準，中央主管機關應於評鑑實地訪查前一年十二月公告之。

第 7 條 護理機構評鑑結果，分為合格及不合格。

前項評鑑結果，其評等類別，中央主管機關得依政策目標或機構類別、特色，於第四條第三項評鑑作業程序定之。

第 8 條 護理機構對評鑑結果不服者，應自收受通知之次日起十四日內，先向中央主管機關提出申復。

護理機構不服前項評鑑申復之決定者，得依法提起訴願及行政訴訟。

第 9 條 評鑑合格效期為四年。

護理機構前一年度評鑑不合格，當年始經評鑑合格者，其合格效期為三年；連續二年評鑑不合格，當年始經評鑑合格者，其合格效期為二年；連續三年評鑑不合格，當年始經評鑑合格者，其合格效期為一年。

第 10 條 護理機構於評鑑合格效期內，經直轄市、縣(市)主管機關認有違反護理機構設立標準或其他法令規定，情節重大或經限期改善而屆期未改善者，中央主管機關得廢止原評鑑處分。

護理機構接受評鑑所提供之文件或資料，有虛偽不實者，中央主管機關得撤銷原評鑑處分。

第 11 條 本辦法施行前，已接受中央主管機關評鑑，且於合格效期內者，應於合格效期已屆最後一年接受評鑑。

第 12 條 本辦法自發布日施行。

附錄十、助產人員法

助產人員法

1. 中華民國 32 年 9 月 30 日國民政府制定公布全文 32 條
2. 中華民國 37 年 12 月 28 日總統令修正公布第 18、19 條條文
3. 中華民國 74 年 5 月 27 日總統令修正公布全文
4. 中華民國 81 年 4 月 27 日總統(81)華總(一)義字第 2154 號令修正公布第 6、27~29、36 條條文
5. 中華民國 89 年 7 月 19 日總統(89)華總一義字第 8900177670 號令修正公布第 3、6、15、41 條條文
6. 中華民國 91 年 6 月 12 日總統華總一義字第 09100119150 號令修正公布第 10、28、32 條條文；增訂第 13-1、39-1、44-1 條條文
7. 中華民國 92 年 7 月 2 日總統華總一義字第 09200121210 號令修正公布名稱及全文 62 條；並自公布日施行（原名稱：助產士法）
中華民國 102 年 7 月 19 日行政院院臺規字第 1020141353 號公告第 4 條所列屬「行政院衛生署」之權責事項，自 102 年 7 月 23 日起改由「衛生福利部」管轄
8. 中華民國 105 年 11 月 30 日總統華總一義字第 10500147041 號令修正公布第 36 條條文
9. 中華民國 106 年 1 月 4 日總統華總一義字第 10500165251 號令修正公布第 4、12、18、34、35、45 條條文；並增訂第 12-1 條條文

第一章 總則

- 第 1 條 中華民國人民，經助產人員考試及格並依本法領有
助產人員證書者，得充助產人員。
- 第 2 條 本法所稱助產人員，指助產師及助產士。
- 第 3 條 具有下列資格之一者，得應助產師考試：
- 一、公立或立案之私立專科學校護理助產合訓科、大學或獨立學院助產學系或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院助產學系、組畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者。
 - 二、領有護理師、護士或助產士證書，於公立或立案之私立大學、獨立學院助產研究所或符合教育部採認規定之國外大學、獨立學院助產研究所畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者。

公立或立案之私立高級醫事職業以上學校助產科、助產特科、護理助產合訓科畢業，並經實習期滿成績及格，領有畢業證書者，得應助產士考試。

第 4 條 本法所稱主管機關：在中央為衛生福利部；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。

第 5 條 經助產人員考試及格者，得請領助產人員證書。

第 6 條 請領助產人員證書，應具申請書及資格證明文件，送請中央主管機關核發之。

第 7 條 有下列情事之一者，不得充助產人員；其已充助產人員者，撤銷或廢止其助產人員證書：

一、曾犯墮胎罪，經判刑確定。

二、曾犯肅清煙毒條例或麻醉藥品管理條例之罪，經判刑確定。

三、曾犯毒品危害防制條例之罪，經判刑確定。

四、受撤銷或廢止助產人員考試及格。

五、依本法受撤銷或廢止助產人員證書處分。

第 8 條 非領有助產師或助產士證書者，不得使用助產師或助產士之名稱。

第二章 執業

第 9 條 助產人員執業，應向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請執業登記，領有執業執照，始得執業。

助產人員執業，應接受繼續教育，並每六年提出完成繼續教育證明文件，辦理執業執照更新。

第一項助產人員執業，其申請執業登記資格、條件、應檢附文件、執業執照發給、補發、換發與其他應遵行事項及前項助產人員接受繼續教育之課程內容、積分、實施方式、完成繼續教育之證明文件、執業執照更新與其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

第 10 條 有下列情事之一者，不得請領執業執照；其已領取者，應撤銷或廢止之：

- 一、經撤銷或廢止助產人員證書。
- 二、經廢止助產人員執業執照未滿一年。
- 三、罹患精神疾病或身心狀況違常，經主管機關認定不能執行業務。

前項第三款原因消失後，仍得依本法規定申請執業執照。

主管機關依第一項第三款規定為認定時，應委請相關專科醫師鑑定。

第 11 條 助產人員非加入所在地助產人員公會，不得執業。

助產人員公會不得拒絕具有會員資格者入會。

第 12 條 助產人員執業登記處所，以一處為限。

助產人員執業，應在所在地主管機關核准登記之助產機構、醫療機構、產後護理機構或其他經中央主管機關認可之機構為之。但急救、執業機構間之支援、應邀出外執行業務或經事先報准者，不在此限。

第 12-1 條 助產人員停業或歇業時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發執業執照機關備查。

前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應辦理歇業。

助產人員變更執業處所或復業者，準用關於執業之規定。

助產人員死亡者，由原發執業執照機關註銷其執業執照。

第三章 助產機構之設置及管理

第 13 條 助產人員得設立助產機構執行業務。

助產人員申請設立助產機構執行業務，須在中央主管機關指定之醫療機構、助產機構執行助產業務二年以上，始得為之。

助產機構之設置標準，由中央主管機關定之。

第 14 條 助產人員申請設立助產機構，應向所在地直轄市或

縣(市)主管機關申請核准登記，發給開業執照。

第 15 條 助產機構應以其申請設立之助產人員為負責人，對其業務負督導責任。

助產機構負責人因故不能執行業務，應指定助產人員代理。代理期間超過一個月者，應報請原發開業執照機關備查。

前項代理期間，最長不得逾一年。

第 16 條 助產機構名稱之使用或變更，應經所在地直轄市、縣(市)主管機關核准。

非助產機構，不得使用助產機構或類似之名稱。

第 17 條 助產機構不得使用下列名稱：

一、在同一直轄市或縣(市)區域內，他人已登記使用之助產機構名稱。

二、在同一直轄市或縣(市)區域內，與被廢止開業執照未滿一年或受停業處分之助產機構相同或類似之名稱。

三、易使人誤認其與政府機關、公益團體有關或有妨害公共秩序或善良風俗之名稱。

第 18 條 助產機構停業、歇業或登記事項變更時，應自事實發生之日起三十日內，報請原發開業執照機關備查。

前項停業之期間，以一年為限；逾一年者，應於屆至日起三十日內辦理歇業。

助產機構未依前項規定辦理歇業時，主管機關得逕予歇業。

助產機構遷移或復業者，準用關於設立之規定。

第 19 條 助產機構收取費用，應開給收費明細表及收據。

助產機構不得違反收費標準，超額或擅立收費項目收費。

前項收費標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定之。

第 20 條 助產機構應將其開業執照、收費標準及其助產人員

證書，揭示於明顯處。

第 21 條 助產機構應保持整潔，秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。

第 22 條 助產機構之廣告內容，以下列事項為限：

一、助產機構之名稱、開業執照字號、地址、電話及交通路線。

二、助產師或助產士之姓名及其證書字號。

三、其他經中央主管機關公告容許登載或宣播之事項。

非助產機構，不得為助產照護業務廣告。

第 23 條 助產機構不得以不正當方法，招攬業務。

助產人員及其助產機構之人員，不得利用業務上之機會，獲取不正當利益。

第 24 條 助產機構應依法令規定或依主管機關之通知，提出報告，並接受主管機關對其人員配置、設備、收費、作業、衛生、安全、紀錄等之檢查及資料蒐集。

第四章 業務及責任

第 25 條 助產人員業務如下：

一、接生。

二、產前檢查及保健指導。

三、產後檢查及保健指導。

四、嬰兒保健指導。

五、生育指導。

六、其他經中央主管機關認定之項目。

助產人員執行相關業務，應製作紀錄。

前項紀錄，由該助產人員之執業機構保存，並至少保存十年。

第 26 條 助產人員執行助產業務時，發現產婦、胎兒或新生兒有危急狀況，應立即聯絡醫師，並予必要之急救處置。

- 第 27 條 助產人員於執行正常分娩之接生時，得依需要施行灌腸、導尿、會陰縫合及給予產後子宮收縮劑等必要事項。
- 第 28 條 助產人員非親自接生，不得出具出生證明書或死產證明書。
- 第 29 條 助產人員不得無故拒絕或遲延接生。
- 第 30 條 助產人員接受衛生、司法或司法警察詢問時，不得為虛偽之陳述或報告。
- 第 31 條 助產人員或助產機構之人員，對於因業務而知悉或持有他人之秘密，不得無故洩漏。

第五章 罰則

- 第 32 條 助產人員將其證照租借他人使用者，廢止其助產人員證書；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。
- 助產人員於業務上有不正當行為者，處一個月以上一年以下之停業處分；其情節重大者，得廢止其執業執照或開業執照；其涉及刑事責任者，並應移送該管檢察機關依法辦理。
- 第 33 條 違反第二十二條規定者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並令限期改善；屆期未改善者，按次連續處罰。
- 第 34 條 違反第十四條、第十六條第二項、第十八條第四項、第十九條第二項、第二十三條、第二十五條第二項、第三項、第二十八條、第三十條或第三十一條規定者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並得令其限期改善；屆期未改善或情節重大者，處一個月以上一年以下之停業處分或廢止其開業執照。
- 違反第十九條第二項規定者，除依前項規定處罰外，並令其限期將超收部分退還；屆期未退還者，按次處罰。

第 35 條 違反第八條、第九條第一項、第二項、第十一條第一項、第十二條、第十二條之一第一項、第十五條第二項、第三項、第十六條第一項、第十八條第一項、第十九條第一項、第二十條、第二十一條、第二十四條、第二十九條或依第十三條第三項所定設置標準者，處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，處一個月以上一年以下之停業處分。

助產人員公會違反第十一條第二項規定者，由人民團體主管機關處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰。

第 36 條 未取得助產人員資格，擅自執行助產業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。但醫師或於婦產科醫師、助產人員指導下實習之助產科、系、所之學生或取得畢業證書日起五年內之畢業生，不在此限。

第 37 條 助產人員受停業處分仍執行業務者，廢止其執業執照；受廢止執業執照處分仍執行業務者，廢止其助產人員證書。

第 38 條 助產機構有下列各款情形之一者，廢止其開業執照：

- 一、容留未具助產人員資格者擅自執行助產業務。
- 二、受停業處分而不停業。

第 39 條 助產機構受停業處分或廢止開業執照者，應同時對其負責人予以停業處分或廢止其執業執照。

助產機構負責人受停業處分或廢止其執業執照時，應同時對該助產機構予以停業處分或廢止其開業執照。

第 40 條 助產機構受廢止開業執照處分，仍繼續開業者，廢止其負責人之助產人員證書。

第 41 條 本法所定之罰鍰，於助產機構，處罰其負責人。

第 42 條 本法所定之罰鍰、停業、撤銷或廢止執業執照、開業執照，除本法另有規定者外，由直轄市或縣(市)主管

機關為之；撤銷或廢止助產人員證書，由中央主管機關為之。

第 43 條 依本法所處之罰鍰，經限期繳納，屆期未繳納者，依法移送強制執行。

第六章 公會

第 44 條 助產人員公會分直轄市及縣(市)公會，並得設助產人員公會全國聯合會。

第 45 條 助產人員公會之區域，依現有之行政區域，在同一區域內，同級之公會以一個為限。但於行政區域調整變更前已成立者，不在此限。

第 46 條 直轄市、縣(市)助產人員公會，由在該管區域內執業助產人員九人以上發起組織之；其不滿九人者，得加入鄰近區域之公會或共同組織之。

第 47 條 助產人員公會全國聯合會應由三分之一以上之直轄市、縣(市)助產人員公會完成組織後，始得發起組織。

第 48 條 各級助產人員公會，由人民團體主管機關主管。但其目的事業，應受主管機關之指導、監督。

第 49 條 各級助產人員公會置理事、監事，均於召開會員(會員代表)大會時，由會員(會員代表)選舉之，並分別成立理事會、監事會，其名額如下：

一、直轄市、縣(市)助產人員公會之理事，不得超過二十一一人。

二、助產人員公會全國聯合會之理事，不得超過二十七人。

三、各級助產人員公會之理事名額，不得超過全體會員(會員代表)人數二分之一。

四、各級助產人員公會之監事名額，不得超過各該公會理事名額三分之一。

各級助產人員公會得置候補理事、候補監事，其名額不得超過各該公會理事、監事名額三分之一。

理事、監事名額在三人以上時，得分別互選常務理事及常務監事；其名額不得超過理事或監事總額三分之一，並應由理事就常務理事中選舉一人為理事長；其不置常務理事者，就理事中互選之。常務監事在三人以上者，應互選一人為監事會召集人。

第 50 條 理事、監事任期均為三年，連選連任者不得超過二分之一；理事長之連任，以一次為限。

第 51 條 助產人員公會全國聯合會理事、監事之當選，不以直轄市、縣(市)助產人員公會選派參加之會員代表為限。

直轄市、縣(市)助產人員公會選派參加助產人員公會全國聯合會之會員代表，不以其理事、監事為限。

第 52 條 助產人員公會每年召開會員(會員代表)大會一次，必要時，得召開臨時大會。

助產人員公會會員人數超過三百人時，得依章程之規定，就會員分布狀況劃定區域，按其會員人數比率選定代表，召開會員代表大會，行使會員大會之職權。

第 53 條 助產人員公會應訂立章程，造具會員名冊及選任職員簡歷名冊，送請所在地人民團體主管機關立案，並分送中央及所在地主管機關備查。

助產人員公會全國聯合會應訂立助產人員倫理規範，提經會員代表大會通過後，報請中央主管機關備查。

第 54 條 公會之章程，應載明下列事項：

一、名稱、區域及會所所在地。

二、宗旨、組織、任務或事業。

三、會員之入會及出會。

四、會員應納之會費及繳納期限。

五、會員代表之產生及其任期。

六、理事、監事名額、權限、任期及其選任、解任。

七、會員(會員代表)大會及理事會、監事會會議之規定。

八、會員應遵守之公約。

九、經費及會計。

十、章程之修改。

十一、其他依法令規定應載明或處理會務之必要事項。

第 55 條 助產人員公會違反法令或章程者，人民團體主管機關得為下列之處分：

一、警告。

二、撤銷其決議。

三、撤免其職員。

四、限期整理。

前項第一款、第二款處分，亦得由主管機關為之。

第 56 條 直轄市、縣(市)助產人員公會對助產人員公會全國聯合會之章程，有遵守義務。

第 57 條 助產人員公會會員有違反法令或章程之行為者，須經會員(會員代表)大會通過之決議處分。

第 58 條 本法中華民國九十二年六月三日修正施行前已立案之省助產士公會，應於本法修正施行之日起四年內辦理解散。

第七章 附則

第 59 條 外國人及華僑得依中華民國法律，應助產人員考試。

前項考試及格，領有助產人員證書之外國人及華僑，在中華民國執行業務，應經中央主管機關許可，並應遵守中華民國關於助產人員之相關法令、專業倫理規範及助產人員公會章程；其執業之許可及管理辦法，由中央主管機關定之。

違反前項規定者，除依法處罰外，中央主管機關並

得廢止其許可。

第 60 條 中央或直轄市、縣(市)主管機關依本法核發證書或執照時，得收取證書費或執照費；其費額，由中央主管機關定之。

第 61 條 本法施行細則，由中央主管機關定之。

第 62 條 本法自公布日施行。

附錄十一、助產人員法施行細則

助產人員法施行細則

1. 中華民國 34 年 7 月 21 日社會部、衛生署會同訂定發布
2. 中華民國 47 年 12 月 15 日內政部修正發布
3. 中華民國 71 年 8 月 24 日行政院衛生署(71)衛署保字第 388540 號令修正發布
4. 中華民國 75 年 2 月 28 日行政院衛生署(75)衛署保字第 579650 號、內政部(75)台內社字第 385133 號令會銜修正發布全文 13 條
5. 中華民國 77 年 9 月 9 日行政院衛生署(77)衛署保字第 739357 號、內政部(77)台內社字第 621517 號令修正發布全文 33 條
6. 中華民國 94 年 7 月 28 日行政院衛生署衛署醫字第 0940223650 號令修正發布名稱及全文 11 條；並自發布日施行(原名稱：助產士法施行細則；新名稱：助產人員法施行細則)

第 1 條 本細則依助產人員法（以下簡稱本法）第六十一條規定訂定之。

第 2 條 依本法第六條規定請領助產人員證書者，應填具申請書，並檢附考試院頒發之助產人員考試及格證書及證書費，送請中央主管機關核發。

第 3 條 助產人員證書滅失或遺失者，應填具申請書，並檢附證書費，向中央主管機關申請補發。助產人員證書損壞者，應填具申請書，並檢附證書費，連同原證書，向中央主管機關申請換發。

第 4 條 助產人員停業、歇業，依本法第十二條第二項規定報請備查時，應填具申請書，並檢附執業執照及有關文件，送由原發給執照機關依下列規定辦理：

一、停業：登記其停業日期及理由後，發還其執業執照。

二、歇業：註銷其執業登記及執業執照。

第 5 條 依本法第十四條規定申請設立助產機構者，應填具申請書，並檢附下列書件及開業執照費，向所在地直轄市、縣（市）主管機關申請核准登記：

一、助產人員證書及其影本一份(正本驗畢後發還)。

二、國民身分證及其影本一份(正本驗畢後發還)。

三、建築物平面配置圖及合法使用證明文件。

四、曾在中央主管機關指定之醫療機構、助產機構執行助產業務二年以上之證明文件。

五、其他主管機關指定應檢附之文件。

直轄市或縣(市)主管機關對於前項之申請，經派員履勘後，核與規定相符者，發給開業執照。

第 6 條 本法第十四條所定助產機構核准登記事項如下：

一、名稱、地址及開業執照字號。

二、負責人之姓名、出生年月日、證書字號、執業執照字號。

三、助產人員人數及其姓名、出生年月日、證書字號、執業執照字號。

四、設立床數。

五、其他必要登記事項。

第 7 條 助產機構開業執照滅失或遺失者，應填具申請書，並檢附開業執照費，向原發開業執照機關申請補發。開業執照損壞者，應填具申請書，並檢附開業執照費，連同原開業執照，向原發開業執照機關申請換發。

第 8 條 助產機構停業、歇業或登記事項變更，依本法第十八條第一項規定報請備查時，應填具申請書，並檢附開業執照及有關文件，送由原發給開業執照機關依下列規定辦理：

一、停業：於其開業執照註明停業日期及理由後發還。

二、歇業：註銷其開業登記及開業執照。

三、登記事項變更：辦理變更登記。

第 9 條 助產機構停業、歇業或受停業、撤銷、廢止開業執照處分者，其所屬助產人員，應申請變更執業處所或依第四條規定辦理停業、歇業。

第 10 條 助產機構歇業或受撤銷、廢止開業執照處分者，其原掛招牌，應予拆除。

第 11 條 本細則自發布日施行。

附錄十二、助產機構設置標準

助產機構設置標準

中華民國 94 年 8 月 3 日行政院衛生署衛署醫字第 0940223640 號令訂定發布全文 6 條；本標準施行日期，除第三條第六款規定自 96 年 1 月 1 日施行外，自發布日施行

- 第 1 條 本標準依助產人員法第十三條第三項規定訂定之。
- 第 2 條 助產機構得依需要設置九床以下之觀察床。觀察床應設聯繫設備及隔離視線之屏障物。
- 第 3 條 助產機構應有下列之基本設備：
- 一、產房。
 - 二、觀察室。
 - 三、觀察床。
 - 四、嬰兒床。
 - 五、產台。
 - 六、保溫箱。
 - 七、消毒鍋。
 - 八、調奶設備。
- 產房及嬰兒床不得設置於地下室。
- 第 4 條 助產機構執行接生業務時，應具備下列藥物及設備：
- 一、接生器材用物。
 - 二、血壓計及聽診器。
 - 三、成人及嬰兒體重計。
 - 四、成人及嬰兒身高測量計。
 - 五、灌腸、導尿器、沖洗器。
 - 六、會陰縫合器材。
 - 七、子宮收縮劑（口服藥及針劑）
 - 八、新生兒用藥膏。
- 第 5 條 助產機構應具備急救下列藥物及設備：
- 一、氧氣。
 - 二、鼻管。

- 三、人工氣道。
- 四、氧氣面罩。
- 五、抽吸設備。
- 六、甦醒袋。
- 七、靜脈點滴設備。
- 八、強心針。

第 6 條 本標準施行日期，除第三條第六款規定自中華民國九十六年一月一日施行外，自發布日施行。

附錄十三、醫事人員執業登記及繼續教育辦法

醫事人員執業登記及繼續教育辦法

1. 中華民國 102 年 7 月 1 日行政院衛生署衛署醫字第 1020269815 號令訂定發布全文 23 條；並自發布日施行
2. 中華民國 104 年 12 月 30 日行政院衛生福利部醫字第 1041668690 號修正發布第 1、2、7、13、14、18、22、23 條並刪除第 12 條
3. 中華民國 105 年 10 月 7 日衛生福利部衛部醫字第 1051666337 號令修正發布第 1、2、13 條條文

第一章 總則

第 1 條 本辦法依醫師法第八條第三項與第四項、藥師法第七條第三項至第四項及第四十條、護理人員法第八條第三項、物理治療師法第七條第三項、職能治療師法第七條第三項、醫事檢驗師法第七條第三項、醫事放射師法第七條第三項、營養師法第七條第三項與第四項、助產人員法第九條第三項、心理師法第七條第三項與第八條第二項、呼吸治療師法第七條第二項與第八條第二項、語言治療師法第七條第三項、聽力師法第七條第三項、牙體技術師法第九條第三項及驗光人員法第七條第三項規定訂定之。

第 2 條 本辦法所稱醫事人員，指醫師、中醫師、牙醫師、藥師、藥劑生、護理師、護士、物理治療師、物理治療生、職能治療師、職能治療生、醫事檢驗師、醫事檢驗生、醫事放射師、醫事放射士、營養師、助產師、助產士、心理師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、牙體技術師及牙體技術生、驗光師及驗光生。

本辦法所稱多重醫事人員，指領有二種以上醫事人員證書者。

第二章 執業登記

第 3 條 領有醫事人員證書，且未有各該醫事人員法律所定不得發給執業執照情形之一者，得申請醫事人員執業登

記。

第 4 條 醫事人員申請執業登記，應填具申請書，並檢附下列文件及繳納執業執照費，向所在地直轄市、縣(市)主管機關申請，發給執業執照：

- 一、醫事人員證書正本及其影本一份（正本驗畢後發還）。
- 二、身分證明文件影本一份。
- 三、最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張。
- 四、擬執業機構出具之證明文件。
- 五、執業所在地醫事人員公會會員證明文件。
- 六、完成第十三條第一項各款繼續教育之證明文件。
- 七、中央主管機關發給且仍在有效期間內之專科醫事人員證書。但醫事人員無專科制度者，得免檢附。

第 5 條 醫事人員申請執業登記，有下列情形之一者，得免檢具前條第六款規定之文件：

- 一、領得醫事人員證書五年內申請執業登記。
- 二、物理治療師(生)或職能治療師(生)於中華民國九十七年五月二十三日、護理師及護士於九十七年六月二十日前，已取得該類醫事人員證書，且於該日期起算五年內申請首次執業登記。
- 三、醫事人員歇業後重新申請執業登記之日期，未逾原執業處所執業執照所載應更新日期。

第 6 條 醫事人員申請執業登記，其依第四條第六款所定繼續教育證明文件，有下列情形之一者，得以該類醫事人員申請執業登記前一年內接受第十三條第一項各款繼續教育課程總積分達六分之一以上之證明文件代之：

- 一、領得醫事人員證書逾五年，首次申請執業登記。
- 二、醫事人員於下列各目日期前，已取得各該類醫事人員證書，且逾該日期起算五年始申請首次

執業登記：

- (一) 醫事檢驗師(生)或醫事放射師(士)：中華民國八十九年七月十一日。
- (二) 心理師：九十二年三月十九日。
- (三) 呼吸治療師：九十二年五月十三日。
- (四) 營養師：九十四年四月八日。
- (五) 助產師(士)：九十四年四月十五日。
- (六) 物理治療師(生)或職能治療師(生)：九十七年五月二十三日。
- (七) 護理師及護士：九十七年六月二十日。

三、醫事人員連續歇業期間逾二年。於具有多重醫事人員或兼具有師級及生(士)級之同一類醫事人員資格者，須分別均逾二年。

專科醫師依前項規定應備之文件，得以申請執業登記前一年內接受第十三條第一項第二款至第四款所定繼續教育課程積分達三點以上之證明文件代之，不受前項規定之限制。

第 7 條 醫事人員辦理執業執照更新，應於其執業執照應更新日期屆滿前六個月內，填具申請書，並檢具下列文件及繳納執業執照費，向原發執業執照機關申請換領執業執照：

- 一、原領執業執照。
- 二、最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張。
- 三、執業所在地醫事人員公會會員證明文件。
- 四、完成第十三條第二項所定繼續教育之證明文件或下列其他相關證明文件：
 - (一)專科醫師、專科牙醫師：完成第十三條第二項第二款第二目所定繼續教育之證明文件。
 - (二)專科護理師：中央主管機關發給，且仍在有效期間內之專科護理師證書。

醫師符合下列各款情形，除應依前項規定辦理外，

並應檢具畢業後 綜合臨床醫學訓練(以下稱一般醫學訓練)證明文件：

- 一、中華民國一百零八年七月一日以後始領有醫師證書，且未領有專科醫師證書者。
- 二、於首次辦理執業執照更新時，或因歇業逾首次執業執照應更新日期，於新發給之執業執照更新時。

第 8 條 領得醫事人員證書未逾五年而申請執業登記者，其執業執照之更新日期為自各該證書發證屆滿第六年之翌日。

中華民國九十七年五月二十三日已取得物理治療師(生)或職能治療師(生)證書，且於該日期起算五年內，申請執業登記者，其執業執照之更新日期不得逾一百零三年五月二十二日。

九十七年六月二十日前已取得護理師或護士證書，且於該日期起算五年內，申請執業登記者，其執業執照之更新日期不得逾一百零三年六月十九日。

醫事人員歇業後重新申請執業登記，執業登記日期未逾原發執業執照所載應更新日期者，以該日期為新發執業執照應更新日期；逾原發執業執照所載應更新日期者，其執業執照應更新日期自執業登記日期起算六年。但依第六條規定辦理執業登記者，其執業執照之更新日期為自執業登記屆滿第六年之翌日。

醫事人員辦理執業執照更新，其新發之執業執照應更新日期為自原發執業執照屆滿第六年之翌日。

第 9 條 醫事人員執業執照滅失或遺失時，應填具申請書、具結書，繳納執業執照費並檢具最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張，向原發執業執照機關申請補發。

醫事人員執業執照損壞時，應填具申請書，繳納執業執照費並檢具最近三個月內之一吋正面脫帽半身照片二張及原執業執照，向原發執業執照機關申請換發。

第 10 條 醫事人員停業及歇業之程序及應備文件等相關事項，依各該醫事人員法律施行細則之規定辦理。

醫事人員停業後申請復業，應檢具原執業執照，向原發執業執照機關辦理。

第 11 條 具有多重醫事人員資格者，得依其多重身分同時辦理執業登記，並應符合下列規定：

一、執業登記場所，以同一處所為限；執業場所並應符合各該醫事人員執業場所相關設置標準之規定，該場所依法規得供該類醫事人員辦理執業登記。

二、應依法律規定分別加入各該醫事人員公會，且應分別完成第十三條第一項各款所定之繼續教育積分。

三、擇一資格為其主要執業類別，據以計算其執業之場所相關設置標準規定應具備之人力。

四、停業、歇業或報准前往其他處所執行業務，應以主要執業登記類別辦理。

五、兼具師級及士(生)級之同一類醫事人員資格者，其執業登記僅得擇一資格辦理。

具有醫師、中醫師、牙醫師等多重醫事人員資格者，其執業登記，依具有多重醫事人員資格者執業管理辦法之規定辦理，不適用前項規定。

第 12 條 (刪除)

第三章 繼續教育

第 13 條 醫事人員執業，應接受下列課程之繼續教育：

- 一、專業課程。
- 二、專業品質。
- 三、專業倫理。
- 四、專業相關法規。

醫事人員每六年應完成前項繼續教育課程之積分數如下：

一、物理治療生、職能治療生、醫事檢驗生、醫事放射士、牙體技術生及驗光生：

(一) 達七十二點。

(二) 前項第二款至第四款繼續教育課程之積分數，合計至少七點，其中應包括感染管制及性別議題之課程；超過十四點者，以十四點計。

二、前款以外之醫事人員：

(一) 達一百二十點。

(二) 前項第二款至第四款繼續教育課程之積分數，合計至少十二點，其中應包括感染管制及性別議題之課程；超過二十四點者，以二十四點計。

兼具醫師、中醫師、牙醫師多重醫師資格者變更資格申請執業登記時，對於第一項第二款至第四款繼續教育課程積分，應予採認；對於第一項第一款性質相近之專業課程積分，得相互認定。

第 14 條 醫事人員繼續教育之實施方式及其積分，如附表。前項及前條第一項、第二項之繼續教育課程及積分，應由經中央主管機關認可之醫事人員團體辦理審查認定及採認。

第 15 條 申請認可辦理前二條繼續教育課程與積分審查認定及採認之各該類醫事人員團體，應符合下列規定：

一、為全國性之醫事人員學會、各該類醫事人員相關學會或公會。

二、設立滿三年。

三、會員中各該類醫事人員全國執業人數，應達下列各目比率或人數之一：

(一) 醫師及助產人員：百分之十以上。

(二) 中醫師及醫事放射師：百分之四十以上。

(三) 護理人員：三千人以上。

(四) 前三目以外醫事人員：百分之二十以上。

各該類醫事人員團體申請前二條認可，應檢具申請函及包括下列文件、資料之計畫書，向中央主管機關提出，經核定後，始得為之：

- 一、設立證明文件、組織章程、組織概況及會員人數資料。
- 二、醫事人員繼續教育課程與積分採認人力配置、處理流程、委員會組成、職責及會議召開之作業方式。
- 三、醫事人員繼續教育課程及積分採認之作業監督方法。
- 四、醫事人員繼續教育課程及積分採認之相關文件保存。
- 五、醫事人員繼續教育課程品質管理方式。
- 六、收費項目及金額。
- 七、其他經中央主管機關指定之文件、資料。

第 16 條 中央主管機關受理前條申請之審查，得至該醫事人員團體實地訪查作業情形。

第 17 條 經認可得辦理完成繼續教育積分審查認定及繼續教育課程與積分採認業務之醫事人員團體，應依核定之計畫書，辦理醫事人員繼續教育課程及積分採認與收費；並適時查核採認之課程，確實依其申請之課程內容實施。

第 18 條 經認可之醫事人員團體有下列情事之一者，中央主管機關得廢止其認可：

- 一、未依規定或計畫書審查醫事人員繼續教育課程及積分，情節重大。
- 二、未依計畫書收費項目及金額收費，致生超收費用或擅立項目收費。
- 三、規避、妨礙或拒絕中央主管機關之查核。

四、不符合第十五條第一項第三款規定。

違反前項第一款規定，未依規定採認之醫事人員繼續教育課程及積分，不生採認之效果。

經中央主管機關依第一項規定廢止認可之醫事人員團體，一年內不得重新申請認可。

第 19 條 第十三條第一項第一款所定繼續教育積分，於專科醫師，依專科醫師分科及甄審辦法之規定。

專科醫師於中華民國九十六年八月十七日醫師執業登記及繼續教育辦法修正施行前，已依專科醫師分科及甄審辦法，規定取得之專業品質、專業倫理或專業相關法規課程之積點，合於本辦法規定者，得予採認。

專科護理師依專科護理師分科及甄審辦法規定參加課程或訓練取得之積點，合於本辦法規定者，得予採認。

第 20 條 醫事人員受懲戒處分應接受一定時數繼續教育者，不得以本辦法所定應接受之繼續教育抵充。

第四章 附則

第 21 條 本辦法施行前，已領有執業執照之醫事人員，其應辦理執業執照更新日期，依原發執業執照所載應更新日期。

第 22 條 本辦法施行前，已依各該類醫事人員執業登記及繼續教育辦法規定，申請認可為各該類醫事人員繼續教育積分審查認定及繼續教育課程與積分採認之醫事人員團體者，免依第十五條規定，重新提出申請認可。

本辦法修正施行前，已依藥師執業登記及繼續教育辦法所採認之繼續教育課程及積分，得由原審查認定及採認之醫事人員團體，依第十三條規定，辦理課程及積分之分類。

第 23 條 本辦法自發布日施行。

中華民國一百零四年十二月三十日修正發布之條

文，除第十三條第二項第二款第二目所定醫事人員為藥師及藥劑生者，自一百零六年一月一日施行外，自發布日施行。

附表 醫事人員繼續教育之實施方式及積分表

實施方式	積分
一、專科以上學校、醫學會、學會、公會、協會、財團法人、教學醫院、主管機關或政府機關舉辦之專業相關繼續教育課程。	(一)參加者，每小時積分一點。 (二)擔任授課者，每小時積分五點。
二、公開徵求論文及審查機制之各該類醫事人員學術研討會。	(一)參加者，每小時積分二點。 (二)發表論文或壁報者，每篇第一作者積分三點，其他作者積分一點。 (三)擔任特別演講者，每次積分十點。
三、公開徵求論文及審查機制之相關醫學會、學會、公會或協會舉辦之學術研討會。	(一)參加者，每小時積分一點。 (二)發表論文或壁報者，每篇第一作者積分二點，其他作者積分一點。 (三)擔任特別演講者，每次積分三點。
四、經醫院評鑑合格之醫院或主管機關跨專業之團隊臨床討論或專題演講之教學活動。	(一)參加者，每小時積分一點。 (二)擔任主要報告或演講者，每次積分三點。 (三)超過六十點者，以六十點計。
五、參加網路繼續教育。	(一)每次積分一點。 (二)超過六十點者，以六十點計。
六、參加各該類醫事人員相關雜誌通訊課程。	(一)每次積分二點。 (二)超過六十點者，以六十點計。
七、在國內外各該類醫事人員具審查機制之相關雜誌發表有關各該類醫事人員原著論文。	(一)每篇第一作者或通訊作者，積分十六點，第二作者，積分六點，其他作者積分二點。 (二)發表其他類論文者，積分減半。 (三)超過五十點者，以五十點計。
八、在國內外大學進修專業相關課程。	(一)每學分積分五點。 (二)每學期超過十五點者，以十五點計。
九、講授衛生教育推廣課程。	(一)每次積分一點。 (二)超過十五點者，以十五點計。

十、在國外執業或開業。	每年以二十點計。
十一、國內外各該類醫事人員專業研究機構進修。	(一)短期進修者(累計一星期內)，每日積分二點。 (二)長期進修者(累計超過一星期)，每星期積分五點。 (三)超過三十點者，以三十點計。
十二、醫師一般醫學訓練、牙醫師一般醫學訓練、專科醫師訓練、專科牙醫師訓練或臨床醫事人員培訓計畫之訓練。	每年以二十點計。
十三、各大專校院專任護理教師至國內醫療或護理機構實務學習，經機構開具證明文件。	(一)每日積分二點。 (二)超過二十五點者，以二十五點計。
十四、於離島地區執業期間。	除參加本表第十點之繼續教育外，其各點實施方式之積分數，得以二倍計。
十五、於偏遠地區執業期間。	除參加本表第十點外之繼續教育外，其各點實施方式之積分數，得以一點五倍計。

附錄十四、實習護士實施要點

實習護士實施要點

1. 中華民國 80 年 6 月 29 日行政院(80)台人政貳字第 22069 號函修正備查
2. 中華民國 94 年 9 月 28 日行政院衛生署衛署醫字第 0940209370 號修正全文 5 點

- 一、為強化護理人員管理，並有效運用人力，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱實習護士，指在國內公立或立案之私立高級職業以上學校，修習護理學科系畢業，領有畢業證書，繼續從事實習者。
- 三、經中央衛生主管機關評鑑合格醫院，得進用實習護士，在護理人員指導下，執行護理業務。
- 四、醫院進用實習護士人數以不超過該院護理人員數之五分之一為限。
- 五、實習護士之實習期間，以自畢業之日起至次年 9 月 30 日止。但本要點修正前，已擔任實習護士者，得實習至 95 年 9 月 30 日止。

附錄十五、醫院照顧服務員管理要點

醫院照顧服務員管理要點

1. 中華民國 95 年 5 月 29 日行政院衛生署衛署照字第 0952800639 號函訂定發布全文 8 點
2. 中華民國 102 年 7 月 17 日行政院衛生署衛署照字第 1022863383 號函修正全文 9 點

- 一、為促進醫院照顧服務員服務品質，保障病人安全，特訂定本要點。
- 二、本要點所稱照顧服務員，指經醫院提供或洽由照顧服務業者安排在醫院內協助照顧住院病人之人員。
醫院對前項所訂照顧服務員執行之業務，應建立管理、監督及查核機制，並負監督之責。
- 三、醫院管理照顧服務員訂定之管理規範，內容應包括：
 - (一) 照顧服務員業務範圍及工作內容（如附表一）。
 - (二) 照顧服務員對於所服務醫院之內部管理相關規定應予遵守，包括：
 1. 對於工作上知悉之病人隱私，不得無故洩漏等。
 2. 照顧服務員每年至少接受 8 小時在職訓練，訓練內容包括感染管制、病人安全、病人隱私、緊急處理及照顧技術等。
 - (三) 照顧服務員之病人分配、排班、接班、交班、工作時間、休息、休假等規定。
 - (四) 在維持照顧品質及護理人員專業評估下，提供照顧服務員照顧一位或多位病人之選項。
 - (五) 醫院依其管理及病人安全所需，應與照顧服務業者或照顧服務員訂定相關契約，契約內容應包括雙方未能遵守相關規定之處理原則。
 - (六) 照顧服務員基本資料應登錄並列冊管理（如附表二）。
- 四、醫院應訂定照顧服務員聘用及服務相關規範，主動提供住院病人或其家屬參考，並揭示於醫院明顯處所，其內容包括如下：

- (一) 安排照顧服務員之原則。
- (二) 照顧服務員之服務範圍。
- (三) 照顧服務員之收費原則。
- (四) 紛爭處理與申訴管道。

五、醫院照顧服務員應符合下列規定之資格及條件：

- (一) 領有照顧服務員訓練結業證明書或照顧服務員職類技術士證。
- (二) 依勞工安全衛生相關規定，每年至少體檢一次，檢查結果需符合規定。如罹患經醫師診斷不適合從事照顧服務之疾病時，應立即停止服務，但經治療複檢合格者，不在此限。

六、本要點第三點第五款所訂契約，應明定因執行照顧服務業務致生事故或醫療爭議之責任歸屬及其賠償機制。

醫院於照顧服務業務因事故或承攬者違約不能履行時，應有即時銜接機制，以保障病人之權益。

七、因照顧服務業務而與病人、家屬、或其關係人產生爭議時，醫院應協助處理與說明。

八、醫院如發現非法工作之大陸地區人民或外籍人士，應通報當地勞政及警政相關單位。

九、醫院依據本要點訂定之管理規範及照顧服務員登錄清冊，應送請當地衛生主管機關備查，修訂時亦同。

附表一

工作項目	工作內容
一般事務工作	1. 量身高、體重 2. 回應叫人鈴 3. 病床整理等 4. 其他庶務工作
一般性技術工作 (非專業性)	1. 協助病人及家屬環境介紹 2. 登記輸出輸入量 3. 床欄適當應用 4. 協助遺體清潔與更衣 5. 冰枕使用(含冰袋、冰囊、冰寶) 6. 點滴更換通知 *7. 在護理人員指導下，協助檢查、治療時環境與病人之準備 8. 發現異常狀況立即通報護理人員等
身體清潔與舒適 照護	1. 頭部清潔(洗臉、刮鬍子、洗頭、梳理及眼耳鼻清潔) 2. 一般口腔衛生清潔(含刷牙漱口、口腔潤濕) 3. 身體清潔(床上擦澡、洗澡、會陰部清潔或皮膚照護) 4. 足部清潔 5. 協助大小便及便後清潔 6. 更換尿布、看護墊 7. 協助更換(穿脫)衣褲 8. 更換床單被服類 9. 指甲修剪(糖尿病及灰指甲病人應由護理人員評估後，徵求家屬同意後始可執行)
排泄照護	1. 倒蓄尿袋之尿液 2. 協助人工肛門便袋之更換清潔 3. 便盆、尿壺、尿套便盆椅使用
膳食與給藥	1. 協助用餐或餵食 *2. 在護理人員指導下，維持個案生理機能之管灌食等
舒適與活動	1. 協助翻身、拍背 2. 姿位改變活動(如協助移位、上下床坐輪椅/椅子、輔具使用)

	3. 維持病人正確與舒適姿勢 4. 協助副木/垂足板使用 *5. 在護理人員指導下，協助溫水坐浴環境與病人之準備
安全維護	1. 床輪、床欄固定 2. 協助注意點滴、導尿管、氧氣導管等各種管路之通暢 3. 協助注意病人臥床、行走、如廁、起坐時之安全, 防止病人跌倒受傷害
其他	1. 餵食/灌食器清潔 2. 水分補充 3. 協助庶務性工作 4. 排泄後便器清潔 5. 其他非專業性臨時交辦事項等 *6. 在護理人員指導下，協助血壓、脈搏、體溫及呼吸狀況資料之收集 *7. 在護理人員指導下，協助餵藥或灌藥

備註：打*號部分應提供教育訓練及標準作業流程

附表二

醫院照顧服務員登錄清冊

服務醫院名稱：

姓名	身份證字號/居留證號	性別	學歷	訓練機構名稱	訓練日期		領有照顧服務員員訓練結業證明書字號或照顧服務員職類技術士證字號	任用方式（請✓）		合約業者名稱
					起	迄		醫院 聘僱	合約	